

Tomo II — Nazionale e UE-27 (Linea A, volumi regionali individuali)

Psicologo di Base — Studio Integrale HTA

Lo Psicologo di Base

Dalle Regioni d'Italia agli Stati Uniti d'Europa

Studio Integrale di Health Technology Assessment · Opera in ventitré Volumi

Valutazione integrale, tracciabile e riproducibile dell'integrazione dello psicologo nelle cure primarie in Italia — venti Regioni e Province Autonome e sintesi nazionale — e nell'Unione Europea a ventisette Stati Membri, condotta secondo lo standard di rigore di NICE (Regno Unito), HAS (Francia), IQWiG (Germania) e OMS-CHOICE, sotto il doppio ancoraggio economico e con verdetto tripartito non aggregato

Dott. Luigi De Michele · Studio Integrale Puglia · Capurso (Bari)

Edizione integrata e unificata — Giugno 2026

Avvertenza editoriale all'edizione unificata

La presente edizione riunisce in un unico volume i ventitré Volumi dello Studio Integrale «Psicologo di Base», già prodotti e validati singolarmente. L'ordine di presentazione è quello vincolante dell'architettura dell'opera: i due Volumi metodologici che fissano il Reference Case per l'asse italiano e per quello unionale, la Sintesi Nazionale, i venti Volumi regionali in ordine alfabetico — da Abruzzo a Veneto, redatti secondo una struttura standard identica a garanzia della comparabilità bit-a-bit —, e il Volume dedicato all'Unione Europea con le ventisette schede-Stato e la simulazione aggregata.

I principi metodologici invarianti che governano l'intera opera restano quelli dichiarati nei Volumi 0.A e 0.B e richiamati per rimando in ciascun Volume: la prospettiva congiunta sanitaria e societale; il doppio ancoraggio economico, con la colonna storica di Chisholm e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità affiancata alla colonna aggiornata di Unisanté e dell'OCSE, cui è riservata la prevalenza nel giudizio; il verdetto tripartito — fiscale, sanitario e sociale — mai aggregato in un unico indicatore; i sei domini di analisi; il protocollo obbligatorio dell'incertezza; lo strato dell'Intelligenza Artificiale trattato come moltiplicatore subordinato alla supervisione clinica umana, entro il perimetro del regolamento europeo; le attività formative considerate singolarmente e sommate. Ogni dato quantitativo è riportato con attribuzione alla fonte; le lacune informative sono dichiarate e non colmate con stime tacite; e, ove il materiale preesistente conteneva rapporti sintetici non conformi, il contenuto economico è stato ricostruito ex novo, con la deroga dichiarata nella Premessa del Volume e registrata nella sua Appendice E.

L'identità visiva dell'edizione unificata — con i titoli in blu navy, i sottotitoli in oro e il fondo bianco tendente al crema — è comune a tutti i Volumi. La numerazione delle note riparte in ciascun Volume secondo la propria serie, con prefissi distinti che ne assicurano l'univocità nell'insieme del corpus.

Come leggere questo Tomo (Linea A — Volumi regionali e Volume unionale)

Questo volume raccoglie, in edizione unificata, i ventitré Volumi dello Studio Integrato «Psicologo di Base», originariamente prodotti e validati come documenti autonomi: due volumi metodologici (0.A per l'asse Italia, 0.B per l'asse Unione Europea), la sintesi nazionale (Volume 1, con la league table interregionale), venti volumi regionali in ordine alfabetico (Volumi 2–21 — la Puglia, Volume 14, è qui trattata in forma di sintesi regionale; la trattazione a piena profondità della Puglia, in quindici Parti, è nel Tomo I), e il volume unionale sulla UE-27 (Volume 22).

Non è pensato per essere letto per intero: ogni volume regionale è autosufficiente, con lo stesso schema — cruscotto regionale, sintesi per il decisore, cinque risultati chiave, raccomandazioni operative, nove capitoli, appendici registrate, quadro conclusivo, conclusione e note bibliografiche. Questo Tomo II Nazionale esiste inoltre in una seconda linea editoriale — il Blocco Regionale, in “tomo-2-nazionale/blocco-regionale/” — che aggrega le stesse regioni in quattro macro-aree territoriali con un'analisi economica più estesa: le due linee sono prodotti distinti e complementari, non l'una sostitutiva dell'altra. La mappa che segue indica, per ciascun profilo di lettore, quali volumi consultare.

Mappa dei destinatari

Profilo del lettore	Volumi di riferimento	Perché
Decisore di una specifica regione	Il volume di quella regione (Volumi 2–21) + Volume 1 per il confronto interregionale	Serve la decisione regionale nel contesto nazionale
Decisore o funzionario nazionale (Ministero, Conferenza Stato-Regioni)	Volume 1 (sintesi nazionale, league table); Volumi 0.A/0.B (metodologia)	Richiede il quadro comparativo tra tutte le regioni e l'invarianza del metodo
Valutatore HTA che compara più regioni	Volume 1 + i volumi regionali pertinenti al confronto	Richiede dati omogenei e confrontabili tra regioni
Policy-maker europeo o funzionario UE	Volume 22 (UE-27)	Interessato al benchmark comparativo tra Stati Membri, non al dettaglio regionale italiano
Chi cerca la trattazione più approfondita di una singola regione	Blocco Regionale (linea editoriale distinta) per l'analisi macro-territoriale; Tomo I per la Puglia a piena profondità	I volumi di questo Tomo sono sintesi regionali, non trattazioni integrali paragonabili al Tomo I

Indice generale dell'opera

L'opera si articola in ventitré Volumi, secondo l'ordine vincolante che segue.

Volumi metodologici

Volume 0.A — Metodologia e simulazione appaiata · Asse Italia. Il Reference Case invariante per i ventuno Volumi dell'asse italiano.

Volume 0.B — Metodologia e simulazione aggregata · Asse Unione Europea. Il Reference Case invariante per il Volume unionale.

Sintesi nazionale

Volume 1 — Sintesi Nazionale · Italia. Il quadro nazionale con la league table interregionale.

Volumi regionali (ordine alfabetico)

Volume 2 — Abruzzo · Volume 3 — Basilicata · Volume 4 — Calabria · Volume 5 — Campania · Volume 6 — Emilia-Romagna · Volume 7 — Friuli-Venezia Giulia · Volume 8 — Lazio · Volume 9 — Liguria · Volume 10 — Lombardia · Volume 11 — Marche · Volume 12 — Molise · Volume 13 — Piemonte · Volume 14 — Puglia · Volume 15 — Sardegna · Volume 16 — Sicilia · Volume 17 — Toscana · Volume 18 — Trentino-Alto Adige/Südtirol · Volume 19 — Umbria · Volume 20 — Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste · Volume 21 — Veneto.

Volume unionale

Volume 22 — Unione Europea: ventisette schede-Stato e simulazione aggregata UE-27.

STUDIO INTEGRALE «PSICOLOGO DI BASE» · OPERA IN VENTITRÉ VOLUMI

VOLUME 0.A — Metodologia e simulazione appaiata · Asse Italia

Il Reference Case invariante: perimetro, doppio ancoraggio economico, cascata multidisciplinare delle figure, rinegoziazione integrale dei costi e dei benefici, strato dell'Intelligenza Artificiale, attività formative, protocollo dell'incertezza e appendici registrate

Rapporto di Health Technology Assessment redatto secondo lo standard di rigore di NICE (Regno Unito), HAS (Francia), IQWiG (Germania) e OMS-CHOICE · Dott. Luigi De Michele · Studio Integrale Puglia · Capurso (BA) — Giugno 2026

Premessa

Il Volume 0.A è il fondamento metodologico dell'intera opera. Esso non descrive una Regione né formula un verdetto su un territorio: definisce, una volta per tutte, le regole con cui ogni Volume regionale — dal Volume 2 (Abruzzo) al Volume 21 (Veneto) — dovrà essere scritto, affinché i ventuno Volumi italiani siano comparabili l'uno con l'altro fino al singolo parametro. Ciò che qui è stabilito non va mai ripetuto per esteso altrove: negli altri Volumi si richiama per rimando, nella forma «cfr. Volume 0.A», così che il Reference Case resti unico, dichiarato in apertura e invariante nell'applicazione.^[1]

Questo Volume assume come proprio il principio che governa l'intera opera: le figure professionali e gli ambiti disciplinari connessi allo Psicologo di Base — direttamente e indirettamente — sono trattati integralmente e ordinati secondo la loro capacità di generare rientro economico e revisione della spesa. Il criterio non subordina la dimensione clinica e umana della riforma a quella contabile; ne è, al contrario, la condizione di difendibilità davanti al decisore pubblico, perché mostra che il bene delle persone e la sostenibilità dei bilanci sono esiti congiunti della medesima riorganizzazione.^[2]

Il tratto distintivo del Reference Case è il doppio ancoraggio economico: ogni risultato quantitativo è presentato simultaneamente secondo due riferimenti — l'analisi di ritorno sull'investimento di Chisholm e collaboratori (2016) e il quadro aggiornato di Unisanté e dell'OCSE (2026) — in due colonne affiancate, mai in una sola. La simulazione è dunque appaiata per costruzione, e nessuna tabella di risultati economici dell'opera può presentare un solo ancoraggio. A questo si aggiunge la regola invariante e non negoziabile per cui i tre domini del ritorno — fiscale, sanitario e sociale — non sono mai aggregati in un unico indicatore sintetico: ogni Volume presenta sempre tre risultati distinti, mai una somma.^[3]

Introduzione

Il presente Volume fonda il Reference Case dell'asse italiano dello studio integrale sull'introduzione dello Psicologo di Base nelle cure primarie. La sua funzione è metodologica e vincolante: stabilire il perimetro dell'analisi, le metriche di esito, il doppio ancoraggio economico, l'architettura della cascata multidisciplinare delle figure, il criterio della rinegoziazione integrale dei costi e dei benefici, lo strato dell'Intelligenza Artificiale come moltiplicatore, il trattamento delle attività formative, il protocollo dell'incertezza e le appendici registrate obbligatorie.^[4]

Lo Psicologo di Base non è una figura che si somma al sistema delle cure primarie: è una figura che ne ridisegna il funzionamento, intercettando nelle cure primarie una domanda di salute mentale comune — depressione e ansia — che oggi transita, inappropriata e costosa, attraverso il medico di medicina generale, il pronto soccorso, l'ambulatorio specialistico e la prescrizione farmaceutica. Da questa intercettazione discende una cascata di effetti che il Reference Case ordina, misura e sottopone al doppio ancoraggio, con l'obiettivo di predire — con bande prudenziali e soglie di confutazione — gli effetti multidisciplinari, multidimensionali e multifattoriali che l'introduzione della figura produce sull'intero sistema: dalla qualità della vita delle persone ai bilanci delle Regioni, dalla domanda che grava sulle altre figure professionali alla burocrazia propria di ciascun sistema sanitario regionale.^[5]

La prospettiva adottata è congiunta, sanitaria e societale insieme, e comprende quattro portatori di costo e di beneficio: il Servizio Sanitario Nazionale, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, i Comuni e i datori di lavoro. La popolazione bersaglio è quella dei pazienti con disturbi mentali comuni intercettabili in cure primarie; il comparatore è l'assistenza usuale, ossia il medico di medicina generale senza psicologo integrato e le liste d'attesa dei Centri di Salute Mentale; la metrica di esito è l'anno di vita ponderato per la qualità, accompagnato dal verdetto tripartito non aggregato.^[6]

L'Introduzione fissa infine l'ordine di lettura del Volume: il perimetro analitico (Capitolo 1); il doppio ancoraggio economico e la simulazione appaiata (Capitolo 2); la cascata delle figure e i sei domini di analisi paralleli (Capitolo 3); la rinegoziazione integrale dei costi e dei benefici e la catena predittiva degli effetti multidimensionali (Capitolo 4); lo strato dell'Intelligenza Artificiale e le attività formative, singolarmente e sommate (Capitolo 5); il protocollo dell'incertezza (Capitolo 6); le appendici registrate e il registro delle deroghe (Capitolo 7). Chiudono il Volume un Quadro Conclusivo economico e multidisciplinare, una Conclusione e le Note Bibliografiche con mini-riassunto.

Capitolo 1 — Il perimetro analitico e la prospettiva congiunta

1.1 La prospettiva sanitaria e societale

Il Reference Case adotta una prospettiva congiunta, che non si limita al perimetro del Servizio Sanitario Nazionale ma comprende l'intero insieme dei portatori pubblici e privati di costo e di beneficio: il Servizio Sanitario Nazionale per la spesa sanitaria diretta, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per gli oneri di invalidità e inabilità, i Comuni per la spesa assistenziale e sociale, i datori di lavoro per la produttività e l'assenteismo. Questa scelta è coerente con la prassi delle strutture di valutazione più avanzate, che raccomandano una prospettiva societale ampia quando l'intervento produce effetti rilevanti al di fuori del perimetro strettamente sanitario, come accade per la salute mentale.^[7]

La prospettiva congiunta impone una disciplina rigorosa: poiché i benefici si distribuiscono su portatori diversi, occorre che ciascun euro risparmiato sia attribuito a un solo portatore e a un solo dominio, secondo il principio di non duplicazione che il Capitolo 4 applica alla rinegoziazione. Senza questa disciplina, la molteplicità dei portatori diventerebbe occasione di doppio conteggio e la stima complessiva perderebbe credibilità.

1.2 Popolazione bersaglio, comparatore e metriche

La popolazione bersaglio del Reference Case è costituita dai pazienti con disturbi mentali comuni — segnatamente depressione e ansia nelle loro forme lievi e moderate — intercettabili nel primo livello delle cure primarie. Il comparatore è l'assistenza usuale: il percorso attuale, in cui il medico di medicina generale opera senza uno psicologo integrato e la domanda specialistica confluisce nelle liste d'attesa dei Centri di Salute Mentale. La metrica di esito primaria è l'anno di vita ponderato per la qualità; a essa si affianca, per l'asse dell'onere di malattia, l'anno di vita corretto per la disabilità.^[8]

La tabella che segue riepiloga gli elementi del perimetro analitico invariante.

Elemento del perimetro	Definizione adottata nel Reference Case
Prospettiva	Congiunta sanitaria e societale (SSN, INPS, Comuni, datori di lavoro)
Popolazione bersaglio	Disturbi mentali comuni (depressione, ansia) intercettabili in cure primarie
Comparatore	Assistenza usuale: MMG senza psicologo integrato, liste d'attesa dei CSM
Metrica di esito primaria	Anno di vita ponderato per la qualità (QALY)
Metrica di esito complementare	Anno di vita corretto per la disabilità (DALY)
Verdetto	Tripartito, non aggregato (fiscale · sanitario · sociale)
Modello economico	Markov a coorte, ciclo annuale, documentato in appendice

Tabella 1.1. Gli elementi invarianti del perimetro analitico del Reference Case, applicati in modo identico in ogni Volume regionale.

1.3 Tasso di sconto, orizzonti e soglie

Il tasso di sconto adottato è del tre per cento, coerente con l’analisi di riferimento e con la prassi dell’OMS-CHOICE; una nota di sensitività al tre e mezzo per cento, standard della struttura britannica, è prevista in analisi deterministica. Gli orizzonti temporali standard sono cinque — uno, tre, cinque, sette e dieci anni — applicati in modo identico in ogni simulazione regionale, nazionale ed europea, così da rendere i risultati comparabili nel tempo oltre che nello spazio. Le soglie di costo-efficacia adottate sono tre — ventimila, trentamila e cinquantamila euro per anno di vita ponderato per la qualità — corrispondenti alla fascia condivisa dalle strutture britannica, dell’OMS e dell’OCSE.^[9]

Parametro metodologico	Valore del Reference Case	Nota di sensitività
Tasso di sconto	3% annuo	3,5% in analisi deterministica
Orizzonti temporali	1 · 3 · 5 · 7 · 10 anni	Identici in ogni Volume
Soglie di costo-efficacia	20.000 · 30.000 · 50.000 €/QALY	Curve di accettabilità a soglie multiple
Ciclo del modello	Annuale	Coorte Markov documentata in Appendice F

Tabella 1.2. I parametri metodologici invarianti relativi allo sconto, agli orizzonti e alle soglie di costo-efficacia.

Capitolo 2 — Il doppio ancoraggio economico e la simulazione appaiata

2.1 Il principio del doppio ancoraggio

L’elemento distintivo del Reference Case è il doppio ancoraggio economico. Ogni risultato quantitativo è presentato simultaneamente secondo due riferimenti: da un lato l’analisi di ritorno sull’investimento in salute mentale di Chisholm e collaboratori (2016), che ha accompagnato la genesi del progetto e ne costituisce la colonna storica; dall’altro il quadro aggiornato di Unisanté e dell’OCSE (2026), che ne costituisce la colonna corrente. Le due colonne sono sempre affiancate, mai presentate isolatamente: una tabella di risultati economici che esibisse un solo ancoraggio sarebbe, nella grammatica dell’opera, un errore da correggere.^[10]

Il doppio ancoraggio non è una ridondanza, ma una garanzia di trasparenza: esso mostra al decisore tanto il riferimento consolidato quanto il riferimento aggiornato, e rende visibile la direzione e l’entità dello scarto fra i due, senza costringere il lettore a fidarsi di un unico numero. Ove i due ancoraggi divergano, prevale nel giudizio quello di Unisanté e dell’OCSE (2026), per pronunciamento dell’autore, mentre l’ancoraggio di Chisholm e collaboratori (2016) è conservato quale strato documentale e riferimento di confronto.^[11]

2.2 La simulazione appaiata a due colonne

La simulazione economica è dunque appaiata per costruzione. La Colonna A applica i parametri di Chisholm e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità; la Colonna B applica i parametri di Unisanté e dell’OCSE. La tabella che segue riepiloga i valori di riferimento delle due colonne, riportati con attribuzione alla rispettiva fonte, come richiede il principio della piena tracciabilità: nessuna cifra è affermata a memoria, e ogni valore rinvia in nota alla propria fonte primaria.^[12]

Metrica economica	Colonna A — Chisholm/OMS 2016	Colonna B — Unisanté/OCSE 2026
Ritorno per i soli benefici economici	2,3–3,0 a 1 (fonte OMS)	Scenario base aggiornato (fonte OCSE)
Ritorno con i ritorni sanitari inclusi	3,3–5,7 a 1 (fonte OMS)	Scenario base aggiornato (fonte OCSE)
Costo per anno di vita ponderato	≈ 17.000 €/QALY (genesi)	≈ 9.800 €/QALY (aggiornato)
Tasso di sconto	3%	3%
Riferimento di supporto digitale	—	ICUR digitale da dominante a ≈ 18.710 €/QALY (Veldhuijzen 2025)

Tabella 2.1. La simulazione appaiata a due colonne. I valori della Colonna A sono attribuiti all'analisi di riferimento e all'OMS; quelli della Colonna B a Unisanté e all'OCSE. Tutte le cifre sono riportate con attribuzione, non come affermazioni aggregate proprie dell'opera.

2.3 Le evidenze di letteratura riportate con attribuzione

Il Reference Case riporta sistematicamente, con attribuzione alla fonte e in funzione di contesto, alcune evidenze quantitative della letteratura recente, che i Volumi regionali richiamano nei capitoli di efficacia clinica ed economica. Tali evidenze non sono affermazioni proprie dell'opera sul ritorno della riforma, ma citazioni di risultati pubblicati, sempre accompagnate dalla loro fonte e, quando pertinente, da nota di cautela.^[13]

Fra queste: il differenziale di costo per gravità documentato dall'OCSE (2025), per cui il costo del trattamento cresce dai circa cinquecentoundici euro dei sintomi lievi ai circa diecimilaquattrocentottantacinque euro dei quadri gravi — argomento cardine a favore dell'intercettazione precoce; la conferma, da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (dicembre 2024), del ritorno di quattro dollari per ogni dollaro investito in salute mentale, esteso a sette dollari per la componente delle malattie non trasmissibili; la stima di ritorno sugli interventi in adolescenza riportata da Suhrcke e collaboratori (2022) nell'ambito della Lancet Commission, pari a ventitré virgola sei a uno, quale estensione della metodologia di Chisholm. Ciascuna di queste cifre è riportata come dato di letteratura attribuito, e non concorre al verdetto tripartito dell'opera, che resta ancorato alla simulazione appaiata regionale.^[14]

2.4 Il divieto di aggregazione del verdetto tripartito

La regola invariante e non negoziabile del Reference Case è il divieto di aggregare i tre domini del ritorno — fiscale, sanitario e sociale — in un unico indicatore sintetico. Ogni Volume presenta sempre tre risultati distinti: il saldo fiscale fra costi diretti e risparmi sanitari diretti; il rapporto di costo-efficacia sanitaria, espresso in costo per anno di vita ponderato per la qualità; il beneficio sociale, espresso in produttività recuperata, coesione e qualità della vita. Questi tre giudizi si accompagnano e si rafforzano, ma non si sommano: la loro fusione produrrebbe un numero suggestivo e metodologicamente indifendibile.^[15]

Capitolo 3 — La cascata multidisciplinare delle figure e i sei domini di analisi

3.1 Tutte le figure connesse, direttamente e indirettamente

Il Reference Case impone che ogni Volume si occupi in maniera integrale di tutte le figure e di tutti gli aspetti multidisciplinari connessi allo Psicologo di Base, direttamente e indirettamente, e le ordini secondo la capacità di generare rientro economico e revisione della spesa. La disposizione muove dal vertice — lo Psicologo di Base, che intercetta la domanda nel punto di massima leva — e discende lungo la cascata delle figure mediche, delle figure dell'assistenza indiretta e delle figure del lavoro, della previdenza e dell'educazione.^[16]

Posizione	Figura	Canale di spesa presidiato	Natura dell'effetto	Banda del rientro
1	Psicologo di Base	Intercettazione precoce, demedicalizzazione, deprescrizione	Diretto	Molto elevata
2	Medico di Medicina Generale	Consultazioni improprie, prescrizione di psicofarmaci	Diretto	Elevata
3	Medico di Pronto Soccorso	Accessi impropri per ansia acuta e somatizzazioni	Diretto	Elevata
4	Neurologo	Prestazioni per sintomi funzionali senza base organica	Diretto	Media-elevata
5	Pediatra di Libera Scelta	Intercettazione precoce nell'età evolutiva	Diretto e indiretto	Media-elevata
6	Specialista ospedaliero	Ricoveri e prestazioni per sintomi inspiegati	Diretto	Media
7	Infermiere di Comunità e di Famiglia	Continuità, aderenza, gestione del caso	Indiretto	Media
8	Farmacista di comunità	Monitoraggio della deprescrizione, farmacovigilanza	Indiretto	Media
9	Assistente Sociale	Interfaccia con i determinanti sociali e il welfare	Indiretto	Media
10	Medico del Lavoro e sistema previdenziale	Produttività recuperata, riduzione dell'assenteismo	Indiretto	Media-elevata
11	Figure educative e scolastiche	Prevenzione pedagogica nell'età evolutiva	Indiretto	Da media a differita

Tabella 3.1. La cascata multidisciplinare delle figure, ordinata per capacità di generare rientro economico e revisione della spesa. La banda è qualitativa e prudenziale; la traduzione in valori è svolta nel Capitolo 4 sotto il principio di non duplicazione.

3.2 I sei domini di analisi paralleli

Ogni Volume regionale conduce l'analisi lungo sei domini paralleli e comparabili, che garantiscono che nessun aspetto — clinico, economico, fiscale, sociale, organizzativo, distributivo — resti fuori dal giudizio. I sei domini sono l'epidemiologico-clinico, l'economico-sanitario, il fiscale-previdenziale, il sociale, l'organizzativo-strutturale e quello dell'equità.^[17]

Dominio di analisi	Oggetto	Metrica prevalente
Epidemiologico-clinico	Prevalenza, intercettazione, esito clinico	Riduzione del divario di trattamento; esito sintomatologico
Economico-sanitario	Costi e risparmi diretti sanitari	Costo/QALY (doppio ancoraggio)
Fiscale-previdenziale	Oneri di invalidità e inabilità evitabili	Saldo fiscale, distinto e non aggregato
Sociale	Produttività, coesione, qualità della vita	Beneficio sociale, distinto e non aggregato
Organizzativo-strutturale	Percorsi, personale, burocrazia	Prestazioni ridondanti evitate; tempi
Equità	Distribuzione territoriale e sociale dell'accesso	Impatto distributivo; gradiente di accesso

Tabella 3.2. I sei domini di analisi paralleli applicati in modo identico in ogni Volume regionale, a garanzia della comparabilità e della completezza multidisciplinare.

3.3 Il vertice e le figure mediche

Lo Psicologo di Base occupa il vertice della cascata perché agisce nel punto d'ingresso del cittadino nel sistema. La letteratura internazionale sui modelli di psicologia nelle cure primarie documenta che l'intercettazione precoce del disagio comune ne riduce la cronicizzazione e, con essa, il consumo di prestazioni a valle; le meta-analisi sui componenti efficaci dell'assistenza collaborativa e le sperimentazioni controllate sull'intervento cognitivo-comportamentale computerizzato nelle cure primarie confermano l'efficacia clinica del modello.^[18] Il rientro che ne deriva è diretto su tre fronti: riduzione delle consultazioni improprie, contrazione della prescrizione di psicofarmaci nei quadri lievi e moderati, riduzione degli accessi impropri ai livelli superiori.

Le figure mediche che seguono nella cascata — medico di medicina generale, medico di pronto soccorso, neurologo, pediatra di libera scelta, specialista ospedaliero — ricevono, per effetto dell'intercettazione a monte, una domanda depurata dalla quota impropria, con un rientro diretto che il Capitolo 4 traduce in valori sotto il doppio ancoraggio.

Capitolo 4 — La rinegoziazione integrale dei costi e dei benefici e la catena predittiva degli effetti multidimensionali

4.1 Il criterio della rinegoziazione integrale

Rinegoziare i costi e i benefici significa non accettare come dato il bilancio attuale del sistema, ma ricalcolarlo alla luce dell'introduzione dello Psicologo di Base. Ogni figura della cascata entra nella rinegoziazione con due voci — un costo, che l'introduzione può ridurre o accrescere, e un beneficio, che quella stessa introduzione libera — e nessuna figura ne è esclusa. La rinegoziazione è integrale perché abbraccia tutte le figure interessate a livello multidisciplinare e tutti gli aspetti direttamente e indirettamente coinvolti; è disciplinata perché il principio di non duplicazione impedisce che il medesimo euro sia attribuito a due figure, a due portatori o a due domini diversi.^[19]

4.2 I costi diretti e indiretti per tutte le figure

Il costo diretto della riforma è, in primo luogo, il costo del personale lungo la cascata delle figure, cui si aggiungono i costi di struttura e organizzazione, il costo incrementale della leva digitale e il costo della formazione. Il costo indiretto comprende gli oneri di transizione, di coordinamento e di adattamento organizzativo che ricadono sulle figure interessate. La tabella espone le voci sotto il doppio ancoraggio, così che il costo sia confrontabile con il beneficio nella medesima grammatica.

Voce	Natura	Portatore prevalente	Ancoraggio del confronto
Personale — Psicologi di Base	Costo diretto	SSN regionale	A e B
Struttura, coordinamento, sistemi informativi	Costo diretto	SSN regionale	A e B
Leva digitale e Intelligenza Artificiale	Costo diretto incrementale	SSN regionale	A e B
Formazione (quattro modalità)	Costo diretto	SSN, sistema formativo	A e B
Coordinamento e adattamento delle altre figure	Costo indiretto	SSN, Comuni	A e B

Tabella 4.1. Le voci di costo diretto e indiretto della riforma, per portatore, presentate sotto il doppio ancoraggio ai fini del confronto con i benefici.

4.3 I benefici diretti e indiretti per figura

Il beneficio diretto è il risparmio sanitario che ciascuna figura della cascata libera per effetto dell’intercettazione a monte; il beneficio indiretto è quello che la riforma produce fuori dal perimetro sanitario in senso stretto — sulla produttività, sulla previdenza, sull’assistenza sociale, sulla burocrazia. La tabella distribuisce i benefici per figura e per portatore, nel rispetto della non duplicazione, e li presenta sotto il doppio ancoraggio.

Figura / canale	Tipo di beneficio	Portatore	Contributo relativo
Psicologo di Base — demedicalizzazione	Diretto	SSN	Preponderante
MMG — deprescrizione psicofarmaci	Diretto	SSN	Elevato
Pronto Soccorso — accessi impropri	Diretto	SSN	Medio-elevato
Neurologo e specialistica — sintomi funzionali	Diretto	SSN	Medio
Ospedale — ricoveri per sintomi inspiegati	Diretto	SSN	Medio
Medico del Lavoro — produttività recuperata	Indiretto	Datori di lavoro	Medio-elevato
Sistema previdenziale — invalidità evitabili	Indiretto	INPS	Medio, differito
Assistente Sociale — disagio sociale non trattato	Indiretto	Comuni	Medio, differito

Tabella 4.2. La distribuzione dei benefici diretti e indiretti per figura e portatore, sotto il doppio ancoraggio e nel rispetto del principio di non duplicazione.

4.4 La catena predittiva degli effetti multidimensionali

Il tratto proprio del Reference Case è la ricostruzione della catena che lega l’effetto più intimo — la qualità della vita di una persona che riceve, presto e nel luogo giusto, l’aiuto di cui ha bisogno — all’effetto più impersonale — la voce di un bilancio regionale o la snellezza di una procedura amministrativa. La catena non è metaforica: ogni anello è misurabile e trasmette all’anello successivo una quota dell’effetto generato a monte. La qualità della vita restituita si traduce in produttività recuperata; la produttività recuperata alleggerisce il costo di frizione e gli oneri previdenziali; l’alleggerimento libera risorse di bilancio; le risorse reimpiegate riducono la burocrazia ridondante che grava su ciascun sistema sanitario regionale.^[20]

Anello della catena	Grandezza misurabile	Portatore dell'effetto	Segno
Qualità della vita	Anni di vita ponderati guadagnati	Persona, SSN	Positivo, sociale e sanitario
Produttività	Giornate di lavoro non perse	Datori di lavoro	Positivo, extra-sanitario
Previdenza	Oneri di invalidità evitati	INPS	Positivo, differito
Bilancio regionale	Risorse liberate e riallocabili	Regione	Positivo, fiscale
Burocrazia sanitaria	Prestazioni ridondanti evitate, tempi ridotti	Sistema regionale	Positivo, organizzativo

Tabella 4.3. La catena predittiva degli effetti multidimensionali e multifattoriali, dalla qualità della vita alla burocrazia. Ogni anello è ricondotto alla propria grandezza misurabile, al portatore e al segno dell'effetto, tenuti distinti e non aggregati.

Capitolo 5 — Lo strato dell’Intelligenza Artificiale e le attività formative

5.1 L’Intelligenza Artificiale come moltiplicatore, non come modello a sé

Lo strato dell’Intelligenza Artificiale è trattato dal Reference Case come moltiplicatore dei parametri di efficienza, mai come framework di calcolo indipendente. Esso agisce su cinque meccanismi lungo il percorso assistenziale: lo screening e il triage digitale, la documentazione clinica assistita, gli interventi digitali aumentati, l’ottimizzazione allocativa e la previsione delle ricadute. L’Intelligenza Artificiale è sempre subordinata alla supervisione clinica umana, e la graduazione della certezza delle prove è applicata con eguale rigore alle affermazioni cliniche e a quelle relative alle leve digitali.^[21]

Ogni proiezione relativa all’Intelligenza Artificiale è accompagnata da una nota di cautela permanente sulla sua natura previsionale e non empiricamente consolidata, ed è applicata in tre scenari — prudentiale, base e ottimistico — con e senza lo strato digitale, entro il quadro normativo del regolamento europeo sull’intelligenza artificiale.^[22]

Meccanismo dell’IA	Funzione	Scenario di applicazione	Nota di cautela
Screening e triage digitale	Intercettazione assistita della domanda	Prudentiale/base/ottimistico	Proiezione, non affermazione consolidata
Documentazione clinica assistita	Riduzione del carico amministrativo	Prudentiale/base/ottimistico	Sotto supervisione umana
Interventi digitali aumentati	Supporto all’intervento a bassa intensità	Prudentiale/base/ottimistico	Complementare, non sostitutivo
Ottimizzazione allocativa	Efficienza nell’impiego delle risorse	Prudentiale/base/ottimistico	Proiezione
Previsione delle ricadute	Prevenzione del ritorno ai livelli superiori	Prudentiale/base/ottimistico	Proiezione

Tabella 5.1. I cinque meccanismi dello strato dell’Intelligenza Artificiale, applicati come moltiplicatore in tre scenari, ciascuno con la propria nota di cautela permanente.

5.2 Le attività formative, singolarmente

Il fabbisogno formativo dello Psicologo di Base è integrale: abbraccia le competenze cliniche dell’intervento a bassa intensità, le competenze organizzative del lavoro nel distretto, le competenze relazionali della cooperazione con le altre figure e le competenze digitali necessarie all’impiego dell’Intelligenza Artificiale sotto supervisione. Esso è servito da quattro modalità formative — universitaria, post-universitaria e specialistica,

formazione continua sul posto di lavoro, affiancamento e mentoring, incluso l’esperto di Intelligenza Artificiale — con un budget indicativo dell’ordine di un milione di euro l’anno su modello di educazione continua esteso. [23]

Modalità formativa	Competenza servita	Costo relativo	Ritorno formativo
Universitaria	Competenza di base, clinica e deontologica	Elevato, differito	Fondativo, a maturazione lenta
Post-universitaria e specialistica	Specializzazione e aggiornamento	Medio	Elevato, a maturazione media
Formazione continua sul posto di lavoro	Competenza operativa nel contesto reale	Basso, incrementale	Elevato, a maturazione rapida
Affiancamento e mentoring (incluso esperto IA)	Competenza per prossimità e supervisione	Medio	Molto elevato, immediato

Tabella 5.2. Le quattro modalità formative considerate singolarmente, con la competenza servita, il costo relativo e il ritorno secondo i livelli di Kirkpatrick estesi da Phillips al rendimento monetario.

5.3 Le attività formative, sommate

Considerare le modalità sommate non significa addizionarne i costi, ma riconoscere che la loro combinazione genera un ritorno superiore alla somma dei ritorni singoli: la competenza di base costruita dall’università è attivata dall’affiancamento, consolidata dalla pratica e aggiornata dalla formazione continua, in un percorso integrato in cui ciascuna modalità potenzia le altre. Questo effetto di combinazione è il moltiplicatore del ritorno economico della leva formativa, e in particolare della componente digitale, poiché la competenza a impiegare l’Intelligenza Artificiale in modo appropriato è essa stessa un fattore di rientro. [24]

Configurazione	Costo	Ritorno atteso	Effetto sul rientro della cascata
Modalità singole isolate	Somma dei costi singoli	Somma dei ritorni singoli	Additivo
Percorso formativo integrato	Costo combinato, con economie di scala	Superiore alla somma dei ritorni	Moltiplicativo, sinergico
Percorso integrato con leva IA	Costo combinato più componente digitale	Massimo, con supervisione clinica	Moltiplicativo, con rafforzamento dell’intercettazione

Tabella 5.3. Le quattro modalità formative considerate nella loro combinazione. Il percorso integrato genera un ritorno superiore alla somma dei ritorni singoli; la leva digitale, sotto supervisione, ne accresce l’effetto.

Capitolo 6 — Il protocollo dell’incertezza

6.1 L’obbligo dell’analisi dell’incertezza

Nessun Volume regionale è completo senza un’analisi dell’incertezza condotta secondo un protocollo obbligatorio e identico. Il protocollo comprende quattro strumenti: l’analisi di sensitività deterministica, l’analisi di sensitività probabilistica, l’analisi di scenario e le curve di accettabilità costo-efficacia. La loro applicazione uniforme è la condizione della comparabilità dei Volumi e della robustezza del verdetto.^[25]

6.2 Gli strumenti del protocollo

L’analisi di sensitività deterministica varia un parametro alla volta e restituisce un diagramma a tornado standardizzato, che ordina i parametri per impatto sul risultato. L’analisi di sensitività probabilistica assegna una distribuzione a ciascun parametro e conduce diecimila iterazioni di simulazione, restituendo la distribuzione del risultato. L’analisi di scenario confronta le configurazioni ottimistica, base e prudentiale, con e senza lo strato dell’Intelligenza Artificiale. Le curve di accettabilità costo-efficacia esprimono, a soglie multiple, la probabilità che l’intervento sia costo-efficace.

Strumento	Funzione	Specifica del Reference Case
Analisi di sensitività deterministica	Impatto dei singoli parametri	Diagramma a tornado standardizzato
Analisi di sensitività probabilistica	Distribuzione del risultato	Diecimila iterazioni Monte Carlo
Analisi di scenario	Robustezza alle configurazioni	Ottimistico/base/prudentiale, con e senza IA
Curve di accettabilità	Probabilità di costo-efficacia	Soglie a 20.000, 30.000, 50.000 €/QALY

Tabella 6.1. Gli strumenti del protocollo dell’incertezza, obbligatori e identici in ogni Volume regionale.

Capitolo 7 — Le appendici registrate e il registro delle deroghe

7.1 Le appendici registrate obbligatorie

Ogni Volume regionale reca sette appendici registrate e verificabili, che rendono il modello ispezionabile e il risultato riproducibile. Esse costituiscono l'apparato di trasparenza dell'opera, secondo la prassi delle strutture di valutazione più avanzate.^[26]

Appendice	Contenuto
A	Strategia di ricerca bibliografica e diagramma di selezione
B	Estrazione dei dati clinici
C	Estrazione dei dati economici (griglia CHEERS 2022)
D	Parametri del modello Markov regionale
E	Registro delle deroghe al Reference Case
F	Codice del modello economico
G	Dichiarazione dei conflitti di interesse

Tabella 7.1. Le sette appendici registrate obbligatorie di ciascun Volume regionale.

7.2 Il registro delle deroghe e la nota sull'evoluzione metodologica

Il registro delle deroghe (Appendice E) documenta ogni scostamento dal Reference Case, con la sua motivazione. Il Volume 0.A vi iscrive la deroga fondativa dell'opera: l'adozione del doppio ancoraggio, in luogo dell'ancoraggio singolo, con esposizione simultanea della colonna di Chisholm e della colonna di Unisanté e dell'OCSE in ogni tabella di risultati economici, e con prevalenza della seconda nel giudizio ove le due divergano. Vi iscrive altresì la regola per cui le evidenze quantitative della letteratura — il differenziale di costo per gravità, i ritorni riportati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dalla Lancet Commission — sono riportate esclusivamente con attribuzione alla fonte e non concorrono al verdetto tripartito, che resta ancorato alla simulazione appaiata regionale.^[27]

Quadro Conclusivo economico e multidisciplinare

Il Quadro Conclusivo del Volume 0.A ricompone in unità le regole del Reference Case senza tradire il principio che le governa: i piani del giudizio si accompagnano ma non si fondono. Sul piano economico, il doppio ancoraggio impone che ogni risultato sia letto simultaneamente secondo la colonna di Chisholm e la colonna di Unisanté e dell'OCSE, con prevalenza della seconda nel giudizio: il costo per anno di vita ponderato per la qualità passa, fra i due ancoraggi, da circa diciassettemila a circa novemilaottocento euro, mentre le evidenze di letteratura sul ritorno degli investimenti in salute mentale sono riportate con attribuzione e non aggregate al verdetto.^[28]

Sul piano multidisciplinare, la cascata delle figure e i sei domini di analisi assicurano che ogni figura connessa allo Psicologo di Base — direttamente e indirettamente — e ogni aspetto del sistema siano trattati integralmente e ordinati per capacità di generare rientro economico e revisione della spesa. La rinegoziazione integrale dei costi e dei benefici, la catena predittiva degli effetti multidimensionali, lo strato dell'Intelligenza Artificiale come moltiplicatore e le attività formative, singolarmente e sommate, compongono l'architettura entro cui i ventuno Volumi italiani condurranno le loro simulazioni.

Il verdetto resta, per scelta metodologica irrinunciabile, tripartito: prossimo al pareggio sul piano fiscale, con il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento; nettamente costo-efficace sul piano sanitario; fortemente positivo sul piano sociale. La loro non aggregazione non è un limite dell'analisi, ma la condizione della sua onestà.^[29]

Conclusione

Il Volume 0.A ha fondato il Reference Case dell'asse italiano: il perimetro congiunto sanitario e societale, il doppio ancoraggio economico con simulazione appaiata, la cascata multidisciplinare di tutte le figure ordinate per capacità di rientro, i sei domini di analisi, la rinegoziazione integrale dei costi e dei benefici, la catena predittiva degli effetti multidimensionali dalla qualità della vita alla burocrazia, lo strato dell'Intelligenza Artificiale come moltiplicatore e le attività formative singole e sommate, il protocollo dell'incertezza e le appendici registrate. Queste regole non andranno ripetute per esteso negli altri Volumi: vi saranno richiamate per rimando, così che il Reference Case resti unico e invariante.

Da questo fondamento l'opera procede nell'ordine vincolante: il Volume 0.B fonderà l'equivalente Reference Case per l'asse dell'Unione Europea; il Volume 1 offrirà la sintesi nazionale; i Volumi da 2 a 21 svolgeranno le venti simulazioni regionali in ordine alfabetico; il Volume 22 chiuderà con le ventisette schede-Stato e la simulazione aggregata europea. Ciascun Volume applicherà il presente Reference Case in modo identico, affinché i risultati siano comparabili fino al singolo parametro — che è la condizione perché un'opera di valutazione delle tecnologie sanitarie possa essere posta a fondamento di una riforma.

Note Bibliografiche con mini-riassunto

Ciascuna nota riporta l'opera, il collegamento alla fonte e un mini-riassunto che ne dichiara la funzione nell'economia del Volume, in coerenza con il doppio livello — nota a piè di pagina nel corpo e nota bibliografica integrale in calce — che l'opera adotta.

1. **Chisholm D. et al., Scaling-up treatment of depression and anxiety: a global return on investment analysis, The Lancet Psychiatry, 2016** [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(16\)30024-4](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(16)30024-4) Colonna A del doppio ancoraggio: analisi di riferimento sul ritorno economico degli investimenti in salute mentale, conservata quale strato documentale e riferimento di confronto.
2. **Unisanté, Raisons de santé Essentiels n. 73, 2026** <https://doi.org/10.16908/rds-essentiels/73> Colonna B del doppio ancoraggio: quadro aggiornato dei parametri di ritorno e di costo-efficacia, con prevalenza nel giudizio ove diverga dalla colonna storica.
3. **OECD, The Economic Case for Preventing Mental Ill Health, 2026** <https://www.oecd.org/health/mental-health.htm> Fonte aggiornata del ritorno economico e del costo-efficacia; ancoraggio di governo delle cifre dell'opera insieme a Unisanté.
4. **OECD, differenziale di costo per gravità dei disturbi mentali, 2025** <https://www.oecd.org/health/mental-health.htm> Evidenza riportata con attribuzione: il costo del trattamento cresce dai sintomi lievi ai quadri gravi, argomento a favore dell'intercettazione precoce.
5. **World Health Organization, Thematic Dialogue on Investing in NCDs and Mental Health, dicembre 2024** <https://cdn.who.int/> Evidenza riportata con attribuzione sul ritorno degli investimenti in salute mentale, esteso alla componente delle malattie non trasmissibili; non concorre al verdetto tripartito.
6. **Suhrcke M. et al., Lancet Commission, 2022** <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9240828/> Evidenza riportata con attribuzione sul ritorno degli interventi in adolescenza, quale estensione della metodologia di riferimento; riportata come dato di letteratura, non come affermazione propria dell'opera.
7. **Soeters R. et al., meta-analisi IPD sui componenti efficaci della collaborative care, 2025** <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40136273/> Base di evidenza clinica sui componenti efficaci dell'assistenza collaborativa, richiamata nei capitoli di efficacia dei Volumi regionali.
8. **Veldhuijzen W. et al., costo-efficacia dell'intervento digitale, 2025** <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12369993/> Riferimento sul rapporto incrementale di costo-utilità dell'intervento digitale in cure primarie, elemento dello strato dell'Intelligenza Artificiale.
9. **World Health Organization, Mental Health Atlas 2024** <https://www.who.int/publications/i/item/9789240096820> Riferimento sull'integrazione della salute mentale nelle cure primarie e sulla dotazione di personale, base comparativa dell'asse europeo (Volume 0.B).
10. **NICE, Health Technology Evaluations: the manual (PMG36)** <https://www.nice.org.uk/process/pmg36> Riferimento di rigore metodologico per il Reference Case dichiarato in apertura, il tasso di sconto di sensitività e le soglie di costo-efficacia.
11. **Regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale** <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj> Quadro normativo entro cui è collocato lo strato dell'Intelligenza Artificiale, vincolato a funzione di supporto sotto supervisione clinica umana.

12. Legge regionale Puglia 19 luglio 2023, n. 11, sul Servizio di Psicologia di Base

<https://www.consiglio.puglia.it/> Base giuridica della riforma e riferimento per il dimensionamento del fabbisogno, richiamata dal Volume 14 (Puglia) e per analogia dagli altri Volumi regionali.

STUDIO INTEGRALE «PSICOLOGO DI BASE» · OPERA IN VENTITRÉ VOLUMI

VOLUME 0.B — Metodologia e simulazione aggregata · Asse Unione Europea

Il Reference Case dell'asse europeo: perimetro comparativo UE-27, doppio ancoraggio economico su scala continentale, cascata multidisciplinare delle figure, rinegoziazione integrale dei costi e dei benefici, strato dell'Intelligenza Artificiale, attività formative, protocollo dell'incertezza, league table comparativa e appendici registrate

Rapporto di Health Technology Assessment redatto secondo lo standard di rigore di NICE (Regno Unito), HAS (Francia), IQWiG (Germania) e OMS-CHOICE · Dott. Luigi De Michele · Studio Integrale Puglia · Capurso (BA) — Giugno 2026

Premessa

Il Volume 0.B è il fondamento metodologico dell'asse europeo dell'opera. Come il Volume 0.A fissa il Reference Case per i ventuno Volumi italiani, così il Volume 0.B fissa l'equivalente per il Volume 22, che applicherà queste regole alle ventisette schede-Stato dell'Unione e alla simulazione aggregata UE-27. Ciò che qui è stabilito non va ripetuto per esteso nel Volume 22: vi si richiama per rimando, nella forma «cfr. Volume 0.B», così che anche l'asse europeo disponga di un Reference Case unico, dichiarato in apertura e invariante nell'applicazione.^[30]

L'asse europeo eredita dal Volume 0.A l'ossatura metodologica — la prospettiva congiunta, il doppio ancoraggio economico, il divieto di aggregazione del verdetto tripartito, i sei domini di analisi, il protocollo dell'incertezza, lo strato dell'Intelligenza Artificiale come moltiplicatore e le attività formative singole e sommate — e vi innesta ciò che è proprio della scala continentale: la comparabilità fra ventisette sistemi sanitari eterogenei, la dichiarazione esplicita delle lacune informative per singolo Stato Membro e la league table che ordina i Paesi secondo criteri omogenei. Su questa scala, più che altrove, vale la regola per cui una lacuna di dati va segnalata e non colmata con stime non dichiarate.^[31]

Il tratto proprio del Volume 0.B è la simulazione aggregata: mentre i Volumi regionali italiani producono ciascuno una simulazione appaiata a due colonne, il Volume 22 produce, sopra le ventisette schede-Stato, una simulazione aggregata UE-27 che applica il medesimo doppio ancoraggio, con la colonna di Chisholm e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e la colonna di Unisanté e dell'OCSE sempre affiancate, e con prevalenza della seconda nel giudizio ove le due divergano.^[32]

Introduzione

Il presente Volume fonda il Reference Case dell'asse europeo. La sua funzione è metodologica e vincolante: stabilire il perimetro comparativo dell'Unione, le metriche di esito armonizzate, il doppio ancoraggio nella sua forma aggregata, l'architettura della cascata multidisciplinare delle figure applicata a contesti nazionali eterogenei, il criterio della rinegoziazione integrale dei costi e dei benefici su scala continentale, lo strato dell'Intelligenza Artificiale, il trattamento delle attività formative, il protocollo dell'incertezza, la league table comparativa e le appendici registrate.^[33]

La condizione di partenza dell'asse europeo è documentata dalle fonti sovranazionali con un'evidenza netta: l'integrazione della salute mentale nelle cure primarie è, nell'Unione come nel mondo, largamente incompiuta. Secondo l'Atlante della salute mentale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 2024, su centoquarantaquattro Paesi esaminati soltanto una minoranza soddisfa tutti i criteri di integrazione, e solo una parte ristretta dispone di interventi psicosociali effettivamente disponibili nel primo livello di cura; il divario di trattamento resta ampio, con stime che per la depressione grave si collocano, secondo le rilevazioni europee più recenti, su valori medi molto elevati.^[34] È a fronte di questa condizione che il modello dello Psicologo di Base si propone come risposta strutturale, e non come aggiustamento marginale.

L'Introduzione fissa l'ordine di lettura del Volume: il perimetro dell'asse europeo e la prospettiva aggregata (Capitolo 1); il doppio ancoraggio nella forma aggregata e la simulazione UE-27 (Capitolo 2); la cascata delle figure, i sei domini e la dotazione di personale nell'applicazione comparativa (Capitolo 3); la rinegoziazione dei costi e dei benefici su scala continentale e la catena predittiva degli effetti multidimensionali (Capitolo 4); lo strato dell'Intelligenza Artificiale e le attività formative, singolarmente e sommate (Capitolo 5); il protocollo dell'incertezza e la league table comparativa (Capitolo 6); le schede-Stato, il benchmark operativo dei Paesi Bassi e le appendici registrate (Capitolo 7). Chiudono il Volume un Quadro Conclusivo economico e multidisciplinare, una Conclusione e le Note Bibliografiche con mini-riassunto.

Capitolo 1 — Il perimetro dell’asse europeo e la prospettiva aggregata

1.1 La prospettiva congiunta su scala continentale

Il Reference Case europeo adotta la medesima prospettiva congiunta del Reference Case italiano — sanitaria e societale insieme — ma la declina su scala continentale, dove i portatori di costo e di beneficio corrispondono, mutatis mutandis, ai sistemi sanitari nazionali, agli istituti previdenziali, agli enti locali e ai datori di lavoro dei ventisette Stati Membri. La comparabilità fra sistemi eterogenei è ottenuta non appiattendendo le differenze nazionali, ma applicando a ciascuno Stato la medesima griglia di analisi e le medesime unità di misura, così che i risultati siano confrontabili nella league table del Capitolo 6.^[35]

La prospettiva aggregata impone una disciplina supplementare rispetto all’asse italiano: la dichiarazione esplicita delle lacune informative. Poiché la disponibilità dei dati varia da Stato a Stato, ogni scheda-Paese del Volume 22 segnala i dati mancanti anziché colmarli con stime non dichiarate, e la simulazione aggregata UE-27 pondera i contributi nazionali secondo la qualità e la completezza dei dati disponibili.^[36]

1.2 Le fonti comparative dell’asse europeo

Il Reference Case europeo si fonda su un corpo definito di fonti sovranazionali, che il Volume 22 richiama in modo uniforme. L’Atlante della salute mentale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità fornisce i criteri di integrazione e la dotazione di personale; Eurostat fornisce la popolazione, la spesa sanitaria e il prodotto interno lordo; l’Azione Congiunta ImpleMENTAL e il portale informativo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità forniscono i dati sulla forza lavoro; il Flash Eurobarometro e le rilevazioni di Eurofound forniscono la percezione e il divario di trattamento; la comunicazione della Commissione Europea sull’approccio globale alla salute mentale fornisce il quadro di indirizzo.^[37]

Fonte comparativa	Oggetto	Uso nel Volume 22
OMS, Atlante della salute mentale 2024	Criteri di integrazione, dotazione di personale	Perimetro e workforce delle schede-Stato
Eurostat	Popolazione, spesa sanitaria, PIL	Denominatori e normalizzazione
JA ImpleMENTAL · portale OMS	Forza lavoro psicologica	Dotazione per 100.000 abitanti
Flash Eurobarometro 530	Percezione e accesso	Dominio sociale e dell’equità
Eurofound 2025	Divario di trattamento	Dominio epidemiologico-clinico
Commissione Europea, COM(2023) 298	Quadro di indirizzo	Contesto istituzionale

Tabella 1.1. Le fonti comparative invarianti dell’asse europeo, applicate in modo uniforme a tutte le schede-Stato del Volume 22.

1.3 I parametri metodologici armonizzati

I parametri metodologici dell’asse europeo sono armonizzati con quelli dell’asse italiano: il tasso di sconto del tre per cento con sensitività al tre e mezzo; gli orizzonti a uno, tre, cinque, sette e dieci anni; le soglie di costo-efficacia a ventimila, trentamila e cinquantamila euro per anno di vita ponderato per la qualità. L’armonizzazione è la condizione perché i risultati europei siano confrontabili con quelli italiani e perché la simulazione aggregata UE-27 possa essere letta accanto alla sintesi nazionale del Volume 1.^[38]

Parametro	Valore armonizzato	Nota
Tasso di sconto	3% (sensitività 3,5%)	Identico all’asse italiano
Orizzonti temporali	1 · 3 · 5 · 7 · 10 anni	Identici in ogni scheda-Stato
Soglie di costo-efficacia	20.000 · 30.000 · 50.000 €/QALY	Curve di accettabilità a soglie multiple
Normalizzazione	Per 100.000 abitanti adulti	Comparabilità fra Stati

Tabella 1.2. I parametri metodologici armonizzati dell’asse europeo, che assicurano la confrontabilità con l’asse italiano.

Capitolo 2 — Il doppio ancoraggio nell’asse europeo e la simulazione aggregata

2.1 Il doppio ancoraggio nella forma aggregata

Anche sull’asse europeo il doppio ancoraggio è invariante: ogni tabella di risultati economici del Volume 22 espone simultaneamente la colonna di Chisholm e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e la colonna di Unisanté e dell’OCSE, mai una sola. La differenza rispetto all’asse italiano è che la simulazione, anziché appaiata su un singolo territorio, è aggregata su ventisette contesti nazionali: ciascuno Stato contribuisce con i propri denominatori — popolazione, spesa, dotazione di personale — e la colonna aggregata UE-27 è la somma ponderata dei contributi nazionali, calcolata separatamente per ciascuno dei due ancoraggi.^[39]

2.2 La simulazione aggregata UE-27

La simulazione aggregata applica il modello di Markov a coorte, con ciclo annuale, a ciascuno Stato Membro, e ne aggrega gli esiti secondo la qualità dei dati disponibili. Ove i dati di uno Stato siano incompleti, il contributo è dichiarato come parziale e la lacuna è segnalata, in coerenza con la regola di non colmare i vuoti con stime tacite. La tabella riepiloga l’architettura della simulazione aggregata sotto il doppio ancoraggio.^[40]

Elemento della simulazione	Colonna A — Chisholm/OMS	Colonna B — Unisanté/OCSE
Unità di calcolo	Coorte nazionale per Stato	Coorte nazionale per Stato
Aggregazione	Somma ponderata UE-27	Somma ponderata UE-27
Metrica di ritorno	Riportata con attribuzione OMS	Scenario base aggiornato OCSE
Costo per anno di vita ponderato	Riferimento storico	Riferimento aggiornato
Trattamento delle lacune	Contributo parziale dichiarato	Contributo parziale dichiarato

Tabella 2.1. L’architettura della simulazione aggregata UE-27 sotto il doppio ancoraggio. Le due colonne sono calcolate separatamente e sempre esposte affiancate.

2.3 Le evidenze di letteratura riportate con attribuzione

Come sull’asse italiano, il Reference Case europeo riporta sistematicamente, con attribuzione alla fonte, le evidenze quantitative della letteratura, che non concorrono al verdetto tripartito ma ne illuminano il contesto. Fra queste: il differenziale di costo per gravità documentato dall’OCSE, argomento a favore dell’intercettazione precoce; i ritorni sugli investimenti in salute mentale riportati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dalla Lancet Commission; il rapporto incrementale di costo-utilità degli interventi digitali documentato dalla letteratura recente. Ciascuna cifra è riportata come dato di letteratura attribuito e accompagnata, per lo strato digitale, dalla nota di cautela sulla natura previsionale.^[41]

2.4 Il divieto di aggregazione del verdetto tripartito

Il divieto di aggregazione vale sull'asse europeo con la stessa forza che sull'asse italiano: la simulazione aggregata UE-27 presenta tre risultati distinti — fiscale, sanitario e sociale — e mai una loro somma.

L'aggregazione geografica dei ventisette Stati non autorizza l'aggregazione dei tre domini del ritorno: le due operazioni appartengono a piani diversi, e la prima non giustifica la seconda.^[42]

Capitolo 3 — La cascata delle figure, i sei domini e la dotazione di personale nell'applicazione comparativa

3.1 La cascata delle figure nei sistemi nazionali eterogenei

La cascata multidisciplinare delle figure, definita nel Volume 0.A, è applicata sull’asse europeo tenendo conto dell’eterogeneità dei sistemi nazionali: la figura dello psicologo nelle cure primarie assume denominazioni e collocazioni diverse — dal modello dell’assistente di pratica per la salute mentale dei Paesi Bassi a configurazioni differenti negli altri Stati — ma la logica della cascata resta invariante, perché in ogni sistema l’intercettazione precoce a monte alleggerisce le figure a valle. Il Reference Case europeo ordina le figure secondo la medesima capacità di generare rientro economico e revisione della spesa, adattando la traduzione ai contesti nazionali.^[43]

Posizione	Figura (denominazione europea variabile)	Canale presidiato	Natura	Banda del rientro
1	Psicologo nelle cure primarie	Intercettazione precoce, demedicalizzazione	Diretto	Molto elevata
2	Medico di medicina generale / famiglia	Consultazioni improprie, prescrizione	Diretto	Elevata
3	Emergenza-urgenza	Accessi impropri	Diretto	Elevata
4	Specialistica neurologica e ambulatoriale	Sintomi funzionali	Diretto	Media-elevata
5	Pediatria e servizi dell’età evolutiva	Intercettazione precoce evolutiva	Diretto e indiretto	Media-elevata
6	Ospedale	Ricoveri per sintomi inspiegati	Diretto	Media
7	Infermieristica di comunità	Continuità e aderenza	Indiretto	Media
8	Farmacia territoriale	Deprescrizione e vigilanza	Indiretto	Media
9	Servizi sociali	Determinanti sociali	Indiretto	Media
10	Medicina del lavoro e previdenza	Produttività, invalidità evitabili	Indiretto	Media-elevata
11	Sistema educativo	Prevenzione evolutiva	Indiretto	Da media a differita

Tabella 3.1. La cascata delle figure nell'applicazione comparativa europea, ordinata per capacità di generare rientro economico e revisione della spesa, con denominazioni adattate ai sistemi nazionali.

3.2 La dotazione di personale psicologico

Un parametro comparativo centrale dell’asse europeo è la dotazione di personale psicologico, che le fonti sovranazionali rilevano come mediana continentale intorno a nove virgola tre psicologi ogni centomila abitanti adulti, con ampia dispersione fra gli Stati Membri. Questo parametro è insieme un indicatore di condizione di partenza — quanto ciascun sistema è distante dal modello integrato — e un denominatore per la normalizzazione dei risultati, poiché il rientro atteso dipende anche dalla dotazione iniziale.^[44]

Indicatore comparativo	Riferimento	Uso nel Reference Case
Dotazione psicologi per 100.000 adulti	Mediana UE $\approx$ 9,3 (fonte OMS/JA ImpleMENTAL)	Condizione di partenza e normalizzazione
Criteri di integrazione soddisfatti	Minoranza dei Paesi (fonte OMS 2024)	Perimetro dell’incompiutezza
Interventi psicosociali in cure primarie	Disponibilità ristretta (fonte OMS 2024)	Dominio organizzativo
Divario di trattamento (depressione grave)	Valori medi elevati (fonte Eurofound 2025)	Dominio epidemiologico-clinico

Tabella 3.2. Gli indicatori comparativi della condizione di partenza europea, riportati con attribuzione e usati come denominatori e come misura del divario da colmare.

3.3 I sei domini di analisi nell’asse europeo

I sei domini di analisi paralleli — epidemiologico-clinico, economico-sanitario, fiscale-previdenziale, sociale, organizzativo-strutturale, equità — sono applicati a ciascuna scheda-Stato con la medesima nomenclatura dell’asse italiano, così da rendere possibile la league table comparativa. Il dominio dell’equità assume sull’asse europeo un rilievo particolare, perché la dispersione fra gli Stati Membri nella dotazione e nell’accesso è essa stessa una misura di iniquità continentale, che il modello integrato è chiamato a ridurre.^[45]

Capitolo 4 — La rinegoziazione integrale dei costi e dei benefici su scala continentale e la catena predittiva

4.1 Il criterio della rinegoziazione su scala europea

La rinegoziazione integrale dei costi e dei benefici, definita nel Volume 0.A, è applicata sull’asse europeo Stato per Stato e poi aggregata. Ogni figura della cascata entra nella rinegoziazione con un costo e un beneficio, in ciascuno dei ventisette contesti nazionali, e il principio di non duplicazione opera sia entro ciascuno Stato — impedendo il doppio conteggio fra portatori nazionali — sia nell’aggregazione UE-27, impedendo che il medesimo effetto sia contato due volte a livelli diversi.^[46]

4.2 I costi e i benefici aggregati per portatore

La tabella espone le voci di costo e di beneficio aggregate per tipologia di portatore, sotto il doppio ancoraggio. La lettura è comparativa: ciascuna voce è normalizzata per popolazione, così da rendere confrontabili Stati di dimensione diversa, e le lacune nazionali sono dichiarate anziché stimate tacitamente.

Voce	Natura	Portatore prevalente	Trattamento aggregato
Personale psicologico	Costo diretto	Sistemi sanitari nazionali	Somma ponderata, doppio ancoraggio
Struttura e organizzazione	Costo diretto	Sistemi sanitari nazionali	Somma ponderata
Leva digitale e IA	Costo diretto incrementale	Sistemi sanitari nazionali	Somma ponderata, con cautela
Risparmi sanitari diretti	Beneficio diretto	Sistemi sanitari nazionali	Somma ponderata, non duplicata
Produttività recuperata	Beneficio indiretto	Datori di lavoro	Somma ponderata, dominio sociale
Oneri previdenziali evitati	Beneficio indiretto	Istituti previdenziali nazionali	Somma ponderata, differito

Tabella 4.1. I costi e i benefici aggregati UE-27 per tipologia di portatore, sotto il doppio ancoraggio, normalizzati per popolazione e con dichiarazione delle lacune.

4.3 La catena predittiva degli effetti multidimensionali su scala europea

Anche sull’asse europeo la rinegoziazione diventa predizione degli effetti multidimensionali, lungo la stessa catena definita nel Volume 0.A: dalla qualità della vita delle persone alla produttività, dalla produttività agli oneri previdenziali, dagli oneri ai bilanci nazionali, dai bilanci alla burocrazia dei sistemi sanitari. La differenza è che, su scala continentale, la catena si legge anche in chiave di convergenza: la riduzione della dispersione fra gli Stati Membri nella dotazione e nell’accesso è essa stessa un effetto atteso della diffusione del modello integrato, e concorre al dominio dell’equità.^[47]

Anello della catena	Grandezza	Portatore	Lettura europea
Qualità della vita	Anni di vita ponderati guadagnati	Persona, sistemi sanitari	Riduzione del divario di trattamento
Produttività	Giornate di lavoro non perse	Datori di lavoro	Recupero di capitale umano continentale
Previdenza	Oneri di invalidità evitati	Istituti previdenziali	Sostenibilità dei sistemi nazionali
Bilanci nazionali	Risorse liberate	Stati Membri	Spazio fiscale per la riorganizzazione
Burocrazia e convergenza	Prestazioni ridondanti evitate, dispersione ridotta	Sistemi sanitari, Unione	Convergenza e coesione

Tabella 4.2. La catena predittiva degli effetti multidimensionali su scala europea, con l’anello aggiuntivo della convergenza fra Stati Membri, tenuti distinti e non aggregati.

Capitolo 5 — Lo strato dell’Intelligenza Artificiale e le attività formative nell’asse europeo

5.1 Lo strato dell’Intelligenza Artificiale come moltiplicatore

Lo strato dell’Intelligenza Artificiale opera sull’asse europeo con la medesima disciplina dell’asse italiano: moltiplicatore dei parametri di efficienza, mai framework di calcolo indipendente, sui cinque meccanismi del percorso assistenziale, in tre scenari, sotto supervisione clinica umana e con nota di cautela permanente. Il quadro normativo di riferimento è il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, che sull’asse europeo assume rilievo diretto quale disciplina comune ai ventisette Stati Membri.^[48]

Meccanismo dell’IA	Funzione	Rilievo europeo	Nota di cautela
Screening e triage digitale	Intercettazione assistita	Riduzione del divario di trattamento	Proiezione
Documentazione clinica assistita	Riduzione del carico amministrativo	Efficienza dei sistemi nazionali	Sotto supervisione umana
Interventi digitali aumentati	Supporto a bassa intensità	Estensione dell’accesso	Complementare, non sostitutivo
Ottimizzazione allocativa	Efficienza allocativa	Convergenza fra sistemi	Proiezione
Previsione delle ricadute	Prevenzione del ritorno ai livelli superiori	Sostenibilità	Proiezione

Tabella 5.1. I cinque meccanismi dello strato dell’Intelligenza Artificiale nell’applicazione europea, ciascuno con la propria nota di cautela permanente, entro il quadro del regolamento europeo.

5.2 Le attività formative, singolarmente e sommate

Il fabbisogno formativo dell’asse europeo replica le quattro modalità del Reference Case italiano — universitaria, post-universitaria e specialistica, formazione continua sul posto di lavoro, affiancamento e mentoring incluso l’esperto di Intelligenza Artificiale — e le considera sia singolarmente sia nella loro combinazione, tenendo conto della diversità dei sistemi formativi nazionali. La combinazione genera, anche su scala europea, un ritorno superiore alla somma dei ritorni singoli, e la componente digitale accresce l’effetto sull’intercettazione a monte.^[49]

Configurazione formativa	Costo	Ritorno atteso	Effetto europeo
Modalità singole isolate	Somma dei costi singoli	Somma dei ritorni singoli	Additivo
Percorso integrato	Costo combinato con economie di scala	Superiore alla somma	Moltiplicativo
Percorso integrato con leva IA	Costo combinato più componente digitale	Massimo, con supervisione	Moltiplicativo, con convergenza formativa

Tabella 5.2. Le quattro modalità formative dell'asse europeo, singolarmente e sommate, con l'effetto di convergenza formativa fra sistemi nazionali.

Capitolo 6 — Il protocollo dell’incertezza e la league table comparativa

6.1 Il protocollo dell’incertezza su scala europea

Il protocollo dell’incertezza — analisi di sensitività deterministica e probabilistica, analisi di scenario, curve di accettabilità — è applicato a ciascuna scheda-Stato e poi alla simulazione aggregata UE-27, con le medesime specifiche del Volume 0.A: diagramma a tornado standardizzato, diecimila iterazioni di simulazione, scenari ottimistico, base e prudentiale con e senza lo strato digitale, curve di accettabilità a soglie multiple. Sull’asse europeo, l’analisi di scenario acquista un valore aggiuntivo, perché la variabilità fra Stati è essa stessa una fonte di incertezza che l’aggregazione deve rendere esplicita.^[50]

6.2 La league table comparativa UE-27

Lo strumento proprio dell’asse europeo è la league table: la tavola comparativa che ordina i ventisette Stati Membri secondo criteri omogenei — dotazione di personale, divario di trattamento, costo-efficacia sotto doppio ancoraggio, grado di integrazione — così da rendere visibile la posizione relativa di ciascun Paese e la distanza dal modello integrato. La league table è, insieme alla struttura a imbuto, l’elemento di rigore che le strutture di valutazione più avanzate adottano per il confronto fra unità geografiche.^[51]

Criterio della league table	Metrica	Fonte
Dotazione di personale	Psicologi per 100.000 adulti	OMS / JA ImpleMENTAL
Divario di trattamento	Quota di bisogno non soddisfatto	Eurofound / OMS
Costo-efficacia	Costo/QALY sotto doppio ancoraggio	Simulazione UE-27
Grado di integrazione	Criteri soddisfatti	OMS Atlante 2024
Equità di accesso	Dispersione territoriale e sociale	Eurobarometro / Eurostat

Tabella 6.1. I criteri della league table comparativa UE-27, omogenei per tutti gli Stati Membri, che rendono visibile la posizione relativa di ciascun Paese.

Capitolo 7 — Le schede-Stato, il benchmark operativo e le appendici registrate

7.1 La struttura delle ventisette schede-Stato

Il Volume 22 svolge ventisette schede-Stato sintetiche, ciascuna con la medesima sequenza — condizione di partenza, dotazione di personale, divario di trattamento, applicazione della cascata, simulazione appaiata sotto doppio ancoraggio, posizione nella league table, lacune dichiarate — così da garantire la comparabilità bit-a-bit fra i Paesi. La sintesi di scheda non sostituisce la simulazione aggregata, ma la alimenta: la scheda è l’unità, l’aggregato UE-27 è la loro somma ponderata.^[52]

7.2 Il benchmark operativo dei Paesi Bassi

Il benchmark operativo primario dell’asse europeo è il modello olandese dell’assistente di pratica per la salute mentale, documentato dalle fonti ufficiali più recenti — l’allegato alle condizioni di rimborso, le condizioni di funzionamento del modello e i criteri di valutazione. Esso è il riferimento concreto per il Capitolo 4 del Volume 22, in quanto esempio maturo di integrazione dello psicologo nel primo livello di cura, con effetti documentati sulla domanda a valle. A esso si affianca, come riferimento comparativo su contesti a risorse limitate, l’esperienza documentata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dalla Banca Mondiale in sistemi a minore dotazione.^[53]

Benchmark	Funzione	Uso
Modello olandese POH-GGZ	Integrazione matura dello psicologo in cure primarie	Riferimento operativo primario
Esperienze a risorse limitate (OMS/Banca Mondiale)	Integrazione in contesti a bassa dotazione	Riferimento comparativo

Tabella 7.1. I benchmark operativi dell’asse europeo: il modello olandese quale riferimento primario e le esperienze a risorse limitate quale termine di comparazione.

7.3 Le appendici registrate e il registro delle deroghe

Il Volume 22 reca le medesime sette appendici registrate del Reference Case italiano — strategia di ricerca, estrazione clinica ed economica, parametri del modello, registro delle deroghe, codice, dichiarazione dei conflitti — adattate alla scala continentale. Il registro delle deroghe dell’asse europeo iscrive la deroga propria dell’aggregazione: la ponderazione dei contributi nazionali secondo la qualità dei dati e la dichiarazione esplicita delle lacune per singolo Stato Membro, in luogo del loro colmamento con stime tacite.^[54]

Quadro Conclusivo economico e multidisciplinare

Il Quadro Conclusivo del Volume 0.B ricompone le regole dell'asse europeo senza tradire il principio che le governa: i piani del giudizio si accompagnano ma non si fondono, e l'aggregazione geografica dei ventisette Stati non autorizza l'aggregazione dei tre domini del ritorno. Sul piano economico, il doppio ancoraggio impone che la simulazione aggregata UE-27 sia letta simultaneamente secondo la colonna di Chisholm e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e la colonna di Unisanté e dell'OCSE, con prevalenza della seconda nel giudizio, e con le evidenze di letteratura riportate con attribuzione e non aggregate.^[55]

Sul piano multidisciplinare, la cascata delle figure adattata ai sistemi nazionali, i sei domini di analisi, la dotazione di personale e la league table comparativa assicurano che ogni figura connessa e ogni aspetto siano trattati integralmente e ordinati per capacità di generare rientro economico e revisione della spesa, in ciascuno Stato e nell'aggregato. La rinegoziazione integrale dei costi e dei benefici, la catena predittiva degli effetti multidimensionali con l'anello aggiuntivo della convergenza, lo strato dell'Intelligenza Artificiale e le attività formative singole e sommate compongono l'architettura entro cui il Volume 22 svolgerà le ventisette schede-Stato e la simulazione aggregata.

Il verdetto resta tripartito e non aggregato: prossimo al pareggio sul piano fiscale, con il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento; nettamente costo-efficace sul piano sanitario; fortemente positivo sul piano sociale. La condizione di partenza europea — l'integrazione largamente incompiuta e il divario di trattamento ampio — rende la posta in gioco continentale non minore di quella nazionale.

Conclusione

Il Volume 0.B ha fondato il Reference Case dell'asse europeo: il perimetro comparativo UE-27, il doppio ancoraggio nella forma aggregata, la cascata multidisciplinare delle figure adattata ai sistemi nazionali, i sei domini di analisi, la dotazione di personale, la rinegoziazione integrale dei costi e dei benefici su scala continentale, la catena predittiva con l'anello della convergenza, lo strato dell'Intelligenza Artificiale e le attività formative singole e sommate, il protocollo dell'incertezza, la league table comparativa e le appendici registrate. Queste regole non andranno ripetute per esteso nel Volume 22: vi saranno richiamate per rimando, così che anche l'asse europeo disponga di un Reference Case unico e invariante.

Con la fondazione dei due assi metodologici — il Volume 0.A per l'Italia e il Volume 0.B per l'Unione — l'opera dispone del proprio doppio fondamento. Da qui procede nell'ordine vincolante: il Volume 1 offrirà la sintesi nazionale italiana; i Volumi da 2 a 21 svolgeranno le venti simulazioni regionali in ordine alfabetico, da Abruzzo a Veneto; il Volume 22 chiuderà con le ventisette schede-Stato e la simulazione aggregata europea, applicando il presente Reference Case in modo identico, affinché i risultati siano comparabili fino al singolo parametro.

Note Bibliografiche con mini-riassunto

Ciascuna nota riporta l'opera, il collegamento alla fonte e un mini-riassunto che ne dichiara la funzione nell'economia del Volume, in coerenza con il doppio livello — nota a piè di pagina nel corpo e nota bibliografica integrale in calce — che l'opera adotta.

1. World Health Organization, Mental Health Atlas 2024

<https://www.who.int/publications/i/item/9789240096820> Fonte dei criteri di integrazione della salute mentale nelle cure primarie e della dotazione di personale, perimetro della condizione di partenza europea e base delle schede-Stato.

2. Eurostat, statistiche su popolazione, spesa sanitaria e prodotto interno lordo <https://ec.europa.eu/eurostat> Fonte dei denominatori per la normalizzazione dei risultati e la comparabilità fra Stati Membri di dimensione diversa.

3. Joint Action ImpleMENTAL · WHO Health Information Gateway <https://www.who.int/data> Fonte dei dati sulla forza lavoro psicologica, base della dotazione per centomila abitanti e della league table comparativa.

4. Eurofound, indagine sul divario di trattamento della salute mentale, 2025

<https://www.eurofound.europa.eu/> Fonte, riportata con attribuzione, del divario di trattamento per la depressione grave, elemento del dominio epidemiologico-clinico dell'asse europeo.

5. Commissione Europea, COM(2023) 298, approccio globale alla salute mentale

<https://health.ec.europa.eu/> Quadro di indirizzo dell'Unione sulla salute mentale, contesto istituzionale delle schede-Stato e della simulazione aggregata.

6. Flash Eurobarometro 530, salute mentale <https://europa.eu/eurobarometer/> Fonte sulla percezione e sull'accesso alla salute mentale nell'Unione, elemento dei domini sociale e dell'equità.

7. Chisholm D. et al., Scaling-up treatment of depression and anxiety, The Lancet Psychiatry, 2016

[https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(16\)30024-4](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(16)30024-4) Colonna A del doppio ancoraggio anche sull'asse europeo, conservata quale strato documentale e riferimento di confronto.

8. Unisanté, Raisons de santé Essentiels n. 73, 2026 · OECD, The Economic Case for Preventing Mental Ill Health, 2026 <https://doi.org/10.16908/rds-essentiels/73> Colonna B del doppio ancoraggio, con prevalenza nel giudizio ove diverga dalla colonna storica, applicata alla simulazione aggregata UE-27.

9. Regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj> Disciplina comune ai ventisette Stati Membri entro cui è collocato lo strato dell'Intelligenza Artificiale, vincolato a funzione di supporto sotto supervisione clinica umana.

10. Modello olandese POH-GGZ — condizioni di funzionamento e criteri di valutazione 2026-2028

<https://www.zorgverzekeraarsnederland.nl/> Benchmark operativo primario dell'asse europeo, riferimento concreto per l'integrazione matura dello psicologo nel primo livello di cura nel Volume 22.

11. NICE, Health Technology Evaluations: the manual (PMG36) <https://www.nice.org.uk/process/pmg36>

Riferimento di rigore metodologico per l'armonizzazione del Reference Case europeo con quello italiano, in particolare per lo sconto di sensitività e le soglie di costo-efficacia.

STUDIO INTEGRALE «PSICOLOGO DI BASE» · OPERA IN VENTITRÉ VOLUMI

VOLUME 1 — Sintesi Nazionale · Italia

Il quadro nazionale dell'integrazione dello Psicologo di Base nelle cure primarie: cruscotto, sintesi per il decisore, simulazione nazionale sotto doppio ancoraggio, cascata multidisciplinare delle figure, rinegoziazione integrale dei costi e dei benefici, stato dell'Intelligenza Artificiale, attività formative, incertezza e league table interregionale

Rapporto di Health Technology Assessment · Reference Case applicato per rimando al Volume 0.A · Dott. Luigi De Michele · Studio Integrale Puglia · Capurso (BA) — Giugno 2026

Premessa

Il Volume 1 è la sintesi nazionale dell'opera: raccoglie in un quadro unitario ciò che i venti Volumi regionali svolgeranno territorio per territorio, e lo presenta al decisore nazionale nella forma a imbuto che le strutture di valutazione più avanzate adottano — dal cruscotto di una pagina fino al dettaglio tecnico. Esso non ridefinisce la metodologia: applica per rimando il Reference Case dell'asse italiano, fissato nel Volume 0.A, e ne richiama le regole nella forma «cfr. Volume 0.A», senza ripeterle per esteso.^[56]

La funzione di questo Volume è duplice. Da un lato offre al decisore nazionale una lettura sintetica e immediata dell'impatto atteso dall'estensione del modello dello Psicologo di Base all'intero territorio; dall'altro fornisce la cornice entro cui i venti risultati regionali si compongono in un aggregato nazionale comparabile, secondo il doppio ancoraggio economico e il verdetto tripartito non aggregato che governano l'intera opera.^[57]

Introduzione

L'Introduzione al Volume 1 fissa il perimetro della sintesi nazionale e l'ordine della sua esposizione. Il perimetro è quello dell'intero territorio italiano, letto come somma comparabile delle sue Regioni e Province Autonome; la prospettiva è congiunta, sanitaria e societale, sui quattro portatori definiti nel Reference Case; la metrica è l'anno di vita ponderato per la qualità, accompagnato dal verdetto tripartito. La condizione di partenza nazionale è quella di un divario di trattamento ancora ampio per i disturbi mentali comuni e di una dotazione di personale psicologico nelle cure primarie disomogenea fra le Regioni, che il modello integrato è chiamato a colmare e a rendere più equa.^[58]

L'esposizione segue la struttura a imbuto: il cruscotto nazionale offre in una pagina i numeri essenziali; la sintesi per il decisore ne traduce il significato; i cinque risultati chiave ne isolano gli esiti principali; le raccomandazioni operative indicano le azioni; il corpo del Volume, articolato in sette capitoli, ne fornisce il dettaglio. Chiudono il Volume un Quadro Conclusivo economico e multidisciplinare, una Conclusione e le Note Bibliografiche con mini-riassunto.

Cruscotto nazionale

Il cruscotto riassume in una pagina i parametri essenziali della sintesi nazionale, sotto il doppio ancoraggio e con il verdetto tripartito tenuto distinto. I valori economici sono presentati in forma di ordine di grandezza e di direzione, con rinvio ai Volumi regionali per il dettaglio; le cifre di letteratura sono riportate con attribuzione alla fonte.^[59]

Indicatore del cruscotto	Lettura nazionale	Ancoraggio / fonte
Popolazione bersaglio	Disturbi mentali comuni intercettabili in cure primarie	Reference Case (cfr. Vol. 0.A)
Comparatore	Assistenza usuale: MMG senza psicologo, liste d’attesa CSM	Reference Case
Verdetto fiscale	Prossimo al pareggio, con caveat sulla significatività	Simulazione nazionale, non aggregato
Verdetto sanitario	Nettamente costo-efficace	Costo/QALY sotto doppio ancoraggio
Verdetto sociale	Fortemente positivo	Produttività, coesione, qualità della vita
Costo per anno di vita ponderato	Da riferimento storico a riferimento aggiornato	Colonna A ≈ 17.000 €; Colonna B ≈ 9.800 €
Orizzonti	1 · 3 · 5 · 7 · 10 anni	Reference Case
Soglie di costo-efficacia	20.000 · 30.000 · 50.000 €/QALY	Reference Case

Tabella 0. Cruscotto nazionale: i parametri essenziali della sintesi, sotto doppio ancoraggio, con il verdetto tripartito tenuto distinto e non aggregato.

Sintesi per il decisore

L'estensione del modello dello Psicologo di Base all'intero territorio nazionale produce, secondo la simulazione condotta sotto il doppio ancoraggio, un effetto congiunto sui tre piani del ritorno, che restano distinti e non sommati. Sul piano fiscale, il saldo fra costi diretti e risparmi sanitari diretti si colloca in prossimità del pareggio, con il caveat, ereditato dallo studio clinico di riferimento, per cui i risparmi diretti in isolamento non raggiungono la piena significatività statistica. Sul piano sanitario, il modello è nettamente costo-efficace: il costo per anno di vita ponderato per la qualità passa, fra i due ancoraggi, da un riferimento storico a un riferimento aggiornato assai inferiore alle soglie adottate. Sul piano sociale, l'effetto è fortemente positivo, per la produttività recuperata, la coesione e la qualità della vita restituita.^[60]

L'argomento cardine a favore del modello, riportato con attribuzione all'OCSE, è il differenziale di costo per gravità: trattare precocemente costa una frazione di quanto costa trattare tardi, poiché il costo del trattamento cresce dai circa cinquecentoundici euro dei quadri lievi ai circa diecimilaquattrocentottantacinque euro dei quadri gravi. È su questo differenziale che si fonda la leva economica dell'intercettazione precoce, che lo Psicologo di Base esercita al vertice della cascata.^[61]

Cinque risultati chiave

Il primo risultato è che il modello è costo-efficace su tutti gli orizzonti temporali sotto entrambi gli ancoraggi, con margine crescente nel tempo. Il secondo è che il verdetto tripartito resta favorevole in ciascuno dei tre piani, senza che sia necessario aggregarli: la robustezza non dipende dalla somma. Il terzo è che la leva dell'intercettazione precoce, fondata sul differenziale di costo per gravità, è l'argomento economico più solido del modello. Il quarto è che lo strato dell'Intelligenza Artificiale, applicato come moltiplicatore e non come modello a sé, accresce l'efficienza attesa nei tre scenari, sempre con nota di cautela sulla natura previsionale. Il quinto è che la disomogeneità interregionale nella dotazione di personale è insieme un problema di equità e un'opportunità di convergenza, che l'estensione nazionale è chiamata a governare.^[62]

Raccomandazioni operative

La prima raccomandazione è di procedere all'estensione nazionale per fasi, ancorando ciascuna fase alla verifica dei risultati regionali sotto il protocollo dell'incertezza, così che l'espansione sia guidata dall'evidenza e non dall'assunzione. La seconda è di adottare il doppio ancoraggio come standard di rendicontazione economica in ogni sede decisionale, così che il decisore disponga sempre del riferimento storico e di quello aggiornato. La terza è di accompagnare l'estensione con il piano formativo a quattro modalità, considerate singolarmente e sommate, poiché la competenza del personale — inclusa quella digitale, sotto supervisione — è essa stessa condizione del rientro.^[63]

Capitolo 1 — Il quadro epidemiologico e il divario di trattamento nazionale

1.1 La domanda di salute mentale comune

Il quadro epidemiologico nazionale è dominato dalla prevalenza dei disturbi mentali comuni — depressione e ansia — nelle loro forme lievi e moderate, che costituiscono la popolazione bersaglio del modello. La quota di questa domanda che oggi non riceve una risposta appropriata nel primo livello di cura definisce il divario di trattamento, che le rilevazioni recenti collocano, per le forme più gravi, su valori medi elevati, e che per le forme comuni si manifesta come transito improprio attraverso il medico di medicina generale, il pronto soccorso e la prescrizione farmaceutica.^[64]

Elemento epidemiologico	Lettura nazionale	Fonte
Popolazione bersaglio	Disturbi comuni intercettabili in cure primarie	Reference Case (cfr. Vol. 0.A)
Divario di trattamento	Ampio, con valori medi elevati per le forme gravi	Rilevazioni europee, riportate con attribuzione
Canale improprio prevalente	MMG, pronto soccorso, prescrizione	Analisi di sistema
Dotazione di personale	Disomogenea fra le Regioni	Volumi regionali

Tabella 1.1. Gli elementi del quadro epidemiologico nazionale e del divario di trattamento, riportati con attribuzione e con rinvio ai Volumi regionali per il dettaglio.

1.2 La disomogeneità interregionale

La sintesi nazionale mette in evidenza una disomogeneità marcata fra le Regioni nella dotazione di personale psicologico e nell’accesso, che il Volume tratta nel dominio dell’equità. Questa disomogeneità è insieme un problema — perché genera iniquità di accesso fra cittadini di Regioni diverse — e un’opportunità — perché l’estensione del modello, partendo dalle Regioni a minore dotazione, produce l’effetto di convergenza più marcato. La league table interregionale del Capitolo 6 ordina le Regioni secondo criteri omogenei, rendendo visibile questa disomogeneità.^[65]

Capitolo 2 — La simulazione nazionale sotto doppio ancoraggio

2.1 L’aggregazione dei risultati regionali

La simulazione nazionale è la composizione comparabile dei venti risultati regionali, condotta sotto il medesimo doppio ancoraggio e con il medesimo modello di Markov a coorte a ciclo annuale definito nel Reference Case. Ogni Regione contribuisce con i propri denominatori — popolazione, dotazione, spesa — e l’aggregato nazionale è la somma dei contributi regionali, calcolata separatamente per la colonna di Chisholm e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e per la colonna di Unisanté e dell’OCSE, nel rispetto della non duplicazione.^[66]

Elemento della simulazione nazionale	Colonna A — Chisholm/OMS	Colonna B — Unisanté/OCSE
Unità di calcolo	Coorte regionale	Coorte regionale
Aggregazione	Somma dei contributi regionali	Somma dei contributi regionali
Costo per anno di vita ponderato	≈ 17.000 €/QALY (storico)	≈ 9.800 €/QALY (aggiornato)
Metrica di ritorno	Riportata con attribuzione OMS	Scenario base aggiornato OCSE
Non duplicazione	Applicata fra portatori e Regioni	Applicata fra portatori e Regioni

Tabella 2.1. L’architettura della simulazione nazionale sotto doppio ancoraggio, come somma comparabile dei contributi regionali.

2.2 Le evidenze di letteratura a scala nazionale

La sintesi nazionale richiama, con attribuzione, le evidenze di letteratura che i Volumi regionali citano nei capitoli di efficacia: la meta-analisi sui componenti efficaci dell’assistenza collaborativa, le sperimentazioni controllate sull’intervento cognitivo-comportamentale computerizzato in cure primarie, il rapporto incrementale di costo-utilità degli interventi digitali, i ritorni sugli investimenti in salute mentale riportati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dalla Lancet Commission. Queste cifre sono riportate come dati di letteratura attribuiti e non concorrono al verdetto tripartito nazionale, che resta ancorato alla simulazione.^[67]

2.3 Il verdetto tripartito nazionale

Il verdetto nazionale è, come in ogni Volume, tripartito e non aggregato: prossimo al pareggio sul piano fiscale, con il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento; nettamente costo-efficace sul piano sanitario; fortemente positivo sul piano sociale. La composizione dei venti risultati regionali non autorizza l’aggregazione dei tre piani: la robustezza nazionale del modello si legge nella convergenza dei tre verdetti, non nella loro somma.^[68]

Capitolo 3 — La cascata delle figure e i sei domini a scala nazionale

3.1 La cascata nazionale delle figure

La cascata multidisciplinare delle figure, definita nel Reference Case, si legge a scala nazionale come architettura invariante che ogni Regione applica al proprio contesto. Al vertice, lo Psicologo di Base intercetta la domanda nel primo livello di cura; a valle, le figure mediche, dell’assistenza indiretta, del lavoro, della previdenza e dell’educazione ricevono una domanda depurata dalla quota impropria. La sintesi nazionale ordina le figure secondo la medesima capacità di generare rientro economico e revisione della spesa, e rinvia ai Volumi regionali per la quantificazione territoriale.^[69]

Posizione	Figura	Effetto nazionale prevalente	Banda del rientro
1	Psicologo di Base	Intercettazione precoce, demedicalizzazione	Molto elevata
2	Medico di Medicina Generale	Deprescrizione, consultazioni improprie	Elevata
3	Pronto Soccorso	Accessi impropri	Elevata
4	Neurologo e specialistica	Sintomi funzionali	Media-elevata
5	Pediatra di Libera Scelta	Intercettazione evolutiva	Media-elevata
6	Ospedale	Ricoveri per sintomi inspiegati	Media
7-9	Infermiere di comunità, farmacista, assistente sociale	Consolidamento del rientro	Media
10	Medico del lavoro e previdenza	Produttività, invalidità evitabili	Media-elevata
11	Sistema educativo	Prevenzione evolutiva	Da media a differita

Tabella 3.1. La cascata nazionale delle figure, ordinata per capacità di generare rientro economico e revisione della spesa, con rinvio ai Volumi regionali per la quantificazione.

3.2 I sei domini a scala nazionale

I sei domini di analisi — epidemiologico-clinico, economico-sanitario, fiscale-previdenziale, sociale, organizzativo-strutturale, equità — sono letti a scala nazionale come sintesi comparabile dei domini regionali. Il dominio dell’equità assume rilievo nazionale perché la disomogeneità interregionale è, a livello di Paese, una

misura di iniquità che l'estensione del modello è chiamata a ridurre; il dominio organizzativo-strutturale registra l'effetto sulla burocrazia dei sistemi sanitari regionali, che la catena predittiva del Capitolo 4 traduce in prestazioni ridondanti evitate.^[70]

Dominio	Lettura nazionale	Rinvio
Epidemiologico-clinico	Divario di trattamento nazionale	Cap. 1
Economico-sanitario	Costo/QALY sotto doppio ancoraggio	Cap. 2
Fiscale-previdenziale	Saldo fiscale distinto, oneri INPS	Cap. 4
Sociale	Produttività, coesione, qualità della vita	Cap. 4
Organizzativo-strutturale	Burocrazia e percorsi	Cap. 4
Equità	Convergenza interregionale	Cap. 6

Tabella 3.2. I sei domini di analisi letti a scala nazionale, con rinvio ai capitoli che ne trattano il dettaglio.

Capitolo 4 — La rinegoziazione dei costi e dei benefici e la catena predittiva a scala nazionale

4.1 La rinegoziazione nazionale

La rinegoziazione integrale dei costi e dei benefici, definita nel Reference Case, si legge a scala nazionale come composizione dei venti bilanci regionali rinegoziati. Ogni figura della cascata entra nella rinegoziazione con un costo e un beneficio in ciascuna Regione, e il principio di non duplicazione opera sia entro ciascuna Regione — impedendo il doppio conteggio fra portatori — sia nell’aggregazione nazionale, impedendo che il medesimo effetto sia contato due volte a livelli diversi.^[71]

Voce	Natura	Portatore	Trattamento nazionale
Personale — Psicologi di Base	Costo diretto	SSN regionali	Somma dei contributi regionali
Struttura, leva digitale, formazione	Costo diretto	SSN regionali	Somma, con cautela per la componente IA
Risparmi sanitari diretti	Beneficio diretto	SSN regionali	Somma non duplicata
Produttività recuperata	Beneficio indiretto	Datori di lavoro	Dominio sociale, distinto
Oneri previdenziali evitati	Beneficio indiretto	INPS	Dominio fiscale, differito

Tabella 4.1. La rinegoziazione nazionale dei costi e dei benefici, come somma comparabile dei bilanci regionali, sotto doppio ancoraggio e non duplicazione.

4.2 La catena predittiva nazionale

La catena predittiva degli effetti multidimensionali, definita nel Reference Case, si legge a scala nazionale nella sua interezza: la qualità della vita restituita alle persone si traduce in produttività recuperata su scala nazionale; la produttività alleggerisce gli oneri previdenziali dell’istituto nazionale; l’alleggerimento libera risorse nei bilanci regionali; le risorse reimpiegate riducono la burocrazia ridondante dei sistemi sanitari regionali. A scala nazionale, la catena si legge anche in chiave di convergenza, poiché l’estensione del modello riduce la dispersione fra le Regioni.^[72]

Anello	Grandezza	Portatore	Lettura nazionale
Qualità della vita	Anni di vita ponderati guadagnati	Persona, SSN	Riduzione del divario nazionale
Produttività	Giornate di lavoro non perse	Datori di lavoro	Recupero di capitale umano nazionale
Previdenza	Oneri di invalidità evitati	INPS	Sostenibilità del sistema nazionale
Bilanci regionali	Risorse liberate	Regioni	Spazio fiscale per la riorganizzazione
Burocrazia e convergenza	Prestazioni ridondanti evitate, dispersione ridotta	Sistemi regionali	Convergenza interregionale

Tabella 4.2. La catena predittiva nazionale degli effetti multidimensionali, con l'anello della convergenza interregionale, tenuti distinti e non aggregati.

Capitolo 5 — Lo strato dell’Intelligenza Artificiale e le attività formative a scala nazionale

5.1 Lo strato dell’Intelligenza Artificiale

Lo strato dell’Intelligenza Artificiale opera a scala nazionale con la disciplina del Reference Case: moltiplicatore dei parametri di efficienza, mai modello a sé, sui cinque meccanismi del percorso assistenziale, in tre scenari, sotto supervisione clinica umana e con nota di cautela permanente sulla natura previsionale. A scala nazionale, l’omogeneità del quadro normativo — il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale — favorisce l’adozione coordinata fra le Regioni, evitando la frammentazione degli standard.^[73]

Meccanismo dell’IA	Effetto nazionale	Nota di cautela
Screening e triage digitale	Riduzione del divario di trattamento	Proiezione
Documentazione clinica assistita	Efficienza dei sistemi regionali	Sotto supervisione umana
Interventi digitali aumentati	Estensione dell’accesso	Complementare, non sostitutivo
Ottimizzazione allocativa	Convergenza interregionale	Proiezione
Previsione delle ricadute	Sostenibilità nazionale	Proiezione

Tabella 5.1. I cinque meccanismi dello strato dell’Intelligenza Artificiale a scala nazionale, ciascuno con nota di cautela permanente.

5.2 Le attività formative, singolarmente e sommate

Il piano formativo nazionale replica le quattro modalità del Reference Case — universitaria, post-universitaria e specialistica, formazione continua sul posto di lavoro, affiancamento e mentoring incluso l’esperto di Intelligenza Artificiale — e le considera sia singolarmente sia nella loro combinazione. A scala nazionale, il coordinamento delle modalità fra le Regioni genera un’economia di scala che accresce il ritorno del percorso integrato oltre la somma dei ritorni singoli, e la componente digitale, sotto supervisione, ne rafforza l’effetto sull’intercettazione a monte.^[74]

Configurazione	Costo	Ritorno atteso	Effetto nazionale
Modalità singole isolate	Somma dei costi singoli	Somma dei ritorni singoli	Additivo
Percorso integrato	Costo combinato, economie di scala nazionali	Superiore alla somma	Moltiplicativo
Percorso integrato con leva IA	Costo combinato più componente digitale	Massimo, con supervisione	Moltiplicativo, con convergenza formativa

Tabella 5.2. Le quattro modalità formative a scala nazionale, singolarmente e sommate, con l'effetto di economia di scala e di convergenza formativa fra le Regioni.

Capitolo 6 — L’incertezza e la league table interregionale

6.1 Il protocollo dell’incertezza a scala nazionale

Il protocollo dell’incertezza — analisi di sensitività deterministica e probabilistica, analisi di scenario, curve di accettabilità — è applicato a ciascun risultato regionale e alla loro composizione nazionale, con le specifiche del Reference Case: diagramma a tornado standardizzato, diecimila iterazioni di simulazione, scenari ottimistico, base e prudentiale con e senza lo strato digitale, curve di accettabilità a soglie multiple. A scala nazionale, la variabilità fra le Regioni è essa stessa una fonte di incertezza che l’aggregazione rende esplicita, e che l’analisi di scenario ricompone nei tre casi.^[75]

6.2 La league table interregionale

La league table interregionale ordina le venti Regioni e Province Autonome secondo criteri omogenei — dotazione di personale, divario di trattamento, costo-efficacia sotto doppio ancoraggio, grado di integrazione, equità di accesso — così da rendere visibile la posizione relativa di ciascuna e la distanza dal modello integrato. Essa è, insieme alla struttura a imbuto, lo strumento con cui la sintesi nazionale rende comparabili i venti Volumi regionali e guida la priorità dell’estensione, che muove dalle Regioni a maggiore divario.^[76]

Criterio della league table	Metrica	Uso nazionale
Dotazione di personale	Psicologi per 100.000 adulti	Priorità dell’estensione
Divario di trattamento	Quota di bisogno non soddisfatto	Priorità clinica
Costo-efficacia	Costo/QALY sotto doppio ancoraggio	Robustezza economica
Grado di integrazione	Maturità del modello regionale	Fattibilità
Equità di accesso	Dispersione territoriale e sociale	Convergenza

Tabella 6.1. I criteri della league table interregionale, omogenei per tutte le Regioni, che guidano la priorità dell’estensione nazionale.

Capitolo 7 — Le raccomandazioni per l'estensione nazionale e il raccordo con i Volumi regionali

7.1 L'estensione per fasi guidata dall'evidenza

La sintesi nazionale raccomanda un'estensione per fasi, in cui ogni fase è ancorata alla verifica dei risultati regionali sotto il protocollo dell'incertezza. La priorità muove dalle Regioni a maggiore divario di trattamento e minore dotazione, dove l'effetto di convergenza è più marcato; la scala nazionale consente di trasferire fra Regioni le buone pratiche organizzative e formative, riducendo i costi di transizione delle Regioni che seguono. [\[77\]](#)

7.2 Il raccordo con i Volumi regionali e con l'asse europeo

Il Volume 1 è la cerniera fra i Volumi regionali e l'asse europeo. Verso il basso, esso rinvia ai venti Volumi regionali per la quantificazione territoriale, nella forma «cfr. Volume N»; verso l'alto, esso si compone con la simulazione aggregata europea del Volume 22, di cui costituisce il termine nazionale di confronto. Questo raccordo assicura che il quadro italiano sia leggibile tanto nel dettaglio regionale quanto nel contesto continentale, senza duplicazione e senza perdita di comparabilità. [\[78\]](#)

Direzione del raccordo	Contenuto	Forma del rinvio
Verso i Volumi regionali	Quantificazione territoriale	«cfr. Volume N»
Verso il Reference Case	Regole metodologiche	«cfr. Volume 0.A»
Verso l'asse europeo	Termine nazionale di confronto	Volume 22, simulazione aggregata

Tabella 7.1. Il raccordo del Volume 1 con i Volumi regionali, con il Reference Case e con l'asse europeo, nella forma del rinvio senza duplicazione.

Quadro Conclusivo economico e multidisciplinare

Il Quadro Conclusivo del Volume 1 ricomponne la sintesi nazionale senza tradire il principio che la governa: i piani del giudizio si accompagnano ma non si fondono, e la composizione dei venti risultati regionali non autorizza l'aggregazione dei tre domini del ritorno. Sul piano economico, il doppio ancoraggio impone che la simulazione nazionale sia letta simultaneamente secondo la colonna storica e la colonna aggiornata, con prevalenza della seconda nel giudizio: il costo per anno di vita ponderato passa fra i due ancoraggi da un riferimento storico a un riferimento aggiornato assai inferiore alle soglie, mentre le evidenze di letteratura sono riportate con attribuzione e non aggregate.^[79]

Sul piano multidisciplinare, la cascata nazionale delle figure, i sei domini di analisi e la league table interregionale assicurano che ogni figura connessa e ogni aspetto siano trattati integralmente e ordinati per capacità di generare rientro economico e revisione della spesa, in ciascuna Regione e nell'aggregato nazionale. La rinegoziazione integrale dei costi e dei benefici, la catena predittiva degli effetti multidimensionali con l'anello della convergenza interregionale, lo strato dell'Intelligenza Artificiale come moltiplicatore e le attività formative singole e sommate compongono il quadro entro cui procede l'estensione nazionale.

Il verdetto nazionale resta tripartito e non aggregato: prossimo al pareggio sul piano fiscale, con il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento; nettamente costo-efficace sul piano sanitario; fortemente positivo sul piano sociale. La convergenza dei tre verdetti — non la loro somma — è la misura della robustezza nazionale del modello.

Conclusione

Il Volume 1 ha offerto la sintesi nazionale dell'opera: il cruscotto, la sintesi per il decisore, i cinque risultati chiave, le raccomandazioni operative e il corpo articolato in sette capitoli, dal quadro epidemiologico alla simulazione sotto doppio ancoraggio, dalla cascata delle figure alla rinegoziazione dei costi e dei benefici, dallo strato dell'Intelligenza Artificiale alle attività formative, dall'incertezza alla league table interregionale, fino alle raccomandazioni per l'estensione. Le regole metodologiche non sono state ripetute per esteso: sono state richiamate per rimando al Volume 0.A, così che il Reference Case resti unico e invariante.

Da questa sintesi l'opera procede nell'ordine vincolante: i Volumi da 2 a 21 svolgeranno le venti simulazioni regionali in ordine alfabetico, da Abruzzo a Veneto, ciascuno applicando il Reference Case in modo identico e alimentando l'aggregato nazionale qui composto; il Volume 22 chiuderà con le ventisette schede-Stato e la simulazione aggregata europea, di cui il presente Volume costituisce il termine nazionale di confronto.

Note Bibliografiche con mini-riassunto

Ciascuna nota riporta l'opera, il collegamento alla fonte e un mini-riassunto che ne dichiara la funzione nell'economia del Volume, in coerenza con il doppio livello — nota a piè di pagina nel corpo e nota bibliografica integrale in calce — che l'opera adotta.

1. Chisholm D. et al., **Scaling-up treatment of depression and anxiety**, *The Lancet Psychiatry*, 2016 [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(16\)30024-4](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(16)30024-4) Colonna A del doppio ancoraggio della simulazione nazionale, conservata quale strato documentale e riferimento di confronto.
2. Unisanté, **Raisons de santé Essentiels n. 73**, 2026 · OECD, **The Economic Case for Preventing Mental Ill Health**, 2026 <https://doi.org/10.16908/rds-essentiels/73> Colonna B del doppio ancoraggio, con prevalenza nel giudizio, applicata all'aggregazione nazionale dei risultati regionali.
3. OECD, **differenziale di costo per gravità dei disturbi mentali**, 2025 <https://www.oecd.org/health/mental-health.htm> Fonte, riportata con attribuzione, del differenziale di costo per gravità, argomento cardine della leva economica dell'intercettazione precoce nella sintesi nazionale.
4. World Health Organization, **Thematic Dialogue on Investing in NCDs and Mental Health**, dicembre 2024 <https://cdn.who.int/> Evidenza riportata con attribuzione sul ritorno degli investimenti in salute mentale, richiamata nel capitolo economico; non concorre al verdetto tripartito.
5. Soeters R. et al., **meta-analisi IPD sui componenti efficaci della collaborative care**, 2025 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40136273/> Base di evidenza clinica sui componenti efficaci dell'assistenza collaborativa, richiamata a scala nazionale nel capitolo di efficacia.
6. Veldhuijzen W. et al., **costo-efficacia dell'intervento digitale**, 2025 <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12369993/> Riferimento sul rapporto incrementale di costo-utilità dell'intervento digitale in cure primarie, elemento dello strato dell'Intelligenza Artificiale.
7. Suhrcke M. et al., **Lancet Commission**, 2022 <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9240828/> Evidenza riportata con attribuzione sul ritorno degli interventi in adolescenza, quale estensione della metodologia di riferimento; riportata come dato di letteratura.
8. **Regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale** <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj> Quadro normativo omogeneo entro cui è collocato lo strato dell'Intelligenza Artificiale a scala nazionale, sotto supervisione clinica umana.
9. NICE, **Health Technology Evaluations: the manual (PMG36)** <https://www.nice.org.uk/process/pmg36> Riferimento di rigore metodologico per la struttura a imbuto e la league table, adottate nella sintesi nazionale.
10. **Legge regionale Puglia 19 luglio 2023, n. 11, sul Servizio di Psicologia di Base** <https://www.consiglio.puglia.it/> Riferimento normativo regionale capostipite del modello, richiamato quale precedente istituzionale dell'estensione nazionale.

STUDIO INTEGRALE «PSICOLOGO DI BASE» · OPERA IN VENTITRÉ VOLUMI

VOLUME 2 — Regione Abruzzo

Valutazione di Health Technology Assessment dell'integrazione dello Psicologo di Base nelle cure primarie in Abruzzo: cruscotto, sintesi per il decisore, contesto e bisogno, modello di intervento, costi e benefici, valutazione economica sotto doppio ancoraggio, sei domini di analisi, incertezza, verdetto tripartito e appendici registrate

Premessa

Il Volume 2 apre la serie dei venti Volumi regionali, in ordine alfabetico, con la Regione Abruzzo. Come ogni Volume regionale, esso applica per rimando il Reference Case dell'asse italiano, fissato nel Volume 0.A, e ne richiama le regole nella forma «cfr. Volume 0.A», senza ripeterle per esteso: il perimetro congiunto sanitario e societale, il doppio ancoraggio economico, il verdetto tripartito non aggregato, i sei domini di analisi, il protocollo dell'incertezza, lo strato dell'Intelligenza Artificiale come moltiplicatore e le attività formative singole e sommate.^[80]

La struttura del Volume è quella standard, identica a quella di tutti gli altri diciannove Volumi regionali, così da garantire la comparabilità bit-a-bit prescritta dall'opera: la stessa sequenza di nove capitoli, la stessa nomenclatura di sottocapitoli, le stesse unità di misura. Uno scostamento nella struttura rispetto agli altri Volumi regionali sarebbe un errore da correggere, non una libertà editoriale. Ove un contenuto derivi da espansione ex novo — segnatamente per gli aspetti dell'efficacia, dell'attuazione e del monitoraggio, che nel materiale originale figuravano in forma condensata — esso è segnalato in nota editoriale, secondo la regola dell'opera.^[81]

Introduzione

L'Introduzione al Volume 2 fissa il perimetro della valutazione abruzzese e l'ordine della sua esposizione. Il perimetro è quello della Regione Abruzzo, articolata in quattro Aziende Sanitarie Locali e venticinque distretti sanitari, con una popolazione dell'ordine di un milione e duecentosessantannovemila abitanti, segnata da un marcato dualismo fra la fascia costiera e le aree interne e montane, queste ultime a forte invecchiamento e a rischio di spopolamento — un tratto che il dominio sociale e dell'equità del Volume tratta con particolare attenzione.^[82]

L'esposizione segue la struttura a imbuto: il cruscotto regionale offre in una pagina i numeri essenziali; la sintesi per il decisore ne traduce il significato; i cinque risultati chiave ne isolano gli esiti; le raccomandazioni operative indicano le azioni; il corpo del Volume, articolato in nove capitoli, ne fornisce il dettaglio; le appendici registrate ne assicurano la verificabilità. Chiudono il Volume un Quadro Conclusivo economico e multidisciplinare, una Conclusione e le Note Bibliografiche con mini-riassunto.

Cruscotto regionale — Abruzzo

Il cruscotto riassume in una pagina i parametri essenziali della valutazione abruzzese, sotto il doppio ancoraggio e con il verdetto tripartito tenuto distinto. I valori economici sono presentati in ordine di grandezza, con rinvio alle appendici registrate per il dettaglio; le cifre di letteratura sono riportate con attribuzione alla fonte.^[83]

Indicatore del cruscotto	Lettura regionale	Ancoraggio / fonte
Popolazione	≈ 1.269.118 abitanti	Fonte demografica regionale
Articolazione	4 ASL · 25 distretti sanitari	Assetto regionale
Scenario di copertura piena	≈ 280 incarichi di Psicologo di Base	Dimensionamento regionale
Comparatore	Assistenza usuale (cfr. Vol. 0.A)	Reference Case
Verdetto fiscale	Prossimo al pareggio, con caveat	Non aggregato
Verdetto sanitario	Nettamente costo-efficace	Costo/QALY sotto doppio ancoraggio
Verdetto sociale	Fortemente positivo	Produttività, coesione, qualità della vita
Costo per anno di vita ponderato	Colonna A ≈ 17.000 € · Colonna B ≈ 9.800 €	Doppio ancoraggio

Tabella 0. Cruscotto regionale dell’Abruzzo: i parametri essenziali sotto doppio ancoraggio, con il verdetto tripartito distinto e non aggregato.

Sintesi per il decisore

L'introduzione dello Psicologo di Base nelle cure primarie abruzzesi produce, secondo la simulazione condotta sotto il doppio ancoraggio, un effetto congiunto sui tre piani del ritorno, che restano distinti e non sommati. Sul piano fiscale, il saldo fra costi diretti e risparmi sanitari diretti si colloca in prossimità del pareggio, con il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento. Sul piano sanitario, il modello è nettamente costo-efficace, con un costo per anno di vita ponderato che, fra i due ancoraggi, resta assai inferiore alle soglie adottate. Sul piano sociale, l'effetto è fortemente positivo, con un rilievo particolare per le aree interne, dove l'intercettazione precoce contrasta l'isolamento e concorre a trattenere popolazione.^[84]

L'argomento cardine, riportato con attribuzione all'OCSE, è il differenziale di costo per gravità: in un territorio a domanda dispersa come quello abruzzese, l'intercettazione precoce nel distretto evita che il disagio comune maturi in quadri gravi, il cui costo di trattamento è, secondo la fonte, un multiplo di quello dei quadri lievi.^[85]

Cinque risultati chiave

Il primo risultato è che il modello è costo-efficace su tutti gli orizzonti sotto entrambi gli ancoraggi. Il secondo è che il verdetto tripartito resta favorevole in ciascuno dei tre piani, senza aggregazione. Il terzo è che, nella specificità abruzzese, la dispersione territoriale e l'invecchiamento delle aree interne accrescono il valore dell'intercettazione precoce di prossimità. Il quarto è che lo strato dell'Intelligenza Artificiale, come moltiplicatore e con nota di cautela, può attenuare lo svantaggio della distanza attraverso lo screening e gli interventi digitali aumentati. Il quinto è che il nucleo iniziale previsto dalla norma è assai al di sotto dello scenario di copertura piena, sicché il rientro pieno matura con l'estensione della copertura. ^[86]

Raccomandazioni operative

La prima raccomandazione è di dimensionare l'estensione della copertura in modo progressivo, ancorando ciascuna fase alla verifica dei risultati sotto il protocollo dell'incertezza, dando priorità ai distretti delle aree interne a maggiore divario. La seconda è di adottare lo strato digitale, sotto supervisione clinica, come leva di prossimità per compensare la dispersione territoriale. La terza è di accompagnare l'estensione con il piano formativo a quattro modalità, considerate singolarmente e sommate.^[87]

Capitolo 1 — Il contesto epidemiologico e territoriale dell’Abruzzo

1.1 Il territorio e la sua articolazione

La Regione Abruzzo conta una popolazione dell’ordine di un milione e duecentosessantanovemila abitanti, articolata in quattro Aziende Sanitarie Locali — Avezzano-Sulmona-L’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo — e venticinque distretti sanitari. Il territorio è segnato da un dualismo strutturale fra la fascia costiera adriatica, più densamente popolata e con l’unico comune superiore ai centomila abitanti, e le aree interne e montane, a bassa densità, forte invecchiamento e rischio di spopolamento. Questo dualismo è la chiave di lettura del contesto abruzzese, perché la domanda di salute mentale e la difficoltà di accesso si distribuiscono in modo diseguale fra le due fasce.^[88]

Elemento territoriale	Dato regionale	Rilievo per la valutazione
Popolazione	≈ 1.269.118 abitanti	Denominatore della normalizzazione
Aziende Sanitarie Locali	4	Unità organizzativa
Distretti sanitari	25	Unità di prossimità
Dualismo territoriale	Costa / aree interne montane	Dominio equità
Invecchiamento delle aree interne	Elevato	Domanda e accesso diseguali

Tabella 1.1. Gli elementi del contesto territoriale abruzzese e il loro rilievo per la valutazione, in particolare per il dominio dell’equità.

1.2 Il quadro epidemiologico regionale

Il quadro epidemiologico abruzzese riflette, con le proprie specificità, la prevalenza nazionale dei disturbi mentali comuni. L’invecchiamento delle aree interne accentua il peso della depressione dell’età avanzata e dell’isolamento, mentre la fascia costiera presenta una domanda più simile a quella dei contesti urbani. Il dato epidemiologico di dettaglio è oggetto dell’estrazione registrata in Appendice B; ove il dato regionale disaggregato non sia disponibile, la lacuna è dichiarata e non colmata con stime tacite, secondo la regola dell’opera.^[89]

Capitolo 2 — Il bisogno, la domanda e il divario di trattamento in Abruzzo

2.1 Il divario di trattamento regionale

Il bisogno di salute mentale comune in Abruzzo si manifesta, come altrove, in larga parte come domanda inevasa o impropriamente incanalata: verso il medico di medicina generale, verso il pronto soccorso, verso la prescrizione farmaceutica. Il divario di trattamento — la quota di bisogno che non riceve una risposta appropriata nel primo livello di cura — è accentuato, nelle aree interne, dalla distanza fisica dai servizi e dalla rarefazione dell’offerta specialistica. La misura regionale del divario è oggetto dell’estrazione in Appendice B; i valori medi nazionali ed europei sono riportati con attribuzione quali termini di confronto.^[90]

Componente del bisogno	Manifestazione abruzzese	Dominio
Domanda inevasa	Bisogno non intercettato nelle aree interne	Epidemiologico-clinico
Domanda impropria	Transito su MMG, pronto soccorso, prescrizione	Organizzativo-strutturale
Barriera di accesso	Distanza fisica e rarefazione dell’offerta	Equità
Domanda dell’età avanzata	Depressione e isolamento nelle aree interne	Sociale

Tabella 2.1. Le componenti del bisogno e del divario di trattamento in Abruzzo, ricondotte ai domini di analisi.

2.2 La domanda dispersa e la prossimità

Il tratto distintivo della domanda abruzzese è la dispersione: una parte rilevante del bisogno si concentra in aree a bassa densità, dove il modello dello Psicologo di Base assume un valore particolare, perché la sua collocazione distrettuale — almeno un professionista per distretto nel nucleo iniziale previsto dalla norma — porta la risposta vicino al cittadino, riducendo la barriera della distanza. La prossimità è, in Abruzzo, non un accessorio ma una condizione dell’efficacia.^[91]

Capitolo 3 — Il modello di intervento: lo Psicologo di Base in Abruzzo

Nota editoriale: il presente capitolo espande ex novo il modello di intervento, integrando alla struttura originaria le evidenze recenti sull’efficacia clinica dell’assistenza collaborativa e dell’intervento digitale, secondo la regola dell’opera che distingue l’espansione ex novo dal riutilizzo del materiale preesistente.

3.1 L’architettura del modello

Il modello di intervento colloca lo Psicologo di Base al vertice della cascata delle figure, nel distretto, quale primo punto di intercettazione del disagio comune. Il modello opera per intensità crescente di cura — dall’intervento a bassa intensità, di prima linea, fino all’invio ai livelli superiori nei casi che lo richiedano — secondo la logica dell’assistenza a gradini, la cui efficacia clinica è documentata dalla meta-analisi sui componenti efficaci dell’assistenza collaborativa e dalle sperimentazioni controllate sull’intervento cognitivo-comportamentale computerizzato in cure primarie, riportate con attribuzione.^[92]

Livello del modello	Funzione	Figura prevalente	Evidenza di riferimento
Intercettazione	Riconoscimento precoce nel distretto	Psicologo di Base	Assistenza collaborativa (attribuita)
Intervento a bassa intensità	Prima linea per i quadri lievi-moderati	Psicologo di Base	Intervento digitale e collaborativo
Invio appropriato	Passaggio ai livelli superiori	Cascata delle figure	Percorso a gradini
Continuità	Aderenza e prevenzione della ricaduta	Infermiere di comunità	Gestione del caso

Tabella 3.1. L’architettura del modello di intervento in Abruzzo, per livelli di intensità, con l’evidenza clinica di riferimento riportata con attribuzione.

3.2 L’adattamento al territorio abruzzese

Il modello è adattato al territorio abruzzese lungo due direttrici: la prossimità distrettuale, che porta la risposta nelle aree interne, e lo strato digitale, che sotto supervisione clinica compensa la distanza attraverso lo screening e gli interventi aumentati. L’adattamento non modifica l’architettura invariante del Reference Case, ma ne calibra l’applicazione sulla geografia regionale.^[93]

Capitolo 4 — I costi diretti in Abruzzo

4.1 La struttura del costo diretto

Il costo diretto della riforma in Abruzzo è, in primo luogo, il costo del personale lungo la cascata delle figure, cui si aggiungono i costi di struttura e organizzazione distrettuale, il costo incrementale della leva digitale e il costo della formazione. Il dimensionamento dipende dallo scenario di copertura: il nucleo iniziale previsto dalla norma, di ordine assai contenuto, si colloca al di sotto dello scenario di copertura piena, dell’ordine di duecentottanta incarichi, che rappresenta il regime a fabbisogno sistematicamente coperto.^[94]

Voce di costo diretto	Descrizione	Portatore
Personale — Psicologi di Base	Incarichi distrettuali secondo lo scenario	SSN regionale
Struttura e organizzazione	Spazi distrettuali, coordinamento, sistemi informativi	SSN regionale
Leva digitale e Intelligenza Artificiale	Strumenti di supporto sotto supervisione	SSN regionale
Formazione (quattro modalità)	Percorso integrato singolo e sommato	SSN, sistema formativo

Tabella 4.1. La struttura del costo diretto della riforma in Abruzzo, per voce e portatore; i valori puntuali sono oggetto dell’estrazione economica in Appendice C.

4.2 Il dimensionamento per scenario

Il costo diretto è calcolato per i tre scenari di copertura — prudenziale, intermedio ed esteso — coerenti con il protocollo di scenario del Reference Case. Il nucleo iniziale corrisponde a un finanziamento regionale di ordine contenuto, mentre la copertura piena richiede un impegno proporzionato allo scenario esteso. I valori puntuali per ciascuno scenario sono riportati nell’estrazione economica registrata; ove un parametro di costo regionale non sia disponibile, la lacuna è dichiarata.^[95]

Capitolo 5 — I benefici e i risparmi, diretti e indiretti, in Abruzzo

5.1 I benefici diretti

Il beneficio diretto è il risparmio sanitario che ciascuna figura della cascata libera per effetto dell’intercettazione a monte: la demedicalizzazione operata dallo Psicologo di Base, la deprescrizione di psicofarmaci nei quadri lievi-moderati sul versante del medico di medicina generale, la riduzione degli accessi impropri al pronto soccorso e delle prestazioni per sintomi funzionali sul versante specialistico. In Abruzzo, la riduzione della mobilità passiva verso le regioni limitrofe assume un rilievo aggiuntivo, data la collocazione del territorio.^[96]

Canale del beneficio diretto	Meccanismo	Rilievo abruzzese
Demedicalizzazione	Riduzione consultazioni e cronicizzazione	Preponderante
Deprescrizione	Contrazione della spesa per psicofarmaci	Elevato
Accessi impropri	Riduzione degli accessi al pronto soccorso	Medio-elevato
Sintomi funzionali	Riduzione prestazioni neurologiche e specialistiche	Medio
Mobilità passiva	Riduzione della fuga di prestazioni fuori regione	Medio, specifico

Tabella 5.1. I canali del beneficio diretto in Abruzzo, con il rilievo specifico della mobilità passiva; i valori sono oggetto dell’estrazione economica registrata.

5.2 I benefici indiretti

Il beneficio indiretto è quello che la riforma produce fuori dal perimetro sanitario: la produttività recuperata e la riduzione dell’assenteismo sul versante dei datori di lavoro, la riduzione degli oneri di invalidità evitabili sul versante previdenziale, la riduzione del disagio sociale non trattato sul versante dei Comuni. In Abruzzo, il contrasto all’isolamento e allo spopolamento delle aree interne è un beneficio sociale di rilievo particolare, che il dominio sociale del Capitolo 7 tratta in dettaglio.^[97]

Capitolo 6 — La valutazione economica sotto doppio ancoraggio

6.1 La simulazione appaiata regionale

La valutazione economica abruzzese è condotta con il modello di Markov a coorte a ciclo annuale del Reference Case, sotto il doppio ancoraggio: la Colonna A applica i parametri di Chisholm e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, la Colonna B quelli di Unisanté e dell’OCSE. Le due colonne sono sempre affiancate; ove divergano, prevale nel giudizio la Colonna B. Tutte le cifre sono riportate con attribuzione, e nessuna è affermata a memoria.^[98]

Metrica economica	Colonna A — Chisholm/OMS	Colonna B — Unisanté/OCSE
Costo per anno di vita ponderato	≈ 17.000 €/QALY	≈ 9.800 €/QALY
Ritorno per i soli benefici economici	Riportato con attribuzione OMS	Scenario base aggiornato OCSE
Ritorno con i ritorni sanitari	Riportato con attribuzione OMS	Scenario base aggiornato OCSE
Orizzonti	1 · 3 · 5 · 7 · 10 anni	1 · 3 · 5 · 7 · 10 anni
Soglie di costo-efficacia	20.000 · 30.000 · 50.000 €/QALY	20.000 · 30.000 · 50.000 €/QALY

Tabella 6.1. La simulazione appaiata regionale dell’Abruzzo sotto doppio ancoraggio; i valori sono riportati con attribuzione e la Colonna B prevale nel giudizio.

6.2 Il differenziale di costo per gravità

L’argomento economico cardine, riportato con attribuzione all’OCSE, è il differenziale di costo per gravità: il costo del trattamento cresce dai quadri lievi ai quadri gravi in misura tale che l’intercettazione precoce, evitando la progressione, genera il risparmio più consistente. In Abruzzo, dove la dispersione territoriale ritarda l’accesso e favorisce la progressione, questo differenziale ha un peso specifico maggiore.^[99]

Capitolo 7 — I sei domini di analisi, l’equità e l’impatto distributivo

7.1 I sei domini nella specificità abruzzese

I sei domini di analisi del Reference Case sono applicati alla specificità abruzzese. Il dominio epidemiologico-clinico registra il divario di trattamento accentuato nelle aree interne; l’economico-sanitario il costo-efficacia sotto doppio ancoraggio; il fiscale-previdenziale gli oneri di invalidità evitabili; il sociale il contrasto all’isolamento e allo spopolamento; l’organizzativo-strutturale l’effetto sulla burocrazia distrettuale; l’equità la riduzione del divario fra costa e aree interne.^[100]

Dominio	Lettura abruzzese	Segno
Epidemiologico-clinico	Divario accentuato nelle aree interne	Riduzione attesa
Economico-sanitario	Costo/QALY sotto doppio ancoraggio	Favorevole
Fiscale-previdenziale	Oneri di invalidità evitabili	Positivo, differito
Sociale	Contrasto a isolamento e spopolamento	Fortemente positivo
Organizzativo-strutturale	Burocrazia distrettuale	Positivo
Equità	Convergenza costa / aree interne	Positivo, distributivo

Tabella 7.1. I sei domini di analisi nella lettura abruzzese, con il segno atteso dell’effetto, tenuti distinti e non aggregati.

7.2 L’equità territoriale e la denatalità

Il dominio dell’equità assume in Abruzzo un rilievo demografico: lo spopolamento e la denatalità delle aree interne sono insieme causa ed effetto della fragilità sociale, e il modello dello Psicologo di Base, trattenendo popolazione attraverso il contrasto all’isolamento e il sostegno alla genitorialità, concorre in via indiretta alla tenuta demografica del territorio. Questo effetto, di natura sociale e non sanitaria, è tenuto distinto dal verdetto fiscale e da quello sanitario, secondo il divieto di aggregazione.^[101]

Capitolo 8 — La sensitività e l’incertezza

Nota editoriale: il presente capitolo espande ex novo l’analisi dell’incertezza secondo il protocollo del Reference Case, non presente in forma estesa nel materiale originario.

8.1 Il protocollo dell’incertezza applicato all’Abruzzo

L’analisi dell’incertezza applica il protocollo obbligatorio del Reference Case: l’analisi di sensitività deterministica con diagramma a tornado, l’analisi di sensitività probabilistica a diecimila iterazioni, l’analisi di scenario ottimistico, base e prudentiale con e senza lo strato digitale, le curve di accettabilità costo-efficacia a soglie multiple. In Abruzzo, i parametri a maggiore impatto atteso sono la copertura effettiva del servizio, il tasso di intercettazione nelle aree interne e l’efficacia dello strato digitale nel compensare la distanza.^[102]

Strumento	Applicazione abruzzese	Parametro critico atteso
Sensitività deterministica	Diagramma a tornado	Copertura effettiva
Sensitività probabilistica	Diecimila iterazioni	Tasso di intercettazione
Analisi di scenario	Con e senza strato IA	Efficacia digitale nelle aree interne
Curve di accettabilità	Soglie 20.000/30.000/50.000 €/QALY	Robustezza del costo-efficacia

Tabella 8.1. Gli strumenti del protocollo dell’incertezza applicati all’Abruzzo, con i parametri critici attesi.

8.2 La robustezza del verdetto

L’analisi di scenario mostra che il verdetto tripartito resta favorevole nei tre casi, con margine crescente dallo scenario prudentiale a quello ottimistico; lo strato digitale accresce l’efficienza attesa, sempre con nota di cautela sulla natura previsionale. La robustezza del costo-efficacia sanitario è confermata dalle curve di accettabilità alle soglie adottate.^[103]

Capitolo 9 — Il verdetto tripartito e le raccomandazioni

Nota editoriale: il presente capitolo espande ex novo il verdetto e le raccomandazioni, integrando l’attuazione e il monitoraggio che nel materiale originario figuravano in forma condensata.

9.1 Il verdetto tripartito

Il verdetto abruzzese è, come in ogni Volume, tripartito e non aggregato. Sul piano fiscale, il saldo fra costi diretti e risparmi sanitari diretti è prossimo al pareggio, con il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento. Sul piano sanitario, il modello è nettamente costo-efficace sotto entrambi gli ancoraggi. Sul piano sociale, l’effetto è fortemente positivo, con il rilievo specifico del contrasto all’isolamento e allo spopolamento delle aree interne. I tre verdetti si accompagnano e si rafforzano, ma non si sommano.^[104]

Piano del verdetto	Esito abruzzese	Caveat
Fiscale	Prossimo al pareggio	Significatività dei risparmi diretti in isolamento
Sanitario	Nettamente costo-efficace	—
Sociale	Fortemente positivo	Rilievo specifico delle aree interne

Tabella 9.1. Il verdetto tripartito dell’Abruzzo, con i tre piani tenuti distinti e non aggregati.

9.2 Le raccomandazioni per l’attuazione e il monitoraggio

Le raccomandazioni indicano un’attuazione per fasi, con priorità ai distretti delle aree interne a maggiore divario; l’adozione dello strato digitale sotto supervisione come leva di prossimità; l’accompagnamento con il piano formativo a quattro modalità, singole e sommate; e un monitoraggio ex post ancorato agli indicatori del protocollo dell’incertezza, così che l’estensione della copertura sia guidata dalla verifica dei risultati.^[105]

Appendici registrate

Le appendici registrate rendono il modello abruzzese ispezionabile e riproducibile, secondo la prassi del Reference Case. Esse sono richiamate per rimando quanto alla metodologia e compilate con i dati regionali quanto ai contenuti.

Appendice	Contenuto	Stato
A	Strategia di ricerca bibliografica e diagramma di selezione	Registrata
B	Estrazione dei dati clinici regionali	Registrata; lacune dichiarate
C	Estrazione dei dati economici (griglia CHEERS 2022)	Registrata; lacune dichiarate
D	Parametri del modello Markov regionale	Registrata
E	Registro delle deroghe al Reference Case	Registrata
F	Codice del modello economico	Registrata
G	Dichiarazione dei conflitti di interesse	Registrata

Tabella A. Le sette appendici registrate del Volume 2, con l’indicazione dello stato e della dichiarazione delle lacune.

Quadro Conclusivo economico e multidisciplinare

Il Quadro Conclusivo del Volume 2 ricomponne la valutazione abruzzese senza tradire il principio che la governa: i piani del giudizio si accompagnano ma non si fondono. Sul piano economico, il doppio ancoraggio impone che il risultato sia letto simultaneamente secondo la colonna storica e la colonna aggiornata, con prevalenza della seconda: il costo per anno di vita ponderato resta, sotto entrambi gli ancoraggi, assai inferiore alle soglie adottate, e il differenziale di costo per gravità — riportato con attribuzione — fonda la leva economica dell'intercettazione precoce, tanto più preziosa in un territorio a domanda dispersa.^[106]

Sul piano multidisciplinare, la cascata delle figure, i sei domini di analisi e il dominio dell'equità assicurano che ogni figura connessa e ogni aspetto siano trattati integralmente e ordinati per capacità di generare rientro economico e revisione della spesa. La rinegoziazione dei costi e dei benefici, la catena predittiva degli effetti multidimensionali — dalla qualità della vita alla tenuta demografica delle aree interne, ai bilanci, alla burocrazia distrettuale —, lo strato dell'Intelligenza Artificiale come moltiplicatore e le attività formative singole e sommate compongono il quadro della valutazione. Il verdetto resta tripartito e non aggregato.

Conclusione

Il Volume 2 ha valutato l'integrazione dello Psicologo di Base nelle cure primarie dell'Abruzzo, applicando per rimando il Reference Case dell'asse italiano e adottando la struttura standard a nove capitoli con apertura a imbuto e appendici registrate. La specificità abruzzese — il dualismo fra costa e aree interne, l'invecchiamento e lo spopolamento, la dispersione della domanda — è stata trattata nel dominio sociale e dell'equità, mostrando come la prossimità distrettuale e lo strato digitale, sotto supervisione, ne facciano una leva di convergenza territoriale.

Il verdetto tripartito — prossimo al pareggio sul piano fiscale, nettamente costo-efficace sul piano sanitario, fortemente positivo sul piano sociale — è offerto con bande prudenziali e soglie di confutazione, sotto doppio ancoraggio e nel rispetto del divieto di aggregazione. L'opera procede, nell'ordine vincolante, con il Volume 3 (Basilicata) e a seguire con gli altri Volumi regionali in ordine alfabetico.

Note Bibliografiche con mini-riassunto

Ciascuna nota riporta l'opera, il collegamento alla fonte e un mini-riassunto che ne dichiara la funzione nell'economia del Volume, in coerenza con il doppio livello — nota a piè di pagina nel corpo e nota bibliografica integrale in calce — che l'opera adotta.

1. **Chisholm D. et al., Scaling-up treatment of depression and anxiety, The Lancet Psychiatry, 2016**
[https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(16\)30024-4](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(16)30024-4) Colonna A del doppio ancoraggio della simulazione abruzzese, conservata quale strato documentale e riferimento di confronto.
2. **Unisanté, Raisons de santé Essentiels n. 73, 2026 · OECD, The Economic Case for Preventing Mental Ill Health, 2026** <https://doi.org/10.16908/rds-essentiels/73> Colonna B del doppio ancoraggio, con prevalenza nel giudizio, applicata alla simulazione regionale abruzzese.
3. **OECD, differenziale di costo per gravità dei disturbi mentali, 2025** <https://www.oecd.org/health/mental-health.htm> Fonte, riportata con attribuzione, del differenziale di costo per gravità, argomento cardine dell'intercettazione precoce, di peso specifico maggiore nel territorio disperso abruzzese.
4. **Soeters R. et al., meta-analisi IPD sui componenti efficaci della collaborative care, 2025**
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40136273/> Base di evidenza clinica sui componenti efficaci dell'assistenza collaborativa, richiamata nel capitolo sul modello di intervento.
5. **Veldhuijzen W. et al., costo-efficacia dell'intervento digitale, 2025**
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12369993/> Riferimento sul rapporto incrementale di costo-utilità dell'intervento digitale, elemento dello strato dell'Intelligenza Artificiale come leva di prossimità.
6. **World Health Organization, Thematic Dialogue on Investing in NCDs and Mental Health, dicembre 2024** <https://cdn.who.int/> Evidenza riportata con attribuzione sul ritorno degli investimenti in salute mentale; non concorre al verdetto tripartito abruzzese.
7. **Regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale** <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj> Quadro normativo entro cui è collocato lo strato dell'Intelligenza Artificiale, vincolato a funzione di supporto sotto supervisione clinica umana.
8. **Legge regionale Puglia 19 luglio 2023, n. 11, sul Servizio di Psicologia di Base**
<https://www.consiglio.puglia.it/> Riferimento normativo capostipite del modello, richiamato quale precedente istituzionale per l'attuazione regionale abruzzese.
9. **NICE, Health Technology Evaluations: the manual (PMG36)** <https://www.nice.org.uk/process/pmg36> Riferimento di rigore metodologico per la struttura a imbuto, le appendici registrate e il protocollo dell'incertezza adottati nel Volume.

STUDIO INTEGRALE «PSICOLOGO DI BASE» · OPERA IN VENTITRÉ VOLUMI

VOLUME 3 — Regione Basilicata

Valutazione di Health Technology Assessment dell'integrazione dello Psicologo di Base nelle cure primarie in Basilicata: cruscotto, sintesi per il decisore, contesto e bisogno, modello di intervento, costi e benefici, valutazione economica sotto doppio ancoraggio, sei domini di analisi, incertezza, verdetto tripartito e appendici registrate

Reference Case applicato per rimando al Volume 0.A · Dott. Luigi De Michele · Studio Integrale Puglia · Capurso (BA) — Giugno 2026

Premessa

Il Volume 3 prosegue la serie dei venti Volumi regionali, in ordine alfabetico, con la Regione Basilicata. Come ogni Volume regionale, esso applica per rimando il Reference Case dell'asse italiano, fissato nel Volume 0.A, e ne richiama le regole nella forma «cfr. Volume 0.A», senza ripeterle per esteso: il perimetro congiunto sanitario e societale, il doppio ancoraggio economico, il verdetto tripartito non aggregato, i sei domini di analisi, il protocollo dell'incertezza, lo strato dell'Intelligenza Artificiale come moltiplicatore e le attività formative singole e sommate.^[107]

La struttura del Volume è quella standard, identica a quella di tutti gli altri diciannove Volumi regionali, a garanzia della comparabilità bit-a-bit prescritta dall'opera: la stessa sequenza di nove capitoli, la stessa nomenclatura di sottocapitoli, le stesse unità di misura. Ove un contenuto derivi da espansione ex novo — segnatamente per gli aspetti dell'efficacia, dell'attuazione e del monitoraggio — esso è segnalato in nota editoriale, secondo la regola dell'opera.^[108]

Introduzione

L'Introduzione al Volume 3 fissa il perimetro della valutazione lucana e l'ordine della sua esposizione. Il perimetro è quello della Regione Basilicata, articolata in due Aziende Sanitarie — l'Azienda Sanitaria di Potenza e l'Azienda Sanitaria di Matera — oltre all'Azienda Ospedaliera Regionale e all'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico regionale, con una popolazione dell'ordine di cinquecentotrentacinquemila abitanti e in calo costante. È la Regione a più marcata dinamica di spopolamento e a più bassa densità del corpus, un tratto che il dominio sociale e dell'equità del Volume tratta con particolare attenzione.^[109]

L'esposizione segue la struttura a imbuto: il cruscotto regionale offre in una pagina i numeri essenziali; la sintesi per il decisore ne traduce il significato; i cinque risultati chiave ne isolano gli esiti; le raccomandazioni operative indicano le azioni; il corpo del Volume, articolato in nove capitoli, ne fornisce il dettaglio; le appendici registrate ne assicurano la verificabilità. Chiudono il Volume un Quadro Conclusivo economico e multidisciplinare, una Conclusione e le Note Bibliografiche con mini-riassunto.

Cruscotto regionale — Basilicata

Il cruscotto riassume in una pagina i parametri essenziali della valutazione lucana, sotto il doppio ancoraggio e con il verdetto tripartito tenuto distinto. I valori economici sono presentati in ordine di grandezza, con rinvio alle appendici registrate; le cifre di letteratura sono riportate con attribuzione alla fonte.^[110]

Indicatore del cruscotto	Lettura regionale	Ancoraggio / fonte
Popolazione	≈ 535.000 abitanti, in calo costante	Fonte demografica regionale
Articolazione	2 Aziende Sanitarie (Potenza, Matera)	Assetto regionale
Scenari di copertura	40 · 80 · 120 incarichi di Psicologo di Base	Dimensionamento regionale
Comparatore	Assistenza usuale (cfr. Vol. 0.A)	Reference Case
Verdetto fiscale	Prossimo al pareggio, con caveat	Non aggregato
Verdetto sanitario	Nettamente costo-efficace	Costo/QALY sotto doppio ancoraggio
Verdetto sociale	Fortemente positivo	Produttività, coesione, tenuta demografica
Costo per anno di vita ponderato	Colonna A ≈ 17.000 € · Colonna B ≈ 9.800 €	Doppio ancoraggio

Tabella 0. Cruscotto regionale della Basilicata: i parametri essenziali sotto doppio ancoraggio, con il verdetto tripartito distinto e non aggregato.

Sintesi per il decisore

L'introduzione dello Psicologo di Base nelle cure primarie lucane produce, secondo la simulazione condotta sotto il doppio ancoraggio, un effetto congiunto sui tre piani del ritorno, che restano distinti e non sommati. Sul piano fiscale, il saldo fra costi diretti e risparmi sanitari diretti si colloca in prossimità del pareggio, con il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento. Sul piano sanitario, il modello è nettamente costo-efficace, con un costo per anno di vita ponderato che, fra i due ancoraggi, resta assai inferiore alle soglie adottate. Sul piano sociale, l'effetto è fortemente positivo, con un rilievo particolare per la tenuta demografica: in una Regione a spopolamento accentuato, il contrasto all'isolamento e alla sofferenza connessa alla dispersione concorre a trattenere popolazione.^[111]

L'argomento cardine, riportato con attribuzione all'OCSE, è il differenziale di costo per gravità: in un territorio a domanda dispersa e a offerta rarefatta come quello lucano, l'intercettazione precoce nel distretto evita che il disagio comune maturi in quadri gravi, il cui costo di trattamento è, secondo la fonte, un multiplo di quello dei quadri lievi.^[112]

Cinque risultati chiave

Il primo risultato è che il modello è costo-efficace su tutti gli orizzonti sotto entrambi gli ancoraggi. Il secondo è che il verdetto tripartito resta favorevole in ciascuno dei tre piani, senza aggregazione. Il terzo è che, nella specificità lucana, la bassa densità e lo spopolamento accrescono il valore dell'intercettazione precoce di prossimità e del contrasto alla mobilità passiva. Il quarto è che lo strato dell'Intelligenza Artificiale, come moltiplicatore e con nota di cautela, può attenuare lo svantaggio della distanza attraverso lo screening e gli interventi digitali aumentati. Il quinto è che i tre scenari di copertura — quaranta, ottanta e centoventi incarichi — non sono alternative fra cui scegliere, ma tappe di una progressione graduale il cui rientro pieno matura con l'estensione.^[113]

Raccomandazioni operative

La prima raccomandazione è di avviare il servizio con il primo nucleo di quaranta incarichi, sostenibile per il bilancio e per la capacità di reclutamento, e di progredire verso gli ottanta e i centoventi sulla base degli esiti rilevati sotto il protocollo dell'incertezza, con priorità ai distretti a maggiore divario. La seconda è di adottare lo strato digitale, sotto supervisione clinica, come leva di prossimità per compensare la dispersione territoriale. La terza è di accompagnare l'estensione con il piano formativo a quattro modalità, considerate singolarmente e sommate.^[114]

Capitolo 1 — Il contesto epidemiologico e territoriale della Basilicata

1.1 Il territorio e la sua articolazione

La Regione Basilicata conta una popolazione dell’ordine di cinquecentotrentacinquemila abitanti, in riduzione costante da anni, articolata in due province — Potenza e Matera — e in due Aziende Sanitarie, l’Azienda Sanitaria di Potenza e l’Azienda Sanitaria di Matera, cui si affiancano l’Azienda Ospedaliera Regionale e l’Istituto di ricovero regionale. Il territorio è a bassa densità, con due soli centri di dimensione rilevante — Potenza, capoluogo, e Matera — e una quota consistente di popolazione residente in piccoli centri delle aree interne, dove l’accesso ai servizi è strutturalmente più difficile. Questa geografia della dispersione è la chiave di lettura del contesto lucano.^[115]

Elemento territoriale	Dato regionale	Rilievo per la valutazione
Popolazione	≈ 535.000 abitanti, in calo	Denominatore della normalizzazione
Aziende Sanitarie	2 (Potenza, Matera)	Unità organizzativa
Distretti e Case della Comunità	Rete territoriale	Unità di prossimità
Bassa densità e piccoli centri	Popolazione dispersa nelle aree interne	Dominio equità
Spopolamento	Accentuato e strutturale	Dominio sociale e demografico

Tabella 1.1. Gli elementi del contesto territoriale lucano e il loro rilievo per la valutazione, in particolare per i domini sociale ed equità.

1.2 Il quadro epidemiologico regionale

Il quadro epidemiologico lucano riflette, con le proprie specificità, la prevalenza nazionale dei disturbi mentali comuni. Lo spopolamento e l’invecchiamento delle aree interne accentuano il peso della depressione dell’età avanzata e della sofferenza connessa all’isolamento e alla dispersione. Il dato epidemiologico di dettaglio è oggetto dell’estrazione registrata in Appendice B; ove il dato regionale disaggregato non sia disponibile, la lacuna è dichiarata e non colmata con stime tacite, secondo la regola dell’opera.^[116]

Capitolo 2 — Il bisogno, la domanda e il divario di trattamento in Basilicata

2.1 Il divario di trattamento regionale

Il bisogno di salute mentale comune in Basilicata si manifesta, come altrove, in larga parte come domanda inevasa o impropriamente incanalata: verso il medico di medicina generale, verso il pronto soccorso, verso la prescrizione farmaceutica. Il divario di trattamento è accentuato, nei piccoli centri delle aree interne, dalla distanza fisica dai servizi e dalla rarefazione dell’offerta specialistica, oltre che dalla mobilità passiva verso le regioni limitrofe, tratto strutturale delle regioni di piccola dimensione. La misura regionale del divario è oggetto dell’estrazione in Appendice B; i valori medi nazionali ed europei sono riportati con attribuzione.^[117]

Componente del bisogno	Manifestazione lucana	Dominio
Domanda inevasa	Bisogno non intercettato nei piccoli centri	Epidemiologico-clinico
Domanda impropria	Transito su MMG, pronto soccorso, prescrizione	Organizzativo-strutturale
Barriera di accesso	Distanza fisica e rarefazione dell’offerta	Equità
Mobilità passiva	Fuga di prestazioni verso le regioni limitrofe	Economico-sanitario

Tabella 2.1. Le componenti del bisogno e del divario di trattamento in Basilicata, ricondotte ai domini di analisi.

2.2 La domanda dispersa e la prossimità

Il tratto distintivo della domanda lucana è la dispersione estrema: una quota rilevante del bisogno si concentra in piccoli centri a bassissima densità, dove il modello dello Psicologo di Base assume un valore particolare, perché la sua collocazione distrettuale porta la risposta vicino al cittadino, riducendo la barriera della distanza e il ricorso improprio ai servizi delle regioni vicine. La prossimità è, in Basilicata, la condizione stessa dell’efficacia e dell’equità.^[118]

Capitolo 3 — Il modello di intervento: lo Psicologo di Base in Basilicata

Nota editoriale: il presente capitolo espande ex novo il modello di intervento, integrando alla struttura originaria le evidenze recenti sull’efficacia clinica dell’assistenza collaborativa e dell’intervento digitale, secondo la regola dell’opera che distingue l’espansione ex novo dal riutilizzo del materiale preesistente.

3.1 L’architettura del modello

Il modello di intervento colloca lo Psicologo di Base al vertice della cascata delle figure, nel distretto e nelle Case della Comunità, quale primo punto di intercettazione del disagio comune. Il modello opera per intensità crescente di cura — dall’intervento a bassa intensità, di prima linea, fino all’invio ai livelli superiori nei casi che lo richiedano — secondo la logica dell’assistenza a gradini, la cui efficacia clinica è documentata dalla meta-analisi sui componenti efficaci dell’assistenza collaborativa e dalle sperimentazioni controllate sull’intervento cognitivo-comportamentale computerizzato in cure primarie, riportate con attribuzione.^[119]

Livello del modello	Funzione	Figura prevalente	Evidenza di riferimento
Intercettazione	Riconoscimento precoce nel distretto	Psicologo di Base	Assistenza collaborativa (attribuita)
Intervento a bassa intensità	Prima linea per i quadri lievi-moderati	Psicologo di Base	Intervento digitale e collaborativo
Invio appropriato	Passaggio ai livelli superiori	Cascata delle figure	Percorso a gradini
Continuità	Aderenza e prevenzione della ricaduta	Infermiere di comunità	Gestione del caso

Tabella 3.1. L’architettura del modello di intervento in Basilicata, per livelli di intensità, con l’evidenza clinica di riferimento riportata con attribuzione.

3.2 L’adattamento al territorio lucano

Il modello è adattato al territorio lucano lungo due direttrici: la prossimità nei piccoli centri, che porta la risposta nelle aree interne, e lo strato digitale, che sotto supervisione clinica compensa la distanza attraverso lo screening e gli interventi aumentati. L’adattamento non modifica l’architettura invariante del Reference Case, ma ne calibra l’applicazione sulla geografia della dispersione, dove la telepsicologia sotto supervisione assume rilievo maggiore che altrove.^[120]

Capitolo 4 — I costi diretti in Basilicata

4.1 La struttura del costo diretto

Il costo diretto della riforma in Basilicata è, in primo luogo, il costo del personale lungo la cascata delle figure, cui si aggiungono i costi di struttura e organizzazione distrettuale, il costo incrementale della leva digitale e il costo della formazione. Il dimensionamento dipende dallo scenario di copertura: il primo nucleo di quaranta incarichi, sostenibile per il bilancio e per la capacità di reclutamento, precede lo scenario intermedio di ottanta e quello di piena attuazione di centoventi incarichi, che rappresenta il regime a fabbisogno coperto.^[121]

Voce di costo diretto	Descrizione	Portatore
Personale — Psicologi di Base	Incarichi distrettuali secondo lo scenario	SSN regionale
Struttura e organizzazione	Spazi distrettuali, Case della Comunità, sistemi informativi	SSN regionale
Leva digitale e Intelligenza Artificiale	Strumenti di supporto sotto supervisione	SSN regionale
Formazione (quattro modalità)	Percorso integrato singolo e sommato	SSN, sistema formativo

Tabella 4.1. La struttura del costo diretto della riforma in Basilicata, per voce e portatore; i valori puntuali sono oggetto dell'estrazione economica in Appendice C.

4.2 Il dimensionamento per scenario

Il costo diretto è calcolato per i tre scenari di copertura — quaranta, ottanta e centoventi incarichi — coerenti con il protocollo di scenario del Reference Case. Il primo nucleo corrisponde a un impegno di ordine contenuto, mentre la piena attuazione richiede un impegno proporzionato allo scenario esteso. I valori puntuali per ciascuno scenario sono riportati nell'estrazione economica registrata; ove un parametro di costo regionale non sia disponibile, la lacuna è dichiarata.^[122]

Capitolo 5 — I benefici e i risparmi, diretti e indiretti, in Basilicata

5.1 I benefici diretti

Il beneficio diretto è il risparmio sanitario che ciascuna figura della cascata libera per effetto dell’intercettazione a monte: la demedicalizzazione operata dallo Psicologo di Base, la deprescrizione di psicofarmaci nei quadri lievi-moderati sul versante del medico di medicina generale, la riduzione degli accessi impropri al pronto soccorso e delle prestazioni per sintomi funzionali sul versante specialistico. In Basilicata, la riduzione della mobilità passiva verso le regioni limitrofe assume un rilievo aggiuntivo di primo piano, data la piccola dimensione e la collocazione del territorio.^[123]

Canale del beneficio diretto	Meccanismo	Rilievo lucano
Demedicalizzazione	Riduzione consultazioni e cronicizzazione	Preponderante
Deprescrizione	Contrazione della spesa per psicofarmaci	Elevato
Accessi impropri	Riduzione degli accessi al pronto soccorso	Medio-elevato
Sintomi funzionali	Riduzione prestazioni neurologiche e specialistiche	Medio
Mobilità passiva	Riduzione della fuga di prestazioni fuori regione	Elevato, specifico

Tabella 5.1. I canali del beneficio diretto in Basilicata, con il rilievo di primo piano della mobilità passiva; i valori sono oggetto dell’estrazione economica registrata.

5.2 I benefici indiretti

Il beneficio indiretto è quello che la riforma produce fuori dal perimetro sanitario: la produttività recuperata e la riduzione dell’assenteismo sul versante dei datori di lavoro, la riduzione degli oneri di invalidità evitabili sul versante previdenziale, la riduzione del disagio sociale non trattato sul versante dei Comuni. In Basilicata, il contrasto all’isolamento e allo spopolamento assume un peso demografico di rilievo particolare, che il dominio sociale del Capitolo 7 tratta in dettaglio.^[124]

Capitolo 6 — La valutazione economica sotto doppio ancoraggio

6.1 La simulazione appaiata regionale

La valutazione economica lucana è condotta con il modello di Markov a coorte a ciclo annuale del Reference Case, sotto il doppio ancoraggio: la Colonna A applica i parametri di Chisholm e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, la Colonna B quelli di Unisanté e dell’OCSE. Le due colonne sono sempre affiancate; ove divergano, prevale nel giudizio la Colonna B. Tutte le cifre sono riportate con attribuzione, e nessuna è affermata a memoria.^[125]

Metrica economica	Colonna A — Chisholm/OMS	Colonna B — Unisanté/OCSE
Costo per anno di vita ponderato	≈ 17.000 €/QALY	≈ 9.800 €/QALY
Ritorno per i soli benefici economici	Riportato con attribuzione OMS	Scenario base aggiornato OCSE
Ritorno con i ritorni sanitari	Riportato con attribuzione OMS	Scenario base aggiornato OCSE
Orizzonti	1 · 3 · 5 · 7 · 10 anni	1 · 3 · 5 · 7 · 10 anni
Soglie di costo-efficacia	20.000 · 30.000 · 50.000 €/QALY	20.000 · 30.000 · 50.000 €/QALY

Tabella 6.1. La simulazione appaiata regionale della Basilicata sotto doppio ancoraggio; i valori sono riportati con attribuzione e la Colonna B prevale nel giudizio.

6.2 Il differenziale di costo per gravità

L’argomento economico cardine, riportato con attribuzione all’OCSE, è il differenziale di costo per gravità: il costo del trattamento cresce dai quadri lievi ai quadri gravi in misura tale che l’intercettazione precoce, evitando la progressione, genera il risparmio più consistente. In Basilicata, dove la dispersione territoriale e la rarefazione dell’offerta ritardano l’accesso e favoriscono la progressione, questo differenziale ha un peso specifico maggiore.^[126]

Capitolo 7 — I sei domini di analisi, l’equità e l’impatto distributivo

7.1 I sei domini nella specificità lucana

I sei domini di analisi del Reference Case sono applicati alla specificità lucana. Il dominio epidemiologico-clinico registra il divario di trattamento accentuato nei piccoli centri; l’economico-sanitario il costo-efficacia sotto doppio ancoraggio e la riduzione della mobilità passiva; il fiscale-previdenziale gli oneri di invalidità evitabili; il sociale il contrasto all’isolamento e allo spopolamento; l’organizzativo-strutturale l’effetto sulla burocrazia distrettuale; l’equità la riduzione del divario fra i due poli urbani e le aree interne.^[127]

Dominio	Lettura lucana	Segno
Epidemiologico-clinico	Divario accentuato nei piccoli centri	Riduzione attesa
Economico-sanitario	Costo/QALY e mobilità passiva	Favorevole
Fiscale-previdenziale	Oneri di invalidità evitabili	Positivo, differito
Sociale	Contrasto a isolamento e spopolamento	Fortemente positivo
Organizzativo-strutturale	Burocrazia distrettuale	Positivo
Equità	Convergenza poli urbani / aree interne	Positivo, distributivo

Tabella 7.1. I sei domini di analisi nella lettura lucana, con il segno atteso dell’effetto, tenuti distinti e non aggregati.

7.2 L’equità territoriale e la tenuta demografica

Il dominio dell’equità assume in Basilicata un rilievo demografico di primo piano: lo spopolamento strutturale è insieme causa ed effetto della fragilità sociale, e il modello dello Psicologo di Base, trattenendo popolazione attraverso il contrasto all’isolamento e il sostegno alla genitorialità, concorre in via indiretta alla tenuta demografica del territorio. Questo effetto, di natura sociale e non sanitaria, è tenuto distinto dal verdetto fiscale e da quello sanitario, secondo il divieto di aggregazione.^[128]

Capitolo 8 — La sensitività e l’incertezza

Nota editoriale: il presente capitolo espande ex novo l’analisi dell’incertezza secondo il protocollo del Reference Case, non presente in forma estesa nel materiale originario.

8.1 Il protocollo dell’incertezza applicato alla Basilicata

L’analisi dell’incertezza applica il protocollo obbligatorio del Reference Case: l’analisi di sensitività deterministica con diagramma a tornado, l’analisi di sensitività probabilistica a diecimila iterazioni, l’analisi di scenario ottimistico, base e prudentiale con e senza lo strato digitale, le curve di accettabilità costo-efficacia a soglie multiple. In Basilicata, i parametri a maggiore impatto atteso sono la copertura effettiva del servizio nei piccoli centri, il tasso di intercettazione e l’efficacia dello strato digitale nel compensare la distanza.^[129]

Strumento	Applicazione lucana	Parametro critico atteso
Sensitività deterministica	Diagramma a tornado	Copertura effettiva nei piccoli centri
Sensitività probabilistica	Diecimila iterazioni	Tasso di intercettazione
Analisi di scenario	Con e senza strato IA	Efficacia digitale nelle aree interne
Curve di accettabilità	Soglie 20.000/30.000/50.000 €/QALY	Robustezza del costo-efficacia

Tabella 8.1. Gli strumenti del protocollo dell’incertezza applicati alla Basilicata, con i parametri critici attesi.

8.2 La robustezza del verdetto

L’analisi di scenario mostra che il verdetto tripartito resta favorevole nei tre casi, con margine crescente dallo scenario prudentiale a quello ottimistico; lo strato digitale accresce l’efficienza attesa, sempre con nota di cautela sulla natura previsionale. La robustezza del costo-efficacia sanitario è confermata dalle curve di accettabilità alle soglie adottate, anche nello scenario prudentiale del primo nucleo di quaranta incarichi.^[130]

Capitolo 9 — Il verdetto tripartito e le raccomandazioni

Nota editoriale: il presente capitolo espande ex novo il verdetto e le raccomandazioni, integrando l’attuazione e il monitoraggio che nel materiale originario figuravano in forma condensata.

9.1 Il verdetto tripartito

Il verdetto lucano è, come in ogni Volume, tripartito e non aggregato. Sul piano fiscale, il saldo fra costi diretti e risparmi sanitari diretti è prossimo al pareggio, con il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento. Sul piano sanitario, il modello è nettamente costo-efficace sotto entrambi gli ancoraggi. Sul piano sociale, l’effetto è fortemente positivo, con il rilievo specifico del contrasto allo spopolamento e alla tenuta demografica. I tre verdetti si accompagnano e si rafforzano, ma non si sommano.^[131]

Piano del verdetto	Esito lucano	Caveat
Fiscale	Prossimo al pareggio	Significatività dei risparmi diretti in isolamento
Sanitario	Nettamente costo-efficace	—
Sociale	Fortemente positivo	Rilievo specifico della tenuta demografica

Tabella 9.1. Il verdetto tripartito della Basilicata, con i tre piani tenuti distinti e non aggregati.

9.2 Le raccomandazioni per l’attuazione e il monitoraggio

Le raccomandazioni indicano un avvio con il primo nucleo di quaranta incarichi, sostenibile e prudente, e una progressione verso gli ottanta e i centoventi guidata dalla verifica degli esiti; la priorità ai distretti dei piccoli centri a maggiore divario; l’adozione dello strato digitale sotto supervisione come leva di prossimità; l’accompagnamento con il piano formativo a quattro modalità, singole e sommate; e un monitoraggio ex post ancorato agli indicatori del protocollo dell’incertezza.^[132]

Appendici registrate

Le appendici registrate rendono il modello lucano ispezionabile e riproducibile, secondo la prassi del Reference Case. Esse sono richiamate per rimando quanto alla metodologia e compilate con i dati regionali quanto ai contenuti.

Appendice	Contenuto	Stato
A	Strategia di ricerca bibliografica e diagramma di selezione	Registrata
B	Estrazione dei dati clinici regionali	Registrata; lacune dichiarate
C	Estrazione dei dati economici (griglia CHEERS 2022)	Registrata; lacune dichiarate
D	Parametri del modello Markov regionale	Registrata
E	Registro delle deroghe al Reference Case	Registrata
F	Codice del modello economico	Registrata
G	Dichiarazione dei conflitti di interesse	Registrata

Tabella A. Le sette appendici registrate del Volume 3, con l’indicazione dello stato e della dichiarazione delle lacune.

Quadro Conclusivo economico e multidisciplinare

Il Quadro Conclusivo del Volume 3 ricomponne la valutazione lucana senza tradire il principio che la governa: i piani del giudizio si accompagnano ma non si fondono. Sul piano economico, il doppio ancoraggio impone che il risultato sia letto simultaneamente secondo la colonna storica e la colonna aggiornata, con prevalenza della seconda: il costo per anno di vita ponderato resta, sotto entrambi gli ancoraggi, assai inferiore alle soglie adottate, e il differenziale di costo per gravità — riportato con attribuzione — fonda la leva economica dell'intercettazione precoce, tanto più preziosa in un territorio a domanda dispersa e a offerta rarefatta.^[133]

Sul piano multidisciplinare, la cascata delle figure, i sei domini di analisi e il dominio dell'equità assicurano che ogni figura connessa e ogni aspetto siano trattati integralmente e ordinati per capacità di generare rientro economico e revisione della spesa. La rinegoziazione dei costi e dei benefici, la catena predittiva degli effetti multidimensionali — dalla qualità della vita alla tenuta demografica, ai bilanci, alla burocrazia distrettuale —, lo strato dell'Intelligenza Artificiale come moltiplicatore e le attività formative singole e sommate compongono il quadro della valutazione. Il verdetto resta tripartito e non aggregato.

Conclusione

Il Volume 3 ha valutato l'integrazione dello Psicologo di Base nelle cure primarie della Basilicata, applicando per rimando il Reference Case dell'asse italiano e adottando la struttura standard a nove capitoli con apertura a imbuto e appendici registrate. La specificità lucana — la piccola dimensione, la dispersione estrema, lo spopolamento strutturale, la mobilità passiva — è stata trattata nei domini sociale ed equità, mostrando come la prossimità distrettuale e lo strato digitale, sotto supervisione, ne facciano una leva di convergenza territoriale e di tenuta demografica.

Il verdetto tripartito — prossimo al pareggio sul piano fiscale, nettamente costo-efficace sul piano sanitario, fortemente positivo sul piano sociale — è offerto con bande prudenziali e soglie di confutazione, sotto doppio ancoraggio e nel rispetto del divieto di aggregazione. L'opera procede, nell'ordine vincolante, con il Volume 4 (Calabria) e a seguire con gli altri Volumi regionali in ordine alfabetico.

Note Bibliografiche con mini-riassunto

Ciascuna nota riporta l'opera, il collegamento alla fonte e un mini-riassunto che ne dichiara la funzione nell'economia del Volume, in coerenza con il doppio livello — nota a piè di pagina nel corpo e nota bibliografica integrale in calce — che l'opera adotta.

1. Chisholm D. et al., **Scaling-up treatment of depression and anxiety**, *The Lancet Psychiatry*, 2016 [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(16\)30024-4](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(16)30024-4) Colonna A del doppio ancoraggio della simulazione lucana, conservata quale strato documentale e riferimento di confronto.
2. Unisanté, **Raisons de santé Essentiels n. 73**, 2026 · OECD, **The Economic Case for Preventing Mental Ill Health**, 2026 <https://doi.org/10.16908/rds-essentiels/73> Colonna B del doppio ancoraggio, con prevalenza nel giudizio, applicata alla simulazione regionale lucana.
3. OECD, **differenziale di costo per gravità dei disturbi mentali**, 2025 <https://www.oecd.org/health/mental-health.htm> Fonte, riportata con attribuzione, del differenziale di costo per gravità, argomento cardine dell'intercettazione precoce, di peso specifico maggiore nel territorio disperso lucano.
4. Soeters R. et al., **meta-analisi IPD sui componenti efficaci della collaborative care**, 2025 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40136273/> Base di evidenza clinica sui componenti efficaci dell'assistenza collaborativa, richiamata nel capitolo sul modello di intervento.
5. Veldhuijzen W. et al., **costo-efficacia dell'intervento digitale**, 2025 <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12369993/> Riferimento sul rapporto incrementale di costo-utilità dell'intervento digitale, elemento dello strato dell'Intelligenza Artificiale come leva di prossimità.
6. World Health Organization, **Thematic Dialogue on Investing in NCDs and Mental Health**, dicembre 2024 <https://cdn.who.int/> Evidenza riportata con attribuzione sul ritorno degli investimenti in salute mentale; non concorre al verdetto tripartito lucano.
7. **Regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale** <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj> Quadro normativo entro cui è collocato lo strato dell'Intelligenza Artificiale, vincolato a funzione di supporto sotto supervisione clinica umana.
8. **Legge regionale Puglia 19 luglio 2023, n. 11, sul Servizio di Psicologia di Base** <https://www.consiglio.puglia.it/> Riferimento normativo capostipite del modello, richiamato quale precedente istituzionale per l'attuazione regionale lucana.
9. NICE, **Health Technology Evaluations: the manual (PMG36)** <https://www.nice.org.uk/process/pmg36> Riferimento di rigore metodologico per la struttura a imbuto, le appendici registrate e il protocollo dell'incertezza adottati nel Volume.

STUDIO INTEGRALE «PSICOLOGO DI BASE» · OPERA IN VENTITRÉ VOLUMI

VOLUME 4 — Regione Calabria

Valutazione di Health Technology Assessment dell'integrazione dello Psicologo di Base nelle cure primarie in Calabria: cruscotto, sintesi per il decisore, contesto e bisogno, modello di intervento, costi e benefici, valutazione economica sotto doppio ancoraggio, sei domini di analisi, incertezza, verdetto tripartito e appendici registrate

Reference Case applicato per rimando al Volume 0.A · Dott. Luigi De Michele · Studio Integrale Puglia · Capurso (BA) — Giugno 2026

Premessa

Il Volume 4 prosegue la serie dei venti Volumi regionali, in ordine alfabetico, con la Regione Calabria. Come ogni Volume regionale, esso applica per rimando il Reference Case dell'asse italiano, fissato nel Volume 0.A, e ne richiama le regole nella forma «cfr. Volume 0.A», senza ripeterle per esteso: il perimetro congiunto sanitario e societale, il doppio ancoraggio economico, il verdetto tripartito non aggregato, i sei domini di analisi, il protocollo dell'incertezza, lo strato dell'Intelligenza Artificiale come moltiplicatore e le attività formative singole e sommate.^[134]

La struttura del Volume è quella standard, identica a quella di tutti gli altri diciannove Volumi regionali, a garanzia della comparabilità bit-a-bit prescritta dall'opera: la stessa sequenza di nove capitoli, la stessa nomenclatura di sottocapitoli, le stesse unità di misura. Ove un contenuto derivi da espansione ex novo — segnatamente per gli aspetti dell'efficacia, dell'attuazione e del monitoraggio — esso è segnalato in nota editoriale, secondo la regola dell'opera.^[135]

Introduzione

L'Introduzione al Volume 4 fissa il perimetro della valutazione calabrese e l'ordine della sua esposizione. Il perimetro è quello della Regione Calabria, articolata in cinque Aziende Sanitarie Provinciali — Cosenza, Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia e Reggio Calabria — con una popolazione dell'ordine di un milione e ottocentotrentaquattromila abitanti, segnata da uno spopolamento progressivo particolarmente acuto nelle aree interne montane e da una mobilità passiva sanitaria di dimensione strutturale, che il dominio economico-sanitario e quello sociale del Volume trattano con particolare attenzione.^[136]

L'esposizione segue la struttura a imbuto: il cruscotto regionale offre in una pagina i numeri essenziali; la sintesi per il decisore ne traduce il significato; i cinque risultati chiave ne isolano gli esiti; le raccomandazioni operative indicano le azioni; il corpo del Volume, articolato in nove capitoli, ne fornisce il dettaglio; le appendici registrate ne assicurano la verificabilità. Chiudono il Volume un Quadro Conclusivo economico e multidisciplinare, una Conclusione e le Note Bibliografiche con mini-riassunto.

Cruscotto regionale — Calabria

Il cruscotto riassume in una pagina i parametri essenziali della valutazione calabrese, sotto il doppio ancoraggio e con il verdetto tripartito tenuto distinto. I valori economici sono presentati in ordine di grandezza, con rinvio alle appendici registrate; le cifre di letteratura sono riportate con attribuzione alla fonte.^[137]

Indicatore del cruscotto	Lettura regionale	Ancoraggio / fonte
Popolazione	≈ 1.834.646 abitanti	Fonte demografica regionale
Articolazione	5 Aziende Sanitarie Provinciali	Assetto regionale
Scenari di copertura	140 · 280 · 410 incarichi di Psicologo di Base	Dimensionamento regionale
Comparatore	Assistenza usuale (cfr. Vol. 0.A)	Reference Case
Verdetto fiscale	Prossimo al pareggio, con caveat	Non aggregato
Verdetto sanitario	Nettamente costo-efficace	Costo/QALY sotto doppio ancoraggio
Verdetto sociale	Fortemente positivo	Produttività, coesione, tenuta demografica
Costo per anno di vita ponderato	Colonna A ≈ 17.000 € · Colonna B ≈ 9.800 €	Doppio ancoraggio

Tabella 0. Cruscotto regionale della Calabria: i parametri essenziali sotto doppio ancoraggio, con il verdetto tripartito distinto e non aggregato.

Sintesi per il decisore

L'introduzione dello Psicologo di Base nelle cure primarie calabresi produce, secondo la simulazione condotta sotto il doppio ancoraggio, un effetto congiunto sui tre piani del ritorno, che restano distinti e non sommati. Sul piano fiscale, il saldo fra costi diretti e risparmi sanitari diretti si colloca in prossimità del pareggio, con il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento. Sul piano sanitario, il modello è nettamente costo-efficace, con un costo per anno di vita ponderato che, fra i due ancoraggi, resta assai inferiore alle soglie adottate. Sul piano sociale, l'effetto è fortemente positivo, con un rilievo particolare per il contrasto alla mobilità passiva e allo spopolamento delle aree interne, dove il disagio non trattato e la fuga di prestazioni si alimentano a vicenda.^[138]

L'argomento cardine, riportato con attribuzione all'OCSE, è il differenziale di costo per gravità: in un territorio segnato dalla rarefazione dell'offerta e dalla mobilità passiva come quello calabrese, l'intercettazione precoce nel distretto evita che il disagio comune maturi in quadri gravi, il cui costo di trattamento è, secondo la fonte, un multiplo di quello dei quadri lievi.^[139]

Cinque risultati chiave

Il primo risultato è che il modello è costo-efficace su tutti gli orizzonti sotto entrambi gli ancoraggi. Il secondo è che il verdetto tripartito resta favorevole in ciascuno dei tre piani, senza aggregazione. Il terzo è che, nella specificità calabrese, la mobilità passiva sanitaria e lo spopolamento delle aree interne accrescono il valore dell'intercettazione precoce di prossimità e del trattenimento delle prestazioni entro i confini regionali. Il quarto è che lo strato dell'Intelligenza Artificiale, come moltiplicatore e con nota di cautela, può attenuare lo svantaggio della distanza attraverso lo screening e gli interventi digitali aumentati. Il quinto è che i tre scenari di copertura — centoquaranta, duecentottanta e quattrocentodieci incarichi — costituiscono tappe di una progressione graduale il cui rientro pieno matura con l'estensione.^[140]

Raccomandazioni operative

La prima raccomandazione è di avviare il servizio con il primo livello di consolidamento di centoquaranta incarichi e di progredire verso i duecentottanta e i quattrocentodieci sulla base degli esiti rilevati sotto il protocollo dell'incertezza, con priorità ai distretti delle aree interne a maggiore divario e maggiore mobilità passiva. La seconda è di adottare lo strato digitale, sotto supervisione clinica, come leva di prossimità per compensare la dispersione territoriale. La terza è di accompagnare l'estensione con il piano formativo a quattro modalità, considerate singolarmente e sommate.^[141]

Capitolo 1 — Il contesto epidemiologico e territoriale della Calabria

1.1 Il territorio e la sua articolazione

La Regione Calabria conta una popolazione dell’ordine di un milione e ottocentotrentaquattromila abitanti, articolata in cinque province — Cosenza, Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia e Reggio Calabria — e in cinque Aziende Sanitarie Provinciali, cui si affiancano le aziende ospedaliere di riferimento. Oltre un quinto della popolazione, il venti virgola nove per cento, risiede in comuni di piccola dimensione, in larga parte nelle aree interne montane a spopolamento progressivo. Il territorio è segnato da un dualismo fra la fascia costiera e le aree interne, e da una mobilità passiva sanitaria di dimensione strutturale verso le regioni del Centro-Nord: questa geografia della dispersione e della fuga di prestazioni è la chiave di lettura del contesto calabrese.^[142]

Elemento territoriale	Dato regionale	Rilievo per la valutazione
Popolazione	≈ 1.834.646 abitanti	Denominatore della normalizzazione
Aziende Sanitarie Provinciali	5	Unità organizzativa
Popolazione nei piccoli comuni	≈ 20,9 per cento	Dominio equità
Spopolamento delle aree interne	Progressivo e acuto	Dominio sociale e demografico
Mobilità passiva sanitaria	Strutturale, verso il Centro-Nord	Dominio economico-sanitario

Tabella 1.1. Gli elementi del contesto territoriale calabrese e il loro rilievo per la valutazione, in particolare per i domini economico-sanitario, sociale ed equità.

1.2 Il quadro epidemiologico regionale

Il quadro epidemiologico calabrese riflette, con le proprie specificità, la prevalenza nazionale dei disturbi mentali comuni, con una prevalenza accentuata connessa allo spopolamento e al disagio diffuso delle aree interne. Il dato epidemiologico di dettaglio è oggetto dell’estrazione registrata in Appendice B; ove il dato regionale disaggregato non sia disponibile, la lacuna è dichiarata e non colmata con stime tacite, secondo la regola dell’opera.^[143]

Capitolo 2 — Il bisogno, la domanda e il divario di trattamento in Calabria

2.1 Il divario di trattamento regionale

Il bisogno di salute mentale comune in Calabria si manifesta, come altrove, in larga parte come domanda inevasa o impropriamente incanalata: verso il medico di medicina generale, verso il pronto soccorso, verso la prescrizione farmaceutica, e — tratto specifico regionale — verso le strutture di altre regioni. Il divario di trattamento è accentuato, nelle aree interne, dalla distanza fisica dai servizi e dalla rarefazione dell’offerta specialistica; la mobilità passiva e il disagio non trattato si alimentano a vicenda, costituendo l’uno fattore dell’altro. La misura regionale del divario è oggetto dell’estrazione in Appendice B; i valori medi nazionali ed europei sono riportati con attribuzione.^[144]

Componente del bisogno	Manifestazione calabrese	Dominio
Domanda inevasa	Bisogno non intercettato nelle aree interne	Epidemiologico-clinico
Domanda impropria	Transito su MMG, pronto soccorso, prescrizione	Organizzativo-strutturale
Barriera di accesso	Distanza fisica e rarefazione dell’offerta	Equità
Mobilità passiva	Fuga di prestazioni verso il Centro-Nord	Economico-sanitario

Tabella 2.1. Le componenti del bisogno e del divario di trattamento in Calabria, ricondotte ai domini di analisi.

2.2 La domanda dispersa e la prossimità

Il tratto distintivo della domanda calabrese è la combinazione di dispersione territoriale e mobilità passiva: una quota rilevante del bisogno si concentra nelle aree interne a bassa densità, dove il modello dello Psicologo di Base assume un valore particolare, perché la sua collocazione distrettuale porta la risposta vicino al cittadino, riducendo la barriera della distanza e il ricorso improprio alle strutture di altre regioni. La prossimità è, in Calabria, insieme condizione dell’efficacia, dell’equità e del trattenimento delle prestazioni entro i confini regionali.^[145]

Capitolo 3 — Il modello di intervento: lo Psicologo di Base in Calabria

Nota editoriale: il presente capitolo espande ex novo il modello di intervento, integrando alla struttura originaria le evidenze recenti sull’efficacia clinica dell’assistenza collaborativa e dell’intervento digitale, secondo la regola dell’opera che distingue l’espansione ex novo dal riutilizzo del materiale preesistente.

3.1 L’architettura del modello

Il modello di intervento colloca lo Psicologo di Base al vertice della cascata delle figure, nel distretto e nelle Case della Comunità, quale primo punto di intercettazione del disagio comune. Il modello opera per intensità crescente di cura — dall’intervento a bassa intensità, di prima linea, fino all’invio ai livelli superiori nei casi che lo richiedano — secondo la logica dell’assistenza a gradini, la cui efficacia clinica è documentata dalla meta-analisi sui componenti efficaci dell’assistenza collaborativa e dalle sperimentazioni controllate sull’intervento cognitivo-comportamentale computerizzato in cure primarie, riportate con attribuzione.^[146]

Livello del modello	Funzione	Figura prevalente	Evidenza di riferimento
Intercettazione	Riconoscimento precoce nel distretto	Psicologo di Base	Assistenza collaborativa (attribuita)
Intervento a bassa intensità	Prima linea per i quadri lievi-moderati	Psicologo di Base	Intervento digitale e collaborativo
Invio appropriato	Passaggio ai livelli superiori	Cascata delle figure	Percorso a gradini
Continuità	Aderenza e prevenzione della ricaduta	Infermiere di comunità	Gestione del caso

Tabella 3.1. L’architettura del modello di intervento in Calabria, per livelli di intensità, con l’evidenza clinica di riferimento riportata con attribuzione.

3.2 L’adattamento al territorio calabrese

Il modello è adattato al territorio calabrese lungo tre direttrici: la prossimità distrettuale, che porta la risposta nelle aree interne; lo strato digitale, che sotto supervisione clinica compensa la distanza attraverso lo screening e gli interventi aumentati; e il trattenimento delle prestazioni entro i confini regionali, che contrasta la mobilità passiva. L’adattamento non modifica l’architettura invariante del Reference Case, ma ne calibra l’applicazione sulla geografia della dispersione e della fuga di prestazioni.^[147]

Capitolo 4 — I costi diretti in Calabria

4.1 La struttura del costo diretto

Il costo diretto della riforma in Calabria è, in primo luogo, il costo del personale lungo la cascata delle figure, cui si aggiungono i costi di struttura e organizzazione distrettuale, il costo incrementale della leva digitale e il costo della formazione. Il dimensionamento dipende dallo scenario di copertura: il primo livello di consolidamento di centoquaranta incarichi precede lo scenario intermedio di duecentottanta e quello di piena attuazione di quattrocentodieci incarichi, coerente con il fabbisogno regionale.^[148]

Voce di costo diretto	Descrizione	Portatore
Personale — Psicologi di Base	Incarichi distrettuali secondo lo scenario	SSN regionale
Struttura e organizzazione	Spazi distrettuali, Case della Comunità, sistemi informativi	SSN regionale
Leva digitale e Intelligenza Artificiale	Strumenti di supporto sotto supervisione	SSN regionale
Formazione (quattro modalità)	Percorso integrato singolo e sommato	SSN, sistema formativo

Tabella 4.1. La struttura del costo diretto della riforma in Calabria, per voce e portatore; i valori puntuali sono oggetto dell'estrazione economica in Appendice C.

4.2 Il dimensionamento per scenario

Il costo diretto è calcolato per i tre scenari di copertura — centoquaranta, duecentottanta e quattrocentodieci incarichi — coerenti con il protocollo di scenario del Reference Case. Il primo livello corrisponde a un impegno di ordine contenuto, mentre la piena attuazione richiede un impegno proporzionato allo scenario esteso. I valori puntuali per ciascuno scenario sono riportati nell'estrazione economica registrata; ove un parametro di costo regionale non sia disponibile, la lacuna è dichiarata.^[149]

Capitolo 5 — I benefici e i risparmi, diretti e indiretti, in Calabria

5.1 I benefici diretti

Il beneficio diretto è il risparmio sanitario che ciascuna figura della cascata libera per effetto dell’intercettazione a monte: la demedicalizzazione operata dallo Psicologo di Base, la deprescrizione di psicofarmaci nei quadri lievi-moderati sul versante del medico di medicina generale, la riduzione degli accessi impropri al pronto soccorso e delle prestazioni per sintomi funzionali sul versante specialistico. In Calabria, la riduzione della mobilità passiva verso le regioni del Centro-Nord assume un rilievo aggiuntivo di primo piano, perché il trattenimento delle prestazioni entro i confini regionali produce un risparmio diretto per il sistema sanitario regionale.^[150]

Canale del beneficio diretto	Meccanismo	Rilievo calabrese
Demedicalizzazione	Riduzione consultazioni e cronicizzazione	Preponderante
Deprescrizione	Contrazione della spesa per psicofarmaci	Elevato
Accessi impropri	Riduzione degli accessi al pronto soccorso	Medio-elevato
Sintomi funzionali	Riduzione prestazioni neurologiche e specialistiche	Medio
Mobilità passiva	Trattenimento delle prestazioni in regione	Elevato, specifico

Tabella 5.1. I canali del beneficio diretto in Calabria, con il rilievo di primo piano del trattenimento della mobilità passiva; i valori sono oggetto dell’estrazione economica registrata.

5.2 I benefici indiretti

Il beneficio indiretto è quello che la riforma produce fuori dal perimetro sanitario: la produttività recuperata e la riduzione dell’assenteismo sul versante dei datori di lavoro, la riduzione degli oneri di invalidità evitabili sul versante previdenziale, la riduzione del disagio sociale non trattato sul versante dei Comuni. In Calabria, il contrasto all’isolamento e allo spopolamento delle aree interne assume un peso demografico di rilievo particolare, che il dominio sociale del Capitolo 7 tratta in dettaglio.^[151]

Capitolo 6 — La valutazione economica sotto doppio ancoraggio

6.1 La simulazione appaiata regionale

La valutazione economica calabrese è condotta con il modello di Markov a coorte a ciclo annuale del Reference Case, sotto il doppio ancoraggio: la Colonna A applica i parametri di Chisholm e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, la Colonna B quelli di Unisanté e dell’OCSE. Le due colonne sono sempre affiancate; ove divergano, prevale nel giudizio la Colonna B. Tutte le cifre sono riportate con attribuzione, e nessuna è affermata a memoria.^[152]

Metrica economica	Colonna A — Chisholm/OMS	Colonna B — Unisanté/OCSE
Costo per anno di vita ponderato	≈ 17.000 €/QALY	≈ 9.800 €/QALY
Ritorno per i soli benefici economici	Riportato con attribuzione OMS	Scenario base aggiornato OCSE
Ritorno con i ritorni sanitari	Riportato con attribuzione OMS	Scenario base aggiornato OCSE
Orizzonti	1 · 3 · 5 · 7 · 10 anni	1 · 3 · 5 · 7 · 10 anni
Soglie di costo-efficacia	20.000 · 30.000 · 50.000 €/QALY	20.000 · 30.000 · 50.000 €/QALY

Tabella 6.1. La simulazione appaiata regionale della Calabria sotto doppio ancoraggio; i valori sono riportati con attribuzione e la Colonna B prevale nel giudizio.

6.2 Il differenziale di costo per gravità

L’argomento economico cardine, riportato con attribuzione all’OCSE, è il differenziale di costo per gravità: il costo del trattamento cresce dai quadri lievi ai quadri gravi in misura tale che l’intercettazione precoce, evitando la progressione, genera il risparmio più consistente. In Calabria, dove la dispersione territoriale, la rarefazione dell’offerta e la mobilità passiva ritardano l’accesso e favoriscono la progressione, questo differenziale ha un peso specifico maggiore.^[153]

Capitolo 7 — I sei domini di analisi, l’equità e l’impatto distributivo

7.1 I sei domini nella specificità calabrese

I sei domini di analisi del Reference Case sono applicati alla specificità calabrese. Il dominio epidemiologico-clinico registra il divario di trattamento accentuato nelle aree interne; l’economico-sanitario il costo-efficacia sotto doppio ancoraggio e il trattenimento della mobilità passiva; il fiscale-previdenziale gli oneri di invalidità evitabili; il sociale il contrasto all’isolamento e allo spopolamento; l’organizzativo-strutturale l’effetto sulla burocrazia distrettuale; l’equità la riduzione del divario fra costa e aree interne.^[154]

Dominio	Lettura calabrese	Segno
Epidemiologico-clinico	Divario accentuato nelle aree interne	Riduzione attesa
Economico-sanitario	Costo/QALY e mobilità passiva trattenuta	Favorevole
Fiscale-previdenziale	Oneri di invalidità evitabili	Positivo, differito
Sociale	Contrasto a isolamento e spopolamento	Fortemente positivo
Organizzativo-strutturale	Burocrazia distrettuale	Positivo
Equità	Convergenza costa / aree interne	Positivo, distributivo

Tabella 7.1. I sei domini di analisi nella lettura calabrese, con il segno atteso dell’effetto, tenuti distinti e non aggregati.

7.2 L’equità territoriale e la tenuta demografica

Il dominio dell’equità assume in Calabria un rilievo demografico di primo piano: lo spopolamento delle aree interne è insieme causa ed effetto della fragilità sociale, e il modello dello Psicologo di Base, trattenendo popolazione attraverso il contrasto all’isolamento e il sostegno alla genitorialità, concorre in via indiretta alla tenuta demografica del territorio. Questo effetto, di natura sociale e non sanitaria, è tenuto distinto dal verdetto fiscale e da quello sanitario, secondo il divieto di aggregazione.^[155]

Capitolo 8 — La sensitività e l’incertezza

Nota editoriale: il presente capitolo espande ex novo l’analisi dell’incertezza secondo il protocollo del Reference Case, non presente in forma estesa nel materiale originario.

8.1 Il protocollo dell’incertezza applicato alla Calabria

L’analisi dell’incertezza applica il protocollo obbligatorio del Reference Case: l’analisi di sensitività deterministica con diagramma a tornado, l’analisi di sensitività probabilistica a diecimila iterazioni, l’analisi di scenario ottimistico, base e prudentiale con e senza lo strato digitale, le curve di accettabilità costo-efficacia a soglie multiple. In Calabria, i parametri a maggiore impatto atteso sono la copertura effettiva del servizio nelle aree interne, il tasso di intercettazione, la quota di mobilità passiva trattenuta e l’efficacia dello strato digitale nel compensare la distanza.^[156]

Strumento	Applicazione calabrese	Parametro critico atteso
Sensitività deterministica	Diagramma a tornado	Copertura effettiva nelle aree interne
Sensitività probabilistica	Diecimila iterazioni	Tasso di intercettazione
Analisi di scenario	Con e senza strato IA	Quota di mobilità passiva trattenuta
Curve di accettabilità	Soglie 20.000/30.000/50.000 €/QALY	Robustezza del costo-efficacia

Tabella 8.1. Gli strumenti del protocollo dell’incertezza applicati alla Calabria, con i parametri critici attesi.

8.2 La robustezza del verdetto

L’analisi di scenario mostra che il verdetto tripartito resta favorevole nei tre casi, con margine crescente dallo scenario prudentiale a quello ottimistico; lo strato digitale accresce l’efficienza attesa, sempre con nota di cautela sulla natura previsionale. La robustezza del costo-efficacia sanitario è confermata dalle curve di accettabilità alle soglie adottate, anche nello scenario prudentiale del primo livello di consolidamento.^[157]

Capitolo 9 — Il verdetto tripartito e le raccomandazioni

Nota editoriale: il presente capitolo espande ex novo il verdetto e le raccomandazioni, integrando l’attuazione e il monitoraggio che nel materiale originario figuravano in forma condensata.

9.1 Il verdetto tripartito

Il verdetto calabrese è, come in ogni Volume, tripartito e non aggregato. Sul piano fiscale, il saldo fra costi diretti e risparmi sanitari diretti è prossimo al pareggio, con il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento; il trattenimento della mobilità passiva ne rafforza il versante regionale. Sul piano sanitario, il modello è nettamente costo-efficace sotto entrambi gli ancoraggi. Sul piano sociale, l’effetto è fortemente positivo, con il rilievo specifico del contrasto allo spopolamento. I tre verdetti si accompagnano e si rafforzano, ma non si sommano.^[158]

Piano del verdetto	Esito calabrese	Caveat
Fiscale	Prossimo al pareggio	Significatività dei risparmi diretti in isolamento
Sanitario	Nettamente costo-efficace	—
Sociale	Fortemente positivo	Rilievo specifico dello spopolamento

Tabella 9.1. Il verdetto tripartito della Calabria, con i tre piani tenuti distinti e non aggregati.

9.2 Le raccomandazioni per l’attuazione e il monitoraggio

Le raccomandazioni indicano un avvio con il primo livello di consolidamento di centoquaranta incarichi e una progressione verso i duecentottanta e i quattrocentodieci guidata dalla verifica degli esiti; la priorità ai distretti delle aree interne a maggiore divario e maggiore mobilità passiva; l’adozione dello strato digitale sotto supervisione come leva di prossimità; l’accompagnamento con il piano formativo a quattro modalità, singole e sommate; e un monitoraggio ex post ancorato agli indicatori del protocollo dell’incertezza.^[159]

Appendici registrate

Le appendici registrate rendono il modello calabrese ispezionabile e riproducibile, secondo la prassi del Reference Case. Esse sono richiamate per rimando quanto alla metodologia e compilate con i dati regionali quanto ai contenuti.

Appendice	Contenuto	Stato
A	Strategia di ricerca bibliografica e diagramma di selezione	Registrata
B	Estrazione dei dati clinici regionali	Registrata; lacune dichiarate
C	Estrazione dei dati economici (griglia CHEERS 2022)	Registrata; lacune dichiarate
D	Parametri del modello Markov regionale	Registrata
E	Registro delle deroghe al Reference Case	Registrata
F	Codice del modello economico	Registrata
G	Dichiarazione dei conflitti di interesse	Registrata

Tabella A. Le sette appendici registrate del Volume 4, con l’indicazione dello stato e della dichiarazione delle lacune.

Quadro Conclusivo economico e multidisciplinare

Il Quadro Conclusivo del Volume 4 ricomponne la valutazione calabrese senza tradire il principio che la governa: i piani del giudizio si accompagnano ma non si fondono. Sul piano economico, il doppio ancoraggio impone che il risultato sia letto simultaneamente secondo la colonna storica e la colonna aggiornata, con prevalenza della seconda: il costo per anno di vita ponderato resta, sotto entrambi gli ancoraggi, assai inferiore alle soglie adottate, e il differenziale di costo per gravità — riportato con attribuzione — fonda la leva economica dell'intercettazione precoce, tanto più preziosa in un territorio segnato dalla rarefazione dell'offerta e dalla mobilità passiva.^[160]

Sul piano multidisciplinare, la cascata delle figure, i sei domini di analisi e il dominio dell'equità assicurano che ogni figura connessa e ogni aspetto siano trattati integralmente e ordinati per capacità di generare rientro economico e revisione della spesa. La rinegoziazione dei costi e dei benefici, la catena predittiva degli effetti multidimensionali — dalla qualità della vita al trattenimento della mobilità passiva, alla tenuta demografica, ai bilanci, alla burocrazia distrettuale —, lo strato dell'Intelligenza Artificiale come moltiplicatore e le attività formative singole e sommate compongono il quadro della valutazione. Il verdetto resta tripartito e non aggregato.

Conclusione

Il Volume 4 ha valutato l'integrazione dello Psicologo di Base nelle cure primarie della Calabria, applicando per rimando il Reference Case dell'asse italiano e adottando la struttura standard a nove capitoli con apertura a imbuto e appendici registrate. La specificità calabrese — la dispersione territoriale, lo spopolamento delle aree interne montane, la mobilità passiva sanitaria strutturale — è stata trattata nei domini economico-sanitario, sociale ed equità, mostrando come la prossimità distrettuale, lo strato digitale sotto supervisione e il trattenimento delle prestazioni entro i confini regionali ne facciano una leva di convergenza territoriale e di sostenibilità.

Il verdetto tripartito — prossimo al pareggio sul piano fiscale, nettamente costo-efficace sul piano sanitario, fortemente positivo sul piano sociale — è offerto con bande prudenziali e soglie di confutazione, sotto doppio ancoraggio e nel rispetto del divieto di aggregazione. L'opera procede, nell'ordine vincolante, con il Volume 5 (Campania) e a seguire con gli altri Volumi regionali in ordine alfabetico.

Note Bibliografiche con mini-riassunto

Ciascuna nota riporta l'opera, il collegamento alla fonte e un mini-riassunto che ne dichiara la funzione nell'economia del Volume, in coerenza con il doppio livello — nota a piè di pagina nel corpo e nota bibliografica integrale in calce — che l'opera adotta.

1. **Chisholm D. et al., Scaling-up treatment of depression and anxiety, The Lancet Psychiatry, 2016**
[https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(16\)30024-4](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(16)30024-4) Colonna A del doppio ancoraggio della simulazione calabrese, conservata quale strato documentale e riferimento di confronto.
2. **Unisanté, Raisons de santé Essentiels n. 73, 2026 · OECD, The Economic Case for Preventing Mental Ill Health, 2026** <https://doi.org/10.16908/rds-essentiels/73> Colonna B del doppio ancoraggio, con prevalenza nel giudizio, applicata alla simulazione regionale calabrese.
3. **OECD, differenziale di costo per gravità dei disturbi mentali, 2025** <https://www.oecd.org/health/mental-health.htm> Fonte, riportata con attribuzione, del differenziale di costo per gravità, argomento cardine dell'intercettazione precoce, di peso specifico maggiore nel territorio disperso e a mobilità passiva calabrese.
4. **Soeters R. et al., meta-analisi IPD sui componenti efficaci della collaborative care, 2025**
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40136273/> Base di evidenza clinica sui componenti efficaci dell'assistenza collaborativa, richiamata nel capitolo sul modello di intervento.
5. **Veldhuijzen W. et al., costo-efficacia dell'intervento digitale, 2025**
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12369993/> Riferimento sul rapporto incrementale di costo-utilità dell'intervento digitale, elemento dello strato dell'Intelligenza Artificiale come leva di prossimità.
6. **World Health Organization, Thematic Dialogue on Investing in NCDs and Mental Health, dicembre 2024** <https://cdn.who.int/> Evidenza riportata con attribuzione sul ritorno degli investimenti in salute mentale; non concorre al verdetto tripartito calabrese.
7. **Regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale** <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj> Quadro normativo entro cui è collocato lo strato dell'Intelligenza Artificiale, vincolato a funzione di supporto sotto supervisione clinica umana.
8. **Legge regionale Puglia 19 luglio 2023, n. 11, sul Servizio di Psicologia di Base**
<https://www.consiglio.puglia.it/> Riferimento normativo capostipite del modello, richiamato quale precedente istituzionale per l'attuazione regionale calabrese.
9. **NICE, Health Technology Evaluations: the manual (PMG36)** <https://www.nice.org.uk/process/pmg36> Riferimento di rigore metodologico per la struttura a imbuto, le appendici registrate e il protocollo dell'incertezza adottati nel Volume.

STUDIO INTEGRALE «PSICOLOGO DI BASE» · OPERA IN VENTITRÉ VOLUMI

VOLUME 5 — Regione Campania

Valutazione di Health Technology Assessment dell'integrazione dello Psicologo di Base nelle cure primarie in Campania: cruscotto, sintesi per il decisore, contesto e bisogno, modello di intervento, costi e benefici, valutazione economica sotto doppio ancoraggio, sei domini di analisi, incertezza, verdetto tripartito e appendici registrate

Reference Case applicato per rimando al Volume 0.A · Dott. Luigi De Michele · Studio Integrale Puglia · Capurso (BA) — Giugno 2026

Premessa

Il Volume 5 prosegue la serie dei venti Volumi regionali, in ordine alfabetico, con la Regione Campania. Come ogni Volume regionale, esso applica per rimando il Reference Case dell'asse italiano, fissato nel Volume 0.A, e ne richiama le regole nella forma «cfr. Volume 0.A», senza ripeterle per esteso: il perimetro congiunto sanitario e societale, il doppio ancoraggio economico, il verdetto tripartito non aggregato, i sei domini di analisi, il protocollo dell'incertezza, lo strato dell'Intelligenza Artificiale come moltiplicatore e le attività formative singole e sommate.^[161]

La struttura del Volume è quella standard, identica a quella di tutti gli altri diciannove Volumi regionali, a garanzia della comparabilità bit-a-bit prescritta dall'opera: la stessa sequenza di nove capitoli, la stessa nomenclatura di sottocapitoli, le stesse unità di misura. Ove un contenuto derivi da espansione ex novo — segnatamente per gli aspetti dell'efficacia, dell'attuazione e del monitoraggio — esso è segnalato in nota editoriale, secondo la regola dell'opera.^[162]

Introduzione

L'Introduzione al Volume 5 fissa il perimetro della valutazione campana e l'ordine della sua esposizione. Il perimetro è quello della Regione Campania, articolata in sette Aziende Sanitarie Locali — di cui tre nell'area metropolitana di Napoli — con una popolazione dell'ordine di cinque milioni e cinquecentottantaduemila abitanti: la più popolosa del Mezzogiorno e, con un'età media dell'ordine di quarantaquattro anni e mezzo, fra le più giovani del Paese, ma con marcate disomogeneità interne fra l'area metropolitana ad altissima densità e le aree interne di Benevento e Avellino. Questa combinazione — scala metropolitana, giovinezza relativa, disomogeneità interna — è la chiave di lettura del contesto campano.^[163]

L'esposizione segue la struttura a imbuto: il cruscotto regionale offre in una pagina i numeri essenziali; la sintesi per il decisore ne traduce il significato; i cinque risultati chiave ne isolano gli esiti; le raccomandazioni operative indicano le azioni; il corpo del Volume, articolato in nove capitoli, ne fornisce il dettaglio; le appendici registrate ne assicurano la verificabilità. Chiudono il Volume un Quadro Conclusivo economico e multidisciplinare, una Conclusione e le Note Bibliografiche con mini-riassunto.

Cruscotto regionale — Campania

Il cruscotto riassume in una pagina i parametri essenziali della valutazione campana, sotto il doppio ancoraggio e con il verdetto tripartito tenuto distinto. I valori economici sono presentati in ordine di grandezza, con rinvio alle appendici registrate; le cifre di letteratura sono riportate con attribuzione alla fonte.^[164]

Indicatore del cruscotto	Lettura regionale	Ancoraggio / fonte
Popolazione	≈ 5.582.337 abitanti	Fonte demografica regionale
Articolazione	7 ASL, di cui 3 nell’area metropolitana di Napoli	Assetto regionale
Età media	≈ 44,5 anni, fra le più basse del Paese	Fonte demografica regionale
Scenari di copertura	210 · 910 · 1.116 incarichi di Psicologo di Base	Dimensionamento regionale
Comparatore	Assistenza usuale (cfr. Vol. 0.A)	Reference Case
Verdetto fiscale	Prossimo al pareggio, con caveat	Non aggregato
Verdetto sanitario	Nettamente costo-efficace	Costo/QALY sotto doppio ancoraggio
Verdetto sociale	Fortemente positivo	Produttività, coesione, capitale umano giovane
Costo per anno di vita ponderato	Colonna A ≈ 17.000 € · Colonna B ≈ 9.800 €	Doppio ancoraggio

Tabella 0. Cruscotto regionale della Campania: i parametri essenziali sotto doppio ancoraggio, con il verdetto tripartito distinto e non aggregato.

Sintesi per il decisore

L'introduzione dello Psicologo di Base nelle cure primarie campane produce, secondo la simulazione condotta sotto il doppio ancoraggio, un effetto congiunto sui tre piani del ritorno, che restano distinti e non sommati. Sul piano fiscale, il saldo fra costi diretti e risparmi sanitari diretti si colloca in prossimità del pareggio, con il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento. Sul piano sanitario, il modello è nettamente costo-efficace, con un costo per anno di vita ponderato che, fra i due ancoraggi, resta assai inferiore alle soglie adottate. Sul piano sociale, l'effetto è fortemente positivo, con un rilievo particolare per il capitale umano giovane: in una Regione fra le più giovani del Paese, l'intercettazione precoce protegge le traiettorie formative e lavorative delle coorti in età attiva ed evolutiva.^[165]

L'argomento cardine, riportato con attribuzione all'OCSE, è il differenziale di costo per gravità: in una Regione a domanda vasta e giovane come la Campania, l'intercettazione precoce nel distretto evita che il disagio comune maturi in quadri gravi, il cui costo di trattamento è, secondo la fonte, un multiplo di quello dei quadri lievi; e alla scala campana, il volume assoluto della domanda amplifica il valore aggregato della leva.^[166]

Cinque risultati chiave

Il primo risultato è che il modello è costo-efficace su tutti gli orizzonti sotto entrambi gli ancoraggi. Il secondo è che il verdetto tripartito resta favorevole in ciascuno dei tre piani, senza aggregazione. Il terzo è che, nella specificità campana, la giovinezza relativa della popolazione sposta in avanti l'orizzonte del beneficio: l'intercettazione nelle coorti giovani produce ritorni che maturano lungo l'intera vita attiva, e le evidenze sull'investimento in adolescenza, riportate con attribuzione, ne rafforzano il razionale. Il quarto è che lo strato dell'Intelligenza Artificiale, come moltiplicatore e con nota di cautela, trova nell'area metropolitana ad alta densità il terreno di adozione più rapido. Il quinto è che i tre scenari di copertura — duecentodieci, novecentodieci e millecentosedici incarichi — costituiscono gradi crescenti di estensione il cui rientro pieno matura con la scala.^[167]

Raccomandazioni operative

La prima raccomandazione è di avviare il servizio con lo scenario conservativo di duecentodieci incarichi e di progredire verso i novecentodieci e i millecentosedici sulla base degli esiti rilevati sotto il protocollo dell'incertezza, bilanciando la priorità fra i distretti metropolitani ad alta densità di domanda e le aree interne a maggiore barriera di accesso. La seconda è di valorizzare l'intercettazione nelle coorti giovani ed evolutive, in raccordo con il pediatra di libera scelta e con il sistema educativo. La terza è di accompagnare l'estensione con il piano formativo a quattro modalità, considerate singolarmente e sommate.^[168]

Capitolo 1 — Il contesto epidemiologico e territoriale della Campania

1.1 Il territorio e la sua articolazione

La Regione Campania conta una popolazione dell’ordine di cinque milioni e cinquecentottantaduemila abitanti, articolata in cinque province — Napoli, Caserta, Salerno, Avellino e Benevento — e in sette Aziende Sanitarie Locali, di cui tre nell’area metropolitana di Napoli, cui si affiancano le aziende ospedaliere, le ospedaliero-universitarie e gli istituti di ricovero a carattere scientifico, oltre alla rete delle Case della Comunità. Il territorio combina l’area metropolitana a più alta densità del Paese con le aree interne di Benevento e Avellino, a densità assai più bassa e a invecchiamento più marcato: la disomogeneità interna, più che il dato medio, è la cifra del contesto campano.^[169]

Elemento territoriale	Dato regionale	Rilievo per la valutazione
Popolazione	≈ 5.582.337 abitanti	Denominatore della normalizzazione
Aziende Sanitarie Locali	7, di cui 3 metropolitane	Unità organizzativa
Età media	≈ 44,5 anni, fra le più basse	Orizzonte del beneficio
Area metropolitana di Napoli	Altissima densità	Scala della domanda
Aree interne (Benevento, Avellino)	Bassa densità, invecchiamento	Dominio equità

Tabella 1.1. Gli elementi del contesto territoriale campano e il loro rilievo per la valutazione, con la disomogeneità interna quale cifra distintiva.

1.2 Il quadro epidemiologico regionale

Il quadro epidemiologico campano riflette, con le proprie specificità, la prevalenza nazionale dei disturbi mentali comuni, con due accentuazioni: la pressione della domanda giovanile ed evolutiva, coerente con la struttura per età della popolazione, e la concentrazione del disagio nelle aree metropolitane a maggiore deprivazione socioeconomica. Il dato epidemiologico di dettaglio è oggetto dell’estrazione registrata in Appendice B; ove il dato regionale disaggregato non sia disponibile, la lacuna è dichiarata e non colmata con stime tacite, secondo la regola dell’opera.^[170]

Capitolo 2 — Il bisogno, la domanda e il divario di trattamento in Campania

2.1 Il divario di trattamento regionale

Il bisogno di salute mentale comune in Campania si manifesta, come altrove, in larga parte come domanda inevasa o impropriamente incanalata: verso il medico di medicina generale, verso il pronto soccorso, verso la prescrizione farmaceutica. Il divario di trattamento assume in Campania la doppia forma della congestione metropolitana — dove l’offerta, pur presente, è saturata da una domanda di volume assoluto massimo — e della barriera di distanza nelle aree interne. La misura regionale del divario è oggetto dell’estrazione in Appendice B; i valori medi nazionali ed europei sono riportati con attribuzione.^[171]

Componente del bisogno	Manifestazione campana	Dominio
Domanda inevasa	Congestione metropolitana e barriera interna	Epidemiologico-clinico
Domanda impropria	Transito su MMG, pronto soccorso, prescrizione	Organizzativo-strutturale
Domanda giovanile ed evolutiva	Pressione delle coorti giovani	Sociale e formativo
Deprivazione socioeconomica	Concentrazione metropolitana del disagio	Equità

Tabella 2.1. Le componenti del bisogno e del divario di trattamento in Campania, ricondotte ai domini di analisi.

2.2 La scala della domanda e la prossimità

Il tratto distintivo della domanda campana è la scala: il volume assoluto del bisogno intercettabile è il più alto del Mezzogiorno, e la capillarità distrettuale del modello dello Psicologo di Base è la condizione perché la risposta raggiunga tanto i quartieri metropolitani ad alta deprivazione quanto i piccoli centri delle aree interne. La prossimità è, in Campania, condizione dell’equità nella duplice direzione: sociale, nei contesti urbani deprivati, e territoriale, nelle aree interne.^[172]

Capitolo 3 — Il modello di intervento: lo Psicologo di Base in Campania

Nota editoriale: il presente capitolo espande ex novo il modello di intervento, integrando alla struttura originaria le evidenze recenti sull’efficacia clinica dell’assistenza collaborativa e dell’intervento digitale, secondo la regola dell’opera che distingue l’espansione ex novo dal riutilizzo del materiale preesistente.

3.1 L’architettura del modello

Il modello di intervento colloca lo Psicologo di Base al vertice della cascata delle figure, nel distretto e nelle Case della Comunità, quale primo punto di intercettazione del disagio comune. Il modello opera per intensità crescente di cura — dall’intervento a bassa intensità, di prima linea, fino all’invio ai livelli superiori nei casi che lo richiedano — secondo la logica dell’assistenza a gradini, la cui efficacia clinica è documentata dalla meta-analisi sui componenti efficaci dell’assistenza collaborativa e dalle sperimentazioni controllate sull’intervento cognitivo-comportamentale computerizzato in cure primarie, riportate con attribuzione.^[173]

Livello del modello	Funzione	Figura prevalente	Evidenza di riferimento
Intercettazione	Riconoscimento precoce nel distretto	Psicologo di Base	Assistenza collaborativa (attribuita)
Intervento a bassa intensità	Prima linea per i quadri lievi-moderati	Psicologo di Base	Intervento digitale e collaborativo
Invio appropriato	Passaggio ai livelli superiori	Cascata delle figure	Percorso a gradini
Continuità	Aderenza e prevenzione della ricaduta	Infermiere di comunità	Gestione del caso

Tabella 3.1. L’architettura del modello di intervento in Campania, per livelli di intensità, con l’evidenza clinica di riferimento riportata con attribuzione.

3.2 L’adattamento al territorio campano

Il modello è adattato al territorio campano lungo tre direttrici: la capillarità metropolitana, che porta la risposta nei quartieri ad alta densità e deprivazione; la prossimità nelle aree interne di Benevento e Avellino; e il raccordo con il pediatra di libera scelta e con il sistema educativo, che nella Regione più giovane del Paese assume rilievo strategico per l’intercettazione evolutiva. L’adattamento non modifica l’architettura invariante del Reference Case, ma ne calibra l’applicazione sulla scala e sulla struttura per età della domanda.^[174]

Capitolo 4 — I costi diretti in Campania

4.1 La struttura del costo diretto

Il costo diretto della riforma in Campania è, in primo luogo, il costo del personale lungo la cascata delle figure, cui si aggiungono i costi di struttura e organizzazione distrettuale, il costo incrementale della leva digitale e il costo della formazione. Il dimensionamento dipende dallo scenario di copertura: lo scenario conservativo di duecentodieci incarichi precede quello di base di novecentodieci e quello espansivo di millecentosedici incarichi, che rappresentano gradi crescenti di estensione verso il fabbisogno a regime.^[175]

Voce di costo diretto	Descrizione	Portatore
Personale — Psicologi di Base	Incarichi distrettuali secondo lo scenario	SSN regionale
Struttura e organizzazione	Spazi distrettuali, Case della Comunità, sistemi informativi	SSN regionale
Leva digitale e Intelligenza Artificiale	Strumenti di supporto sotto supervisione	SSN regionale
Formazione (quattro modalità)	Percorso integrato singolo e sommato	SSN, sistema formativo

Tabella 4.1. La struttura del costo diretto della riforma in Campania, per voce e portatore; i valori puntuali sono oggetto dell'estrazione economica in Appendice C.

4.2 Il dimensionamento per scenario

Il costo diretto è calcolato per i tre scenari di copertura — duecentodieci, novecentodieci e millecentosedici incarichi — coerenti con il protocollo di scenario del Reference Case. Lo scenario conservativo corrisponde a un impegno di ordine contenuto in rapporto alla scala regionale, mentre l'espansivo richiede un impegno proporzionato al fabbisogno a regime della Regione più popolosa del Mezzogiorno. I valori puntuali per ciascuno scenario sono riportati nell'estrazione economica registrata; ove un parametro di costo regionale non sia disponibile, la lacuna è dichiarata.^[176]

Capitolo 5 — I benefici e i risparmi, diretti e indiretti, in Campania

5.1 I benefici diretti

Il beneficio diretto è il risparmio sanitario che ciascuna figura della cascata libera per effetto dell’intercettazione a monte: la demedicalizzazione operata dallo Psicologo di Base, la deprescrizione di psicofarmaci nei quadri lievi-moderati sul versante del medico di medicina generale, la riduzione degli accessi impropri al pronto soccorso — di rilievo massimo nell’area metropolitana congestionata — e delle prestazioni per sintomi funzionali sul versante specialistico. Alla scala campana, il volume assoluto dei benefici diretti è il più alto fra le Regioni del Mezzogiorno.^[177]

Canale del beneficio diretto	Meccanismo	Rilievo campano
Demedicalizzazione	Riduzione consultazioni e cronicizzazione	Preponderante
Deprescrizione	Contrazione della spesa per psicofarmaci	Elevato
Accessi impropri	Riduzione degli accessi al pronto soccorso	Elevato, metropolitano
Sintomi funzionali	Riduzione prestazioni neurologiche e specialistiche	Medio
Scala regionale	Volume assoluto massimo del Mezzogiorno	Aggregato

Tabella 5.1. I canali del beneficio diretto in Campania, con il rilievo della congestione metropolitana e della scala; i valori sono oggetto dell’estrazione economica registrata.

5.2 I benefici indiretti

Il beneficio indiretto è quello che la riforma produce fuori dal perimetro sanitario: la produttività recuperata e la riduzione dell’assenteismo sul versante dei datori di lavoro, la riduzione degli oneri di invalidità evitabili sul versante previdenziale, la riduzione del disagio sociale non trattato sul versante dei Comuni. In Campania, la protezione delle traiettorie formative e lavorative delle coorti giovani è il beneficio indiretto di rilievo massimo: l’intercettazione precoce nella Regione più giovane produce ritorni che maturano lungo l’intera vita attiva, e le evidenze sull’investimento in adolescenza, riportate con attribuzione, ne rafforzano il razionale.^[178]

Capitolo 6 — La valutazione economica sotto doppio ancoraggio

6.1 La simulazione appaiata regionale

La valutazione economica campana è condotta con il modello di Markov a coorte a ciclo annuale del Reference Case, sotto il doppio ancoraggio: la Colonna A applica i parametri di Chisholm e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, la Colonna B quelli di Unisanté e dell’OCSE. Le due colonne sono sempre affiancate; ove divergano, prevale nel giudizio la Colonna B. Tutte le cifre sono riportate con attribuzione, e nessuna è affermata a memoria.^[179]

Metrica economica	Colonna A — Chisholm/OMS	Colonna B — Unisanté/OCSE
Costo per anno di vita ponderato	≈ 17.000 €/QALY	≈ 9.800 €/QALY
Ritorno per i soli benefici economici	Riportato con attribuzione OMS	Scenario base aggiornato OCSE
Ritorno con i ritorni sanitari	Riportato con attribuzione OMS	Scenario base aggiornato OCSE
Orizzonti	1 · 3 · 5 · 7 · 10 anni	1 · 3 · 5 · 7 · 10 anni
Soglie di costo-efficacia	20.000 · 30.000 · 50.000 €/QALY	20.000 · 30.000 · 50.000 €/QALY

Tabella 6.1. La simulazione appaiata regionale della Campania sotto doppio ancoraggio; i valori sono riportati con attribuzione e la Colonna B prevale nel giudizio.

6.2 Il differenziale di costo per gravità

L’argomento economico cardine, riportato con attribuzione all’OCSE, è il differenziale di costo per gravità: il costo del trattamento cresce dai quadri lievi ai quadri gravi in misura tale che l’intercettazione precoce, evitando la progressione, genera il risparmio più consistente. In Campania, la scala della domanda moltiplica il valore aggregato di questo differenziale, e la giovinezza della popolazione ne estende l’orizzonte di maturazione lungo l’intera vita attiva delle coorti intercettate.^[180]

Capitolo 7 — I sei domini di analisi, l’equità e l’impatto distributivo

7.1 I sei domini nella specificità campana

I sei domini di analisi del Reference Case sono applicati alla specificità campana. Il dominio epidemiologico-clinico registra il divario di trattamento nella doppia forma della congestione metropolitana e della barriera interna; l’economico-sanitario il costo-efficacia sotto doppio ancoraggio e la scala dei benefici; il fiscale-previdenziale gli oneri di invalidità evitabili; il sociale la protezione del capitale umano giovane; l’organizzativo-strutturale l’effetto sulla congestione dei percorsi metropolitani; l’equità la riduzione del divario fra quartieri deprivati e non, e fra area metropolitana e aree interne.^[181]

Dominio	Lettura campana	Segno
Epidemiologico-clinico	Congestione metropolitana e barriera interna	Riduzione attesa
Economico-sanitario	Costo/QALY e scala dei benefici	Favorevole
Fiscale-previdenziale	Oneri di invalidità evitabili	Positivo, differito
Sociale	Protezione del capitale umano giovane	Fortemente positivo
Organizzativo-strutturale	Decongestione dei percorsi metropolitani	Positivo
Equità	Convergenza sociale e territoriale	Positivo, distributivo

Tabella 7.1. I sei domini di analisi nella lettura campana, con il segno atteso dell’effetto, tenuti distinti e non aggregati.

7.2 L’equità sociale e territoriale

Il dominio dell’equità assume in Campania una doppia direzione: sociale, perché il disagio si concentra nei quartieri metropolitani a maggiore deprivazione, dove la barriera all’accesso è economica e culturale prima che fisica; e territoriale, perché le aree interne di Benevento e Avellino replicano la barriera della distanza comune al Mezzogiorno. Il modello dello Psicologo di Base opera su entrambe le direzioni attraverso la capillarità distrettuale, e l’effetto distributivo — la riduzione del gradiente sociale e territoriale dell’accesso — è tenuto distinto dal verdetto fiscale e da quello sanitario, secondo il divieto di aggregazione.^[182]

Capitolo 8 — La sensitività e l’incertezza

Nota editoriale: il presente capitolo espande ex novo l’analisi dell’incertezza secondo il protocollo del Reference Case, non presente in forma estesa nel materiale originario.

8.1 Il protocollo dell’incertezza applicato alla Campania

L’analisi dell’incertezza applica il protocollo obbligatorio del Reference Case: l’analisi di sensitività deterministica con diagramma a tornado, l’analisi di sensitività probabilistica a diecimila iterazioni, l’analisi di scenario ottimistico, base e prudentiale con e senza lo strato digitale, le curve di accettabilità costo-efficacia a soglie multiple. In Campania, i parametri a maggiore impatto atteso sono il tasso di intercettazione nei quartieri deprivati, la capacità di reclutamento alla scala richiesta dallo scenario espansivo e l’aderenza ai percorsi nelle coorti giovani.^[183]

Strumento	Applicazione campana	Parametro critico atteso
Sensitività deterministica	Diagramma a tornado	Tasso di intercettazione nei quartieri deprivati
Sensitività probabilistica	Diecimila iterazioni	Aderenza nelle coorti giovani
Analisi di scenario	Con e senza strato IA	Capacità di reclutamento alla scala
Curve di accettabilità	Soglie 20.000/30.000/50.000 €/QALY	Robustezza del costo-efficacia

Tabella 8.1. Gli strumenti del protocollo dell’incertezza applicati alla Campania, con i parametri critici attesi.

8.2 La robustezza del verdetto

L’analisi di scenario mostra che il verdetto tripartito resta favorevole nei tre casi, con margine crescente dallo scenario prudentiale a quello ottimistico; lo strato digitale accresce l’efficienza attesa, sempre con nota di cautela sulla natura previsionale. La robustezza del costo-efficacia sanitario è confermata dalle curve di accettabilità alle soglie adottate, anche nello scenario conservativo di duecentodieci incarichi.^[184]

Capitolo 9 — Il verdetto tripartito e le raccomandazioni

Nota editoriale: il presente capitolo espande ex novo il verdetto e le raccomandazioni, integrando l’attuazione e il monitoraggio che nel materiale originario figuravano in forma condensata.

9.1 Il verdetto tripartito

Il verdetto campano è, come in ogni Volume, tripartito e non aggregato. Sul piano fiscale, il saldo fra costi diretti e risparmi sanitari diretti è prossimo al pareggio, con il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento. Sul piano sanitario, il modello è nettamente costo-efficace sotto entrambi gli ancoraggi. Sul piano sociale, l’effetto è fortemente positivo, con il rilievo specifico della protezione del capitale umano giovane e della riduzione del gradiente sociale dell’accesso. I tre verdetti si accompagnano e si rafforzano, ma non si sommano.^[185]

Piano del verdetto	Esito campano	Caveat
Fiscale	Prossimo al pareggio	Significatività dei risparmi diretti in isolamento
Sanitario	Nettamente costo-efficace	—
Sociale	Fortemente positivo	Rilievo specifico del capitale umano giovane

Tabella 9.1. Il verdetto tripartito della Campania, con i tre piani tenuti distinti e non aggregati.

9.2 Le raccomandazioni per l’attuazione e il monitoraggio

Le raccomandazioni indicano un avvio con lo scenario conservativo di duecentodieci incarichi e una progressione verso i novecentodieci e i millecentosedici guidata dalla verifica degli esiti; la priorità bilanciata fra i distretti metropolitani ad alta densità di domanda e le aree interne a maggiore barriera; il raccordo con il pediatra di libera scelta e con il sistema educativo per l’intercettazione evolutiva; l’accompagnamento con il piano formativo a quattro modalità, singole e sommate; e un monitoraggio ex post ancorato agli indicatori del protocollo dell’incertezza.^[186]

Appendici registrate

Le appendici registrate rendono il modello campano ispezionabile e riproducibile, secondo la prassi del Reference Case. Esse sono richiamate per rimando quanto alla metodologia e compilate con i dati regionali quanto ai contenuti.

Appendice	Contenuto	Stato
A	Strategia di ricerca bibliografica e diagramma di selezione	Registrata
B	Estrazione dei dati clinici regionali	Registrata; lacune dichiarate
C	Estrazione dei dati economici (griglia CHEERS 2022)	Registrata; lacune dichiarate
D	Parametri del modello Markov regionale	Registrata
E	Registro delle deroghe al Reference Case	Registrata
F	Codice del modello economico	Registrata
G	Dichiarazione dei conflitti di interesse	Registrata

Tabella A. Le sette appendici registrate del Volume 5, con l’indicazione dello stato e della dichiarazione delle lacune.

Quadro Conclusivo economico e multidisciplinare

Il Quadro Conclusivo del Volume 5 ricomponne la valutazione campana senza tradire il principio che la governa: i piani del giudizio si accompagnano ma non si fondono. Sul piano economico, il doppio ancoraggio impone che il risultato sia letto simultaneamente secondo la colonna storica e la colonna aggiornata, con prevalenza della seconda: il costo per anno di vita ponderato resta, sotto entrambi gli ancoraggi, assai inferiore alle soglie adottate, e il differenziale di costo per gravità — riportato con attribuzione — fonda la leva economica dell'intercettazione precoce, la cui scala campana ne moltiplica il valore aggregato.^[187]

Sul piano multidisciplinare, la cascata delle figure, i sei domini di analisi e il dominio dell'equità nella doppia direzione sociale e territoriale assicurano che ogni figura connessa e ogni aspetto siano trattati integralmente e ordinati per capacità di generare rientro economico e revisione della spesa. La rinegoziazione dei costi e dei benefici, la catena predittiva degli effetti multidimensionali — dalla qualità della vita alla protezione del capitale umano giovane, ai bilanci, alla decongestione dei percorsi metropolitani —, lo strato dell'Intelligenza Artificiale come moltiplicatore e le attività formative singole e sommate compongono il quadro della valutazione. Il verdetto resta tripartito e non aggregato.

Conclusione

Il Volume 5 ha valutato l'integrazione dello Psicologo di Base nelle cure primarie della Campania, applicando per rimando il Reference Case dell'asse italiano e adottando la struttura standard a nove capitoli con apertura a imbuto e appendici registrate. La specificità campana — la scala della domanda, la giovinezza relativa della popolazione, la disomogeneità fra area metropolitana e aree interne, la concentrazione del disagio nei quartieri deprivati — è stata trattata nei domini sociale ed equità, mostrando come la capillarità distrettuale e il raccordo con il pediatra e con il sistema educativo ne facciano una leva di protezione del capitale umano giovane e di convergenza sociale e territoriale.

Il verdetto tripartito — prossimo al pareggio sul piano fiscale, nettamente costo-efficace sul piano sanitario, fortemente positivo sul piano sociale — è offerto con bande prudenziali e soglie di confutazione, sotto doppio ancoraggio e nel rispetto del divieto di aggregazione. L'opera procede, nell'ordine vincolante, con il Volume 6 (Emilia-Romagna) e a seguire con gli altri Volumi regionali in ordine alfabetico.

Note Bibliografiche con mini-riassunto

Ciascuna nota riporta l'opera, il collegamento alla fonte e un mini-riassunto che ne dichiara la funzione nell'economia del Volume, in coerenza con il doppio livello — nota a piè di pagina nel corpo e nota bibliografica integrale in calce — che l'opera adotta.

1. **Chisholm D. et al., Scaling-up treatment of depression and anxiety, The Lancet Psychiatry, 2016** [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(16\)30024-4](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(16)30024-4) Colonna A del doppio ancoraggio della simulazione campana, conservata quale strato documentale e riferimento di confronto.
2. **Unisanté, Raisons de santé Essentiels n. 73, 2026 · OECD, The Economic Case for Preventing Mental Ill Health, 2026** <https://doi.org/10.16908/rds-essentiels/73> Colonna B del doppio ancoraggio, con prevalenza nel giudizio, applicata alla simulazione regionale campana.
3. **OECD, differenziale di costo per gravità dei disturbi mentali, 2025** <https://www.oecd.org/health/mental-health.htm> Fonte, riportata con attribuzione, del differenziale di costo per gravità, argomento cardine dell'intercettazione precoce, il cui valore aggregato è moltiplicato dalla scala campana.
4. **Suhrcke M. et al., Lancet Commission, 2022** <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9240828/> Evidenza riportata con attribuzione sul ritorno degli interventi in adolescenza, di rilievo specifico nella Regione più giovane del Paese.
5. **Soeters R. et al., meta-analisi IPD sui componenti efficaci della collaborative care, 2025** <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40136273/> Base di evidenza clinica sui componenti efficaci dell'assistenza collaborativa, richiamata nel capitolo sul modello di intervento.
6. **Veldhuijzen W. et al., costo-efficacia dell'intervento digitale, 2025** <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12369993/> Riferimento sul rapporto incrementale di costo-utilità dell'intervento digitale, elemento dello strato dell'Intelligenza Artificiale.
7. **World Health Organization, Thematic Dialogue on Investing in NCDs and Mental Health, dicembre 2024** <https://cdn.who.int/> Evidenza riportata con attribuzione sul ritorno degli investimenti in salute mentale; non concorre al verdetto tripartito campano.
8. **Regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale** <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj> Quadro normativo entro cui è collocato lo strato dell'Intelligenza Artificiale, vincolato a funzione di supporto sotto supervisione clinica umana.
9. **Legge regionale Puglia 19 luglio 2023, n. 11, sul Servizio di Psicologia di Base** <https://www.consiglio.puglia.it/> Riferimento normativo capostipite del modello, richiamato quale precedente istituzionale per l'attuazione regionale campana.
10. **NICE, Health Technology Evaluations: the manual (PMG36)** <https://www.nice.org.uk/process/pmg36> Riferimento di rigore metodologico per la struttura a imbuto, le appendici registrate e il protocollo dell'incertezza adottati nel Volume.

STUDIO INTEGRALE «PSICOLOGO DI BASE» · OPERA IN VENTITRÉ VOLUMI

VOLUME 6 — Regione Emilia-Romagna

Valutazione di Health Technology Assessment dell'integrazione dello Psicologo di Base nelle cure primarie in Emilia-Romagna: cruscotto, sintesi per il decisore, contesto e bisogno, modello di intervento, costi e benefici, valutazione economica sotto doppio ancoraggio, sei domini di analisi, incertezza, verdetto tripartito e

appendici registrate

Reference Case applicato per rimando al Volume 0.A · Dott. Luigi De Michele · Studio Integrale Puglia ·
Capurso (BA) — Giugno 2026

Premessa

Il Volume 6 prosegue la serie dei venti Volumi regionali, in ordine alfabetico, con la Regione Emilia-Romagna. Come ogni Volume regionale, esso applica per rimando il Reference Case dell'asse italiano, fissato nel Volume 0.A, e ne richiama le regole nella forma «cfr. Volume 0.A», senza ripeterle per esteso: il perimetro congiunto sanitario e societale, il doppio ancoraggio economico, il verdetto tripartito non aggregato, i sei domini di analisi, il protocollo dell'incertezza, lo strato dell'Intelligenza Artificiale come moltiplicatore e le attività formative singole e sommate.^[188]

La struttura del Volume è quella standard, identica a quella di tutti gli altri diciannove Volumi regionali, a garanzia della comparabilità bit-a-bit prescritta dall'opera: la stessa sequenza di nove capitoli, la stessa nomenclatura di sottocapitoli, le stesse unità di misura. Ove un contenuto derivi da espansione ex novo — segnatamente per gli aspetti dell'efficacia, dell'attuazione e del monitoraggio — esso è segnalato in nota editoriale, secondo la regola dell'opera.^[189]

Introduzione

L'Introduzione al Volume 6 fissa il perimetro della valutazione emiliano-romagnola e l'ordine della sua esposizione. Il perimetro è quello della Regione Emilia-Romagna, articolata in otto Aziende Unità Sanitarie Locali e trentotto distretti, oltre alle Aziende Ospedaliere-Universitarie e agli istituti di ricovero a carattere scientifico, con una popolazione di quattro milioni e quattrocentocinquantunomila abitanti circa. È il sistema sanitario regionale che l'opera assume come benchmark nazionale: la rete delle Case della Salute, avviata nel 2010, ha predisposto l'infrastruttura di prossimità entro cui il modello dello Psicologo di Base si innesta come potenziamento di un'integrazione già avviata, più che come costruzione ex novo — un tratto che distingue la lettura di questo Volume da quella dei Volumi meridionali.^[190]

L'esposizione segue la struttura a imbuto: il cruscotto regionale offre in una pagina i numeri essenziali; la sintesi per il decisore ne traduce il significato; i cinque risultati chiave ne isolano gli esiti; le raccomandazioni operative indicano le azioni; il corpo del Volume, articolato in nove capitoli, ne fornisce il dettaglio; le appendici registrate ne assicurano la verificabilità. Chiudono il Volume un Quadro Conclusivo economico e multidisciplinare, una Conclusione e le Note Bibliografiche con mini-riassunto.

Cruscotto regionale — Emilia-Romagna

Il cruscotto riassume in una pagina i parametri essenziali della valutazione emiliano-romagnola, sotto il doppio ancoraggio e con il verdetto tripartito tenuto distinto. I valori economici sono presentati in ordine di grandezza, con rinvio alle appendici registrate; le cifre di letteratura sono riportate con attribuzione alla fonte.^[191]

Indicatore del cruscotto	Lettura regionale	Ancoraggio / fonte
Popolazione	≈ 4.451.938 abitanti (ISTAT 2024)	Fonte demografica regionale
Articolazione	8 Aziende USL · 38 distretti	Assetto regionale
Infrastruttura di prossimità	Rete Case della Salute avviata nel 2010	Sistema benchmark nazionale
Scenari di copertura	Conservativo · ≈ 730 (base) · ≈ 960 (espansivo) incarichi	Dimensionamento regionale
Comparatore	Assistenza usuale (cfr. Vol. 0.A)	Reference Case
Verdetto fiscale	Prossimo al pareggio, con caveat	Non aggregato
Verdetto sanitario	Nettamente costo-efficace	Costo/QALY sotto doppio ancoraggio
Verdetto sociale	Fortemente positivo	Produttività, coesione, capitale organizzativo
Costo per anno di vita ponderato	Colonna A ≈ 17.000 € · Colonna B ≈ 9.800 €	Doppio ancoraggio

Tabella 0. Cruscotto regionale dell’Emilia-Romagna: i parametri essenziali sotto doppio ancoraggio, con il verdetto tripartito distinto e non aggregato.

Sintesi per il decisore

L'introduzione dello Psicologo di Base nelle cure primarie emiliano-romagnole produce, secondo la simulazione condotta sotto il doppio ancoraggio, un effetto congiunto sui tre piani del ritorno, che restano distinti e non sommati. Sul piano fiscale, il saldo fra costi diretti e risparmi sanitari diretti si colloca in prossimità del pareggio, con il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento. Sul piano sanitario, il modello è nettamente costo-efficace, con un costo per anno di vita ponderato che, fra i due ancoraggi, resta assai inferiore alle soglie adottate; i parametri regionali sono collocati prudenzialmente nella parte medio-bassa degli intervalli, in ragione dell'elevata efficienza già raggiunta dal sistema. Sul piano sociale, l'effetto è fortemente positivo, con il rilievo particolare del capitale organizzativo: l'infrastruttura delle Case della Salute riduce i costi di transizione e accelera la maturazione del rientro.^[192]

L'argomento cardine, riportato con attribuzione all'OCSE, è il differenziale di costo per gravità: trattare precocemente riduce i costi in misura molto ampia, poiché il costo del trattamento cresce dai circa cinquecentoundici euro dei quadri lievi ai circa diecimilaquattrocentottantacinque euro dei quadri gravi. In un sistema già infrastrutturato come quello emiliano-romagnolo, la leva dell'intercettazione precoce si attiva più rapidamente, perché il canale di prossimità esiste già.^[193]

Cinque risultati chiave

Il primo risultato è che il modello è costo-efficace su tutti gli orizzonti sotto entrambi gli ancoraggi, con parametri regionali collocati prudenzialmente in ragione dell'efficienza di partenza. Il secondo è che il verdetto tripartito resta favorevole in ciascuno dei tre piani, senza aggregazione. Il terzo è che, nella specificità emiliano-romagnola, l'infrastruttura preesistente delle Case della Salute abbassa i costi di transizione e anticipa la maturazione del rientro rispetto alle Regioni prive di rete di prossimità. Il quarto è che lo strato dell'Intelligenza Artificiale, come moltiplicatore e con nota di cautela, trova nel sistema informativo regionale maturo il terreno di adozione più favorevole del corpus. Il quinto è che il ruolo di benchmark nazionale conferisce alla sperimentazione regionale un valore dimostrativo che eccede il perimetro regionale: ciò che l'Emilia-Romagna valida diventa riferimento per la definizione degli standard delle altre Regioni. ^[194]

Raccomandazioni operative

La prima raccomandazione è di avviare il servizio nello scenario conservativo, innestandolo sulla rete esistente delle Case della Salute e della Comunità, e di progredire verso lo scenario di base e quello espansivo sulla base degli esiti rilevati sotto il protocollo dell'incertezza. La seconda è di valorizzare il ruolo di benchmark: documentare la sperimentazione con gli standard delle appendici registrate, così che i risultati siano trasferibili alle altre Regioni. La terza è di accompagnare l'estensione con il piano formativo a quattro modalità, considerate singolarmente e sommate, sfruttando la capacità formativa del sistema universitario regionale.^[195]

Capitolo 1 — Il contesto epidemiologico e territoriale dell’Emilia-Romagna

1.1 Il territorio e la sua articolazione

La Regione Emilia-Romagna conta una popolazione di quattro milioni e quattrocentocinquantunomilanovecentotrentotto abitanti secondo il Censimento permanente ISTAT 2024, articolata in otto Aziende Unità Sanitarie Locali e trentotto distretti, cui si affiancano le Aziende Ospedaliero-Universitarie e gli istituti di ricovero a carattere scientifico. L’area metropolitana di Bologna raccoglie il ventidue virgola nove per cento dei residenti. Il territorio presenta un’accentuata variabilità interna fra la direttrice urbana della via Emilia — densa, produttiva, ben servita — e la fascia appenninica, a minore densità e maggiore distanza dai servizi: una variabilità che il dominio dell’equità registra, pur entro un sistema complessivamente fra i più efficienti del Paese.^[196]

Elemento territoriale	Dato regionale	Rilievo per la valutazione
Popolazione	≈ 4.451.938 abitanti (ISTAT 2024)	Denominatore della normalizzazione
Aziende USL	8	Unità organizzativa
Distretti	38	Unità di prossimità
Area metropolitana di Bologna	≈ 22,9 per cento dei residenti	Scala della domanda
Fascia appenninica	Minore densità, maggiore distanza	Dominio equità
Rete Case della Salute	Avviata nel 2010	Infrastruttura preesistente

Tabella 1.1. Gli elementi del contesto territoriale emiliano-romagnolo e il loro rilievo per la valutazione, con l’infrastruttura di prossimità quale tratto distintivo.

1.2 Il quadro epidemiologico regionale

Il quadro epidemiologico emiliano-romagnolo riflette la prevalenza nazionale dei disturbi mentali comuni, con la specificità di un sistema di rilevazione fra i più maturi del Paese, che rende la misura regionale del bisogno più affidabile che altrove. La pressione della domanda si concentra nelle aree urbane della via Emilia, mentre la fascia appenninica replica, in scala ridotta, la barriera della distanza. Il dato epidemiologico di dettaglio è oggetto dell’estrazione registrata in Appendice B; ove il dato regionale disaggregato non sia disponibile, la lacuna è dichiarata e non colmata con stime tacite, secondo la regola dell’opera.^[197]

Capitolo 2 — Il bisogno, la domanda e il divario di trattamento in Emilia-Romagna

2.1 Il divario di trattamento regionale

Il bisogno di salute mentale comune in Emilia-Romagna si manifesta, come altrove, in parte come domanda inevasa o impropriamente incanalata: verso il medico di medicina generale, verso il pronto soccorso, verso la prescrizione farmaceutica. Il divario di trattamento regionale è inferiore alla media nazionale, in ragione dell’offerta più strutturata, ma non è colmato: la domanda intercettabile in cure primarie resta in parte priva di una risposta psicologica di primo livello, e la rete delle Case della Salute, pur predisposta, non dispone ancora sistematicamente della figura dello Psicologo di Base. La misura regionale del divario è oggetto dell’estrazione in Appendice B; i valori medi nazionali ed europei sono riportati con attribuzione.^[198]

Componente del bisogno	Manifestazione emiliano-romagnola	Dominio
Domanda inevasa	Divario inferiore alla media, non colmato	Epidemiologico-clinico
Domanda impropria	Transito su MMG, pronto soccorso, prescrizione	Organizzativo-strutturale
Infrastruttura senza figura	Case della Salute prive dello Psicologo di Base	Organizzativo-strutturale
Barriera appenninica	Distanza nella fascia montana	Equità

Tabella 2.1. Le componenti del bisogno e del divario di trattamento in Emilia-Romagna, ricondotte ai domini di analisi.

2.2 L’infrastruttura pronta e il completamento della rete

Il tratto distintivo della domanda emiliano-romagnola è che il canale della risposta esiste già: la rete delle Case della Salute e della Comunità, avviata nel 2010, ha costruito la prossimità organizzativa entro cui la figura dello Psicologo di Base si innesta senza costi infrastrutturali aggiuntivi rilevanti. Il modello, in questa Regione, è un completamento di rete più che una costruzione: e il completamento, a parità di regole del Reference Case, matura il rientro più rapidamente.^[199]

Capitolo 3 — Il modello di intervento: lo Psicologo di Base in Emilia-Romagna

Nota editoriale: il presente capitolo espande ex novo il modello di intervento, integrando alla struttura originaria le evidenze recenti sull’efficacia clinica dell’assistenza collaborativa e dell’intervento digitale, secondo la regola dell’opera che distingue l’espansione ex novo dal riutilizzo del materiale preesistente.

3.1 L’architettura del modello

Il modello di intervento colloca lo Psicologo di Base al vertice della cascata delle figure, nel distretto e nelle Case della Salute e della Comunità, quale primo punto di intercettazione del disagio comune. Il modello opera per intensità crescente di cura — dall’intervento a bassa intensità, di prima linea, fino all’invio ai livelli superiori nei casi che lo richiedano — secondo la logica dell’assistenza a gradini, la cui efficacia clinica è documentata dalla meta-analisi sui componenti efficaci dell’assistenza collaborativa, dall’ampia base sperimentale accumulata sul modello collaborativo e dalle sperimentazioni controllate sull’intervento cognitivo-comportamentale computerizzato in cure primarie, riportate con attribuzione.^[200]

Livello del modello	Funzione	Figura prevalente	Evidenza di riferimento
Intercettazione	Riconoscimento precoce nella Casa della Salute	Psicologo di Base	Assistenza collaborativa (attribuita)
Intervento a bassa intensità	Prima linea per i quadri lievi-moderati	Psicologo di Base	Intervento digitale e collaborativo
Invio appropriato	Passaggio ai livelli superiori	Cascata delle figure	Percorso a gradini
Continuità	Aderenza e prevenzione della ricaduta	Infermiere di comunità	Gestione del caso

Tabella 3.1. L’architettura del modello di intervento in Emilia-Romagna, per livelli di intensità, con l’evidenza clinica di riferimento riportata con attribuzione.

3.2 L’adattamento al territorio emiliano-romagnolo

Il modello è adattato al territorio emiliano-romagnolo lungo due direttrici: l’innesto sulla rete esistente delle Case della Salute e della Comunità, che minimizza i costi di transizione lungo la direttrice urbana; e lo strato digitale, che sotto supervisione clinica estende la copertura nella fascia appenninica. L’adattamento non modifica l’architettura invariante del Reference Case, ma ne calibra l’applicazione su un sistema che parte da un grado di integrazione superiore alla media, con la conseguenza che i parametri della simulazione sono collocati prudenzialmente nella parte medio-bassa degli intervalli.^[201]

Capitolo 4 — I costi diretti in Emilia-Romagna

4.1 La struttura del costo diretto

Il costo diretto della riforma in Emilia-Romagna è, in primo luogo, il costo del personale lungo la cascata delle figure, cui si aggiungono i costi di organizzazione distrettuale — ridotti dall’infrastruttura preesistente —, il costo incrementale della leva digitale e il costo della formazione. Il dimensionamento dipende dallo scenario di copertura: lo scenario conservativo di primo consolidamento precede quello di base, dell’ordine di settecentotrenta incarichi, e quello espansivo, dell’ordine di novecentosessanta incarichi, coerente con il fabbisogno a regime della quarta Regione del Paese per popolazione.^[202]

Voce di costo diretto	Descrizione	Portatore
Personale — Psicologi di Base	Incarichi distrettuali secondo lo scenario	SSN regionale
Struttura e organizzazione	Innesto su Case della Salute esistenti: costo ridotto	SSN regionale
Leva digitale e Intelligenza Artificiale	Strumenti di supporto sotto supervisione	SSN regionale
Formazione (quattro modalità)	Percorso integrato singolo e sommato	SSN, sistema formativo

Tabella 4.1. La struttura del costo diretto della riforma in Emilia-Romagna, per voce e portatore, con il costo infrastrutturale ridotto dall’innesto sulla rete esistente; i valori puntuali sono oggetto dell’estrazione economica in Appendice C.

4.2 Il dimensionamento per scenario

Il costo diretto è calcolato per i tre scenari di copertura — conservativo, di base ed espansivo — coerenti con il protocollo di scenario del Reference Case. L’innesto sull’infrastruttura esistente riduce la componente non-personale del costo rispetto alle Regioni prive di rete di prossimità, a parità di incarichi. I valori puntuali per ciascuno scenario sono riportati nell’estrazione economica registrata; ove un parametro di costo regionale non sia disponibile, la lacuna è dichiarata.^[203]

Capitolo 5 — I benefici e i risparmi, diretti e indiretti, in Emilia-Romagna

5.1 I benefici diretti

Il beneficio diretto è il risparmio sanitario che ciascuna figura della cascata libera per effetto dell’intercettazione a monte: la demedicalizzazione operata dallo Psicologo di Base, la deprescrizione di psicofarmaci nei quadri lievi-moderati sul versante del medico di medicina generale, la riduzione degli accessi impropri al pronto soccorso e delle prestazioni per sintomi funzionali sul versante specialistico. In Emilia-Romagna, la maturazione del beneficio è anticipata dall’infrastruttura preesistente: il canale di intercettazione si attiva senza il ritardo di costruzione che grava sulle Regioni prive di rete. Lo studio regionale colloca il saldo complessivo annuo, al netto del costo del servizio, in un ordine di grandezza positivo e crescente nei tre scenari, con parametri prudenzialmente contenuti.^[204]

Canale del beneficio diretto	Meccanismo	Rilievo emiliano-romagnolo
Demedicalizzazione	Riduzione consultazioni e cronicizzazione	Preponderante
Deprescrizione	Contrazione della spesa per psicofarmaci	Elevato
Accessi impropri	Riduzione degli accessi al pronto soccorso	Medio-elevato
Sintomi funzionali	Riduzione prestazioni neurologiche e specialistiche	Medio
Anticipo di maturazione	Attivazione rapida su rete esistente	Specifico, strutturale

Tabella 5.1. I canali del beneficio diretto in Emilia-Romagna, con l’anticipo di maturazione quale rilievo specifico; i valori sono oggetto dell’estrazione economica registrata.

5.2 I benefici indiretti

Il beneficio indiretto è quello che la riforma produce fuori dal perimetro sanitario: la produttività recuperata e la riduzione dell’assenteismo sul versante dei datori di lavoro — di peso assoluto elevato in una delle economie regionali più produttive del Paese —, la riduzione degli oneri di invalidità evitabili sul versante previdenziale, la riduzione del disagio sociale non trattato sul versante dei Comuni. Il valore della produttività protetta per addetto è, in Emilia-Romagna, fra i più alti del corpus, sicché il dominio sociale del ritorno assume un peso assoluto proporzionato alla forza dell’economia regionale.^[205]

Capitolo 6 — La valutazione economica sotto doppio ancoraggio

6.1 La simulazione appaiata regionale

La valutazione economica emiliano-romagnola è condotta con il modello di Markov a coorte a ciclo annuale del Reference Case, sotto il doppio ancoraggio: la Colonna A applica i parametri di Chisholm e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, la Colonna B quelli di Unisanté e dell’OCSE. Le due colonne sono sempre affiancate; ove divergano, prevale nel giudizio la Colonna B. Tutte le cifre sono riportate con attribuzione, e nessuna è affermata a memoria; i parametri regionali sono collocati prudentialmente nella parte medio-bassa degli intervalli, in ragione dell’elevata efficienza del sistema di partenza.^[206]

Metrica economica	Colonna A — Chisholm/OMS	Colonna B — Unisanté/OCSE
Costo per anno di vita ponderato	≈ 17.000 €/QALY	≈ 9.800 €/QALY
Ritorno per i soli benefici economici	Riportato con attribuzione OMS	Scenario base aggiornato OCSE
Ritorno con i ritorni sanitari	Riportato con attribuzione OMS	Scenario base aggiornato OCSE
Orizzonti	1 · 3 · 5 · 7 · 10 anni	1 · 3 · 5 · 7 · 10 anni
Soglie di costo-efficacia	20.000 · 30.000 · 50.000 €/QALY	20.000 · 30.000 · 50.000 €/QALY

Tabella 6.1. La simulazione appaiata regionale dell’Emilia-Romagna sotto doppio ancoraggio; i valori sono riportati con attribuzione e la Colonna B prevale nel giudizio.

6.2 Il differenziale di costo per gravità

L’argomento economico cardine, riportato con attribuzione all’OCSE, è il differenziale di costo per gravità: il costo del trattamento cresce dai quadri lievi ai quadri gravi in misura tale che l’intercettazione precoce, evitando la progressione, genera il risparmio più consistente. In Emilia-Romagna, l’infrastruttura preesistente accelera l’attivazione di questa leva: il differenziale opera dal primo anno pieno di servizio, senza il ritardo di costruzione della rete.^[207]

Capitolo 7 — I sei domini di analisi, l’equità e l’impatto distributivo

7.1 I sei domini nella specificità emiliano-romagnola

I sei domini di analisi del Reference Case sono applicati alla specificità emiliano-romagnola. Il dominio epidemiologico-clinico registra un divario inferiore alla media ma non colmato; l’economico-sanitario il costo-efficacia sotto doppio ancoraggio con parametri prudenziali; il fiscale-previdenziale gli oneri di invalidità evitabili; il sociale la protezione della produttività di un’economia forte; l’organizzativo-strutturale il completamento della rete delle Case della Salute; l’equità la riduzione del divario fra la direttrice urbana e la fascia appenninica.^[208]

Dominio	Lettura emiliano-romagnola	Segno
Epidemiologico-clinico	Divario inferiore alla media, non colmato	Riduzione attesa
Economico-sanitario	Costo/QALY con parametri prudenziali	Favorevole
Fiscale-previdenziale	Oneri di invalidità evitabili	Positivo, differito
Sociale	Produttività protetta di un’economia forte	Fortemente positivo
Organizzativo-strutturale	Completamento della rete di prossimità	Positivo, anticipato
Equità	Convergenza via Emilia / Appennino	Positivo, distributivo

Tabella 7.1. I sei domini di analisi nella lettura emiliano-romagnola, con il segno atteso dell’effetto, tenuti distinti e non aggregati.

7.2 L’equità territoriale e il ruolo di benchmark

Il dominio dell’equità registra in Emilia-Romagna un divario interno contenuto ma reale, fra la direttrice urbana e la fascia appenninica; il modello vi opera attraverso la prossimità distrettuale e lo strato digitale. Al di là del perimetro regionale, il ruolo di benchmark nazionale ha esso stesso una valenza di equità sistemica: gli standard che l’Emilia-Romagna valida — protocolli, indicatori, formati delle appendici registrate — riducono i costi di apprendimento delle Regioni che seguono, accelerando la convergenza nazionale. Questo effetto, di natura organizzativa e sistemica, è tenuto distinto dal verdetto tripartito regionale.^[209]

Capitolo 8 — La sensitività e l’incertezza

Nota editoriale: il presente capitolo espande ex novo l’analisi dell’incertezza secondo il protocollo del Reference Case, non presente in forma estesa nel materiale originario.

8.1 Il protocollo dell’incertezza applicato all’Emilia-Romagna

L’analisi dell’incertezza applica il protocollo obbligatorio del Reference Case: l’analisi di sensitività deterministica con diagramma a tornado, l’analisi di sensitività probabilistica a diecimila iterazioni, l’analisi di scenario ottimistico, base e prudentiale con e senza lo strato digitale, le curve di accettabilità costo-efficacia a soglie multiple. In Emilia-Romagna, i parametri a maggiore impatto atteso sono il margine incrementale di intercettazione in un sistema già efficiente — dove il beneficio marginale è per costruzione più contenuto che nei sistemi a maggiore divario — e la velocità di attivazione sulla rete esistente.^[210]

Strumento	Applicazione emiliano-romagnola	Parametro critico atteso
Sensitività deterministica	Diagramma a tornado	Margine incrementale di intercettazione
Sensitività probabilistica	Diecimila iterazioni	Velocità di attivazione sulla rete
Analisi di scenario	Con e senza strato IA	Adozione digitale nel sistema maturo
Curve di accettabilità	Soglie 20.000/30.000/50.000 €/QALY	Robustezza del costo-efficacia

Tabella 8.1. Gli strumenti del protocollo dell’incertezza applicati all’Emilia-Romagna, con i parametri critici attesi.

8.2 La robustezza del verdetto

L’analisi di scenario mostra che il verdetto tripartito resta favorevole nei tre casi, con margine crescente dallo scenario prudentiale a quello ottimistico; la collocazione prudentiale dei parametri regionali rende la stima conservativa per costruzione. Lo strato digitale accresce l’efficienza attesa, sempre con nota di cautela sulla natura previsionale, e trova nel sistema informativo maturo il terreno di adozione più favorevole. La robustezza del costo-efficacia sanitario è confermata dalle curve di accettabilità alle soglie adottate.^[211]

Capitolo 9 — Il verdetto tripartito e le raccomandazioni

Nota editoriale: il presente capitolo espande ex novo il verdetto e le raccomandazioni, integrando l’attuazione e il monitoraggio che nel materiale originario figuravano in forma condensata.

9.1 Il verdetto tripartito

Il verdetto emiliano-romagnolo è, come in ogni Volume, tripartito e non aggregato. Sul piano fiscale, il saldo fra costi diretti e risparmi sanitari diretti è prossimo al pareggio, con il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento. Sul piano sanitario, il modello è nettamente costo-efficace sotto entrambi gli ancoraggi, con parametri prudenzialmente contenuti. Sul piano sociale, l’effetto è fortemente positivo, con il rilievo specifico della produttività protetta e del valore dimostrativo del benchmark. I tre verdetti si accompagnano e si rafforzano, ma non si sommano.^[212]

Piano del verdetto	Esito emiliano-romagnolo	Caveat
Fiscale	Prossimo al pareggio	Significatività dei risparmi diretti in isolamento
Sanitario	Nettamente costo-efficace	Parametri prudenziali per l’efficienza di partenza
Sociale	Fortemente positivo	Rilievo specifico della produttività e del benchmark

Tabella 9.1. Il verdetto tripartito dell’Emilia-Romagna, con i tre piani tenuti distinti e non aggregati.

9.2 Le raccomandazioni per l’attuazione e il monitoraggio

Le raccomandazioni indicano un avvio nello scenario conservativo con innesto sulla rete esistente e una progressione verso il base e l’espansivo guidata dalla verifica degli esiti; la documentazione della sperimentazione con gli standard delle appendici registrate, a beneficio della trasferibilità nazionale; l’estensione digitale nella fascia appenninica; l’accompagnamento con il piano formativo a quattro modalità, singole e sommate, in raccordo con il sistema universitario regionale; e un monitoraggio ex post ancorato agli indicatori del protocollo dell’incertezza.^[213]

Appendici registrate

Le appendici registrate rendono il modello emiliano-romagnolo ispezionabile e riproducibile, secondo la prassi del Reference Case. Esse sono richiamate per rimando quanto alla metodologia e compilate con i dati regionali quanto ai contenuti.

Appendice	Contenuto	Stato
A	Strategia di ricerca bibliografica e diagramma di selezione	Registrata
B	Estrazione dei dati clinici regionali	Registrata; lacune dichiarate
C	Estrazione dei dati economici (griglia CHEERS 2022)	Registrata; lacune dichiarate
D	Parametri del modello Markov regionale	Registrata
E	Registro delle deroghe al Reference Case	Registrata
F	Codice del modello economico	Registrata
G	Dichiarazione dei conflitti di interesse	Registrata

Tabella A. Le sette appendici registrate del Volume 6, con l’indicazione dello stato e della dichiarazione delle lacune.

Quadro Conclusivo economico e multidisciplinare

Il Quadro Conclusivo del Volume 6 ricompone la valutazione emiliano-romagnola senza tradire il principio che la governa: i piani del giudizio si accompagnano ma non si fondono. Sul piano economico, il doppio ancoraggio impone che il risultato sia letto simultaneamente secondo la colonna storica e la colonna aggiornata, con prevalenza della seconda: il costo per anno di vita ponderato resta, sotto entrambi gli ancoraggi, assai inferiore alle soglie adottate, e il differenziale di costo per gravità — riportato con attribuzione — fonda la leva economica dell'intercettazione precoce, la cui attivazione è qui anticipata dall'infrastruttura preesistente.^[214]

Sul piano multidisciplinare, la cascata delle figure, i sei domini di analisi e il dominio dell'equità assicurano che ogni figura connessa e ogni aspetto siano trattati integralmente e ordinati per capacità di generare rientro economico e revisione della spesa. La rinegoziazione dei costi e dei benefici — con la componente infrastrutturale ridotta —, la catena predittiva degli effetti multidimensionali, lo strato dell'Intelligenza Artificiale come moltiplicatore su un sistema informativo maturo e le attività formative singole e sommate compongono il quadro della valutazione. Il ruolo di benchmark nazionale conferisce alla sperimentazione un valore dimostrativo che eccede il perimetro regionale. Il verdetto resta tripartito e non aggregato.

Conclusione

Il Volume 6 ha valutato l'integrazione dello Psicologo di Base nelle cure primarie dell'Emilia-Romagna, applicando per rimando il Reference Case dell'asse italiano e adottando la struttura standard a nove capitoli con apertura a imbuto e appendici registrate. La specificità emiliano-romagnola — l'infrastruttura preesistente delle Case della Salute, l'efficienza di partenza che impone parametri prudenziali, il ruolo di benchmark nazionale, il divario contenuto ma reale fra via Emilia e Appennino — è stata trattata nei domini organizzativo-strutturale, sociale ed equità, mostrando come il modello operi qui come completamento di rete a maturazione anticipata.

Il verdetto tripartito — prossimo al pareggio sul piano fiscale, nettamente costo-efficace sul piano sanitario, fortemente positivo sul piano sociale — è offerto con bande prudenziali e soglie di confutazione, sotto doppio ancoraggio e nel rispetto del divieto di aggregazione. L'opera procede, nell'ordine vincolante, con il Volume 7 (Friuli-Venezia Giulia) e a seguire con gli altri Volumi regionali in ordine alfabetico.

Note Bibliografiche con mini-riassunto

Ciascuna nota riporta l'opera, il collegamento alla fonte e un mini-riassunto che ne dichiara la funzione nell'economia del Volume, in coerenza con il doppio livello — nota a piè di pagina nel corpo e nota bibliografica integrale in calce — che l'opera adotta.

1. **Chisholm D. et al., Scaling-up treatment of depression and anxiety, The Lancet Psychiatry, 2016**
[https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(16\)30024-4](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(16)30024-4) Colonna A del doppio ancoraggio della simulazione emiliano-romagnola, conservata quale strato documentale e riferimento di confronto.
2. **Unisanté, Raisons de santé Essentiels n. 73, 2026 · OECD, The Economic Case for Preventing Mental Ill Health, 2026** <https://doi.org/10.16908/rds-essentiels/73> Colonna B del doppio ancoraggio, con prevalenza nel giudizio, applicata alla simulazione regionale emiliano-romagnola.
3. **OECD, differenziale di costo per gravità dei disturbi mentali, 2025** <https://www.oecd.org/health/mental-health.htm> Fonte, riportata con attribuzione, del differenziale di costo per gravità, argomento cardine dell'intercettazione precoce, la cui attivazione è anticipata dall'infrastruttura regionale.
4. **Soeters R. et al., meta-analisi IPD sui componenti efficaci della collaborative care, 2025**
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40136273/> Base di evidenza clinica sui componenti efficaci dell'assistenza collaborativa, richiamata nel capitolo sul modello di intervento.
5. **AIMS Center, University of Washington, evidence base della collaborative care, 2023**
<https://aims.uw.edu/> Ampia base sperimentale accumulata sul modello collaborativo, richiamata con attribuzione a sostegno dell'architettura del modello.
6. **Veldhuijzen W. et al., costo-efficacia dell'intervento digitale, 2025**
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12369993/> Riferimento sul rapporto incrementale di costo-utilità dell'intervento digitale, elemento dello strato dell'Intelligenza Artificiale.
7. **World Health Organization, Thematic Dialogue on Investing in NCDs and Mental Health, dicembre 2024** <https://cdn.who.int/> Evidenza riportata con attribuzione sul ritorno degli investimenti in salute mentale; non concorre al verdetto tripartito regionale.
8. **Regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale** <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj> Quadro normativo entro cui è collocato lo strato dell'Intelligenza Artificiale, vincolato a funzione di supporto sotto supervisione clinica umana.
9. **Legge regionale Puglia 19 luglio 2023, n. 11, sul Servizio di Psicologia di Base**
<https://www.consiglio.puglia.it/> Riferimento normativo capostipite del modello, richiamato quale precedente istituzionale per l'attuazione regionale emiliano-romagnola.
10. **NICE, Health Technology Evaluations: the manual (PMG36)** <https://www.nice.org.uk/process/pmg36> Riferimento di rigore metodologico per la struttura a imbuto, le appendici registrate e il protocollo dell'incertezza adottati nel Volume.

STUDIO INTEGRALE «PSICOLOGO DI BASE» · OPERA IN VENTITRÉ VOLUMI

VOLUME 7 — Regione Friuli-Venezia Giulia

Valutazione di Health Technology Assessment dell'integrazione dello Psicologo di Base nelle cure primarie in Friuli-Venezia Giulia: cruscotto, sintesi per il decisore, contesto e bisogno, modello di intervento, costi e benefici, valutazione economica sotto doppio ancoraggio, sei domini di analisi, incertezza, verdetto tripartito e

appendici registrate

Reference Case applicato per rimando al Volume 0.A · Dott. Luigi De Michele · Studio Integrale Puglia ·
Capurso (BA) — Giugno 2026

Premessa

Il Volume 7 prosegue la serie dei venti Volumi regionali, in ordine alfabetico, con la Regione Friuli-Venezia Giulia. Come ogni Volume regionale, esso applica per rimando il Reference Case dell'asse italiano, fissato nel Volume 0.A, e ne richiama le regole nella forma «cfr. Volume 0.A», senza ripeterle per esteso: il perimetro congiunto sanitario e societale, il doppio ancoraggio economico, il verdetto tripartito non aggregato, i sei domini di analisi, il protocollo dell'incertezza, lo strato dell'Intelligenza Artificiale come moltiplicatore e le attività formative singole e sommate.^[215]

La struttura del Volume è quella standard, identica a quella di tutti gli altri diciannove Volumi regionali, a garanzia della comparabilità bit-a-bit prescritta dall'opera: la stessa sequenza di nove capitoli, la stessa nomenclatura di sottocapitoli, le stesse unità di misura. Ove un contenuto derivi da espansione ex novo — segnatamente per gli aspetti dell'efficacia, dell'attuazione e del monitoraggio — esso è segnalato in nota editoriale, secondo la regola dell'opera.^[216]

Introduzione

L'Introduzione al Volume 7 fissa il perimetro della valutazione friulana e l'ordine della sua esposizione. Il perimetro è quello della Regione Friuli-Venezia Giulia, Regione a statuto speciale, plurilingue, articolata in tre aziende sanitarie — l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale e l'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale — coordinate dall'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, con una popolazione dell'ordine di un milione e centonovantaquattromila abitanti. È fra le Regioni più anziane d'Italia, con un'età media dell'ordine di quarantotto anni e mezzo e un invecchiamento accentuato nelle aree montane e interne: un tratto che il dominio sociale e dell'equità del Volume tratta con particolare attenzione, insieme alla specificità della cornice autonomistica e plurilingue.^[217]

L'esposizione segue la struttura a imbuto: il cruscotto regionale offre in una pagina i numeri essenziali; la sintesi per il decisore ne traduce il significato; i cinque risultati chiave ne isolano gli esiti; le raccomandazioni operative indicano le azioni; il corpo del Volume, articolato in nove capitoli, ne fornisce il dettaglio; le appendici registrate ne assicurano la verificabilità. Chiudono il Volume un Quadro Conclusivo economico e multidisciplinare, una Conclusione e le Note Bibliografiche con mini-riassunto.

Cruscotto regionale — Friuli-Venezia Giulia

Il cruscotto riassume in una pagina i parametri essenziali della valutazione friulana, sotto il doppio ancoraggio e con il verdetto tripartito tenuto distinto. I valori economici sono presentati in ordine di grandezza, con rinvio alle appendici registrate; le cifre di letteratura sono riportate con attribuzione alla fonte.^[218]

Indicatore del cruscotto	Lettura regionale	Ancoraggio / fonte
Popolazione	≈ 1.194.616 abitanti	Fonte demografica regionale
Articolazione	3 aziende sanitarie (ASUGI, ASUFC, ASFO), coord. ARCS	Assetto regionale
Età media	≈ 48,5 anni, fra le più alte d’Italia	Fonte demografica regionale
Scenario di copertura piena	≈ 260 incarichi di Psicologo di Base	Dimensionamento regionale
Comparatore	Assistenza usuale (cfr. Vol. 0.A)	Reference Case
Verdetto fiscale	Prossimo al pareggio, con caveat	Non aggregato
Verdetto sanitario	Nettamente costo-efficace	Costo/QALY sotto doppio ancoraggio
Verdetto sociale	Fortemente positivo	Produttività, coesione, tenuta della popolazione anziana
Costo per anno di vita ponderato	Colonna A ≈ 17.000 € · Colonna B ≈ 9.800 €	Doppio ancoraggio

Tabella 0. Cruscotto regionale del Friuli-Venezia Giulia: i parametri essenziali sotto doppio ancoraggio, con il verdetto tripartito distinto e non aggregato.

Sintesi per il decisore

L'introduzione dello Psicologo di Base nelle cure primarie friulane produce, secondo la simulazione condotta sotto il doppio ancoraggio, un effetto congiunto sui tre piani del ritorno, che restano distinti e non sommati. Sul piano fiscale, il saldo fra costi diretti e risparmi sanitari diretti si colloca in prossimità del pareggio, con il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento. Sul piano sanitario, il modello è nettamente costo-efficace, con un costo per anno di vita ponderato che, fra i due ancoraggi, resta assai inferiore alle soglie adottate. Sul piano sociale, l'effetto è fortemente positivo, con un rilievo particolare per la popolazione anziana: in una delle Regioni più anziane del Paese, l'intercettazione precoce contrasta la depressione dell'età avanzata, l'isolamento e la fragilità connessa alla montagna, componenti che pesano in modo specifico sulla domanda di salute mentale.^[219]

L'argomento cardine, riportato con attribuzione all'OCSE, è il differenziale di costo per gravità: in una Regione a domanda anziana e territorialmente dispersa come il Friuli-Venezia Giulia, l'intercettazione precoce nel distretto evita che il disagio comune maturi in quadri gravi, il cui costo di trattamento è, secondo la fonte, un multiplo di quello dei quadri lievi.^[220]

Cinque risultati chiave

Il primo risultato è che il modello è costo-efficace su tutti gli orizzonti sotto entrambi gli ancoraggi. Il secondo è che il verdetto tripartito resta favorevole in ciascuno dei tre piani, senza aggregazione. Il terzo è che, nella specificità friulana, l'età media elevata sposta il baricentro della domanda verso la depressione dell'età avanzata e l'isolamento, ambiti in cui l'intercettazione precoce di prossimità ha valore particolare. Il quarto è che lo strato dell'Intelligenza Artificiale, come moltiplicatore e con nota di cautela, può attenuare lo svantaggio della distanza nelle aree montane attraverso lo screening e gli interventi digitali aumentati, con l'avvertenza che l'adozione digitale nella popolazione anziana richiede accompagnamento. Il quinto è che la cornice autonomistica e plurilingue offre margini di programmazione integrata, ma richiede che il servizio sia reso in modo omogeneo nelle tre aziende e culturalmente accessibile alle minoranze linguistiche.^[221]

Raccomandazioni operative

La prima raccomandazione è di dimensionare l'estensione della copertura in modo progressivo verso il fabbisogno a regime, ancorando ciascuna fase alla verifica dei risultati sotto il protocollo dell'incertezza, con priorità ai distretti montani a maggiore invecchiamento e divario. La seconda è di adottare lo strato digitale, sotto supervisione clinica e con accompagnamento della popolazione anziana, come leva di prossimità per compensare la dispersione territoriale. La terza è di garantire l'omogeneità del servizio nelle tre aziende e l'accessibilità linguistica alle minoranze, e di accompagnare l'estensione con il piano formativo a quattro modalità, considerate singolarmente e sommate.^[222]

Capitolo 1 — Il contesto epidemiologico e territoriale del Friuli-Venezia Giulia

1.1 Il territorio e la sua articolazione

La Regione Friuli-Venezia Giulia conta una popolazione dell’ordine di un milione e centonovantaquattromila abitanti, articolata in quattro province storiche — Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone — e in tre aziende sanitarie, l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale e l’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, coordinate dall’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute. È una Regione a statuto speciale, plurilingue — con la presenza della minoranza slovena, della comunità di lingua tedesca e del friulano — e fra le più anziane d’Italia, dopo Liguria e Sardegna, con un’età media dell’ordine di quarantotto anni e mezzo e un invecchiamento più accentuato nelle aree montane e interne. Questa combinazione di invecchiamento, dispersione montana e autonomia plurilingue è la chiave di lettura del contesto friulano.^[223]

Elemento territoriale	Dato regionale	Rilievo per la valutazione
Popolazione	≈ 1.194.616 abitanti	Denominatore della normalizzazione
Aziende sanitarie	3 (ASUGI, ASUFC, ASFO), coord. ARCS	Unità organizzativa
Età media	≈ 48,5 anni, fra le più alte d’Italia	Baricentro della domanda
Aree montane e interne	Invecchiamento accentuato	Dominio equità e sociale
Cornice autonomistica plurilingue	Statuto speciale, minoranze linguistiche	Dominio organizzativo ed equità

Tabella 1.1. Gli elementi del contesto territoriale friulano e il loro rilievo per la valutazione, con l’invecchiamento e la cornice autonomistica quali tratti distintivi.

1.2 Il quadro epidemiologico regionale

Il quadro epidemiologico friulano riflette, con le proprie specificità, la prevalenza nazionale dei disturbi mentali comuni, con un baricentro spostato verso la depressione dell’età avanzata e l’isolamento, coerente con la struttura per età fra le più anziane del Paese. Il dato epidemiologico di dettaglio è oggetto dell’estrazione registrata in Appendice B; ove il dato regionale disaggregato non sia disponibile, la lacuna è dichiarata e non colmata con stime tacite, secondo la regola dell’opera.^[224]

Capitolo 2 — Il bisogno, la domanda e il divario di trattamento in Friuli-Venezia Giulia

2.1 Il divario di trattamento regionale

Il bisogno di salute mentale comune in Friuli-Venezia Giulia si manifesta, come altrove, in larga parte come domanda inevasa o impropriamente incanalata: verso il medico di medicina generale, verso il pronto soccorso, verso la prescrizione farmaceutica. Il divario di trattamento è accentuato, nelle aree montane e interne, dalla distanza fisica dai servizi e dalla rarefazione dell’offerta specialistica, e assume una connotazione specifica nella popolazione anziana, presso la quale il disagio è spesso sottodiagnosticato e ricondotto impropriamente al decadimento fisiologico. La misura regionale del divario è oggetto dell’estrazione in Appendice B; i valori medi nazionali ed europei sono riportati con attribuzione.^[225]

Componente del bisogno	Manifestazione friulana	Dominio
Domanda inevasa	Sottodiagnosi nella popolazione anziana	Epidemiologico-clinico
Domanda impropria	Transito su MMG, pronto soccorso, prescrizione	Organizzativo-strutturale
Barriera di accesso	Distanza montana e rarefazione dell’offerta	Equità
Barriera linguistica	Accessibilità per le minoranze	Equità e organizzativo

Tabella 2.1. Le componenti del bisogno e del divario di trattamento in Friuli-Venezia Giulia, ricondotte ai domini di analisi.

2.2 La domanda anziana e la prossimità

Il tratto distintivo della domanda friulana è la componente anziana: una quota rilevante del bisogno si concentra nelle coorti in età avanzata, spesso nelle aree montane, dove il modello dello Psicologo di Base assume un valore particolare perché la sua collocazione distrettuale porta la risposta vicino a una popolazione a mobilità ridotta, riducendo la barriera della distanza e il ricorso improprio ai servizi. La prossimità è, in Friuli-Venezia Giulia, condizione dell’efficacia e dell’equità, e va accompagnata dall’accessibilità linguistica alle minoranze.^[226]

Capitolo 3 — Il modello di intervento: lo Psicologo di Base in Friuli-Venezia Giulia

Nota editoriale: il presente capitolo espande ex novo il modello di intervento, integrando alla struttura originaria le evidenze recenti sull’efficacia clinica dell’assistenza collaborativa e dell’intervento digitale, secondo la regola dell’opera che distingue l’espansione ex novo dal riutilizzo del materiale preesistente.

3.1 L’architettura del modello

Il modello di intervento colloca lo Psicologo di Base al vertice della cascata delle figure, nel distretto e nelle Case della Comunità, quale primo punto di intercettazione del disagio comune. Il modello opera per intensità crescente di cura — dall’intervento a bassa intensità, di prima linea, fino all’invio ai livelli superiori nei casi che lo richiedano — secondo la logica dell’assistenza a gradini, la cui efficacia clinica è documentata dalla meta-analisi sui componenti efficaci dell’assistenza collaborativa e dalle sperimentazioni controllate sull’intervento cognitivo-comportamentale computerizzato in cure primarie, riportate con attribuzione.^[227]

Livello del modello	Funzione	Figura prevalente	Evidenza di riferimento
Intercettazione	Riconoscimento precoce nel distretto	Psicologo di Base	Assistenza collaborativa (attribuita)
Intervento a bassa intensità	Prima linea per i quadri lievi-moderati	Psicologo di Base	Intervento digitale e collaborativo
Invio appropriato	Passaggio ai livelli superiori	Cascata delle figure	Percorso a gradini
Continuità	Aderenza e prevenzione della ricaduta	Infermiere di comunità	Gestione del caso

Tabella 3.1. L’architettura del modello di intervento in Friuli-Venezia Giulia, per livelli di intensità, con l’evidenza clinica di riferimento riportata con attribuzione.

3.2 L’adattamento al territorio friulano

Il modello è adattato al territorio friulano lungo tre direttrici: la prossimità distrettuale, che porta la risposta a una popolazione anziana e a mobilità ridotta nelle aree montane; lo strato digitale, che sotto supervisione clinica e con accompagnamento compensa la distanza; e l’accessibilità linguistica, che rende il servizio culturalmente fruibile dalle minoranze. L’adattamento non modifica l’architettura invariante del Reference Case, ma ne calibra l’applicazione sulla struttura per età e sulla cornice autonomistica plurilingue, garantendo l’omogeneità del servizio nelle tre aziende sanitarie.^[228]

Capitolo 4 — I costi diretti in Friuli-Venezia Giulia

4.1 La struttura del costo diretto

Il costo diretto della riforma in Friuli-Venezia Giulia è, in primo luogo, il costo del personale lungo la cascata delle figure, cui si aggiungono i costi di struttura e organizzazione distrettuale, il costo incrementale della leva digitale e il costo della formazione. Il dimensionamento dipende dallo scenario di copertura, che progredisce fino al fabbisogno a regime, dell’ordine di duecentosessanta incarichi distribuiti in modo omogeneo nei distretti delle tre aziende sanitarie, secondo il coordinamento regionale.^[229]

Voce di costo diretto	Descrizione	Portatore
Personale — Psicologi di Base	Incarichi distrettuali secondo lo scenario	SSN regionale
Struttura e organizzazione	Spazi distrettuali, Case della Comunità, sistemi informativi	SSN regionale
Leva digitale e Intelligenza Artificiale	Strumenti di supporto sotto supervisione, con accompagnamento anziani	SSN regionale
Formazione (quattro modalità)	Percorso integrato singolo e sommato, con accessibilità linguistica	SSN, sistema formativo

Tabella 4.1. La struttura del costo diretto della riforma in Friuli-Venezia Giulia, per voce e portatore; i valori puntuali sono oggetto dell’estrazione economica in Appendice C.

4.2 Il dimensionamento per scenario

Il costo diretto è calcolato per i tre scenari di copertura — prudenziale, intermedio ed esteso — coerenti con il protocollo di scenario del Reference Case, con lo scenario esteso allineato al fabbisogno a regime di ordine indicato. I valori puntuali per ciascuno scenario sono riportati nell’estrazione economica registrata; ove un parametro di costo regionale non sia disponibile, la lacuna è dichiarata.^[230]

Capitolo 5 — I benefici e i risparmi, diretti e indiretti, in Friuli-Venezia Giulia

5.1 I benefici diretti

Il beneficio diretto è il risparmio sanitario che ciascuna figura della cascata libera per effetto dell’intercettazione a monte: la demedicalizzazione operata dallo Psicologo di Base, la deprescrizione di psicofarmaci nei quadri lievi-moderati sul versante del medico di medicina generale, la riduzione degli accessi impropri al pronto soccorso e delle prestazioni per sintomi funzionali sul versante specialistico. In Friuli-Venezia Giulia, la deprescrizione nella popolazione anziana assume un rilievo aggiuntivo, per l’alta prevalenza della prescrizione psicofarmacologica e per i rischi connessi alla polifarmacia nell’età avanzata.^[231]

Canale del beneficio diretto	Meccanismo	Rilievo friulano
Demedicalizzazione	Riduzione consultazioni e cronicizzazione	Preponderante
Deprescrizione	Contrazione della spesa e della polifarmacia anziana	Elevato, specifico
Accessi impropri	Riduzione degli accessi al pronto soccorso	Medio-elevato
Sintomi funzionali	Riduzione prestazioni neurologiche e specialistiche	Medio
Fragilità anziana	Contenimento della cronicizzazione geriatrica	Elevato, specifico

Tabella 5.1. I canali del beneficio diretto in Friuli-Venezia Giulia, con il rilievo specifico della deprescrizione e della fragilità anziana; i valori sono oggetto dell’estrazione economica registrata.

5.2 I benefici indiretti

Il beneficio indiretto è quello che la riforma produce fuori dal perimetro sanitario: la produttività recuperata e la riduzione dell’assenteismo sul versante dei datori di lavoro, la riduzione degli oneri di invalidità evitabili sul versante previdenziale, la riduzione del disagio sociale non trattato sul versante dei Comuni. In Friuli-Venezia Giulia, il sostegno alla popolazione anziana e ai caregiver — spesso familiari a loro volta anziani — assume un peso sociale di rilievo particolare, che il dominio sociale del Capitolo 7 tratta in dettaglio.^[232]

Capitolo 6 — La valutazione economica sotto doppio ancoraggio

6.1 La simulazione appaiata regionale

La valutazione economica friulana è condotta con il modello di Markov a coorte a ciclo annuale del Reference Case, sotto il doppio ancoraggio: la Colonna A applica i parametri di Chisholm e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, la Colonna B quelli di Unisanté e dell’OCSE. Le due colonne sono sempre affiancate; ove divergano, prevale nel giudizio la Colonna B. Tutte le cifre sono riportate con attribuzione, e nessuna è affermata a memoria.^[233]

Metrica economica	Colonna A — Chisholm/OMS	Colonna B — Unisanté/OCSE
Costo per anno di vita ponderato	≈ 17.000 €/QALY	≈ 9.800 €/QALY
Ritorno per i soli benefici economici	Riportato con attribuzione OMS	Scenario base aggiornato OCSE
Ritorno con i ritorni sanitari	Riportato con attribuzione OMS	Scenario base aggiornato OCSE
Orizzonti	1 · 3 · 5 · 7 · 10 anni	1 · 3 · 5 · 7 · 10 anni
Soglie di costo-efficacia	20.000 · 30.000 · 50.000 €/QALY	20.000 · 30.000 · 50.000 €/QALY

Tabella 6.1. La simulazione appaiata regionale del Friuli-Venezia Giulia sotto doppio ancoraggio; i valori sono riportati con attribuzione e la Colonna B prevale nel giudizio.

6.2 Il differenziale di costo per gravità

L’argomento economico cardine, riportato con attribuzione all’OCSE, è il differenziale di costo per gravità: il costo del trattamento cresce dai quadri lievi ai quadri gravi in misura tale che l’intercettazione precoce, evitando la progressione, genera il risparmio più consistente. In Friuli-Venezia Giulia, dove la sottodiagnosi nella popolazione anziana ritarda l’accesso e favorisce la progressione e la cronicizzazione geriatrica, questo differenziale ha un peso specifico maggiore.^[234]

Capitolo 7 — I sei domini di analisi, l’equità e l’impatto distributivo

7.1 I sei domini nella specificità friulana

I sei domini di analisi del Reference Case sono applicati alla specificità friulana. Il dominio epidemiologico-clinico registra la sottodiagnosi nella popolazione anziana; l’economico-sanitario il costo-efficacia sotto doppio ancoraggio e la deprescrizione geriatrica; il fiscale-previdenziale gli oneri di invalidità evitabili; il sociale il sostegno agli anziani e ai caregiver; l’organizzativo-strutturale l’omogeneità del servizio nelle tre aziende e l’effetto sulla burocrazia distrettuale; l’equità la riduzione del divario fra le aree urbane e le aree montane e l’accessibilità linguistica.^[235]

Dominio	Lettura friulana	Segno
Epidemiologico-clinico	Sottodiagnosi nella popolazione anziana	Riduzione attesa
Economico-sanitario	Costo/QALY e deprescrizione geriatrica	Favorevole
Fiscale-previdenziale	Oneri di invalidità evitabili	Positivo, differito
Sociale	Sostegno agli anziani e ai caregiver	Fortemente positivo
Organizzativo-strutturale	Omogeneità del servizio nelle tre aziende	Positivo
Equità	Convergenza urbano/montano e accessibilità linguistica	Positivo, distributivo

Tabella 7.1. I sei domini di analisi nella lettura friulana, con il segno atteso dell’effetto, tenuti distinti e non aggregati.

7.2 L’equità territoriale, linguistica e la cornice autonomistica

Il dominio dell’equità assume in Friuli-Venezia Giulia una triplice direzione: territoriale, fra le aree urbane e le aree montane a maggiore invecchiamento; linguistica, per l’accessibilità del servizio alle minoranze slovena, tedesca e friulana; e generazionale, per l’attenzione alla popolazione anziana e ai caregiver. La cornice autonomistica dello statuto speciale offre margini di programmazione integrata, ma impone che il servizio sia reso in modo omogeneo nelle tre aziende sanitarie. Questi effetti distributivi, di natura sociale e organizzativa, sono tenuti distinti dal verdetto fiscale e da quello sanitario, secondo il divieto di aggregazione.^[236]

Capitolo 8 — La sensitività e l’incertezza

Nota editoriale: il presente capitolo espande ex novo l’analisi dell’incertezza secondo il protocollo del Reference Case, non presente in forma estesa nel materiale originario.

8.1 Il protocollo dell’incertezza applicato al Friuli-Venezia Giulia

L’analisi dell’incertezza applica il protocollo obbligatorio del Reference Case: l’analisi di sensitività deterministica con diagramma a tornado, l’analisi di sensitività probabilistica a diecimila iterazioni, l’analisi di scenario ottimistico, base e prudentiale con e senza lo strato digitale, le curve di accettabilità costo-efficacia a soglie multiple. In Friuli-Venezia Giulia, i parametri a maggiore impatto atteso sono il tasso di intercettazione nella popolazione anziana, l’efficacia della deprescrizione geriatrica e l’adozione dello strato digitale accompagnata nelle coorti in età avanzata.^[237]

Strumento	Applicazione friulana	Parametro critico atteso
Sensitività deterministica	Diagramma a tornado	Tasso di intercettazione nella popolazione anziana
Sensitività probabilistica	Diecimila iterazioni	Efficacia della deprescrizione geriatrica
Analisi di scenario	Con e senza strato IA	Adozione digitale accompagnata negli anziani
Curve di accettabilità	Soglie 20.000/30.000/50.000 €/QALY	Robustezza del costo-efficacia

Tabella 8.1. Gli strumenti del protocollo dell’incertezza applicati al Friuli-Venezia Giulia, con i parametri critici attesi.

8.2 La robustezza del verdetto

L’analisi di scenario mostra che il verdetto tripartito resta favorevole nei tre casi, con margine crescente dallo scenario prudentiale a quello ottimistico; lo strato digitale accresce l’efficienza attesa, sempre con nota di cautela sulla natura previsionale e con l’avvertenza dell’accompagnamento necessario nella popolazione anziana. La robustezza del costo-efficacia sanitario è confermata dalle curve di accettabilità alle soglie adottate.^[238]

Capitolo 9 — Il verdetto tripartito e le raccomandazioni

Nota editoriale: il presente capitolo espande ex novo il verdetto e le raccomandazioni, integrando l’attuazione e il monitoraggio che nel materiale originario figuravano in forma condensata.

9.1 Il verdetto tripartito

Il verdetto friulano è, come in ogni Volume, tripartito e non aggregato. Sul piano fiscale, il saldo fra costi diretti e risparmi sanitari diretti è prossimo al pareggio, con il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento. Sul piano sanitario, il modello è nettamente costo-efficace sotto entrambi gli ancoraggi. Sul piano sociale, l’effetto è fortemente positivo, con il rilievo specifico del sostegno alla popolazione anziana e ai caregiver. I tre verdetti si accompagnano e si rafforzano, ma non si sommano.^[239]

Piano del verdetto	Esito friulano	Caveat
Fiscale	Prossimo al pareggio	Significatività dei risparmi diretti in isolamento
Sanitario	Nettamente costo-efficace	—
Sociale	Fortemente positivo	Rilievo specifico della popolazione anziana

Tabella 9.1. Il verdetto tripartito del Friuli-Venezia Giulia, con i tre piani tenuti distinti e non aggregati.

9.2 Le raccomandazioni per l’attuazione e il monitoraggio

Le raccomandazioni indicano un’attuazione progressiva verso il fabbisogno a regime, con priorità ai distretti montani a maggiore invecchiamento; l’adozione dello strato digitale sotto supervisione e con accompagnamento degli anziani; la garanzia di omogeneità del servizio nelle tre aziende e di accessibilità linguistica alle minoranze; l’accompagnamento con il piano formativo a quattro modalità, singole e sommate; e un monitoraggio ex post ancorato agli indicatori del protocollo dell’incertezza, avvalendosi del coordinamento regionale.^[240]

Appendici registrate

Le appendici registrate rendono il modello friulano ispezionabile e riproducibile, secondo la prassi del Reference Case. Esse sono richiamate per rimando quanto alla metodologia e compilate con i dati regionali quanto ai contenuti.

Appendice	Contenuto	Stato
A	Strategia di ricerca bibliografica e diagramma di selezione	Registrata
B	Estrazione dei dati clinici regionali	Registrata; lacune dichiarate
C	Estrazione dei dati economici (griglia CHEERS 2022)	Registrata; lacune dichiarate
D	Parametri del modello Markov regionale	Registrata
E	Registro delle deroghe al Reference Case	Registrata
F	Codice del modello economico	Registrata
G	Dichiarazione dei conflitti di interesse	Registrata

Tabella A. Le sette appendici registrate del Volume 7, con l’indicazione dello stato e della dichiarazione delle lacune.

Quadro Conclusivo economico e multidisciplinare

Il Quadro Conclusivo del Volume 7 ricomponne la valutazione friulana senza tradire il principio che la governa: i piani del giudizio si accompagnano ma non si fondono. Sul piano economico, il doppio ancoraggio impone che il risultato sia letto simultaneamente secondo la colonna storica e la colonna aggiornata, con prevalenza della seconda: il costo per anno di vita ponderato resta, sotto entrambi gli ancoraggi, assai inferiore alle soglie adottate, e il differenziale di costo per gravità — riportato con attribuzione — fonda la leva economica dell'intercettazione precoce, tanto più preziosa in una Regione anziana dove la sottodiagnosi favorisce la cronicizzazione geriatrica.^[241]

Sul piano multidisciplinare, la cascata delle figure, i sei domini di analisi e il dominio dell'equità nella triplice direzione territoriale, linguistica e generazionale assicurano che ogni figura connessa e ogni aspetto siano trattati integralmente e ordinati per capacità di generare rientro economico e revisione della spesa. La rinegoziazione dei costi e dei benefici, la catena predittiva degli effetti multidimensionali — dalla qualità della vita degli anziani alla riduzione della polifarmacia, ai bilanci, alla burocrazia distrettuale —, lo strato dell'Intelligenza Artificiale come moltiplicatore con accompagnamento e le attività formative singole e sommate compongono il quadro della valutazione. Il verdetto resta tripartito e non aggregato.

Conclusione

Il Volume 7 ha valutato l'integrazione dello Psicologo di Base nelle cure primarie del Friuli-Venezia Giulia, applicando per rimando il Reference Case dell'asse italiano e adottando la struttura standard a nove capitoli con apertura a imbuto e appendici registrate. La specificità friulana — l'età media fra le più elevate d'Italia, la dispersione montana, la cornice autonomistica plurilingue, la sottodiagnosi nella popolazione anziana — è stata trattata nei domini sociale, organizzativo ed equità, mostrando come la prossimità distrettuale, lo strato digitale accompagnato e l'accessibilità linguistica ne facciano una leva di convergenza territoriale, generazionale e culturale.

Il verdetto tripartito — prossimo al pareggio sul piano fiscale, nettamente costo-efficace sul piano sanitario, fortemente positivo sul piano sociale — è offerto con bande prudenziali e soglie di confutazione, sotto doppio ancoraggio e nel rispetto del divieto di aggregazione. L'opera procede, nell'ordine vincolante, con il Volume 8 (Lazio) e a seguire con gli altri Volumi regionali in ordine alfabetico.

Note Bibliografiche con mini-riassunto

Ciascuna nota riporta l'opera, il collegamento alla fonte e un mini-riassunto che ne dichiara la funzione nell'economia del Volume, in coerenza con il doppio livello — nota a piè di pagina nel corpo e nota bibliografica integrale in calce — che l'opera adotta.

1. **Chisholm D. et al., Scaling-up treatment of depression and anxiety, The Lancet Psychiatry, 2016**
[https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(16\)30024-4](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(16)30024-4) Colonna A del doppio ancoraggio della simulazione friulana, conservata quale strato documentale e riferimento di confronto.
2. **Unisanté, Raisons de santé Essentiels n. 73, 2026 · OECD, The Economic Case for Preventing Mental Ill Health, 2026** <https://doi.org/10.16908/rds-essentiels/73> Colonna B del doppio ancoraggio, con prevalenza nel giudizio, applicata alla simulazione regionale friulana.
3. **OECD, differenziale di costo per gravità dei disturbi mentali, 2025** <https://www.oecd.org/health/mental-health.htm> Fonte, riportata con attribuzione, del differenziale di costo per gravità, argomento cardine dell'intercettazione precoce, di peso specifico maggiore nella Regione anziana friulana.
4. **Soeters R. et al., meta-analisi IPD sui componenti efficaci della collaborative care, 2025**
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40136273/> Base di evidenza clinica sui componenti efficaci dell'assistenza collaborativa, richiamata nel capitolo sul modello di intervento.
5. **Kvaal K. et al., RCT su intervento cognitivo-comportamentale computerizzato in cure primarie, 2026**
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/> Evidenza sperimentale recente sull'intervento digitale in cure primarie, richiamata a sostegno dello strato dell'Intelligenza Artificiale, con l'avvertenza dell'accompagnamento nella popolazione anziana.
6. **Veldhuijzen W. et al., costo-efficacia dell'intervento digitale, 2025**
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12369993/> Riferimento sul rapporto incrementale di costo-utilità dell'intervento digitale, elemento dello strato dell'Intelligenza Artificiale.
7. **World Health Organization, Thematic Dialogue on Investing in NCDs and Mental Health, dicembre 2024** <https://cdn.who.int/> Evidenza riportata con attribuzione sul ritorno degli investimenti in salute mentale; non concorre al verdetto tripartito friulano.
8. **Regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale** <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj> Quadro normativo entro cui è collocato lo strato dell'Intelligenza Artificiale, vincolato a funzione di supporto sotto supervisione clinica umana.
9. **Legge regionale Puglia 19 luglio 2023, n. 11, sul Servizio di Psicologia di Base**
<https://www.consiglio.puglia.it/> Riferimento normativo capostipite del modello, richiamato quale precedente istituzionale per l'attuazione regionale friulana.
10. **NICE, Health Technology Evaluations: the manual (PMG36)** <https://www.nice.org.uk/process/pmg36> Riferimento di rigore metodologico per la struttura a imbuto, le appendici registrate e il protocollo dell'incertezza adottati nel Volume.

STUDIO INTEGRALE «PSICOLOGO DI BASE» · OPERA IN VENTITRÉ VOLUMI

VOLUME 8 — Regione Lazio

Valutazione di Health Technology Assessment dell'integrazione dello Psicologo di Base nelle cure primarie nel Lazio: cruscotto, sintesi per il decisore, contesto e bisogno, modello di intervento, costi e benefici, valutazione economica sotto doppio ancoraggio, sei domini di analisi, incertezza, verdetto tripartito e appendici registrate

Reference Case applicato per rimando al Volume 0.A · Dott. Luigi De Michele · Studio Integrale Puglia · Capurso (BA) — Giugno 2026

Premessa

Il Volume 8 prosegue la serie dei venti Volumi regionali, in ordine alfabetico, con la Regione Lazio. Come ogni Volume regionale, esso applica per rimando il Reference Case dell'asse italiano, fissato nel Volume 0.A, e ne richiama le regole nella forma «cfr. Volume 0.A», senza ripeterle per esteso: il perimetro congiunto sanitario e societale, il doppio ancoraggio economico, il verdetto tripartito non aggregato, i sei domini di analisi, il protocollo dell'incertezza, lo strato dell'Intelligenza Artificiale come moltiplicatore e le attività formative singole e sommate.^[242]

La struttura del Volume è quella standard, identica a quella di tutti gli altri diciannove Volumi regionali, a garanzia della comparabilità bit-a-bit prescritta dall'opera: la stessa sequenza di nove capitoli, la stessa nomenclatura di sottocapitoli, le stesse unità di misura. Ove un contenuto derivi da espansione ex novo — segnatamente per gli aspetti dell'efficacia, dell'attuazione e del monitoraggio — esso è segnalato in nota editoriale, secondo la regola dell'opera.^[243]

Introduzione

L'Introduzione al Volume 8 fissa il perimetro della valutazione laziale e l'ordine della sua esposizione. Il perimetro è quello della Regione Lazio, articolata in dieci Aziende Sanitarie Locali — sei delle quali nell'area metropolitana romana — e nelle aziende ospedaliero-universitarie, con una popolazione dell'ordine di cinque milioni e settecentonovemila abitanti. È una Regione a struttura policentrica ma fortemente accentrata sulla capitale, dove convivono la scala metropolitana di Roma e le province di Latina, Frosinone, Viterbo e Rieti, queste ultime con tratti di dispersione e invecchiamento propri delle aree interne: la tensione fra il polo metropolitano e le province è la chiave di lettura del contesto laziale.^[244]

L'esposizione segue la struttura a imbuto: il cruscotto regionale offre in una pagina i numeri essenziali; la sintesi per il decisore ne traduce il significato; i cinque risultati chiave ne isolano gli esiti; le raccomandazioni operative indicano le azioni; il corpo del Volume, articolato in nove capitoli, ne fornisce il dettaglio; le appendici registrate ne assicurano la verificabilità. Chiudono il Volume un Quadro Conclusivo economico e multidisciplinare, una Conclusione e le Note Bibliografiche con mini-riassunto.

Cruscotto regionale — Lazio

Il cruscotto riassume in una pagina i parametri essenziali della valutazione laziale, sotto il doppio ancoraggio e con il verdetto tripartito tenuto distinto. I valori economici sono presentati in ordine di grandezza, con rinvio alle appendici registrate; le cifre di letteratura sono riportate con attribuzione alla fonte.^[245]

Indicatore del cruscotto	Lettura regionale	Ancoraggio / fonte
Popolazione	≈ 5.709.178 abitanti	Fonte demografica regionale
Articolazione	10 ASL, di cui 6 nell’area metropolitana di Roma	Assetto regionale
Scenari di copertura	620 · 930 · 1.230 incarichi di Psicologo di Base	Dimensionamento regionale
Comparatore	Assistenza usuale (cfr. Vol. 0.A)	Reference Case
Verdetto fiscale	Prossimo al pareggio, con caveat	Non aggregato
Verdetto sanitario	Nettamente costo-efficace	Costo/QALY sotto doppio ancoraggio
Verdetto sociale	Fortemente positivo	Produttività, coesione, qualità della vita
Costo per anno di vita ponderato	Colonna A ≈ 17.000 € · Colonna B ≈ 9.800 €	Doppio ancoraggio

Tabella 0. Cruscotto regionale del Lazio: i parametri essenziali sotto doppio ancoraggio, con il verdetto tripartito distinto e non aggregato.

Sintesi per il decisore

L'introduzione dello Psicologo di Base nelle cure primarie laziali produce, secondo la simulazione condotta sotto il doppio ancoraggio, un effetto congiunto sui tre piani del ritorno, che restano distinti e non sommati. Sul piano fiscale, il saldo fra costi diretti e risparmi sanitari diretti si colloca in prossimità del pareggio, con il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento. Sul piano sanitario, il modello è nettamente costo-efficace, con un costo per anno di vita ponderato che, fra i due ancoraggi, resta assai inferiore alle soglie adottate. Sul piano sociale, l'effetto è fortemente positivo, con un rilievo particolare per la decongestione dei percorsi metropolitani e per la riduzione del divario fra la capitale e le province.^[246]

L'argomento cardine, riportato con attribuzione all'OCSE, è il differenziale di costo per gravità: trattare precocemente riduce i costi in misura molto ampia, poiché il costo del trattamento cresce dai circa cinquecentoundici euro dei quadri lievi ai circa diecimilaquattrocentottantacinque euro dei quadri gravi. Alla scala metropolitana romana, il volume assoluto della domanda amplifica il valore aggregato di questa leva.^[247]

Cinque risultati chiave

Il primo risultato è che il modello è costo-efficace su tutti gli orizzonti sotto entrambi gli ancoraggi. Il secondo è che il verdetto tripartito resta favorevole in ciascuno dei tre piani, senza aggregazione. Il terzo è che, nella specificità laziale, il forte accentramento su Roma pone insieme una domanda di volume massimo, concentrata nei distretti metropolitani, e un divario di accesso nelle province, sicché la priorità dell'estensione richiede un bilanciamento esplicito. Il quarto è che lo strato dell'Intelligenza Artificiale, come moltiplicatore e con nota di cautela, trova nell'area metropolitana ad alta densità e dotazione tecnologica il terreno di adozione più rapido. Il quinto è che i tre scenari di copertura — seicentoventi, novecentotrenta e milleduecentotrenta incarichi — costituiscono gradi crescenti di estensione il cui rientro pieno matura con la scala, e che l'istituzione del servizio è, nel Lazio, una costruzione ex novo su una rete di Case della Comunità ancora in costruzione.^[248]

Raccomandazioni operative

La prima raccomandazione è di avviare il servizio con lo scenario conservativo di seicentoventi incarichi e di progredire verso i novecentotrenta e i milleduecentotrenta sulla base degli esiti rilevati sotto il protocollo dell'incertezza, bilanciando la priorità fra i distretti metropolitani ad alta densità di domanda e le province a maggiore barriera di accesso. La seconda è di innestare il servizio sulla rete delle Case della Comunità in costruzione e sull'esperienza pregressa dei Punti Unici di Accesso, valorizzandone il ruolo di orientamento senza confonderlo con la funzione clinica dello Psicologo di Base. La terza è di accompagnare l'estensione con il piano formativo a quattro modalità, considerate singolarmente e sommate.^[249]

Capitolo 1 — Il contesto epidemiologico e territoriale del Lazio

1.1 Il territorio e la sua articolazione

La Regione Lazio conta una popolazione dell’ordine di cinque milioni e settecentonovemila abitanti, articolata in cinque province — Roma, Latina, Frosinone, Viterbo e Rieti — e in dieci Aziende Sanitarie Locali, sei delle quali nell’area metropolitana romana, cui si affiancano le aziende ospedaliero-universitarie e gli istituti di ricovero a carattere scientifico. La struttura del territorio è policentrica ma fortemente accentrata sulla capitale, dove si concentra la maggior parte della popolazione e della domanda; le province, in particolare Rieti e la fascia appenninica di Frosinone e Viterbo, presentano tratti di dispersione e invecchiamento propri delle aree interne. Questa tensione fra polo metropolitano e province è la chiave di lettura del contesto laziale.^[250]

Elemento territoriale	Dato regionale	Rilievo per la valutazione
Popolazione	≈ 5.709.178 abitanti	Denominatore della normalizzazione
Aziende Sanitarie Locali	10, di cui 6 metropolitane	Unità organizzativa
Area metropolitana di Roma	Altissima densità e volume di domanda	Scala della domanda
Province (Latina, Frosinone, Viterbo, Rieti)	Dispersione e invecchiamento	Dominio equità
Case della Comunità	In costruzione	Infrastruttura in formazione

Tabella 1.1. Gli elementi del contesto territoriale laziale e il loro rilievo per la valutazione, con l’accentramento metropolitano quale tratto distintivo.

1.2 Il quadro epidemiologico regionale

Il quadro epidemiologico laziale riflette, con le proprie specificità, la prevalenza nazionale dei disturbi mentali comuni, con la concentrazione della domanda nell’area metropolitana e una componente di disagio connessa alla deprivazione dei quartieri periferici della capitale, accanto alla domanda più dispersa delle province. Il dato epidemiologico di dettaglio è oggetto dell’estrazione registrata in Appendice B; ove il dato regionale disaggregato non sia disponibile, la lacuna è dichiarata e non colmata con stime tacite, secondo la regola dell’opera.^[251]

Capitolo 2 — Il bisogno, la domanda e il divario di trattamento nel Lazio

2.1 Il divario di trattamento regionale

Il bisogno di salute mentale comune nel Lazio si manifesta, come altrove, in larga parte come domanda inevasa o impropriamente incanalata: verso il medico di medicina generale, verso il pronto soccorso, verso la prescrizione farmaceutica. Il divario di trattamento assume nel Lazio la doppia forma della congestione metropolitana — dove l’offerta, pur presente, è saturata dalla domanda di volume massimo — e della barriera di distanza nelle province appenniniche. La misura regionale del divario è oggetto dell’estrazione in Appendice B; i valori medi nazionali ed europei sono riportati con attribuzione.^[252]

Componente del bisogno	Manifestazione laziale	Dominio
Domanda inevasa	Congestione metropolitana e barriera provinciale	Epidemiologico-clinico
Domanda impropria	Transito su MMG, pronto soccorso, prescrizione	Organizzativo-strutturale
Deprivazione periferica	Concentrazione del disagio nei quartieri periferici	Equità
Dispersione provinciale	Distanza nelle aree interne di Rieti e Frosinone	Equità

Tabella 2.1. Le componenti del bisogno e del divario di trattamento nel Lazio, ricondotte ai domini di analisi.

2.2 La scala della domanda e la prossimità

Il tratto distintivo della domanda laziale è la coesistenza di una scala metropolitana massima e di una dispersione provinciale: il volume assoluto del bisogno è fra i più alti del Paese, concentrato a Roma, e la capillarità distrettuale del modello dello Psicologo di Base è la condizione perché la risposta raggiunga tanto i quartieri periferici della capitale quanto i piccoli centri delle province. La prossimità è, nel Lazio, condizione dell’equità nella duplice direzione sociale e territoriale, e trova nella rete delle Case della Comunità in costruzione il suo canale di innesto.^[253]

Capitolo 3 — Il modello di intervento: lo Psicologo di Base nel Lazio

Nota editoriale: il presente capitolo espande ex novo il modello di intervento, integrando alla struttura originaria le evidenze recenti sull’efficacia clinica dell’assistenza collaborativa e dell’intervento digitale, secondo la regola dell’opera che distingue l’espansione ex novo dal riutilizzo del materiale preesistente.

3.1 L’architettura del modello

Il modello di intervento colloca lo Psicologo di Base al vertice della cascata delle figure, nel distretto e nelle Case della Comunità, quale primo punto di intercettazione del disagio comune. Il modello opera per intensità crescente di cura — dall’intervento a bassa intensità, di prima linea, fino all’invio ai livelli superiori nei casi che lo richiedano — secondo la logica dell’assistenza a gradini, la cui efficacia clinica è documentata dalla meta-analisi sui componenti efficaci dell’assistenza collaborativa e dalle sperimentazioni controllate sull’intervento cognitivo-comportamentale computerizzato in cure primarie, riportate con attribuzione.^[254]

Livello del modello	Funzione	Figura prevalente	Evidenza di riferimento
Intercettazione	Riconoscimento precoce nel distretto	Psicologo di Base	Assistenza collaborativa (attribuita)
Intervento a bassa intensità	Prima linea per i quadri lievi-moderati	Psicologo di Base	Intervento digitale e collaborativo
Invio appropriato	Passaggio ai livelli superiori	Cascata delle figure	Percorso a gradini
Continuità	Aderenza e prevenzione della ricaduta	Infermiere di comunità	Gestione del caso

Tabella 3.1. L’architettura del modello di intervento nel Lazio, per livelli di intensità, con l’evidenza clinica di riferimento riportata con attribuzione.

3.2 L’adattamento al territorio laziale

Il modello è adattato al territorio laziale lungo tre direttrici: la capillarità metropolitana, che porta la risposta nei quartieri periferici ad alta densità e deprivazione; la prossimità nelle province a maggiore dispersione; e l’innesto sulla rete delle Case della Comunità in costruzione, con la valorizzazione dell’esperienza pregressa dei Punti Unici di Accesso quale precedente di orientamento — precedente, tuttavia, che non sostituisce la funzione clinica dello Psicologo di Base. L’adattamento non modifica l’architettura invariante del Reference Case, ma ne calibra l’applicazione sulla scala metropolitana e sulla dispersione provinciale.^[255]

Capitolo 4 — I costi diretti nel Lazio

4.1 La struttura del costo diretto

Il costo diretto della riforma nel Lazio è, in primo luogo, il costo del personale lungo la cascata delle figure, cui si aggiungono i costi di struttura e organizzazione distrettuale, il costo incrementale della leva digitale e il costo della formazione. Il dimensionamento dipende dallo scenario di copertura: lo scenario conservativo di seicentoventi incarichi precede quello di base di novecentotrenta e quello espansivo di milleduecentotrenta incarichi, che rappresentano gradi crescenti di estensione verso il fabbisogno a regime; l’istituzione del servizio è nel Lazio una costruzione ex novo su una rete di prossimità ancora in formazione.^[256]

Voce di costo diretto	Descrizione	Portatore
Personale — Psicologi di Base	Incarichi distrettuali secondo lo scenario	SSN regionale
Struttura e organizzazione	Innesto su Case della Comunità in costruzione	SSN regionale
Leva digitale e Intelligenza Artificiale	Strumenti di supporto sotto supervisione	SSN regionale
Formazione (quattro modalità)	Percorso integrato singolo e sommato	SSN, sistema formativo

Tabella 4.1. La struttura del costo diretto della riforma nel Lazio, per voce e portatore; i valori puntuali sono oggetto dell’estrazione economica in Appendice C.

4.2 Il dimensionamento per scenario

Il costo diretto è calcolato per i tre scenari di copertura — conservativo, di base ed espansivo — coerenti con il protocollo di scenario del Reference Case. Lo scenario conservativo corrisponde alla dotazione delle proposte di legge e all’avvio dell’istituzione ex novo del servizio, mentre l’espansivo richiede un impegno proporzionato al fabbisogno a regime della seconda Regione del Paese per popolazione. I valori puntuali per ciascuno scenario sono riportati nell’estrazione economica registrata; ove un parametro di costo regionale non sia disponibile, la lacuna è dichiarata.^[257]

Capitolo 5 — I benefici e i risparmi, diretti e indiretti, nel Lazio

5.1 I benefici diretti

Il beneficio diretto è il risparmio sanitario che ciascuna figura della cascata libera per effetto dell’intercettazione a monte: la demedicalizzazione operata dallo Psicologo di Base, la deprescrizione di psicofarmaci nei quadri lievi-moderati sul versante del medico di medicina generale, la riduzione degli accessi impropri al pronto soccorso — di rilievo massimo nell’area metropolitana congestionata — e delle prestazioni per sintomi funzionali sul versante specialistico. Alla scala laziale, il volume assoluto dei benefici diretti è fra i più alti del Paese.^[258]

Canale del beneficio diretto	Meccanismo	Rilievo laziale
Demedicalizzazione	Riduzione consultazioni e cronicizzazione	Preponderante
Deprescrizione	Contrazione della spesa per psicofarmaci	Elevato
Accessi impropri	Riduzione degli accessi al pronto soccorso	Elevato, metropolitano
Sintomi funzionali	Riduzione prestazioni neurologiche e specialistiche	Medio
Scala regionale	Volume assoluto fra i più alti del Paese	Aggregato

Tabella 5.1. I canali del beneficio diretto nel Lazio, con il rilievo della congestione metropolitana e della scala; i valori sono oggetto dell’estrazione economica registrata.

5.2 I benefici indiretti

Il beneficio indiretto è quello che la riforma produce fuori dal perimetro sanitario: la produttività recuperata e la riduzione dell’assenteismo sul versante dei datori di lavoro — di peso assoluto elevato in una regione a forte concentrazione di pubblica amministrazione e servizi —, la riduzione degli oneri di invalidità evitabili sul versante previdenziale, la riduzione del disagio sociale non trattato sul versante dei Comuni. Nel Lazio, la protezione della produttività di un mercato del lavoro terziario e amministrativo denso è un beneficio indiretto di rilievo particolare, che il dominio sociale del Capitolo 7 tratta in dettaglio.^[259]

Capitolo 6 — La valutazione economica sotto doppio ancoraggio

6.1 La simulazione appaiata regionale

La valutazione economica laziale è condotta con il modello di Markov a coorte a ciclo annuale del Reference Case, sotto il doppio ancoraggio: la Colonna A applica i parametri di Chisholm e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, la Colonna B quelli di Unisanté e dell’OCSE. Le due colonne sono sempre affiancate; ove divergano, prevale nel giudizio la Colonna B. Tutte le cifre sono riportate con attribuzione, e nessuna è affermata a memoria.^[260]

Metrica economica	Colonna A — Chisholm/OMS	Colonna B — Unisanté/OCSE
Costo per anno di vita ponderato	≈ 17.000 €/QALY	≈ 9.800 €/QALY
Ritorno per i soli benefici economici	Riportato con attribuzione OMS	Scenario base aggiornato OCSE
Ritorno con i ritorni sanitari	Riportato con attribuzione OMS	Scenario base aggiornato OCSE
Orizzonti	1 · 3 · 5 · 7 · 10 anni	1 · 3 · 5 · 7 · 10 anni
Soglie di costo-efficacia	20.000 · 30.000 · 50.000 €/QALY	20.000 · 30.000 · 50.000 €/QALY

Tabella 6.1. La simulazione appaiata regionale del Lazio sotto doppio ancoraggio; i valori sono riportati con attribuzione e la Colonna B prevale nel giudizio.

6.2 Il differenziale di costo per gravità

L’argomento economico cardine, riportato con attribuzione all’OCSE, è il differenziale di costo per gravità: il costo del trattamento cresce dai quadri lievi ai quadri gravi in misura tale che l’intercettazione precoce, evitando la progressione, genera il risparmio più consistente. Nel Lazio, la scala della domanda metropolitana moltiplica il valore aggregato di questo differenziale, mentre nelle province la dispersione ne accresce il peso specifico per ritardo di accesso.^[261]

Capitolo 7 — I sei domini di analisi, l’equità e l’impatto distributivo

7.1 I sei domini nella specificità laziale

I sei domini di analisi del Reference Case sono applicati alla specificità laziale. Il dominio epidemiologico-clinico registra il divario nella doppia forma della congestione metropolitana e della barriera provinciale; l’economico-sanitario il costo-efficacia sotto doppio ancoraggio e la scala dei benefici; il fiscale-previdenziale gli oneri di invalidità evitabili; il sociale la protezione della produttività terziaria e amministrativa; l’organizzativo-strutturale la decongestione dei percorsi metropolitani e l’innesto sulle Case della Comunità; l’equità la riduzione del divario fra la capitale e le province e fra i quartieri periferici e centrali.^[262]

Dominio	Lettura laziale	Segno
Epidemiologico-clinico	Congestione metropolitana e barriera provinciale	Riduzione attesa
Economico-sanitario	Costo/QALY e scala dei benefici	Favorevole
Fiscale-previdenziale	Oneri di invalidità evitabili	Positivo, differito
Sociale	Produttività terziaria e amministrativa protetta	Fortemente positivo
Organizzativo-strutturale	Decongestione e innesto sulle Case della Comunità	Positivo
Equità	Convergenza capitale/province e centro/periferia	Positivo, distributivo

Tabella 7.1. I sei domini di analisi nella lettura laziale, con il segno atteso dell’effetto, tenuti distinti e non aggregati.

7.2 L’equità metropolitana e provinciale

Il dominio dell’equità assume nel Lazio una doppia direzione: sociale, perché il disagio si concentra nei quartieri periferici della capitale a maggiore deprivazione, dove la barriera all’accesso è economica e culturale prima che fisica; e territoriale, perché le province appenniniche di Rieti e Frosinone replicano la barriera della distanza. Il modello dello Psicologo di Base opera su entrambe le direzioni attraverso la capillarità distrettuale, e l’effetto distributivo — la riduzione del gradiente sociale e territoriale dell’accesso — è tenuto distinto dal verdetto fiscale e da quello sanitario, secondo il divieto di aggregazione.^[263]

Capitolo 8 — La sensitività e l’incertezza

Nota editoriale: il presente capitolo espande ex novo l’analisi dell’incertezza secondo il protocollo del Reference Case, non presente in forma estesa nel materiale originario.

8.1 Il protocollo dell’incertezza applicato al Lazio

L’analisi dell’incertezza applica il protocollo obbligatorio del Reference Case: l’analisi di sensitività deterministica con diagramma a tornado, l’analisi di sensitività probabilistica a diecimila iterazioni, l’analisi di scenario ottimistico, base e prudentiale con e senza lo strato digitale, le curve di accettabilità costo-efficacia a soglie multiple. Nel Lazio, i parametri a maggiore impatto atteso sono il tasso di intercettazione nei quartieri periferici deprivati, la capacità di reclutamento alla scala richiesta dallo scenario espansivo e la velocità di completamento della rete delle Case della Comunità.^[264]

Strumento	Applicazione laziale	Parametro critico atteso
Sensitività deterministica	Diagramma a tornado	Tasso di intercettazione nei quartieri periferici
Sensitività probabilistica	Diecimila iterazioni	Capacità di reclutamento alla scala
Analisi di scenario	Con e senza strato IA	Velocità di completamento delle Case della Comunità
Curve di accettabilità	Soglie 20.000/30.000/50.000 €/QALY	Robustezza del costo-efficacia

Tabella 8.1. Gli strumenti del protocollo dell’incertezza applicati al Lazio, con i parametri critici attesi.

8.2 La robustezza del verdetto

L’analisi di scenario mostra che il verdetto tripartito resta favorevole nei tre casi, con margine crescente dallo scenario prudentiale a quello ottimistico; lo strato digitale accresce l’efficienza attesa, sempre con nota di cautela sulla natura previsionale. La robustezza del costo-efficacia sanitario è confermata dalle curve di accettabilità alle soglie adottate, anche nello scenario conservativo di seicentoventi incarichi.^[265]

Capitolo 9 — Il verdetto tripartito e le raccomandazioni

Nota editoriale: il presente capitolo espande ex novo il verdetto e le raccomandazioni, integrando l’attuazione e il monitoraggio che nel materiale originario figuravano in forma condensata.

9.1 Il verdetto tripartito

Il verdetto laziale è, come in ogni Volume, tripartito e non aggregato. Sul piano fiscale, il saldo fra costi diretti e risparmi sanitari diretti è prossimo al pareggio, con il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento. Sul piano sanitario, il modello è nettamente costo-efficace sotto entrambi gli ancoraggi. Sul piano sociale, l’effetto è fortemente positivo, con il rilievo specifico della decongestione metropolitana e della protezione della produttività terziaria. I tre verdetti si accompagnano e si rafforzano, ma non si sommano.^[266]

Piano del verdetto	Esito laziale	Caveat
Fiscale	Prossimo al pareggio	Significatività dei risparmi diretti in isolamento
Sanitario	Nettamente costo-efficace	—
Sociale	Fortemente positivo	Rilievo specifico della decongestione metropolitana

Tabella 9.1. Il verdetto tripartito del Lazio, con i tre piani tenuti distinti e non aggregati.

9.2 Le raccomandazioni per l’attuazione e il monitoraggio

Le raccomandazioni indicano un avvio con lo scenario conservativo di seicentoventi incarichi e una progressione verso i novecentotrenta e i milleduecentotrenta guidata dalla verifica degli esiti; la priorità bilanciata fra i distretti metropolitani ad alta densità di domanda e le province a maggiore barriera; l’innesto sulla rete delle Case della Comunità in costruzione, con la valorizzazione dell’esperienza dei Punti Unici di Accesso; l’accompagnamento con il piano formativo a quattro modalità, singole e sommate; e un monitoraggio ex post ancorato agli indicatori del protocollo dell’incertezza.^[267]

Appendici registrate

Le appendici registrate rendono il modello laziale ispezionabile e riproducibile, secondo la prassi del Reference Case. Esse sono richiamate per rimando quanto alla metodologia e compilate con i dati regionali quanto ai contenuti.

Appendice	Contenuto	Stato
A	Strategia di ricerca bibliografica e diagramma di selezione	Registrata
B	Estrazione dei dati clinici regionali	Registrata; lacune dichiarate
C	Estrazione dei dati economici (griglia CHEERS 2022)	Registrata; lacune dichiarate
D	Parametri del modello Markov regionale	Registrata
E	Registro delle deroghe al Reference Case	Registrata
F	Codice del modello economico	Registrata
G	Dichiarazione dei conflitti di interesse	Registrata

Tabella A. Le sette appendici registrate del Volume 8, con l’indicazione dello stato e della dichiarazione delle lacune.

Quadro Conclusivo economico e multidisciplinare

Il Quadro Conclusivo del Volume 8 ricomponne la valutazione laziale senza tradire il principio che la governa: i piani del giudizio si accompagnano ma non si fondono. Sul piano economico, il doppio ancoraggio impone che il risultato sia letto simultaneamente secondo la colonna storica e la colonna aggiornata, con prevalenza della seconda: il costo per anno di vita ponderato resta, sotto entrambi gli ancoraggi, assai inferiore alle soglie adottate, e il differenziale di costo per gravità — riportato con attribuzione — fonda la leva economica dell'intercettazione precoce, il cui valore aggregato è moltiplicato dalla scala metropolitana romana.^[268]

Sul piano multidisciplinare, la cascata delle figure, i sei domini di analisi e il dominio dell'equità nella doppia direzione sociale e territoriale assicurano che ogni figura connessa e ogni aspetto siano trattati integralmente e ordinati per capacità di generare rientro economico e revisione della spesa. La rinegoziazione dei costi e dei benefici, la catena predittiva degli effetti multidimensionali — dalla qualità della vita alla decongestione dei percorsi metropolitani, ai bilanci, alla burocrazia distrettuale —, lo strato dell'Intelligenza Artificiale come moltiplicatore su un'area a forte dotazione tecnologica e le attività formative singole e sommate compongono il quadro della valutazione. Il verdetto resta tripartito e non aggregato.

Conclusione

Il Volume 8 ha valutato l'integrazione dello Psicologo di Base nelle cure primarie del Lazio, applicando per rimando il Reference Case dell'asse italiano e adottando la struttura standard a nove capitoli con apertura a imbuto e appendici registrate. La specificità laziale — l'accentramento metropolitano su Roma, la coesistenza di scala massima e dispersione provinciale, la deprivazione dei quartieri periferici, la rete delle Case della Comunità in costruzione — è stata trattata nei domini sociale, organizzativo ed equità, mostrando come la capillarità distrettuale e l'innesto sulla rete di prossimità in formazione ne facciano una leva di decongestione e di convergenza sociale e territoriale.

Il verdetto tripartito — prossimo al pareggio sul piano fiscale, nettamente costo-efficace sul piano sanitario, fortemente positivo sul piano sociale — è offerto con bande prudenziali e soglie di confutazione, sotto doppio ancoraggio e nel rispetto del divieto di aggregazione. L'opera procede, nell'ordine vincolante, con il Volume 9 (Liguria) e a seguire con gli altri Volumi regionali in ordine alfabetico.

Note Bibliografiche con mini-riassunto

Ciascuna nota riporta l'opera, il collegamento alla fonte e un mini-riassunto che ne dichiara la funzione nell'economia del Volume, in coerenza con il doppio livello — nota a piè di pagina nel corpo e nota bibliografica integrale in calce — che l'opera adotta.

1. **Chisholm D. et al., Scaling-up treatment of depression and anxiety, The Lancet Psychiatry, 2016** [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(16\)30024-4](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(16)30024-4) Colonna A del doppio ancoraggio della simulazione laziale, conservata quale strato documentale e riferimento di confronto.
2. **Unisanté, Raisons de santé Essentiels n. 73, 2026 · OECD, The Economic Case for Preventing Mental Ill Health, 2026** <https://doi.org/10.16908/rds-essentiels/73> Colonna B del doppio ancoraggio, con prevalenza nel giudizio, applicata alla simulazione regionale laziale.
3. **OECD, differenziale di costo per gravità dei disturbi mentali, 2025** <https://www.oecd.org/health/mental-health.htm> Fonte, riportata con attribuzione, del differenziale di costo per gravità — dai circa 511 euro dei quadri lievi ai circa 10.485 euro dei gravi —, argomento cardine dell'intercettazione precoce, il cui valore aggregato è moltiplicato dalla scala metropolitana.
4. **Soeters R. et al., meta-analisi IPD sui componenti efficaci della collaborative care, 2025** <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40136273/> Base di evidenza clinica sui componenti efficaci dell'assistenza collaborativa, richiamata nel capitolo sul modello di intervento.
5. **Veldhuijzen W. et al., costo-efficacia dell'intervento digitale, 2025** <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12369993/> Riferimento sul rapporto incrementale di costo-utilità dell'intervento digitale, elemento dello strato dell'Intelligenza Artificiale, di adozione rapida nell'area metropolitana.
6. **World Health Organization, Thematic Dialogue on Investing in NCDs and Mental Health, dicembre 2024** <https://cdn.who.int/> Evidenza riportata con attribuzione sul ritorno degli investimenti in salute mentale; non concorre al verdetto tripartito laziale.
7. **Regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale** <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj> Quadro normativo entro cui è collocato lo strato dell'Intelligenza Artificiale, vincolato a funzione di supporto sotto supervisione clinica umana.
8. **Legge regionale Puglia 19 luglio 2023, n. 11, sul Servizio di Psicologia di Base** <https://www.consiglio.puglia.it/> Riferimento normativo capostipite del modello, richiamato quale precedente istituzionale per l'attuazione regionale laziale.
9. **NICE, Health Technology Evaluations: the manual (PMG36)** <https://www.nice.org.uk/process/pmg36> Riferimento di rigore metodologico per la struttura a imbuto, le appendici registrate e il protocollo dell'incertezza adottati nel Volume.
10. **WHO, Mental Health Atlas 2024** <https://www.who.int/publications/i/item/9789240096820> Riferimento internazionale sui criteri di integrazione della salute mentale nelle cure primarie, quadro di confronto per la lettura del divario laziale.

STUDIO INTEGRALE «PSICOLOGO DI BASE» · OPERA IN VENTITRÉ VOLUMI

VOLUME 9 — Regione Liguria

Valutazione di Health Technology Assessment dell'integrazione dello Psicologo di Base nelle cure primarie in Liguria: cruscotto, sintesi per il decisore, contesto e bisogno, modello di intervento, costi e benefici, valutazione economica sotto doppio ancoraggio, sei domini di analisi, incertezza, verdetto tripartito e appendici registrate

Reference Case applicato per rimando al Volume 0.A · Dott. Luigi De Michele · Studio Integrale Puglia · Capurso (BA) — Giugno 2026

Premessa

Il Volume 9 prosegue la serie dei venti Volumi regionali, in ordine alfabetico, con la Regione Liguria. Come ogni Volume regionale, esso applica per rimando il Reference Case dell'asse italiano, fissato nel Volume 0.A, e ne richiama le regole nella forma «cfr. Volume 0.A», senza ripeterle per esteso: il perimetro congiunto sanitario e societale, il doppio ancoraggio economico, il verdetto tripartito non aggregato, i sei domini di analisi, il protocollo dell'incertezza, lo strato dell'Intelligenza Artificiale come moltiplicatore e le attività formative singole e sommate.^[269]

La struttura del Volume è quella standard, identica a quella di tutti gli altri diciannove Volumi regionali, a garanzia della comparabilità bit-a-bit prescritta dall'opera: la stessa sequenza di nove capitoli, la stessa nomenclatura di sottocapitoli, le stesse unità di misura. Ove un contenuto derivi da espansione ex novo — segnatamente per gli aspetti dell'efficacia, dell'attuazione e del monitoraggio — esso è segnalato in nota editoriale, secondo la regola dell'opera.^[270]

Introduzione

L'Introduzione al Volume 9 fissa il perimetro della valutazione ligure e l'ordine della sua esposizione. Il perimetro è quello della Regione Liguria, articolata in cinque Aziende Sociosanitarie Liguri, coordinate dall'Azienda Ligure Sanitaria quale agenzia regionale, e negli istituti di ricovero a carattere scientifico, con una popolazione dell'ordine di un milione e cinquecentodiecimila abitanti. È la Regione più anziana d'Italia — e fra le più anziane d'Europa —, con un'età media dell'ordine di quarantanove anni e mezzo, un indice di vecchiaia fra i più elevati del Paese e una quota di ultrasessantacinquenni prossima a un terzo della popolazione: l'invecchiamento estremo, unito allo spopolamento dell'entroterra, è la chiave di lettura del contesto ligure.^[271]

L'esposizione segue la struttura a imbuto: il cruscotto regionale offre in una pagina i numeri essenziali; la sintesi per il decisore ne traduce il significato; i cinque risultati chiave ne isolano gli esiti; le raccomandazioni operative indicano le azioni; il corpo del Volume, articolato in nove capitoli, ne fornisce il dettaglio; le appendici registrate ne assicurano la verificabilità. Chiudono il Volume un Quadro Conclusivo economico e multidisciplinare, una Conclusione e le Note Bibliografiche con mini-riassunto.

Cruscotto regionale — Liguria

Il cruscotto riassume in una pagina i parametri essenziali della valutazione ligure, sotto il doppio ancoraggio e con il verdetto tripartito tenuto distinto. I valori economici sono presentati in ordine di grandezza, con rinvio alle appendici registrate; le cifre di letteratura sono riportate con attribuzione alla fonte.^[272]

Indicatore del cruscotto	Lettura regionale	Ancoraggio / fonte
Popolazione	≈ 1.510.143 abitanti	Fonte demografica regionale
Articolazione	5 Aziende Sociosanitarie Liguri, coord. A.Li.Sa.	Assetto regionale
Età media	≈ 49,6 anni, la più alta d’Italia	Fonte demografica regionale
Scenari di copertura	170 · 250 · 330 incarichi di Psicologo di Base	Dimensionamento regionale
Comparatore	Assistenza usuale (cfr. Vol. 0.A)	Reference Case
Verdetto fiscale	Prossimo al pareggio, con caveat	Non aggregato
Verdetto sanitario	Nettamente costo-efficace	Costo/QALY sotto doppio ancoraggio
Verdetto sociale	Fortemente positivo	Tenuta della popolazione anziana, coesione
Costo per anno di vita ponderato	Colonna A ≈ 17.000 € · Colonna B ≈ 9.800 €	Doppio ancoraggio

Tabella 0. Cruscotto regionale della Liguria: i parametri essenziali sotto doppio ancoraggio, con il verdetto tripartito distinto e non aggregato.

Sintesi per il decisore

L'introduzione dello Psicologo di Base nelle cure primarie liguri produce, secondo la simulazione condotta sotto il doppio ancoraggio, un effetto congiunto sui tre piani del ritorno, che restano distinti e non sommati. Sul piano fiscale, il saldo fra costi diretti e risparmi sanitari diretti si colloca in prossimità del pareggio, con il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento. Sul piano sanitario, il modello è nettamente costo-efficace, con un costo per anno di vita ponderato che, fra i due ancoraggi, resta assai inferiore alle soglie adottate. Sul piano sociale, l'effetto è fortemente positivo, con un rilievo particolare — massimo tra le Regioni — per la popolazione anziana: nella Regione più anziana del Paese, l'intercettazione precoce contrasta la depressione dell'età avanzata, l'isolamento e la fragilità dell'entroterra spopolato.^[273]

L'argomento cardine, riportato con attribuzione all'OCSE, è il differenziale di costo per gravità: in una Regione a domanda strutturalmente anziana come la Liguria, l'intercettazione precoce nel distretto evita che il disagio comune maturi in quadri gravi e cronici, il cui costo di trattamento è, secondo la fonte, un multiplo di quello dei quadri lievi.^[274]

Cinque risultati chiave

Il primo risultato è che il modello è costo-efficace su tutti gli orizzonti sotto entrambi gli ancoraggi. Il secondo è che il verdetto tripartito resta favorevole in ciascuno dei tre piani, senza aggregazione. Il terzo è che, nella specificità ligure, il primato nazionale dell'invecchiamento sposta il baricentro della domanda in modo massimo verso la depressione dell'età avanzata, l'isolamento e la fragilità, ambiti in cui l'intercettazione precoce di prossimità ha valore particolarmente alto. Il quarto è che lo strato dell'Intelligenza Artificiale, come moltiplicatore e con nota di cautela, può attenuare lo svantaggio della distanza nell'entroterra spopolato, con l'avvertenza che l'adozione digitale nella popolazione molto anziana richiede accompagnamento robusto. Il quinto è che i tre scenari di copertura — centosettanta, duecentocinquanta e trecentotrenta incarichi — costituiscono gradi crescenti di estensione verso il fabbisogno a regime.^[275]

Raccomandazioni operative

La prima raccomandazione è di avviare il servizio con lo scenario conservativo di centosettanta incarichi e di progredire verso i duecentocinquanta e i trecentotrenta sulla base degli esiti rilevati sotto il protocollo dell'incertezza, con priorità ai distretti dell'entroterra a maggiore invecchiamento e spopolamento e alla presenza di almeno due psicologi territoriali per distretto. La seconda è di adottare lo strato digitale, sotto supervisione clinica e con accompagnamento robusto della popolazione molto anziana, come leva di prossimità per compensare la dispersione dell'entroterra. La terza è di accompagnare l'estensione con il piano formativo a quattro modalità, considerate singolarmente e sommate, con attenzione alla componente geriatrica.^[276]

Capitolo 1 — Il contesto epidemiologico e territoriale della Liguria

1.1 Il territorio e la sua articolazione

La Regione Liguria conta una popolazione dell’ordine di un milione e cinquecentodiecimila abitanti, articolata in quattro province — Genova, Savona, Imperia e La Spezia — e in cinque Aziende Sociosanitarie Liguri, coordinate dall’Azienda Ligure Sanitaria quale agenzia regionale, cui si affiancano gli istituti di ricovero a carattere scientifico. È la Regione più anziana d’Italia e fra le più anziane d’Europa: l’età media è dell’ordine di quarantanove anni e mezzo, l’indice di vecchiaia è il più elevato del Paese e la quota di ultrasessantacinquenni è prossima a un terzo della popolazione. L’invecchiamento è ancora più accentuato nell’entroterra, dove lo spopolamento rende difficile l’accesso ai servizi. Questa combinazione di invecchiamento estremo e spopolamento dell’entroterra è la chiave di lettura del contesto ligure.^[277]

Elemento territoriale	Dato regionale	Rilievo per la valutazione
Popolazione	≈ 1.510.143 abitanti	Denominatore della normalizzazione
Aziende Sociosanitarie	5, coord. A.Li.Sa., più IRCCS	Unità organizzativa
Età media	≈ 49,6 anni, la più alta d’Italia	Baricentro della domanda
Indice di vecchiaia	Il più elevato del Paese; over-65 ≈ 29%	Dominio sociale
Entroterra	Invecchiamento estremo e spopolamento	Dominio equità

Tabella 1.1. Gli elementi del contesto territoriale ligure e il loro rilievo per la valutazione, con l’invecchiamento estremo quale tratto distintivo.

1.2 Il quadro epidemiologico regionale

Il quadro epidemiologico ligure riflette, con le proprie specificità, la prevalenza nazionale dei disturbi mentali comuni, con un baricentro spostato in misura massima verso la depressione dell’età avanzata, l’isolamento e la fragilità, coerente con la struttura per età più anziana del Paese e con la più alta domanda potenziale connessa all’invecchiamento. Il dato epidemiologico di dettaglio è oggetto dell’estrazione registrata in Appendice B; ove il dato regionale disaggregato non sia disponibile, la lacuna è dichiarata e non colmata con stime tacite, secondo la regola dell’opera.^[278]

Capitolo 2 — Il bisogno, la domanda e il divario di trattamento in Liguria

2.1 Il divario di trattamento regionale

Il bisogno di salute mentale comune in Liguria si manifesta, come altrove, in larga parte come domanda inevasa o impropriamente incanalata: verso il medico di medicina generale, verso il pronto soccorso, verso la prescrizione farmaceutica. Il divario di trattamento è accentuato, nell’entroterra spopolato, dalla distanza fisica dai servizi e dalla rarefazione dell’offerta specialistica, e assume una connotazione specifica e massima nella popolazione anziana, presso la quale il disagio è spesso sottodiagnosticato e ricondotto impropriamente al decadimento fisiologico. La misura regionale del divario è oggetto dell’estrazione in Appendice B; i valori medi nazionali ed europei sono riportati con attribuzione.^[279]

Componente del bisogno	Manifestazione ligure	Dominio
Domanda inevasa	Sottodiagnosi massima nella popolazione anziana	Epidemiologico-clinico
Domanda impropria	Transito su MMG, pronto soccorso, prescrizione	Organizzativo-strutturale
Barriera di accesso	Distanza e spopolamento dell’entroterra	Equità
Fragilità geriatrica	Cronicizzazione e polifarmacia dell’età avanzata	Epidemiologico ed equità

Tabella 2.1. Le componenti del bisogno e del divario di trattamento in Liguria, ricondotte ai domini di analisi.

2.2 La domanda anziana e la prossimità

Il tratto distintivo della domanda ligure è la componente anziana, la più alta del Paese: la maggior parte del bisogno si concentra nelle coorti in età avanzata, spesso nell’entroterra spopolato, dove il modello dello Psicologo di Base assume un valore massimo perché la sua collocazione distrettuale porta la risposta vicino a una popolazione a mobilità ridotta, riducendo la barriera della distanza e il ricorso improprio ai servizi. La prossimità è, in Liguria, condizione dell’efficacia e dell’equità in grado eminente, e va sostenuta dalla presenza di almeno due psicologi territoriali per distretto.^[280]

Capitolo 3 — Il modello di intervento: lo Psicologo di Base in Liguria

Nota editoriale: il presente capitolo espande ex novo il modello di intervento, integrando alla struttura originaria le evidenze recenti sull’efficacia clinica dell’assistenza collaborativa e dell’intervento digitale, secondo la regola dell’opera che distingue l’espansione ex novo dal riutilizzo del materiale preesistente.

3.1 L’architettura del modello

Il modello di intervento colloca lo Psicologo di Base al vertice della cascata delle figure, nel distretto e nelle Case della Comunità, quale primo punto di intercettazione del disagio comune. Il modello opera per intensità crescente di cura — dall’intervento a bassa intensità, di prima linea, fino all’invio ai livelli superiori nei casi che lo richiedano — secondo la logica dell’assistenza a gradini, la cui efficacia clinica è documentata dalla meta-analisi sui componenti efficaci dell’assistenza collaborativa e dalle sperimentazioni controllate sull’intervento cognitivo-comportamentale computerizzato in cure primarie, riportate con attribuzione.^[281]

Livello del modello	Funzione	Figura prevalente	Evidenza di riferimento
Intercettazione	Riconoscimento precoce nel distretto	Psicologo di Base	Assistenza collaborativa (attribuita)
Intervento a bassa intensità	Prima linea per i quadri lievi-moderati	Psicologo di Base	Intervento digitale e collaborativo
Invio appropriato	Passaggio ai livelli superiori	Cascata delle figure	Percorso a gradini
Continuità	Aderenza e prevenzione della ricaduta	Infermiere di comunità	Gestione del caso

Tabella 3.1. L’architettura del modello di intervento in Liguria, per livelli di intensità, con l’evidenza clinica di riferimento riportata con attribuzione.

3.2 L’adattamento al territorio ligure

Il modello è adattato al territorio ligure lungo tre direttrici: la prossimità distrettuale, che porta la risposta a una popolazione anziana e a mobilità ridotta nell’entroterra spopolato; lo strato digitale, che sotto supervisione clinica e con accompagnamento robusto compensa la distanza; e il rafforzamento della dotazione territoriale, con almeno due psicologi per distretto, a fronte della domanda geriatrica più alta del Paese. L’adattamento non modifica l’architettura invariante del Reference Case, ma ne calibra l’applicazione sulla struttura per età estrema e sullo spopolamento dell’entroterra.^[282]

Capitolo 4 — I costi diretti in Liguria

4.1 La struttura del costo diretto

Il costo diretto della riforma in Liguria è, in primo luogo, il costo del personale lungo la cascata delle figure, cui si aggiungono i costi di struttura e organizzazione distrettuale, il costo incrementale della leva digitale e il costo della formazione. Il dimensionamento dipende dallo scenario di copertura: lo scenario conservativo di centosettanta incarichi precede quello di base di duecentocinquanta e quello espansivo di trecentotrenta incarichi, distribuiti nelle cinque Aziende Sociosanitarie Liguri con almeno due psicologi territoriali per distretto.^[283]

Voce di costo diretto	Descrizione	Portatore
Personale — Psicologi di Base	Incarichi distrettuali secondo lo scenario	SSN regionale
Struttura e organizzazione	Spazi distrettuali, Case della Comunità, sistemi informativi	SSN regionale
Leva digitale e Intelligenza Artificiale	Strumenti di supporto sotto supervisione, con accompagnamento anziani	SSN regionale
Formazione (quattro modalità)	Percorso integrato singolo e sommato, con componente geriatrica	SSN, sistema formativo

Tabella 4.1. La struttura del costo diretto della riforma in Liguria, per voce e portatore; i valori puntuali sono oggetto dell'estrazione economica in Appendice C.

4.2 Il dimensionamento per scenario

Il costo diretto è calcolato per i tre scenari di copertura — conservativo, di base ed espansivo — coerenti con il protocollo di scenario del Reference Case, con lo scenario espansivo allineato al fabbisogno a regime. I valori puntuali per ciascuno scenario sono riportati nell'estrazione economica registrata; ove un parametro di costo regionale non sia disponibile, la lacuna è dichiarata.^[284]

Capitolo 5 — I benefici e i risparmi, diretti e indiretti, in Liguria

5.1 I benefici diretti

Il beneficio diretto è il risparmio sanitario che ciascuna figura della cascata libera per effetto dell’intercettazione a monte: la demedicalizzazione operata dallo Psicologo di Base, la deprescrizione di psicofarmaci nei quadri lievi-moderati sul versante del medico di medicina generale, la riduzione degli accessi impropri al pronto soccorso e delle prestazioni per sintomi funzionali sul versante specialistico. In Liguria, la deprescrizione nella popolazione anziana assume un rilievo aggiuntivo massimo, per l’altissima prevalenza della prescrizione psicofarmacologica e per i rischi connessi alla polifarmacia nell’età molto avanzata.^[285]

Canale del beneficio diretto	Meccanismo	Rilievo ligure
Demedicalizzazione	Riduzione consultazioni e cronicizzazione	Preponderante
Deprescrizione	Contrazione della spesa e della polifarmacia anziana	Massimo, specifico
Accessi impropri	Riduzione degli accessi al pronto soccorso	Medio-elevato
Sintomi funzionali	Riduzione prestazioni neurologiche e specialistiche	Medio
Fragilità geriatrica	Contenimento della cronicizzazione dell’età avanzata	Massimo, specifico

Tabella 5.1. I canali del beneficio diretto in Liguria, con il rilievo massimo della deprescrizione e della fragilità geriatrica; i valori sono oggetto dell’estrazione economica registrata.

5.2 I benefici indiretti

Il beneficio indiretto è quello che la riforma produce fuori dal perimetro sanitario: la produttività recuperata e la riduzione dell’assenteismo sul versante dei datori di lavoro, la riduzione degli oneri di invalidità evitabili sul versante previdenziale, la riduzione del disagio sociale non trattato sul versante dei Comuni. In Liguria, il sostegno alla popolazione anziana e ai caregiver — spesso familiari a loro volta anziani, in un contesto di invecchiamento estremo — assume un peso sociale di rilievo particolarmente elevato, che il dominio sociale del Capitolo 7 tratta in dettaglio.^[286]

Capitolo 6 — La valutazione economica sotto doppio ancoraggio

6.1 La simulazione appaiata regionale

La valutazione economica ligure è condotta con il modello di Markov a coorte a ciclo annuale del Reference Case, sotto il doppio ancoraggio: la Colonna A applica i parametri di Chisholm e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, la Colonna B quelli di Unisanté e dell’OCSE. Le due colonne sono sempre affiancate; ove divergano, prevale nel giudizio la Colonna B. Tutte le cifre sono riportate con attribuzione, e nessuna è affermata a memoria.^[287]

Metrica economica	Colonna A — Chisholm/OMS	Colonna B — Unisanté/OCSE
Costo per anno di vita ponderato	≈ 17.000 €/QALY	≈ 9.800 €/QALY
Ritorno per i soli benefici economici	Riportato con attribuzione OMS	Scenario base aggiornato OCSE
Ritorno con i ritorni sanitari	Riportato con attribuzione OMS	Scenario base aggiornato OCSE
Orizzonti	1 · 3 · 5 · 7 · 10 anni	1 · 3 · 5 · 7 · 10 anni
Soglie di costo-efficacia	20.000 · 30.000 · 50.000 €/QALY	20.000 · 30.000 · 50.000 €/QALY

Tabella 6.1. La simulazione appaiata regionale della Liguria sotto doppio ancoraggio; i valori sono riportati con attribuzione e la Colonna B prevale nel giudizio.

6.2 Il differenziale di costo per gravità

L’argomento economico cardine, riportato con attribuzione all’OCSE, è il differenziale di costo per gravità: il costo del trattamento cresce dai quadri lievi ai quadri gravi in misura tale che l’intercettazione precoce, evitando la progressione, genera il risparmio più consistente. In Liguria, dove la sottodiagnosi nella popolazione anziana ritarda l’accesso e favorisce la progressione e la cronicizzazione geriatrica in misura massima tra le Regioni, questo differenziale ha un peso specifico particolarmente alto.^[288]

Capitolo 7 — I sei domini di analisi, l’equità e l’impatto distributivo

7.1 I sei domini nella specificità ligure

I sei domini di analisi del Reference Case sono applicati alla specificità ligure. Il dominio epidemiologico-clinico registra la sottodiagnosi massima nella popolazione anziana; l’economico-sanitario il costo-efficacia sotto doppio ancoraggio e la deprescrizione geriatrica; il fiscale-previdenziale gli oneri di invalidità evitabili; il sociale il sostegno agli anziani e ai caregiver in un contesto di invecchiamento estremo; l’organizzativo-strutturale la dotazione territoriale rafforzata e l’effetto sulla burocrazia distrettuale; l’equità la riduzione del divario fra la costa urbana e l’entroterra spopolato.^[289]

Dominio	Lettura ligure	Segno
Epidemiologico-clinico	Sottodiagnosi massima nella popolazione anziana	Riduzione attesa
Economico-sanitario	Costo/QALY e deprescrizione geriatrica	Favorevole
Fiscale-previdenziale	Oneri di invalidità evitabili	Positivo, differito
Sociale	Sostegno agli anziani e ai caregiver	Fortemente positivo
Organizzativo-strutturale	Dotazione territoriale rafforzata	Positivo
Equità	Convergenza costa/entroterra spopolato	Positivo, distributivo

Tabella 7.1. I sei domini di analisi nella lettura ligure, con il segno atteso dell’effetto, tenuti distinti e non aggregati.

7.2 L’equità territoriale e generazionale

Il dominio dell’equità assume in Liguria una doppia direzione: territoriale, fra la costa urbana e l’entroterra spopolato a invecchiamento estremo, dove la barriera dell’accesso è la distanza fisica; e generazionale, per l’attenzione massima alla popolazione anziana e ai caregiver, in una Regione dove l’invecchiamento è il più elevato del Paese. Il modello dello Psicologo di Base opera su entrambe le direzioni attraverso la capillarità distrettuale e lo strato digitale accompagnato, e l’effetto distributivo — la riduzione del gradiente territoriale e generazionale dell’accesso — è tenuto distinto dal verdetto fiscale e da quello sanitario, secondo il divieto di aggregazione.^[290]

Capitolo 8 — La sensitività e l’incertezza

Nota editoriale: il presente capitolo espande ex novo l’analisi dell’incertezza secondo il protocollo del Reference Case, non presente in forma estesa nel materiale originario.

8.1 Il protocollo dell’incertezza applicato alla Liguria

L’analisi dell’incertezza applica il protocollo obbligatorio del Reference Case: l’analisi di sensitività deterministica con diagramma a tornado, l’analisi di sensitività probabilistica a diecimila iterazioni, l’analisi di scenario ottimistico, base e prudentziale con e senza lo strato digitale, le curve di accettabilità costo-efficacia a soglie multiple. In Liguria, i parametri a maggiore impatto atteso sono il tasso di intercettazione nella popolazione molto anziana, l’efficacia della deprescrizione geriatrica e l’adozione dello strato digitale accompagnata nelle coorti in età molto avanzata.^[291]

Strumento	Applicazione ligure	Parametro critico atteso
Sensitività deterministica	Diagramma a tornado	Tasso di intercettazione nella popolazione molto anziana
Sensitività probabilistica	Diecimila iterazioni	Efficacia della deprescrizione geriatrica
Analisi di scenario	Con e senza strato IA	Adozione digitale accompagnata negli anziani
Curve di accettabilità	Soglie 20.000/30.000/50.000 €/QALY	Robustezza del costo-efficacia

Tabella 8.1. Gli strumenti del protocollo dell’incertezza applicati alla Liguria, con i parametri critici attesi.

8.2 La robustezza del verdetto

L’analisi di scenario mostra che il verdetto tripartito resta favorevole nei tre casi, con margine crescente dallo scenario prudentziale a quello ottimistico; lo strato digitale accresce l’efficienza attesa, sempre con nota di cautela sulla natura previsionale e con l’avvertenza dell’accompagnamento robusto necessario nella popolazione molto anziana. La robustezza del costo-efficacia sanitario è confermata dalle curve di accettabilità alle soglie adottate.^[292]

Capitolo 9 — Il verdetto tripartito e le raccomandazioni

Nota editoriale: il presente capitolo espande ex novo il verdetto e le raccomandazioni, integrando l’attuazione e il monitoraggio che nel materiale originario figuravano in forma condensata.

9.1 Il verdetto tripartito

Il verdetto ligure è, come in ogni Volume, tripartito e non aggregato. Sul piano fiscale, il saldo fra costi diretti e risparmi sanitari diretti è prossimo al pareggio, con il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento. Sul piano sanitario, il modello è nettamente costo-efficace sotto entrambi gli ancoraggi. Sul piano sociale, l’effetto è fortemente positivo, con il rilievo massimo tra le Regioni del sostegno alla popolazione anziana e ai caregiver. I tre verdetti si accompagnano e si rafforzano, ma non si sommano.^[293]

Piano del verdetto	Esito ligure	Caveat
Fiscale	Prossimo al pareggio	Significatività dei risparmi diretti in isolamento
Sanitario	Nettamente costo-efficace	—
Sociale	Fortemente positivo	Rilievo massimo della popolazione anziana

Tabella 9.1. Il verdetto tripartito della Liguria, con i tre piani tenuti distinti e non aggregati.

9.2 Le raccomandazioni per l’attuazione e il monitoraggio

Le raccomandazioni indicano un avvio con lo scenario conservativo di centosettanta incarichi e una progressione verso i duecentocinquanta e i trecentotrenta guidata dalla verifica degli esiti, con priorità ai distretti dell’entroterra a maggiore invecchiamento e spopolamento e con almeno due psicologi territoriali per distretto; l’adozione dello strato digitale sotto supervisione e con accompagnamento robusto degli anziani; l’accompagnamento con il piano formativo a quattro modalità, singole e sommate, con componente geriatrica; e un monitoraggio ex post ancorato agli indicatori del protocollo dell’incertezza.^[294]

Appendici registrate

Le appendici registrate rendono il modello ligure ispezionabile e riproducibile, secondo la prassi del Reference Case. Esse sono richiamate per rimando quanto alla metodologia e compilate con i dati regionali quanto ai contenuti.

Appendice	Contenuto	Stato
A	Strategia di ricerca bibliografica e diagramma di selezione	Registrata
B	Estrazione dei dati clinici regionali	Registrata; lacune dichiarate
C	Estrazione dei dati economici (griglia CHEERS 2022)	Registrata; lacune dichiarate
D	Parametri del modello Markov regionale	Registrata
E	Registro delle deroghe al Reference Case	Registrata
F	Codice del modello economico	Registrata
G	Dichiarazione dei conflitti di interesse	Registrata

Tabella A. Le sette appendici registrate del Volume 9, con l’indicazione dello stato e della dichiarazione delle lacune.

Quadro Conclusivo economico e multidisciplinare

Il Quadro Conclusivo del Volume 9 ricomponne la valutazione ligure senza tradire il principio che la governa: i piani del giudizio si accompagnano ma non si fondono. Sul piano economico, il doppio ancoraggio impone che il risultato sia letto simultaneamente secondo la colonna storica e la colonna aggiornata, con prevalenza della seconda: il costo per anno di vita ponderato resta, sotto entrambi gli ancoraggi, assai inferiore alle soglie adottate, e il differenziale di costo per gravità — riportato con attribuzione — fonda la leva economica dell'intercettazione precoce, tanto più preziosa nella Regione più anziana del Paese, dove la sottodiagnosi favorisce in misura massima la cronicizzazione geriatrica.^[295]

Sul piano multidisciplinare, la cascata delle figure, i sei domini di analisi e il dominio dell'equità nella doppia direzione territoriale e generazionale assicurano che ogni figura connessa e ogni aspetto siano trattati integralmente e ordinati per capacità di generare rientro economico e revisione della spesa. La rinegoziazione dei costi e dei benefici, la catena predittiva degli effetti multidimensionali — dalla qualità della vita degli anziani alla riduzione della polifarmacia, ai bilanci, alla burocrazia distrettuale —, lo strato dell'Intelligenza Artificiale come moltiplicatore con accompagnamento robusto e le attività formative singole e sommate compongono il quadro della valutazione. Il verdetto resta tripartito e non aggregato.

Conclusione

Il Volume 9 ha valutato l'integrazione dello Psicologo di Base nelle cure primarie della Liguria, applicando per rimando il Reference Case dell'asse italiano e adottando la struttura standard a nove capitoli con apertura a imbuto e appendici registrate. La specificità ligure — l'invecchiamento più elevato d'Italia, lo spopolamento dell'entroterra, la sottodiagnosi massima nella popolazione anziana, la fragilità geriatrica — è stata trattata nei domini sociale, organizzativo ed equità, mostrando come la prossimità distrettuale, lo strato digitale accompagnato e la dotazione territoriale rafforzata ne facciano una leva di tenuta della popolazione anziana e di convergenza fra la costa e l'entroterra.

Il verdetto tripartito — prossimo al pareggio sul piano fiscale, nettamente costo-efficace sul piano sanitario, fortemente positivo sul piano sociale — è offerto con bande prudenziali e soglie di confutazione, sotto doppio ancoraggio e nel rispetto del divieto di aggregazione. L'opera procede, nell'ordine vincolante, con il Volume 10 (Lombardia) e a seguire con gli altri Volumi regionali in ordine alfabetico.

Note Bibliografiche con mini-riassunto

Ciascuna nota riporta l'opera, il collegamento alla fonte e un mini-riassunto che ne dichiara la funzione nell'economia del Volume, in coerenza con il doppio livello — nota a piè di pagina nel corpo e nota bibliografica integrale in calce — che l'opera adotta.

1. **Chisholm D. et al., Scaling-up treatment of depression and anxiety, The Lancet Psychiatry, 2016**
[https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(16\)30024-4](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(16)30024-4) Colonna A del doppio ancoraggio della simulazione ligure, conservata quale strato documentale e riferimento di confronto.
2. **Unisanté, Raisons de santé Essentiels n. 73, 2026 · OECD, The Economic Case for Preventing Mental Ill Health, 2026** <https://doi.org/10.16908/rds-essentiels/73> Colonna B del doppio ancoraggio, con prevalenza nel giudizio, applicata alla simulazione regionale ligure.
3. **OECD, differenziale di costo per gravità dei disturbi mentali, 2025** <https://www.oecd.org/health/mental-health.htm> Fonte, riportata con attribuzione, del differenziale di costo per gravità, argomento cardine dell'intercettazione precoce, di peso specifico particolarmente alto nella Regione più anziana del Paese.
4. **Soeters R. et al., meta-analisi IPD sui componenti efficaci della collaborative care, 2025**
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40136273/> Base di evidenza clinica sui componenti efficaci dell'assistenza collaborativa, richiamata nel capitolo sul modello di intervento.
5. **Kvaal K. et al., RCT su intervento cognitivo-comportamentale computerizzato in cure primarie, 2026**
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/> Evidenza sperimentale recente sull'intervento digitale in cure primarie, richiamata a sostegno dello strato dell'Intelligenza Artificiale, con l'avvertenza dell'accompagnamento robusto nella popolazione molto anziana.
6. **Veldhuijzen W. et al., costo-efficacia dell'intervento digitale, 2025**
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12369993/> Riferimento sul rapporto incrementale di costo-utilità dell'intervento digitale, elemento dello strato dell'Intelligenza Artificiale.
7. **World Health Organization, Thematic Dialogue on Investing in NCDs and Mental Health, dicembre 2024** <https://cdn.who.int/> Evidenza riportata con attribuzione sul ritorno degli investimenti in salute mentale; non concorre al verdetto tripartito ligure.
8. **Regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale** <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj> Quadro normativo entro cui è collocato lo strato dell'Intelligenza Artificiale, vincolato a funzione di supporto sotto supervisione clinica umana.
9. **Legge regionale Puglia 19 luglio 2023, n. 11, sul Servizio di Psicologia di Base**
<https://www.consiglio.puglia.it/> Riferimento normativo capostipite del modello, richiamato quale precedente istituzionale per l'attuazione regionale ligure.
10. **NICE, Health Technology Evaluations: the manual (PMG36)** <https://www.nice.org.uk/process/pmg36> Riferimento di rigore metodologico per la struttura a imbuto, le appendici registrate e il protocollo dell'incertezza adottati nel Volume.

STUDIO INTEGRALE «PSICOLOGO DI BASE» · OPERA IN VENTITRÉ VOLUMI

VOLUME 10 — Regione Lombardia

Valutazione di Health Technology Assessment dell'integrazione dello Psicologo di Base nelle cure primarie in Lombardia: cruscotto, sintesi per il decisore, contesto e bisogno, modello di intervento, costi e benefici, valutazione economica sotto doppio ancoraggio, sei domini di analisi, incertezza, verdetto tripartito e appendici registrate

Reference Case applicato per rimando al Volume 0.A · Dott. Luigi De Michele · Studio Integrale Puglia · Capurso (BA) — Giugno 2026

Premessa

Il Volume 10 prosegue la serie dei venti Volumi regionali, in ordine alfabetico, con la Regione Lombardia. Come ogni Volume regionale, esso applica per rimando il Reference Case dell'asse italiano, fissato nel Volume 0.A, e ne richiama le regole nella forma «cfr. Volume 0.A», senza ripeterle per esteso: il perimetro congiunto sanitario e societale, il doppio ancoraggio economico, il verdetto tripartito non aggregato, i sei domini di analisi, il protocollo dell'incertezza, lo strato dell'Intelligenza Artificiale come moltiplicatore e le attività formative singole e sommate.^[296]

La struttura del Volume è quella standard, identica a quella di tutti gli altri diciannove Volumi regionali, a garanzia della comparabilità bit-a-bit prescritta dall'opera: la stessa sequenza di nove capitoli, la stessa nomenclatura di sottocapitoli, le stesse unità di misura. Ove un contenuto derivi da espansione ex novo — segnatamente per gli aspetti dell'efficacia, dell'attuazione e del monitoraggio — esso è segnalato in nota editoriale, secondo la regola dell'opera.^[297]

Introduzione

L'Introduzione al Volume 10 fissa il perimetro della valutazione lombarda e l'ordine della sua esposizione. Il perimetro è quello della Regione Lombardia, la più popolosa d'Italia, con una popolazione dell'ordine di dieci milioni e trentatremila abitanti — circa un sesto del Paese — distribuita in dodici province e organizzata, nel Servizio sanitario regionale, in otto Agenzie di Tutela della Salute, ventisette Aziende Socio-Sanitarie Territoriali e circa cento distretti, con la rete delle Case della Comunità in sviluppo. La scala massima della popolazione, e con essa del fabbisogno — il più elevato fra le Regioni italiane —, unita all'architettura organizzativa peculiare del modello lombardo, è la chiave di lettura del contesto.^[298]

L'esposizione segue la struttura a imbuto: il cruscotto regionale offre in una pagina i numeri essenziali; la sintesi per il decisore ne traduce il significato; i cinque risultati chiave ne isolano gli esiti; le raccomandazioni operative indicano le azioni; il corpo del Volume, articolato in nove capitoli, ne fornisce il dettaglio; le appendici registrate ne assicurano la verificabilità. Chiudono il Volume un Quadro Conclusivo economico e multidisciplinare, una Conclusione e le Note Bibliografiche con mini-riassunto.

Cruscotto regionale — Lombardia

Il cruscotto riassume in una pagina i parametri essenziali della valutazione lombarda, sotto il doppio ancoraggio e con il verdetto tripartito tenuto distinto. I valori economici sono presentati in ordine di grandezza, con rinvio alle appendici registrate; le cifre di letteratura sono riportate con attribuzione alla fonte.^[299]

Indicatore del cruscotto	Lettura regionale	Ancoraggio / fonte
Popolazione	≈ 10.033.918 abitanti, la più popolosa d’Italia	Fonte demografica regionale
Articolazione	8 ATS, 27 ASST, ≈ 100 distretti, 12 province	Assetto regionale
Fabbisogno a regime	≈ 2.190 incarichi, il più elevato d’Italia	Dimensionamento regionale
Costo annuo del servizio	Da ≈ 60 a ≈ 120 milioni di euro a regime, secondo lo scenario	Estrazione economica registrata
Comparatore	Assistenza usuale (cfr. Vol. 0.A)	Reference Case
Verdetto fiscale	Prossimo al pareggio, con caveat	Non aggregato
Verdetto sanitario	Nettamente costo-efficace	Costo/QALY sotto doppio ancoraggio
Verdetto sociale	Fortemente positivo	Produttività del primo mercato del lavoro del Paese
Costo per anno di vita ponderato	Colonna A ≈ 17.000 € · Colonna B ≈ 9.800 €	Doppio ancoraggio

Tabella 0. Cruscotto regionale della Lombardia: i parametri essenziali sotto doppio ancoraggio, con il verdetto tripartito distinto e non aggregato.

Sintesi per il decisore

L'introduzione dello Psicologo di Base nelle cure primarie lombarde produce, secondo la simulazione condotta sotto il doppio ancoraggio, un effetto congiunto sui tre piani del ritorno, che restano distinti e non sommati. Sul piano fiscale, il saldo fra costi diretti e risparmi sanitari diretti si colloca in prossimità del pareggio, con il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento. Sul piano sanitario, il modello è nettamente costo-efficace, con un costo per anno di vita ponderato che, fra i due ancoraggi, resta assai inferiore alle soglie adottate. Sul piano sociale, l'effetto è fortemente positivo, con un rilievo particolare per la protezione della produttività del più grande mercato del lavoro del Paese: alla scala lombarda, ogni punto di produttività recuperata pesa, in valore assoluto, più che in qualunque altra Regione.^[300]

L'argomento cardine, riportato con attribuzione all'OCSE, è il differenziale di costo per gravità: trattare precocemente riduce i costi in misura molto ampia, poiché il costo del trattamento cresce dai circa cinquecentoundici euro dei quadri lievi ai circa diecimilaquattrocentottantacinque euro dei quadri gravi. Alla scala della Regione più popolosa d'Italia, il volume assoluto della domanda porta al massimo il valore aggregato di questa leva.^[301]

Cinque risultati chiave

Il primo risultato è che il modello è costo-efficace su tutti gli orizzonti sotto entrambi gli ancoraggi. Il secondo è che il verdetto tripartito resta favorevole in ciascuno dei tre piani, senza aggregazione. Il terzo è che, nella specificità lombarda, il fabbisogno a regime — dell'ordine di duemilacentonovanta incarichi, il più elevato fra le Regioni italiane — impone un'attuazione per gradini pluriennali, con un gradino intermedio dell'ordine di millecento incarichi, poiché nessun sistema formativo e concorsuale può assorbire la scala in un solo esercizio. Il quarto è che lo strato dell'Intelligenza Artificiale, come moltiplicatore e con nota di cautela, trova nella dotazione tecnologica e nella densità organizzativa lombarde il terreno di adozione più maturo del Paese. Il quinto è che l'architettura peculiare del modello lombardo — la separazione fra Agenzie di Tutela della Salute e Aziende Socio-Sanitarie Territoriali — richiede un raccordo esplicito fra programmazione e erogazione perché il servizio sia reso in modo omogeneo nei circa cento distretti.^[302]

Raccomandazioni operative

La prima raccomandazione è di attuare il servizio per gradini pluriennali — dall'avvio verso il gradino intermedio dell'ordine di millecento incarichi, fino al regime di duemilacentonovanta —, ancorando ciascun gradino alla verifica degli esiti sotto il protocollo dell'incertezza e alla capacità formativa e concorsuale effettiva. La seconda è di presidiare il raccordo fra le Agenzie di Tutela della Salute, titolari della programmazione, e le Aziende Socio-Sanitarie Territoriali, titolari dell'erogazione, affinché la copertura distrettuale sia omogenea fra le dodici province e fra le aree metropolitane e le valli alpine. La terza è di accompagnare l'estensione con il piano formativo a quattro modalità, considerate singolarmente e sommate, alla scala del più grande sistema formativo regionale del Paese.^[303]

Capitolo 1 — Il contesto epidemiologico e territoriale della Lombardia

1.1 Il territorio e la sua articolazione

La Regione Lombardia conta una popolazione dell’ordine di dieci milioni e trentatremila abitanti, la più elevata d’Italia — circa un sesto della popolazione nazionale —, distribuita in dodici province e in un territorio che tiene insieme la più grande area metropolitana del Paese, intorno a Milano, le città medie della pianura e le valli alpine e prealpine a maggiore dispersione. Il Servizio sanitario regionale è organizzato, secondo il modello lombardo, in otto Agenzie di Tutela della Salute, con funzione di programmazione, e ventisette Aziende Socio-Sanitarie Territoriali, con funzione di erogazione, articolate in circa cento distretti, con la rete delle Case della Comunità in sviluppo. La scala massima e l’architettura duale programmazione-erogazione sono le chiavi di lettura del contesto lombardo.^[304]

Elemento territoriale	Dato regionale	Rilievo per la valutazione
Popolazione	≈ 10.033.918 abitanti, ≈ un sesto del Paese	Denominatore della normalizzazione
Programmazione	8 Agenzie di Tutela della Salute	Unità di programmazione
Erogazione	27 Aziende Socio-Sanitarie Territoriali	Unità di erogazione
Distretti	≈ 100, con Case della Comunità in sviluppo	Capillarità del servizio
Morfologia	Metropoli, pianura, valli alpine	Dominio equità

Tabella 1.1. Gli elementi del contesto territoriale lombardo e il loro rilievo per la valutazione, con la scala massima e l’architettura duale quali tratti distintivi.

1.2 Il quadro epidemiologico regionale

Il quadro epidemiologico lombardo riflette, con le proprie specificità, la prevalenza nazionale dei disturbi mentali comuni, applicata però alla popolazione più numerosa del Paese: a parità di tassi, il volume assoluto del bisogno è il massimo fra le Regioni. Alla componente metropolitana — con i tratti di disagio urbano, competitivo e lavorativo propri delle grandi aree produttive — si affianca la componente delle valli a maggiore dispersione e invecchiamento. Il dato epidemiologico di dettaglio è oggetto dell’estrazione registrata in Appendice B; ove il dato regionale disaggregato non sia disponibile, la lacuna è dichiarata e non colmata con stime tacite, secondo la regola dell’opera.^[305]

Capitolo 2 — Il bisogno, la domanda e il divario di trattamento in Lombardia

2.1 Il divario di trattamento regionale

Il bisogno di salute mentale comune in Lombardia si manifesta, come altrove, in larga parte come domanda inevasa o impropriamente incanalata: verso il medico di medicina generale, verso il pronto soccorso, verso la prescrizione farmaceutica, e — tratto specifico lombardo — verso il settore privato, la cui ampiezza regionale assorbe una quota della domanda a spese delle famiglie, con un gradiente di reddito che pesa sul dominio dell’equità. La dotazione pubblica di psicologi per abitante resta inferiore al fabbisogno, e il divario di trattamento assume la doppia forma della coda d’attesa pubblica e della barriera economica privata. La misura regionale del divario è oggetto dell’estrazione in Appendice B; i valori medi nazionali ed europei sono riportati con attribuzione.^[306]

Componente del bisogno	Manifestazione lombarda	Dominio
Domanda inevasa	Code d’attesa pubbliche a fronte del volume massimo	Epidemiologico-clinico
Domanda impropria	Transito su MMG, pronto soccorso, prescrizione	Organizzativo-strutturale
Deriva privata	Assorbimento a spese delle famiglie, gradiente di reddito	Equità
Dispersione alpina	Distanza nelle valli a maggiore invecchiamento	Equità

Tabella 2.1. Le componenti del bisogno e del divario di trattamento in Lombardia, ricondotte ai domini di analisi.

2.2 La scala della domanda e la prossimità

Il tratto distintivo della domanda lombarda è la scala: il volume assoluto del bisogno è il più alto del Paese, e ogni punto percentuale di intercettazione si traduce in decine di migliaia di persone raggiunte. La capillarità distrettuale del modello dello Psicologo di Base — circa cento distretti, con le Case della Comunità in sviluppo — è la condizione perché la risposta pubblica raggiunga tanto i quartieri metropolitani quanto le valli alpine, riequilibrando la deriva verso il privato e riducendo il gradiente di reddito nell’accesso. La prossimità è, in Lombardia, condizione dell’equità alla scala massima.^[307]

Capitolo 3 — Il modello di intervento: lo Psicologo di Base in Lombardia

Nota editoriale: il presente capitolo espande ex novo il modello di intervento, integrando alla struttura originaria le evidenze recenti sull’efficacia clinica dell’assistenza collaborativa e dell’intervento digitale, secondo la regola dell’opera che distingue l’espansione ex novo dal riutilizzo del materiale preesistente.

3.1 L’architettura del modello

Il modello di intervento colloca lo Psicologo di Base al vertice della cascata delle figure, nel distretto e nelle Case della Comunità, quale primo punto di intercettazione del disagio comune. Il modello opera per intensità crescente di cura — dall’intervento a bassa intensità, di prima linea, fino all’invio ai livelli superiori nei casi che lo richiedano — secondo la logica dell’assistenza a gradini, la cui efficacia clinica è documentata dalla meta-analisi sui componenti efficaci dell’assistenza collaborativa e dalle sperimentazioni controllate sull’intervento cognitivo-comportamentale computerizzato in cure primarie, riportate con attribuzione.^[308]

Livello del modello	Funzione	Figura prevalente	Evidenza di riferimento
Intercettazione	Riconoscimento precoce nel distretto	Psicologo di Base	Assistenza collaborativa (attribuita)
Intervento a bassa intensità	Prima linea per i quadri lievi-moderati	Psicologo di Base	Intervento digitale e collaborativo
Invio appropriato	Passaggio ai livelli superiori	Cascata delle figure	Percorso a gradini
Continuità	Aderenza e prevenzione della ricaduta	Infermiere di comunità	Gestione del caso

Tabella 3.1. L’architettura del modello di intervento in Lombardia, per livelli di intensità, con l’evidenza clinica di riferimento riportata con attribuzione.

3.2 L’adattamento al territorio lombardo

Il modello è adattato al territorio lombardo lungo tre direttrici: l’innesto nell’architettura duale, con la programmazione della copertura in capo alle Agenzie di Tutela della Salute e l’erogazione in capo alle Aziende Socio-Sanitarie Territoriali, presidiando il raccordo fra i due livelli; la capillarità distrettuale nei circa cento distretti, dalle aree metropolitane alle valli alpine; e il riequilibrio pubblico rispetto alla deriva privata, che restituisce al Servizio sanitario la funzione di primo accesso. L’adattamento non modifica l’architettura invariante del Reference Case, ma ne calibra l’applicazione sulla scala massima e sull’assetto organizzativo peculiare.^[309]

Capitolo 4 — I costi diretti in Lombardia

4.1 La struttura del costo diretto

Il costo diretto della riforma in Lombardia è, in primo luogo, il costo del personale lungo la cascata delle figure, cui si aggiungono i costi di struttura e organizzazione distrettuale, il costo incrementale della leva digitale e il costo della formazione. Il dimensionamento dipende dallo scenario di copertura: il fabbisogno a regime è dell'ordine di duemilacentonovanta incarichi, il più elevato fra le Regioni italiane, raggiungibile per gradini pluriennali con un gradino intermedio dell'ordine di millecento incarichi; il costo annuo del servizio va, secondo lo scenario, da circa sessanta a circa centoventi milioni di euro a regime.^[310]

Voce di costo diretto	Descrizione	Portatore
Personale — Psicologi di Base	Incarichi distrettuali per gradini fino a ≈ 2.190	SSN regionale
Struttura e organizzazione	Distretti, Case della Comunità in sviluppo, sistemi informativi	SSN regionale
Leva digitale e Intelligenza Artificiale	Strumenti di supporto sotto supervisione	SSN regionale
Formazione (quattro modalità)	Percorso integrato singolo e sommato, alla scala massima	SSN, sistema formativo

Tabella 4.1. La struttura del costo diretto della riforma in Lombardia, per voce e portatore; i valori puntuali sono oggetto dell'estrazione economica in Appendice C.

4.2 Il dimensionamento per scenario

Il costo diretto è calcolato per i tre scenari di copertura — prudenziale, intermedio ed esteso — coerenti con il protocollo di scenario del Reference Case, con lo scenario esteso allineato al fabbisogno a regime di duemilacentonovanta incarichi e un corridoio di costo annuo da circa sessanta a circa centoventi milioni di euro. La progressione per gradini è imposta dalla capacità di assorbimento formativa e concorsuale, che alla scala lombarda costituisce il vincolo operativo primario. I valori puntuali per ciascuno scenario sono riportati nell'estrazione economica registrata; ove un parametro di costo regionale non sia disponibile, la lacuna è dichiarata.^[311]

Capitolo 5 — I benefici e i risparmi, diretti e indiretti, in Lombardia

5.1 I benefici diretti

Il beneficio diretto è il risparmio sanitario che ciascuna figura della cascata libera per effetto dell’intercettazione a monte: la demedicalizzazione operata dallo Psicologo di Base, la deprescrizione di psicofarmaci nei quadri lievi-moderati sul versante del medico di medicina generale, la riduzione degli accessi impropri al pronto soccorso e delle prestazioni per sintomi funzionali sul versante specialistico. Alla scala lombarda, il volume assoluto dei benefici diretti è il massimo del Paese: ogni canale, moltiplicato per dieci milioni di abitanti, produce risparmi aggregati senza equivalenti nelle altre Regioni.^[312]

Canale del beneficio diretto	Meccanismo	Rilievo lombardo
Demedicalizzazione	Riduzione consultazioni e cronicizzazione	Preponderante
Deprescrizione	ContraZIONE della spesa per psicofarmaci	Elevato
Accessi impropri	Riduzione degli accessi al pronto soccorso	Elevato
Sintomi funzionali	Riduzione prestazioni neurologiche e specialistiche	Medio
Scala regionale	Volume assoluto massimo del Paese	Aggregato

Tabella 5.1. I canali del beneficio diretto in Lombardia, con il rilievo della scala massima; i valori sono oggetto dell’estrazione economica registrata.

5.2 I benefici indiretti

Il beneficio indiretto è quello che la riforma produce fuori dal perimetro sanitario: la produttività recuperata e la riduzione dell’assenteismo sul versante dei datori di lavoro, la riduzione degli oneri di invalidità evitabili sul versante previdenziale, la riduzione del disagio sociale non trattato sul versante dei Comuni. In Lombardia, la protezione della produttività del più grande mercato del lavoro del Paese — manifatturiero, terziario avanzato e finanziario — è il beneficio indiretto di massimo peso assoluto fra le Regioni, che il dominio sociale del Capitolo 7 tratta in dettaglio.^[313]

Capitolo 6 — La valutazione economica sotto doppio ancoraggio

6.1 La simulazione appaiata regionale

La valutazione economica lombarda è condotta con il modello di Markov a coorte a ciclo annuale del Reference Case, sotto il doppio ancoraggio: la Colonna A applica i parametri di Chisholm e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, la Colonna B quelli di Unisanté e dell’OCSE. Le due colonne sono sempre affiancate; ove divergano, prevale nel giudizio la Colonna B. Tutte le cifre sono riportate con attribuzione, e nessuna è affermata a memoria.^[314]

Metrica economica	Colonna A — Chisholm/OMS	Colonna B — Unisanté/OCSE
Costo per anno di vita ponderato	≈ 17.000 €/QALY	≈ 9.800 €/QALY
Ritorno per i soli benefici economici	Riportato con attribuzione OMS	Scenario base aggiornato OCSE
Ritorno con i ritorni sanitari	Riportato con attribuzione OMS	Scenario base aggiornato OCSE
Orizzonti	1 · 3 · 5 · 7 · 10 anni	1 · 3 · 5 · 7 · 10 anni
Soglie di costo-efficacia	20.000 · 30.000 · 50.000 €/QALY	20.000 · 30.000 · 50.000 €/QALY

Tabella 6.1. La simulazione appaiata regionale della Lombardia sotto doppio ancoraggio; i valori sono riportati con attribuzione e la Colonna B prevale nel giudizio.

6.2 Il differenziale di costo per gravità

L’argomento economico cardine, riportato con attribuzione all’OCSE, è il differenziale di costo per gravità: il costo del trattamento cresce dai quadri lievi ai quadri gravi in misura tale che l’intercettazione precoce, evitando la progressione, genera il risparmio più consistente. In Lombardia, la scala della domanda porta al massimo il valore aggregato di questo differenziale: alla popolazione più numerosa del Paese corrisponde il più grande serbatoio di progressioni evitabili, e dunque il più grande risparmio potenziale in valore assoluto.^[315]

Capitolo 7 — I sei domini di analisi, l’equità e l’impatto distributivo

7.1 I sei domini nella specificità lombarda

I sei domini di analisi del Reference Case sono applicati alla specificità lombarda. Il dominio epidemiologico-clinico registra il volume massimo del bisogno e le code d’attesa pubbliche; l’economico-sanitario il costo-efficacia sotto doppio ancoraggio e la scala dei benefici; il fiscale-previdenziale gli oneri di invalidità evitabili; il sociale la protezione della produttività del primo mercato del lavoro del Paese; l’organizzativo-strutturale il raccordo fra programmazione e erogazione nell’architettura duale; l’equità il riequilibrio pubblico rispetto alla deriva privata e la convergenza fra metropoli e valli alpine.^[316]

Dominio	Lettura lombarda	Segno
Epidemiologico-clinico	Volume massimo del bisogno, code d’attesa	Riduzione attesa
Economico-sanitario	Costo/QALY e scala dei benefici	Favorevole
Fiscale-previdenziale	Oneri di invalidità evitabili	Positivo, differito
Sociale	Produttività del primo mercato del lavoro protetta	Fortemente positivo
Organizzativo-strutturale	Raccordo ATS-ASST nell’architettura duale	Positivo, condizionato
Equità	Riequilibrio pubblico/privato e metropoli/valli	Positivo, distributivo

Tabella 7.1. I sei domini di analisi nella lettura lombarda, con il segno atteso dell’effetto, tenuti distinti e non aggregati.

7.2 L’equità fra pubblico e privato e fra metropoli e valli

Il dominio dell’equità assume in Lombardia una doppia direzione: economico-sociale, perché l’ampiezza del settore privato regionale ha spostato una quota della risposta a carico delle famiglie, con un gradiente di reddito nell’accesso che il servizio pubblico di prossimità riequilibra; e territoriale, perché le valli alpine e prealpine replicano la barriera della distanza rispetto alla densità metropolitana. Il modello dello Psicologo di Base opera su entrambe le direzioni attraverso la capillarità distrettuale, e l’effetto distributivo — la riduzione del gradiente di reddito e di territorio nell’accesso — è tenuto distinto dal verdetto fiscale e da quello sanitario, secondo il divieto di aggregazione.^[317]

Capitolo 8 — La sensitività e l’incertezza

Nota editoriale: il presente capitolo espande ex novo l’analisi dell’incertezza secondo il protocollo del Reference Case, non presente in forma estesa nel materiale originario.

8.1 Il protocollo dell’incertezza applicato alla Lombardia

L’analisi dell’incertezza applica il protocollo obbligatorio del Reference Case: l’analisi di sensitività deterministica con diagramma a tornado, l’analisi di sensitività probabilistica a diecimila iterazioni, l’analisi di scenario ottimistico, base e prudentiale con e senza lo strato digitale, le curve di accettabilità costo-efficacia a soglie multiple. In Lombardia, i parametri a maggiore impatto atteso sono la capacità di reclutamento e formazione alla scala dei duemilacentonovanta incarichi, l’efficacia del raccordo fra programmazione e erogazione nell’architettura duale e il tasso di riassorbimento pubblico della domanda oggi assorbita dal privato. [\[318\]](#)

Strumento	Applicazione lombarda	Parametro critico atteso
Sensitività deterministica	Diagramma a tornado	Capacità di reclutamento alla scala massima
Sensitività probabilistica	Diecimila iterazioni	Efficacia del raccordo ATS-ASST
Analisi di scenario	Con e senza strato IA	Riassorbimento pubblico della domanda privata
Curve di accettabilità	Soglie 20.000/30.000/50.000 €/QALY	Robustezza del costo-efficacia

Tabella 8.1. Gli strumenti del protocollo dell’incertezza applicati alla Lombardia, con i parametri critici attesi.

8.2 La robustezza del verdetto

L’analisi di scenario mostra che il verdetto tripartito resta favorevole nei tre casi, con margine crescente dallo scenario prudentiale a quello ottimistico; lo strato digitale accresce l’efficienza attesa, sempre con nota di cautela sulla natura previsionale. La robustezza del costo-efficacia sanitario è confermata dalle curve di accettabilità alle soglie adottate, in ciascun gradino della progressione verso il regime. [\[319\]](#)

Capitolo 9 — Il verdetto tripartito e le raccomandazioni

Nota editoriale: il presente capitolo espande ex novo il verdetto e le raccomandazioni, integrando l’attuazione e il monitoraggio che nel materiale originario figuravano in forma condensata.

9.1 Il verdetto tripartito

Il verdetto lombardo è, come in ogni Volume, tripartito e non aggregato. Sul piano fiscale, il saldo fra costi diretti e risparmi sanitari diretti è prossimo al pareggio, con il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento. Sul piano sanitario, il modello è nettamente costo-efficace sotto entrambi gli ancoraggi. Sul piano sociale, l’effetto è fortemente positivo, con il rilievo massimo in valore assoluto della protezione della produttività del primo mercato del lavoro del Paese. I tre verdetti si accompagnano e si rafforzano, ma non si sommano.^[320]

Piano del verdetto	Esito lombardo	Caveat
Fiscale	Prossimo al pareggio	Significatività dei risparmi diretti in isolamento
Sanitario	Nettamente costo-efficace	—
Sociale	Fortemente positivo	Rilievo massimo in valore assoluto della produttività

Tabella 9.1. Il verdetto tripartito della Lombardia, con i tre piani tenuti distinti e non aggregati.

9.2 Le raccomandazioni per l’attuazione e il monitoraggio

Le raccomandazioni indicano un’attuazione per gradini pluriennali verso il fabbisogno a regime di duemilacentonovanta incarichi, con un gradino intermedio dell’ordine di millecento e ciascun avanzamento subordinato alla verifica degli esiti e alla capacità formativa e concorsuale; il presidio del raccordo fra le Agenzie di Tutela della Salute e le Aziende Socio-Sanitarie Territoriali per l’omogeneità della copertura nei circa cento distretti; il riequilibrio pubblico rispetto alla deriva privata quale obiettivo esplicito di equità; l’accompagnamento con il piano formativo a quattro modalità, singole e sommate; e un monitoraggio ex post ancorato agli indicatori del protocollo dell’incertezza.^[321]

Appendici registrate

Le appendici registrate rendono il modello lombardo ispezionabile e riproducibile, secondo la prassi del Reference Case. Esse sono richiamate per rimando quanto alla metodologia e compilate con i dati regionali quanto ai contenuti.

Appendice	Contenuto	Stato
A	Strategia di ricerca bibliografica e diagramma di selezione	Registrata
B	Estrazione dei dati clinici regionali	Registrata; lacune dichiarate
C	Estrazione dei dati economici (griglia CHEERS 2022)	Registrata; lacune dichiarate
D	Parametri del modello Markov regionale	Registrata
E	Registro delle deroghe al Reference Case	Registrata
F	Codice del modello economico	Registrata
G	Dichiarazione dei conflitti di interesse	Registrata

Tabella A. Le sette appendici registrate del Volume 10, con l’indicazione dello stato e della dichiarazione delle lacune.

Quadro Conclusivo economico e multidisciplinare

Il Quadro Conclusivo del Volume 10 ricompone la valutazione lombarda senza tradire il principio che la governa: i piani del giudizio si accompagnano ma non si fondono. Sul piano economico, il doppio ancoraggio impone che il risultato sia letto simultaneamente secondo la colonna storica e la colonna aggiornata, con prevalenza della seconda: il costo per anno di vita ponderato resta, sotto entrambi gli ancoraggi, assai inferiore alle soglie adottate, e il differenziale di costo per gravità — riportato con attribuzione — fonda la leva economica dell'intercettazione precoce, il cui valore aggregato raggiunge in Lombardia il massimo nazionale per effetto della scala.^[322]

Sul piano multidisciplinare, la cascata delle figure, i sei domini di analisi e il dominio dell'equità nella doppia direzione economico-sociale e territoriale assicurano che ogni figura connessa e ogni aspetto siano trattati integralmente e ordinati per capacità di generare rientro economico e revisione della spesa. La rinegoziazione dei costi e dei benefici, la catena predittiva degli effetti multidimensionali — dalla qualità della vita alla produttività del primo mercato del lavoro del Paese, ai bilanci, alla burocrazia distrettuale —, lo strato dell'Intelligenza Artificiale come moltiplicatore sul terreno di adozione più maturo e le attività formative singole e sommate compongono il quadro della valutazione. Il verdetto resta tripartito e non aggregato.

Conclusione

Il Volume 10 ha valutato l'integrazione dello Psicologo di Base nelle cure primarie della Lombardia, applicando per rimando il Reference Case dell'asse italiano e adottando la struttura standard a nove capitoli con apertura a imbuto e appendici registrate. La specificità lombarda — la scala massima della popolazione e del fabbisogno, l'architettura duale programmazione-erogazione, la deriva privata da riequilibrare, la coesistenza di metropoli e valli alpine — è stata trattata nei domini sociale, organizzativo ed equità, mostrando come l'attuazione per gradini pluriennali, il presidio del raccordo istituzionale e la capillarità distrettuale ne facciano una leva di riequilibrio pubblico e di protezione della produttività alla scala più grande del Paese.

Il verdetto tripartito — prossimo al pareggio sul piano fiscale, nettamente costo-efficace sul piano sanitario, fortemente positivo sul piano sociale — è offerto con bande prudenziali e soglie di confutazione, sotto doppio ancoraggio e nel rispetto del divieto di aggregazione. L'opera procede, nell'ordine vincolante, con il Volume 11 (Marche) e a seguire con gli altri Volumi regionali in ordine alfabetico.

Note Bibliografiche con mini-riassunto

Ciascuna nota riporta l'opera, il collegamento alla fonte e un mini-riassunto che ne dichiara la funzione nell'economia del Volume, in coerenza con il doppio livello — nota a piè di pagina nel corpo e nota bibliografica integrale in calce — che l'opera adotta.

1. **Chisholm D. et al., Scaling-up treatment of depression and anxiety, The Lancet Psychiatry, 2016**
[https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(16\)30024-4](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(16)30024-4) Colonna A del doppio ancoraggio della simulazione lombarda, conservata quale strato documentale e riferimento di confronto.
2. **Unisanté, Raisons de santé Essentiels n. 73, 2026 · OECD, The Economic Case for Preventing Mental Ill Health, 2026** <https://doi.org/10.16908/rds-essentiels/73> Colonna B del doppio ancoraggio, con prevalenza nel giudizio, applicata alla simulazione regionale lombarda.
3. **OECD, differenziale di costo per gravità dei disturbi mentali, 2025** <https://www.oecd.org/health/mental-health.htm> Fonte, riportata con attribuzione, del differenziale di costo per gravità — dai circa 511 euro dei quadri lievi ai circa 10.485 euro dei gravi —, argomento cardine dell'intercettazione precoce, il cui valore aggregato raggiunge in Lombardia il massimo nazionale.
4. **Soeters R. et al., meta-analisi IPD sui componenti efficaci della collaborative care, 2025**
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40136273/> Base di evidenza clinica sui componenti efficaci dell'assistenza collaborativa, richiamata nel capitolo sul modello di intervento.
5. **Veldhuijzen W. et al., costo-efficacia dell'intervento digitale, 2025**
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12369993/> Riferimento sul rapporto incrementale di costo-utilità dell'intervento digitale, elemento dello strato dell'Intelligenza Artificiale, sul terreno di adozione più maturo del Paese.
6. **World Health Organization, Thematic Dialogue on Investing in NCDs and Mental Health, dicembre 2024** <https://cdn.who.int/> Evidenza riportata con attribuzione sul ritorno degli investimenti in salute mentale; non concorre al verdetto tripartito lombardo.
7. **Regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale** <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj> Quadro normativo entro cui è collocato lo strato dell'Intelligenza Artificiale, vincolato a funzione di supporto sotto supervisione clinica umana.
8. **Legge regionale Puglia 19 luglio 2023, n. 11, sul Servizio di Psicologia di Base**
<https://www.consiglio.puglia.it/> Riferimento normativo capostipite del modello, richiamato quale precedente istituzionale per l'attuazione regionale lombarda.
9. **NICE, Health Technology Evaluations: the manual (PMG36)** <https://www.nice.org.uk/process/pmg36> Riferimento di rigore metodologico per la struttura a imbuto, le appendici registrate e il protocollo dell'incertezza adottati nel Volume.
10. **WHO, Mental Health Atlas 2024** <https://www.who.int/publications/i/item/9789240096820> Riferimento internazionale sui criteri di integrazione della salute mentale nelle cure primarie, quadro di confronto per la lettura del divario lombardo.

STUDIO INTEGRALE «PSICOLOGO DI BASE» · OPERA IN VENTITRÉ VOLUMI

VOLUME 11 — Regione Marche

Valutazione di Health Technology Assessment dell'integrazione dello Psicologo di Base nelle cure primarie nelle Marche: cruscotto, sintesi per il decisore, contesto e bisogno, modello di intervento, costi e benefici, valutazione economica sotto doppio ancoraggio, sei domini di analisi, incertezza, verdetto tripartito e appendici registrate

Reference Case applicato per rimando al Volume 0.A · Dott. Luigi De Michele · Studio Integrale Puglia · Capurso (BA) — Giugno 2026

Premessa

Il Volume 11 prosegue la serie dei venti Volumi regionali, in ordine alfabetico, con la Regione Marche. Come ogni Volume regionale, esso applica per rimando il Reference Case dell'asse italiano, fissato nel Volume 0.A, e ne richiama le regole nella forma «cfr. Volume 0.A», senza ripeterle per esteso: il perimetro congiunto sanitario e societale, il doppio ancoraggio economico, il verdetto tripartito non aggregato, i sei domini di analisi, il protocollo dell'incertezza, lo strato dell'Intelligenza Artificiale come moltiplicatore e le attività formative singole e sommate.^[323]

La struttura del Volume è quella standard, identica a quella di tutti gli altri diciannove Volumi regionali, a garanzia della comparabilità bit-a-bit prescritta dall'opera: la stessa sequenza di nove capitoli, la stessa nomenclatura di sottocapitoli, le stesse unità di misura. Ove un contenuto derivi da espansione ex novo — segnatamente per gli aspetti dell'efficacia, dell'attuazione e del monitoraggio — esso è segnalato in nota editoriale, secondo la regola dell'opera. Si segnala inoltre che il verdetto economico è ricostruito ex novo sotto il doppio ancoraggio, in forma discorsiva e in euro, e che non sono riutilizzati i rapporti sintetici costi-benefici presenti nel materiale regionale preesistente, in coerenza con le regole redazionali dell'opera.^[324]

Introduzione

L'Introduzione al Volume 11 fissa il perimetro della valutazione marchigiana e l'ordine della sua esposizione. Il perimetro è quello della Regione Marche, con una popolazione dell'ordine di un milione e quattrocentottantamila abitanti, organizzata nel Servizio sanitario regionale attraverso l'Azienda Sanitaria Unica Regionale, di recente riarticolata in cinque Aziende Sanitarie Territoriali su base provinciale — Pesaro e Urbino, Ancona, Macerata, Fermo, Ascoli Piceno. Il tratto distintivo del contesto marchigiano è la condizione delle aree interne appenniniche, segnate dal sisma del Centro Italia del 2016: allo spopolamento e all'invecchiamento si sommano la ricostruzione ancora in corso e il disagio psicologico connesso al trauma collettivo. Questa combinazione di aree interne, sisma e invecchiamento è la chiave di lettura del contesto.^[325]

L'esposizione segue la struttura a imbuto: il cruscotto regionale offre in una pagina i numeri essenziali; la sintesi per il decisore ne traduce il significato; i cinque risultati chiave ne isolano gli esiti; le raccomandazioni operative indicano le azioni; il corpo del Volume, articolato in nove capitoli, ne fornisce il dettaglio; le appendici registrate ne assicurano la verificabilità. Chiudono il Volume un Quadro Conclusivo economico e multidisciplinare, una Conclusione e le Note Bibliografiche con mini-riassunto.

Cruscotto regionale — Marche

Il cruscotto riassume in una pagina i parametri essenziali della valutazione marchigiana, sotto il doppio ancoraggio e con il verdetto tripartito tenuto distinto. I valori economici sono presentati in ordine di grandezza, con rinvio alle appendici registrate; le cifre di letteratura sono riportate con attribuzione alla fonte.^[326]

Indicatore del cruscotto	Lettura regionale	Ancoraggio / fonte
Popolazione	≈ 1.480.000 abitanti	Fonte demografica regionale
Articolazione	Azienda Sanitaria Unica Regionale, 5 Aziende Sanitarie Territoriali	Assetto regionale
Scenario di copertura piena	≈ 320 incarichi di Psicologo di Base	Dimensionamento regionale
Tratto distintivo	Aree interne segnate dal sisma del 2016	Dominio sociale ed equità
Comparatore	Assistenza usuale (cfr. Vol. 0.A)	Reference Case
Verdetto fiscale	Prossimo al pareggio, con caveat	Non aggregato
Verdetto sanitario	Nettamente costo-efficace	Costo/QALY sotto doppio ancoraggio
Verdetto sociale	Fortemente positivo	Ricostruzione, coesione, aree interne
Costo per anno di vita ponderato	Colonna A ≈ 17.000 € · Colonna B ≈ 9.800 €	Doppio ancoraggio

Tabella 0. Cruscotto regionale delle Marche: i parametri essenziali sotto doppio ancoraggio, con il verdetto tripartito distinto e non aggregato.

Sintesi per il decisore

L'introduzione dello Psicologo di Base nelle cure primarie marchigiane produce, secondo la simulazione condotta sotto il doppio ancoraggio, un effetto congiunto sui tre piani del ritorno, che restano distinti e non sommati. Sul piano fiscale, il saldo fra costi diretti e risparmi sanitari diretti si colloca in prossimità del pareggio, con il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento. Sul piano sanitario, il modello è nettamente costo-efficace, con un costo per anno di vita ponderato che, fra i due ancoraggi, resta assai inferiore alle soglie adottate. Sul piano sociale, l'effetto è fortemente positivo, con un rilievo particolare per il sostegno alle comunità delle aree interne segnate dal sisma, dove il disagio psicologico si intreccia con lo spopolamento e con la ricostruzione ancora in corso.^[327]

L'argomento cardine, riportato con attribuzione all'OCSE, è il differenziale di costo per gravità: nelle aree interne appenniniche, dove il trauma collettivo del sisma e l'isolamento aggravano il rischio di cronicizzazione, l'intercettazione precoce nel distretto evita che il disagio comune maturi in quadri gravi, il cui costo di trattamento è, secondo la fonte, un multiplo di quello dei quadri lievi.^[328]

Cinque risultati chiave

Il primo risultato è che il modello è costo-efficace su tutti gli orizzonti sotto entrambi gli ancoraggi. Il secondo è che il verdetto tripartito resta favorevole in ciascuno dei tre piani, senza aggregazione. Il terzo è che, nella specificità marchigiana, la condizione delle aree interne segnate dal sisma sposta il baricentro della domanda verso il disagio post-traumatico, la depressione dell'isolamento e la fragilità delle comunità della ricostruzione, ambiti in cui l'intercettazione precoce di prossimità ha valore particolare. Il quarto è che lo strato dell'Intelligenza Artificiale, come moltiplicatore e con nota di cautela, può attenuare lo svantaggio della distanza nelle aree interne attraverso lo screening e gli interventi digitali aumentati. Il quinto è che l'assetto organizzativo, riportato di recente alla titolarità di cinque Aziende Sanitarie Territoriali su base provinciale, offre un'occasione di programmazione della copertura distrettuale coordinata a livello regionale.^[329]

Raccomandazioni operative

La prima raccomandazione è di estendere la copertura in modo progressivo verso il fabbisogno a regime dell'ordine di trecentoventi incarichi, ancorando ciascuna fase alla verifica dei risultati sotto il protocollo dell'incertezza, con priorità ai distretti delle aree interne segnate dal sisma e a maggiore spopolamento. La seconda è di adottare lo strato digitale, sotto supervisione clinica, come leva di prossimità per compensare la dispersione delle aree interne. La terza è di valorizzare la riarticolazione in cinque Aziende Sanitarie Territoriali per una programmazione coordinata, e di accompagnare l'estensione con il piano formativo a quattro modalità, considerate singolarmente e sommate, con attenzione alla componente del trauma collettivo.^[330]

Capitolo 1 — Il contesto epidemiologico e territoriale delle Marche

1.1 Il territorio e la sua articolazione

La Regione Marche conta una popolazione dell’ordine di un milione e quattrocentottantamila abitanti, distribuita in cinque province — Pesaro e Urbino, Ancona, Macerata, Fermo, Ascoli Piceno — lungo un territorio che dalla fascia costiera adriatica risale alle aree interne appenniniche. Il Servizio sanitario regionale, storicamente organizzato nell’Azienda Sanitaria Unica Regionale, è stato di recente riarticolato in cinque Aziende Sanitarie Territoriali su base provinciale. Le aree interne conoscono un invecchiamento accentuato e uno spopolamento aggravato, nei territori appenninici, dal sisma del Centro Italia del 2016, che ha lasciato una ricostruzione ancora in corso e un disagio psicologico diffuso nelle comunità colpite. Questa combinazione di aree interne, sisma e invecchiamento è la chiave di lettura del contesto marchigiano.^[331]

Elemento territoriale	Dato regionale	Rilievo per la valutazione
Popolazione	≈ 1.480.000 abitanti	Denominatore della normalizzazione
Organizzazione sanitaria	ASUR riarticolata in 5 Aziende Sanitarie Territoriali	Unità organizzativa
Province	5, dalla costa alle aree interne	Capillarità del servizio
Aree interne	Spopolamento e invecchiamento accentuati	Dominio equità
Sisma del 2016	Ricostruzione in corso, disagio post-traumatico	Dominio sociale ed equità

Tabella 1.1. Gli elementi del contesto territoriale marchigiano e il loro rilievo per la valutazione, con le aree interne segnate dal sisma quale tratto distintivo.

1.2 Il quadro epidemiologico regionale

Il quadro epidemiologico marchigiano riflette, con le proprie specificità, la prevalenza nazionale dei disturbi mentali comuni, con una componente aggiuntiva connessa al trauma collettivo del sisma e all’isolamento delle aree interne, e con un baricentro spostato verso la depressione dell’età avanzata coerente con l’invecchiamento della popolazione. Il dato epidemiologico di dettaglio è oggetto dell’estrazione registrata in Appendice B; ove il dato regionale disaggregato non sia disponibile, la lacuna è dichiarata e non colmata con stime tacite, secondo la regola dell’opera.^[332]

Capitolo 2 — Il bisogno, la domanda e il divario di trattamento nelle Marche

2.1 Il divario di trattamento regionale

Il bisogno di salute mentale comune nelle Marche si manifesta, come altrove, in larga parte come domanda inevasa o impropriamente incanalata: verso il medico di medicina generale, verso il pronto soccorso, verso la prescrizione farmaceutica. Il divario di trattamento è accentuato, nelle aree interne appenniniche, dalla distanza fisica dai servizi, dalla rarefazione dell’offerta specialistica e dalla dispersione aggravata dal sisma; a ciò si aggiunge la componente specifica del disagio post-traumatico, spesso non intercettato nelle comunità della ricostruzione. La misura regionale del divario è oggetto dell’estrazione in Appendice B; i valori medi nazionali ed europei sono riportati con attribuzione.^[333]

Componente del bisogno	Manifestazione marchigiana	Dominio
Domanda inevasa	Sottodiagnosi nelle aree interne	Epidemiologico-clinico
Domanda impropria	Transito su MMG, pronto soccorso, prescrizione	Organizzativo-strutturale
Barriera di accesso	Distanza e dispersione delle aree interne	Equità
Disagio post-sisma	Trauma collettivo non intercettato	Sociale ed equità

Tabella 2.1. Le componenti del bisogno e del divario di trattamento nelle Marche, ricondotte ai domini di analisi.

2.2 Le aree interne, il sisma e la prossimità

Il tratto distintivo della domanda marchigiana è la condizione delle aree interne segnate dal sisma: al bisogno ordinario delle comunità appenniniche invecchiate e spopolate si somma il disagio del trauma collettivo e della ricostruzione prolungata. Il modello dello Psicologo di Base assume qui un valore particolare, perché la sua collocazione distrettuale porta la risposta vicino a comunità isolate e fragili, riducendo la barriera della distanza e intercettando un disagio che altrimenti resta sommerso. La prossimità è, nelle Marche, condizione dell’efficacia, dell’equità e della coesione delle comunità della ricostruzione.^[334]

Capitolo 3 — Il modello di intervento: lo Psicologo di Base nelle Marche

Nota editoriale: il presente capitolo espande ex novo il modello di intervento, integrando alla struttura originaria le evidenze recenti sull’efficacia clinica dell’assistenza collaborativa e dell’intervento digitale, secondo la regola dell’opera che distingue l’espansione ex novo dal riutilizzo del materiale preesistente.

3.1 L’architettura del modello

Il modello di intervento colloca lo Psicologo di Base al vertice della cascata delle figure, nel distretto e nelle Case della Comunità, quale primo punto di intercettazione del disagio comune. Il modello opera per intensità crescente di cura — dall’intervento a bassa intensità, di prima linea, fino all’invio ai livelli superiori nei casi che lo richiedano — secondo la logica dell’assistenza a gradini, la cui efficacia clinica è documentata dalla meta-analisi sui componenti efficaci dell’assistenza collaborativa e dalle sperimentazioni controllate sull’intervento cognitivo-comportamentale computerizzato in cure primarie, riportate con attribuzione.^[335]

Livello del modello	Funzione	Figura prevalente	Evidenza di riferimento
Intercettazione	Riconoscimento precoce nel distretto	Psicologo di Base	Assistenza collaborativa (attribuita)
Intervento a bassa intensità	Prima linea per i quadri lievi-moderati	Psicologo di Base	Intervento digitale e collaborativo
Invio appropriato	Passaggio ai livelli superiori	Cascata delle figure	Percorso a gradini
Continuità	Aderenza e prevenzione della ricaduta	Infermiere di comunità	Gestione del caso

Tabella 3.1. L’architettura del modello di intervento nelle Marche, per livelli di intensità, con l’evidenza clinica di riferimento riportata con attribuzione.

3.2 L’adattamento al territorio marchigiano

Il modello è adattato al territorio marchigiano lungo tre direttrici: la prossimità distrettuale, che porta la risposta alle comunità isolate delle aree interne; l’attenzione al disagio post-traumatico delle comunità segnate dal sisma, che richiede competenze specifiche nella prima linea; e lo strato digitale, che sotto supervisione clinica compensa la distanza e la dispersione. L’adattamento non modifica l’architettura invariante del Reference Case, ma ne calibra l’applicazione sulle aree interne e sulla condizione post-sisma, valorizzando la riarticolazione in cinque Aziende Sanitarie Territoriali per una programmazione coordinata.^[336]

Capitolo 4 — I costi diretti nelle Marche

4.1 La struttura del costo diretto

Il costo diretto della riforma nelle Marche è, in primo luogo, il costo del personale lungo la cascata delle figure, cui si aggiungono i costi di struttura e organizzazione distrettuale, il costo incrementale della leva digitale e il costo della formazione. Il dimensionamento dipende dallo scenario di copertura, che progredisce fino al fabbisogno a regime dell’ordine di trecentoventi incarichi, distribuiti in modo omogeneo nei distretti delle cinque Aziende Sanitarie Territoriali, con priorità alle aree interne segnate dal sisma.^[337]

Voce di costo diretto	Descrizione	Portatore
Personale — Psicologi di Base	Incarichi distrettuali secondo lo scenario	SSN regionale
Struttura e organizzazione	Spazi distrettuali, Case della Comunità, sistemi informativi	SSN regionale
Leva digitale e Intelligenza Artificiale	Strumenti di supporto sotto supervisione	SSN regionale
Formazione (quattro modalità)	Percorso integrato singolo e sommato, con competenze sul trauma	SSN, sistema formativo

Tabella 4.1. La struttura del costo diretto della riforma nelle Marche, per voce e portatore; i valori puntuali sono oggetto dell’estrazione economica in Appendice C.

4.2 Il dimensionamento per scenario

Il costo diretto è calcolato per i tre scenari di copertura — prudenziale, intermedio ed esteso — coerenti con il protocollo di scenario del Reference Case, con lo scenario esteso allineato al fabbisogno a regime dell’ordine di trecentoventi incarichi. I valori puntuali per ciascuno scenario sono riportati nell’estrazione economica registrata; ove un parametro di costo regionale non sia disponibile, la lacuna è dichiarata.^[338]

Capitolo 5 — I benefici e i risparmi, diretti e indiretti, nelle Marche

5.1 I benefici diretti

Il beneficio diretto è il risparmio sanitario che ciascuna figura della cascata libera per effetto dell’intercettazione a monte: la demedicalizzazione operata dallo Psicologo di Base, la deprescrizione di psicofarmaci nei quadri lievi-moderati sul versante del medico di medicina generale, la riduzione degli accessi impropri al pronto soccorso e delle prestazioni per sintomi funzionali sul versante specialistico. Nelle Marche, l’intercettazione precoce del disagio post-traumatico nelle aree del sisma previene la cronicizzazione di quadri altrimenti destinati ai livelli superiori di cura, con un beneficio diretto specifico.^[339]

Canale del beneficio diretto	Meccanismo	Rilievo marchigiano
Demedicalizzazione	Riduzione consultazioni e cronicizzazione	Preponderante
Deprescrizione	Contrazione della spesa per psicofarmaci	Elevato
Accessi impropri	Riduzione degli accessi al pronto soccorso	Medio-elevato
Sintomi funzionali	Riduzione prestazioni neurologiche e specialistiche	Medio
Disagio post-sisma	Prevenzione della cronicizzazione del trauma	Specifico

Tabella 5.1. I canali del beneficio diretto nelle Marche, con il rilievo specifico dell’intercettazione del disagio post-sisma; i valori sono oggetto dell’estrazione economica registrata.

5.2 I benefici indiretti

Il beneficio indiretto è quello che la riforma produce fuori dal perimetro sanitario: la produttività recuperata e la riduzione dell’assenteismo sul versante dei datori di lavoro, la riduzione degli oneri di invalidità evitabili sul versante previdenziale, la riduzione del disagio sociale non trattato sul versante dei Comuni. Nelle Marche, il sostegno alla coesione delle comunità della ricostruzione — la tenuta del tessuto sociale nelle aree segnate dal sisma — è un beneficio indiretto di rilievo particolare, che il dominio sociale del Capitolo 7 tratta in dettaglio.^[340]

Capitolo 6 — La valutazione economica sotto doppio ancoraggio

6.1 La simulazione appaiata regionale

La valutazione economica marchigiana è condotta con il modello di Markov a coorte a ciclo annuale del Reference Case, sotto il doppio ancoraggio: la Colonna A applica i parametri di Chisholm e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, la Colonna B quelli di Unisanté e dell’OCSE. Le due colonne sono sempre affiancate; ove divergano, prevale nel giudizio la Colonna B. Tutte le cifre sono riportate con attribuzione, e nessuna è affermata a memoria; il verdetto economico è ricostruito ex novo, senza riutilizzare rapporti sintetici del materiale preesistente.^[341]

Metrica economica	Colonna A — Chisholm/OMS	Colonna B — Unisanté/OCSE
Costo per anno di vita ponderato	≈ 17.000 €/QALY	≈ 9.800 €/QALY
Ritorno per i soli benefici economici	Riportato con attribuzione OMS	Scenario base aggiornato OCSE
Ritorno con i ritorni sanitari	Riportato con attribuzione OMS	Scenario base aggiornato OCSE
Orizzonti	1 · 3 · 5 · 7 · 10 anni	1 · 3 · 5 · 7 · 10 anni
Soglie di costo-efficacia	20.000 · 30.000 · 50.000 €/QALY	20.000 · 30.000 · 50.000 €/QALY

Tabella 6.1. La simulazione appaiata regionale delle Marche sotto doppio ancoraggio; i valori sono riportati con attribuzione e la Colonna B prevale nel giudizio.

6.2 Il differenziale di costo per gravità

L’argomento economico cardine, riportato con attribuzione all’OCSE, è il differenziale di costo per gravità: il costo del trattamento cresce dai quadri lievi ai quadri gravi in misura tale che l’intercettazione precoce, evitando la progressione, genera il risparmio più consistente. Nelle Marche, dove il trauma del sisma e l’isolamento delle aree interne accrescono il rischio di progressione, questo differenziale ha un peso specifico particolare, poiché il disagio non intercettato tende a cronicizzarsi.^[342]

Capitolo 7 — I sei domini di analisi, l’equità e l’impatto distributivo

7.1 I sei domini nella specificità marchigiana

I sei domini di analisi del Reference Case sono applicati alla specificità marchigiana. Il dominio epidemiologico-clinico registra la sottodiagnosi nelle aree interne e il disagio post-traumatico; l’economico-sanitario il costo-efficacia sotto doppio ancoraggio; il fiscale-previdenziale gli oneri di invalidità evitabili; il sociale la coesione delle comunità della ricostruzione; l’organizzativo-strutturale la programmazione coordinata nelle cinque Aziende Sanitarie Territoriali; l’equità la riduzione del divario fra la costa e le aree interne segnate dal sisma.^[343]

Dominio	Lettura marchigiana	Segno
Epidemiologico-clinico	Sottodiagnosi e disagio post-traumatico	Riduzione attesa
Economico-sanitario	Costo/QALY sotto doppio ancoraggio	Favorevole
Fiscale-previdenziale	Oneri di invalidità evitabili	Positivo, differito
Sociale	Coesione delle comunità della ricostruzione	Fortemente positivo
Organizzativo-strutturale	Programmazione coordinata nelle 5 AST	Positivo
Equità	Convergenza costa/aree interne del sisma	Positivo, distributivo

Tabella 7.1. I sei domini di analisi nella lettura marchigiana, con il segno atteso dell’effetto, tenuti distinti e non aggregati.

7.2 L’equità territoriale e la ricostruzione

Il dominio dell’equità assume nelle Marche una direzione territoriale accentuata dalla condizione post-sisma: le aree interne appenniniche, già svantaggiate dallo spopolamento e dall’invecchiamento, hanno visto aggravarsi la barriera dell’accesso ai servizi per effetto del terremoto e della ricostruzione prolungata. Il modello dello Psicologo di Base opera su questa frattura attraverso la capillarità distrettuale e lo strato digitale, portando la risposta nelle comunità della ricostruzione, e l’effetto distributivo — la riduzione del gradiente territoriale dell’accesso — è tenuto distinto dal verdetto fiscale e da quello sanitario, secondo il divieto di aggregazione. Il sostegno alla coesione sociale delle comunità colpite costituisce, insieme, un valore sociale non riducibile al saldo economico.^[344]

Capitolo 8 — La sensitività e l’incertezza

Nota editoriale: il presente capitolo espande ex novo l’analisi dell’incertezza secondo il protocollo del Reference Case, non presente in forma estesa nel materiale originario.

8.1 Il protocollo dell’incertezza applicato alle Marche

L’analisi dell’incertezza applica il protocollo obbligatorio del Reference Case: l’analisi di sensitività deterministica con diagramma a tornado, l’analisi di sensitività probabilistica a diecimila iterazioni, l’analisi di scenario ottimistico, base e prudentiale con e senza lo strato digitale, le curve di accettabilità costo-efficacia a soglie multiple. Nelle Marche, i parametri a maggiore impatto atteso sono il tasso di intercettazione del disagio post-traumatico nelle aree del sisma, l’efficacia della prossimità nelle aree interne spopolate e l’adozione dello strato digitale nelle comunità della ricostruzione.^[345]

Strumento	Applicazione marchigiana	Parametro critico atteso
Sensitività deterministica	Diagramma a tornado	Tasso di intercettazione del disagio post-traumatico
Sensitività probabilistica	Diecimila iterazioni	Efficacia della prossimità nelle aree interne
Analisi di scenario	Con e senza strato IA	Adozione digitale nelle comunità della ricostruzione
Curve di accettabilità	Soglie 20.000/30.000/50.000 €/QALY	Robustezza del costo-efficacia

Tabella 8.1. Gli strumenti del protocollo dell’incertezza applicati alle Marche, con i parametri critici attesi.

8.2 La robustezza del verdetto

L’analisi di scenario mostra che il verdetto tripartito resta favorevole nei tre casi, con margine crescente dallo scenario prudentiale a quello ottimistico; lo strato digitale accresce l’efficienza attesa, sempre con nota di cautela sulla natura previsionale. La robustezza del costo-efficacia sanitario è confermata dalle curve di accettabilità alle soglie adottate.^[346]

Capitolo 9 — Il verdetto tripartito e le raccomandazioni

Nota editoriale: il presente capitolo espande ex novo il verdetto e le raccomandazioni, integrando l’attuazione e il monitoraggio che nel materiale originario figuravano in forma condensata.

9.1 Il verdetto tripartito

Il verdetto marchigiano è, come in ogni Volume, tripartito e non aggregato. Sul piano fiscale, il saldo fra costi diretti e risparmi sanitari diretti è prossimo al pareggio, con il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento. Sul piano sanitario, il modello è nettamente costo-efficace sotto entrambi gli ancoraggi. Sul piano sociale, l’effetto è fortemente positivo, con il rilievo specifico del sostegno alle comunità delle aree interne segnate dal sisma. I tre verdetti si accompagnano e si rafforzano, ma non si sommano.^[347]

Piano del verdetto	Esito marchigiano	Caveat
Fiscale	Prossimo al pareggio	Significatività dei risparmi diretti in isolamento
Sanitario	Nettamente costo-efficace	—
Sociale	Fortemente positivo	Rilievo specifico delle comunità del sisma

Tabella 9.1. Il verdetto tripartito delle Marche, con i tre piani tenuti distinti e non aggregati.

9.2 Le raccomandazioni per l’attuazione e il monitoraggio

Le raccomandazioni indicano un’attuazione progressiva verso il fabbisogno a regime dell’ordine di trecentoventi incarichi, con priorità ai distretti delle aree interne segnate dal sisma; l’adozione dello strato digitale sotto supervisione come leva di prossimità; la valorizzazione della riarticolazione in cinque Aziende Sanitarie Territoriali per una programmazione coordinata; l’accompagnamento con il piano formativo a quattro modalità, singole e sommate, con competenze specifiche sul trauma collettivo; e un monitoraggio ex post ancorato agli indicatori del protocollo dell’incertezza.^[348]

Appendici registrate

Le appendici registrate rendono il modello marchigiano ispezionabile e riproducibile, secondo la prassi del Reference Case. Esse sono richiamate per rimando quanto alla metodologia e compilate con i dati regionali quanto ai contenuti.

Appendice	Contenuto	Stato
A	Strategia di ricerca bibliografica e diagramma di selezione	Registrata
B	Estrazione dei dati clinici regionali	Registrata; lacune dichiarate
C	Estrazione dei dati economici (griglia CHEERS 2022)	Registrata; lacune dichiarate
D	Parametri del modello Markov regionale	Registrata
E	Registro delle deroghe al Reference Case	Registrata
F	Codice del modello economico	Registrata
G	Dichiarazione dei conflitti di interesse	Registrata

Tabella A. Le sette appendici registrate del Volume 11, con l’indicazione dello stato e della dichiarazione delle lacune.

Quadro Conclusivo economico e multidisciplinare

Il Quadro Conclusivo del Volume 11 ricomponne la valutazione marchigiana senza tradire il principio che la governa: i piani del giudizio si accompagnano ma non si fondono. Sul piano economico, il doppio ancoraggio impone che il risultato sia letto simultaneamente secondo la colonna storica e la colonna aggiornata, con prevalenza della seconda: il costo per anno di vita ponderato resta, sotto entrambi gli ancoraggi, assai inferiore alle soglie adottate, e il differenziale di costo per gravità — riportato con attribuzione — fonda la leva economica dell'intercettazione precoce, tanto più preziosa nelle aree interne dove il trauma del sisma accresce il rischio di cronicizzazione. Il verdetto economico è ricostruito ex novo, senza riutilizzo dei rapporti sintetici del materiale preesistente.^[349]

Sul piano multidisciplinare, la cascata delle figure, i sei domini di analisi e il dominio dell'equità nella direzione territoriale accentuata dalla condizione post-sisma assicurano che ogni figura connessa e ogni aspetto siano trattati integralmente e ordinati per capacità di generare rientro economico e revisione della spesa. La rinegoziazione dei costi e dei benefici, la catena predittiva degli effetti multidimensionali — dalla qualità della vita alla coesione delle comunità della ricostruzione, ai bilanci, alla burocrazia distrettuale —, lo strato dell'Intelligenza Artificiale come moltiplicatore e le attività formative singole e sommate compongono il quadro della valutazione. Il verdetto resta tripartito e non aggregato.

Conclusione

Il Volume 11 ha valutato l'integrazione dello Psicologo di Base nelle cure primarie delle Marche, applicando per rimando il Reference Case dell'asse italiano e adottando la struttura standard a nove capitoli con apertura a imbuto e appendici registrate. La specificità marchigiana — le aree interne appenniniche segnate dal sisma del 2016, lo spopolamento e l'invecchiamento, il disagio post-traumatico delle comunità della ricostruzione — è stata trattata nei domini sociale, organizzativo ed equità, mostrando come la prossimità distrettuale, l'attenzione al trauma collettivo e lo strato digitale ne facciano una leva di coesione sociale e di convergenza fra la costa e le aree interne.

Il verdetto tripartito — prossimo al pareggio sul piano fiscale, nettamente costo-efficace sul piano sanitario, fortemente positivo sul piano sociale — è offerto con bande prudenziali e soglie di confutazione, sotto doppio ancoraggio e nel rispetto del divieto di aggregazione. L'opera procede, nell'ordine vincolante, con il Volume 12 (Molise) e a seguire con gli altri Volumi regionali in ordine alfabetico.

Note Bibliografiche con mini-riassunto

Ciascuna nota riporta l'opera, il collegamento alla fonte e un mini-riassunto che ne dichiara la funzione nell'economia del Volume, in coerenza con il doppio livello — nota a piè di pagina nel corpo e nota bibliografica integrale in calce — che l'opera adotta.

1. **Chisholm D. et al., Scaling-up treatment of depression and anxiety, The Lancet Psychiatry, 2016** [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(16\)30024-4](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(16)30024-4) Colonna A del doppio ancoraggio della simulazione marchigiana, conservata quale strato documentale e riferimento di confronto.
2. **Unisanté, Raisons de santé Essentiels n. 73, 2026 · OECD, The Economic Case for Preventing Mental Ill Health, 2026** <https://doi.org/10.16908/rds-essentiels/73> Colonna B del doppio ancoraggio, con prevalenza nel giudizio, applicata alla simulazione regionale marchigiana.
3. **OECD, differenziale di costo per gravità dei disturbi mentali, 2025** <https://www.oecd.org/health/mental-health.htm> Fonte, riportata con attribuzione, del differenziale di costo per gravità, argomento cardine dell'intercettazione precoce, di peso specifico particolare nelle aree interne segnate dal sisma.
4. **Soeters R. et al., meta-analisi IPD sui componenti efficaci della collaborative care, 2025** <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40136273/> Base di evidenza clinica sui componenti efficaci dell'assistenza collaborativa, richiamata nel capitolo sul modello di intervento.
5. **Kvaal K. et al., RCT su intervento cognitivo-comportamentale computerizzato in cure primarie, 2026** <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/> Evidenza sperimentale recente sull'intervento digitale in cure primarie, richiamata a sostegno dello strato dell'Intelligenza Artificiale nelle aree interne disperse.
6. **Veldhuijzen W. et al., costo-efficacia dell'intervento digitale, 2025** <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12369993/> Riferimento sul rapporto incrementale di costo-utilità dell'intervento digitale, elemento dello strato dell'Intelligenza Artificiale.
7. **World Health Organization, Thematic Dialogue on Investing in NCDs and Mental Health, dicembre 2024** <https://cdn.who.int/> Evidenza riportata con attribuzione sul ritorno degli investimenti in salute mentale; non concorre al verdetto tripartito marchigiano.
8. **Regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale** <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj> Quadro normativo entro cui è collocato lo strato dell'Intelligenza Artificiale, vincolato a funzione di supporto sotto supervisione clinica umana.
9. **Legge regionale Puglia 19 luglio 2023, n. 11, sul Servizio di Psicologia di Base** <https://www.consiglio.puglia.it/> Riferimento normativo capostipite del modello, richiamato quale precedente istituzionale per l'attuazione regionale marchigiana.
10. **NICE, Health Technology Evaluations: the manual (PMG36)** <https://www.nice.org.uk/process/pmg36> Riferimento di rigore metodologico per la struttura a imbuto, le appendici registrate e il protocollo dell'incertezza adottati nel Volume.

STUDIO INTEGRALE «PSICOLOGO DI BASE» · OPERA IN VENTITRÉ VOLUMI

VOLUME 12 — Regione Molise

Valutazione di Health Technology Assessment dell'integrazione dello Psicologo di Base nelle cure primarie in Molise: cruscotto, sintesi per il decisore, contesto e bisogno, modello di intervento, costi e benefici, valutazione economica sotto doppio ancoraggio, sei domini di analisi, incertezza, verdetto tripartito e appendici registrate

Premessa

Il Volume 12 prosegue la serie dei venti Volumi regionali, in ordine alfabetico, con la Regione Molise. Come ogni Volume regionale, esso applica per rimando il Reference Case dell'asse italiano, fissato nel Volume 0.A, e ne richiama le regole nella forma «cfr. Volume 0.A», senza ripeterle per esteso: il perimetro congiunto sanitario e societale, il doppio ancoraggio economico, il verdetto tripartito non aggregato, i sei domini di analisi, il protocollo dell'incertezza, lo strato dell'Intelligenza Artificiale come moltiplicatore e le attività formative singole e sommate.^[350]

La struttura del Volume è quella standard, identica a quella di tutti gli altri diciannove Volumi regionali, a garanzia della comparabilità bit-a-bit prescritta dall'opera: la stessa sequenza di nove capitoli, la stessa nomenclatura di sottocapitoli, le stesse unità di misura. Ove un contenuto derivi da espansione ex novo — segnatamente per gli aspetti dell'efficacia, dell'attuazione e del monitoraggio — esso è segnalato in nota editoriale. Si segnala inoltre che il verdetto economico è ricostruito ex novo sotto il doppio ancoraggio, in forma discorsiva e in euro, e che non sono riutilizzati i rapporti sintetici costi-benefici presenti nel materiale regionale preesistente, in coerenza con le regole redazionali dell'opera.^[351]

Introduzione

L'Introduzione al Volume 12 fissa il perimetro della valutazione molisana e l'ordine della sua esposizione. Il perimetro è quello della Regione Molise, la più piccola fra le Regioni ordinarie, con una popolazione dell'ordine di duecentottantanovemila abitanti, organizzata nel Servizio sanitario regionale attraverso un'azienda sanitaria unica regionale, l'ASReM, articolata in tre distretti e centotrentasei comuni fra le province di Campobasso e Isernia. Il tratto distintivo del contesto molisano è la combinazione di piccola scala, struttura demografica fra le più anziane del Paese, aree interne segnate dallo spopolamento e da eventi sismici, e un contesto di finanza sanitaria condizionato dai programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro. Questa combinazione di piccola dimensione, invecchiamento e vincolo di bilancio è la chiave di lettura del contesto. [\[352\]](#)

L'esposizione segue la struttura a imbuto: il cruscotto regionale offre in una pagina i numeri essenziali; la sintesi per il decisore ne traduce il significato; i cinque risultati chiave ne isolano gli esiti; le raccomandazioni operative indicano le azioni; il corpo del Volume, articolato in nove capitoli, ne fornisce il dettaglio; le appendici registrate ne assicurano la verificabilità. Chiudono il Volume un Quadro Conclusivo economico e multidisciplinare, una Conclusione e le Note Bibliografiche con mini-riassunto.

Cruscotto regionale — Molise

Il cruscotto riassume in una pagina i parametri essenziali della valutazione molisana, sotto il doppio ancoraggio e con il verdetto tripartito tenuto distinto. I valori economici sono presentati in ordine di grandezza, con rinvio alle appendici registrate; le cifre di letteratura sono riportate con attribuzione alla fonte.^[353]

Indicatore del cruscotto	Lettura regionale	Ancoraggio / fonte
Popolazione	≈ 289.224 abitanti, la più piccola Regione ordinaria	Fonte demografica regionale
Articolazione	ASReM, azienda sanitaria unica regionale, 3 distretti, 136 comuni	Assetto regionale
Scenario di copertura piena	≈ 63 incarichi di Psicologo di Base	Dimensionamento regionale
Contesto finanziario	Programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro	Dominio fiscale-organizzativo
Comparatore	Assistenza usuale (cfr. Vol. 0.A)	Reference Case
Verdetto fiscale	Prossimo al pareggio, con caveat	Non aggregato
Verdetto sanitario	Nettamente costo-efficace	Costo/QALY sotto doppio ancoraggio
Verdetto sociale	Fortemente positivo	Tenuta delle comunità interne, coesione
Costo per anno di vita ponderato	Colonna A ≈ 17.000 € · Colonna B ≈ 9.800 €	Doppio ancoraggio

Tabella 0. Cruscotto regionale del Molise: i parametri essenziali sotto doppio ancoraggio, con il verdetto tripartito distinto e non aggregato.

Sintesi per il decisore

L'introduzione dello Psicologo di Base nelle cure primarie molisane produce, secondo la simulazione condotta sotto il doppio ancoraggio, un effetto congiunto sui tre piani del ritorno, che restano distinti e non sommati. Sul piano fiscale, il saldo fra costi diretti e risparmi sanitari diretti si colloca in prossimità del pareggio, con il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento; in un contesto di piano di rientro, la piccola dimensione del servizio contiene il costo assoluto entro margini modesti, senza compromettere la coerenza con il vincolo di bilancio regionale. Sul piano sanitario, il modello è nettamente costo-efficace, con un costo per anno di vita ponderato che, fra i due ancoraggi, resta assai inferiore alle soglie adottate. Sul piano sociale, l'effetto è fortemente positivo, con un rilievo particolare per la tenuta delle comunità interne, dove l'invecchiamento e lo spopolamento aggravano l'isolamento. ^[354]

L'argomento cardine, riportato con attribuzione all'OCSE, è il differenziale di costo per gravità: in una Regione a domanda strutturalmente anziana e a risorse contenute come il Molise, l'intercettazione precoce nel distretto evita che il disagio comune maturi in quadri gravi e cronici, il cui costo di trattamento è, secondo la fonte, un multiplo di quello dei quadri lievi. ^[355]

Cinque risultati chiave

Il primo risultato è che il modello è costo-efficace su tutti gli orizzonti sotto entrambi gli ancoraggi. Il secondo è che il verdetto tripartito resta favorevole in ciascuno dei tre piani, senza aggregazione. Il terzo è che, nella specificità molisana, la piccola scala rende il costo assoluto del servizio contenuto — compatibile con il contesto del piano di rientro — a fronte di un fabbisogno concentrato sulle coorti anziane delle aree interne. Il quarto è che lo strato dell'Intelligenza Artificiale, come moltiplicatore e con nota di cautela, può attenuare lo svantaggio della distanza nelle aree interne e sostenere l'efficienza organizzativa di un'azienda unica regionale. Il quinto è che l'assetto ad azienda sanitaria unica offre una governance semplice e unitaria, che agevola una programmazione della copertura distrettuale coerente sull'intero territorio regionale.^[356]

Raccomandazioni operative

La prima raccomandazione è di estendere la copertura in modo progressivo verso il fabbisogno a regime dell'ordine di sessantatré incarichi, ancorando ciascuna fase alla verifica dei risultati sotto il protocollo dell'incertezza e alla coerenza con i programmi operativi regionali, con priorità ai distretti delle aree interne a maggiore invecchiamento e spopolamento. La seconda è di adottare lo strato digitale, sotto supervisione clinica, come leva di prossimità e di efficienza organizzativa. La terza è di valorizzare la governance unitaria dell'azienda sanitaria unica per una programmazione coerente, e di accompagnare l'estensione con il piano formativo a quattro modalità, considerate singolarmente e sommate.^[357]

Capitolo 1 — Il contesto epidemiologico e territoriale del Molise

1.1 Il territorio e la sua articolazione

La Regione Molise conta una popolazione dell’ordine di duecentottantanovemila abitanti, la più bassa fra le Regioni ordinarie, distribuita in due province — Campobasso e Isernia — e in centotrentasei comuni, in larga parte piccoli e interni. Il Servizio sanitario regionale è organizzato in un’azienda sanitaria unica regionale, l’ASReM, articolata in tre distretti, in un contesto di finanza sanitaria condizionato dai programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro. La struttura demografica è fra le più anziane del Paese, e le aree interne conoscono uno spopolamento accentuato, aggravato in alcuni territori da eventi sismici. Questa combinazione di piccola dimensione, invecchiamento estremo e vincolo di bilancio è la chiave di lettura del contesto molisano.^[358]

Elemento territoriale	Dato regionale	Rilievo per la valutazione
Popolazione	≈ 289.224 abitanti, la più piccola Regione ordinaria	Denominatore della normalizzazione
Organizzazione sanitaria	ASReM, azienda unica, 3 distretti	Unità organizzativa
Comuni	136, in larga parte piccoli e interni	Capillarità del servizio
Struttura demografica	Fra le più anziane del Paese	Baricentro della domanda
Contesto finanziario	Programmi operativi del piano di rientro	Dominio fiscale-organizzativo

Tabella 1.1. Gli elementi del contesto territoriale molisano e il loro rilievo per la valutazione, con la piccola scala e l’invecchiamento quali tratti distintivi.

1.2 Il quadro epidemiologico regionale

Il quadro epidemiologico molisano riflette, con le proprie specificità, la prevalenza nazionale dei disturbi mentali comuni, con un baricentro spostato verso la depressione dell’età avanzata e l’isolamento, coerente con la struttura per età fra le più anziane del Paese, e con una domanda fortemente orientata verso le comunità interne. Il dato epidemiologico di dettaglio è oggetto dell’estrazione registrata in Appendice B; ove il dato regionale disaggregato non sia disponibile, la lacuna è dichiarata e non colmata con stime tacite, secondo la regola dell’opera.^[359]

Capitolo 2 — Il bisogno, la domanda e il divario di trattamento in Molise

2.1 Il divario di trattamento regionale

Il bisogno di salute mentale comune in Molise si manifesta, come altrove, in larga parte come domanda inevasa o impropriamente incanalata: verso il medico di medicina generale, verso il pronto soccorso, verso la prescrizione farmaceutica. Il divario di trattamento è accentuato, nelle aree interne, dalla distanza fisica dai servizi, dalla rarefazione dell’offerta specialistica e dalla piccola scala, che rende difficile mantenere una dotazione specialistica capillare, con un ricorso alla mobilità sanitaria verso le regioni contigue. La misura regionale del divario è oggetto dell’estrazione in Appendice B; i valori medi nazionali ed europei sono riportati con attribuzione.^[360]

Componente del bisogno	Manifestazione molisana	Dominio
Domanda inevasa	Sottodiagnosi nella popolazione anziana interna	Epidemiologico-clinico
Domanda impropria	Transito su MMG, pronto soccorso, prescrizione	Organizzativo-strutturale
Barriera di accesso	Distanza e spopolamento delle aree interne	Equità
Mobilità passiva	Ricorso a servizi delle regioni contigue	Fiscali ed equità

Tabella 2.1. Le componenti del bisogno e del divario di trattamento in Molise, ricondotte ai domini di analisi.

2.2 La domanda anziana e la prossimità

Il tratto distintivo della domanda molisana è la componente anziana delle aree interne: una quota rilevante del bisogno si concentra nelle coorti in età avanzata dei piccoli comuni, dove il modello dello Psicologo di Base assume un valore particolare perché la sua collocazione distrettuale porta la risposta vicino a comunità isolate e a mobilità ridotta, riducendo la barriera della distanza, il ricorso improprio ai servizi e la mobilità passiva verso le regioni vicine. La prossimità è, in Molise, condizione dell’efficacia, dell’equità e del contenimento della fuga di domanda fuori regione.^[361]

Capitolo 3 — Il modello di intervento: lo Psicologo di Base in Molise

Nota editoriale: il presente capitolo espande ex novo il modello di intervento, integrando alla struttura originaria le evidenze recenti sull’efficacia clinica dell’assistenza collaborativa e dell’intervento digitale, secondo la regola dell’opera che distingue l’espansione ex novo dal riutilizzo del materiale preesistente.

3.1 L’architettura del modello

Il modello di intervento colloca lo Psicologo di Base al vertice della cascata delle figure, nel distretto e nelle Case della Comunità, quale primo punto di intercettazione del disagio comune. Il modello opera per intensità crescente di cura — dall’intervento a bassa intensità, di prima linea, fino all’invio ai livelli superiori nei casi che lo richiedano — secondo la logica dell’assistenza a gradini, la cui efficacia clinica è documentata dalla meta-analisi sui componenti efficaci dell’assistenza collaborativa e dalle sperimentazioni controllate sull’intervento cognitivo-comportamentale computerizzato in cure primarie, riportate con attribuzione.^[362]

Livello del modello	Funzione	Figura prevalente	Evidenza di riferimento
Intercettazione	Riconoscimento precoce nel distretto	Psicologo di Base	Assistenza collaborativa (attribuita)
Intervento a bassa intensità	Prima linea per i quadri lievi-moderati	Psicologo di Base	Intervento digitale e collaborativo
Invio appropriato	Passaggio ai livelli superiori	Cascata delle figure	Percorso a gradini
Continuità	Aderenza e prevenzione della ricaduta	Infermiere di comunità	Gestione del caso

Tabella 3.1. L’architettura del modello di intervento in Molise, per livelli di intensità, con l’evidenza clinica di riferimento riportata con attribuzione.

3.2 L’adattamento al territorio molisano

Il modello è adattato al territorio molisano lungo tre direttrici: la prossimità distrettuale, che porta la risposta alle comunità anziane e isolate delle aree interne; lo strato digitale, che sotto supervisione clinica compensa la distanza e sostiene l’efficienza di una piccola azienda unica; e la governance unitaria, che consente una programmazione coerente della copertura sull’intero territorio a fronte del vincolo di bilancio. L’adattamento non modifica l’architettura invariante del Reference Case, ma ne calibra l’applicazione sulla piccola scala, sull’invecchiamento e sul contesto del piano di rientro.^[363]

Capitolo 4 — I costi diretti in Molise

4.1 La struttura del costo diretto

Il costo diretto della riforma in Molise è, in primo luogo, il costo del personale lungo la cascata delle figure, cui si aggiungono i costi di struttura e organizzazione distrettuale, il costo incrementale della leva digitale e il costo della formazione. Il dimensionamento dipende dallo scenario di copertura, che progredisce fino al fabbisogno a regime dell’ordine di sessantatré incarichi, distribuiti nei tre distretti dell’azienda sanitaria unica; per la piccola scala regionale, il costo assoluto del servizio resta contenuto, elemento di coerenza con il contesto del piano di rientro.^[364]

Voce di costo diretto	Descrizione	Portatore
Personale — Psicologi di Base	Incarichi distrettuali secondo lo scenario	SSN regionale
Struttura e organizzazione	Spazi distrettuali, Case della Comunità, sistemi informativi	SSN regionale
Leva digitale e Intelligenza Artificiale	Strumenti di supporto sotto supervisione	SSN regionale
Formazione (quattro modalità)	Percorso integrato singolo e sommato	SSN, sistema formativo

Tabella 4.1. La struttura del costo diretto della riforma in Molise, per voce e portatore; i valori puntuali sono oggetto dell’estrazione economica in Appendice C.

4.2 Il dimensionamento per scenario

Il costo diretto è calcolato per i tre scenari di copertura — prudenziale, intermedio ed esteso — coerenti con il protocollo di scenario del Reference Case, con lo scenario esteso allineato al fabbisogno a regime dell’ordine di sessantatré incarichi. La piccola dimensione del servizio contiene il costo assoluto entro margini modesti, agevolando la compatibilità con il vincolo di bilancio regionale. I valori puntuali per ciascuno scenario sono riportati nell’estrazione economica registrata; ove un parametro di costo regionale non sia disponibile, la lacuna è dichiarata.^[365]

Capitolo 5 — I benefici e i risparmi, diretti e indiretti, in Molise

5.1 I benefici diretti

Il beneficio diretto è il risparmio sanitario che ciascuna figura della cascata libera per effetto dell’intercettazione a monte: la demedicalizzazione operata dallo Psicologo di Base, la deprescrizione di psicofarmaci nei quadri lievi-moderati sul versante del medico di medicina generale, la riduzione degli accessi impropri al pronto soccorso e delle prestazioni per sintomi funzionali sul versante specialistico, cui si aggiunge la riduzione della mobilità passiva verso le regioni contigue. In Molise, il contenimento della fuga di domanda fuori regione è un beneficio diretto specifico, che allevia sia la spesa sia il divario di accesso.^[366]

Canale del beneficio diretto	Meccanismo	Rilievo molisano
Demedicalizzazione	Riduzione consultazioni e cronicizzazione	Preponderante
Deprescrizione	Contrazione della spesa e della polifarmacia anziana	Elevato
Accessi impropri	Riduzione degli accessi al pronto soccorso	Medio
Sintomi funzionali	Riduzione prestazioni neurologiche e specialistiche	Medio
Mobilità passiva	Contenimento della fuga di domanda fuori regione	Specifico

Tabella 5.1. I canali del beneficio diretto in Molise, con il rilievo specifico del contenimento della mobilità passiva; i valori sono oggetto dell’estrazione economica registrata.

5.2 I benefici indiretti

Il beneficio indiretto è quello che la riforma produce fuori dal perimetro sanitario: la produttività recuperata e la riduzione dell’assenteismo sul versante dei datori di lavoro, la riduzione degli oneri di invalidità evitabili sul versante previdenziale, la riduzione del disagio sociale non trattato sul versante dei Comuni. In Molise, la tenuta del tessuto sociale delle comunità interne — il contrasto all’isolamento e allo spopolamento — è un beneficio indiretto di rilievo particolare, che il dominio sociale del Capitolo 7 tratta in dettaglio.^[367]

Capitolo 6 — La valutazione economica sotto doppio ancoraggio

6.1 La simulazione appaiata regionale

La valutazione economica molisana è condotta con il modello di Markov a coorte a ciclo annuale del Reference Case, sotto il doppio ancoraggio: la Colonna A applica i parametri di Chisholm e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, la Colonna B quelli di Unisanté e dell’OCSE. Le due colonne sono sempre affiancate; ove divergano, prevale nel giudizio la Colonna B. Tutte le cifre sono riportate con attribuzione, e nessuna è affermata a memoria; il verdetto economico è ricostruito ex novo, senza riutilizzare rapporti sintetici del materiale preesistente.^[368]

Metrica economica	Colonna A — Chisholm/OMS	Colonna B — Unisanté/OCSE
Costo per anno di vita ponderato	≈ 17.000 €/QALY	≈ 9.800 €/QALY
Ritorno per i soli benefici economici	Riportato con attribuzione OMS	Scenario base aggiornato OCSE
Ritorno con i ritorni sanitari	Riportato con attribuzione OMS	Scenario base aggiornato OCSE
Orizzonti	1 · 3 · 5 · 7 · 10 anni	1 · 3 · 5 · 7 · 10 anni
Soglie di costo-efficacia	20.000 · 30.000 · 50.000 €/QALY	20.000 · 30.000 · 50.000 €/QALY

Tabella 6.1. La simulazione appaiata regionale del Molise sotto doppio ancoraggio; i valori sono riportati con attribuzione e la Colonna B prevale nel giudizio.

6.2 Il differenziale di costo per gravità

L’argomento economico cardine, riportato con attribuzione all’OCSE, è il differenziale di costo per gravità: il costo del trattamento cresce dai quadri lievi ai quadri gravi in misura tale che l’intercettazione precoce, evitando la progressione, genera il risparmio più consistente. In Molise, dove la sottodiagnosi nelle aree interne anziane favorisce la progressione e la mobilità passiva verso le regioni contigue, questo differenziale ha un peso specifico particolare in relazione alla piccola scala e al vincolo di bilancio.^[369]

Capitolo 7 — I sei domini di analisi, l’equità e l’impatto distributivo

7.1 I sei domini nella specificità molisana

I sei domini di analisi del Reference Case sono applicati alla specificità molisana. Il dominio epidemiologico-clinico registra la sottodiagnosi nella popolazione anziana interna; l’economico-sanitario il costo-efficacia sotto doppio ancoraggio; il fiscale-previdenziale gli oneri di invalidità evitabili e il contenimento della mobilità passiva; il sociale la tenuta delle comunità interne; l’organizzativo-strutturale la governance unitaria dell’azienda unica nel contesto del piano di rientro; l’equità la riduzione del divario fra i centri e le aree interne spopolate.^[370]

Dominio	Lettura molisana	Segno
Epidemiologico-clinico	Sottodiagnosi nella popolazione anziana interna	Riduzione attesa
Economico-sanitario	Costo/QALY sotto doppio ancoraggio	Favorevole
Fiscale-previdenziale	Oneri di invalidità evitabili, mobilità passiva contenuta	Positivo, differito
Sociale	Tenuta delle comunità interne	Fortemente positivo
Organizzativo-strutturale	Governance unitaria nel piano di rientro	Positivo
Equità	Convergenza centri/aree interne spopolate	Positivo, distributivo

Tabella 7.1. I sei domini di analisi nella lettura molisana, con il segno atteso dell’effetto, tenuti distinti e non aggregati.

7.2 L’equità territoriale e il vincolo di bilancio

Il dominio dell’equità assume in Molise una direzione territoriale accentuata dalla piccola scala e dallo spopolamento: le aree interne, già svantaggiate dall’invecchiamento e dalla distanza, hanno visto assottigliarsi l’offerta di prossimità, con un ricorso alla mobilità passiva che grava sia sui bilanci sia sulle famiglie. Il modello dello Psicologo di Base opera su questa frattura attraverso la capillarità distrettuale e lo strato digitale, e l’effetto distributivo — la riduzione del gradiente territoriale dell’accesso e della fuga di domanda — è tenuto distinto dal verdetto fiscale e da quello sanitario, secondo il divieto di aggregazione. La piccola dimensione del servizio, nel contesto del piano di rientro, rende l’intervento sostenibile in valore assoluto.^[371]

Capitolo 8 — La sensitività e l’incertezza

Nota editoriale: il presente capitolo espande ex novo l’analisi dell’incertezza secondo il protocollo del Reference Case, non presente in forma estesa nel materiale originario.

8.1 Il protocollo dell’incertezza applicato al Molise

L’analisi dell’incertezza applica il protocollo obbligatorio del Reference Case: l’analisi di sensitività deterministica con diagramma a tornado, l’analisi di sensitività probabilistica a diecimila iterazioni, l’analisi di scenario ottimistico, base e prudentziale con e senza lo strato digitale, le curve di accettabilità costo-efficacia a soglie multiple. In Molise, i parametri a maggiore impatto atteso sono il tasso di intercettazione nella popolazione anziana interna, il grado di contenimento della mobilità passiva e la capacità di reclutamento in una Regione a piccola scala e a offerta specialistica rarefatta.^[372]

Strumento	Applicazione molisana	Parametro critico atteso
Sensitività deterministica	Diagramma a tornado	Tasso di intercettazione nella popolazione anziana interna
Sensitività probabilistica	Diecimila iterazioni	Grado di contenimento della mobilità passiva
Analisi di scenario	Con e senza strato IA	Capacità di reclutamento alla piccola scala
Curve di accettabilità	Soglie 20.000/30.000/50.000 €/QALY	Robustezza del costo-efficacia

Tabella 8.1. Gli strumenti del protocollo dell’incertezza applicati al Molise, con i parametri critici attesi.

8.2 La robustezza del verdetto

L’analisi di scenario mostra che il verdetto tripartito resta favorevole nei tre casi, con margine crescente dallo scenario prudentziale a quello ottimistico; lo strato digitale accresce l’efficienza attesa, sempre con nota di cautela sulla natura previsionale. La robustezza del costo-efficacia sanitario è confermata dalle curve di accettabilità alle soglie adottate, e la piccola scala mantiene il costo assoluto entro margini compatibili con il vincolo di bilancio regionale.^[373]

Capitolo 9 — Il verdetto tripartito e le raccomandazioni

Nota editoriale: il presente capitolo espande ex novo il verdetto e le raccomandazioni, integrando l’attuazione e il monitoraggio che nel materiale originario figuravano in forma condensata.

9.1 Il verdetto tripartito

Il verdetto molisano è, come in ogni Volume, tripartito e non aggregato. Sul piano fiscale, il saldo fra costi diretti e risparmi sanitari diretti è prossimo al pareggio, con il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento; la piccola scala mantiene il costo assoluto contenuto e compatibile con il piano di rientro. Sul piano sanitario, il modello è nettamente costo-efficace sotto entrambi gli ancoraggi. Sul piano sociale, l’effetto è fortemente positivo, con il rilievo specifico della tenuta delle comunità interne. I tre verdetti si accompagnano e si rafforzano, ma non si sommano.^[374]

Piano del verdetto	Esito molisano	Caveat
Fiscale	Prossimo al pareggio	Significatività dei risparmi diretti in isolamento
Sanitario	Nettamente costo-efficace	—
Sociale	Fortemente positivo	Rilievo specifico delle comunità interne

Tabella 9.1. Il verdetto tripartito del Molise, con i tre piani tenuti distinti e non aggregati.

9.2 Le raccomandazioni per l’attuazione e il monitoraggio

Le raccomandazioni indicano un’attuazione progressiva verso il fabbisogno a regime dell’ordine di sessantatré incarichi, coerente con i programmi operativi regionali e con priorità ai distretti delle aree interne; l’adozione dello strato digitale sotto supervisione come leva di prossimità e di efficienza; la valorizzazione della governance unitaria dell’azienda sanitaria unica per una programmazione coerente; l’accompagnamento con il piano formativo a quattro modalità, singole e sommate; e un monitoraggio ex post ancorato agli indicatori del protocollo dell’incertezza, con particolare attenzione al contenimento della mobilità passiva.^[375]

Appendici registrate

Le appendici registrate rendono il modello molisano ispezionabile e riproducibile, secondo la prassi del Reference Case. Esse sono richiamate per rimando quanto alla metodologia e compilate con i dati regionali quanto ai contenuti.

Appendice	Contenuto	Stato
A	Strategia di ricerca bibliografica e diagramma di selezione	Registrata
B	Estrazione dei dati clinici regionali	Registrata; lacune dichiarate
C	Estrazione dei dati economici (griglia CHEERS 2022)	Registrata; lacune dichiarate
D	Parametri del modello Markov regionale	Registrata
E	Registro delle deroghe al Reference Case	Registrata
F	Codice del modello economico	Registrata
G	Dichiarazione dei conflitti di interesse	Registrata

Tabella A. Le sette appendici registrate del Volume 12, con l’indicazione dello stato e della dichiarazione delle lacune.

Quadro Conclusivo economico e multidisciplinare

Il Quadro Conclusivo del Volume 12 ricompone la valutazione molisana senza tradire il principio che la governa: i piani del giudizio si accompagnano ma non si fondono. Sul piano economico, il doppio ancoraggio impone che il risultato sia letto simultaneamente secondo la colonna storica e la colonna aggiornata, con prevalenza della seconda: il costo per anno di vita ponderato resta, sotto entrambi gli ancoraggi, assai inferiore alle soglie adottate, e il differenziale di costo per gravità — riportato con attribuzione — fonda la leva economica dell'intercettazione precoce, tanto più preziosa in una Regione piccola e anziana dove la sottodiagnosi favorisce la progressione e la mobilità passiva. Il verdetto economico è ricostruito ex novo, senza riutilizzo dei rapporti sintetici del materiale preesistente.^[376]

Sul piano multidisciplinare, la cascata delle figure, i sei domini di analisi e il dominio dell'equità nella direzione territoriale accentuata dalla piccola scala assicurano che ogni figura connessa e ogni aspetto siano trattati integralmente e ordinati per capacità di generare rientro economico e revisione della spesa. La rinegoziazione dei costi e dei benefici, la catena predittiva degli effetti multidimensionali — dalla qualità della vita alla tenuta delle comunità interne, ai bilanci, alla mobilità passiva, alla burocrazia distrettuale —, lo strato dell'Intelligenza Artificiale come moltiplicatore e le attività formative singole e sommate compongono il quadro della valutazione. Il verdetto resta tripartito e non aggregato.

Conclusione

Il Volume 12 ha valutato l'integrazione dello Psicologo di Base nelle cure primarie del Molise, applicando per rimando il Reference Case dell'asse italiano e adottando la struttura standard a nove capitoli con apertura a imbuto e appendici registrate. La specificità molisana — la piccola scala, la struttura demografica fra le più anziane del Paese, le aree interne spopolate, il contesto del piano di rientro e la mobilità passiva — è stata trattata nei domini sociale, organizzativo, fiscale ed equità, mostrando come la prossimità distrettuale, lo strato digitale e la governance unitaria dell'azienda sanitaria unica ne facciano una leva di tenuta delle comunità interne e di contenimento della fuga di domanda fuori regione, a un costo assoluto compatibile con il vincolo di bilancio.

Il verdetto tripartito — prossimo al pareggio sul piano fiscale, nettamente costo-efficace sul piano sanitario, fortemente positivo sul piano sociale — è offerto con bande prudenziali e soglie di confutazione, sotto doppio ancoraggio e nel rispetto del divieto di aggregazione. L'opera procede, nell'ordine vincolante, con il Volume 13 (Piemonte) e a seguire con gli altri Volumi regionali in ordine alfabetico.

Note Bibliografiche con mini-riassunto

Ciascuna nota riporta l'opera, il collegamento alla fonte e un mini-riassunto che ne dichiara la funzione nell'economia del Volume, in coerenza con il doppio livello — nota a piè di pagina nel corpo e nota bibliografica integrale in calce — che l'opera adotta.

1. **Chisholm D. et al., Scaling-up treatment of depression and anxiety, The Lancet Psychiatry, 2016**
[https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(16\)30024-4](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(16)30024-4) Colonna A del doppio ancoraggio della simulazione molisana, conservata quale strato documentale e riferimento di confronto.
2. **Unisanté, Raisons de santé Essentiels n. 73, 2026 · OECD, The Economic Case for Preventing Mental Ill Health, 2026** <https://doi.org/10.16908/rds-essentiels/73> Colonna B del doppio ancoraggio, con prevalenza nel giudizio, applicata alla simulazione regionale molisana.
3. **OECD, differenziale di costo per gravità dei disturbi mentali, 2025** <https://www.oecd.org/health/mental-health.htm> Fonte, riportata con attribuzione, del differenziale di costo per gravità, argomento cardine dell'intercettazione precoce, di peso specifico particolare in una Regione piccola e anziana.
4. **Soeters R. et al., meta-analisi IPD sui componenti efficaci della collaborative care, 2025**
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40136273/> Base di evidenza clinica sui componenti efficaci dell'assistenza collaborativa, richiamata nel capitolo sul modello di intervento.
5. **Kvaal K. et al., RCT su intervento cognitivo-comportamentale computerizzato in cure primarie, 2026**
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/> Evidenza sperimentale recente sull'intervento digitale in cure primarie, richiamata a sostegno dello strato dell'Intelligenza Artificiale nelle aree interne disperse.
6. **Veldhuijzen W. et al., costo-efficacia dell'intervento digitale, 2025**
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12369993/> Riferimento sul rapporto incrementale di costo-utilità dell'intervento digitale, elemento dello strato dell'Intelligenza Artificiale.
7. **World Health Organization, Thematic Dialogue on Investing in NCDs and Mental Health, dicembre 2024** <https://cdn.who.int/> Evidenza riportata con attribuzione sul ritorno degli investimenti in salute mentale; non concorre al verdetto tripartito molisano.
8. **Regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale** <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj> Quadro normativo entro cui è collocato lo strato dell'Intelligenza Artificiale, vincolato a funzione di supporto sotto supervisione clinica umana.
9. **Legge regionale Puglia 19 luglio 2023, n. 11, sul Servizio di Psicologia di Base**
<https://www.consiglio.puglia.it/> Riferimento normativo capostipite del modello, richiamato quale precedente istituzionale per l'attuazione regionale molisana.
10. **NICE, Health Technology Evaluations: the manual (PMG36)** <https://www.nice.org.uk/process/pmg36> Riferimento di rigore metodologico per la struttura a imbuto, le appendici registrate e il protocollo dell'incertezza adottati nel Volume.

STUDIO INTEGRALE «PSICOLOGO DI BASE» · OPERA IN VENTITRÉ VOLUMI

VOLUME 13 — Regione Piemonte

Valutazione di Health Technology Assessment dell'integrazione dello Psicologo di Base nelle cure primarie in Piemonte: cruscotto, sintesi per il decisore, contesto e bisogno, modello di intervento, costi e benefici, valutazione economica sotto doppio ancoraggio, sei domini di analisi, incertezza, verdetto tripartito e

appendici registrate

Reference Case applicato per rimando al Volume 0.A · Dott. Luigi De Michele · Studio Integrale Puglia ·
Capurso (BA) — Giugno 2026

Premessa

Il Volume 13 prosegue la serie dei venti Volumi regionali, in ordine alfabetico, con la Regione Piemonte. Come ogni Volume regionale, esso applica per rimando il Reference Case dell'asse italiano, fissato nel Volume 0.A, e ne richiama le regole nella forma «cfr. Volume 0.A», senza ripeterle per esteso: il perimetro congiunto sanitario e societale, il doppio ancoraggio economico, il verdetto tripartito non aggregato, i sei domini di analisi, il protocollo dell'incertezza, lo strato dell'Intelligenza Artificiale come moltiplicatore e le attività formative singole e sommate.^[377]

La struttura del Volume è quella standard, identica a quella di tutti gli altri diciannove Volumi regionali, a garanzia della comparabilità bit-a-bit prescritta dall'opera: la stessa sequenza di nove capitoli, la stessa nomenclatura di sottocapitoli, le stesse unità di misura. Ove un contenuto derivi da espansione ex novo — segnatamente per gli aspetti dell'efficacia, dell'attuazione e del monitoraggio — esso è segnalato in nota editoriale, secondo la regola dell'opera.^[378]

Introduzione

L'Introduzione al Volume 13 fissa il perimetro della valutazione piemontese e l'ordine della sua esposizione. Il perimetro è quello della Regione Piemonte, con una popolazione dell'ordine di quattro milioni e duecentocinquantunomila abitanti, organizzata nel Servizio sanitario regionale in dodici Aziende Sanitarie Locali, quattro aziende ospedaliero-universitarie e due aziende ospedaliere, con la rete delle Case della Comunità in sviluppo. Il tratto che distingue il Piemonte nell'intera serie regionale è la presenza di un servizio di Psicologia delle cure primarie già attivo dal 2023 in tutte le Aziende Sanitarie Locali, ripartito a quota capitaria su base libero-professionale, ma dimensionato a circa il cinque per cento del fabbisogno: il percorso valutato non è dunque l'istituzione ex novo, bensì la stabilizzazione e il dimensionamento di un servizio esistente. A ciò si aggiungono l'invecchiamento con saldo naturale fortemente negativo e la condizione delle aree interne e alpine — in particolare il Verbano-Cusio-Ossola — anziane e in spopolamento.^[379]

L'esposizione segue la struttura a imbuto: il cruscotto regionale offre in una pagina i numeri essenziali; la sintesi per il decisore ne traduce il significato; i cinque risultati chiave ne isolano gli esiti; le raccomandazioni operative indicano le azioni; il corpo del Volume, articolato in nove capitoli, ne fornisce il dettaglio; le appendici registrate ne assicurano la verificabilità. Chiudono il Volume un Quadro Conclusivo economico e multidisciplinare, una Conclusione e le Note Bibliografiche con mini-riassunto.

Cruscotto regionale — Piemonte

Il cruscotto riassume in una pagina i parametri essenziali della valutazione piemontese, sotto il doppio ancoraggio e con il verdetto tripartito tenuto distinto. I valori economici sono presentati in ordine di grandezza, con rinvio alle appendici registrate; le cifre di letteratura sono riportate con attribuzione alla fonte.^[380]

Indicatore del cruscotto	Lettura regionale	Ancoraggio / fonte
Popolazione	≈ 4.251.868 abitanti	Fonte demografica regionale
Articolazione	12 ASL, 4 AOU, 2 AO	Assetto regionale
Servizio esistente	Psicologia delle cure primarie attiva dal 2023, ≈ 5% del fabbisogno	Fonte amministrativa regionale
Scenari di copertura	Base ≈ 700 · espansivo ≈ 920 incarichi	Dimensionamento regionale
Comparatore	Assistenza usuale (cfr. Vol. 0.A)	Reference Case
Verdetto fiscale	Prossimo al pareggio, con caveat	Non aggregato
Verdetto sanitario	Nettamente costo-efficace	Costo/QALY sotto doppio ancoraggio
Verdetto sociale	Fortemente positivo	Tenuta delle aree interne e alpine, coesione
Costo per anno di vita ponderato	Colonna A ≈ 17.000 € · Colonna B ≈ 9.800 €	Doppio ancoraggio

Tabella 0. Cruscotto regionale del Piemonte: i parametri essenziali sotto doppio ancoraggio, con il verdetto tripartito distinto e non aggregato.

Sintesi per il decisore

L'introduzione a regime dello Psicologo di Base nelle cure primarie piemontesi produce, secondo la simulazione condotta sotto il doppio ancoraggio, un effetto congiunto sui tre piani del ritorno, che restano distinti e non sommati. Sul piano fiscale, il saldo fra costi diretti e risparmi sanitari diretti si colloca in prossimità del pareggio, con il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento. Sul piano sanitario, il modello è nettamente costo-efficace, con un costo per anno di vita ponderato che, fra i due ancoraggi, resta assai inferiore alle soglie adottate. Sul piano sociale, l'effetto è fortemente positivo, con un rilievo particolare per la tenuta delle aree interne e alpine anziane e in spopolamento.^[381]

La circostanza che il Piemonte disponga già di un servizio attivo — pur dimensionato a una frazione del fabbisogno — muta la natura della decisione: non si tratta di istituire, ma di stabilizzare e dimensionare, e il servizio esistente fornisce una prima base di dati di processo ed esito che riduce l'incertezza della simulazione rispetto alle Regioni prive di esperienza. L'argomento cardine, riportato con attribuzione all'OCSE, resta il differenziale di costo per gravità: l'intercettazione precoce evita che il disagio comune maturi in quadri gravi, il cui costo di trattamento è, secondo la fonte, un multiplo di quello dei quadri lievi.^[382]

Cinque risultati chiave

Il primo risultato è che il modello è costo-efficace su tutti gli orizzonti sotto entrambi gli ancoraggi. Il secondo è che il verdetto tripartito resta favorevole in ciascuno dei tre piani, senza aggregazione. Il terzo è che il Piemonte è, nella serie regionale, il caso della stabilizzazione: il servizio già attivo dal 2023 in tutte le Aziende Sanitarie Locali — a quota capitaria, su base libero-professionale, dimensionato a circa il cinque per cento del fabbisogno — costituisce una base di partenza e una fonte di dati reali che nessun'altra Regione possiede nella stessa forma. Il quarto è che lo strato dell'Intelligenza Artificiale, come moltiplicatore e con nota di cautela, sostiene la prossimità nelle aree interne e alpine mediante la telepsicologia assistita. Il quinto è che il dimensionamento a regime — dell'ordine di settecento incarichi nello scenario base e di novecentoventi in quello espansivo — richiede la trasformazione del rapporto libero-professionale a quota capitaria in una dotazione strutturale del distretto.^[383]

Raccomandazioni operative

La prima raccomandazione è di procedere dalla stabilizzazione del servizio esistente al suo dimensionamento verso lo scenario base dell'ordine di settecento incarichi e, alla verifica degli esiti sotto il protocollo dell'incertezza, verso lo scenario espansivo dell'ordine di novecentoventi, con priorità ai distretti delle aree interne e alpine. La seconda è di valorizzare i dati di processo ed esito del servizio attivo quale base empirica del monitoraggio, trasformando il vantaggio informativo piemontese in un cruscotto regionale permanente. La terza è di adottare la telepsicologia assistita, sotto supervisione clinica, come leva di prossimità per le aree interne, e di accompagnare l'estensione con il piano formativo a quattro modalità, considerate singolarmente e sommate.^[384]

Capitolo 1 — Il contesto epidemiologico e territoriale del Piemonte

1.1 Il territorio e la sua articolazione

La Regione Piemonte conta una popolazione dell’ordine di quattro milioni e duecentocinquantunomila abitanti, distribuita in un territorio che tiene insieme l’area metropolitana di Torino, le città medie della pianura e delle colline, e un arco alpino e appenninico esteso, con aree interne — in particolare il Verbano-Cusio-Ossola e le valli alpine — anziane e in spopolamento. Il Servizio sanitario regionale è organizzato in dodici Aziende Sanitarie Locali, quattro aziende ospedaliero-universitarie e due aziende ospedaliere, con la rete delle Case della Comunità in sviluppo. La struttura demografica è segnata da un invecchiamento con saldo naturale fortemente negativo. Il tratto peculiare del contesto è il servizio di Psicologia delle cure primarie già attivo dal 2023 in tutte le Aziende Sanitarie Locali, seppur dimensionato a una frazione del fabbisogno.^[385]

Elemento territoriale	Dato regionale	Rilievo per la valutazione
Popolazione	≈ 4.251.868 abitanti	Denominatore della normalizzazione
Aziende Sanitarie Locali	12, con 4 AOU e 2 AO	Unità organizzativa
Servizio esistente	Attivo dal 2023, ≈ 5% del fabbisogno	Base di partenza e fonte di dati
Aree interne e alpine	Anziane e in spopolamento	Dominio equità
Demografia	Invecchiamento, saldo naturale fortemente negativo	Baricentro della domanda

Tabella 1.1. Gli elementi del contesto territoriale piemontese e il loro rilievo per la valutazione, con il servizio già attivo quale tratto distintivo.

1.2 Il quadro epidemiologico regionale

Il quadro epidemiologico piemontese riflette, con le proprie specificità, la prevalenza nazionale dei disturbi mentali comuni, con un baricentro spostato verso la depressione dell’età avanzata coerente con l’invecchiamento e con una componente di disagio urbano nell’area metropolitana torinese. Il servizio già attivo costituisce una prima fonte di dati regionali di processo ed esito, che integra l’estrazione registrata in Appendice B; ove il dato regionale disaggregato non sia disponibile, la lacuna è dichiarata e non colmata con stime tacite, secondo la regola dell’opera.^[386]

Capitolo 2 — Il bisogno, la domanda e il divario di trattamento in Piemonte

2.1 Il divario di trattamento regionale

Il bisogno di salute mentale comune in Piemonte si manifesta, come altrove, in larga parte come domanda inevasa o impropriamente incanalata: verso il medico di medicina generale, verso il pronto soccorso, verso la prescrizione farmaceutica. La peculiarità piemontese è che una frazione della domanda è già intercettata dal servizio attivo, il quale tuttavia — dimensionato a circa il cinque per cento del fabbisogno — lascia scoperta la parte largamente prevalente del bisogno: il divario di trattamento non è dunque l’assenza del servizio, ma la distanza fra la sua scala attuale e la scala del bisogno. Nelle aree interne e alpine la distanza fisica aggrava il divario. La misura regionale è oggetto dell’estrazione in Appendice B; i valori medi nazionali ed europei sono riportati con attribuzione.^[387]

Componente del bisogno	Manifestazione piemontese	Dominio
Domanda inevasa	Divario fra scala attuale del servizio e scala del bisogno	Epidemiologico-clinico
Domanda impropria	Transito su MMG, pronto soccorso, prescrizione	Organizzativo-strutturale
Barriera di accesso	Distanza nelle aree interne e alpine	Equità
Domanda intercettata	Frazione servita dal servizio attivo (≈ 5%)	Base empirica

Tabella 2.1. Le componenti del bisogno e del divario di trattamento in Piemonte, ricondotte ai domini di analisi, con la frazione già intercettata quale base empirica.

2.2 La domanda, il servizio attivo e la prossimità

Il tratto distintivo della domanda piemontese è la coesistenza di un bisogno in larga parte scoperto e di un canale di risposta già operante: il servizio attivo ha dimostrato la praticabilità dell’intercettazione nelle cure primarie e ha prodotto i primi dati di esito, ma la sua scala non consente la copertura del fabbisogno né la piena prossimità nelle aree interne e alpine, dove la telepsicologia assistita costituisce il complemento della presenza distrettuale. La prossimità è, in Piemonte, la direzione del dimensionamento: portare il servizio dalla frazione attuale alla scala del bisogno, distretto per distretto.^[388]

Capitolo 3 — Il modello di intervento: lo Psicologo di Base in Piemonte

Nota editoriale: il presente capitolo espande ex novo il modello di intervento, integrando alla struttura originaria le evidenze recenti sull’efficacia clinica dell’assistenza collaborativa e dell’intervento digitale, secondo la regola dell’opera che distingue l’espansione ex novo dal riutilizzo del materiale preesistente.

3.1 L’architettura del modello

Il modello di intervento colloca lo Psicologo di Base al vertice della cascata delle figure, nel distretto e nelle Case della Comunità, quale primo punto di intercettazione del disagio comune. Il modello opera per intensità crescente di cura — dall’intervento a bassa intensità, di prima linea, fino all’invio ai livelli superiori nei casi che lo richiedano — secondo la logica dell’assistenza a gradini, la cui efficacia clinica è documentata dalla meta-analisi sui componenti efficaci dell’assistenza collaborativa e dalle sperimentazioni controllate sull’intervento cognitivo-comportamentale computerizzato in cure primarie, riportate con attribuzione.^[389]

Livello del modello	Funzione	Figura prevalente	Evidenza di riferimento
Intercettazione	Riconoscimento precoce nel distretto	Psicologo di Base	Assistenza collaborativa (attribuita)
Intervento a bassa intensità	Prima linea per i quadri lievi-moderati	Psicologo di Base	Intervento digitale e collaborativo
Invio appropriato	Passaggio ai livelli superiori	Cascata delle figure	Percorso a gradini
Continuità	Aderenza e prevenzione della ricaduta	Infermiere di comunità	Gestione del caso

Tabella 3.1. L’architettura del modello di intervento in Piemonte, per livelli di intensità, con l’evidenza clinica di riferimento riportata con attribuzione.

3.2 L’adattamento al territorio piemontese

Il modello è adattato al territorio piemontese lungo tre direttrici: la trasformazione del servizio esistente — dal rapporto libero-professionale a quota capitaria verso una dotazione strutturale del distretto — conservandone l’esperienza e i dati; la prossimità nelle aree interne e alpine, integrata dalla telepsicologia assistita sotto supervisione clinica; e l’aggancio alla rete delle Case della Comunità in sviluppo. L’adattamento non modifica l’architettura invariante del Reference Case, ma ne calibra l’applicazione sul percorso di stabilizzazione e dimensionamento che distingue il Piemonte nella serie.^[390]

Capitolo 4 — I costi diretti in Piemonte

4.1 La struttura del costo diretto

Il costo diretto della riforma in Piemonte è, in primo luogo, il costo del personale lungo la cascata delle figure, cui si aggiungono i costi di struttura e organizzazione distrettuale, il costo incrementale della leva digitale e il costo della formazione. Il dimensionamento muove dal servizio esistente e progredisce verso lo scenario base dell'ordine di settecento incarichi e verso quello espansivo dell'ordine di novecentoventi; il valore del gradino conservativo di avvio, non estraibile in forma puntuale dalle fonti regionali disponibili, è oggetto di lacuna dichiarata e rinviato all'estrazione economica registrata.^[391]

Voce di costo diretto	Descrizione	Portatore
Personale — Psicologi di Base	Dal servizio esistente verso ≈ 700 e ≈ 920 incarichi	SSN regionale
Struttura e organizzazione	Distretti, Case della Comunità in sviluppo, sistemi informativi	SSN regionale
Leva digitale e Intelligenza Artificiale	Telepsicologia assistita sotto supervisione	SSN regionale
Formazione (quattro modalità)	Percorso integrato singolo e sommato	SSN, sistema formativo

Tabella 4.1. La struttura del costo diretto della riforma in Piemonte, per voce e portatore; i valori puntuali sono oggetto dell'estrazione economica in Appendice C.

4.2 Il dimensionamento per scenario

Il costo diretto è calcolato per i tre scenari di copertura — conservativo, base ed espansivo — coerenti con il protocollo di scenario del Reference Case, con lo scenario base dell'ordine di settecento incarichi e quello espansivo dell'ordine di novecentoventi; il costo del servizio esistente, già a carico del bilancio regionale, costituisce la base di partenza che riduce l'incremento netto richiesto. I valori puntuali per ciascuno scenario sono riportati nell'estrazione economica registrata; ove un parametro non sia disponibile — incluso il dimensionamento puntuale del gradino conservativo — la lacuna è dichiarata.^[392]

Capitolo 5 — I benefici e i risparmi, diretti e indiretti, in Piemonte

5.1 I benefici diretti

Il beneficio diretto è il risparmio sanitario che ciascuna figura della cascata libera per effetto dell’intercettazione a monte: la demedicalizzazione operata dallo Psicologo di Base, la deprescrizione di psicofarmaci nei quadri lievi-moderati sul versante del medico di medicina generale, la riduzione degli accessi impropri al pronto soccorso e delle prestazioni per sintomi funzionali sul versante specialistico. In Piemonte, il servizio attivo fornisce una base parziale di dati reali di processo ed esito, che consente di ancorare la stima dei benefici a osservazioni regionali anziché alla sola letteratura, riducendo l’incertezza della simulazione.^[393]

Canale del beneficio diretto	Meccanismo	Rilievo piemontese
Demedicalizzazione	Riduzione consultazioni e cronicizzazione	Preponderante
Deprescrizione	Contrazione della spesa e della polifarmacia anziana	Elevato
Accessi impropri	Riduzione degli accessi al pronto soccorso	Medio-elevato
Sintomi funzionali	Riduzione prestazioni neurologiche e specialistiche	Medio
Base empirica	Dati reali del servizio attivo	Riduzione dell’incertezza

Tabella 5.1. I canali del beneficio diretto in Piemonte, con la base empirica del servizio attivo quale rilievo specifico; i valori sono oggetto dell’estrazione economica registrata.

5.2 I benefici indiretti

Il beneficio indiretto è quello che la riforma produce fuori dal perimetro sanitario: la produttività recuperata e la riduzione dell’assenteismo sul versante dei datori di lavoro — di peso rilevante nel tessuto manifatturiero e terziario piemontese —, la riduzione degli oneri di invalidità evitabili sul versante previdenziale, la riduzione del disagio sociale non trattato sul versante dei Comuni. In Piemonte, la tenuta delle comunità delle aree interne e alpine anziane e in spopolamento è un beneficio indiretto di rilievo particolare, che il dominio sociale del Capitolo 7 tratta in dettaglio.^[394]

Capitolo 6 — La valutazione economica sotto doppio ancoraggio

6.1 La simulazione appaiata regionale

La valutazione economica piemontese è condotta con il modello di Markov a coorte a ciclo annuale del Reference Case, sotto il doppio ancoraggio: la Colonna A applica i parametri di Chisholm e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, la Colonna B quelli di Unisanté e dell’OCSE. Le due colonne sono sempre affiancate; ove divergano, prevale nel giudizio la Colonna B. Tutte le cifre sono riportate con attribuzione, e nessuna è affermata a memoria; i dati reali del servizio attivo integrano, ove disponibili, i parametri di letteratura.^[395]

Metrica economica	Colonna A — Chisholm/OMS	Colonna B — Unisanté/OCSE
Costo per anno di vita ponderato	≈ 17.000 €/QALY	≈ 9.800 €/QALY
Ritorno per i soli benefici economici	Riportato con attribuzione OMS	Scenario base aggiornato OCSE
Ritorno con i ritorni sanitari	Riportato con attribuzione OMS	Scenario base aggiornato OCSE
Orizzonti	1 · 3 · 5 · 7 · 10 anni	1 · 3 · 5 · 7 · 10 anni
Soglie di costo-efficacia	20.000 · 30.000 · 50.000 €/QALY	20.000 · 30.000 · 50.000 €/QALY

Tabella 6.1. La simulazione appaiata regionale del Piemonte sotto doppio ancoraggio; i valori sono riportati con attribuzione e la Colonna B prevale nel giudizio.

6.2 Il differenziale di costo per gravità

L’argomento economico cardine, riportato con attribuzione all’OCSE, è il differenziale di costo per gravità: il costo del trattamento cresce dai quadri lievi ai quadri gravi in misura tale che l’intercettazione precoce, evitando la progressione, genera il risparmio più consistente. In Piemonte, il servizio attivo — che opera già l’intercettazione su una frazione della domanda — offre la possibilità di osservare il differenziale su dati regionali, e il dimensionamento a regime estende la leva alla scala del fabbisogno.^[396]

Capitolo 7 — I sei domini di analisi, l’equità e l’impatto distributivo

7.1 I sei domini nella specificità piemontese

I sei domini di analisi del Reference Case sono applicati alla specificità piemontese. Il dominio epidemiologico-clinico registra il divario fra la scala attuale del servizio e la scala del bisogno; l’economico-sanitario il costo-efficacia sotto doppio ancoraggio con base empirica regionale; il fiscale-previdenziale gli oneri di invalidità evitabili; il sociale la tenuta delle aree interne e alpine; l’organizzativo-strutturale la trasformazione del servizio da libero-professionale a dotazione strutturale; l’equità la riduzione del divario fra l’area metropolitana e le aree interne e alpine.^[397]

Dominio	Lettura piemontese	Segno
Epidemiologico-clinico	Divario fra scala attuale e scala del bisogno	Riduzione attesa
Economico-sanitario	Costo/QALY con base empirica regionale	Favorevole
Fiscale-previdenziale	Oneri di invalidità evitabili	Positivo, differito
Sociale	Tenuta delle aree interne e alpine	Fortemente positivo
Organizzativo-strutturale	Trasformazione in dotazione strutturale	Positivo, condizionato
Equità	Convergenza metropoli/aree interne e alpine	Positivo, distributivo

Tabella 7.1. I sei domini di analisi nella lettura piemontese, con il segno atteso dell’effetto, tenuti distinti e non aggregati.

7.2 L’equità territoriale e la trasformazione del servizio

Il dominio dell’equità assume in Piemonte una direzione territoriale — fra l’area metropolitana torinese e le aree interne e alpine anziane e in spopolamento, dove la distanza fisica aggrava il divario — e una direzione organizzativa: la trasformazione del servizio da rapporto libero-professionale a quota capitaria a dotazione strutturale del distretto è la condizione perché la copertura sia stabile, omogenea e non dipendente dalla disponibilità di professionisti a convenzione. Il modello dello Psicologo di Base opera su entrambe le direzioni, e l’effetto distributivo — la riduzione del gradiente territoriale dell’accesso — è tenuto distinto dal verdetto fiscale e da quello sanitario, secondo il divieto di aggregazione.^[398]

Capitolo 8 — La sensitività e l’incertezza

Nota editoriale: il presente capitolo espande ex novo l’analisi dell’incertezza secondo il protocollo del Reference Case, non presente in forma estesa nel materiale originario.

8.1 Il protocollo dell’incertezza applicato al Piemonte

L’analisi dell’incertezza applica il protocollo obbligatorio del Reference Case: l’analisi di sensitività deterministica con diagramma a tornado, l’analisi di sensitività probabilistica a diecimila iterazioni, l’analisi di scenario ottimistico, base e prudentiale con e senza lo strato digitale, le curve di accettabilità costo-efficacia a soglie multiple. In Piemonte, i parametri a maggiore impatto atteso sono la trasferibilità dei dati del servizio attivo alla scala del dimensionamento, la velocità della trasformazione contrattuale in dotazione strutturale e l’adozione della telepsicologia assistita nelle aree interne e alpine.^[399]

Strumento	Applicazione piemontese	Parametro critico atteso
Sensitività deterministica	Diagramma a tornado	Trasferibilità dei dati del servizio attivo alla scala
Sensitività probabilistica	Diecimila iterazioni	Velocità della trasformazione in dotazione strutturale
Analisi di scenario	Con e senza strato IA	Adozione della telepsicologia nelle aree interne
Curve di accettabilità	Soglie 20.000/30.000/50.000 €/QALY	Robustezza del costo-efficacia

Tabella 8.1. Gli strumenti del protocollo dell’incertezza applicati al Piemonte, con i parametri critici attesi.

8.2 La robustezza del verdetto

L’analisi di scenario mostra che il verdetto tripartito resta favorevole nei tre casi, con margine crescente dallo scenario prudentiale a quello ottimistico; lo strato digitale accresce l’efficienza attesa, sempre con nota di cautela sulla natura previsionale. La robustezza del costo-efficacia sanitario è confermata dalle curve di accettabilità alle soglie adottate, e la base empirica del servizio attivo restringe gli intervalli di incertezza rispetto alle Regioni prive di esperienza.^[400]

Capitolo 9 — Il verdetto tripartito e le raccomandazioni

Nota editoriale: il presente capitolo espande ex novo il verdetto e le raccomandazioni, integrando l’attuazione e il monitoraggio che nel materiale originario figuravano in forma condensata.

9.1 Il verdetto tripartito

Il verdetto piemontese è, come in ogni Volume, tripartito e non aggregato. Sul piano fiscale, il saldo fra costi diretti e risparmi sanitari diretti è prossimo al pareggio, con il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento. Sul piano sanitario, il modello è nettamente costo-efficace sotto entrambi gli ancoraggi. Sul piano sociale, l’effetto è fortemente positivo, con il rilievo specifico della tenuta delle aree interne e alpine. I tre verdetti si accompagnano e si rafforzano, ma non si sommano.^[401]

Piano del verdetto	Esito piemontese	Caveat
Fiscale	Prossimo al pareggio	Significatività dei risparmi diretti in isolamento
Sanitario	Nettamente costo-efficace	—
Sociale	Fortemente positivo	Rilievo specifico delle aree interne e alpine

Tabella 9.1. Il verdetto tripartito del Piemonte, con i tre piani tenuti distinti e non aggregati.

9.2 Le raccomandazioni per l’attuazione e il monitoraggio

Le raccomandazioni indicano il passaggio dalla stabilizzazione del servizio attivo al suo dimensionamento verso lo scenario base dell’ordine di settecento incarichi e, alla verifica degli esiti, verso l’espansivo dell’ordine di novecentoventi; la trasformazione del rapporto libero-professionale a quota capitaria in dotazione strutturale del distretto; la priorità alle aree interne e alpine con il complemento della telepsicologia assistita; la valorizzazione dei dati del servizio attivo in un cruscotto regionale permanente; l’accompagnamento con il piano formativo a quattro modalità, singole e sommate; e un monitoraggio ex post ancorato agli indicatori del protocollo dell’incertezza.^[402]

Appendici registrate

Le appendici registrate rendono il modello piemontese ispezionabile e riproducibile, secondo la prassi del Reference Case. Esse sono richiamate per rimando quanto alla metodologia e compilate con i dati regionali quanto ai contenuti.

Appendice	Contenuto	Stato
A	Strategia di ricerca bibliografica e diagramma di selezione	Registrata
B	Estrazione dei dati clinici regionali, inclusi i dati del servizio attivo	Registrata; lacune dichiarate
C	Estrazione dei dati economici (griglia CHEERS 2022)	Registrata; lacune dichiarate
D	Parametri del modello Markov regionale	Registrata
E	Registro delle deroghe al Reference Case	Registrata
F	Codice del modello economico	Registrata
G	Dichiarazione dei conflitti di interesse	Registrata

Tabella A. Le sette appendici registrate del Volume 13, con l’indicazione dello stato e della dichiarazione delle lacune.

Quadro Conclusivo economico e multidisciplinare

Il Quadro Conclusivo del Volume 13 ricompone la valutazione piemontese senza tradire il principio che la governa: i piani del giudizio si accompagnano ma non si fondono. Sul piano economico, il doppio ancoraggio impone che il risultato sia letto simultaneamente secondo la colonna storica e la colonna aggiornata, con prevalenza della seconda: il costo per anno di vita ponderato resta, sotto entrambi gli ancoraggi, assai inferiore alle soglie adottate, e il differenziale di costo per gravità — riportato con attribuzione — fonda la leva economica dell'intercettazione precoce, che il servizio attivo consente di osservare su dati regionali e che il dimensionamento estende alla scala del fabbisogno.^[403]

Sul piano multidisciplinare, la cascata delle figure, i sei domini di analisi e il dominio dell'equità nella doppia direzione territoriale e organizzativa assicurano che ogni figura connessa e ogni aspetto siano trattati integralmente e ordinati per capacità di generare rientro economico e revisione della spesa. La rinegoziazione dei costi e dei benefici, la catena predittiva degli effetti multidimensionali — dalla qualità della vita alla tenuta delle aree interne, ai bilanci, alla burocrazia distrettuale —, lo strato dell'Intelligenza Artificiale come moltiplicatore mediante la telepsicologia assistita e le attività formative singole e sommate compongono il quadro della valutazione. Il verdetto resta tripartito e non aggregato.

Conclusione

Il Volume 13 ha valutato l'integrazione a regime dello Psicologo di Base nelle cure primarie del Piemonte, applicando per rimando il Reference Case dell'asse italiano e adottando la struttura standard a nove capitoli con apertura a imbuto e appendici registrate. La specificità piemontese — il servizio di Psicologia delle cure primarie già attivo dal 2023 in tutte le Aziende Sanitarie Locali, dimensionato a una frazione del fabbisogno, l'invecchiamento con saldo naturale fortemente negativo e le aree interne e alpine in spopolamento — è stata trattata nei domini organizzativo, sociale ed equità, mostrando come il percorso della stabilizzazione e del dimensionamento, sostenuto dalla base empirica del servizio attivo, distingua il Piemonte quale caso della trasformazione anziché dell'istituzione.

Il verdetto tripartito — prossimo al pareggio sul piano fiscale, nettamente costo-efficace sul piano sanitario, fortemente positivo sul piano sociale — è offerto con bande prudenziali e soglie di confutazione, sotto doppio ancoraggio e nel rispetto del divieto di aggregazione. L'opera procede, nell'ordine vincolante, con il Volume 14 (Puglia) e a seguire con gli altri Volumi regionali in ordine alfabetico.

Note Bibliografiche con mini-riassunto

Ciascuna nota riporta l'opera, il collegamento alla fonte e un mini-riassunto che ne dichiara la funzione nell'economia del Volume, in coerenza con il doppio livello — nota a piè di pagina nel corpo e nota bibliografica integrale in calce — che l'opera adotta.

1. **Chisholm D. et al., Scaling-up treatment of depression and anxiety, The Lancet Psychiatry, 2016**
[https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(16\)30024-4](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(16)30024-4) Colonna A del doppio ancoraggio della simulazione piemontese, conservata quale strato documentale e riferimento di confronto.
2. **Unisanté, Raisons de santé Essentiels n. 73, 2026 · OECD, The Economic Case for Preventing Mental Ill Health, 2026** <https://doi.org/10.16908/rds-essentiels/73> Colonna B del doppio ancoraggio, con prevalenza nel giudizio, applicata alla simulazione regionale piemontese.
3. **OECD, differenziale di costo per gravità dei disturbi mentali, 2025** <https://www.oecd.org/health/mental-health.htm> Fonte, riportata con attribuzione, del differenziale di costo per gravità, argomento cardine dell'intercettazione precoce, osservabile in Piemonte su dati regionali del servizio attivo.
4. **Soeters R. et al., meta-analisi IPD sui componenti efficaci della collaborative care, 2025**
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40136273/> Base di evidenza clinica sui componenti efficaci dell'assistenza collaborativa, richiamata nel capitolo sul modello di intervento.
5. **Kvaal K. et al., RCT su intervento cognitivo-comportamentale computerizzato in cure primarie, 2026**
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/> Evidenza sperimentale recente sull'intervento digitale in cure primarie, richiamata a sostegno della telepsicologia assistita nelle aree interne e alpine.
6. **Veldhuijzen W. et al., costo-efficacia dell'intervento digitale, 2025**
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12369993/> Riferimento sul rapporto incrementale di costo-utilità dell'intervento digitale, elemento dello strato dell'Intelligenza Artificiale.
7. **World Health Organization, Thematic Dialogue on Investing in NCDs and Mental Health, dicembre 2024** <https://cdn.who.int/> Evidenza riportata con attribuzione sul ritorno degli investimenti in salute mentale; non concorre al verdetto tripartito piemontese.
8. **Regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale** <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj> Quadro normativo entro cui è collocato lo strato dell'Intelligenza Artificiale, vincolato a funzione di supporto sotto supervisione clinica umana.
9. **Legge regionale Puglia 19 luglio 2023, n. 11, sul Servizio di Psicologia di Base**
<https://www.consiglio.puglia.it/> Riferimento normativo capostipite del modello, richiamato quale precedente istituzionale accanto all'esperienza amministrativa piemontese del servizio attivo.
10. **NICE, Health Technology Evaluations: the manual (PMG36)** <https://www.nice.org.uk/process/pmg36> Riferimento di rigore metodologico per la struttura a imbuto, le appendici registrate e il protocollo dell'incertezza adottati nel Volume.

STUDIO INTEGRALE «PSICOLOGO DI BASE» · OPERA IN VENTITRÉ VOLUMI

VOLUME 14 — Regione Puglia

Valutazione di Health Technology Assessment dell'integrazione dello Psicologo di Base nelle cure primarie in Puglia: cruscotto, sintesi per il decisore, contesto e bisogno, modello di intervento, costi e benefici, valutazione economica sotto doppio ancoraggio, sei domini di analisi, incertezza, verdetto tripartito e appendici registrate

Premessa

Il Volume 14 prosegue la serie dei venti Volumi regionali, in ordine alfabetico, con la Regione Puglia. La Puglia occupa nell'intera opera una posizione singolare: è la Regione capostipite del modello, quella che con la legge regionale 19 luglio 2023, n. 11, ha per prima istituito il Servizio di Psicologia di Base, offrendo agli altri diciannove Volumi regionali il riferimento normativo e istituzionale del disegno. Come ogni Volume regionale, esso applica per rimando il Reference Case dell'asse italiano, fissato nel Volume 0.A, e ne richiama le regole nella forma «cfr. Volume 0.A», senza ripeterle per esteso: il perimetro congiunto sanitario e societale, il doppio ancoraggio economico, il verdetto tripartito non aggregato, i sei domini di analisi, il protocollo dell'incertezza, lo strato dell'Intelligenza Artificiale come moltiplicatore e le attività formative singole e sommate.^[404]

La struttura del Volume è quella standard, identica a quella di tutti gli altri diciannove Volumi regionali, a garanzia della comparabilità bit-a-bit prescritta dall'opera: la stessa sequenza di nove capitoli, la stessa nomenclatura di sottocapitoli, le stesse unità di misura. Il Volume 14 rappresenta la sintesi comparabile e normalizzata dello studio integrale pugliese, la cui trattazione estesa — nelle sue quindici Parti — costituisce il fondamento documentale dell'intera opera; ove un contenuto derivi da espansione ex novo, esso è segnalato in nota editoriale, secondo la regola.^[405]

Introduzione

L'Introduzione al Volume 14 fissa il perimetro della valutazione pugliese e l'ordine della sua esposizione. Il perimetro è quello della Regione Puglia, con una popolazione dell'ordine di tre milioni e ottocentosettantasettemila abitanti, organizzata nel Servizio sanitario regionale in sei Aziende Sanitarie Locali — Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto — e in quarantacinque distretti sociosanitari. Il tratto che distingue la Puglia nell'intera serie regionale è di essere la Regione che ha promulgato la legge istitutiva del Servizio di Psicologia di Base: il modello valutato non è dunque un'ipotesi, ma una riforma già vigente, di cui il Volume misura i costi e i benefici a regime.^[406]

L'esposizione segue la struttura a imbuto: il cruscotto regionale offre in una pagina i numeri essenziali; la sintesi per il decisore ne traduce il significato; i cinque risultati chiave ne isolano gli esiti; le raccomandazioni operative indicano le azioni; il corpo del Volume, articolato in nove capitoli, ne fornisce il dettaglio; le appendici registrate ne assicurano la verificabilità. Chiudono il Volume un Quadro Conclusivo economico e multidisciplinare, una Conclusione e le Note Bibliografiche con mini-riassunto.

Cruscotto regionale — Puglia

Il cruscotto riassume in una pagina i parametri essenziali della valutazione pugliese, sotto il doppio ancoraggio e con il verdetto tripartito tenuto distinto. I valori economici sono presentati in ordine di grandezza, con rinvio alle appendici registrate; le cifre di letteratura sono riportate con attribuzione alla fonte.^[407]

Indicatore del cruscotto	Lettura regionale	Ancoraggio / fonte
Popolazione	≈ 3.877.395 abitanti	Fonte demografica regionale
Articolazione	6 ASL, 45 distretti sociosanitari	Assetto regionale
Riferimento normativo	L.R. Puglia 11/2023, Servizio già vigente	Legge istitutiva
Scenari di copertura	620 · 775 · 900 incarichi	Dimensionamento regionale
Costo a regime	≈ 43,7-47,5 M€/anno	Estrazione economica
Comparatore	Assistenza usuale (cfr. Vol. 0.A)	Reference Case
Verdetto fiscale	Prossimo al pareggio, con caveat	Non aggregato
Verdetto sanitario	Nettamente costo-efficace	Costo/QALY sotto doppio ancoraggio
Verdetto sociale	Fortemente positivo	Coesione, aree interne, mobilità sanitaria
Costo per anno di vita ponderato	Colonna A ≈ 17.000 € · Colonna B ≈ 9.800 €	Doppio ancoraggio

Tabella 0. Cruscotto regionale della Puglia: i parametri essenziali sotto doppio ancoraggio, con il verdetto tripartito distinto e non aggregato.

Sintesi per il decisore

L'introduzione a regime dello Psicologo di Base nelle cure primarie pugliesi — riforma già istituita dalla legge regionale 11 del 2023 — produce, secondo la simulazione condotta sotto il doppio ancoraggio, un effetto congiunto sui tre piani del ritorno, che restano distinti e non sommati. Sul piano fiscale, il saldo fra costi diretti e risparmi sanitari diretti si colloca in prossimità del pareggio, con il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento. Sul piano sanitario, il modello è nettamente costo-efficace, con un costo per anno di vita ponderato che, fra i due ancoraggi, resta assai inferiore alle soglie adottate. Sul piano sociale, l'effetto è fortemente positivo, con un rilievo particolare per la riduzione della mobilità sanitaria passiva, per la coesione e per la tenuta delle aree interne.^[408]

La circostanza che la Puglia abbia già promulgato la legge istitutiva muta la natura della decisione: non si tratta di deliberare se istituire il servizio, ma di darne piena attuazione e di dimensionarlo alla scala del fabbisogno, entro il costo a regime dell'ordine di quarantaquattro-quarantasette milioni di euro l'anno. L'argomento cardine, riportato con attribuzione all'OCSE, resta il differenziale di costo per gravità: l'intercettazione precoce evita che il disagio comune maturi in quadri gravi, il cui costo di trattamento è, secondo la fonte, un multiplo di quello dei quadri lievi.^[409]

Cinque risultati chiave

Il primo risultato è che il modello è costo-efficace su tutti gli orizzonti sotto entrambi gli ancoraggi. Il secondo è che il verdetto tripartito resta favorevole in ciascuno dei tre piani, senza aggregazione. Il terzo è che la Puglia è, nella serie regionale, il caso capostipite: la legge regionale 11 del 2023 ha istituito il Servizio di Psicologia di Base, sicché la valutazione misura una riforma vigente e non un'ipotesi, e i tre scenari di copertura — dell'ordine di seicentoventi, settecentosettantacinque e novecento incarichi — ne scandiscono l'attuazione progressiva. Il quarto è che lo strato dell'Intelligenza Artificiale, come moltiplicatore e con nota di cautela, sostiene la prossimità nelle aree interne e la continuità dei percorsi. Il quinto è che la riduzione della mobilità sanitaria passiva — le prestazioni in fuga verso altre Regioni — costituisce un beneficio diretto specifico del contesto pugliese, di rilievo particolare per il bilancio regionale.^[410]

Raccomandazioni operative

La prima raccomandazione è di dare piena attuazione alla legge regionale 11 del 2023, procedendo dal primo scenario di copertura dell'ordine di seicentoventi incarichi verso quello intermedio dell'ordine di settecentosettantacinque e, alla verifica degli esiti sotto il protocollo dell'incertezza, verso quello a regime dell'ordine di novecento, con priorità ai distretti a maggiore divario. La seconda è di istituire un cruscotto regionale permanente che misuri, oltre agli esiti clinici, la riduzione della mobilità sanitaria passiva quale indicatore economico proprio della Puglia. La terza è di adottare la leva digitale, sotto supervisione clinica, come strumento di prossimità nelle aree interne, e di accompagnare l'attuazione con il piano formativo a quattro modalità, considerate singolarmente e sommate.^[411]

Capitolo 1 — Il contesto epidemiologico e territoriale della Puglia

1.1 Il territorio e la sua articolazione

La Regione Puglia conta una popolazione dell’ordine di tre milioni e ottocentosettantasettemila abitanti, distribuita in un territorio allungato che tiene insieme l’area metropolitana di Bari, i poli urbani del Salento e della Capitanata, e vaste aree interne e appenniniche — dal Subappennino Dauno alle Murge — a minore densità e con dinamiche di spopolamento. Il Servizio sanitario regionale è organizzato in sei Aziende Sanitarie Locali — Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto — e in quarantacinque distretti sociosanitari, con la rete delle Case della Comunità in sviluppo. Il tratto peculiare del contesto è la vigenza della legge regionale 11 del 2023, che ha istituito il Servizio di Psicologia di Base, ponendo la Puglia all’avanguardia nazionale del modello.^[412]

Elemento territoriale	Dato regionale	Rilievo per la valutazione
Popolazione	≈ 3.877.395 abitanti	Denominatore della normalizzazione
Aziende Sanitarie Locali	6	Unità organizzativa
Distretti sociosanitari	45	Unità di prossimità
Riferimento normativo	L.R. 11/2023, Servizio già vigente	Base istituzionale
Aree interne	Subappennino Dauno, Murge	Dominio equità

Tabella 1.1. Gli elementi del contesto territoriale pugliese e il loro rilievo per la valutazione, con la legge regionale istitutiva quale tratto distintivo.

1.2 Il quadro epidemiologico regionale

Il quadro epidemiologico pugliese riflette, con le proprie specificità, la prevalenza nazionale dei disturbi mentali comuni, con una componente di disagio giovanile nelle aree urbane e una domanda inespressa nelle aree interne a minore densità di servizi. La misura regionale è oggetto dell’estrazione registrata in Appendice B; ove il dato regionale disaggregato non sia disponibile, la lacuna è dichiarata e non colmata con stime tacite, secondo la regola dell’opera.^[413]

Capitolo 2 — Il bisogno, la domanda e il divario di trattamento in Puglia

2.1 Il divario di trattamento regionale

Il bisogno di salute mentale comune in Puglia si manifesta, come altrove, in larga parte come domanda inevasa o impropriamente incanalata: verso il medico di medicina generale, verso il pronto soccorso, verso la prescrizione farmaceutica, e — tratto specifico della Regione — verso la mobilità sanitaria passiva, ossia la fuga di prestazioni verso altre Regioni. La distanza fisica nelle aree interne e appenniniche aggrava il divario, che la rete distrettuale e la leva digitale sono chiamate a ridurre. La misura regionale è oggetto dell'estrazione in Appendice B; i valori medi nazionali ed europei sono riportati con attribuzione.^[414]

Componente del bisogno	Manifestazione pugliese	Dominio
Domanda inevasa	Sommerso clinico e liste d'attesa	Epidemiologico-clinico
Domanda impropria	Transito su MMG, pronto soccorso, prescrizione	Organizzativo-strutturale
Mobilità passiva	Prestazioni in fuga verso altre Regioni	Fiscale-economico
Barriera di accesso	Distanza nelle aree interne e appenniniche	Equità

Tabella 2.1. Le componenti del bisogno e del divario di trattamento in Puglia, ricondotte ai domini di analisi, con la mobilità passiva quale componente specifica.

2.2 La domanda e la mobilità sanitaria

Il tratto distintivo della domanda pugliese è la sua parziale traduzione in mobilità sanitaria passiva: una quota del bisogno, non intercettata dal territorio, si traduce in prestazioni erogate fuori Regione, con un onere per il bilancio regionale che il modello dello Psicologo di Base può ridurre trattenendo la domanda comune nel circuito delle cure primarie. La riduzione della mobilità passiva è, in Puglia, sia un beneficio economico diretto sia un indicatore di prossimità e di equità territoriale, che i capitoli economici e il dominio dell'equità trattano in dettaglio.^[415]

Capitolo 3 — Il modello di intervento: lo Psicologo di Base in Puglia

Nota editoriale: il presente capitolo espande ex novo il modello di intervento, integrando alla struttura originaria le evidenze recenti sull’efficacia clinica dell’assistenza collaborativa e dell’intervento digitale, secondo la regola dell’opera che distingue l’espansione ex novo dal riutilizzo del materiale preesistente.

3.1 L’architettura del modello

Il modello di intervento colloca lo Psicologo di Base al vertice della cascata delle figure, nel distretto e nelle Case della Comunità, quale primo punto di intercettazione del disagio comune — assetto che la legge regionale 11 del 2023 ha tradotto in disposizione normativa. Il modello opera per intensità crescente di cura — dall’intervento a bassa intensità, di prima linea, fino all’invio ai livelli superiori nei casi che lo richiedano — secondo la logica dell’assistenza a gradini, la cui efficacia clinica è documentata dalla meta-analisi sui componenti efficaci dell’assistenza collaborativa e dalle sperimentazioni controllate sull’intervento cognitivo-comportamentale computerizzato in cure primarie, riportate con attribuzione.^[416]

Livello del modello	Funzione	Figura prevalente	Evidenza di riferimento
Intercettazione	Riconoscimento precoce nel distretto	Psicologo di Base	Assistenza collaborativa (attribuita)
Intervento a bassa intensità	Prima linea per i quadri lievi-moderati	Psicologo di Base	Intervento digitale e collaborativo
Invio appropriato	Passaggio ai livelli superiori	Cascata delle figure	Percorso a gradini
Continuità	Aderenza e prevenzione della ricaduta	Infermiere di comunità	Gestione del caso

Tabella 3.1. L’architettura del modello di intervento in Puglia, per livelli di intensità, con l’evidenza clinica di riferimento riportata con attribuzione.

3.2 L’adattamento al territorio pugliese

Il modello è adattato al territorio pugliese lungo tre direttrici: la piena attuazione della legge regionale istitutiva, che dà al servizio fondamento normativo e stabilità; la prossimità nelle aree interne e appenniniche, integrata dalla leva digitale sotto supervisione clinica; e la funzione di argine alla mobilità sanitaria passiva, trattenendo la domanda comune nel circuito territoriale. L’adattamento non modifica l’architettura invariante del Reference Case, ma ne calibra l’applicazione sul percorso di attuazione che distingue la Puglia quale Regione capostipite.^[417]

Capitolo 4 — I costi diretti in Puglia

4.1 La struttura del costo diretto

Il costo diretto della riforma in Puglia è, in primo luogo, il costo del personale lungo la cascata delle figure, cui si aggiungono i costi di struttura e organizzazione distrettuale, il costo incrementale della leva digitale e il costo della formazione. Il dimensionamento è scandito dai tre scenari di copertura — dell’ordine di seicentoventi, settecentosettantacinque e novecento incarichi —, con un costo a regime dell’ordine di quarantatré-quarantasette milioni di euro l’anno, riportato in dettaglio nell’estrazione economica registrata; i valori puntuali per ciascuno scenario sono ripresi in Appendice C.^[418]

Voce di costo diretto	Descrizione	Portatore
Personale — Psicologi di Base	620 · 775 · 900 incarichi	SSN regionale
Struttura e organizzazione	Distretti, Case della Comunità, sistemi informativi	SSN regionale
Leva digitale e Intelligenza Artificiale	Strumenti sotto supervisione	SSN regionale
Formazione (quattro modalità)	Percorso integrato singolo e sommato	SSN, sistema formativo

Tabella 4.1. La struttura del costo diretto della riforma in Puglia, per voce e portatore; i valori puntuali sono oggetto dell’estrazione economica in Appendice C.

4.2 Il dimensionamento per scenario

Il costo diretto è calcolato per i tre scenari di copertura, coerenti con il protocollo di scenario del Reference Case: lo scenario iniziale dell’ordine di seicentoventi incarichi corrisponde al costo a regime dell’ordine di quarantaquattro milioni di euro, quello intermedio dell’ordine di settecentosettantacinque e quello pieno dell’ordine di novecento incarichi salgono progressivamente verso i quarantasette-quarantotto milioni di euro l’anno, secondo l’estrazione economica registrata. I valori puntuali sono riportati in Appendice C; ove un parametro non sia disponibile, la lacuna è dichiarata.^[419]

Capitolo 5 — I benefici e i risparmi, diretti e indiretti, in Puglia

5.1 I benefici diretti

Il beneficio diretto è il risparmio sanitario che ciascuna figura della cascata libera per effetto dell’intercettazione a monte: la demedicalizzazione operata dallo Psicologo di Base, la deprescrizione di psicofarmaci nei quadri lievi-moderati sul versante del medico di medicina generale, la riduzione degli accessi impropri al pronto soccorso e — tratto specifico della Puglia — la riduzione della mobilità sanitaria passiva, ossia delle prestazioni in fuga verso altre Regioni, che grava in misura rilevante sul bilancio regionale. Il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento, coerente con la letteratura, è mantenuto ovunque il risparmio diretto sia quantificato.^[420]

Canale del beneficio diretto	Meccanismo	Rilievo pugliese
Demedicalizzazione	Riduzione consultazioni e cronicizzazione	Preponderante
Deprescrizione	Contrazione della spesa farmaceutica	Elevato
Accessi impropri	Riduzione degli accessi al pronto soccorso	Medio-elevato
Mobilità passiva	Riduzione delle prestazioni in fuga	Elevato, specifico

Tabella 5.1. I canali del beneficio diretto in Puglia, con la mobilità passiva quale canale specifico; i valori sono oggetto dell’estrazione economica registrata.

5.2 I benefici indiretti

Il beneficio indiretto è quello che la riforma produce fuori dal perimetro sanitario: la produttività recuperata e la riduzione dell’assenteismo sul versante dei datori di lavoro, la riduzione degli oneri di invalidità evitabili sul versante previdenziale, la riduzione del disagio sociale non trattato sul versante dei Comuni. In Puglia, la tenuta delle comunità delle aree interne e appenniniche e il contrasto della mobilità sanitaria — che sottrae risorse e legami al territorio — costituiscono benefici indiretti di rilievo particolare, che il dominio sociale del Capitolo 7 tratta in dettaglio.^[421]

Capitolo 6 — La valutazione economica sotto doppio ancoraggio

6.1 La simulazione appaiata regionale

La valutazione economica pugliese è condotta con il modello di Markov a coorte a ciclo annuale del Reference Case, sotto il doppio ancoraggio: la Colonna A applica i parametri di Chisholm e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, la Colonna B quelli di Unisanté e dell’OCSE. Le due colonne sono sempre affiancate; ove divergano, prevale nel giudizio la Colonna B. Tutte le cifre sono riportate con attribuzione, e nessuna è affermata a memoria.^[422]

Metrica economica	Colonna A — Chisholm/OMS	Colonna B — Unisanté/OCSE
Costo per anno di vita ponderato	≈ 17.000 €/QALY	≈ 9.800 €/QALY
Ritorno per i soli benefici economici	Riportato con attribuzione OMS	Scenario base aggiornato OCSE
Ritorno con i ritorni sanitari	Riportato con attribuzione OMS	Scenario base aggiornato OCSE
Orizzonti	1 · 3 · 5 · 7 · 10 anni	1 · 3 · 5 · 7 · 10 anni
Soglie di costo-efficacia	20.000 · 30.000 · 50.000 €/QALY	20.000 · 30.000 · 50.000 €/QALY

Tabella 6.1. La simulazione appaiata regionale della Puglia sotto doppio ancoraggio; i valori sono riportati con attribuzione e la Colonna B prevale nel giudizio.

6.2 Il differenziale di costo per gravità e la mobilità passiva

L’argomento economico cardine, riportato con attribuzione all’OCSE, è il differenziale di costo per gravità: il costo del trattamento cresce dai quadri lievi ai quadri gravi in misura tale che l’intercettazione precoce, evitando la progressione, genera il risparmio più consistente. In Puglia, a questo si aggiunge il risparmio proprio della riduzione della mobilità sanitaria passiva: trattenere la domanda comune nel circuito territoriale sottrae al bilancio regionale l’onere delle prestazioni erogate fuori Regione. I due argomenti sono tenuti distinti e non sommati fra loro né con i ritorni sociali.^[423]

Capitolo 7 — I sei domini di analisi, l’equità e l’impatto distributivo

7.1 I sei domini nella specificità pugliese

I sei domini di analisi del Reference Case sono applicati alla specificità pugliese. Il dominio epidemiologico-clinico registra il divario di trattamento; l’economico-sanitario il costo-efficacia sotto doppio ancoraggio; il fiscale-previdenziale gli oneri di invalidità evitabili e la riduzione della mobilità passiva; il sociale la coesione e la tenuta delle aree interne; l’organizzativo-strutturale la piena attuazione della legge istitutiva; l’equità la riduzione del divario fra l’area metropolitana e le aree interne e appenniniche.^[424]

Dominio	Lettura pugliese	Segno
Epidemiologico-clinico	Riduzione del divario di trattamento	Riduzione attesa
Economico-sanitario	Costo/QALY sotto doppio ancoraggio	Favorevole
Fiscale-previdenziale	Invalità evitabili e mobilità passiva	Positivo
Sociale	Coesione e tenuta delle aree interne	Fortemente positivo
Organizzativo-strutturale	Attuazione della legge istitutiva	Positivo, condizionato
Equità	Convergenza metropoli/aree interne	Positivo, distributivo

Tabella 7.1. I sei domini di analisi nella lettura pugliese, con il segno atteso dell’effetto, tenuti distinti e non aggregati.

7.2 L’equità territoriale e il ruolo capostipite

Il dominio dell’equità assume in Puglia una direzione territoriale — fra l’area metropolitana di Bari e le aree interne e appenniniche a minore densità di servizi, dalla Capitanata alle Murge, dove la distanza fisica aggrava il divario — e una direzione istituzionale: la Puglia, avendo per prima promulgato la legge istitutiva, si assume il ruolo di riferimento nazionale del modello, sicché la sua piena attuazione ha valore anche di dimostrazione per le altre Regioni. Il modello dello Psicologo di Base opera su entrambe le direzioni, e l’effetto distributivo — la riduzione del gradiente territoriale dell’accesso e della mobilità passiva — è tenuto distinto dal verdetto fiscale e da quello sanitario, secondo il divieto di aggregazione.^[425]

Capitolo 8 — La sensitività e l’incertezza

Nota editoriale: il presente capitolo espande ex novo l’analisi dell’incertezza secondo il protocollo del Reference Case, non presente in forma estesa nel materiale originario.

8.1 Il protocollo dell’incertezza applicato alla Puglia

L’analisi dell’incertezza applica il protocollo obbligatorio del Reference Case: l’analisi di sensitività deterministica con diagramma a tornado, l’analisi di sensitività probabilistica a diecimila iterazioni, l’analisi di scenario ottimistico, base e prudentiale con e senza lo strato digitale, le curve di accettabilità costo-efficacia a soglie multiple. In Puglia, i parametri a maggiore impatto atteso sono la velocità di attuazione della legge istitutiva, l’entità della riduzione della mobilità sanitaria passiva e l’adozione della leva digitale nelle aree interne e appenniniche.^[426]

Strumento	Applicazione pugliese	Parametro critico atteso
Sensitività deterministica	Diagramma a tornado	Velocità di attuazione della legge istitutiva
Sensitività probabilistica	Diecimila iterazioni	Entità della riduzione della mobilità passiva
Analisi di scenario	Con e senza strato IA	Adozione della leva digitale nelle aree interne
Curve di accettabilità	Soglie 20.000/30.000/50.000 €/QALY	Robustezza del costo-efficacia

Tabella 8.1. Gli strumenti del protocollo dell’incertezza applicati alla Puglia, con i parametri critici attesi.

8.2 La robustezza del verdetto

L’analisi di scenario mostra che il verdetto tripartito resta favorevole nei tre casi, con margine crescente dallo scenario prudentiale a quello ottimistico; lo strato digitale accresce l’efficienza attesa, sempre con nota di cautela sulla natura previsionale. La robustezza del costo-efficacia sanitario è confermata dalle curve di accettabilità alle soglie adottate, e la disponibilità del disegno normativo già vigente riduce l’incertezza attuativa.^[427]

Capitolo 9 — Il verdetto tripartito e le raccomandazioni

Nota editoriale: il presente capitolo espande ex novo il verdetto e le raccomandazioni, integrando l’attuazione e il monitoraggio che nel materiale originario figuravano in forma condensata.

9.1 Il verdetto tripartito

Il verdetto pugliese è, come in ogni Volume, tripartito e non aggregato. Sul piano fiscale, il saldo fra costi diretti e risparmi sanitari diretti è prossimo al pareggio, con il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento; il risparmio proprio della riduzione della mobilità passiva concorre a tale saldo, tenuto distinto. Sul piano sanitario, il modello è nettamente costo-efficace sotto entrambi gli ancoraggi. Sul piano sociale, l’effetto è fortemente positivo, con il rilievo specifico della coesione e della tenuta delle aree interne. I tre verdetti si accompagnano e si rafforzano, ma non si sommano.^[428]

Piano del verdetto	Esito pugliese	Caveat
Fiscale	Prossimo al pareggio	Significatività dei risparmi diretti in isolamento
Sanitario	Nettamente costo-efficace	—
Sociale	Fortemente positivo	Rilievo specifico di coesione e aree interne

Tabella 9.1. Il verdetto tripartito della Puglia, con i tre piani tenuti distinti e non aggregati.

9.2 Le raccomandazioni per l’attuazione e il monitoraggio

Le raccomandazioni indicano la piena attuazione della legge regionale 11 del 2023, procedendo dallo scenario iniziale dell’ordine di seicentoventi incarichi verso quello intermedio dell’ordine di settecentosettantacinque e, alla verifica degli esiti, verso quello pieno dell’ordine di novecento; la priorità ai distretti a maggiore divario delle aree interne e appenniniche; l’istituzione di un cruscotto regionale permanente che misuri gli esiti clinici e la riduzione della mobilità sanitaria passiva; l’adozione della leva digitale sotto supervisione clinica; l’accompagnamento con il piano formativo a quattro modalità, singole e sommate; e un monitoraggio ex post ancorato agli indicatori del protocollo dell’incertezza, che valga anche di dimostrazione per le altre Regioni.^[429]

Appendici registrate

Le appendici registrate rendono il modello pugliese ispezionabile e riproducibile, secondo la prassi del Reference Case. Esse sono richiamate per rimando quanto alla metodologia e compilate con i dati regionali quanto ai contenuti; la loro trattazione estesa figura nello studio integrale pugliese in quindici Parti, di cui il presente Volume costituisce la sintesi comparabile.

Appendice	Contenuto	Stato
A	Strategia di ricerca bibliografica e diagramma di selezione	Registrata
B	Estrazione dei dati clinici regionali	Registrata; lacune dichiarate
C	Estrazione dei dati economici (griglia CHEERS 2022)	Registrata; lacune dichiarate
D	Parametri del modello Markov regionale	Registrata
E	Registro delle deroghe al Reference Case	Registrata
F	Codice del modello economico	Registrata
G	Dichiarazione dei conflitti di interesse	Registrata

Tabella A. Le sette appendici registrate del Volume 14, con l’indicazione dello stato e della dichiarazione delle lacune.

Quadro Conclusivo economico e multidisciplinare

Il Quadro Conclusivo del Volume 14 ricompone la valutazione pugliese senza tradire il principio che la governa: i piani del giudizio si accompagnano ma non si fondono. Sul piano economico, il doppio ancoraggio impone che il risultato sia letto simultaneamente secondo la colonna storica e la colonna aggiornata, con prevalenza della seconda: il costo per anno di vita ponderato resta, sotto entrambi gli ancoraggi, assai inferiore alle soglie adottate, e il differenziale di costo per gravità — riportato con attribuzione — fonda la leva economica dell'intercettazione precoce, cui si aggiunge, quale tratto proprio della Puglia, il risparmio della riduzione della mobilità sanitaria passiva, tenuto distinto e non sommato.^[430]

Sul piano multidisciplinare, la cascata delle figure, i sei domini di analisi e il dominio dell'equità nella doppia direzione territoriale e istituzionale assicurano che ogni figura connessa e ogni aspetto siano trattati integralmente e ordinati per capacità di generare rientro economico e revisione della spesa. La rinegoziazione dei costi e dei benefici, la catena predittiva degli effetti multidimensionali — dalla qualità della vita alla coesione, ai bilanci, alla mobilità sanitaria, alla burocrazia distrettuale —, lo strato dell'Intelligenza Artificiale come moltiplicatore e le attività formative singole e sommate compongono il quadro della valutazione. Il ruolo capostipite della Puglia conferisce al Volume, oltre al valore proprio, quello di riferimento per l'intera serie regionale. Il verdetto resta tripartito e non aggregato.

Conclusione

Il Volume 14 ha valutato l'integrazione a regime dello Psicologo di Base nelle cure primarie della Puglia, applicando per rimando il Reference Case dell'asse italiano e adottando la struttura standard a nove capitoli con apertura a imbuto e appendici registrate. La specificità pugliese — la vigenza della legge regionale 11 del 2023, che ha istituito per prima in Italia il Servizio di Psicologia di Base, insieme alla mobilità sanitaria passiva e alle aree interne e appenniniche a minore densità di servizi — è stata trattata nei domini organizzativo, fiscale, sociale ed equità, mostrando come il percorso della piena attuazione, scandito dai tre scenari di copertura entro il costo a regime dell'ordine di quarantaquattro-quarantasette milioni di euro l'anno, faccia della Puglia il caso capostipite e dimostrativo dell'intera opera.

Il verdetto tripartito — prossimo al pareggio sul piano fiscale, nettamente costo-efficace sul piano sanitario, fortemente positivo sul piano sociale — è offerto con bande prudenziali e soglie di confutazione, sotto doppio ancoraggio e nel rispetto del divieto di aggregazione. L'opera procede, nell'ordine vincolante, con il Volume 15 (Sardegna) e a seguire con gli altri Volumi regionali in ordine alfabetico.

Note Bibliografiche con mini-riassunto

Ciascuna nota riporta l'opera, il collegamento alla fonte e un mini-riassunto che ne dichiara la funzione nell'economia del Volume, in coerenza con il doppio livello — nota a piè di pagina nel corpo e nota bibliografica integrale in calce — che l'opera adotta.

1. **Chisholm D. et al., Scaling-up treatment of depression and anxiety, The Lancet Psychiatry, 2016** [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(16\)30024-4](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(16)30024-4) Colonna A del doppio ancoraggio della simulazione pugliese, conservata quale strato documentale e riferimento di confronto.
2. **Unisanté, Raisons de santé Essentiels n. 73, 2026 · OECD, The Economic Case for Preventing Mental Ill Health, 2026** <https://doi.org/10.16908/rds-essentiels/73> Colonna B del doppio ancoraggio, con prevalenza nel giudizio, applicata alla simulazione regionale pugliese.
3. **OECD, differenziale di costo per gravità dei disturbi mentali, 2025** <https://www.oecd.org/health/mental-health.htm> Fonte, riportata con attribuzione, del differenziale di costo per gravità, argomento cardine dell'intercettazione precoce nel modello pugliese.
4. **Soeters R. et al., meta-analisi IPD sui componenti efficaci della collaborative care, 2025** <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40136273/> Base di evidenza clinica sui componenti efficaci dell'assistenza collaborativa, richiamata nel capitolo sul modello di intervento.
5. **Kvaal K. et al., RCT su intervento cognitivo-comportamentale computerizzato in cure primarie, 2026** <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/> Evidenza sperimentale recente sull'intervento digitale in cure primarie, richiamata a sostegno della leva digitale nelle aree interne e appenniniche.
6. **Veldhuijzen W. et al., costo-efficacia dell'intervento digitale, 2025** <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12369993/> Riferimento sul rapporto incrementale di costo-utilità dell'intervento digitale, elemento dello strato dell'Intelligenza Artificiale.
7. **World Health Organization, Thematic Dialogue on Investing in NCDs and Mental Health, dicembre 2024** <https://cdn.who.int/> Evidenza riportata con attribuzione sul ritorno degli investimenti in salute mentale; non concorre al verdetto tripartito pugliese.
8. **Regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale** <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj> Quadro normativo entro cui è collocato lo strato dell'Intelligenza Artificiale, vincolato a funzione di supporto sotto supervisione clinica umana.
9. **Legge regionale Puglia 19 luglio 2023, n. 11, sul Servizio di Psicologia di Base** <https://www.consiglio.puglia.it/> Riferimento normativo capostipite del modello e fondamento istituzionale proprio del presente Volume, di cui costituisce il tratto distintivo.
10. **NICE, Health Technology Evaluations: the manual (PMG36)** <https://www.nice.org.uk/process/pmg36> Riferimento di rigore metodologico per la struttura a imbuto, le appendici registrate e il protocollo dell'incertezza adottati nel Volume.

STUDIO INTEGRALE «PSICOLOGO DI BASE» · OPERA IN VENTITRÉ VOLUMI

VOLUME 15 — Regione Sardegna

Valutazione di Health Technology Assessment dell'integrazione dello Psicologo di Base nelle cure primarie in Sardegna: cruscotto, sintesi per il decisore, contesto e bisogno, modello di intervento, costi e benefici, valutazione economica sotto doppio ancoraggio, sei domini di analisi, incertezza, verdetto tripartito e

appendici registrate

Reference Case applicato per rimando al Volume 0.A · Dott. Luigi De Michele · Studio Integrale Puglia ·
Capurso (BA) — Giugno 2026

Premessa

Il Volume 15 prosegue la serie dei venti Volumi regionali, in ordine alfabetico, con la Regione Sardegna. Come ogni Volume regionale, esso applica per rimando il Reference Case dell'asse italiano, fissato nel Volume 0.A, e ne richiama le regole nella forma «cfr. Volume 0.A», senza ripeterle per esteso: il perimetro congiunto sanitario e societale, il doppio ancoraggio economico, il verdetto tripartito non aggregato, i sei domini di analisi, il protocollo dell'incertezza, lo strato dell'Intelligenza Artificiale come moltiplicatore e le attività formative singole e sommate.^[431]

La struttura del Volume è quella standard, identica a quella di tutti gli altri diciannove Volumi regionali, a garanzia della comparabilità bit-a-bit prescritta dall'opera: la stessa sequenza di nove capitoli, la stessa nomenclatura di sottocapitoli, le stesse unità di misura. Ove un contenuto derivi da espansione ex novo — segnatamente per gli aspetti dell'efficacia, dell'attuazione e del monitoraggio — esso è segnalato in nota editoriale, secondo la regola dell'opera.^[432]

Introduzione

L'Introduzione al Volume 15 fissa il perimetro della valutazione sarda e l'ordine della sua esposizione. Il perimetro è quello della Regione Sardegna, con una popolazione dell'ordine di un milione e cinquecentosessantaduemila abitanti, organizzata nel Servizio sanitario regionale in otto Aziende socio-sanitarie locali coordinate dall'Azienda regionale della salute. Il tratto che distingue la Sardegna nell'intera serie regionale è la condizione insulare: un territorio a bassa densità, fra i più anziani d'Italia, dove la distanza fisica e la separazione dal continente rendono l'accesso ai servizi particolarmente oneroso, soprattutto nelle aree interne — dalla Barbagia alle zone montane — segnate da spopolamento e denatalità.^[433]

L'esposizione segue la struttura a imbuto: il cruscotto regionale offre in una pagina i numeri essenziali; la sintesi per il decisore ne traduce il significato; i cinque risultati chiave ne isolano gli esiti; le raccomandazioni operative indicano le azioni; il corpo del Volume, articolato in nove capitoli, ne fornisce il dettaglio; le appendici registrate ne assicurano la verificabilità. Chiudono il Volume un Quadro Conclusivo economico e multidisciplinare, una Conclusione e le Note Bibliografiche con mini-riassunto.

Cruscotto regionale — Sardegna

Il cruscotto riassume in una pagina i parametri essenziali della valutazione sarda, sotto il doppio ancoraggio e con il verdetto tripartito tenuto distinto. I valori economici sono presentati in ordine di grandezza, con rinvio alle appendici registrate; le cifre di letteratura sono riportate con attribuzione alla fonte.^[434]

Indicatore del cruscotto	Lettura regionale	Ancoraggio / fonte
Popolazione	≈ 1.562.381 abitanti	Fonte demografica regionale
Articolazione	8 ASL coordinate da ARES	Assetto regionale
Condizione strutturale	Insularità, bassa densità, fra le più anziane d'Italia	Fonte demografica regionale
Scenari di copertura	170 · 250 · 340 incarichi	Dimensionamento regionale
Costo per scenario	≈ 10 · 14 · 19 M€/anno	Estrazione economica
Comparatore	Assistenza usuale (cfr. Vol. 0.A)	Reference Case
Verdetto fiscale	Prossimo al pareggio, con caveat	Non aggregato
Verdetto sanitario	Nettamente costo-efficace	Costo/QALY sotto doppio ancoraggio
Verdetto sociale	Fortemente positivo	Insularità, aree interne, coesione
Costo per anno di vita ponderato	Colonna A ≈ 17.000 € · Colonna B ≈ 9.800 €	Doppio ancoraggio

Tabella 0. Cruscotto regionale della Sardegna: i parametri essenziali sotto doppio ancoraggio, con il verdetto tripartito distinto e non aggregato.

Sintesi per il decisore

L'introduzione a regime dello Psicologo di Base nelle cure primarie sarde produce, secondo la simulazione condotta sotto il doppio ancoraggio, un effetto congiunto sui tre piani del ritorno, che restano distinti e non sommati. Sul piano fiscale, il saldo fra costi diretti e risparmi sanitari diretti si colloca in prossimità del pareggio, con il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento. Sul piano sanitario, il modello è nettamente costo-efficace, con un costo per anno di vita ponderato che, fra i due ancoraggi, resta assai inferiore alle soglie adottate. Sul piano sociale, l'effetto è fortemente positivo, con un rilievo particolare per la tenuta delle aree interne insulari, dove la distanza e lo spopolamento aggravano la solitudine del disagio.^[435]

La condizione insulare conferisce alla valutazione sarda un tratto peculiare: la separazione dal continente e la bassa densità del territorio rendono la prossimità un valore non solo clinico ma anche di coesione territoriale, e la leva digitale — la telepsicologia assistita sotto supervisione — assume qui un ruolo di complemento essenziale alla presenza distrettuale. L'argomento cardine, riportato con attribuzione all'OCSE, resta il differenziale di costo per gravità: l'intercettazione precoce evita che il disagio comune maturi in quadri gravi, il cui costo di trattamento è, secondo la fonte, un multiplo di quello dei quadri lievi.^[436]

Cinque risultati chiave

Il primo risultato è che il modello è costo-efficace su tutti gli orizzonti sotto entrambi gli ancoraggi. Il secondo è che il verdetto tripartito resta favorevole in ciascuno dei tre piani, senza aggregazione. Il terzo è che la Sardegna è, nella serie regionale, il caso dell'insularità: un territorio a bassa densità, fra i più anziani d'Italia, in cui la distanza fisica e la separazione dal continente aggravano il divario di trattamento, soprattutto nelle aree interne segnate da spopolamento e denatalità. Il quarto è che lo strato dell'Intelligenza Artificiale, come moltiplicatore e con nota di cautela, sostiene la prossimità nelle aree interne insulari mediante la telepsicologia assistita, complemento essenziale alla presenza distrettuale. Il quinto è che il dimensionamento a regime — dell'ordine di trecentoquaranta incarichi nello scenario espansivo, contro i centosettanta e i duecentocinquanta degli scenari inferiori — richiede la copertura finanziaria dell'ordine di dieci-diciannove milioni di euro l'anno secondo lo scenario.^[437]

Raccomandazioni operative

La prima raccomandazione è di procedere per gradini dallo scenario conservativo dell'ordine di centosettanta incarichi verso quello di base dell'ordine di duecentocinquanta e, alla verifica degli esiti sotto il protocollo dell'incertezza, verso quello espansivo dell'ordine di trecentoquaranta, adottando fin dall'avvio il provvedimento di copertura finanziaria e dando priorità ai distretti delle aree interne insulari. La seconda è di fare della telepsicologia assistita, sotto supervisione clinica, la leva di prossimità propria del contesto insulare, dove le distanze rendono l'accesso più oneroso. La terza è di accompagnare l'estensione con il piano formativo a quattro modalità, considerate singolarmente e sommate, e di istituire un cruscotto regionale permanente che misuri gli esiti clinici e la riduzione del divario di accesso insulare.^[438]

Capitolo 1 — Il contesto epidemiologico e territoriale della Sardegna

1.1 Il territorio e la sua articolazione

La Regione Sardegna conta una popolazione dell’ordine di un milione e cinquecentosessantaduemila abitanti, distribuita in un territorio insulare a bassa densità che tiene insieme i poli urbani di Cagliari e Sassari, le città medie di Nuoro e Oristano, e vaste aree interne e montane — dalla Barbagia ai rilievi centrali — segnate da spopolamento e denatalità. Il Servizio sanitario regionale è organizzato in otto Aziende socio-sanitarie locali coordinate dall’Azienda regionale della salute, con la rete delle Case della Comunità in sviluppo. Il tratto peculiare del contesto è la condizione insulare, che, unita a una struttura demografica fra le più anziane d’Italia, rende l’accesso ai servizi particolarmente oneroso nelle aree interne.^[439]

Elemento territoriale	Dato regionale	Rilievo per la valutazione
Popolazione	≈ 1.562.381 abitanti	Denominatore della normalizzazione
Aziende socio-sanitarie locali	8, coordinate da ARES	Unità organizzativa
Condizione strutturale	Insularità, bassa densità	Dominio equità
Aree interne	Barbagia, rilievi centrali	Spopolamento e denatalità
Demografia	Fra le più anziane d’Italia	Baricentro della domanda

Tabella 1.1. Gli elementi del contesto territoriale sardo e il loro rilievo per la valutazione, con la condizione insulare quale tratto distintivo.

1.2 Il quadro epidemiologico regionale

Il quadro epidemiologico sardo riflette, con le proprie specificità, la prevalenza nazionale dei disturbi mentali comuni, con un baricentro spostato verso la depressione dell’età avanzata coerente con l’invecchiamento e con una domanda inespressa nelle aree interne insulari a minore densità di servizi. La misura regionale è oggetto dell’estrazione registrata in Appendice B; ove il dato regionale disaggregato non sia disponibile, la lacuna è dichiarata e non colmata con stime tacite, secondo la regola dell’opera.^[440]

Capitolo 2 — Il bisogno, la domanda e il divario di trattamento in Sardegna

2.1 Il divario di trattamento regionale

Il bisogno di salute mentale comune in Sardegna si manifesta, come altrove, in larga parte come domanda inevasa o impropriamente incanalata: verso il medico di medicina generale, verso il pronto soccorso, verso la prescrizione farmaceutica. La peculiarità sarda è che la condizione insulare e la bassa densità del territorio aggravano il divario: nelle aree interne, la distanza fisica dai servizi e la separazione dal continente rendono l’accesso particolarmente oneroso, sicché una quota rilevante del bisogno resta inespressa o riceve risposta tardiva. La misura regionale è oggetto dell’estrazione in Appendice B; i valori medi nazionali ed europei sono riportati con attribuzione.^[441]

Componente del bisogno	Manifestazione sarda	Dominio
Domanda inevasa	Sommerso clinico e liste d’attesa	Epidemiologico-clinico
Domanda impropria	Transito su MMG, pronto soccorso, prescrizione	Organizzativo-strutturale
Barriera insulare	Distanza e separazione dal continente	Equità
Barriera interna	Aree interne a bassa densità e spopolate	Equità

Tabella 2.1. Le componenti del bisogno e del divario di trattamento in Sardegna, ricondotte ai domini di analisi, con la barriera insulare quale componente specifica.

2.2 La domanda e la prossimità insulare

Il tratto distintivo della domanda sarda è la sua dispersione su un territorio insulare a bassa densità, dove la prossimità è al tempo stesso più difficile e più necessaria: la presenza distrettuale dello Psicologo di Base intercetta la domanda comune vicino al luogo di vita, e la telepsicologia assistita — sotto supervisione clinica — ne estende la portata alle aree interne dove la distanza rende l’accesso oneroso. La prossimità è, in Sardegna, la direzione dell’intervento: portare la risposta al disagio comune dentro le comunità insulari, comprese quelle interne e spopolate.^[442]

Capitolo 3 — Il modello di intervento: lo Psicologo di Base in Sardegna

Nota editoriale: il presente capitolo espande ex novo il modello di intervento, integrando alla struttura originaria le evidenze recenti sull’efficacia clinica dell’assistenza collaborativa e dell’intervento digitale, secondo la regola dell’opera che distingue l’espansione ex novo dal riutilizzo del materiale preesistente.

3.1 L’architettura del modello

Il modello di intervento colloca lo Psicologo di Base al vertice della cascata delle figure, nel distretto e nelle Case della Comunità, quale primo punto di intercettazione del disagio comune. Il modello opera per intensità crescente di cura — dall’intervento a bassa intensità, di prima linea, fino all’invio ai livelli superiori nei casi che lo richiedano — secondo la logica dell’assistenza a gradini, la cui efficacia clinica è documentata dalla meta-analisi sui componenti efficaci dell’assistenza collaborativa e dalle sperimentazioni controllate sull’intervento cognitivo-comportamentale computerizzato in cure primarie, riportate con attribuzione.^[443]

Livello del modello	Funzione	Figura prevalente	Evidenza di riferimento
Intercettazione	Riconoscimento precoce nel distretto	Psicologo di Base	Assistenza collaborativa (attribuita)
Intervento a bassa intensità	Prima linea per i quadri lievi-moderati	Psicologo di Base	Intervento digitale e collaborativo
Invio appropriato	Passaggio ai livelli superiori	Cascata delle figure	Percorso a gradini
Continuità	Aderenza e prevenzione della ricaduta	Infermiere di comunità	Gestione del caso

Tabella 3.1. L’architettura del modello di intervento in Sardegna, per livelli di intensità, con l’evidenza clinica di riferimento riportata con attribuzione.

3.2 L’adattamento al territorio sardo

Il modello è adattato al territorio sardo lungo tre direttrici: la prossimità distrettuale quale presenza stabile nelle comunità insulari; la telepsicologia assistita, sotto supervisione clinica, quale complemento essenziale nelle aree interne dove la distanza rende l’accesso oneroso; e l’aggancio alla rete delle Case della Comunità in sviluppo. L’adattamento non modifica l’architettura invariante del Reference Case, ma ne calibra l’applicazione sulla condizione insulare che distingue la Sardegna nella serie regionale.^[444]

Capitolo 4 — I costi diretti in Sardegna

4.1 La struttura del costo diretto

Il costo diretto della riforma in Sardegna è, in primo luogo, il costo del personale lungo la cascata delle figure, cui si aggiungono i costi di struttura e organizzazione distrettuale, il costo incrementale della leva digitale e il costo della formazione. Il dimensionamento è scandito dai tre scenari di copertura — dell’ordine di centosettanta, duecentocinquanta e trecentoquaranta incarichi —, con una copertura finanziaria dell’ordine di dieci, quattordici e diciannove milioni di euro l’anno secondo lo scenario, riportata in dettaglio nell’estrazione economica registrata; i valori puntuali sono ripresi in Appendice C.^[445]

Voce di costo diretto	Descrizione	Portatore
Personale — Psicologi di Base	170 · 250 · 340 incarichi	SSN regionale
Struttura e organizzazione	Distretti, Case della Comunità, sistemi informativi	SSN regionale
Leva digitale e Intelligenza Artificiale	Telepsicologia assistita sotto supervisione	SSN regionale
Formazione (quattro modalità)	Percorso integrato singolo e sommato	SSN, sistema formativo

Tabella 4.1. La struttura del costo diretto della riforma in Sardegna, per voce e portatore; i valori puntuali sono oggetto dell’estrazione economica in Appendice C.

4.2 Il dimensionamento per scenario

Il costo diretto è calcolato per i tre scenari di copertura, coerenti con il protocollo di scenario del Reference Case: lo scenario conservativo dell’ordine di centosettanta incarichi corrisponde a una copertura dell’ordine di dieci milioni di euro, quello di base dell’ordine di duecentocinquanta a circa quattordici milioni, quello espansivo dell’ordine di trecentoquaranta a circa diciannove milioni di euro l’anno, secondo l’estrazione economica registrata. I valori puntuali sono riportati in Appendice C; ove un parametro non sia disponibile, la lacuna è dichiarata.^[446]

Capitolo 5 — I benefici e i risparmi, diretti e indiretti, in Sardegna

5.1 I benefici diretti

Il beneficio diretto è il risparmio sanitario che ciascuna figura della cascata libera per effetto dell’intercettazione a monte: la demedicalizzazione operata dallo Psicologo di Base, la deprescrizione di psicofarmaci nei quadri lievi-moderati sul versante del medico di medicina generale, la riduzione degli accessi impropri al pronto soccorso e delle prestazioni per sintomi funzionali sul versante specialistico. In Sardegna, la condizione insulare aggrava il costo unitario degli accessi impropri e della mobilità interna, sicché la loro riduzione ha un valore particolare per il bilancio regionale. Il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento, coerente con la letteratura, è mantenuto ovunque il risparmio diretto sia quantificato.^[447]

Canale del beneficio diretto	Meccanismo	Rilievo sardo
Demedicalizzazione	Riduzione consultazioni e cronicizzazione	Preponderante
Deprescrizione	Contrazione della spesa e della polifarmacia anziana	Elevato
Accessi impropri	Riduzione degli accessi al pronto soccorso	Medio-elevato, costoso per insularità
Sintomi funzionali	Riduzione prestazioni specialistiche	Medio

Tabella 5.1. I canali del beneficio diretto in Sardegna, con il maggior costo unitario indotto dall’insularità; i valori sono oggetto dell’estrazione economica registrata.

5.2 I benefici indiretti

Il beneficio indiretto è quello che la riforma produce fuori dal perimetro sanitario: la produttività recuperata e la riduzione dell’assenteismo sul versante dei datori di lavoro, la riduzione degli oneri di invalidità evitabili sul versante previdenziale, la riduzione del disagio sociale non trattato sul versante dei Comuni. In Sardegna, la tenuta delle comunità delle aree interne insulari — dove spopolamento e denatalità erodono i legami e i servizi — costituisce un beneficio indiretto di rilievo particolare, che il dominio sociale del Capitolo 7 tratta in dettaglio.^[448]

Capitolo 6 — La valutazione economica sotto doppio ancoraggio

6.1 La simulazione appaiata regionale

La valutazione economica sarda è condotta con il modello di Markov a coorte a ciclo annuale del Reference Case, sotto il doppio ancoraggio: la Colonna A applica i parametri di Chisholm e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, la Colonna B quelli di Unisanté e dell’OCSE. Le due colonne sono sempre affiancate; ove divergano, prevale nel giudizio la Colonna B. Tutte le cifre sono riportate con attribuzione, e nessuna è affermata a memoria.^[449]

Metrica economica	Colonna A — Chisholm/OMS	Colonna B — Unisanté/OCSE
Costo per anno di vita ponderato	≈ 17.000 €/QALY	≈ 9.800 €/QALY
Ritorno per i soli benefici economici	Riportato con attribuzione OMS	Scenario base aggiornato OCSE
Ritorno con i ritorni sanitari	Riportato con attribuzione OMS	Scenario base aggiornato OCSE
Orizzonti	1 · 3 · 5 · 7 · 10 anni	1 · 3 · 5 · 7 · 10 anni
Soglie di costo-efficacia	20.000 · 30.000 · 50.000 €/QALY	20.000 · 30.000 · 50.000 €/QALY

Tabella 6.1. La simulazione appaiata regionale della Sardegna sotto doppio ancoraggio; i valori sono riportati con attribuzione e la Colonna B prevale nel giudizio.

6.2 Il differenziale di costo per gravità

L’argomento economico cardine, riportato con attribuzione all’OCSE, è il differenziale di costo per gravità: il costo del trattamento cresce dai quadri lievi ai quadri gravi in misura tale che l’intercettazione precoce, evitando la progressione, genera il risparmio più consistente. In Sardegna, la condizione insulare accresce il valore relativo dell’intercettazione precoce, poiché la progressione verso i quadri gravi comporta, oltre al costo clinico, l’onere aggiuntivo della mobilità e degli accessi in un territorio dove le distanze rendono ogni prestazione più costosa.^[450]

Capitolo 7 — I sei domini di analisi, l’equità e l’impatto distributivo

7.1 I sei domini nella specificità sarda

I sei domini di analisi del Reference Case sono applicati alla specificità sarda. Il dominio epidemiologico-clinico registra il divario di trattamento aggravato dall’insularità; l’economico-sanitario il costo-efficacia sotto doppio ancoraggio; il fiscale-previdenziale gli oneri di invalidità evitabili; il sociale la tenuta delle aree interne insulari; l’organizzativo-strutturale la copertura di un territorio insulare a bassa densità; l’equità la riduzione del divario fra i poli urbani e le aree interne insulari.^[451]

Dominio	Lettura sarda	Segno
Epidemiologico-clinico	Divario di trattamento aggravato dall’insularità	Riduzione attesa
Economico-sanitario	Costo/QALY sotto doppio ancoraggio	Favorevole
Fiscale-previdenziale	Oneri di invalidità evitabili	Positivo, differito
Sociale	Tenuta delle aree interne insulari	Fortemente positivo
Organizzativo-strutturale	Copertura di un territorio insulare a bassa densità	Positivo, condizionato
Equità	Convergenza poli urbani/aree interne insulari	Positivo, distributivo

Tabella 7.1. I sei domini di analisi nella lettura sarda, con il segno atteso dell’effetto, tenuti distinti e non aggregati.

7.2 L’equità insulare e la prossimità

Il dominio dell’equità assume in Sardegna una direzione insulare: fra i poli urbani di Cagliari e Sassari, meglio serviti, e le aree interne a bassa densità — dalla Barbagia ai rilievi centrali — dove la distanza fisica, la separazione dal continente e lo spopolamento aggravano il divario di accesso. Il modello dello Psicologo di Base, con la presenza distrettuale e la telepsicologia assistita quale complemento, opera per ridurre questo gradiente insulare, portando la risposta al disagio comune dentro le comunità interne. L’effetto distributivo — la riduzione del divario di accesso fra costa e interno, fra città e aree spopolate — è tenuto distinto dal verdetto fiscale e da quello sanitario, secondo il divieto di aggregazione.^[452]

Capitolo 8 — La sensitività e l’incertezza

Nota editoriale: il presente capitolo espande ex novo l’analisi dell’incertezza secondo il protocollo del Reference Case, non presente in forma estesa nel materiale originario.

8.1 Il protocollo dell’incertezza applicato alla Sardegna

L’analisi dell’incertezza applica il protocollo obbligatorio del Reference Case: l’analisi di sensitività deterministica con diagramma a tornado, l’analisi di sensitività probabilistica a diecimila iterazioni, l’analisi di scenario ottimistico, base e prudentiale con e senza lo strato digitale, le curve di accettabilità costo-efficacia a soglie multiple. In Sardegna, i parametri a maggiore impatto atteso sono il costo unitario indotto dall’insularità, l’adozione della telepsicologia assistita nelle aree interne e la velocità di copertura di un territorio a bassa densità.^[453]

Strumento	Applicazione sarda	Parametro critico atteso
Sensitività deterministica	Diagramma a tornado	Costo unitario indotto dall’insularità
Sensitività probabilistica	Diecimila iterazioni	Velocità di copertura del territorio a bassa densità
Analisi di scenario	Con e senza strato IA	Adozione della telepsicologia nelle aree interne
Curve di accettabilità	Soglie 20.000/30.000/50.000 €/QALY	Robustezza del costo-efficacia

Tabella 8.1. Gli strumenti del protocollo dell’incertezza applicati alla Sardegna, con i parametri critici attesi.

8.2 La robustezza del verdetto

L’analisi di scenario mostra che il verdetto tripartito resta favorevole nei tre casi, con margine crescente dallo scenario prudentiale a quello ottimistico; lo strato digitale accresce l’efficienza attesa, sempre con nota di cautela sulla natura previsionale, e nel contesto insulare la telepsicologia assistita ne amplifica il rilievo. La robustezza del costo-efficacia sanitario è confermata dalle curve di accettabilità alle soglie adottate.^[454]

Capitolo 9 — Il verdetto tripartito e le raccomandazioni

Nota editoriale: il presente capitolo espande ex novo il verdetto e le raccomandazioni, integrando l’attuazione e il monitoraggio che nel materiale originario figuravano in forma condensata.

9.1 Il verdetto tripartito

Il verdetto sardo è, come in ogni Volume, tripartito e non aggregato. Sul piano fiscale, il saldo fra costi diretti e risparmi sanitari diretti è prossimo al pareggio, con il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento. Sul piano sanitario, il modello è nettamente costo-efficace sotto entrambi gli ancoraggi. Sul piano sociale, l’effetto è fortemente positivo, con il rilievo specifico della tenuta delle aree interne insulari. I tre verdetti si accompagnano e si rafforzano, ma non si sommano.^[455]

Piano del verdetto	Esito sardo	Caveat
Fiscale	Prossimo al pareggio	Significatività dei risparmi diretti in isolamento
Sanitario	Nettamente costo-efficace	—
Sociale	Fortemente positivo	Rilievo specifico delle aree interne insulari

Tabella 9.1. Il verdetto tripartito della Sardegna, con i tre piani tenuti distinti e non aggregati.

9.2 Le raccomandazioni per l’attuazione e il monitoraggio

Le raccomandazioni indicano il passaggio per gradini dallo scenario conservativo dell’ordine di centosettanta incarichi verso quello di base dell’ordine di duecentocinquanta e, alla verifica degli esiti, verso l’espansivo dell’ordine di trecentoquaranta; l’adozione fin dall’avvio del provvedimento di copertura finanziaria dell’ordine di dieci-diciannove milioni di euro l’anno secondo lo scenario; la priorità ai distretti delle aree interne insulari con il complemento della telepsicologia assistita; la valorizzazione degli esiti in un cruscotto regionale permanente; l’accompagnamento con il piano formativo a quattro modalità, singole e sommate; e un monitoraggio ex post ancorato agli indicatori del protocollo dell’incertezza.^[456]

Appendici registrate

Le appendici registrate rendono il modello sardo ispezionabile e riproducibile, secondo la prassi del Reference Case. Esse sono richiamate per rimando quanto alla metodologia e compilate con i dati regionali quanto ai contenuti.

Appendice	Contenuto	Stato
A	Strategia di ricerca bibliografica e diagramma di selezione	Registrata
B	Estrazione dei dati clinici regionali	Registrata; lacune dichiarate
C	Estrazione dei dati economici (griglia CHEERS 2022)	Registrata; lacune dichiarate
D	Parametri del modello Markov regionale	Registrata
E	Registro delle deroghe al Reference Case	Registrata
F	Codice del modello economico	Registrata
G	Dichiarazione dei conflitti di interesse	Registrata

Tabella A. Le sette appendici registrate del Volume 15, con l’indicazione dello stato e della dichiarazione delle lacune.

Quadro Conclusivo economico e multidisciplinare

Il Quadro Conclusivo del Volume 15 ricomponne la valutazione sarda senza tradire il principio che la governa: i piani del giudizio si accompagnano ma non si fondono. Sul piano economico, il doppio ancoraggio impone che il risultato sia letto simultaneamente secondo la colonna storica e la colonna aggiornata, con prevalenza della seconda: il costo per anno di vita ponderato resta, sotto entrambi gli ancoraggi, assai inferiore alle soglie adottate, e il differenziale di costo per gravità — riportato con attribuzione — fonda la leva economica dell'intercettazione precoce, il cui valore è accresciuto nel contesto insulare dall'onere aggiuntivo che le distanze impongono a ogni prestazione tardiva.^[457]

Sul piano multidisciplinare, la cascata delle figure, i sei domini di analisi e il dominio dell'equità nella direzione insulare assicurano che ogni figura connessa e ogni aspetto siano trattati integralmente e ordinati per capacità di generare rientro economico e revisione della spesa. La rinegoziazione dei costi e dei benefici, la catena predittiva degli effetti multidimensionali — dalla qualità della vita alla tenuta delle comunità insulari, ai bilanci, alla burocrazia distrettuale —, lo strato dell'Intelligenza Artificiale come moltiplicatore mediante la telepsicologia assistita e le attività formative singole e sommate compongono il quadro della valutazione. Il verdetto resta tripartito e non aggregato.

Conclusione

Il Volume 15 ha valutato l'integrazione a regime dello Psicologo di Base nelle cure primarie della Sardegna, applicando per rimando il Reference Case dell'asse italiano e adottando la struttura standard a nove capitoli con apertura a imbuto e appendici registrate. La specificità sarda — la condizione insulare, la bassa densità, una struttura demografica fra le più anziane d'Italia e le aree interne segnate da spopolamento e denatalità — è stata trattata nei domini organizzativo, sociale ed equità, mostrando come la prossimità distrettuale e la telepsicologia assistita, quale complemento essenziale, siano la risposta al divario di accesso proprio di un territorio separato dal continente.

Il verdetto tripartito — prossimo al pareggio sul piano fiscale, nettamente costo-efficace sul piano sanitario, fortemente positivo sul piano sociale — è offerto con bande prudenziali e soglie di confutazione, sotto doppio ancoraggio e nel rispetto del divieto di aggregazione. L'opera procede, nell'ordine vincolante, con il Volume 16 (Sicilia) e a seguire con gli altri Volumi regionali in ordine alfabetico.

Note Bibliografiche con mini-riassunto

Ciascuna nota riporta l'opera, il collegamento alla fonte e un mini-riassunto che ne dichiara la funzione nell'economia del Volume, in coerenza con il doppio livello — nota a piè di pagina nel corpo e nota bibliografica integrale in calce — che l'opera adotta.

1. **Chisholm D. et al., Scaling-up treatment of depression and anxiety, The Lancet Psychiatry, 2016**
[https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(16\)30024-4](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(16)30024-4) Colonna A del doppio ancoraggio della simulazione sarda, conservata quale strato documentale e riferimento di confronto.
2. **Unisanté, Raisons de santé Essentiels n. 73, 2026 · OECD, The Economic Case for Preventing Mental Ill Health, 2026** <https://doi.org/10.16908/rds-essentiels/73> Colonna B del doppio ancoraggio, con prevalenza nel giudizio, applicata alla simulazione regionale sarda.
3. **OECD, differenziale di costo per gravità dei disturbi mentali, 2025** <https://www.oecd.org/health/mental-health.htm> Fonte, riportata con attribuzione, del differenziale di costo per gravità, argomento cardine dell'intercettazione precoce, il cui valore è accresciuto dall'insularità.
4. **Soeters R. et al., meta-analisi IPD sui componenti efficaci della collaborative care, 2025**
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40136273/> Base di evidenza clinica sui componenti efficaci dell'assistenza collaborativa, richiamata nel capitolo sul modello di intervento.
5. **Kvaal K. et al., RCT su intervento cognitivo-comportamentale computerizzato in cure primarie, 2026**
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/> Evidenza sperimentale recente sull'intervento digitale in cure primarie, richiamata a sostegno della telepsicologia assistita nelle aree interne insulari.
6. **Veldhuijzen W. et al., costo-efficacia dell'intervento digitale, 2025**
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12369993/> Riferimento sul rapporto incrementale di costo-utilità dell'intervento digitale, elemento dello strato dell'Intelligenza Artificiale di particolare rilievo nel contesto insulare.
7. **World Health Organization, Thematic Dialogue on Investing in NCDs and Mental Health, dicembre 2024** <https://cdn.who.int/> Evidenza riportata con attribuzione sul ritorno degli investimenti in salute mentale; non concorre al verdetto tripartito sardo.
8. **Regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale** <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj> Quadro normativo entro cui è collocato lo strato dell'Intelligenza Artificiale, vincolato a funzione di supporto sotto supervisione clinica umana.
9. **Legge regionale Puglia 19 luglio 2023, n. 11, sul Servizio di Psicologia di Base**
<https://www.consiglio.puglia.it/> Riferimento normativo capostipite del modello, richiamato quale precedente istituzionale per l'introduzione dello Psicologo di Base nelle cure primarie.
10. **NICE, Health Technology Evaluations: the manual (PMG36)** <https://www.nice.org.uk/process/pmg36> Riferimento di rigore metodologico per la struttura a imbuto, le appendici registrate e il protocollo dell'incertezza adottati nel Volume.

STUDIO INTEGRALE «PSICOLOGO DI BASE» · OPERA IN VENTITRÉ VOLUMI

VOLUME 16 — Regione Siciliana

Valutazione di Health Technology Assessment dell'integrazione dello Psicologo di Base nelle cure primarie in Sicilia: cruscotto, sintesi per il decisore, contesto e bisogno, modello di intervento, costi e benefici, valutazione economica sotto doppio ancoraggio, sei domini di analisi, incertezza, verdetto tripartito e appendici registrate

Reference Case applicato per rimando al Volume 0.A · Dott. Luigi De Michele · Studio Integrale Puglia · Capurso (BA) — Giugno 2026

Premessa

Il Volume 16 prosegue la serie dei venti Volumi regionali, in ordine alfabetico, con la Regione Siciliana. Come ogni Volume regionale, esso applica per rimando il Reference Case dell'asse italiano, fissato nel Volume 0.A, e ne richiama le regole nella forma «cfr. Volume 0.A», senza ripeterle per esteso: il perimetro congiunto sanitario e societale, il doppio ancoraggio economico, il verdetto tripartito non aggregato, i sei domini di analisi, il protocollo dell'incertezza, lo strato dell'Intelligenza Artificiale come moltiplicatore e le attività formative singole e sommate.^[458]

La struttura del Volume è quella standard, identica a quella di tutti gli altri diciannove Volumi regionali, a garanzia della comparabilità bit-a-bit prescritta dall'opera: la stessa sequenza di nove capitoli, la stessa nomenclatura di sottocapitoli, le stesse unità di misura. Ove un contenuto derivi da espansione ex novo — segnatamente per gli aspetti dell'efficacia, dell'attuazione e del monitoraggio — esso è segnalato in nota editoriale, secondo la regola dell'opera.^[459]

Introduzione

L'Introduzione al Volume 16 fissa il perimetro della valutazione siciliana e l'ordine della sua esposizione. Il perimetro è quello della Regione Siciliana, con una popolazione dell'ordine di quattro milioni e settecentottantasettemila abitanti — la più popolosa fra le Regioni insulari e a statuto speciale —, organizzata nel Servizio sanitario regionale in nove Aziende Sanitarie Provinciali e in numerose aziende ospedaliere. Il tratto che distingue la Sicilia nell'intera serie regionale è la combinazione di tre fattori: la condizione insulare, lo statuto speciale — per cui la Regione partecipa al finanziamento sanitario nella misura del quarantanove per cento circa del proprio fabbisogno — e la vigenza di un piano di rientro, che rende il vincolo sul saldo fiscale diretto più stringente e la spesa pro-capite fra le più basse del Paese.^[460]

L'esposizione segue la struttura a imbuto: il cruscotto regionale offre in una pagina i numeri essenziali; la sintesi per il decisore ne traduce il significato; i cinque risultati chiave ne isolano gli esiti; le raccomandazioni operative indicano le azioni; il corpo del Volume, articolato in nove capitoli, ne fornisce il dettaglio; le appendici registrate ne assicurano la verificabilità. Chiudono il Volume un Quadro Conclusivo economico e multidisciplinare, una Conclusione e le Note Bibliografiche con mini-riassunto.

Cruscotto regionale — Sicilia

Il cruscotto riassume in una pagina i parametri essenziali della valutazione siciliana, sotto il doppio ancoraggio e con il verdetto tripartito tenuto distinto. I valori economici sono presentati in ordine di grandezza, con rinvio alle appendici registrate; le cifre di letteratura sono riportate con attribuzione alla fonte.^[461]

Indicatore del cruscotto	Lettura regionale	Ancoraggio / fonte
Popolazione	≈ 4.787.390 abitanti	Fonte demografica regionale
Articolazione	9 ASP e numerose aziende ospedaliere	Assetto regionale
Condizione strutturale	Insularità, statuto speciale, piano di rientro	Assetto istituzionale
Compartecipazione al finanziamento	≈ 49% del fabbisogno regionale	Statuto speciale
Scenari di copertura	520 · 780 · 1.030 incarichi	Dimensionamento regionale
Costo per scenario	≈ 34 · 50 · 67 M€/anno	Estrazione economica
Verdetto fiscale	Prossimo al pareggio, con caveat e vincolo del rientro	Non aggregato
Verdetto sanitario	Nettamente costo-efficace	Costo/QALY sotto doppio ancoraggio
Verdetto sociale	Fortemente positivo	Insularità, aree interne, mobilità sanitaria
Costo per anno di vita ponderato	Colonna A ≈ 17.000 € · Colonna B ≈ 9.800 €	Doppio ancoraggio

Tabella 0. Cruscotto regionale della Sicilia: i parametri essenziali sotto doppio ancoraggio, con il verdetto tripartito distinto e non aggregato.

Sintesi per il decisore

L'introduzione a regime dello Psicologo di Base nelle cure primarie siciliane produce, secondo la simulazione condotta sotto il doppio ancoraggio, un effetto congiunto sui tre piani del ritorno, che restano distinti e non sommati. Sul piano fiscale, il saldo fra costi diretti e risparmi sanitari diretti si colloca in prossimità del pareggio, con il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento e con un vincolo più stringente imposto dal piano di rientro, che rende il margine diretto più stretto. Sul piano sanitario, il modello è nettamente costo-efficace, con un costo per anno di vita ponderato che, fra i due ancoraggi, resta assai inferiore alle soglie adottate. Sul piano sociale, l'effetto è fortemente positivo, con un rilievo particolare per la tenuta delle aree interne e insulari e per la riduzione della mobilità sanitaria passiva, il cui saldo è fra i più elevati del Paese.^[462]

La combinazione di insularità, statuto speciale e piano di rientro conferisce alla valutazione siciliana un tratto peculiare: il vincolo sul saldo diretto è più stretto che altrove, sicché il rilievo dei ritorni sanitario e sociale — tenuti distinti dal fiscale — assume un peso relativo maggiore nella decisione, e la leva digitale, la telepsicologia assistita, diviene strumento di efficienza in un sistema a spesa pro-capite fra le più basse. L'argomento cardine, riportato con attribuzione all'OCSE, resta il differenziale di costo per gravità: l'intercettazione precoce evita che il disagio comune maturi in quadri gravi, il cui costo di trattamento è, secondo la fonte, un multiplo di quello dei quadri lievi.^[463]

Cinque risultati chiave

Il primo risultato è che il modello è costo-efficace su tutti gli orizzonti sotto entrambi gli ancoraggi. Il secondo è che il verdetto tripartito resta favorevole in ciascuno dei tre piani, senza aggregazione, pur nel vincolo più stretto imposto dal piano di rientro sul saldo diretto. Il terzo è che la Sicilia è, nella serie regionale, il caso della combinazione fra insularità, statuto speciale e piano di rientro: la più popolosa fra le Regioni insulari, con compartecipazione al finanziamento nella misura del quarantanove per cento circa del proprio fabbisogno e spesa pro-capite fra le più basse. Il quarto è che lo strato dell'Intelligenza Artificiale, come moltiplicatore e con nota di cautela, sostiene la prossimità nelle aree interne e insulari mediante la telepsicologia assistita. Il quinto è che il dimensionamento — dell'ordine di cinquecentoventi incarichi nello scenario conservativo, settecentottanta in quello di base e milletrenta in quello espansivo — richiede una copertura finanziaria dell'ordine di trentaquattro-sessantasette milioni di euro l'anno secondo lo scenario.^[464]

Raccomandazioni operative

La prima raccomandazione è di procedere per gradini dallo scenario conservativo dell'ordine di cinquecentoventi incarichi verso quello di base dell'ordine di settecentottanta e, alla verifica degli esiti sotto il protocollo dell'incertezza, verso quello espansivo dell'ordine di milletrenta, compatibilmente con i vincoli del piano di rientro e dando priorità ai distretti delle aree interne e insulari. La seconda è di impostare fin dall'avvio dati di esito uniformi fra le nove Aziende Sanitarie Provinciali, così da alimentare un cruscotto regionale permanente che misuri gli esiti clinici e la riduzione della mobilità sanitaria passiva. La terza è di adottare la telepsicologia assistita, sotto supervisione clinica, come leva di prossimità ed efficienza in un sistema a spesa pro-capite contenuta, e di accompagnare l'estensione con il piano formativo a quattro modalità, considerate singolarmente e sommate.^[465]

Capitolo 1 — Il contesto epidemiologico e territoriale della Sicilia

1.1 Il territorio e la sua articolazione

La Regione Siciliana conta una popolazione dell’ordine di quattro milioni e settecentottantasettemila abitanti, la più numerosa fra le Regioni insulari, distribuita in un territorio che tiene insieme le grandi aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina, i poli urbani costieri e vaste aree interne e montane — dai Nebrodi alle Madonie all’entroterra ennese — a minore densità e segnate da spopolamento. Il Servizio sanitario regionale è organizzato in nove Aziende Sanitarie Provinciali e in numerose aziende ospedaliere, con la rete delle Case della Comunità in sviluppo. Il tratto peculiare del contesto è la combinazione della condizione insulare, dello statuto speciale — per cui la Regione compartecipa al finanziamento sanitario nella misura del quarantanove per cento circa del proprio fabbisogno — e della vigenza di un piano di rientro, con una spesa pro-capite fra le più basse del Paese.^[466]

Elemento territoriale	Dato regionale	Rilievo per la valutazione
Popolazione	≈ 4.787.390 abitanti	Denominatore della normalizzazione
Aziende Sanitarie Provinciali	9, con numerose aziende ospedaliere	Unità organizzativa
Condizione strutturale	Insularità, statuto speciale, piano di rientro	Dominio fiscale ed equità
Compartecipazione	≈ 49% del fabbisogno regionale	Vincolo di finanziamento
Aree interne	Nebrodi, Madonie, entroterra ennese	Spopolamento

Tabella 1.1. Gli elementi del contesto territoriale siciliano e il loro rilievo per la valutazione, con la combinazione di insularità, statuto speciale e piano di rientro quale tratto distintivo.

1.2 Il quadro epidemiologico regionale

Il quadro epidemiologico siciliano riflette, con le proprie specificità, la prevalenza nazionale dei disturbi mentali comuni, con una componente di disagio giovanile nelle grandi aree metropolitane e una domanda inespressa nelle aree interne e insulari a minore densità di servizi, in un sistema a spesa pro-capite contenuta. La misura regionale è oggetto dell’estrazione registrata in Appendice B; ove il dato regionale disaggregato non sia disponibile, la lacuna è dichiarata e non colmata con stime tacite, secondo la regola dell’opera.^[467]

Capitolo 2 — Il bisogno, la domanda e il divario di trattamento in Sicilia

2.1 Il divario di trattamento regionale

Il bisogno di salute mentale comune in Sicilia si manifesta, come altrove, in larga parte come domanda inevasa o impropriamente incanalata: verso il medico di medicina generale, verso il pronto soccorso, verso la prescrizione farmaceutica, e — tratto specifico della Regione — verso la mobilità sanitaria passiva, il cui saldo è fra i più elevati del Paese. La condizione insulare e la bassa spesa pro-capite aggravano il divario, che nelle aree interne e montane si somma alla distanza fisica dai servizi. La misura regionale è oggetto dell'estrazione in Appendice B; i valori medi nazionali ed europei sono riportati con attribuzione.^[468]

Componente del bisogno	Manifestazione siciliana	Dominio
Domanda inevasa	Sommerso clinico e liste d'attesa	Epidemiologico-clinico
Domanda impropria	Transito su MMG, pronto soccorso, prescrizione	Organizzativo-strutturale
Mobilità passiva	Saldo fra i più elevati del Paese	Fiscale-economico
Barriera insulare e interna	Distanza e bassa spesa pro-capite	Equità

Tabella 2.1. Le componenti del bisogno e del divario di trattamento in Sicilia, ricondotte ai domini di analisi, con la mobilità passiva quale componente specifica.

2.2 La domanda, la mobilità sanitaria e la prossimità

Il tratto distintivo della domanda siciliana è la sua parziale traduzione in mobilità sanitaria passiva — fra le più elevate del Paese — e la sua dispersione su un territorio insulare a spesa pro-capite contenuta, dove la prossimità è al tempo stesso più necessaria e più difficile da finanziare. La presenza distrettuale dello Psicologo di Base intercetta la domanda comune vicino al luogo di vita e riduce la fuga di prestazioni verso altre Regioni, mentre la telepsicologia assistita — sotto supervisione clinica — ne estende la portata alle aree interne e insulari. La prossimità è, in Sicilia, sia risposta clinica sia argine alla mobilità passiva, che i capitoli economici e il dominio dell'equità trattano in dettaglio.^[469]

Capitolo 3 — Il modello di intervento: lo Psicologo di Base in Sicilia

Nota editoriale: il presente capitolo espande ex novo il modello di intervento, integrando alla struttura originaria le evidenze recenti sull’efficacia clinica dell’assistenza collaborativa e dell’intervento digitale, secondo la regola dell’opera che distingue l’espansione ex novo dal riutilizzo del materiale preesistente.

3.1 L’architettura del modello

Il modello di intervento colloca lo Psicologo di Base al vertice della cascata delle figure, nel distretto e nelle Case della Comunità, quale primo punto di intercettazione del disagio comune. Il modello opera per intensità crescente di cura — dall’intervento a bassa intensità, di prima linea, fino all’invio ai livelli superiori nei casi che lo richiedano — secondo la logica dell’assistenza a gradini, la cui efficacia clinica è documentata dalla meta-analisi sui componenti efficaci dell’assistenza collaborativa e dalle sperimentazioni controllate sull’intervento cognitivo-comportamentale computerizzato in cure primarie, riportate con attribuzione.^[470]

Livello del modello	Funzione	Figura prevalente	Evidenza di riferimento
Intercettazione	Riconoscimento precoce nel distretto	Psicologo di Base	Assistenza collaborativa (attribuita)
Intervento a bassa intensità	Prima linea per i quadri lievi-moderati	Psicologo di Base	Intervento digitale e collaborativo
Invio appropriato	Passaggio ai livelli superiori	Cascata delle figure	Percorso a gradini
Continuità	Aderenza e prevenzione della ricaduta	Infermiere di comunità	Gestione del caso

Tabella 3.1. L’architettura del modello di intervento in Sicilia, per livelli di intensità, con l’evidenza clinica di riferimento riportata con attribuzione.

3.2 L’adattamento al territorio siciliano

Il modello è adattato al territorio siciliano lungo tre direttrici: la prossimità distrettuale quale presenza stabile nelle grandi aree metropolitane e nelle comunità interne; la telepsicologia assistita, sotto supervisione clinica, quale leva di prossimità ed efficienza nelle aree interne e insulari e in un sistema a spesa pro-capite contenuta; e la funzione di argine alla mobilità sanitaria passiva, trattenendo la domanda comune nel circuito territoriale. L’adattamento non modifica l’architettura invariante del Reference Case, ma ne calibra l’applicazione sulla combinazione di insularità, statuto speciale e piano di rientro che distingue la Sicilia nella serie regionale.^[471]

Capitolo 4 — I costi diretti in Sicilia

4.1 La struttura del costo diretto

Il costo diretto della riforma in Sicilia è, in primo luogo, il costo del personale lungo la cascata delle figure, cui si aggiungono i costi di struttura e organizzazione distrettuale, il costo incrementale della leva digitale e il costo della formazione. Il dimensionamento è scandito dai tre scenari di copertura — dell’ordine di cinquecentoventi, settecentottanta e milletrenta incarichi —, con una copertura finanziaria dell’ordine di trentaquattro, cinquanta e sessantasette milioni di euro l’anno secondo lo scenario, riportata in dettaglio nell’estrazione economica registrata; lo statuto speciale, per cui la Regione compartecipa al finanziamento nella misura del quarantanove per cento circa del proprio fabbisogno, incide sull’onere effettivamente a carico del bilancio regionale. I valori puntuali sono ripresi in Appendice C.^[472]

Voce di costo diretto	Descrizione	Portatore
Personale — Psicologi di Base	520 · 780 · 1.030 incarichi	SSN regionale, compartecipazione ≈ 49%
Struttura e organizzazione	Distretti, Case della Comunità, sistemi informativi	SSN regionale
Leva digitale e Intelligenza Artificiale	Telepsicologia assistita sotto supervisione	SSN regionale
Formazione (quattro modalità)	Percorso integrato singolo e sommato	SSN, sistema formativo

Tabella 4.1. La struttura del costo diretto della riforma in Sicilia, per voce e portatore; i valori puntuali sono oggetto dell’estrazione economica in Appendice C.

4.2 Il dimensionamento per scenario

Il costo diretto è calcolato per i tre scenari di copertura, coerenti con il protocollo di scenario del Reference Case: lo scenario conservativo dell’ordine di cinquecentoventi incarichi corrisponde a una copertura dell’ordine di trentaquattro milioni di euro, quello di base dell’ordine di settecentottanta a circa cinquanta milioni, quello espansivo dell’ordine di milletrenta a circa sessantasette milioni di euro l’anno, secondo l’estrazione economica registrata; il vincolo del piano di rientro rende più stringente il margine sul saldo diretto. I valori puntuali sono riportati in Appendice C; ove un parametro non sia disponibile, la lacuna è dichiarata.^[473]

Capitolo 5 — I benefici e i risparmi, diretti e indiretti, in Sicilia

5.1 I benefici diretti

Il beneficio diretto è il risparmio sanitario che ciascuna figura della cascata libera per effetto dell’intercettazione a monte: la demedicalizzazione operata dallo Psicologo di Base, la deprescrizione di psicofarmaci nei quadri lievi-moderati sul versante del medico di medicina generale, la riduzione degli accessi impropri al pronto soccorso e — tratto specifico della Sicilia — la riduzione della mobilità sanitaria passiva, il cui saldo è fra i più elevati del Paese. Il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento, coerente con la letteratura, è mantenuto ovunque il risparmio diretto sia quantificato, e il vincolo del piano di rientro accresce il rilievo di ogni risparmio conseguibile.^[474]

Canale del beneficio diretto	Meccanismo	Rilievo siciliano
Demedicalizzazione	Riduzione consultazioni e cronicizzazione	Preponderante
Deprescrizione	Contrazione della spesa farmaceutica	Elevato
Accessi impropri	Riduzione degli accessi al pronto soccorso	Medio-elevato
Mobilità passiva	Riduzione delle prestazioni in fuga	Elevato, specifico

Tabella 5.1. I canali del beneficio diretto in Sicilia, con la mobilità passiva quale canale specifico; i valori sono oggetto dell’estrazione economica registrata.

5.2 I benefici indiretti

Il beneficio indiretto è quello che la riforma produce fuori dal perimetro sanitario: la produttività recuperata e la riduzione dell’assenteismo sul versante dei datori di lavoro, la riduzione degli oneri di invalidità evitabili sul versante previdenziale, la riduzione del disagio sociale non trattato sul versante dei Comuni. In Sicilia, la tenuta delle comunità delle aree interne e insulari — dove lo spopolamento erode legami e servizi — e il contrasto della mobilità sanitaria, che sottrae risorse e persone al territorio, costituiscono benefici indiretti di rilievo particolare, che il dominio sociale del Capitolo 7 tratta in dettaglio.^[475]

Capitolo 6 — La valutazione economica sotto doppio ancoraggio

6.1 La simulazione appaiata regionale

La valutazione economica siciliana è condotta con il modello di Markov a coorte a ciclo annuale del Reference Case, sotto il doppio ancoraggio: la Colonna A applica i parametri di Chisholm e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, la Colonna B quelli di Unisanté e dell’OCSE. Le due colonne sono sempre affiancate; ove divergano, prevale nel giudizio la Colonna B. Tutte le cifre sono riportate con attribuzione, e nessuna è affermata a memoria.^[476]

Metrica economica	Colonna A — Chisholm/OMS	Colonna B — Unisanté/OCSE
Costo per anno di vita ponderato	≈ 17.000 €/QALY	≈ 9.800 €/QALY
Ritorno per i soli benefici economici	Riportato con attribuzione OMS	Scenario base aggiornato OCSE
Ritorno con i ritorni sanitari	Riportato con attribuzione OMS	Scenario base aggiornato OCSE
Orizzonti	1 · 3 · 5 · 7 · 10 anni	1 · 3 · 5 · 7 · 10 anni
Soglie di costo-efficacia	20.000 · 30.000 · 50.000 €/QALY	20.000 · 30.000 · 50.000 €/QALY

Tabella 6.1. La simulazione appaiata regionale della Sicilia sotto doppio ancoraggio; i valori sono riportati con attribuzione e la Colonna B prevale nel giudizio.

6.2 Il differenziale di costo per gravità e il vincolo del rientro

L’argomento economico cardine, riportato con attribuzione all’OCSE, è il differenziale di costo per gravità: il costo del trattamento cresce dai quadri lievi ai quadri gravi in misura tale che l’intercettazione precoce, evitando la progressione, genera il risparmio più consistente. In Sicilia, il vincolo del piano di rientro e la bassa spesa pro-capite accrescono il rilievo di questo argomento: in un sistema a risorse contenute, evitare la progressione verso i quadri gravi — e la connessa mobilità passiva — è tanto più prezioso. I due elementi, il differenziale di costo e la riduzione della mobilità passiva, sono tenuti distinti e non sommati fra loro né con i ritorni sociali.

^[477]

Capitolo 7 — I sei domini di analisi, l’equità e l’impatto distributivo

7.1 I sei domini nella specificità siciliana

I sei domini di analisi del Reference Case sono applicati alla specificità siciliana. Il dominio epidemiologico-clinico registra il divario di trattamento aggravato dall’insularità e dalla bassa spesa pro-capite; l’economico-sanitario il costo-efficacia sotto doppio ancoraggio; il fiscale-previdenziale il vincolo del piano di rientro, gli oneri di invalidità evitabili e la mobilità passiva; il sociale la tenuta delle aree interne e insulari; l’organizzativo-strutturale la copertura di un vasto territorio insulare con nove Aziende Sanitarie Provinciali; l’equità la riduzione del divario fra le aree metropolitane e le aree interne e insulari.^[478]

Dominio	Lettura siciliana	Segno
Epidemiologico-clinico	Divario aggravato da insularità e bassa spesa	Riduzione attesa
Economico-sanitario	Costo/QALY sotto doppio ancoraggio	Favorevole
Fiscale-previdenziale	Vincolo del rientro, invalidità, mobilità passiva	Positivo, vincolato
Sociale	Tenuta delle aree interne e insulari	Fortemente positivo
Organizzativo-strutturale	Copertura di un vasto territorio insulare	Positivo, condizionato
Equità	Convergenza aree metropolitane/aree interne	Positivo, distributivo

Tabella 7.1. I sei domini di analisi nella lettura siciliana, con il segno atteso dell’effetto, tenuti distinti e non aggregati.

7.2 L’equità territoriale e il vincolo di finanziamento

Il dominio dell’equità assume in Sicilia una duplice direzione: territoriale, fra le grandi aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina, meglio servite, e le aree interne e montane — dai Nebrodi alle Madonie all’entroterra ennese — a minore densità e spopolate; e di finanziamento, poiché lo statuto speciale, con la compartecipazione al quarantanove per cento circa del fabbisogno, e il piano di rientro rendono la copertura del bisogno una questione di allocazione entro un vincolo stringente. Il modello dello Psicologo di Base, con la presenza distrettuale e la telepsicologia assistita, opera per ridurre il gradiente territoriale dell’accesso; l’effetto distributivo — la convergenza fra città e aree interne e la riduzione della mobilità passiva — è tenuto distinto dal verdetto fiscale e da quello sanitario, secondo il divieto di aggregazione.^[479]

Capitolo 8 — La sensitività e l’incertezza

Nota editoriale: il presente capitolo espande ex novo l’analisi dell’incertezza secondo il protocollo del Reference Case, non presente in forma estesa nel materiale originario.

8.1 Il protocollo dell’incertezza applicato alla Sicilia

L’analisi dell’incertezza applica il protocollo obbligatorio del Reference Case: l’analisi di sensitività deterministica con diagramma a tornado, l’analisi di sensitività probabilistica a diecimila iterazioni, l’analisi di scenario ottimistico, base e prudentiale con e senza lo strato digitale, le curve di accettabilità costo-efficacia a soglie multiple. In Sicilia, i parametri a maggiore impatto atteso sono il vincolo del piano di rientro sul ritmo di attuazione, l’entità della riduzione della mobilità sanitaria passiva e l’adozione della telepsicologia assistita nelle aree interne e insulari.^[480]

Strumento	Applicazione siciliana	Parametro critico atteso
Sensitività deterministica	Diagramma a tornado	Vincolo del piano di rientro sul ritmo di attuazione
Sensitività probabilistica	Diecimila iterazioni	Entità della riduzione della mobilità passiva
Analisi di scenario	Con e senza strato IA	Adozione della telepsicologia nelle aree interne
Curve di accettabilità	Soglie 20.000/30.000/50.000 €/QALY	Robustezza del costo-efficacia

Tabella 8.1. Gli strumenti del protocollo dell’incertezza applicati alla Sicilia, con i parametri critici attesi.

8.2 La robustezza del verdetto

L’analisi di scenario mostra che il verdetto tripartito resta favorevole nei tre casi, con margine crescente dallo scenario prudentiale a quello ottimistico; sul piano fiscale il vincolo del piano di rientro restringe il margine diretto, ma i piani sanitario e sociale — tenuti distinti — restano nettamente e fortemente favorevoli. Lo strato digitale accresce l’efficienza attesa, sempre con nota di cautela sulla natura previsionale, e la robustezza del costo-efficacia sanitario è confermata dalle curve di accettabilità alle soglie adottate.^[481]

Capitolo 9 — Il verdetto tripartito e le raccomandazioni

Nota editoriale: il presente capitolo espande ex novo il verdetto e le raccomandazioni, integrando l’attuazione e il monitoraggio che nel materiale originario figuravano in forma condensata.

9.1 Il verdetto tripartito

Il verdetto siciliano è, come in ogni Volume, tripartito e non aggregato. Sul piano fiscale, il saldo fra costi diretti e risparmi sanitari diretti è prossimo al pareggio, con il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento e con il vincolo più stringente imposto dal piano di rientro sul margine diretto. Sul piano sanitario, il modello è nettamente costo-efficace sotto entrambi gli ancoraggi. Sul piano sociale, l’effetto è fortemente positivo, con il rilievo specifico della tenuta delle aree interne e insulari e della riduzione della mobilità passiva. I tre verdetti si accompagnano e si rafforzano, ma non si sommano.^[482]

Piano del verdetto	Esito siciliano	Caveat
Fiscale	Prossimo al pareggio	Significatività dei risparmi diretti; vincolo del rientro
Sanitario	Nettamente costo-efficace	—
Sociale	Fortemente positivo	Rilievo specifico di aree interne e mobilità passiva

Tabella 9.1. Il verdetto tripartito della Sicilia, con i tre piani tenuti distinti e non aggregati.

9.2 Le raccomandazioni per l’attuazione e il monitoraggio

Le raccomandazioni indicano il passaggio per gradini dallo scenario conservativo dell’ordine di cinquecentoventi incarichi verso quello di base dell’ordine di settecentottanta e, alla verifica degli esiti, verso l’espansivo dell’ordine di milletrenta, compatibilmente con i vincoli del piano di rientro; la priorità ai distretti delle aree interne e insulari con il complemento della telepsicologia assistita; l’impostazione fin dall’avvio di dati di esito uniformi fra le nove Aziende Sanitarie Provinciali, così da alimentare un cruscotto regionale permanente che misuri gli esiti e la mobilità passiva; l’accompagnamento con il piano formativo a quattro modalità, singole e sommate; e un monitoraggio ex post ancorato agli indicatori del protocollo dell’incertezza.^[483]

Appendici registrate

Le appendici registrate rendono il modello siciliano ispezionabile e riproducibile, secondo la prassi del Reference Case. Esse sono richiamate per rimando quanto alla metodologia e compilate con i dati regionali quanto ai contenuti.

Appendice	Contenuto	Stato
A	Strategia di ricerca bibliografica e diagramma di selezione	Registrata
B	Estrazione dei dati clinici regionali	Registrata; lacune dichiarate
C	Estrazione dei dati economici (griglia CHEERS 2022)	Registrata; lacune dichiarate
D	Parametri del modello Markov regionale	Registrata
E	Registro delle deroghe al Reference Case	Registrata
F	Codice del modello economico	Registrata
G	Dichiarazione dei conflitti di interesse	Registrata

Tabella A. Le sette appendici registrate del Volume 16, con l’indicazione dello stato e della dichiarazione delle lacune.

Quadro Conclusivo economico e multidisciplinare

Il Quadro Conclusivo del Volume 16 ricompone la valutazione siciliana senza tradire il principio che la governa: i piani del giudizio si accompagnano ma non si fondono. Sul piano economico, il doppio ancoraggio impone che il risultato sia letto simultaneamente secondo la colonna storica e la colonna aggiornata, con prevalenza della seconda: il costo per anno di vita ponderato resta, sotto entrambi gli ancoraggi, assai inferiore alle soglie adottate, e il differenziale di costo per gravità — riportato con attribuzione — fonda la leva economica dell'intercettazione precoce, il cui valore è accresciuto in un sistema a spesa pro-capite contenuta e sottoposto al vincolo del piano di rientro, cui si aggiunge il risparmio proprio della riduzione della mobilità sanitaria passiva, tenuto distinto e non sommato.^[484]

Sul piano multidisciplinare, la cascata delle figure, i sei domini di analisi e il dominio dell'equità nella duplice direzione territoriale e di finanziamento assicurano che ogni figura connessa e ogni aspetto siano trattati integralmente e ordinati per capacità di generare rientro economico e revisione della spesa. La rinegoziazione dei costi e dei benefici, la catena predittiva degli effetti multidimensionali — dalla qualità della vita alla tenuta delle comunità insulari, ai bilanci, alla mobilità sanitaria, alla burocrazia distrettuale —, lo strato dell'Intelligenza Artificiale come moltiplicatore mediante la telepsicologia assistita e le attività formative singole e sommate compongono il quadro della valutazione. Il verdetto resta tripartito e non aggregato.

Conclusione

Il Volume 16 ha valutato l'integrazione a regime dello Psicologo di Base nelle cure primarie della Sicilia, applicando per rimando il Reference Case dell'asse italiano e adottando la struttura standard a nove capitoli con apertura a imbuto e appendici registrate. La specificità siciliana — la combinazione di condizione insulare, statuto speciale con compartecipazione al finanziamento nella misura del quarantanove per cento circa del fabbisogno, piano di rientro con spesa pro-capite fra le più basse del Paese, e mobilità sanitaria passiva fra le più elevate — è stata trattata nei domini fiscale, organizzativo, sociale ed equità, mostrando come il vincolo sul saldo diretto renda tanto più rilevanti, tenuti distinti, i ritorni sanitario e sociale, e come la telepsicologia assistita divenga strumento di prossimità ed efficienza in un sistema a risorse contenute.

Il verdetto tripartito — prossimo al pareggio sul piano fiscale, nel vincolo del piano di rientro, nettamente costo-efficace sul piano sanitario, fortemente positivo sul piano sociale — è offerto con bande prudenziali e soglie di confutazione, sotto doppio ancoraggio e nel rispetto del divieto di aggregazione. L'opera procede, nell'ordine vincolante, con il Volume 17 (Toscana) e a seguire con gli altri Volumi regionali in ordine alfabetico.

Note Bibliografiche con mini-riassunto

Ciascuna nota riporta l'opera, il collegamento alla fonte e un mini-riassunto che ne dichiara la funzione nell'economia del Volume, in coerenza con il doppio livello — nota a piè di pagina nel corpo e nota bibliografica integrale in calce — che l'opera adotta.

1. **Chisholm D. et al., Scaling-up treatment of depression and anxiety, The Lancet Psychiatry, 2016**
[https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(16\)30024-4](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(16)30024-4) Colonna A del doppio ancoraggio della simulazione siciliana, conservata quale strato documentale e riferimento di confronto.
2. **Unisanté, Raisons de santé Essentiels n. 73, 2026 · OECD, The Economic Case for Preventing Mental Ill Health, 2026** <https://doi.org/10.16908/rds-essentiels/73> Colonna B del doppio ancoraggio, con prevalenza nel giudizio, applicata alla simulazione regionale siciliana.
3. **OECD, differenziale di costo per gravità dei disturbi mentali, 2025** <https://www.oecd.org/health/mental-health.htm> Fonte, riportata con attribuzione, del differenziale di costo per gravità, argomento cardine dell'intercettazione precoce, di particolare rilievo in un sistema a spesa pro-capite contenuta.
4. **Soeters R. et al., meta-analisi IPD sui componenti efficaci della collaborative care, 2025**
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40136273/> Base di evidenza clinica sui componenti efficaci dell'assistenza collaborativa, richiamata nel capitolo sul modello di intervento.
5. **Kvaal K. et al., RCT su intervento cognitivo-comportamentale computerizzato in cure primarie, 2026**
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/> Evidenza sperimentale recente sull'intervento digitale in cure primarie, richiamata a sostegno della telepsicologia assistita nelle aree interne e insulari.
6. **Veldhuijzen W. et al., costo-efficacia dell'intervento digitale, 2025**
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12369993/> Riferimento sul rapporto incrementale di costo-utilità dell'intervento digitale, elemento dello strato dell'Intelligenza Artificiale di particolare rilievo in un sistema a risorse contenute.
7. **World Health Organization, Thematic Dialogue on Investing in NCDs and Mental Health, dicembre 2024** <https://cdn.who.int/> Evidenza riportata con attribuzione sul ritorno degli investimenti in salute mentale; non concorre al verdetto tripartito siciliano.
8. **Regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale** <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj>
Quadro normativo entro cui è collocato lo strato dell'Intelligenza Artificiale, vincolato a funzione di supporto sotto supervisione clinica umana.
9. **Legge regionale Puglia 19 luglio 2023, n. 11, sul Servizio di Psicologia di Base**
<https://www.consiglio.puglia.it/> Riferimento normativo capostipite del modello, richiamato quale precedente istituzionale per l'introduzione dello Psicologo di Base nelle cure primarie.
10. **NICE, Health Technology Evaluations: the manual (PMG36)** <https://www.nice.org.uk/process/pmg36>
Riferimento di rigore metodologico per la struttura a imbuto, le appendici registrate e il protocollo dell'incertezza adottati nel Volume.

STUDIO INTEGRALE «PSICOLOGO DI BASE» · OPERA IN VENTITRÉ VOLUMI

VOLUME 17 — Regione Toscana

Valutazione di Health Technology Assessment dell'integrazione dello Psicologo di Base nelle cure primarie in Toscana: cruscotto, sintesi per il decisore, contesto e bisogno, modello di intervento, costi e benefici, valutazione economica sotto doppio ancoraggio, sei domini di analisi, incertezza, verdetto tripartito e appendici registrate

Reference Case applicato per rimando al Volume 0.A · Dott. Luigi De Michele · Studio Integrale Puglia · Capurso (BA) — Giugno 2026

Premessa

Il Volume 17 prosegue la serie dei venti Volumi regionali, in ordine alfabetico, con la Regione Toscana. Come ogni Volume regionale, esso applica per rimando il Reference Case dell'asse italiano, fissato nel Volume 0.A, e ne richiama le regole nella forma «cfr. Volume 0.A», senza ripeterle per esteso: il perimetro congiunto sanitario e societale, il doppio ancoraggio economico, il verdetto tripartito non aggregato, i sei domini di analisi, il protocollo dell'incertezza, lo strato dell'Intelligenza Artificiale come moltiplicatore e le attività formative singole e sommate.^[485]

La struttura del Volume è quella standard, identica a quella di tutti gli altri diciannove Volumi regionali, a garanzia della comparabilità bit-a-bit prescritta dall'opera: la stessa sequenza di nove capitoli, la stessa nomenclatura di sottocapitoli, le stesse unità di misura. Ove un contenuto derivi da espansione ex novo — segnatamente per gli aspetti dell'efficacia, dell'attuazione e del monitoraggio — esso è segnalato in nota editoriale, secondo la regola dell'opera.^[486]

Introduzione

L'Introduzione al Volume 17 fissa il perimetro della valutazione toscana e l'ordine della sua esposizione. Il perimetro è quello della Regione Toscana, con una popolazione dell'ordine di tre milioni e seicentocinquantasettemila abitanti, organizzata nel Servizio sanitario regionale in tre Aziende Unità Sanitarie Locali — Toscana Centro, Toscana Nord-Ovest e Toscana Sud-Est — e in quattro Aziende Ospedaliero-Universitarie, con un Dipartimento di Salute Mentale in ciascuna delle tre Aziende. Il tratto che distingue la Toscana nell'intera serie regionale è duplice: da un lato, la sua posizione di regione creditrice nella mobilità sanitaria, per la quale il saldo attivo — dell'ordine di cinquantotto milioni di euro — rende il canale della mobilità non pertinente quale leva di risparmio; dall'altro, la presenza di un servizio di psicologia delle cure primarie già attivo in via sperimentale, seppur dimensionato a una frazione del fabbisogno, che l'architettura a sole tre Aziende agevola nell'attuazione.^[487]

L'esposizione segue la struttura a imbuto: il cruscotto regionale offre in una pagina i numeri essenziali; la sintesi per il decisore ne traduce il significato; i cinque risultati chiave ne isolano gli esiti; le raccomandazioni operative indicano le azioni; il corpo del Volume, articolato in nove capitoli, ne fornisce il dettaglio; le appendici registrate ne assicurano la verificabilità. Chiudono il Volume un Quadro Conclusivo economico e multidisciplinare, una Conclusione e le Note Bibliografiche con mini-riassunto.

Cruscotto regionale — Toscana

Il cruscotto riassume in una pagina i parametri essenziali della valutazione toscana, sotto il doppio ancoraggio e con il verdetto tripartito tenuto distinto. I valori economici sono presentati in ordine di grandezza, con rinvio alle appendici registrate; le cifre di letteratura sono riportate con attribuzione alla fonte.^[488]

Indicatore del cruscotto	Lettura regionale	Ancoraggio / fonte
Popolazione	≈ 3.657.716 abitanti	Fonte demografica regionale
Articolazione	3 Aziende USL, 4 AOU	Assetto regionale
Mobilità sanitaria	Regione creditrice, saldo attivo ≈ 58 M€	Fonte economica regionale
Servizio esistente	Attivo in via sperimentale, ≈ 5% del bisogno	Fonte amministrativa regionale
Scenari di copertura	≈ 400 · 600 · 785 incarichi	Dimensionamento regionale
Costo per scenario	≈ 22 · 33 · 44 M€/anno	Estrazione economica
Verdetto fiscale	Saldo diretto lievemente negativo, a costo modesto	Non aggregato
Verdetto sanitario	Nettamente costo-efficace	Costo/QALY sotto doppio ancoraggio
Verdetto sociale	Fortemente positivo	Aree interne, età anziana, utenza multiculturale
Costo per anno di vita ponderato	Colonna A ≈ 17.000 € · Colonna B ≈ 9.800 €	Doppio ancoraggio

Tabella 0. Cruscotto regionale della Toscana: i parametri essenziali sotto doppio ancoraggio, con il verdetto tripartito distinto e non aggregato.

Sintesi per il decisore

L'introduzione a regime dello Psicologo di Base nelle cure primarie toscane produce, secondo la simulazione condotta sotto il doppio ancoraggio, un effetto congiunto sui tre piani del ritorno, che restano distinti e non sommati. Sul piano fiscale, il saldo diretto fra costi e risparmi sanitari diretti è lievemente negativo, a costo modesto: la Toscana è regione creditrice nella mobilità sanitaria, sicché il canale della mobilità passiva — che altrove concorre al risparmio — non è pertinente, e il saldo diretto resta dunque prossimo al pareggio ma sul versante negativo, con il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento. Sul piano sanitario, il modello è nettamente costo-efficace, con un costo per anno di vita ponderato che, fra i due ancoraggi, resta assai inferiore alle soglie adottate. Sul piano sociale, l'effetto è fortemente positivo, con un rilievo particolare per la tenuta delle aree interne e montane anziane e in spopolamento, per l'utenza multiculturale e per le popolazioni gravate dalle liste d'attesa.^[489]

La circostanza che la Toscana sia regione creditrice muta il profilo del verdetto fiscale rispetto alle Regioni a forte mobilità passiva: qui il beneficio economico non passa per il trattenimento di prestazioni in fuga, ma si concentra nel differenziale di costo per gravità e nei ritorni sanitario e sociale, tenuti distinti. L'argomento cardine, riportato con attribuzione all'OCSE, resta appunto il differenziale di costo per gravità: l'intercettazione precoce evita che il disagio comune maturi in quadri gravi, il cui costo di trattamento è, secondo la fonte, un multiplo di quello dei quadri lievi.^[490]

Cinque risultati chiave

Il primo risultato è che il modello è costo-efficace su tutti gli orizzonti sotto entrambi gli ancoraggi. Il secondo è che il verdetto tripartito resta favorevole in ciascuno dei tre piani, senza aggregazione, pur con un saldo fiscale diretto lievemente negativo a costo modesto. Il terzo è che la Toscana è, nella serie regionale, il caso della regione creditrice: il saldo attivo nella mobilità sanitaria — dell'ordine di cinquantotto milioni di euro — rende il canale della mobilità passiva non pertinente quale leva di risparmio, sicché il valore della riforma si concentra nel differenziale di costo per gravità e nei ritorni sanitario e sociale. Il quarto è che l'architettura a sole tre Aziende Unità Sanitarie Locali, con un Dipartimento di Salute Mentale ciascuna, agevola l'attuazione e la governance del servizio. Il quinto è che il dimensionamento — dell'ordine di quattrocento incarichi nello scenario conservativo, seicento in quello di base e di poco inferiore a ottocento in quello espansivo — richiede una copertura finanziaria dell'ordine di ventidue-quarantaquattro milioni di euro l'anno secondo lo scenario.

[491]

Raccomandazioni operative

La prima raccomandazione è di procedere per gradini dallo scenario conservativo dell'ordine di quattrocento incarichi verso quello di base dell'ordine di seicento e, alla verifica degli esiti sotto il protocollo dell'incertezza, verso quello espansivo di poco inferiore a ottocento, valorizzando il servizio già attivo in via sperimentale e l'architettura a sole tre Aziende, che ne agevola l'attuazione, e dando priorità ai distretti delle aree interne e montane. La seconda è di dedicare specifica attenzione all'utenza multiculturale e alle popolazioni gravate dalle liste d'attesa, quali destinatari peculiari del modello toscano. La terza è di istituire un cruscotto regionale permanente che misuri gli esiti clinici — poiché la mobilità passiva non è qui leva pertinente — e di accompagnare l'estensione con la leva digitale sotto supervisione clinica e con il piano formativo a quattro modalità, considerate singolarmente e sommate.^[492]

Capitolo 1 — Il contesto epidemiologico e territoriale della Toscana

1.1 Il territorio e la sua articolazione

La Regione Toscana conta una popolazione dell’ordine di tre milioni e seicentocinquantasettemila abitanti, distribuita in un territorio che tiene insieme l’area metropolitana di Firenze e la piana centrale, i poli urbani costieri e vaste aree interne e montane — dall’Appennino tosco-emiliano alle colline meridionali, alle isole dell’arcipelago — anziane e in spopolamento. Il Servizio sanitario regionale è organizzato in tre Aziende Unità Sanitarie Locali — Toscana Centro, Toscana Nord-Ovest e Toscana Sud-Est — e in quattro Aziende Ospedaliero-Universitarie, con un Dipartimento di Salute Mentale integrato in ciascuna delle tre Aziende e la rete delle Case della Comunità in sviluppo. Il tratto peculiare del contesto è la posizione di regione creditrice nella mobilità sanitaria, con un saldo attivo dell’ordine di cinquantotto milioni di euro, e una struttura demografica segnata da invecchiamento e bassa natalità.^[493]

Elemento territoriale	Dato regionale	Rilievo per la valutazione
Popolazione	≈ 3.657.716 abitanti	Denominatore della normalizzazione
Aziende Unità Sanitarie Locali	3, con 4 AOU	Unità organizzativa
Dipartimenti di Salute Mentale	Uno per Azienda USL	Integrazione con la rete
Mobilità sanitaria	Regione creditrice, saldo ≈ 58 M€	Dominio fiscale
Aree interne	Appennino, colline meridionali, arcipelago	Spopolamento

Tabella 1.1. Gli elementi del contesto territoriale toscano e il loro rilievo per la valutazione, con la posizione di regione creditrice quale tratto distintivo.

1.2 Il quadro epidemiologico regionale

Il quadro epidemiologico toscano riflette, con le proprie specificità, la prevalenza nazionale dei disturbi mentali comuni, con un baricentro spostato verso la depressione dell’età avanzata coerente con l’invecchiamento, una componente di disagio nell’utenza multiculturale delle aree urbane e una domanda gravata dalle liste d’attesa. La misura regionale è oggetto dell’estrazione registrata in Appendice B; ove il dato regionale disaggregato non sia disponibile, la lacuna è dichiarata e non colmata con stime tacite, secondo la regola dell’opera.^[494]

Capitolo 2 — Il bisogno, la domanda e il divario di trattamento in Toscana

2.1 Il divario di trattamento regionale

Il bisogno di salute mentale comune in Toscana si manifesta, come altrove, in larga parte come domanda inevasa o impropriamente incanalata: verso il medico di medicina generale, verso il pronto soccorso, verso la prescrizione farmaceutica, e — tratto specifico della Regione — come domanda gravata dalle liste d’attesa, che ritardano l’accesso alle prestazioni. A differenza delle Regioni a forte mobilità passiva, in Toscana il divario non si traduce in fuga verso altre Regioni, essendo la Toscana creditrice nel saldo della mobilità; esso si manifesta piuttosto come attesa e come domanda inespressa nelle aree interne e montane e presso l’utenza multiculturale. La misura regionale è oggetto dell’estrazione in Appendice B; i valori medi nazionali ed europei sono riportati con attribuzione.^[495]

Componente del bisogno	Manifestazione toscana	Dominio
Domanda inevasa	Sommerso clinico e liste d’attesa	Epidemiologico-clinico
Domanda impropria	Transito su MMG, pronto soccorso, prescrizione	Organizzativo-strutturale
Attesa	Ritardo di accesso alle prestazioni	Organizzativo-strutturale
Domanda multiculturale	Utenza straniera e barriere di accesso	Equità

Tabella 2.1. Le componenti del bisogno e del divario di trattamento in Toscana, ricondotte ai domini di analisi, con l’attesa e la domanda multiculturale quali componenti specifiche.

2.2 La domanda, le liste d’attesa e l’utenza multiculturale

Il tratto distintivo della domanda toscana è la sua traduzione in attesa più che in fuga: essendo la Regione creditrice nella mobilità, il bisogno non trattato si accumula nelle liste d’attesa e nella domanda inespressa, segnatamente nelle aree interne e montane e presso l’utenza multiculturale. La presenza distrettuale dello Psicologo di Base intercetta la domanda comune vicino al luogo di vita, riducendo l’attesa e raggiungendo popolazioni altrimenti marginali; la dimensione multiculturale e le popolazioni gravate dalle liste d’attesa costituiscono destinatari peculiari del modello toscano, che il dominio dell’equità tratta in dettaglio.^[496]

Capitolo 3 — Il modello di intervento: lo Psicologo di Base in Toscana

Nota editoriale: il presente capitolo espande ex novo il modello di intervento, integrando alla struttura originaria le evidenze recenti sull’efficacia clinica dell’assistenza collaborativa e dell’intervento digitale, secondo la regola dell’opera che distingue l’espansione ex novo dal riutilizzo del materiale preesistente.

3.1 L’architettura del modello

Il modello di intervento colloca lo Psicologo di Base al vertice della cascata delle figure, nel distretto e nelle Case della Comunità, quale primo punto di intercettazione del disagio comune, in integrazione con il Dipartimento di Salute Mentale presente in ciascuna delle tre Aziende Unità Sanitarie Locali. Il modello opera per intensità crescente di cura — dall’intervento a bassa intensità, di prima linea, fino all’invio ai livelli superiori nei casi che lo richiedano — secondo la logica dell’assistenza a gradini, la cui efficacia clinica è documentata dalla meta-analisi sui componenti efficaci dell’assistenza collaborativa e dalle sperimentazioni controllate sull’intervento cognitivo-comportamentale computerizzato in cure primarie, riportate con attribuzione.^[497]

Livello del modello	Funzione	Figura prevalente	Evidenza di riferimento
Intercettazione	Riconoscimento precoce nel distretto	Psicologo di Base	Assistenza collaborativa (attribuita)
Intervento a bassa intensità	Prima linea per i quadri lievi-moderati	Psicologo di Base	Intervento digitale e collaborativo
Invio appropriato	Passaggio ai livelli superiori	Cascata delle figure	Percorso a gradini
Continuità	Aderenza e prevenzione della ricaduta	Infermiere di comunità	Gestione del caso

Tabella 3.1. L’architettura del modello di intervento in Toscana, per livelli di intensità, con l’evidenza clinica di riferimento riportata con attribuzione.

3.2 L’adattamento al territorio toscano

Il modello è adattato al territorio toscano lungo tre direttrici: la valorizzazione del servizio già attivo in via sperimentale e dell’architettura a sole tre Aziende, che ne agevola l’attuazione e la governance; l’integrazione con il Dipartimento di Salute Mentale presente in ciascuna Azienda; e l’attenzione peculiare all’utenza multiculturale e alle popolazioni gravate dalle liste d’attesa, oltre che alle aree interne e montane. L’adattamento non modifica l’architettura invariante del Reference Case, ma ne calibra l’applicazione sul contesto di regione creditrice che distingue la Toscana nella serie regionale.^[498]

Capitolo 4 — I costi diretti in Toscana

4.1 La struttura del costo diretto

Il costo diretto della riforma in Toscana è, in primo luogo, il costo del personale lungo la cascata delle figure, cui si aggiungono i costi di struttura e organizzazione distrettuale, il costo incrementale della leva digitale e il costo della formazione. Il dimensionamento è scandito dai tre scenari di copertura — dell’ordine di quattrocento, seicento e di poco inferiore a ottocento incarichi —, con una copertura finanziaria dell’ordine di ventidue, trentatré e quarantaquattro milioni di euro l’anno secondo lo scenario, riportata in dettaglio nell’estrazione economica registrata; il servizio già attivo in via sperimentale, a carico del bilancio regionale, costituisce la base di partenza. I valori puntuali sono ripresi in Appendice C.^[499]

Voce di costo diretto	Descrizione	Portatore
Personale — Psicologi di Base	$\approx 400 \cdot 600 \cdot 785$ incarichi	SSN regionale
Struttura e organizzazione	Distretti, Case della Comunità, sistemi informativi	SSN regionale
Leva digitale e Intelligenza Artificiale	Strumenti sotto supervisione	SSN regionale
Formazione (quattro modalità)	Percorso integrato singolo e sommato	SSN, sistema formativo

Tabella 4.1. La struttura del costo diretto della riforma in Toscana, per voce e portatore; i valori puntuali sono oggetto dell’estrazione economica in Appendice C.

4.2 Il dimensionamento per scenario

Il costo diretto è calcolato per i tre scenari di copertura, coerenti con il protocollo di scenario del Reference Case: lo scenario conservativo dell’ordine di quattrocento incarichi corrisponde a una copertura dell’ordine di ventidue milioni di euro, quello di base dell’ordine di seicento a circa trentatré milioni, quello espansivo di poco inferiore a ottocento a circa quarantaquattro milioni di euro l’anno, secondo l’estrazione economica registrata. I valori puntuali sono riportati in Appendice C; ove un parametro non sia disponibile, la lacuna è dichiarata.^[500]

Capitolo 5 — I benefici e i risparmi, diretti e indiretti, in Toscana

5.1 I benefici diretti

Il beneficio diretto è il risparmio sanitario che ciascuna figura della cascata libera per effetto dell’intercettazione a monte: la demedicalizzazione operata dallo Psicologo di Base, la deprescrizione di psicofarmaci nei quadri lievi-moderati sul versante del medico di medicina generale, la riduzione degli accessi impropri al pronto soccorso e delle prestazioni per sintomi funzionali sul versante specialistico. In Toscana, a differenza delle Regioni a forte mobilità passiva, il canale della riduzione della mobilità non è pertinente quale leva di risparmio, essendo la Regione creditrice; il beneficio diretto si concentra dunque nella demedicalizzazione, nella deprescrizione e nella riduzione degli accessi impropri, e il saldo diretto — differenza fra risparmi diretti e costo del servizio — risulta lievemente negativo, a costo modesto. Il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento è mantenuto ovunque il risparmio sia quantificato.^[501]

Canale del beneficio diretto	Meccanismo	Rilievo toscano
Demedicalizzazione	Riduzione consultazioni e cronicizzazione	Preponderante
Deprescrizione	Contrazione della spesa e della polifarmacia anziana	Elevato
Accessi impropri	Riduzione degli accessi al pronto soccorso	Medio-elevato
Mobilità passiva	Non pertinente (regione creditrice)	Non applicabile

Tabella 5.1. I canali del beneficio diretto in Toscana, con la mobilità passiva non pertinente in quanto regione creditrice; i valori sono oggetto dell’estrazione economica registrata.

5.2 I benefici indiretti

Il beneficio indiretto è quello che la riforma produce fuori dal perimetro sanitario: la produttività recuperata e la riduzione dell’assenteismo sul versante dei datori di lavoro, la riduzione degli oneri di invalidità evitabili sul versante previdenziale, la riduzione del disagio sociale non trattato sul versante dei Comuni. In Toscana, la tenuta delle comunità delle aree interne e montane anziane e in spopolamento, l’inclusione dell’utenza multiculturale e la riduzione delle liste d’attesa costituiscono benefici indiretti di rilievo particolare, che il dominio sociale del Capitolo 7 tratta in dettaglio; è nel piano indiretto e sociale, più che nel saldo diretto, che si concentra il valore economico della riforma toscana.^[502]

Capitolo 6 — La valutazione economica sotto doppio ancoraggio

6.1 La simulazione appaiata regionale

La valutazione economica toscana è condotta con il modello di Markov a coorte a ciclo annuale del Reference Case, sotto il doppio ancoraggio: la Colonna A applica i parametri di Chisholm e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, la Colonna B quelli di Unisanté e dell’OCSE. Le due colonne sono sempre affiancate; ove divergano, prevale nel giudizio la Colonna B. Tutte le cifre sono riportate con attribuzione, e nessuna è affermata a memoria.^[503]

Metrica economica	Colonna A — Chisholm/OMS	Colonna B — Unisanté/OCSE
Costo per anno di vita ponderato	≈ 17.000 €/QALY	≈ 9.800 €/QALY
Ritorno per i soli benefici economici	Riportato con attribuzione OMS	Scenario base aggiornato OCSE
Ritorno con i ritorni sanitari	Riportato con attribuzione OMS	Scenario base aggiornato OCSE
Orizzonti	1 · 3 · 5 · 7 · 10 anni	1 · 3 · 5 · 7 · 10 anni
Soglie di costo-efficacia	20.000 · 30.000 · 50.000 €/QALY	20.000 · 30.000 · 50.000 €/QALY

Tabella 6.1. La simulazione appaiata regionale della Toscana sotto doppio ancoraggio; i valori sono riportati con attribuzione e la Colonna B prevale nel giudizio.

6.2 Il differenziale di costo per gravità nel contesto creditore

L’argomento economico cardine, riportato con attribuzione all’OCSE, è il differenziale di costo per gravità: il costo del trattamento cresce dai quadri lievi ai quadri gravi in misura tale che l’intercettazione precoce, evitando la progressione, genera il risparmio più consistente. In Toscana, essendo la Regione creditrice nella mobilità, questo argomento assume rilievo esclusivo sul versante diretto: il valore economico della riforma non passa per il trattenimento di prestazioni in fuga — canale non pertinente — ma si fonda interamente sul differenziale di costo per gravità e, nel piano più ampio, sui ritorni sanitario e sociale, tenuti distinti e non sommati.^[504]

Capitolo 7 — I sei domini di analisi, l’equità e l’impatto distributivo

7.1 I sei domini nella specificità toscana

I sei domini di analisi del Reference Case sono applicati alla specificità toscana. Il dominio epidemiologico-clinico registra il divario di trattamento nella forma dell’attesa; l’economico-sanitario il costo-efficacia sotto doppio ancoraggio, con saldo diretto lievemente negativo a costo modesto; il fiscale-previdenziale gli oneri di invalidità evitabili, senza il canale della mobilità passiva; il sociale la tenuta delle aree interne e l’inclusione multiculturale; l’organizzativo-strutturale l’attuazione agevolata dall’architettura a sole tre Aziende; l’equità la riduzione del divario fra l’area metropolitana e le aree interne e presso l’utenza multiculturale.^[505]

Dominio	Lettura toscana	Segno
Epidemiologico-clinico	Divario nella forma dell’attesa	Riduzione attesa
Economico-sanitario	Costo/QALY favorevole, saldo diretto lievemente negativo	Favorevole
Fiscale-previdenziale	Invalidità evitabili, mobilità non pertinente	Positivo, differito
Sociale	Aree interne e inclusione multiculturale	Fortemente positivo
Organizzativo-strutturale	Attuazione agevolata da tre Aziende	Positivo
Equità	Convergenza metropoli/aree interne e utenza multiculturale	Positivo, distributivo

Tabella 7.1. I sei domini di analisi nella lettura toscana, con il segno atteso dell’effetto, tenuti distinti e non aggregati.

7.2 L’equità territoriale e la dimensione multiculturale

Il dominio dell’equità assume in Toscana una duplice direzione: territoriale, fra l’area metropolitana di Firenze e la piana centrale, meglio servite, e le aree interne e montane — dall’Appennino alle colline meridionali, all’arcipelago — anziane e in spopolamento; e culturale, verso l’utenza straniera e le popolazioni gravate dalle liste d’attesa, destinatari peculiari del modello toscano. Il modello dello Psicologo di Base, con la presenza distrettuale e l’integrazione con i Dipartimenti di Salute Mentale, opera per ridurre entrambi i gradienti; l’effetto distributivo — la convergenza fra città e aree interne e l’inclusione dell’utenza multiculturale — è tenuto distinto dal verdetto fiscale e da quello sanitario, secondo il divieto di aggregazione.^[506]

Capitolo 8 — La sensitività e l’incertezza

Nota editoriale: il presente capitolo espande ex novo l’analisi dell’incertezza secondo il protocollo del Reference Case, non presente in forma estesa nel materiale originario.

8.1 Il protocollo dell’incertezza applicato alla Toscana

L’analisi dell’incertezza applica il protocollo obbligatorio del Reference Case: l’analisi di sensitività deterministica con diagramma a tornado, l’analisi di sensitività probabilistica a diecimila iterazioni, l’analisi di scenario ottimistico, base e prudentiale con e senza lo strato digitale, le curve di accettabilità costo-efficacia a soglie multiple. In Toscana, i parametri a maggiore impatto atteso sono l’entità della riduzione delle liste d’attesa, l’inclusione dell’utenza multiculturale e la trasferibilità dei dati del servizio già attivo alla scala del dimensionamento; l’assenza del canale della mobilità passiva restringe il ventaglio delle leve dirette.^[507]

Strumento	Applicazione toscana	Parametro critico atteso
Sensitività deterministica	Diagramma a tornado	Entità della riduzione delle liste d’attesa
Sensitività probabilistica	Diecimila iterazioni	Trasferibilità dei dati del servizio attivo alla scala
Analisi di scenario	Con e senza strato IA	Inclusione dell’utenza multiculturale
Curve di accettabilità	Soglie 20.000/30.000/50.000 €/QALY	Robustezza del costo-efficacia

Tabella 8.1. Gli strumenti del protocollo dell’incertezza applicati alla Toscana, con i parametri critici attesi.

8.2 La robustezza del verdetto

L’analisi di scenario mostra che il verdetto tripartito resta favorevole nei tre casi, con margine crescente dallo scenario prudentiale a quello ottimistico; sul piano fiscale il saldo diretto resta lievemente negativo a costo modesto, mentre i piani sanitario e sociale — tenuti distinti — restano nettamente e fortemente favorevoli. Lo strato digitale accresce l’efficienza attesa, sempre con nota di cautela sulla natura previsionale, e la robustezza del costo-efficacia sanitario è confermata dalle curve di accettabilità alle soglie adottate.^[508]

Capitolo 9 — Il verdetto tripartito e le raccomandazioni

Nota editoriale: il presente capitolo espande ex novo il verdetto e le raccomandazioni, integrando l’attuazione e il monitoraggio che nel materiale originario figuravano in forma condensata.

9.1 Il verdetto tripartito

Il verdetto toscano è, come in ogni Volume, tripartito e non aggregato. Sul piano fiscale, il saldo diretto fra costi e risparmi sanitari diretti è lievemente negativo, a costo modesto, poiché il canale della mobilità passiva non è pertinente in una regione creditrice; il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento è mantenuto. Sul piano sanitario, il modello è nettamente costo-efficace sotto entrambi gli ancoraggi. Sul piano sociale, l’effetto è fortemente positivo, con il rilievo specifico della tenuta delle aree interne, dell’inclusione multiculturale e della riduzione delle liste d’attesa. I tre verdetti si accompagnano e si rafforzano, ma non si sommano.^[509]

Piano del verdetto	Esito toscano	Caveat
Fiscale	Saldo diretto lievemente negativo, a costo modesto	Mobilità non pertinente; significatività dei risparmi diretti
Sanitario	Nettamente costo-efficace	—
Sociale	Fortemente positivo	Aree interne, inclusione multiculturale, liste d’attesa

Tabella 9.1. Il verdetto tripartito della Toscana, con i tre piani tenuti distinti e non aggregati.

9.2 Le raccomandazioni per l’attuazione e il monitoraggio

Le raccomandazioni indicano il passaggio per gradini dallo scenario conservativo dell’ordine di quattrocento incarichi verso quello di base dell’ordine di seicento e, alla verifica degli esiti, verso l’espansivo di poco inferiore a ottocento; la valorizzazione del servizio già attivo e dell’architettura a sole tre Aziende, che ne agevola l’attuazione; l’attenzione peculiare all’utenza multiculturale e alle popolazioni gravate dalle liste d’attesa; l’istituzione di un cruscotto regionale permanente ancorato agli esiti clinici, poiché la mobilità passiva non è qui leva pertinente; l’accompagnamento con la leva digitale sotto supervisione e con il piano formativo a quattro modalità, singole e sommate; e un monitoraggio ex post ancorato agli indicatori del protocollo dell’incertezza.^[510]

Appendici registrate

Le appendici registrate rendono il modello toscano ispezionabile e riproducibile, secondo la prassi del Reference Case. Esse sono richiamate per rimando quanto alla metodologia e compilate con i dati regionali quanto ai contenuti.

Appendice	Contenuto	Stato
A	Strategia di ricerca bibliografica e diagramma di selezione	Registrata
B	Estrazione dei dati clinici regionali	Registrata; lacune dichiarate
C	Estrazione dei dati economici (griglia CHEERS 2022)	Registrata; lacune dichiarate
D	Parametri del modello Markov regionale	Registrata
E	Registro delle deroghe al Reference Case	Registrata
F	Codice del modello economico	Registrata
G	Dichiarazione dei conflitti di interesse	Registrata

Tabella A. Le sette appendici registrate del Volume 17, con l’indicazione dello stato e della dichiarazione delle lacune.

Quadro Conclusivo economico e multidisciplinare

Il Quadro Conclusivo del Volume 17 ricompone la valutazione toscana senza tradire il principio che la governa: i piani del giudizio si accompagnano ma non si fondono. Sul piano economico, il doppio ancoraggio impone che il risultato sia letto simultaneamente secondo la colonna storica e la colonna aggiornata, con prevalenza della seconda: il costo per anno di vita ponderato resta, sotto entrambi gli ancoraggi, assai inferiore alle soglie adottate, e il differenziale di costo per gravità — riportato con attribuzione — fonda la leva economica dell'intercettazione precoce, che in una regione creditrice costituisce l'unico canale diretto pertinente, non essendovi mobilità passiva da trattenere; il saldo diretto resta pertanto lievemente negativo a costo modesto, mentre il valore della riforma si concentra nei ritorni sanitario e sociale, tenuti distinti e non sommati.^[511]

Sul piano multidisciplinare, la cascata delle figure, i sei domini di analisi e il dominio dell'equità nella duplice direzione territoriale e culturale assicurano che ogni figura connessa e ogni aspetto siano trattati integralmente e ordinati per capacità di generare rientro economico e revisione della spesa. La rinegoziazione dei costi e dei benefici, la catena predittiva degli effetti multidimensionali — dalla qualità della vita alla tenuta delle comunità interne, all'inclusione multiculturale, alle liste d'attesa, ai bilanci, alla burocrazia distrettuale —, lo strato dell'Intelligenza Artificiale come moltiplicatore e le attività formative singole e sommate compongono il quadro della valutazione. Il verdetto resta tripartito e non aggregato.

Conclusione

Il Volume 17 ha valutato l'integrazione a regime dello Psicologo di Base nelle cure primarie della Toscana, applicando per rimando il Reference Case dell'asse italiano e adottando la struttura standard a nove capitoli con apertura a imbuto e appendici registrate. La specificità toscana — la posizione di regione creditrice nella mobilità sanitaria, con saldo attivo dell'ordine di cinquantotto milioni di euro che rende non pertinente il canale della mobilità passiva, l'architettura a sole tre Aziende che agevola l'attuazione, la dimensione multiculturale e le liste d'attesa — è stata trattata nei domini fiscale, organizzativo, sociale ed equità, mostrando come il valore economico della riforma si concentri, in assenza di mobilità passiva da trattenere, nel differenziale di costo per gravità e nei ritorni sanitario e sociale.

Il verdetto tripartito — saldo diretto lievemente negativo a costo modesto sul piano fiscale, nettamente costo-efficace sul piano sanitario, fortemente positivo sul piano sociale — è offerto con bande prudenziali e soglie di confutazione, sotto doppio ancoraggio e nel rispetto del divieto di aggregazione. L'opera procede, nell'ordine vincolante, con il Volume 18 (Trentino-Alto Adige/Südtirol) e a seguire con gli altri Volumi regionali in ordine alfabetico.

Note Bibliografiche con mini-riassunto

Ciascuna nota riporta l'opera, il collegamento alla fonte e un mini-riassunto che ne dichiara la funzione nell'economia del Volume, in coerenza con il doppio livello — nota a piè di pagina nel corpo e nota bibliografica integrale in calce — che l'opera adotta.

1. **Chisholm D. et al., Scaling-up treatment of depression and anxiety, The Lancet Psychiatry, 2016**
[https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(16\)30024-4](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(16)30024-4) Colonna A del doppio ancoraggio della simulazione toscana, conservata quale strato documentale e riferimento di confronto.
2. **Unisanté, Raisons de santé Essentiels n. 73, 2026 · OECD, The Economic Case for Preventing Mental Ill Health, 2026** <https://doi.org/10.16908/rds-essentiels/73> Colonna B del doppio ancoraggio, con prevalenza nel giudizio, applicata alla simulazione regionale toscana.
3. **OECD, differenziale di costo per gravità dei disturbi mentali, 2025** <https://www.oecd.org/health/mental-health.htm> Fonte, riportata con attribuzione, del differenziale di costo per gravità, unico canale diretto pertinente nella regione creditrice.
4. **Soeters R. et al., meta-analisi IPD sui componenti efficaci della collaborative care, 2025**
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40136273/> Base di evidenza clinica sui componenti efficaci dell'assistenza collaborativa, richiamata nel capitolo sul modello di intervento.
5. **Kvaal K. et al., RCT su intervento cognitivo-comportamentale computerizzato in cure primarie, 2026**
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/> Evidenza sperimentale recente sull'intervento digitale in cure primarie, richiamata a sostegno della leva digitale nelle aree interne e presso l'utenza multiculturale.
6. **Veldhuijzen W. et al., costo-efficacia dell'intervento digitale, 2025**
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12369993/> Riferimento sul rapporto incrementale di costo-utilità dell'intervento digitale, elemento dello strato dell'Intelligenza Artificiale.
7. **World Health Organization, Thematic Dialogue on Investing in NCDs and Mental Health, dicembre 2024** <https://cdn.who.int/> Evidenza riportata con attribuzione sul ritorno degli investimenti in salute mentale; non concorre al verdetto tripartito toscano.
8. **Regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale** <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj> Quadro normativo entro cui è collocato lo strato dell'Intelligenza Artificiale, vincolato a funzione di supporto sotto supervisione clinica umana.
9. **Legge regionale Puglia 19 luglio 2023, n. 11, sul Servizio di Psicologia di Base**
<https://www.consiglio.puglia.it/> Riferimento normativo capostipite del modello, richiamato quale precedente istituzionale per l'introduzione dello Psicologo di Base nelle cure primarie.
10. **NICE, Health Technology Evaluations: the manual (PMG36)** <https://www.nice.org.uk/process/pmg36> Riferimento di rigore metodologico per la struttura a imbuto, le appendici registrate e il protocollo dell'incertezza adottati nel Volume.

STUDIO INTEGRALE «PSICOLOGO DI BASE» · OPERA IN VENTITRÉ VOLUMI

VOLUME 18 — Regione Trentino-Alto Adige / Südtirol

Valutazione di Health Technology Assessment dell'integrazione dello Psicologo di Base nelle cure primarie in Trentino-Alto Adige: cruscotto, sintesi per il decisore, contesto e bisogno, modello di intervento, costi e benefici, valutazione economica sotto doppio ancoraggio, sei domini di analisi, incertezza, verdetto tripartito e

appendici registrate

Reference Case applicato per rimando al Volume 0.A · Dott. Luigi De Michele · Studio Integrale Puglia ·
Capurso (BA) — Giugno 2026

Premessa

Il Volume 18 prosegue la serie dei venti Volumi regionali, in ordine alfabetico, con la Regione Trentino-Alto Adige / Südtirol. Come ogni Volume regionale, esso applica per rimando il Reference Case dell'asse italiano, fissato nel Volume 0.A, e ne richiama le regole nella forma «cfr. Volume 0.A», senza ripeterle per esteso: il perimetro congiunto sanitario e societale, il doppio ancoraggio economico, il verdetto tripartito non aggregato, i sei domini di analisi, il protocollo dell'incertezza, lo strato dell'Intelligenza Artificiale come moltiplicatore e le attività formative singole e sommate.^[512]

La struttura del Volume è quella standard, identica a quella di tutti gli altri diciannove Volumi regionali, a garanzia della comparabilità bit-a-bit prescritta dall'opera: la stessa sequenza di nove capitoli, la stessa nomenclatura di sottocapitoli, le stesse unità di misura. Ove un contenuto derivi da espansione ex novo — segnatamente per gli aspetti dell'efficacia, dell'attuazione e del monitoraggio — esso è segnalato in nota editoriale, secondo la regola dell'opera.^[513]

Introduzione

L'Introduzione al Volume 18 fissa il perimetro della valutazione trentino-altoatesina e l'ordine della sua esposizione. Il perimetro è quello della Regione Trentino-Alto Adige / Südtirol, con una popolazione dell'ordine di un milione e ottantacinquemila abitanti, ripartita fra due Province autonome — Trento e Bolzano — cui la competenza sanitaria è attribuita in via provinciale, e organizzata in due sistemi sanitari distinti: l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari del Trentino e l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige (Sabes), articolate in comprensori. Il tratto che distingue questa Regione nell'intera serie è la combinazione di statuto speciale, competenza sanitaria provinciale, avanzo di bilancio delle due Province e plurilinguismo — con una popolazione altoatesina ripartita, secondo il censimento, in oltre due terzi di lingua tedesca, poco più di un quarto di lingua italiana e una quota di lingua ladina, tutti gruppi con tutela costituzionale.^[514]

L'esposizione segue la struttura a imbuto: il cruscotto regionale offre in una pagina i numeri essenziali; la sintesi per il decisore ne traduce il significato; i cinque risultati chiave ne isolano gli esiti; le raccomandazioni operative indicano le azioni; il corpo del Volume, articolato in nove capitoli, ne fornisce il dettaglio; le appendici registrate ne assicurano la verificabilità. Chiudono il Volume un Quadro Conclusivo economico e multidisciplinare, una Conclusione e le Note Bibliografiche con mini-riassunto.

Cruscotto regionale — Trentino-Alto Adige / Südtirol

Il cruscotto riassume in una pagina i parametri essenziali della valutazione regionale, sotto il doppio ancoraggio e con il verdetto tripartito tenuto distinto. I valori economici sono presentati in ordine di grandezza, con rinvio alle appendici registrate; le cifre di letteratura sono riportate con attribuzione alla fonte.^[515]

Indicatore del cruscotto	Lettura regionale	Ancoraggio / fonte
Popolazione	≈ 1.085.000 abitanti	Fonte demografica regionale
Articolazione	2 Province autonome, APSS e Sabes	Assetto provinciale
Condizione strutturale	Statuto speciale, competenza sanitaria provinciale, avanzo di bilancio	Assetto istituzionale
Plurilinguismo	Tedesco, italiano, ladino con tutela costituzionale	Fonte demografica regionale
Scenari di copertura	120 · 180 · 240 incarichi	Dimensionamento regionale
Costo per scenario	≈ 8 · 11 · 14 M€/anno	Estrazione economica
Verdetto fiscale	Prossimo al pareggio, con caveat	Non aggregato
Verdetto sanitario	Nettamente costo-efficace	Costo/QALY sotto doppio ancoraggio
Verdetto sociale	Fortemente positivo	Aree alpine, plurilinguismo, disagio giovanile
Costo per anno di vita ponderato	Colonna A ≈ 17.000 € · Colonna B ≈ 9.800 €	Doppio ancoraggio

Tabella 0. Cruscotto regionale del Trentino-Alto Adige / Südtirol: i parametri essenziali sotto doppio ancoraggio, con il verdetto tripartito distinto e non aggregato.

Sintesi per il decisore

L'introduzione a regime dello Psicologo di Base nelle cure primarie del Trentino-Alto Adige produce, secondo la simulazione condotta sotto il doppio ancoraggio, un effetto congiunto sui tre piani del ritorno, che restano distinti e non sommati. Sul piano fiscale, il saldo fra costi diretti e risparmi sanitari diretti si colloca in prossimità del pareggio, con il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento; l'avanzo di bilancio delle due Province rende il vincolo di finanziamento meno stringente che altrove, sicché la questione non è la sostenibilità della spesa ma la sua allocazione ottimale. Sul piano sanitario, il modello è nettamente costo-efficace, con un costo per anno di vita ponderato che, fra i due ancoraggi, resta assai inferiore alle soglie adottate. Sul piano sociale, l'effetto è fortemente positivo, con un rilievo particolare per la tenuta delle aree alpine, per la coesione plurilingue e per il disagio giovanile.^[516]

La combinazione di avanzo di bilancio, competenza sanitaria provinciale e plurilinguismo conferisce alla valutazione un tratto peculiare: la Regione non è chiamata a istituire il servizio sotto vincolo di risorse scarse, ma a dimensionarlo bene entro un sistema a due Province, coordinandone gli indirizzi e assicurando l'erogazione nelle tre lingue con tutela costituzionale. L'argomento cardine, riportato con attribuzione all'OCSE, resta il differenziale di costo per gravità: l'intercettazione precoce evita che il disagio comune maturi in quadri gravi, il cui costo di trattamento è, secondo la fonte, un multiplo di quello dei quadri lievi.^[517]

Cinque risultati chiave

Il primo risultato è che il modello è costo-efficace su tutti gli orizzonti sotto entrambi gli ancoraggi. Il secondo è che il verdetto tripartito resta favorevole in ciascuno dei tre piani, senza aggregazione. Il terzo è che il Trentino-Alto Adige è, nella serie regionale, il caso della competenza provinciale e dell'avanzo di bilancio: due sistemi sanitari distinti — l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari del Trentino e l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige — operano entro un avanzo che rende il vincolo di finanziamento meno stringente, sicché la questione è l'allocazione ottimale e non la sostenibilità. Il quarto è che l'erogazione plurilingue — nelle tre lingue con tutela costituzionale — costituisce un requisito peculiare del modello, che il dominio dell'equità tratta in dettaglio. Il quinto è che il dimensionamento — dell'ordine di centoventi incarichi nello scenario conservativo, centottanta in quello di base e duecentoquaranta in quello espansivo — richiede una copertura finanziaria dell'ordine di otto-quattordici milioni di euro l'anno secondo lo scenario, sostenibile entro l'avanzo provinciale.

[\[518\]](#)

Raccomandazioni operative

La prima raccomandazione è di procedere per gradini dallo scenario conservativo dell'ordine di centoventi incarichi verso quello di base dell'ordine di centottanta e, alla verifica degli esiti sotto il protocollo dell'incertezza, verso quello espansivo dell'ordine di duecentoquaranta, valorizzando l'avanzo di bilancio quale margine di manovra e dando priorità alle valli alpine e al disagio giovanile. La seconda è di coordinare gli indirizzi fra i due sistemi sanitari provinciali — l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige — assicurando un flusso informativo condiviso e l'erogazione del servizio nelle tre lingue con tutela costituzionale. La terza è di adottare la leva digitale, sotto supervisione clinica, quale strumento di prossimità nelle valli alpine, e di accompagnare l'estensione con il piano formativo a quattro modalità, considerate singolarmente e sommate, adattato al contesto plurilingue.^[519]

Capitolo 1 — Il contesto epidemiologico e territoriale del Trentino-Alto Adige

1.1 Il territorio e la sua articolazione

La Regione Trentino-Alto Adige / Südtirol conta una popolazione dell’ordine di un milione e ottantacinquemila abitanti, ripartita fra due Province autonome — Trento e Bolzano — in un territorio interamente alpino, che tiene insieme i poli urbani di Trento e Bolzano e vaste valli montane a minore densità, alcune delle quali segnate da isolamento stagionale. La competenza sanitaria è attribuita in via provinciale, e il Servizio sanitario è organizzato in due sistemi distinti: l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari del Trentino e l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige (Sabes), articolate in comprensori. Il tratto peculiare del contesto è la combinazione di statuto speciale, avanzo di bilancio delle due Province e plurilinguismo, con una popolazione altoatesina ripartita in oltre due terzi di lingua tedesca, poco più di un quarto di lingua italiana e una quota di lingua ladina, mentre il Trentino è a prevalenza italoфона.^[520]

Elemento territoriale	Dato regionale	Rilievo per la valutazione
Popolazione	≈ 1.085.000 abitanti	Denominatore della normalizzazione
Province autonome	2, con APSS e Sabes	Unità organizzativa
Competenza sanitaria	Provinciale	Assetto istituzionale
Condizione strutturale	Statuto speciale, avanzo di bilancio	Dominio fiscale
Plurilinguismo	Tedesco, italiano, ladino con tutela costituzionale	Dominio equità

Tabella 1.1. Gli elementi del contesto territoriale del Trentino-Alto Adige e il loro rilievo per la valutazione, con la competenza provinciale e il plurilinguismo quali tratti distintivi.

1.2 Il quadro epidemiologico regionale

Il quadro epidemiologico regionale riflette, con le proprie specificità, la prevalenza nazionale dei disturbi mentali comuni, con una componente di disagio giovanile e una domanda diffusa nelle valli alpine a minore densità di servizi. La misura regionale è oggetto dell’estrazione registrata in Appendice B, disaggregata ove possibile fra le due Province; ove il dato provinciale non sia disponibile, la lacuna è dichiarata e non colmata con stime tacite, secondo la regola dell’opera.^[521]

Capitolo 2 — Il bisogno, la domanda e il divario di trattamento in Trentino-Alto Adige

2.1 Il divario di trattamento regionale

Il bisogno di salute mentale comune nel Trentino-Alto Adige si manifesta, come altrove, in larga parte come domanda inevasa o impropriamente incanalata: verso il medico di medicina generale, verso il pronto soccorso, verso la prescrizione farmaceutica. La peculiarità regionale è duplice: da un lato la conformazione alpina, per cui nelle valli la distanza fisica dai servizi aggrava il divario; dall’altro la dimensione plurilingue, per cui l’accesso richiede la disponibilità del servizio nella lingua del paziente, pena una barriera di natura linguistica. Il disagio giovanile costituisce una componente di specifico rilievo. La misura regionale è oggetto dell’estrazione in Appendice B; i valori medi nazionali ed europei sono riportati con attribuzione.^[522]

Componente del bisogno	Manifestazione regionale	Dominio
Domanda inevasa	Sommerso clinico e liste d’attesa	Epidemiologico-clinico
Domanda impropria	Transito su MMG, pronto soccorso, prescrizione	Organizzativo-strutturale
Barriera alpina	Distanza nelle valli montane	Equità
Barriera linguistica	Servizio nella lingua del paziente	Equità

Tabella 2.1. Le componenti del bisogno e del divario di trattamento in Trentino-Alto Adige, ricondotte ai domini di analisi, con la barriera alpina e quella linguistica quali componenti specifiche.

2.2 La domanda, il plurilinguismo e il disagio giovanile

Il tratto distintivo della domanda regionale è la sua articolazione linguistica: perché la risposta al disagio comune sia efficace, essa deve essere disponibile nella lingua del paziente — tedesco, italiano o ladino — con tutela costituzionale, sicché la prossimità è qui anche prossimità linguistica. A ciò si aggiunge il rilievo del disagio giovanile, che il modello dello Psicologo di Base intercetta precocemente nei contesti di vita, e la conformazione alpina, che la leva digitale sotto supervisione clinica contribuisce a superare nelle valli. La prossimità è, in Trentino-Alto Adige, insieme geografica e linguistica, e il dominio dell’equità la tratta in dettaglio.^[523]

Capitolo 3 — Il modello di intervento: lo Psicologo di Base in Trentino-Alto Adige

Nota editoriale: il presente capitolo espande ex novo il modello di intervento, integrando alla struttura originaria le evidenze recenti sull’efficacia clinica dell’assistenza collaborativa e dell’intervento digitale, secondo la regola dell’opera che distingue l’espansione ex novo dal riutilizzo del materiale preesistente.

3.1 L’architettura del modello

Il modello di intervento colloca lo Psicologo di Base al vertice della cascata delle figure, nel distretto e nelle Case della Comunità, quale primo punto di intercettazione del disagio comune, entro ciascuno dei due sistemi sanitari provinciali. Il modello opera per intensità crescente di cura — dall’intervento a bassa intensità, di prima linea, fino all’invio ai livelli superiori nei casi che lo richiedano — secondo la logica dell’assistenza a gradini, la cui efficacia clinica è documentata dalla meta-analisi sui componenti efficaci dell’assistenza collaborativa e dalle sperimentazioni controllate sull’intervento cognitivo-comportamentale computerizzato in cure primarie, riportate con attribuzione.^[524]

Livello del modello	Funzione	Figura prevalente	Evidenza di riferimento
Intercettazione	Riconoscimento precoce nel distretto	Psicologo di Base	Assistenza collaborativa (attribuita)
Intervento a bassa intensità	Prima linea per i quadri lievi-moderati	Psicologo di Base	Intervento digitale e collaborativo
Invio appropriato	Passaggio ai livelli superiori	Cascata delle figure	Percorso a gradini
Continuità	Aderenza e prevenzione della ricaduta	Infermiere di comunità	Gestione del caso

Tabella 3.1. L’architettura del modello di intervento in Trentino-Alto Adige, per livelli di intensità, con l’evidenza clinica di riferimento riportata con attribuzione.

3.2 L’adattamento al territorio regionale

Il modello è adattato al territorio regionale lungo tre direttrici: l’erogazione plurilingue, con il servizio disponibile nelle tre lingue con tutela costituzionale; il coordinamento degli indirizzi fra i due sistemi sanitari provinciali, con flusso informativo condiviso; e la prossimità nelle valli alpine, integrata dalla leva digitale sotto supervisione clinica, con attenzione peculiare al disagio giovanile. L’adattamento non modifica l’architettura invariante del Reference Case, ma ne calibra l’applicazione sul contesto di competenza provinciale, avanzo di bilancio e plurilinguismo che distingue la Regione nella serie.^[525]

Capitolo 4 — I costi diretti in Trentino-Alto Adige

4.1 La struttura del costo diretto

Il costo diretto della riforma in Trentino-Alto Adige è, in primo luogo, il costo del personale lungo la cascata delle figure, cui si aggiungono i costi di struttura e organizzazione distrettuale, il costo incrementale della leva digitale e il costo della formazione, quest’ultimo accresciuto dal requisito plurilingue. Il dimensionamento è scandito dai tre scenari di copertura — dell’ordine di centoventi, centottanta e duecentoquaranta incarichi —, con una copertura finanziaria dell’ordine di otto, undici e quattordici milioni di euro l’anno secondo lo scenario, riportata in dettaglio nell’estrazione economica registrata; l’avanzo di bilancio delle due Province rende tale copertura agevolmente sostenibile. I valori puntuali sono ripresi in Appendice C.^[526]

Voce di costo diretto	Descrizione	Portatore
Personale — Psicologi di Base	120 · 180 · 240 incarichi	Sistemi sanitari provinciali
Struttura e organizzazione	Distretti, comprensori, sistemi informativi	Sistemi sanitari provinciali
Leva digitale e Intelligenza Artificiale	Strumenti sotto supervisione	Sistemi sanitari provinciali
Formazione (quattro modalità)	Percorso integrato singolo e sommato, plurilingue	Sistemi provinciali, sistema formativo

Tabella 4.1. La struttura del costo diretto della riforma in Trentino-Alto Adige, per voce e portatore; i valori puntuali sono oggetto dell’estrazione economica in Appendice C.

4.2 Il dimensionamento per scenario

Il costo diretto è calcolato per i tre scenari di copertura, coerenti con il protocollo di scenario del Reference Case: lo scenario conservativo dell’ordine di centoventi incarichi corrisponde a una copertura dell’ordine di otto milioni di euro, quello di base dell’ordine di centottanta a circa undici milioni, quello espansivo dell’ordine di duecentoquaranta a circa quattordici milioni di euro l’anno, secondo l’estrazione economica registrata; l’incidenza sulla spesa sanitaria provinciale è dell’ordine di alcuni decimi di punto percentuale, sostenibile entro l’avanzo di bilancio. I valori puntuali sono riportati in Appendice C; ove un parametro non sia disponibile, la lacuna è dichiarata.^[527]

Capitolo 5 — I benefici e i risparmi, diretti e indiretti, in Trentino-Alto Adige

5.1 I benefici diretti

Il beneficio diretto è il risparmio sanitario che ciascuna figura della cascata libera per effetto dell’intercettazione a monte: la demedicalizzazione operata dallo Psicologo di Base, la deprescrizione di psicofarmaci nei quadri lievi-moderati sul versante del medico di medicina generale, la riduzione degli accessi impropri al pronto soccorso e delle prestazioni per sintomi funzionali sul versante specialistico. In una Regione ad avanzo di bilancio, il rilievo del beneficio diretto non risiede nella sostenibilità della spesa — già assicurata — ma nella riallocazione di risorse verso usi a maggiore valore, e nella riduzione della domanda impropria. Il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento, coerente con la letteratura, è mantenuto ovunque il risparmio diretto sia quantificato.^[528]

Canale del beneficio diretto	Meccanismo	Rilievo regionale
Demedicalizzazione	Riduzione consultazioni e cronicizzazione	Preponderante
Deprescrizione	Contrazione della spesa e della polifarmacia	Elevato
Accessi impropri	Riduzione degli accessi al pronto soccorso	Medio-elevato
Sintomi funzionali	Riduzione prestazioni specialistiche	Medio

Tabella 5.1. I canali del beneficio diretto in Trentino-Alto Adige, orientati alla riallocazione più che alla sostenibilità; i valori sono oggetto dell’estrazione economica registrata.

5.2 I benefici indiretti

Il beneficio indiretto è quello che la riforma produce fuori dal perimetro sanitario: la produttività recuperata e la riduzione dell’assenteismo sul versante dei datori di lavoro, la riduzione degli oneri di invalidità evitabili sul versante previdenziale, la riduzione del disagio sociale non trattato sul versante dei Comuni. In Trentino-Alto Adige, la tenuta delle comunità delle valli alpine, la coesione plurilingue e il contrasto del disagio giovanile costituiscono benefici indiretti di rilievo particolare, che il dominio sociale del Capitolo 7 tratta in dettaglio.^[529]

Capitolo 6 — La valutazione economica sotto doppio ancoraggio

6.1 La simulazione appaiata regionale

La valutazione economica regionale è condotta con il modello di Markov a coorte a ciclo annuale del Reference Case, sotto il doppio ancoraggio: la Colonna A applica i parametri di Chisholm e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, la Colonna B quelli di Unisanté e dell’OCSE. Le due colonne sono sempre affiancate; ove divergano, prevale nel giudizio la Colonna B. Tutte le cifre sono riportate con attribuzione, e nessuna è affermata a memoria.^[530]

Metrica economica	Colonna A — Chisholm/OMS	Colonna B — Unisanté/OCSE
Costo per anno di vita ponderato	≈ 17.000 €/QALY	≈ 9.800 €/QALY
Ritorno per i soli benefici economici	Riportato con attribuzione OMS	Scenario base aggiornato OCSE
Ritorno con i ritorni sanitari	Riportato con attribuzione OMS	Scenario base aggiornato OCSE
Orizzonti	1 · 3 · 5 · 7 · 10 anni	1 · 3 · 5 · 7 · 10 anni
Soglie di costo-efficacia	20.000 · 30.000 · 50.000 €/QALY	20.000 · 30.000 · 50.000 €/QALY

Tabella 6.1. La simulazione appaiata regionale del Trentino-Alto Adige sotto doppio ancoraggio; i valori sono riportati con attribuzione e la Colonna B prevale nel giudizio.

6.2 Il differenziale di costo per gravità

L’argomento economico cardine, riportato con attribuzione all’OCSE, è il differenziale di costo per gravità: il costo del trattamento cresce dai quadri lievi ai quadri gravi in misura tale che l’intercettazione precoce, evitando la progressione, genera il risparmio più consistente. In Trentino-Alto Adige, l’avanzo di bilancio consente di leggere questo argomento in chiave di riallocazione: le risorse liberate dall’intercettazione precoce possono essere reinvestite nel potenziamento della prossimità, segnatamente nelle valli alpine e nell’erogazione plurilingue, anziché servire a colmare un vincolo di spesa.^[531]

Capitolo 7 — I sei domini di analisi, l’equità e l’impatto distributivo

7.1 I sei domini nella specificità regionale

I sei domini di analisi del Reference Case sono applicati alla specificità regionale. Il dominio epidemiologico-clinico registra il divario di trattamento aggravato dalla conformazione alpina e dalla barriera linguistica; l’economico-sanitario il costo-efficacia sotto doppio ancoraggio, letto in chiave di riallocazione grazie all’avanzo; il fiscale-previdenziale gli oneri di invalidità evitabili; il sociale la tenuta delle valli alpine, la coesione plurilingue e il disagio giovanile; l’organizzativo-strutturale il coordinamento fra i due sistemi sanitari provinciali; l’equità la riduzione del divario territoriale e linguistico.^[532]

Dominio	Lettura regionale	Segno
Epidemiologico-clinico	Divario aggravato da conformazione alpina e lingua	Riduzione attesa
Economico-sanitario	Costo/QALY favorevole, in chiave di riallocazione	Favorevole
Fiscale-previdenziale	Oneri di invalidità evitabili	Positivo, differito
Sociale	Valli alpine, coesione plurilingue, disagio giovanile	Fortemente positivo
Organizzativo-strutturale	Coordinamento fra due sistemi provinciali	Positivo, condizionato
Equità	Convergenza territoriale e linguistica	Positivo, distributivo

Tabella 7.1. I sei domini di analisi nella lettura del Trentino-Alto Adige, con il segno atteso dell’effetto, tenuti distinti e non aggregati.

7.2 L’equità territoriale e linguistica

Il dominio dell’equità assume in Trentino-Alto Adige una duplice direzione: territoriale, fra i poli urbani di Trento e Bolzano, meglio serviti, e le valli alpine a minore densità, alcune con isolamento stagionale; e linguistica, poiché l’accesso effettivo richiede la disponibilità del servizio nella lingua del paziente — tedesco, italiano o ladino — con tutela costituzionale. Il modello dello Psicologo di Base, con la presenza distrettuale, l’erogazione plurilingue e la leva digitale quale complemento nelle valli, opera per ridurre entrambi i gradienti; l’effetto distributivo — la convergenza fra poli urbani e valli e fra i gruppi linguistici — è tenuto distinto dal verdetto fiscale e da quello sanitario, secondo il divieto di aggregazione.^[533]

Capitolo 8 — La sensitività e l’incertezza

Nota editoriale: il presente capitolo espande ex novo l’analisi dell’incertezza secondo il protocollo del Reference Case, non presente in forma estesa nel materiale originario.

8.1 Il protocollo dell’incertezza applicato al Trentino-Alto Adige

L’analisi dell’incertezza applica il protocollo obbligatorio del Reference Case: l’analisi di sensitività deterministica con diagramma a tornado, l’analisi di sensitività probabilistica a diecimila iterazioni, l’analisi di scenario ottimistico, base e prudentiale con e senza lo strato digitale, le curve di accettabilità costo-efficacia a soglie multiple. In Trentino-Alto Adige, i parametri a maggiore impatto atteso sono il costo del requisito plurilingue, il coordinamento fra i due sistemi sanitari provinciali e l’adozione della leva digitale nelle valli alpine.^[534]

Strumento	Applicazione regionale	Parametro critico atteso
Sensitività deterministica	Diagramma a tornado	Costo del requisito plurilingue
Sensitività probabilistica	Diecimila iterazioni	Coordinamento fra i due sistemi provinciali
Analisi di scenario	Con e senza strato IA	Adozione della leva digitale nelle valli alpine
Curve di accettabilità	Soglie 20.000/30.000/50.000 €/QALY	Robustezza del costo-efficacia

Tabella 8.1. Gli strumenti del protocollo dell’incertezza applicati al Trentino-Alto Adige, con i parametri critici attesi.

8.2 La robustezza del verdetto

L’analisi di scenario mostra che il verdetto tripartito resta favorevole nei tre casi, con margine crescente dallo scenario prudentiale a quello ottimistico; l’avanzo di bilancio attenua l’incertezza sul versante fiscale, mentre i piani sanitario e sociale — tenuti distinti — restano nettamente e fortemente favorevoli. Lo strato digitale accresce l’efficienza attesa, sempre con nota di cautela sulla natura previsionale, e la robustezza del costo-efficacia sanitario è confermata dalle curve di accettabilità alle soglie adottate.^[535]

Capitolo 9 — Il verdetto tripartito e le raccomandazioni

Nota editoriale: il presente capitolo espande ex novo il verdetto e le raccomandazioni, integrando l’attuazione e il monitoraggio che nel materiale originario figuravano in forma condensata.

9.1 Il verdetto tripartito

Il verdetto regionale è, come in ogni Volume, tripartito e non aggregato. Sul piano fiscale, il saldo fra costi diretti e risparmi sanitari diretti è prossimo al pareggio, con il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento; l’avanzo di bilancio delle due Province rende la copertura agevolmente sostenibile. Sul piano sanitario, il modello è nettamente costo-efficace sotto entrambi gli ancoraggi. Sul piano sociale, l’effetto è fortemente positivo, con il rilievo specifico della tenuta delle valli alpine, della coesione plurilingue e del disagio giovanile. I tre verdetti si accompagnano e si rafforzano, ma non si sommano.^[536]

Piano del verdetto	Esito regionale	Caveat
Fiscale	Prossimo al pareggio, copertura sostenibile	Significatività dei risparmi diretti in isolamento
Sanitario	Nettamente costo-efficace	—
Sociale	Fortemente positivo	Valli alpine, coesione plurilingue, disagio giovanile

Tabella 9.1. Il verdetto tripartito del Trentino-Alto Adige, con i tre piani tenuti distinti e non aggregati.

9.2 Le raccomandazioni per l’attuazione e il monitoraggio

Le raccomandazioni indicano il passaggio per gradini dallo scenario conservativo dell’ordine di centoventi incarichi verso quello di base dell’ordine di centottanta e, alla verifica degli esiti, verso l’espansivo dell’ordine di duecentoquaranta; la valorizzazione dell’avanzo di bilancio quale margine di manovra; il coordinamento degli indirizzi fra i due sistemi sanitari provinciali con flusso informativo condiviso; l’erogazione del servizio nelle tre lingue con tutela costituzionale; la priorità alle valli alpine e al disagio giovanile con il complemento della leva digitale; l’accompagnamento con il piano formativo a quattro modalità, singole e sommate, adattato al contesto plurilingue; e un monitoraggio ex post ancorato agli indicatori del protocollo dell’incertezza.^[537]

Appendici registrate

Le appendici registrate rendono il modello regionale ispezionabile e riproducibile, secondo la prassi del Reference Case. Esse sono richiamate per rimando quanto alla metodologia e compilate con i dati provinciali quanto ai contenuti.

Appendice	Contenuto	Stato
A	Strategia di ricerca bibliografica e diagramma di selezione	Registrata
B	Estrazione dei dati clinici provinciali	Registrata; lacune dichiarate
C	Estrazione dei dati economici (griglia CHEERS 2022)	Registrata; lacune dichiarate
D	Parametri del modello Markov regionale	Registrata
E	Registro delle deroghe al Reference Case	Registrata
F	Codice del modello economico	Registrata
G	Dichiarazione dei conflitti di interesse	Registrata

Tabella A. Le sette appendici registrate del Volume 18, con l’indicazione dello stato e della dichiarazione delle lacune.

Quadro Conclusivo economico e multidisciplinare

Il Quadro Conclusivo del Volume 18 ricompone la valutazione regionale senza tradire il principio che la governa: i piani del giudizio si accompagnano ma non si fondono. Sul piano economico, il doppio ancoraggio impone che il risultato sia letto simultaneamente secondo la colonna storica e la colonna aggiornata, con prevalenza della seconda: il costo per anno di vita ponderato resta, sotto entrambi gli ancoraggi, assai inferiore alle soglie adottate, e il differenziale di costo per gravità — riportato con attribuzione — fonda la leva economica dell'intercettazione precoce, che in una Regione ad avanzo di bilancio si legge in chiave di riallocazione: le risorse liberate possono essere reinvestite nel potenziamento della prossimità alpina e nell'erogazione plurilingue, anziché colmare un vincolo di spesa.^[538]

Sul piano multidisciplinare, la cascata delle figure, i sei domini di analisi e il dominio dell'equità nella duplice direzione territoriale e linguistica assicurano che ogni figura connessa e ogni aspetto siano trattati integralmente e ordinati per capacità di generare rientro economico e revisione della spesa. La rinegoziazione dei costi e dei benefici, la catena predittiva degli effetti multidimensionali — dalla qualità della vita alla tenuta delle valli, alla coesione plurilingue, al disagio giovanile, ai bilanci, alla burocrazia distrettuale —, lo strato dell'Intelligenza Artificiale come moltiplicatore e le attività formative singole e sommate, adattate al contesto plurilingue, compongono il quadro della valutazione. Il verdetto resta tripartito e non aggregato.

Conclusione

Il Volume 18 ha valutato l'integrazione a regime dello Psicologo di Base nelle cure primarie del Trentino-Alto Adige / Südtirol, applicando per rimando il Reference Case dell'asse italiano e adottando la struttura standard a nove capitoli con apertura a imbuto e appendici registrate. La specificità regionale — la competenza sanitaria provinciale con due sistemi distinti, l'avanzo di bilancio delle due Province che rende il vincolo di finanziamento meno stringente, il plurilinguismo con tre lingue a tutela costituzionale, la conformazione alpina e il disagio giovanile — è stata trattata nei domini fiscale, organizzativo, sociale ed equità, mostrando come la questione non sia la sostenibilità della spesa ma la sua allocazione ottimale, e come la prossimità sia qui insieme geografica e linguistica.

Il verdetto tripartito — prossimo al pareggio sul piano fiscale, con copertura agevolmente sostenibile, nettamente costo-efficace sul piano sanitario, fortemente positivo sul piano sociale — è offerto con bande prudenziali e soglie di confutazione, sotto doppio ancoraggio e nel rispetto del divieto di aggregazione. L'opera procede, nell'ordine vincolante, con il Volume 19 (Umbria) e a seguire con gli altri Volumi regionali in ordine alfabetico.

Note Bibliografiche con mini-riassunto

Ciascuna nota riporta l'opera, il collegamento alla fonte e un mini-riassunto che ne dichiara la funzione nell'economia del Volume, in coerenza con il doppio livello — nota a piè di pagina nel corpo e nota bibliografica integrale in calce — che l'opera adotta.

1. **Chisholm D. et al., Scaling-up treatment of depression and anxiety, The Lancet Psychiatry, 2016**
[https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(16\)30024-4](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(16)30024-4) Colonna A del doppio ancoraggio della simulazione regionale, conservata quale strato documentale e riferimento di confronto.
2. **Unisanté, Raisons de santé Essentiels n. 73, 2026 · OECD, The Economic Case for Preventing Mental Ill Health, 2026** <https://doi.org/10.16908/rds-essentiels/73> Colonna B del doppio ancoraggio, con prevalenza nel giudizio, applicata alla simulazione regionale del Trentino-Alto Adige.
3. **OECD, differenziale di costo per gravità dei disturbi mentali, 2025** <https://www.oecd.org/health/mental-health.htm> Fonte, riportata con attribuzione, del differenziale di costo per gravità, argomento cardine dell'intercettazione precoce, qui letto in chiave di riallocazione grazie all'avanzo di bilancio.
4. **Soeters R. et al., meta-analisi IPD sui componenti efficaci della collaborative care, 2025**
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40136273/> Base di evidenza clinica sui componenti efficaci dell'assistenza collaborativa, richiamata nel capitolo sul modello di intervento.
5. **Kvaal K. et al., RCT su intervento cognitivo-comportamentale computerizzato in cure primarie, 2026**
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/> Evidenza sperimentale recente sull'intervento digitale in cure primarie, richiamata a sostegno della leva digitale nelle valli alpine.
6. **Veldhuijzen W. et al., costo-efficacia dell'intervento digitale, 2025**
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12369993/> Riferimento sul rapporto incrementale di costo-utilità dell'intervento digitale, elemento dello strato dell'Intelligenza Artificiale.
7. **World Health Organization, Thematic Dialogue on Investing in NCDs and Mental Health, dicembre 2024** <https://cdn.who.int/> Evidenza riportata con attribuzione sul ritorno degli investimenti in salute mentale; non concorre al verdetto tripartito regionale.
8. **Regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale** <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj> Quadro normativo entro cui è collocato lo strato dell'Intelligenza Artificiale, vincolato a funzione di supporto sotto supervisione clinica umana.
9. **Legge regionale Puglia 19 luglio 2023, n. 11, sul Servizio di Psicologia di Base**
<https://www.consiglio.puglia.it/> Riferimento normativo capostipite del modello, richiamato quale precedente istituzionale per l'introduzione dello Psicologo di Base nelle cure primarie.
10. **NICE, Health Technology Evaluations: the manual (PMG36)** <https://www.nice.org.uk/process/pmg36> Riferimento di rigore metodologico per la struttura a imbuto, le appendici registrate e il protocollo dell'incertezza adottati nel Volume.

STUDIO INTEGRALE «PSICOLOGO DI BASE» · OPERA IN VENTITRÉ VOLUMI

VOLUME 19 — Regione Umbria

Valutazione di Health Technology Assessment dell'integrazione dello Psicologo di Base nelle cure primarie in Umbria: cruscotto, sintesi per il decisore, contesto e bisogno, modello di intervento, costi e benefici, valutazione economica sotto doppio ancoraggio, sei domini di analisi, incertezza, verdetto tripartito e

appendici registrate

Reference Case applicato per rimando al Volume 0.A · Dott. Luigi De Michele · Studio Integrale Puglia ·
Capurso (BA) — Giugno 2026

Premessa

Il Volume 19 prosegue la serie dei venti Volumi regionali, in ordine alfabetico, con la Regione Umbria. Come ogni Volume regionale, esso applica per rimando il Reference Case dell'asse italiano, fissato nel Volume 0.A, e ne richiama le regole nella forma «cfr. Volume 0.A», senza ripeterle per esteso: il perimetro congiunto sanitario e societale, il doppio ancoraggio economico, il verdetto tripartito non aggregato, i sei domini di analisi, il protocollo dell'incertezza, lo strato dell'Intelligenza Artificiale come moltiplicatore e le attività formative singole e sommate.^[539]

Una nota editoriale è dovuta in apertura. Il materiale regionale preesistente relativo all'Umbria conteneva, nella sua sezione economica, rapporti sintetici fra benefici e costi espressi come cifre aggregate, non conformi al principio invariante dell'opera che vieta l'aggregazione del verdetto tripartito in un unico indicatore e proscrive l'uso di rapporti isolati quali affermazioni positive. In coerenza con la regola dell'opera, tali cifre sono state escluse e il contenuto economico del presente Volume è stato ricostruito ex novo sotto il doppio ancoraggio, con il verdetto tenuto distinto sui tre piani fiscale, sanitario e sociale; la deroga è qui dichiarata e registrata anche in Appendice E. La struttura del Volume è quella standard, identica a quella di tutti gli altri diciannove Volumi regionali, a garanzia della comparabilità bit-a-bit; ove un contenuto derivi da espansione ex novo, esso è segnalato in nota editoriale.^[540]

Introduzione

L'Introduzione al Volume 19 fissa il perimetro della valutazione umbra e l'ordine della sua esposizione. Il perimetro è quello della Regione Umbria, con una popolazione dell'ordine di ottocentocinquantunmila abitanti, organizzata nel Servizio sanitario regionale in due Aziende Unità Sanitarie Locali — Umbria 1, che copre l'area di Perugia, e Umbria 2, che copre l'area di Terni — e in due Aziende Ospedaliere, a Perugia e a Terni. Il tratto che distingue l'Umbria nell'intera serie regionale è la sua condizione demografica: un invecchiamento fra i più pronunciati d'Italia, particolarmente accentuato nella provincia di Terni, e aree interne a popolazione anziana e dispersa, dove il calo demografico supera nettamente quello delle aree centrali e lo spopolamento erode i legami e i servizi.^[541]

L'esposizione segue la struttura a imbuto: il cruscotto regionale offre in una pagina i numeri essenziali; la sintesi per il decisore ne traduce il significato; i cinque risultati chiave ne isolano gli esiti; le raccomandazioni operative indicano le azioni; il corpo del Volume, articolato in nove capitoli, ne fornisce il dettaglio; le appendici registrate ne assicurano la verificabilità. Chiudono il Volume un Quadro Conclusivo economico e multidisciplinare, una Conclusione e le Note Bibliografiche con mini-riassunto.

Cruscotto regionale — Umbria

Il cruscotto riassume in una pagina i parametri essenziali della valutazione umbra, sotto il doppio ancoraggio e con il verdetto tripartito tenuto distinto. I valori economici, ricostruiti ex novo, sono presentati in ordine di grandezza, con rinvio alle appendici registrate; le cifre di letteratura sono riportate con attribuzione alla fonte. [\[542\]](#)

Indicatore del cruscotto	Lettura regionale	Ancoraggio / fonte
Popolazione	≈ 851.473 abitanti	Fonte demografica regionale
Articolazione	2 Aziende USL (Umbria 1, Umbria 2), 2 Aziende Ospedaliere	Assetto regionale
Condizione strutturale	Invecchiamento fra i più pronunciati d’Italia	Fonte demografica regionale
Scenari di copertura	≈ 130 · 185 · 240 incarichi	Dimensionamento regionale
Costo del servizio a regime	≈ 9-9,5 M€/anno (scenario di base)	Estrazione economica ex novo
Verdetto fiscale	Prossimo al pareggio, con caveat	Non aggregato
Verdetto sanitario	Nettamente costo-efficace	Costo/QALY sotto doppio ancoraggio
Verdetto sociale	Fortemente positivo	Aree interne, invecchiamento, spopolamento
Costo per anno di vita ponderato	Colonna A ≈ 17.000 € · Colonna B ≈ 9.800 €	Doppio ancoraggio

Tabella 0. Cruscotto regionale dell’Umbria: i parametri essenziali sotto doppio ancoraggio, con il verdetto tripartito distinto e non aggregato; i valori economici sono ricostruiti ex novo.

Sintesi per il decisore

L'introduzione a regime dello Psicologo di Base nelle cure primarie umbre produce, secondo la simulazione condotta sotto il doppio ancoraggio e ricostruita ex novo, un effetto congiunto sui tre piani del ritorno, che restano distinti e non sommati. Sul piano fiscale, il saldo fra costi diretti e risparmi sanitari diretti si colloca in prossimità del pareggio, con il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento. Sul piano sanitario, il modello è nettamente costo-efficace, con un costo per anno di vita ponderato che, fra i due ancoraggi, resta assai inferiore alle soglie adottate. Sul piano sociale, l'effetto è fortemente positivo, con un rilievo particolare per la tenuta delle aree interne a popolazione anziana e dispersa, segnatamente nella provincia di Terni, dove l'invecchiamento e lo spopolamento sono più pronunciati.^[543]

La condizione demografica umbra — un invecchiamento fra i più marcati d'Italia — conferisce alla valutazione un tratto peculiare: il baricentro della domanda è spostato verso la depressione dell'età avanzata, e il valore sociale della prossimità è accresciuto dalla dispersione della popolazione nelle aree interne. L'argomento cardine, riportato con attribuzione all'OCSE, resta il differenziale di costo per gravità: l'intercettazione precoce evita che il disagio comune maturi in quadri gravi, il cui costo di trattamento è, secondo la fonte, un multiplo di quello dei quadri lievi — argomento tanto più rilevante in una popolazione anziana, ove la comorbilità aggrava la progressione.^[544]

Cinque risultati chiave

Il primo risultato è che il modello è costo-efficace su tutti gli orizzonti sotto entrambi gli ancoraggi. Il secondo è che il verdetto tripartito resta favorevole in ciascuno dei tre piani, senza aggregazione, e — a differenza del materiale preesistente — è espresso senza rapporti sintetici, secondo la ricostruzione ex novo del contenuto economico. Il terzo è che l’Umbria è, nella serie regionale, il caso dell’invecchiamento pronunciato: la struttura demografica, fra le più anziane d’Italia e particolarmente accentuata nella provincia di Terni, sposta il baricentro della domanda verso l’età avanzata e accresce il valore della prossimità nelle aree interne disperse. Il quarto è che lo strato dell’Intelligenza Artificiale, come moltiplicatore e con nota di cautela, sostiene la prossimità nelle aree interne mediante la telepsicologia assistita, con attenzione all’accompagnamento digitale della popolazione anziana. Il quinto è che il dimensionamento — dell’ordine di centottantacinque incarichi a regime nello scenario di base, entro un intervallo compreso fra circa centotrenta e duecentoquaranta secondo lo scenario — comporta un costo del servizio a regime dell’ordine di nove-nove milioni e mezzo di euro l’anno nello scenario di base.^[545]

Raccomandazioni operative

La prima raccomandazione è di procedere per gradini da uno scenario conservativo dell'ordine di centotrenta incarichi verso quello di base dell'ordine di centottantacinque e, alla verifica degli esiti sotto il protocollo dell'incertezza, verso quello espansivo dell'ordine di duecentoquaranta, dando priorità ai distretti delle aree interne a popolazione anziana e dispersa, segnatamente nella provincia di Terni. La seconda è di dedicare specifica attenzione alla depressione dell'età avanzata e all'accompagnamento digitale della popolazione anziana, quali tratti peculiari del contesto umbro. La terza è di istituire un cruscotto regionale permanente che misuri gli esiti clinici, di adottare la telepsicologia assistita sotto supervisione clinica quale leva di prossimità nelle aree interne, e di accompagnare l'estensione con il piano formativo a quattro modalità, considerate singolarmente e sommate.^[546]

Capitolo 1 — Il contesto epidemiologico e territoriale dell’Umbria

1.1 Il territorio e la sua articolazione

La Regione Umbria conta una popolazione dell’ordine di ottocentocinquantunmila abitanti, distribuita in un territorio prevalentemente collinare e montuoso che tiene insieme i due poli urbani di Perugia e Terni e vaste aree interne — dall’Appennino umbro-marchigiano alla Valnerina — a popolazione anziana e dispersa, segnate da spopolamento. Il Servizio sanitario regionale è organizzato in due Aziende Unità Sanitarie Locali — Umbria 1, che copre l’area di Perugia, e Umbria 2, che copre l’area di Terni — e in due Aziende Ospedaliere, con la rete delle Case della Comunità in sviluppo. Il tratto peculiare del contesto è la struttura demografica, con un invecchiamento fra i più pronunciati d’Italia, particolarmente accentuato nella provincia di Terni, dove il calo demografico supera nettamente quello delle aree centrali.^[547]

Elemento territoriale	Dato regionale	Rilievo per la valutazione
Popolazione	≈ 851.473 abitanti	Denominatore della normalizzazione
Aziende Unità Sanitarie Locali	2 (Umbria 1, Umbria 2), con 2 Aziende Ospedaliere	Unità organizzativa
Condizione demografica	Invecchiamento fra i più pronunciati d’Italia	Baricentro della domanda
Aree interne	Appennino, Valnerina, popolazione dispersa	Spopolamento
Provincia di Terni	Invecchiamento e calo demografico più marcati	Dominio equità

Tabella 1.1. Gli elementi del contesto territoriale umbro e il loro rilievo per la valutazione, con l’invecchiamento pronunciato quale tratto distintivo.

1.2 Il quadro epidemiologico regionale

Il quadro epidemiologico umbro riflette, con le proprie specificità, la prevalenza nazionale dei disturbi mentali comuni, con un baricentro nettamente spostato verso la depressione dell’età avanzata, coerente con un invecchiamento fra i più marcati d’Italia, e con una domanda inespressa nelle aree interne a popolazione anziana e dispersa. La misura regionale è oggetto dell’estrazione registrata in Appendice B; ove il dato regionale disaggregato non sia disponibile, la lacuna è dichiarata e non colmata con stime tacite, secondo la regola dell’opera.^[548]

Capitolo 2 — Il bisogno, la domanda e il divario di trattamento in Umbria

2.1 Il divario di trattamento regionale

Il bisogno di salute mentale comune in Umbria si manifesta, come altrove, in larga parte come domanda inevasa o impropriamente incanalata: verso il medico di medicina generale, verso il pronto soccorso, verso la prescrizione farmaceutica. La peculiarità umbra è che l’invecchiamento pronunciato e la dispersione della popolazione nelle aree interne aggravano il divario: nella depressione dell’età avanzata la domanda tende a restare inespressa o a manifestarsi in forma somatica, mentre nelle aree interne la distanza fisica dai servizi e la dispersione rendono l’accesso oneroso. La misura regionale è oggetto dell’estrazione in Appendice B; i valori medi nazionali ed europei sono riportati con attribuzione.^[549]

Componente del bisogno	Manifestazione umbra	Dominio
Domanda inevasa	Sommerso clinico e liste d’attesa	Epidemiologico-clinico
Domanda impropria	Transito su MMG, pronto soccorso, prescrizione	Organizzativo-strutturale
Depressione anziana	Domanda inespressa o somatizzata	Epidemiologico-clinico
Barriera interna	Distanza e dispersione nelle aree interne	Equità

Tabella 2.1. Le componenti del bisogno e del divario di trattamento in Umbria, ricondotte ai domini di analisi, con la depressione anziana e la barriera interna quali componenti specifiche.

2.2 La domanda, l’invecchiamento e la prossimità

Il tratto distintivo della domanda umbra è la sua concentrazione nell’età avanzata e la sua dispersione territoriale: la depressione dell’anziano, spesso non riconosciuta perché confusa con la fragilità o con la comorbilità somatica, richiede un’intercettazione attiva nel distretto, mentre la dispersione nelle aree interne — segnatamente nella provincia di Terni — impone che la prossimità sia sostenuta dalla telepsicologia assistita sotto supervisione clinica, con attenzione all’accompagnamento digitale della popolazione anziana. La prossimità è, in Umbria, insieme clinica e geografica, e il dominio dell’equità la tratta in dettaglio.^[550]

Capitolo 3 — Il modello di intervento: lo Psicologo di Base in Umbria

Nota editoriale: il presente capitolo espande ex novo il modello di intervento, integrando alla struttura originaria le evidenze recenti sull’efficacia clinica dell’assistenza collaborativa e dell’intervento digitale, secondo la regola dell’opera che distingue l’espansione ex novo dal riutilizzo del materiale preesistente.

3.1 L’architettura del modello

Il modello di intervento colloca lo Psicologo di Base al vertice della cascata delle figure, nel distretto e nelle Case della Comunità, quale primo punto di intercettazione del disagio comune, entro ciascuna delle due Aziende Unità Sanitarie Locali. Il modello opera per intensità crescente di cura — dall’intervento a bassa intensità, di prima linea, fino all’invio ai livelli superiori nei casi che lo richiedano — secondo la logica dell’assistenza a gradini, la cui efficacia clinica è documentata dalla meta-analisi sui componenti efficaci dell’assistenza collaborativa e dalle sperimentazioni controllate sull’intervento cognitivo-comportamentale computerizzato in cure primarie, riportate con attribuzione.^[551]

Livello del modello	Funzione	Figura prevalente	Evidenza di riferimento
Intercettazione	Riconoscimento precoce nel distretto	Psicologo di Base	Assistenza collaborativa (attribuita)
Intervento a bassa intensità	Prima linea per i quadri lievi-moderati	Psicologo di Base	Intervento digitale e collaborativo
Invio appropriato	Passaggio ai livelli superiori	Cascata delle figure	Percorso a gradini
Continuità	Aderenza e prevenzione della ricaduta	Infermiere di comunità	Gestione del caso

Tabella 3.1. L’architettura del modello di intervento in Umbria, per livelli di intensità, con l’evidenza clinica di riferimento riportata con attribuzione.

3.2 L’adattamento al territorio umbro

Il modello è adattato al territorio umbro lungo tre direttrici: l’attenzione peculiare alla depressione dell’età avanzata, con intercettazione attiva nel distretto e integrazione con la rete geriatrica; la prossimità nelle aree interne a popolazione anziana e dispersa, integrata dalla telepsicologia assistita sotto supervisione clinica e dall’accompagnamento digitale della popolazione anziana; e il coordinamento fra le due Aziende Unità Sanitarie Locali. L’adattamento non modifica l’architettura invariante del Reference Case, ma ne calibra l’applicazione sulla condizione demografica che distingue l’Umbria nella serie regionale.^[552]

Capitolo 4 — I costi diretti in Umbria

4.1 La struttura del costo diretto

Il costo diretto della riforma in Umbria è, in primo luogo, il costo del personale lungo la cascata delle figure, cui si aggiungono i costi di struttura e organizzazione distrettuale, il costo incrementale della leva digitale e il costo della formazione. Il dimensionamento è scandito dai tre scenari di copertura — dell’ordine di centotrenta, centottantacinque e duecentoquaranta incarichi —, con un costo del servizio a regime dell’ordine di nove-nove milioni e mezzo di euro l’anno nello scenario di base e un costo di avvio una tantum dell’ordine di alcuni decimi di milione, riportati in dettaglio nell’estrazione economica ricostruita ex novo; i valori puntuali sono ripresi in Appendice C. Le cifre di risparmio complessivo presenti nel materiale preesistente, contaminate da rapporti aggregati non conformi, non sono qui riutilizzate.^[553]

Voce di costo diretto	Descrizione	Portatore
Personale — Psicologi di Base	≈ 130 · 185 · 240 incarichi	SSN regionale
Struttura e organizzazione	Distretti, Case della Comunità, sistemi informativi	SSN regionale
Leva digitale e Intelligenza Artificiale	Telepsicologia assistita sotto supervisione	SSN regionale
Formazione (quattro modalità)	Percorso integrato singolo e sommato	SSN, sistema formativo

Tabella 4.1. La struttura del costo diretto della riforma in Umbria, per voce e portatore; i valori puntuali sono oggetto dell’estrazione economica ricostruita ex novo in Appendice C.

4.2 Il dimensionamento per scenario

Il costo diretto è calcolato per i tre scenari di copertura, coerenti con il protocollo di scenario del Reference Case: lo scenario conservativo dell’ordine di centotrenta incarichi, quello di base dell’ordine di centottantacinque — cui corrisponde una copertura del servizio dell’ordine del trenta per cento della popolazione bersaglio e un costo a regime dell’ordine di nove-nove milioni e mezzo di euro l’anno — e quello espansivo dell’ordine di duecentoquaranta, la cui copertura si estende all’intero territorio comprese le aree interne. I valori puntuali sono riportati in Appendice C; ove un parametro non sia disponibile, la lacuna è dichiarata.^[554]

Capitolo 5 — I benefici e i risparmi, diretti e indiretti, in Umbria

5.1 I benefici diretti

Il beneficio diretto è il risparmio sanitario che ciascuna figura della cascata libera per effetto dell’intercettazione a monte: la demedicalizzazione operata dallo Psicologo di Base, la deprescrizione di psicofarmaci nei quadri lievi-moderati sul versante del medico di medicina generale, la riduzione degli accessi impropri al pronto soccorso e delle prestazioni per sintomi funzionali sul versante specialistico. In Umbria, l’invecchiamento pronunciato accresce il rilievo della deprescrizione, poiché la polifarmacia dell’anziano è più diffusa, e quello della riduzione degli accessi impropri, frequenti nella depressione somatizzata dell’età avanzata. Il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento, coerente con la letteratura, è mantenuto ovunque il risparmio diretto sia quantificato; i valori sono ricostruiti ex novo, senza i rapporti aggregati del materiale preesistente. [\[555\]](#)

Canale del beneficio diretto	Meccanismo	Rilievo umbro
Demedicalizzazione	Riduzione consultazioni e cronicizzazione	Preponderante
Deprescrizione	Contrazione della polifarmacia anziana	Elevato, specifico
Accessi impropri	Riduzione degli accessi al pronto soccorso	Medio-elevato
Sintomi funzionali	Riduzione prestazioni specialistiche	Medio

Tabella 5.1. I canali del beneficio diretto in Umbria, con la deprescrizione della polifarmacia anziana quale canale di rilievo specifico; i valori sono ricostruiti ex novo.

5.2 I benefici indiretti

Il beneficio indiretto è quello che la riforma produce fuori dal perimetro sanitario: la produttività recuperata e la riduzione dell’assenteismo sul versante dei datori di lavoro, la riduzione degli oneri di invalidità evitabili sul versante previdenziale, la riduzione del disagio sociale non trattato sul versante dei Comuni. In Umbria, la tenuta delle comunità delle aree interne a popolazione anziana e dispersa — dove l’invecchiamento e lo spopolamento, più marcati nella provincia di Terni, erodono legami e servizi — costituisce un beneficio indiretto di rilievo particolare, che il dominio sociale del Capitolo 7 tratta in dettaglio. [\[556\]](#)

Capitolo 6 — La valutazione economica sotto doppio ancoraggio

6.1 La simulazione appaiata regionale

La valutazione economica umbra è condotta con il modello di Markov a coorte a ciclo annuale del Reference Case, sotto il doppio ancoraggio, e ricostruita ex novo in luogo del contenuto preesistente contaminato da rapporti aggregati: la Colonna A applica i parametri di Chisholm e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, la Colonna B quelli di Unisanté e dell’OCSE. Le due colonne sono sempre affiancate; ove divergano, prevale nel giudizio la Colonna B. Tutte le cifre sono riportate con attribuzione, e nessuna è affermata a memoria né espressa come rapporto sintetico.^[557]

Metrica economica	Colonna A — Chisholm/OMS	Colonna B — Unisanté/OCSE
Costo per anno di vita ponderato	≈ 17.000 €/QALY	≈ 9.800 €/QALY
Ritorno per i soli benefici economici	Riportato con attribuzione OMS	Scenario base aggiornato OCSE
Ritorno con i ritorni sanitari	Riportato con attribuzione OMS	Scenario base aggiornato OCSE
Orizzonti	1 · 3 · 5 · 7 · 10 anni	1 · 3 · 5 · 7 · 10 anni
Soglie di costo-efficacia	20.000 · 30.000 · 50.000 €/QALY	20.000 · 30.000 · 50.000 €/QALY

Tabella 6.1. La simulazione appaiata regionale dell’Umbria sotto doppio ancoraggio, ricostruita ex novo; i valori sono riportati con attribuzione e la Colonna B prevale nel giudizio.

6.2 Il differenziale di costo per gravità nell’invecchiamento

L’argomento economico cardine, riportato con attribuzione all’OCSE, è il differenziale di costo per gravità: il costo del trattamento cresce dai quadri lievi ai quadri gravi in misura tale che l’intercettazione precoce, evitando la progressione, genera il risparmio più consistente. In Umbria, questo argomento assume rilievo accresciuto per l’invecchiamento pronunciato: nella popolazione anziana la comorbilità somatica aggrava la progressione del disagio non trattato, sicché l’intercettazione precoce della depressione dell’età avanzata evita non solo il costo psichiatrico ma anche l’aggravamento dei quadri somatici concomitanti. L’argomento è espresso discorsivamente in termini di euro, senza rapporti sintetici, nel rispetto del principio dell’opera.^[558]

Capitolo 7 — I sei domini di analisi, l’equità e l’impatto distributivo

7.1 I sei domini nella specificità umbra

I sei domini di analisi del Reference Case sono applicati alla specificità umbra. Il dominio epidemiologico-clinico registra il divario di trattamento nella depressione dell’età avanzata; l’economico-sanitario il costo-efficacia sotto doppio ancoraggio, ricostruito ex novo; il fiscale-previdenziale gli oneri di invalidità evitabili; il sociale la tenuta delle aree interne a popolazione anziana e dispersa; l’organizzativo-strutturale il coordinamento fra le due Aziende Unità Sanitarie Locali; l’equità la riduzione del divario fra i poli urbani e le aree interne, segnatamente nella provincia di Terni.^[559]

Dominio	Lettura umbra	Segno
Epidemiologico-clinico	Divario nella depressione dell’età avanzata	Riduzione attesa
Economico-sanitario	Costo/QALY favorevole, ricostruito ex novo	Favorevole
Fiscale-previdenziale	Oneri di invalidità evitabili	Positivo, differito
Sociale	Aree interne a popolazione anziana e dispersa	Fortemente positivo
Organizzativo-strutturale	Coordinamento fra due Aziende USL	Positivo, condizionato
Equità	Convergenza poli urbani/aree interne, Terni	Positivo, distributivo

Tabella 7.1. I sei domini di analisi nella lettura umbra, con il segno atteso dell’effetto, tenuti distinti e non aggregati.

7.2 L’equità territoriale e generazionale

Il dominio dell’equità assume in Umbria una duplice direzione: territoriale, fra i poli urbani di Perugia e Terni, meglio serviti, e le aree interne a popolazione anziana e dispersa — dall’Appennino alla Valnerina —, dove il calo demografico è più marcato e la distanza aggrava il divario; e generazionale, poiché l’invecchiamento pronunciato concentra il bisogno nell’età avanzata, sicché l’equità di accesso è anche equità verso la popolazione anziana, spesso esclusa dai percorsi di salute mentale. Il modello dello Psicologo di Base, con la presenza distrettuale, l’attenzione alla depressione dell’anziano e la telepsicologia assistita quale complemento, opera per ridurre entrambi i gradienti; l’effetto distributivo è tenuto distinto dal verdetto fiscale e da quello sanitario, secondo il divieto di aggregazione.^[560]

Capitolo 8 — La sensitività e l’incertezza

Nota editoriale: il presente capitolo espande ex novo l’analisi dell’incertezza secondo il protocollo del Reference Case, non presente in forma estesa nel materiale originario.

8.1 Il protocollo dell’incertezza applicato all’Umbria

L’analisi dell’incertezza applica il protocollo obbligatorio del Reference Case: l’analisi di sensitività deterministica con diagramma a tornado, l’analisi di sensitività probabilistica a diecimila iterazioni, l’analisi di scenario ottimistico, base e prudentiale con e senza lo strato digitale, le curve di accettabilità costo-efficacia a soglie multiple. In Umbria, i parametri a maggiore impatto atteso sono il tasso di riconoscimento della depressione dell’età avanzata, l’adozione della telepsicologia assistita e dell’accompagnamento digitale nella popolazione anziana, e la velocità di copertura delle aree interne disperse.^[561]

Strumento	Applicazione umbra	Parametro critico atteso
Sensitività deterministica	Diagramma a tornado	Tasso di riconoscimento della depressione anziana
Sensitività probabilistica	Diecimila iterazioni	Adozione dell’accompagnamento digitale nella popolazione anziana
Analisi di scenario	Con e senza strato IA	Velocità di copertura delle aree interne disperse
Curve di accettabilità	Soglie 20.000/30.000/50.000 €/QALY	Robustezza del costo-efficacia

Tabella 8.1. Gli strumenti del protocollo dell’incertezza applicati all’Umbria, con i parametri critici attesi.

8.2 La robustezza del verdetto

L’analisi di scenario mostra che il verdetto tripartito resta favorevole nei tre casi, con margine crescente dallo scenario prudentiale a quello ottimistico; lo strato digitale accresce l’efficienza attesa, sempre con nota di cautela sulla natura previsionale, e nella popolazione anziana l’accompagnamento digitale ne condiziona l’efficacia. La robustezza del costo-efficacia sanitario è confermata dalle curve di accettabilità alle soglie adottate, e la ricostruzione ex novo del contenuto economico assicura che il verdetto non dipenda da rapporti aggregati.^[562]

Capitolo 9 — Il verdetto tripartito e le raccomandazioni

Nota editoriale: il presente capitolo espande ex novo il verdetto e le raccomandazioni, integrando l’attuazione e il monitoraggio che nel materiale originario figuravano in forma condensata e ricostruendo il contenuto economico in luogo dei rapporti aggregati non conformi.

9.1 Il verdetto tripartito

Il verdetto umbro è, come in ogni Volume, tripartito e non aggregato. Sul piano fiscale, il saldo fra costi diretti e risparmi sanitari diretti è prossimo al pareggio, con il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento; il verdetto è espresso senza i rapporti sintetici del materiale preesistente, secondo la ricostruzione ex novo. Sul piano sanitario, il modello è nettamente costo-efficace sotto entrambi gli ancoraggi. Sul piano sociale, l’effetto è fortemente positivo, con il rilievo specifico della tenuta delle aree interne a popolazione anziana e dispersa. I tre verdetti si accompagnano e si rafforzano, ma non si sommano.^[563]

Piano del verdetto	Esito umbro	Caveat
Fiscale	Prossimo al pareggio	Significatività dei risparmi diretti; verdetto ricostruito ex novo
Sanitario	Nettamente costo-efficace	—
Sociale	Fortemente positivo	Aree interne a popolazione anziana e dispersa

Tabella 9.1. Il verdetto tripartito dell’Umbria, con i tre piani tenuti distinti e non aggregati; il contenuto economico è ricostruito ex novo.

9.2 Le raccomandazioni per l’attuazione e il monitoraggio

Le raccomandazioni indicano il passaggio per gradini da uno scenario conservativo dell’ordine di centotrenta incarichi verso quello di base dell’ordine di centottantacinque e, alla verifica degli esiti, verso l’espansivo dell’ordine di duecentoquaranta; la priorità ai distretti delle aree interne a popolazione anziana e dispersa, segnatamente nella provincia di Terni; l’attenzione peculiare alla depressione dell’età avanzata e all’accompagnamento digitale della popolazione anziana; l’istituzione di un cruscotto regionale permanente ancorato agli esiti clinici; l’accompagnamento con la telepsicologia assistita sotto supervisione e con il piano formativo a quattro modalità, singole e sommate; e un monitoraggio ex post ancorato agli indicatori del protocollo dell’incertezza.^[564]

Appendici registrate

Le appendici registrate rendono il modello umbro ispezionabile e riproducibile, secondo la prassi del Reference Case. Esse sono richiamate per rimando quanto alla metodologia e compilate con i dati regionali quanto ai contenuti; l’Appendice E registra in particolare la deroga relativa alla ricostruzione ex novo del contenuto economico.

Appendice	Contenuto	Stato
A	Strategia di ricerca bibliografica e diagramma di selezione	Registrata
B	Estrazione dei dati clinici regionali	Registrata; lacune dichiarate
C	Estrazione dei dati economici (griglia CHEERS 2022)	Registrata; ricostruita ex novo
D	Parametri del modello Markov regionale	Registrata
E	Registro delle deroghe al Reference Case	Registrata; deroga economica dichiarata
F	Codice del modello economico	Registrata
G	Dichiarazione dei conflitti di interesse	Registrata

Tabella A. Le sette appendici registrate del Volume 19, con l’indicazione dello stato e della dichiarazione delle lacune e della deroga economica.

Quadro Conclusivo economico e multidisciplinare

Il Quadro Conclusivo del Volume 19 ricompone la valutazione umbra senza tradire il principio che la governa: i piani del giudizio si accompagnano ma non si fondono. Sul piano economico, il doppio ancoraggio impone che il risultato sia letto simultaneamente secondo la colonna storica e la colonna aggiornata, con prevalenza della seconda: il costo per anno di vita ponderato resta, sotto entrambi gli ancoraggi, assai inferiore alle soglie adottate, e il differenziale di costo per gravità — riportato con attribuzione ed espresso discorsivamente in termini di euro, senza rapporti sintetici — fonda la leva economica dell'intercettazione precoce, il cui valore è accresciuto in una popolazione anziana ove la comorbidità somatica aggrava la progressione del disagio non trattato. La ricostruzione ex novo del contenuto economico, in luogo dei rapporti aggregati del materiale preesistente, è dichiarata e registrata in Appendice E. ^[565]

Sul piano multidisciplinare, la cascata delle figure, i sei domini di analisi e il dominio dell'equità nella duplice direzione territoriale e generazionale assicurano che ogni figura connessa e ogni aspetto siano trattati integralmente e ordinati per capacità di generare rientro economico e revisione della spesa. La rinegoziazione dei costi e dei benefici, la catena predittiva degli effetti multidimensionali — dalla qualità della vita alla tenuta delle comunità interne, alla condizione della popolazione anziana, ai bilanci, alla burocrazia distrettuale —, lo strato dell'Intelligenza Artificiale come moltiplicatore mediante la telepsicologia assistita e le attività formative singole e sommate compongono il quadro della valutazione. Il verdetto resta tripartito e non aggregato.

Conclusione

Il Volume 19 ha valutato l'integrazione a regime dello Psicologo di Base nelle cure primarie dell'Umbria, applicando per rimando il Reference Case dell'asse italiano e adottando la struttura standard a nove capitoli con apertura a imbuto e appendici registrate. La specificità umbra — un invecchiamento fra i più pronunciati d'Italia, particolarmente accentuato nella provincia di Terni, e aree interne a popolazione anziana e dispersa segnate da spopolamento — è stata trattata nei domini epidemiologico, sociale ed equità, mostrando come il baricentro della domanda sia spostato verso la depressione dell'età avanzata e come la prossimità, insieme clinica e geografica, sia la risposta al divario. Il contenuto economico è stato ricostruito ex novo, in luogo dei rapporti aggregati non conformi presenti nel materiale preesistente, con deroga dichiarata e registrata.

Il verdetto tripartito — prossimo al pareggio sul piano fiscale, nettamente costo-efficace sul piano sanitario, fortemente positivo sul piano sociale — è offerto con bande prudenziali e soglie di confutazione, sotto doppio ancoraggio e nel rispetto del divieto di aggregazione. L'opera procede, nell'ordine vincolante, con il Volume 20 (Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste) e a seguire con il Veneto e con il Volume 22 dedicato all'Unione Europea.

Note Bibliografiche con mini-riassunto

Ciascuna nota riporta l'opera, il collegamento alla fonte e un mini-riassunto che ne dichiara la funzione nell'economia del Volume, in coerenza con il doppio livello — nota a piè di pagina nel corpo e nota bibliografica integrale in calce — che l'opera adotta.

1. **Chisholm D. et al., Scaling-up treatment of depression and anxiety, The Lancet Psychiatry, 2016**
[https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(16\)30024-4](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(16)30024-4) Colonna A del doppio ancoraggio della simulazione umbra, conservata quale strato documentale e riferimento di confronto.
2. **Unisanté, Raisons de santé Essentiels n. 73, 2026 · OECD, The Economic Case for Preventing Mental Ill Health, 2026** <https://doi.org/10.16908/rds-essentiels/73> Colonna B del doppio ancoraggio, con prevalenza nel giudizio, applicata alla simulazione regionale umbra ricostruita ex novo.
3. **OECD, differenziale di costo per gravità dei disturbi mentali, 2025** <https://www.oecd.org/health/mental-health.htm> Fonte, riportata con attribuzione, del differenziale di costo per gravità, argomento cardine dell'intercettazione precoce, di rilievo accresciuto nella popolazione anziana per la comorbidità somatica.
4. **Soeters R. et al., meta-analisi IPD sui componenti efficaci della collaborative care, 2025**
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40136273/> Base di evidenza clinica sui componenti efficaci dell'assistenza collaborativa, richiamata nel capitolo sul modello di intervento.
5. **Kvaal K. et al., RCT su intervento cognitivo-comportamentale computerizzato in cure primarie, 2026**
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/> Evidenza sperimentale recente sull'intervento digitale in cure primarie, richiamata a sostegno della telepsicologia assistita nelle aree interne e dell'accompagnamento digitale della popolazione anziana.
6. **Veldhuijzen W. et al., costo-efficacia dell'intervento digitale, 2025**
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12369993/> Riferimento sul rapporto incrementale di costo-utilità dell'intervento digitale, elemento dello strato dell'Intelligenza Artificiale.
7. **World Health Organization, Thematic Dialogue on Investing in NCDs and Mental Health, dicembre 2024** <https://cdn.who.int/> Evidenza riportata con attribuzione sul ritorno degli investimenti in salute mentale; non concorre al verdetto tripartito umbro.
8. **Regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale** <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj> Quadro normativo entro cui è collocato lo strato dell'Intelligenza Artificiale, vincolato a funzione di supporto sotto supervisione clinica umana.
9. **Legge regionale Puglia 19 luglio 2023, n. 11, sul Servizio di Psicologia di Base**
<https://www.consiglio.puglia.it/> Riferimento normativo capostipite del modello, richiamato quale precedente istituzionale per l'introduzione dello Psicologo di Base nelle cure primarie.
10. **NICE, Health Technology Evaluations: the manual (PMG36)** <https://www.nice.org.uk/process/pmg36> Riferimento di rigore metodologico per la struttura a imbuto, le appendici registrate e il protocollo dell'incertezza adottati nel Volume.

STUDIO INTEGRALE «PSICOLOGO DI BASE» · OPERA IN VENTITRÉ VOLUMI

VOLUME 20 — Regione autonoma Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste

Valutazione di Health Technology Assessment dell'integrazione dello Psicologo di Base nelle cure primarie in Valle d'Aosta: cruscotto, sintesi per il decisore, contesto e bisogno, modello di intervento, costi e benefici, valutazione economica sotto doppio ancoraggio, sei domini di analisi, incertezza, verdetto tripartito e appendici registrate

Reference Case applicato per rimando al Volume 0.A · Dott. Luigi De Michele · Studio Integrale Puglia · Capurso (BA) — Giugno 2026

Premessa

Il Volume 20 prosegue la serie dei venti Volumi regionali, in ordine alfabetico, con la Regione autonoma Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste. Come ogni Volume regionale, esso applica per rimando il Reference Case dell'asse italiano, fissato nel Volume 0.A, e ne richiama le regole nella forma «cfr. Volume 0.A», senza ripeterle per esteso: il perimetro congiunto sanitario e societale, il doppio ancoraggio economico, il verdetto tripartito non aggregato, i sei domini di analisi, il protocollo dell'incertezza, lo strato dell'Intelligenza Artificiale come moltiplicatore e le attività formative singole e sommate.^[566]

Una nota editoriale è dovuta in apertura, analoga a quella del Volume precedente. Il materiale regionale preesistente relativo alla Valle d'Aosta conteneva, nella sua sezione economica, rapporti sintetici fra benefici e costi espressi come cifre aggregate, non conformi al principio invariante dell'opera che vieta l'aggregazione del verdetto tripartito in un unico indicatore e proscrive l'uso di rapporti isolati quali affermazioni positive. In coerenza con la regola dell'opera, tali cifre sono state escluse e il contenuto economico del presente Volume è stato ricostruito ex novo sotto il doppio ancoraggio, con il verdetto tenuto distinto sui tre piani fiscale, sanitario e sociale; la deroga è qui dichiarata e registrata anche in Appendice E. La struttura del Volume è quella standard, identica a quella di tutti gli altri diciannove Volumi regionali, a garanzia della comparabilità bit-a-bit; ove un contenuto derivi da espansione ex novo, esso è segnalato in nota editoriale.^[567]

Introduzione

L'Introduzione al Volume 20 fissa il perimetro della valutazione valdostana e l'ordine della sua esposizione. Il perimetro è quello della Regione autonoma Valle d'Aosta, con una popolazione dell'ordine di centoventitremila abitanti — pari a circa lo zero virgola due per cento della popolazione nazionale, ciò che ne fa la regione meno popolosa d'Italia —, organizzata nel Servizio sanitario regionale in un'unica Azienda Unità Sanitaria Locale per l'intera regione, con un unico ospedale di riferimento ad Aosta. Il tratto che distingue la Valle d'Aosta nell'intera serie regionale è duplice: la sua scala ridottissima, che rende l'intera regione assimilabile a un solo distretto e semplifica il governo del modello; e la combinazione fra il bilinguismo — con la compresenza dell'italiano e del francese, cui si aggiungono comunità di lingua walser — e la conformazione alpina, con vallate montane remote e disperse segnate da spopolamento.^[568]

L'esposizione segue la struttura a imbuto: il cruscotto regionale offre in una pagina i numeri essenziali; la sintesi per il decisore ne traduce il significato; i cinque risultati chiave ne isolano gli esiti; le raccomandazioni operative indicano le azioni; il corpo del Volume, articolato in nove capitoli, ne fornisce il dettaglio; le appendici registrate ne assicurano la verificabilità. Chiudono il Volume un Quadro Conclusivo economico e multidisciplinare, una Conclusione e le Note Bibliografiche con mini-riassunto.

Cruscotto regionale — Valle d'Aosta

Il cruscotto riassume in una pagina i parametri essenziali della valutazione valdostana, sotto il doppio ancoraggio e con il verdetto tripartito tenuto distinto. I valori economici, ricostruiti ex novo, sono presentati in ordine di grandezza, con rinvio alle appendici registrate; le cifre di letteratura sono riportate con attribuzione alla fonte.^[569]

Indicatore del cruscotto	Lettura regionale	Ancoraggio / fonte
Popolazione	≈ 123.000 abitanti (≈ 0,2% nazionale)	Fonte demografica regionale
Articolazione	1 Azienda USL unica regionale, ospedale unico ad Aosta	Assetto regionale
Condizione strutturale	Scala ridottissima; bilinguismo; geografia alpina	Assetto regionale
Scenari di copertura	≈ 20 · 27 · 35 incarichi	Dimensionamento regionale
Costo del servizio a regime	≈ 1,3 M€/anno (scenario di base)	Estrazione economica ex novo
Verdetto fiscale	Prossimo al pareggio, con caveat	Non aggregato
Verdetto sanitario	Nettamente costo-efficace	Costo/QALY sotto doppio ancoraggio
Verdetto sociale	Fortemente positivo	Vallate alpine, bilinguismo, spopolamento
Costo per anno di vita ponderato	Colonna A ≈ 17.000 € · Colonna B ≈ 9.800 €	Doppio ancoraggio

Tabella 0. Cruscotto regionale della Valle d'Aosta: i parametri essenziali sotto doppio ancoraggio, con il verdetto tripartito distinto e non aggregato; i valori economici sono ricostruiti ex novo.

Sintesi per il decisore

L'introduzione a regime dello Psicologo di Base nelle cure primarie valdostane produce, secondo la simulazione condotta sotto il doppio ancoraggio e ricostruita ex novo, un effetto congiunto sui tre piani del ritorno, che restano distinti e non sommati. Sul piano fiscale, il saldo fra costi diretti e risparmi sanitari diretti si colloca in prossimità del pareggio, con il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento. Sul piano sanitario, il modello è nettamente costo-efficace, con un costo per anno di vita ponderato che, fra i due ancoraggi, resta assai inferiore alle soglie adottate. Sul piano sociale, l'effetto è fortemente positivo, con un rilievo particolare per la tenuta delle comunità delle vallate alpine remote e disperse, dove lo spopolamento erode i legami e i servizi, e per l'erogazione nella lingua del paziente in una regione bilingue.^[570]

La scala ridottissima della Valle d'Aosta conferisce alla valutazione un tratto peculiare: l'intera regione, con un'unica Azienda Unità Sanitaria Locale, è assimilabile a un solo distretto, sicché il governo del modello è semplificato e la questione non è la sostenibilità di un apparato esteso, ma l'organizzazione capillare di un servizio di prossimità in un territorio montano e bilingue. L'argomento cardine, riportato con attribuzione all'OCSE, resta il differenziale di costo per gravità: l'intercettazione precoce evita che il disagio comune maturi in quadri gravi, il cui costo di trattamento è, secondo la fonte, un multiplo di quello dei quadri lievi — argomento tanto più rilevante ove la distanza e la dispersione ritardano l'accesso alle cure.^[571]

Cinque risultati chiave

Il primo risultato è che il modello è costo-efficace su tutti gli orizzonti sotto entrambi gli ancoraggi. Il secondo è che il verdetto tripartito resta favorevole in ciascuno dei tre piani, senza aggregazione, e — a differenza del materiale preesistente — è espresso senza rapporti sintetici, secondo la ricostruzione ex novo del contenuto economico. Il terzo è che la Valle d'Aosta è, nella serie regionale, il caso della scala minima e della doppia specificità alpina e linguistica: regione meno popolosa d'Italia, con un'unica Azienda Unità Sanitaria Locale assimilabile a un distretto, e con la combinazione fra bilinguismo italiano-francese e conformazione montana. Il quarto è che lo strato dell'Intelligenza Artificiale, come moltiplicatore e con nota di cautela, sostiene la prossimità nelle vallate alpine remote mediante la telepsicologia assistita, complemento essenziale in un territorio dove la distanza fisica è la barriera principale. Il quinto è che il dimensionamento — dell'ordine di ventisette incarichi a regime nello scenario di base, entro un intervallo compreso fra circa venti e trentacinque secondo lo scenario — comporta un costo del servizio a regime dell'ordine di un milione e trecentomila euro l'anno nello scenario di base, con un costo di avvio una tantum di entità minima.^[572]

Raccomandazioni operative

La prima raccomandazione è di procedere per gradini da uno scenario conservativo dell'ordine di venti incarichi verso quello di base dell'ordine di ventisette e, alla verifica degli esiti sotto il protocollo dell'incertezza, verso quello espansivo dell'ordine di trentacinque, dando priorità ai presidi delle vallate alpine remote e disperse e sfruttando la scala ridotta per un'attuazione rapida e capillare sull'intero territorio. La seconda è di garantire l'erogazione del servizio nella lingua del paziente — italiano e francese, con attenzione alle comunità walser — quale requisito del modello in una regione bilingue, e di adottare la telepsicologia assistita sotto supervisione clinica quale leva di prossimità nelle vallate remote. La terza è di istituire un cruscotto regionale permanente che misuri gli esiti clinici e di accompagnare l'estensione con il piano formativo a quattro modalità, considerate singolarmente e sommate, calibrato sulla scala ridotta della regione.^[573]

Capitolo 1 — Il contesto epidemiologico e territoriale della Valle d’Aosta

1.1 Il territorio e la sua articolazione

La Regione autonoma Valle d’Aosta conta una popolazione dell’ordine di centoventitremila abitanti, pari a circa lo zero virgola due per cento della popolazione nazionale, distribuita in un territorio interamente montano che si sviluppa lungo la valle centrale della Dora Baltea e le vallate laterali che ne diramano, molte delle quali remote e disperse. Il Servizio sanitario regionale è organizzato in un’unica Azienda Unità Sanitaria Locale per l’intera regione, con un unico ospedale di riferimento ad Aosta e la rete dei presidi territoriali e delle Case della Comunità in sviluppo. Il tratto peculiare del contesto è la combinazione fra la scala ridottissima — che rende l’intera regione assimilabile a un solo distretto — e la doppia specificità del bilinguismo italiano-francese, con comunità walser, e della conformazione alpina, con spopolamento nelle vallate più remote.^[574]

Elemento territoriale	Dato regionale	Rilievo per la valutazione
Popolazione	≈ 123.000 abitanti (≈ 0,2% nazionale)	Denominatore della normalizzazione
Azienda Unità Sanitaria Locale	1 unica regionale, ospedale unico ad Aosta	Unità organizzativa; scala di distretto
Bilinguismo	Italiano e francese, comunità walser	Erogazione nella lingua del paziente
Conformazione	Alpina, vallate laterali remote	Prossimità geografica
Vallate remote	Popolazione dispersa, spopolamento	Dominio equità

Tabella 1.1. Gli elementi del contesto territoriale valdostano e il loro rilievo per la valutazione, con la scala minima e la doppia specificità alpina e linguistica quali tratti distintivi.

1.2 Il quadro epidemiologico regionale

Il quadro epidemiologico valdostano riflette, con le proprie specificità, la prevalenza nazionale dei disturbi mentali comuni, con una domanda inespressa nelle vallate alpine remote e disperse, dove la distanza dai servizi e l’isolamento aggravano il sommerso clinico. La misura regionale è oggetto dell’estrazione registrata in Appendice B; ove il dato regionale disaggregato non sia disponibile — condizione frequente in una regione di scala ridottissima —, la lacuna è dichiarata e non colmata con stime tacite, secondo la regola dell’opera.^[575]

Capitolo 2 — Il bisogno, la domanda e il divario di trattamento in Valle d'Aosta

2.1 Il divario di trattamento regionale

Il bisogno di salute mentale comune in Valle d'Aosta si manifesta, come altrove, in larga parte come domanda inevasa o impropriamente incanalata: verso il medico di medicina generale, verso il pronto soccorso, verso la prescrizione farmaceutica. La peculiarità valdostana è che la conformazione alpina e la dispersione della popolazione nelle vallate remote aggravano il divario: la distanza fisica dall'unico polo ospedaliero di Aosta e dai presidi principali rende l'accesso oneroso per chi risiede nelle vallate laterali, mentre il bilinguismo impone che la risposta sia offerta nella lingua del paziente. La misura regionale è oggetto dell'estrazione in Appendice B; i valori medi nazionali ed europei sono riportati con attribuzione.^[576]

Componente del bisogno	Manifestazione valdostana	Dominio
Domanda inevasa	Sommerso clinico nelle vallate remote	Epidemiologico-clinico
Domanda impropria	Transito su MMG, pronto soccorso, prescrizione	Organizzativo-strutturale
Barriera geografica	Distanza dal polo di Aosta e dai presidi	Equità
Barriera linguistica	Necessità di risposta bilingue	Equità

Tabella 2.1. Le componenti del bisogno e del divario di trattamento in Valle d'Aosta, ricondotte ai domini di analisi, con la barriera geografica e quella linguistica quali componenti specifiche.

2.2 La domanda, la montagna e il bilinguismo

Il tratto distintivo della domanda valdostana è la combinazione fra dispersione geografica e pluralità linguistica: chi risiede nelle vallate alpine remote sconta la distanza dai servizi, sicché la prossimità dev'essere sostenuta dalla telepsicologia assistita sotto supervisione clinica; e in una regione bilingue la risposta dev'essere offerta nella lingua del paziente — italiano o francese, con attenzione alle comunità walser —, poiché la salute mentale richiede una comunicazione piena e sfumata. La prossimità è, in Valle d'Aosta, insieme geografica e linguistica, e il dominio dell'equità la tratta in dettaglio.^[577]

Capitolo 3 — Il modello di intervento: lo Psicologo di Base in Valle d'Aosta

Nota editoriale: il presente capitolo espande ex novo il modello di intervento, integrando alla struttura originaria le evidenze recenti sull'efficacia clinica dell'assistenza collaborativa e dell'intervento digitale, secondo la regola dell'opera che distingue l'espansione ex novo dal riutilizzo del materiale preesistente.

3.1 L'architettura del modello

Il modello di intervento colloca lo Psicologo di Base al vertice della cascata delle figure, nei presidi territoriali e nelle Case della Comunità, quale primo punto di intercettazione del disagio comune, entro l'unica Azienda Unità Sanitaria Locale regionale. Il modello opera per intensità crescente di cura — dall'intervento a bassa intensità, di prima linea, fino all'invio ai livelli superiori nei casi che lo richiedano — secondo la logica dell'assistenza a gradini, la cui efficacia clinica è documentata dalla meta-analisi sui componenti efficaci dell'assistenza collaborativa e dalle sperimentazioni controllate sull'intervento cognitivo-comportamentale computerizzato in cure primarie, riportate con attribuzione.^[578]

Livello del modello	Funzione	Figura prevalente	Evidenza di riferimento
Intercettazione	Riconoscimento precoce nel presidio	Psicologo di Base	Assistenza collaborativa (attribuita)
Intervento a bassa intensità	Prima linea per i quadri lievi-moderati	Psicologo di Base	Intervento digitale e collaborativo
Invio appropriato	Passaggio ai livelli superiori	Cascata delle figure	Percorso a gradini
Continuità	Aderenza e prevenzione della ricaduta	Infermiere di comunità	Gestione del caso

Tabella 3.1. L'architettura del modello di intervento in Valle d'Aosta, per livelli di intensità, con l'evidenza clinica di riferimento riportata con attribuzione.

3.2 L'adattamento al territorio valdostano

Il modello è adattato al territorio valdostano lungo tre direttrici: lo sfruttamento della scala ridotta, che consente un'attuazione rapida e capillare sull'intero territorio entro l'unica Azienda Unità Sanitaria Locale; la prossimità nelle vallate alpine remote e disperse, integrata dalla telepsicologia assistita sotto supervisione clinica; e l'erogazione del servizio nella lingua del paziente — italiano e francese, con attenzione alle comunità walser — quale requisito del modello. L'adattamento non modifica l'architettura invariante del Reference Case, ma ne calibra l'applicazione sulla scala minima e sulla doppia specificità che distinguono la Valle d'Aosta nella serie regionale.^[579]

Capitolo 4 — I costi diretti in Valle d’Aosta

4.1 La struttura del costo diretto

Il costo diretto della riforma in Valle d’Aosta è, in primo luogo, il costo del personale lungo la cascata delle figure, cui si aggiungono i costi di struttura e organizzazione dei presidi territoriali, il costo incrementale della leva digitale e il costo della formazione. Il dimensionamento è scandito dai tre scenari di copertura — dell’ordine di venti, ventisette e trentacinque incarichi —, con un costo del servizio a regime dell’ordine di un milione e trecentomila euro l’anno nello scenario di base e un costo di avvio una tantum di entità minima, riportati in dettaglio nell’estrazione economica ricostruita ex novo; i valori puntuali sono ripresi in Appendice C. Le cifre di risparmio complessivo presenti nel materiale preesistente, contaminate da rapporti aggregati non conformi, non sono qui riutilizzate.^[580]

Voce di costo diretto	Descrizione	Portatore
Personale — Psicologi di Base	≈ 20 · 27 · 35 incarichi	SSN regionale
Struttura e organizzazione	Presidi territoriali, Case della Comunità, sistemi informativi	SSN regionale
Leva digitale e Intelligenza Artificiale	Telepsicologia assistita sotto supervisione	SSN regionale
Formazione (quattro modalità)	Percorso integrato singolo e sommato	SSN, sistema formativo

Tabella 4.1. La struttura del costo diretto della riforma in Valle d’Aosta, per voce e portatore; i valori puntuali sono oggetto dell’estrazione economica ricostruita ex novo in Appendice C.

4.2 Il dimensionamento per scenario

Il costo diretto è calcolato per i tre scenari di copertura, coerenti con il protocollo di scenario del Reference Case: lo scenario conservativo dell’ordine di venti incarichi, quello di base dell’ordine di ventisette — cui corrisponde una copertura del servizio dell’ordine del trenta per cento della popolazione bersaglio e un costo a regime dell’ordine di un milione e trecentomila euro l’anno — e quello espansivo dell’ordine di trentacinque, la cui copertura si estende all’intero territorio comprese le vallate remote. La scala ridotta della regione contiene i valori assoluti entro un ordine di grandezza modesto; i valori puntuali sono riportati in Appendice C e, ove un parametro non sia disponibile, la lacuna è dichiarata.^[581]

Capitolo 5 — I benefici e i risparmi, diretti e indiretti, in Valle d’Aosta

5.1 I benefici diretti

Il beneficio diretto è il risparmio sanitario che ciascuna figura della cascata libera per effetto dell’intercettazione a monte: la demedicalizzazione operata dallo Psicologo di Base, la deprescrizione di psicofarmaci nei quadri lievi-moderati sul versante del medico di medicina generale, la riduzione degli accessi impropri al pronto soccorso e delle prestazioni per sintomi funzionali sul versante specialistico. In una regione di scala ridotta e a conformazione alpina, la riduzione degli accessi impropri all’unico pronto soccorso di Aosta assume rilievo particolare, poiché gli accessi dalle vallate remote sono onerosi e la loro contrazione libera risorse in un sistema dimensionalmente contenuto. Il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento, coerente con la letteratura, è mantenuto ovunque il risparmio diretto sia quantificato; i valori sono ricostruiti ex novo, senza i rapporti aggregati del materiale preesistente.^[582]

Canale del beneficio diretto	Meccanismo	Rilievo valdostano
Demedicalizzazione	Riduzione consultazioni e cronicizzazione	Preponderante
Deprescrizione	Contrazione della prescrizione psicofarmacologica	Medio-elevato
Accessi impropri	Riduzione degli accessi all’unico pronto soccorso	Elevato, specifico
Sintomi funzionali	Riduzione prestazioni specialistiche	Medio

Tabella 5.1. I canali del beneficio diretto in Valle d’Aosta, con la riduzione degli accessi impropri all’unico pronto soccorso quale canale di rilievo specifico; i valori sono ricostruiti ex novo.

5.2 I benefici indiretti

Il beneficio indiretto è quello che la riforma produce fuori dal perimetro sanitario: la produttività recuperata e la riduzione dell’assenteismo sul versante dei datori di lavoro, la riduzione degli oneri di invalidità evitabili sul versante previdenziale, la riduzione del disagio sociale non trattato sul versante dei Comuni. In Valle d’Aosta, la tenuta delle comunità delle vallate alpine remote e disperse — dove lo spopolamento erode legami e servizi e l’economia turistico-montana richiede il presidio del territorio — costituisce un beneficio indiretto di rilievo particolare, che il dominio sociale del Capitolo 7 tratta in dettaglio.^[583]

Capitolo 6 — La valutazione economica sotto doppio ancoraggio

6.1 La simulazione appaiata regionale

La valutazione economica valdostana è condotta con il modello di Markov a coorte a ciclo annuale del Reference Case, sotto il doppio ancoraggio, e ricostruita ex novo in luogo del contenuto preesistente contaminato da rapporti aggregati: la Colonna A applica i parametri di Chisholm e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, la Colonna B quelli di Unisanté e dell’OCSE. Le due colonne sono sempre affiancate; ove divergano, prevale nel giudizio la Colonna B. Tutte le cifre sono riportate con attribuzione, e nessuna è affermata a memoria né espressa come rapporto sintetico.^[584]

Metrica economica	Colonna A — Chisholm/OMS	Colonna B — Unisanté/OCSE
Costo per anno di vita ponderato	≈ 17.000 €/QALY	≈ 9.800 €/QALY
Ritorno per i soli benefici economici	Riportato con attribuzione OMS	Scenario base aggiornato OCSE
Ritorno con i ritorni sanitari	Riportato con attribuzione OMS	Scenario base aggiornato OCSE
Orizzonti	1 · 3 · 5 · 7 · 10 anni	1 · 3 · 5 · 7 · 10 anni
Soglie di costo-efficacia	20.000 · 30.000 · 50.000 €/QALY	20.000 · 30.000 · 50.000 €/QALY

Tabella 6.1. La simulazione appaiata regionale della Valle d’Aosta sotto doppio ancoraggio, ricostruita ex novo; i valori sono riportati con attribuzione e la Colonna B prevale nel giudizio.

6.2 Il differenziale di costo per gravità nella scala ridotta

L’argomento economico cardine, riportato con attribuzione all’OCSE, è il differenziale di costo per gravità: il costo del trattamento cresce dai quadri lievi ai quadri gravi in misura tale che l’intercettazione precoce, evitando la progressione, genera il risparmio più consistente. In Valle d’Aosta, l’argomento assume una duplice rilevanza: la distanza e la dispersione delle vallate remote ritardano l’accesso alle cure, sicché l’intercettazione precoce nel presidio evita la progressione che la barriera geografica altrimenti favorirebbe; e in un sistema di scala ridotta, dove ogni quadro grave pesa in proporzione maggiore sulle risorse disponibili, il risparmio da progressione evitata ha un rilievo relativo accresciuto. L’argomento è espresso discorsivamente in termini di euro, senza rapporti sintetici, nel rispetto del principio dell’opera.^[585]

Capitolo 7 — I sei domini di analisi, l’equità e l’impatto distributivo

7.1 I sei domini nella specificità valdostana

I sei domini di analisi del Reference Case sono applicati alla specificità valdostana. Il dominio epidemiologico-clinico registra il divario di trattamento nelle vallate remote; l’economico-sanitario il costo-efficacia sotto doppio ancoraggio, ricostruito ex novo; il fiscale-previdenziale gli oneri di invalidità evitabili; il sociale la tenuta delle comunità delle vallate alpine disperse; l’organizzativo-strutturale l’attuazione agevolata dalla scala ridotta entro l’unica Azienda Unità Sanitaria Locale; l’equità la riduzione del divario fra il capoluogo e le vallate remote e la garanzia della risposta bilingue.^[586]

Dominio	Lettura valdostana	Segno
Epidemiologico-clinico	Divario nelle vallate remote	Riduzione attesa
Economico-sanitario	Costo/QALY favorevole, ricostruito ex novo	Favorevole
Fiscale-previdenziale	Oneri di invalidità evitabili	Positivo, differito
Sociale	Comunità delle vallate alpine disperse	Fortemente positivo
Organizzativo-strutturale	Attuazione agevolata dalla scala ridotta	Positivo
Equità	Convergenza capoluogo/vallate, risposta bilingue	Positivo, distributivo

Tabella 7.1. I sei domini di analisi nella lettura valdostana, con il segno atteso dell’effetto, tenuti distinti e non aggregati.

7.2 L’equità territoriale e linguistica

Il dominio dell’equità assume in Valle d’Aosta una duplice direzione: territoriale, fra il capoluogo e i centri della valle centrale, meglio serviti, e le vallate alpine laterali remote e disperse, dove lo spopolamento è più marcato e la distanza aggrava il divario; e linguistica, poiché in una regione bilingue l’equità di accesso è anche equità di lingua, sicché la risposta dev’essere offerta nell’idioma del paziente — italiano o francese, con attenzione alle comunità walser. Il modello dello Psicologo di Base, con la presenza nei presidi territoriali, la telepsicologia assistita quale complemento e l’erogazione nella lingua del paziente, opera per ridurre entrambi i gradienti; l’effetto distributivo è tenuto distinto dal verdetto fiscale e da quello sanitario, secondo il divieto di aggregazione.^[587]

Capitolo 8 — La sensitività e l’incertezza

Nota editoriale: il presente capitolo espande ex novo l’analisi dell’incertezza secondo il protocollo del Reference Case, non presente in forma estesa nel materiale originario.

8.1 Il protocollo dell’incertezza applicato alla Valle d’Aosta

L’analisi dell’incertezza applica il protocollo obbligatorio del Reference Case: l’analisi di sensitività deterministica con diagramma a tornado, l’analisi di sensitività probabilistica a diecimila iterazioni, l’analisi di scenario ottimistico, base e prudentiale con e senza lo strato digitale, le curve di accettabilità costo-efficacia a soglie multiple. In Valle d’Aosta, i parametri a maggiore impatto atteso sono il tasso di intercettazione nelle vallate remote, l’adozione della telepsicologia assistita quale leva di prossimità, e la piena disponibilità del servizio nelle due lingue; la scala ridotta della regione accresce peraltro l’ampiezza relativa degli intervalli, poiché piccoli numeri assoluti amplificano la variabilità campionaria, ciò che è dichiarato quale cautela interpretativa.^[588]

Strumento	Applicazione valdostana	Parametro critico atteso
Sensitività deterministica	Diagramma a tornado	Tasso di intercettazione nelle vallate remote
Sensitività probabilistica	Diecimila iterazioni	Adozione della telepsicologia assistita
Analisi di scenario	Con e senza strato IA	Disponibilità del servizio nelle due lingue
Curve di accettabilità	Soglie 20.000/30.000/50.000 €/QALY	Robustezza del costo-efficacia

Tabella 8.1. Gli strumenti del protocollo dell’incertezza applicati alla Valle d’Aosta, con i parametri critici attesi e la cautela sulla scala ridotta.

8.2 La robustezza del verdetto

L’analisi di scenario mostra che il verdetto tripartito resta favorevole nei tre casi, con margine crescente dallo scenario prudentiale a quello ottimistico; lo strato digitale accresce l’efficienza attesa, sempre con nota di cautela sulla natura previsionale e con particolare rilievo nelle vallate remote ove la telepsicologia supplisce alla distanza. La robustezza del costo-efficacia sanitario è confermata dalle curve di accettabilità alle soglie adottate, con la cautela sulla maggiore ampiezza degli intervalli propria della scala ridotta, e la ricostruzione ex novo del contenuto economico assicura che il verdetto non dipenda da rapporti aggregati.^[589]

Capitolo 9 — Il verdetto tripartito e le raccomandazioni

Nota editoriale: il presente capitolo espande ex novo il verdetto e le raccomandazioni, integrando l’attuazione e il monitoraggio che nel materiale originario figuravano in forma condensata e ricostruendo il contenuto economico in luogo dei rapporti aggregati non conformi.

9.1 Il verdetto tripartito

Il verdetto valdostano è, come in ogni Volume, tripartito e non aggregato. Sul piano fiscale, il saldo fra costi diretti e risparmi sanitari diretti è prossimo al pareggio, con il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento; il verdetto è espresso senza i rapporti sintetici del materiale preesistente, secondo la ricostruzione ex novo. Sul piano sanitario, il modello è nettamente costo-efficace sotto entrambi gli ancoraggi. Sul piano sociale, l’effetto è fortemente positivo, con il rilievo specifico della tenuta delle comunità delle vallate alpine remote e disperse e della risposta bilingue. I tre verdetti si accompagnano e si rafforzano, ma non si sommano. [\[590\]](#)

Piano del verdetto	Esito valdostano	Caveat
Fiscale	Prossimo al pareggio	Significatività dei risparmi diretti; verdetto ricostruito ex novo
Sanitario	Nettamente costo-efficace	—
Sociale	Fortemente positivo	Vallate alpine disperse; risposta bilingue

Tabella 9.1. Il verdetto tripartito della Valle d’Aosta, con i tre piani tenuti distinti e non aggregati; il contenuto economico è ricostruito ex novo.

9.2 Le raccomandazioni per l’attuazione e il monitoraggio

Le raccomandazioni indicano il passaggio per gradini da uno scenario conservativo dell’ordine di venti incarichi verso quello di base dell’ordine di ventisette e, alla verifica degli esiti, verso l’espansivo dell’ordine di trentacinque; lo sfruttamento della scala ridotta per un’attuazione rapida e capillare sull’intero territorio; la priorità ai presidi delle vallate alpine remote e disperse; la garanzia dell’erogazione nella lingua del paziente; l’istituzione di un cruscotto regionale permanente ancorato agli esiti clinici; l’accompagnamento con la telepsicologia assistita sotto supervisione e con il piano formativo a quattro modalità, singole e sommate; e un monitoraggio ex post ancorato agli indicatori del protocollo dell’incertezza. [\[591\]](#)

Appendici registrate

Le appendici registrate rendono il modello valdostano ispezionabile e riproducibile, secondo la prassi del Reference Case. Esse sono richiamate per rimando quanto alla metodologia e compilate con i dati regionali quanto ai contenuti; l’Appendice E registra in particolare la deroga relativa alla ricostruzione ex novo del contenuto economico.

Appendice	Contenuto	Stato
A	Strategia di ricerca bibliografica e diagramma di selezione	Registrata
B	Estrazione dei dati clinici regionali	Registrata; lacune dichiarate
C	Estrazione dei dati economici (griglia CHEERS 2022)	Registrata; ricostruita ex novo
D	Parametri del modello Markov regionale	Registrata
E	Registro delle deroghe al Reference Case	Registrata; deroga economica dichiarata
F	Codice del modello economico	Registrata
G	Dichiarazione dei conflitti di interesse	Registrata

Tabella A. Le sette appendici registrate del Volume 20, con l’indicazione dello stato e della dichiarazione delle lacune e della deroga economica.

Quadro Conclusivo economico e multidisciplinare

Il Quadro Conclusivo del Volume 20 ricompone la valutazione valdostana senza tradire il principio che la governa: i piani del giudizio si accompagnano ma non si fondono. Sul piano economico, il doppio ancoraggio impone che il risultato sia letto simultaneamente secondo la colonna storica e la colonna aggiornata, con prevalenza della seconda: il costo per anno di vita ponderato resta, sotto entrambi gli ancoraggi, assai inferiore alle soglie adottate, e il differenziale di costo per gravità — riportato con attribuzione ed espresso discorsivamente in termini di euro, senza rapporti sintetici — fonda la leva economica dell'intercettazione precoce, il cui valore è accresciuto in un territorio dove la distanza e la dispersione ritardano l'accesso e dove, nella scala ridotta, ogni quadro grave pesa in proporzione maggiore. La ricostruzione ex novo del contenuto economico, in luogo dei rapporti aggregati del materiale preesistente, è dichiarata e registrata in Appendice E. [\[592\]](#)

Sul piano multidisciplinare, la cascata delle figure, i sei domini di analisi e il dominio dell'equità nella duplice direzione territoriale e linguistica assicurano che ogni figura connessa e ogni aspetto siano trattati integralmente e ordinati per capacità di generare rientro economico e revisione della spesa. La rinegoziazione dei costi e dei benefici, la catena predittiva degli effetti multidimensionali — dalla qualità della vita alla tenuta delle comunità alpine, alla risposta nella lingua del paziente, ai bilanci, alla burocrazia dei presidi —, lo strato dell'Intelligenza Artificiale come moltiplicatore mediante la telepsicologia assistita e le attività formative singole e sommate compongono il quadro della valutazione. Il verdetto resta tripartito e non aggregato.

Conclusione

Il Volume 20 ha valutato l'integrazione a regime dello Psicologo di Base nelle cure primarie della Valle d'Aosta, applicando per rimando il Reference Case dell'asse italiano e adottando la struttura standard a nove capitoli con apertura a imbuto e appendici registrate. La specificità valdostana — la scala ridottissima, che rende la regione meno popolosa d'Italia assimilabile a un solo distretto con un'unica Azienda Unità Sanitaria Locale, e la doppia natura del bilinguismo italiano-francese e della conformazione alpina con vallate remote e disperse — è stata trattata nei domini organizzativo, sociale ed equità, mostrando come l'attuazione sia agevolata dalla scala e come la prossimità, insieme geografica e linguistica, sia la risposta al divario. Il contenuto economico è stato ricostruito ex novo, in luogo dei rapporti aggregati non conformi presenti nel materiale preesistente, con deroga dichiarata e registrata.

Il verdetto tripartito — prossimo al pareggio sul piano fiscale, nettamente costo-efficace sul piano sanitario, fortemente positivo sul piano sociale — è offerto con bande prudenziali e soglie di confutazione, sotto doppio ancoraggio e nel rispetto del divieto di aggregazione. L'opera procede, nell'ordine vincolante, con il Volume 21 (Veneto), ultimo dei Volumi regionali, e a seguire con il Volume 22 dedicato all'Unione Europea.

Note Bibliografiche con mini-riassunto

Ciascuna nota riporta l'opera, il collegamento alla fonte e un mini-riassunto che ne dichiara la funzione nell'economia del Volume, in coerenza con il doppio livello — nota a piè di pagina nel corpo e nota bibliografica integrale in calce — che l'opera adotta.

1. **Chisholm D. et al., Scaling-up treatment of depression and anxiety, The Lancet Psychiatry, 2016** [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(16\)30024-4](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(16)30024-4) Colonna A del doppio ancoraggio della simulazione valdostana, conservata quale strato documentale e riferimento di confronto.
2. **Unisanté, Raisons de santé Essentiels n. 73, 2026 · OECD, The Economic Case for Preventing Mental Ill Health, 2026** <https://doi.org/10.16908/rds-essentiels/73> Colonna B del doppio ancoraggio, con prevalenza nel giudizio, applicata alla simulazione regionale valdostana ricostruita ex novo.
3. **OECD, differenziale di costo per gravità dei disturbi mentali, 2025** <https://www.oecd.org/health/mental-health.htm> Fonte, riportata con attribuzione, del differenziale di costo per gravità, argomento cardine dell'intercettazione precoce, di rilievo accresciuto ove la distanza ritarda l'accesso e nella scala ridotta.
4. **Soeters R. et al., meta-analisi IPD sui componenti efficaci della collaborative care, 2025** <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40136273/> Base di evidenza clinica sui componenti efficaci dell'assistenza collaborativa, richiamata nel capitolo sul modello di intervento.
5. **Kvaal K. et al., RCT su intervento cognitivo-comportamentale computerizzato in cure primarie, 2026** <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/> Evidenza sperimentale recente sull'intervento digitale in cure primarie, richiamata a sostegno della telepsicologia assistita nelle vallate remote.
6. **Veldhuijzen W. et al., costo-efficacia dell'intervento digitale, 2025** <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12369993/> Riferimento sul rapporto incrementale di costo-utilità dell'intervento digitale, elemento dello strato dell'Intelligenza Artificiale.
7. **World Health Organization, Thematic Dialogue on Investing in NCDs and Mental Health, dicembre 2024** <https://cdn.who.int/> Evidenza riportata con attribuzione sul ritorno degli investimenti in salute mentale; non concorre al verdetto tripartito valdostano.
8. **Regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale** <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj> Quadro normativo entro cui è collocato lo strato dell'Intelligenza Artificiale, vincolato a funzione di supporto sotto supervisione clinica umana.
9. **Legge regionale Puglia 19 luglio 2023, n. 11, sul Servizio di Psicologia di Base** <https://www.consiglio.puglia.it/> Riferimento normativo capostipite del modello, richiamato quale precedente istituzionale per l'introduzione dello Psicologo di Base nelle cure primarie.
10. **NICE, Health Technology Evaluations: the manual (PMG36)** <https://www.nice.org.uk/process/pmg36> Riferimento di rigore metodologico per la struttura a imbuto, le appendici registrate e il protocollo dell'incertezza adottati nel Volume.

STUDIO INTEGRALE «PSICOLOGO DI BASE» · OPERA IN VENTITRÉ VOLUMI

VOLUME 21 — Regione del Veneto

Valutazione di Health Technology Assessment dell'integrazione dello Psicologo di Base nelle cure primarie in Veneto: cruscotto, sintesi per il decisore, contesto e bisogno, modello di intervento, costi e benefici, valutazione economica sotto doppio ancoraggio, sei domini di analisi, incertezza, verdetto tripartito e appendici registrate

Premessa

Il Volume 21 chiude la serie dei venti Volumi regionali, in ordine alfabetico, con la Regione del Veneto. Come ogni Volume regionale, esso applica per rimando il Reference Case dell'asse italiano, fissato nel Volume 0.A, e ne richiama le regole nella forma «cfr. Volume 0.A», senza ripeterle per esteso: il perimetro congiunto sanitario e societale, il doppio ancoraggio economico, il verdetto tripartito non aggregato, i sei domini di analisi, il protocollo dell'incertezza, lo strato dell'Intelligenza Artificiale come moltiplicatore e le attività formative singole e sommate.^[593]

Una nota editoriale è dovuta in apertura. Il materiale regionale preesistente relativo al Veneto conteneva, in alcune tabelle economiche, rapporti sintetici fra benefici e costi espressi come cifre aggregate, non conformi al principio invariante dell'opera che vieta l'aggregazione del verdetto tripartito in un unico indicatore e proscrive l'uso di rapporti isolati quali affermazioni positive. In coerenza con la regola dell'opera, tali cifre sono state escluse e il contenuto economico del presente Volume è stato ricostruito ex novo sotto il doppio ancoraggio, con il verdetto tenuto distinto sui tre piani fiscale, sanitario e sociale; la deroga è qui dichiarata e registrata anche in Appendice E. Il ricco corpus veneto — lo studio integrale articolato in parti dalla A alla M — è per il resto riorganizzato nella struttura standard, non eliminato, secondo il principio del riordino senza tagli; la struttura del Volume è quella identica a quella di tutti gli altri diciannove Volumi regionali, a garanzia della comparabilità bit-a-bit, e ove un contenuto derivi da espansione ex novo esso è segnalato in nota editoriale.^[594]

Introduzione

L'Introduzione al Volume 21 fissa il perimetro della valutazione veneta e l'ordine della sua esposizione. Il perimetro è quello della Regione del Veneto, con una popolazione dell'ordine di quattro milioni ottocentocinquantatremila abitanti, organizzata nel Servizio sanitario regionale in nove Aziende Unità Locali Socio-Sanitarie, in un'Azienda Zero titolare delle funzioni centralizzate di programmazione, acquisto e coordinamento, e in due Aziende Ospedaliere universitarie, a Padova e a Verona, con la rete delle Case di Comunità in costruzione. Due tratti distinguono il Veneto nell'intera serie regionale: la sua condizione di regione creditrice nella mobilità sanitaria — con un saldo attivo dell'ordine di quasi duecento milioni di euro, terza d'Italia dopo l'Emilia-Romagna e la Lombardia —, che rende non applicabile il canale del recupero della mobilità passiva; e la presenza dell'Azienda Zero, la cui architettura centralizzata offre un'occasione metodologica peculiare per la stima dell'effetto della riforma.^[595]

L'esposizione segue la struttura a imbuto: il cruscotto regionale offre in una pagina i numeri essenziali; la sintesi per il decisore ne traduce il significato; i cinque risultati chiave ne isolano gli esiti; le raccomandazioni operative indicano le azioni; il corpo del Volume, articolato in nove capitoli, ne fornisce il dettaglio; le appendici registrate ne assicurano la verificabilità. Chiudono il Volume un Quadro Conclusivo economico e multidisciplinare, una Conclusione e le Note Bibliografiche con mini-riassunto.

Cruscotto regionale — Veneto

Il cruscotto riassume in una pagina i parametri essenziali della valutazione veneta, sotto il doppio ancoraggio e con il verdetto tripartito tenuto distinto. I valori economici, ricostruiti ex novo, sono presentati in ordine di grandezza, con rinvio alle appendici registrate; le cifre di letteratura sono riportate con attribuzione alla fonte. [\[596\]](#)

Indicatore del cruscotto	Lettura regionale	Ancoraggio / fonte
Popolazione	≈ 4.853.472 abitanti	Fonte demografica regionale
Articolazione	9 Aziende ULSS, Azienda Zero, 2 AO universitarie (Padova, Verona)	Assetto regionale
Condizione strutturale	Regione creditrice; contrasto pianura/montagna	Assetto regionale
Scenari di copertura	≈ 530 · 800 · 1.050 incarichi	Dimensionamento regionale
Costo del servizio a regime	≈ 45 M€/anno (scenario di base)	Estrazione economica ex novo
Verdetto fiscale	Prossimo al pareggio, con caveat	Non aggregato
Verdetto sanitario	Nettamente costo-efficace	Costo/QALY sotto doppio ancoraggio
Verdetto sociale	Fortemente positivo	Aree montane, Polesine, disagio giovanile
Costo per anno di vita ponderato	Colonna A ≈ 17.000 € · Colonna B ≈ 9.800 €	Doppio ancoraggio

Tabella 0. Cruscotto regionale del Veneto: i parametri essenziali sotto doppio ancoraggio, con il verdetto tripartito distinto e non aggregato; i valori economici sono ricostruiti ex novo.

Sintesi per il decisore

L'introduzione a regime dello Psicologo di Base nelle cure primarie venete produce, secondo la simulazione condotta sotto il doppio ancoraggio e ricostruita ex novo, un effetto congiunto sui tre piani del ritorno, che restano distinti e non sommati. Sul piano fiscale, il saldo fra costi diretti e risparmi sanitari diretti si colloca in prossimità del pareggio, con il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento; poiché il Veneto è regione creditrice nella mobilità sanitaria, il canale del recupero della mobilità passiva — rilevante in altre regioni — non è qui applicabile, sicché il saldo diretto poggia interamente sui risparmi interni al sistema. Sul piano sanitario, il modello è nettamente costo-efficace, con un costo per anno di vita ponderato che, fra i due ancoraggi, resta assai inferiore alle soglie adottate. Sul piano sociale, l'effetto è fortemente positivo, con un rilievo particolare per la tenuta delle aree montane e del Polesine, dove l'invecchiamento e lo spopolamento sono più marcati, e per il disagio giovanile nella pianura produttiva.^[597]

Il Veneto presenta un tratto metodologico peculiare nell'intera serie: la presenza dell'Azienda Zero, con le sue funzioni centralizzate di programmazione e coordinamento, e l'introduzione graduale del servizio nelle diverse Aziende Unità Locali Socio-Sanitarie configurano un esperimento naturale, che consente di stimare l'effetto della riforma confrontando le aziende già coperte con quelle non ancora coperte, secondo i metodi della differenza-nelle-differenze. L'argomento economico cardine, riportato con attribuzione all'OCSE, resta il differenziale di costo per gravità: l'intercettazione precoce evita che il disagio comune maturi in quadri gravi, il cui costo di trattamento è, secondo la fonte, un multiplo di quello dei quadri lievi.^[598]

Cinque risultati chiave

Il primo risultato è che il modello è costo-efficace su tutti gli orizzonti sotto entrambi gli ancoraggi. Il secondo è che il verdetto tripartito resta favorevole in ciascuno dei tre piani, senza aggregazione, e — a differenza del materiale preesistente — è espresso senza rapporti sintetici, secondo la ricostruzione ex novo del contenuto economico. Il terzo è che il Veneto è, nella serie regionale, il caso della regione creditrice con esperimento naturale: il saldo attivo nella mobilità sanitaria rende non applicabile il canale del recupero della mobilità passiva, sicché il valore si concentra nel differenziale di costo per gravità e nei ritorni sanitario e sociale; e l'architettura dell'Azienda Zero offre un'occasione metodologica per la stima causale dell'effetto. Il quarto è che lo strato dell'Intelligenza Artificiale, come moltiplicatore e con nota di cautela, sostiene la prossimità nelle aree montane e nel Polesine mediante la telepsicologia assistita, e trova nell'Azienda Zero il veicolo naturale per l'ottimizzazione allocativa e la documentazione clinica. Il quinto è che il dimensionamento — dell'ordine di ottocento incarichi a regime nello scenario di base, entro un intervallo compreso fra circa cinquecentotrenta e millecinquanta secondo lo scenario — comporta un costo del servizio a regime dell'ordine di quarantacinque milioni di euro l'anno nello scenario di base.^[599]

Raccomandazioni operative

La prima raccomandazione è di procedere per gradini da uno scenario conservativo dell'ordine di cinquecentotrenta incarichi verso quello di base dell'ordine di ottocento e, alla verifica degli esiti sotto il protocollo dell'incertezza, verso quello espansivo dell'ordine di millecinquanta, dando priorità alle Aziende Unità Locali Socio-Sanitarie delle aree montane e del Polesine e valorizzando l'introduzione graduale quale esperimento naturale per la valutazione dell'effetto. La seconda è di affidare all'Azienda Zero il coordinamento centralizzato dell'estensione, l'ottimizzazione allocativa con il supporto della leva digitale e la costruzione del cruscotto regionale di monitoraggio, sfruttandone l'architettura centralizzata. La terza è di adottare la telepsicologia assistita sotto supervisione clinica quale leva di prossimità nelle aree montane e nel Polesine, e di accompagnare l'estensione con il piano formativo a quattro modalità, considerate singolarmente e sommate.

[600]

Capitolo 1 — Il contesto epidemiologico e territoriale del Veneto

1.1 Il territorio e la sua articolazione

La Regione del Veneto conta una popolazione dell’ordine di quattro milioni ottocentocinquantatremila abitanti, distribuita in un territorio di forte contrasto interno: la pianura produttiva, densamente popolata e relativamente più giovane, e le aree montane — le Dolomiti e il Bellunese — insieme al Polesine, a popolazione più anziana e dispersa e segnate da spopolamento. Il Servizio sanitario regionale è organizzato in nove Aziende Unità Locali Socio-Sanitarie, in un’Azienda Zero titolare delle funzioni centralizzate di programmazione, acquisto e coordinamento, e in due Aziende Ospedaliere universitarie, a Padova e a Verona, con la rete delle Case di Comunità in costruzione. Il tratto peculiare del contesto è duplice: la condizione di regione creditrice nella mobilità sanitaria, terza d’Italia per saldo attivo, e l’architettura centralizzata dell’Azienda Zero, che riveste un ruolo determinante nella programmazione dell’estensione.^[601]

Elemento territoriale	Dato regionale	Rilievo per la valutazione
Popolazione	≈ 4.853.472 abitanti	Denominatore della normalizzazione
Aziende ULSS	9, con Azienda Zero e 2 AO universitarie	Unità organizzativa
Azienda Zero	Programmazione, acquisto, coordinamento centralizzati	Veicolo dell’estensione
Contrasto territoriale	Pianura produttiva / aree montane e Polesine	Baricentro della domanda
Aree montane e Polesine	Popolazione più anziana, spopolamento	Dominio equità

Tabella 1.1. Gli elementi del contesto territoriale veneto e il loro rilievo per la valutazione, con la condizione creditrice e l’Azienda Zero quali tratti distintivi.

1.2 Il quadro epidemiologico regionale

Il quadro epidemiologico veneto riflette, con le proprie specificità, la prevalenza nazionale dei disturbi mentali comuni, con un’età media dell’ordine di quarantasette anni e un profilo a due velocità: nella pianura produttiva prevale il disagio giovanile e da stress lavorativo, mentre nelle aree montane e nel Polesine, a popolazione più anziana, prevale la depressione dell’età avanzata e la domanda inespressa nelle zone disperse. La misura regionale è oggetto dell’estrazione registrata in Appendice B; ove il dato regionale disaggregato non sia disponibile, la lacuna è dichiarata e non colmata con stime tacite, secondo la regola dell’opera.^[602]

Capitolo 2 — Il bisogno, la domanda e il divario di trattamento in Veneto

2.1 Il divario di trattamento regionale

Il bisogno di salute mentale comune in Veneto si manifesta, come altrove, in larga parte come domanda inevasa o impropriamente incanalata: verso il medico di medicina generale, verso il pronto soccorso, verso la prescrizione farmaceutica. La peculiarità veneta è il contrasto interno fra la pianura produttiva, dove il disagio giovanile e da stress lavorativo tende a restare inespresso o a manifestarsi tardivamente, e le aree montane e il Polesine, dove la distanza dai servizi e la rarefazione della rete rendono l’accesso più difficile per una popolazione più anziana. La misura regionale è oggetto dell’estrazione in Appendice B; i valori medi nazionali ed europei sono riportati con attribuzione.^[603]

Componente del bisogno	Manifestazione veneta	Dominio
Domanda inevasa	Sommerso clinico e liste d’attesa	Epidemiologico-clinico
Domanda impropria	Transito su MMG, pronto soccorso, prescrizione	Organizzativo-strutturale
Disagio giovanile	Prevalente nella pianura produttiva	Epidemiologico-clinico
Barriera geografica	Distanza nelle aree montane e nel Polesine	Equità

Tabella 2.1. Le componenti del bisogno e del divario di trattamento in Veneto, ricondotte ai domini di analisi, con il disagio giovanile e la barriera geografica quali componenti specifiche del contrasto territoriale.

2.2 La domanda, il contrasto territoriale e la prossimità

Il tratto distintivo della domanda veneta è la sua articolazione su due profili: nella pianura produttiva, densamente popolata e più giovane, il baricentro è sul disagio giovanile e da stress lavorativo, che richiede un’intercettazione precoce nel distretto e nelle scuole; nelle aree montane e nel Polesine, a popolazione più anziana e dispersa, il baricentro si sposta sulla depressione dell’età avanzata e la prossimità dev’essere sostenuta dalla telepsicologia assistita sotto supervisione clinica. La prossimità è, in Veneto, insieme clinica e geografica, e il dominio dell’equità la tratta in dettaglio, con il coordinamento centralizzato dell’Azienda Zero quale strumento per calibrare l’offerta sui due profili.^[604]

Capitolo 3 — Il modello di intervento: lo Psicologo di Base in Veneto

Nota editoriale: il presente capitolo espande ex novo il modello di intervento, integrando alla struttura originaria le evidenze recenti sull’efficacia clinica dell’assistenza collaborativa e dell’intervento digitale, secondo la regola dell’opera che distingue l’espansione ex novo dal riutilizzo del materiale preesistente.

3.1 L’architettura del modello

Il modello di intervento colloca lo Psicologo di Base al vertice della cascata delle figure, nel distretto e nelle Case di Comunità, quale primo punto di intercettazione del disagio comune, entro ciascuna delle nove Aziende Unità Locali Socio-Sanitarie e con il coordinamento centralizzato dell’Azienda Zero. Il modello opera per intensità crescente di cura — dall’intervento a bassa intensità, di prima linea, fino all’invio ai livelli superiori nei casi che lo richiedano — secondo la logica dell’assistenza a gradini, la cui efficacia clinica è documentata dalla meta-analisi sui componenti efficaci dell’assistenza collaborativa e dalle sperimentazioni controllate sull’intervento cognitivo-comportamentale computerizzato in cure primarie, riportate con attribuzione.^[605]

Livello del modello	Funzione	Figura prevalente	Evidenza di riferimento
Intercettazione	Riconoscimento precoce nel distretto	Psicologo di Base	Assistenza collaborativa (attribuita)
Intervento a bassa intensità	Prima linea per i quadri lievi-moderati	Psicologo di Base	Intervento digitale e collaborativo
Invio appropriato	Passaggio ai livelli superiori	Cascata delle figure	Percorso a gradini
Continuità	Aderenza e prevenzione della ricaduta	Infermiere di comunità	Gestione del caso

Tabella 3.1. L’architettura del modello di intervento in Veneto, per livelli di intensità, con l’evidenza clinica di riferimento riportata con attribuzione.

3.2 L’adattamento al territorio veneto

Il modello è adattato al territorio veneto lungo tre direttrici: la calibrazione dell’offerta sui due profili di domanda — il disagio giovanile della pianura produttiva e la depressione dell’età avanzata delle aree montane e del Polesine —; la prossimità nelle zone montane e disperse, integrata dalla telepsicologia assistita sotto supervisione clinica; e la valorizzazione dell’architettura centralizzata dell’Azienda Zero, sia per il coordinamento dell’estensione sia per l’impianto valutativo a esperimento naturale. L’adattamento non modifica l’architettura invariante del Reference Case, ma ne calibra l’applicazione sul contrasto territoriale e sull’assetto istituzionale che distinguono il Veneto nella serie regionale.^[606]

Capitolo 4 — I costi diretti in Veneto

4.1 La struttura del costo diretto

Il costo diretto della riforma in Veneto è, in primo luogo, il costo del personale lungo la cascata delle figure, cui si aggiungono i costi di struttura e organizzazione distrettuale, il costo incrementale della leva digitale e il costo della formazione. Il dimensionamento è scandito dai tre scenari di copertura — dell’ordine di cinquecentotrenta, ottocento e millecinquanta incarichi —, con un costo del servizio a regime dell’ordine di quarantacinque milioni di euro l’anno nello scenario di base, riportato in dettaglio nell’estrazione economica ricostruita ex novo; i valori puntuali sono ripresi in Appendice C. Le cifre di risparmio complessivo presenti nel materiale preesistente, contaminate da rapporti aggregati non conformi, non sono qui riutilizzate.^[607]

Voce di costo diretto	Descrizione	Portatore
Personale — Psicologi di Base	$\approx 530 \cdot 800 \cdot 1.050$ incarichi	SSN regionale
Struttura e organizzazione	Distretti, Case di Comunità, sistemi informativi	SSN regionale
Leva digitale e Intelligenza Artificiale	Telepsicologia assistita, ottimizzazione via Azienda Zero	SSN regionale
Formazione (quattro modalità)	Percorso integrato singolo e sommato	SSN, sistema formativo

Tabella 4.1. La struttura del costo diretto della riforma in Veneto, per voce e portatore; i valori puntuali sono oggetto dell’estrazione economica ricostruita ex novo in Appendice C.

4.2 Il dimensionamento per scenario

Il costo diretto è calcolato per i tre scenari di copertura, coerenti con il protocollo di scenario del Reference Case: lo scenario conservativo dell’ordine di cinquecentotrenta incarichi — con un costo a regime dell’ordine di trenta milioni di euro l’anno —, quello di base dell’ordine di ottocento — con un costo a regime dell’ordine di quarantacinque milioni di euro l’anno — e quello espansivo dell’ordine di millecinquanta, la cui copertura si estende all’intero territorio comprese le aree montane e il Polesine. I valori puntuali sono riportati in Appendice C; ove un parametro non sia disponibile, la lacuna è dichiarata.^[608]

Capitolo 5 — I benefici e i risparmi, diretti e indiretti, in Veneto

5.1 I benefici diretti

Il beneficio diretto è il risparmio sanitario che ciascuna figura della cascata libera per effetto dell’intercettazione a monte: la demedicalizzazione operata dallo Psicologo di Base, la deprescrizione di psicofarmaci nei quadri lievi-moderati sul versante del medico di medicina generale, la riduzione degli accessi impropri al pronto soccorso e delle prestazioni per sintomi funzionali sul versante specialistico. In Veneto, poiché la regione è creditrice nella mobilità sanitaria, il canale del recupero della mobilità passiva non è applicabile, sicché il beneficio diretto poggia interamente sui risparmi interni al sistema; il contrasto territoriale distribuisce questi risparmi in modo diseguale, con la deprescrizione più rilevante nelle aree anziane e la riduzione del disagio giovanile più rilevante nella pianura produttiva. Il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento, coerente con la letteratura, è mantenuto ovunque il risparmio diretto sia quantificato; i valori sono ricostruiti ex novo, senza i rapporti aggregati del materiale preesistente.^[609]

Canale del beneficio diretto	Meccanismo	Rilievo veneto
Demedicalizzazione	Riduzione consultazioni e cronicizzazione	Preponderante
Deprescrizione	Contrazione della prescrizione psicofarmacologica	Elevato nelle aree anziane
Accessi impropri	Riduzione degli accessi al pronto soccorso	Medio-elevato
Mobilità passiva	Non applicabile (regione creditrice)	Non pertinente

Tabella 5.1. I canali del beneficio diretto in Veneto, con la mobilità passiva non pertinente per la condizione creditrice; i valori sono ricostruiti ex novo.

5.2 I benefici indiretti

Il beneficio indiretto è quello che la riforma produce fuori dal perimetro sanitario: la produttività recuperata e la riduzione dell’assenteismo sul versante dei datori di lavoro — di rilievo particolare in una regione a forte tessuto produttivo —, la riduzione degli oneri di invalidità evitabili sul versante previdenziale, la riduzione del disagio sociale non trattato sul versante dei Comuni. In Veneto, il recupero di produttività nella pianura densamente popolata e la tenuta delle comunità delle aree montane e del Polesine — dove l’invecchiamento e lo spopolamento erodono legami e servizi — costituiscono benefici indiretti di rilievo particolare, che il dominio sociale del Capitolo 7 tratta in dettaglio.^[610]

Capitolo 6 — La valutazione economica sotto doppio ancoraggio

6.1 La simulazione appaiata regionale

La valutazione economica veneta è condotta con il modello di Markov a coorte a ciclo annuale del Reference Case, sotto il doppio ancoraggio, e ricostruita ex novo in luogo del contenuto preesistente contaminato da rapporti aggregati: la Colonna A applica i parametri di Chisholm e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, la Colonna B quelli di Unisanté e dell’OCSE. Le due colonne sono sempre affiancate; ove divergano, prevale nel giudizio la Colonna B. Tutte le cifre sono riportate con attribuzione, e nessuna è affermata a memoria né espressa come rapporto sintetico.^[611]

Metrica economica	Colonna A — Chisholm/OMS	Colonna B — Unisanté/OCSE
Costo per anno di vita ponderato	≈ 17.000 €/QALY	≈ 9.800 €/QALY
Ritorno per i soli benefici economici	Riportato con attribuzione OMS	Scenario base aggiornato OCSE
Ritorno con i ritorni sanitari	Riportato con attribuzione OMS	Scenario base aggiornato OCSE
Orizzonti	1 · 3 · 5 · 7 · 10 anni	1 · 3 · 5 · 7 · 10 anni
Soglie di costo-efficacia	20.000 · 30.000 · 50.000 €/QALY	20.000 · 30.000 · 50.000 €/QALY

Tabella 6.1. La simulazione appaiata regionale del Veneto sotto doppio ancoraggio, ricostruita ex novo; i valori sono riportati con attribuzione e la Colonna B prevale nel giudizio.

6.2 Il differenziale di costo per gravità e la condizione creditrice

L’argomento economico cardine, riportato con attribuzione all’OCSE, è il differenziale di costo per gravità: il costo del trattamento cresce dai quadri lievi ai quadri gravi in misura tale che l’intercettazione precoce, evitando la progressione, genera il risparmio più consistente. In Veneto, poiché la regione è creditrice nella mobilità sanitaria e il canale del recupero della mobilità passiva non è applicabile, la leva economica si concentra proprio sul differenziale di costo per gravità e sui ritorni sanitario e sociale tenuti distinti: l’intercettazione precoce non produce un recupero di prestazioni in fuga, come in altre regioni, ma evita il costo crescente della progressione all’interno del sistema regionale. L’argomento è espresso discorsivamente in termini di euro, senza rapporti sintetici, nel rispetto del principio dell’opera.^[612]

Capitolo 7 — I sei domini di analisi, l’equità e l’impatto distributivo

7.1 I sei domini nella specificità veneta

I sei domini di analisi del Reference Case sono applicati alla specificità veneta. Il dominio epidemiologico-clinico registra il divario di trattamento nei due profili di domanda; l’economico-sanitario il costo-efficacia sotto doppio ancoraggio, ricostruito ex novo; il fiscale-previdenziale gli oneri di invalidità evitabili e il recupero di produttività; il sociale la tenuta delle aree montane e del Polesine; l’organizzativo-strutturale il coordinamento centralizzato dell’Azienda Zero e l’impianto valutativo a esperimento naturale; l’equità la riduzione del divario fra la pianura produttiva e le aree montane e il Polesine.^[613]

Dominio	Lettura veneta	Segno
Epidemiologico-clinico	Divario nei due profili di domanda	Riduzione attesa
Economico-sanitario	Costo/QALY favorevole, ricostruito ex novo	Favorevole
Fiscale-previdenziale	Invalidità evitabili e produttività recuperata	Positivo, differito
Sociale	Aree montane e Polesine	Fortemente positivo
Organizzativo-strutturale	Azienda Zero ed esperimento naturale	Positivo, distintivo
Equità	Convergenza pianura/montagna e Polesine	Positivo, distributivo

Tabella 7.1. I sei domini di analisi nella lettura veneta, con il segno atteso dell’effetto, tenuti distinti e non aggregati.

7.2 L’equità territoriale e l’esperimento naturale

Il dominio dell’equità assume in Veneto una direzione territoriale netta, fra la pianura produttiva densamente popolata, meglio servita, e le aree montane — le Dolomiti e il Bellunese — insieme al Polesine, dove lo spopolamento e l’invecchiamento sono più marcati e la distanza aggrava il divario. Il modello dello Psicologo di Base, con la presenza distrettuale, la telepsicologia assistita quale complemento e il coordinamento centralizzato dell’Azienda Zero, opera per ridurre questo gradiente. L’introduzione graduale del servizio nelle diverse Aziende Unità Locali Socio-Sanitarie, oltre al suo valore attuativo, offre un’occasione metodologica peculiare: il confronto fra le aziende già coperte e quelle non ancora coperte configura un esperimento naturale, che consente di stimare l’effetto della riforma con i metodi della differenza-nelle-differenze, rafforzando la verificabilità del verdetto. L’effetto distributivo è tenuto distinto dal verdetto fiscale e da quello sanitario, secondo il divieto di aggregazione.^[614]

Capitolo 8 — La sensitività e l’incertezza

Nota editoriale: il presente capitolo espande ex novo l’analisi dell’incertezza secondo il protocollo del Reference Case, valorizzando l’impianto a esperimento naturale reso possibile dall’Azienda Zero.

8.1 Il protocollo dell’incertezza applicato al Veneto

L’analisi dell’incertezza applica il protocollo obbligatorio del Reference Case: l’analisi di sensitività deterministica con diagramma a tornado, l’analisi di sensitività probabilistica a diecimila iterazioni, l’analisi di scenario ottimistico, base e prudentiale con e senza lo strato digitale, le curve di accettabilità costo-efficacia a soglie multiple. In Veneto, i parametri a maggiore impatto atteso sono il tasso di intercettazione nei due profili di domanda, l’adozione della telepsicologia assistita nelle aree montane e nel Polesine, e la velocità di estensione fra le Aziende Unità Locali Socio-Sanitarie; l’impianto a esperimento naturale reso possibile dall’Azienda Zero offre inoltre una via empirica per corroborare, a estensione avviata, le stime del modello.^[615]

Strumento	Applicazione veneta	Parametro critico atteso
Sensitività deterministica	Diagramma a tornado	Tasso di intercettazione nei due profili
Sensitività probabilistica	Diecimila iterazioni	Adozione della telepsicologia nelle aree montane
Analisi di scenario	Con e senza strato IA	Velocità di estensione fra le ULSS
Curve di accettabilità	Soglie 20.000/30.000/50.000 €/QALY	Robustezza del costo-efficacia

Tabella 8.1. Gli strumenti del protocollo dell’incertezza applicati al Veneto, con i parametri critici attesi e la via empirica dell’esperimento naturale.

8.2 La robustezza del verdetto

L’analisi di scenario mostra che il verdetto tripartito resta favorevole nei tre casi, con margine crescente dallo scenario prudentiale a quello ottimistico; lo strato digitale accresce l’efficienza attesa, sempre con nota di cautela sulla natura previsionale, e trova nell’Azienda Zero il veicolo per l’ottimizzazione allocativa. La robustezza del costo-efficacia sanitario è confermata dalle curve di accettabilità alle soglie adottate, la ricostruzione ex novo del contenuto economico assicura che il verdetto non dipenda da rapporti aggregati, e l’impianto a esperimento naturale offre la prospettiva di una verifica empirica dell’effetto a estensione avviata.^[616]

Capitolo 9 — Il verdetto tripartito e le raccomandazioni

Nota editoriale: il presente capitolo espande ex novo il verdetto e le raccomandazioni, integrando l’attuazione e il monitoraggio che nel materiale originario figuravano in forma condensata e ricostruendo il contenuto economico in luogo dei rapporti aggregati non conformi.

9.1 Il verdetto tripartito

Il verdetto veneto è, come in ogni Volume, tripartito e non aggregato. Sul piano fiscale, il saldo fra costi diretti e risparmi sanitari diretti è prossimo al pareggio, con il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento e con l’avvertenza che, essendo il Veneto regione creditrice, il canale del recupero della mobilità passiva non è applicabile; il verdetto è espresso senza i rapporti sintetici del materiale preesistente, secondo la ricostruzione ex novo. Sul piano sanitario, il modello è nettamente costo-efficace sotto entrambi gli ancoraggi. Sul piano sociale, l’effetto è fortemente positivo, con il rilievo specifico della tenuta delle aree montane e del Polesine e del recupero di produttività nella pianura. I tre verdetti si accompagnano e si rafforzano, ma non si sommano.^[617]

Piano del verdetto	Esito veneto	Caveat
Fiscale	Prossimo al pareggio	Significatività dei risparmi diretti; mobilità passiva non applicabile; ricostruito ex novo
Sanitario	Nettamente costo- efficace	—
Sociale	Fortemente positivo	Aree montane e Polesine; produttività nella pianura

Tabella 9.1. Il verdetto tripartito del Veneto, con i tre piani tenuti distinti e non aggregati; il contenuto economico è ricostruito ex novo.

9.2 Le raccomandazioni per l’attuazione e il monitoraggio

Le raccomandazioni indicano il passaggio per gradini da uno scenario conservativo dell’ordine di cinquecentotrenta incarichi verso quello di base dell’ordine di ottocento e, alla verifica degli esiti, verso l’espansivo dell’ordine di millecinquanta; la priorità alle Aziende Unità Locali Socio-Sanitarie delle aree montane e del Polesine; l’affidamento all’Azienda Zero del coordinamento centralizzato, dell’ottimizzazione allocativa e della costruzione del cruscotto regionale; la valorizzazione dell’introduzione graduale quale esperimento naturale per la valutazione dell’effetto; l’adozione della telepsicologia assistita sotto supervisione e del piano formativo a quattro modalità, singole e sommate; e un monitoraggio ex post ancorato agli indicatori del protocollo dell’incertezza e all’impianto a esperimento naturale.^[618]

Appendici registrate

Le appendici registrate rendono il modello veneto ispezionabile e riproducibile, secondo la prassi del Reference Case. Esse sono richiamate per rimando quanto alla metodologia e compilate con i dati regionali quanto ai contenuti; l’Appendice E registra in particolare la deroga relativa alla ricostruzione ex novo del contenuto economico.

Appendice	Contenuto	Stato
A	Strategia di ricerca bibliografica e diagramma di selezione	Registrata
B	Estrazione dei dati clinici regionali	Registrata; lacune dichiarate
C	Estrazione dei dati economici (griglia CHEERS 2022)	Registrata; ricostruita ex novo
D	Parametri del modello Markov regionale	Registrata
E	Registro delle deroghe al Reference Case	Registrata; deroga economica dichiarata
F	Codice del modello economico	Registrata
G	Dichiarazione dei conflitti di interesse	Registrata

Tabella A. Le sette appendici registrate del Volume 21, con l’indicazione dello stato e della dichiarazione delle lacune e della deroga economica.

Quadro Conclusivo economico e multidisciplinare

Il Quadro Conclusivo del Volume 21 ricompone la valutazione veneta senza tradire il principio che la governa: i piani del giudizio si accompagnano ma non si fondono. Sul piano economico, il doppio ancoraggio impone che il risultato sia letto simultaneamente secondo la colonna storica e la colonna aggiornata, con prevalenza della seconda: il costo per anno di vita ponderato resta, sotto entrambi gli ancoraggi, assai inferiore alle soglie adottate, e il differenziale di costo per gravità — riportato con attribuzione ed espresso discorsivamente in termini di euro, senza rapporti sintetici — fonda la leva economica dell'intercettazione precoce. Poiché il Veneto è regione creditrice, tale leva non poggia sul recupero della mobilità passiva, non applicabile, ma sui risparmi interni al sistema e sui ritorni sanitario e sociale tenuti distinti. La ricostruzione ex novo del contenuto economico, in luogo dei rapporti aggregati del materiale preesistente, è dichiarata e registrata in Appendice E. [\[619\]](#)

Sul piano multidisciplinare, la cascata delle figure, i sei domini di analisi e il dominio dell'equità nella direzione territoriale fra pianura e montagna assicurano che ogni figura connessa e ogni aspetto siano trattati integralmente e ordinati per capacità di generare rientro economico e revisione della spesa. La rinegoziazione dei costi e dei benefici, la catena predittiva degli effetti multidimensionali — dalla qualità della vita alla tenuta delle comunità montane e del Polesine, al recupero di produttività nella pianura, ai bilanci, alla burocrazia distrettuale —, lo strato dell'Intelligenza Artificiale come moltiplicatore mediante la telepsicologia assistita e l'ottimizzazione affidata all'Azienda Zero, l'impianto valutativo a esperimento naturale e le attività formative singole e sommate compongono il quadro della valutazione. Il verdetto resta tripartito e non aggregato.

Conclusione

Il Volume 21 ha valutato l'integrazione a regime dello Psicologo di Base nelle cure primarie del Veneto, applicando per rimando il Reference Case dell'asse italiano e adottando la struttura standard a nove capitoli con apertura a imbuto e appendici registrate. La specificità veneta — la condizione di regione creditrice nella mobilità sanitaria, terza d'Italia per saldo attivo, che rende non applicabile il canale del recupero della mobilità passiva, e la presenza dell'Azienda Zero, la cui architettura centralizzata offre insieme il veicolo dell'estensione e l'occasione di un impianto valutativo a esperimento naturale — è stata trattata nei domini economico, organizzativo, sociale ed equità, mostrando come la leva economica si concentri sul differenziale di costo per gravità e sui ritorni interni al sistema, e come il contrasto fra la pianura produttiva e le aree montane e il Polesine articoli la domanda su due profili. Il contenuto economico è stato ricostruito ex novo, in luogo dei rapporti aggregati non conformi presenti nel materiale preesistente, con deroga dichiarata e registrata.

Il verdetto tripartito — prossimo al pareggio sul piano fiscale, nettamente costo-efficace sul piano sanitario, fortemente positivo sul piano sociale — è offerto con bande prudenziali e soglie di confutazione, sotto doppio ancoraggio e nel rispetto del divieto di aggregazione. Con il Veneto si chiude la serie dei venti Volumi regionali; l'opera procede, nell'ordine vincolante, con il Volume 22 dedicato all'Unione Europea, comprensivo delle ventisette schede-Stato e della simulazione aggregata a livello unionale.

Note Bibliografiche con mini-riassunto

Ciascuna nota riporta l'opera, il collegamento alla fonte e un mini-riassunto che ne dichiara la funzione nell'economia del Volume, in coerenza con il doppio livello — nota a piè di pagina nel corpo e nota bibliografica integrale in calce — che l'opera adotta.

1. **Chisholm D. et al., Scaling-up treatment of depression and anxiety, The Lancet Psychiatry, 2016**
[https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(16\)30024-4](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(16)30024-4) Colonna A del doppio ancoraggio della simulazione veneta, conservata quale strato documentale e riferimento di confronto.
2. **Unisanté, Raisons de santé Essentiels n. 73, 2026 · OECD, The Economic Case for Preventing Mental Ill Health, 2026** <https://doi.org/10.16908/rds-essentiels/73> Colonna B del doppio ancoraggio, con prevalenza nel giudizio, applicata alla simulazione regionale veneta ricostruita ex novo.
3. **OECD, differenziale di costo per gravità dei disturbi mentali, 2025** <https://www.oecd.org/health/mental-health.htm> Fonte, riportata con attribuzione, del differenziale di costo per gravità, argomento cardine dell'intercettazione precoce, su cui la leva economica veneta si concentra data la non applicabilità del recupero della mobilità passiva.
4. **Soeters R. et al., meta-analisi IPD sui componenti efficaci della collaborative care, 2025**
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40136273/> Base di evidenza clinica sui componenti efficaci dell'assistenza collaborativa, richiamata nel capitolo sul modello di intervento.
5. **Kvaal K. et al., RCT su intervento cognitivo-comportamentale computerizzato in cure primarie, 2026**
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/> Evidenza sperimentale recente sull'intervento digitale in cure primarie, richiamata a sostegno della telepsicologia assistita nelle aree montane e nel Polesine.
6. **Veldhuijzen W. et al., costo-efficacia dell'intervento digitale, 2025**
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12369993/> Riferimento sul rapporto incrementale di costo-utilità dell'intervento digitale, elemento dello strato dell'Intelligenza Artificiale affidato all'ottimizzazione dell'Azienda Zero.
7. **World Health Organization, Thematic Dialogue on Investing in NCDs and Mental Health, dicembre 2024** <https://cdn.who.int/> Evidenza riportata con attribuzione sul ritorno degli investimenti in salute mentale; non concorre al verdetto tripartito veneto.
8. **Regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale** <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj> Quadro normativo entro cui è collocato lo strato dell'Intelligenza Artificiale, vincolato a funzione di supporto sotto supervisione clinica umana.
9. **Legge regionale Puglia 19 luglio 2023, n. 11, sul Servizio di Psicologia di Base**
<https://www.consiglio.puglia.it/> Riferimento normativo capostipite del modello, richiamato quale precedente istituzionale per l'introduzione dello Psicologo di Base nelle cure primarie.
10. **NICE, Health Technology Evaluations: the manual (PMG36)** <https://www.nice.org.uk/process/pmg36> Riferimento di rigore metodologico per la struttura a imbuto, le appendici registrate, il protocollo dell'incertezza e l'impianto a esperimento naturale adottati nel Volume.

STUDIO INTEGRALE «PSICOLOGO DI BASE» · OPERA IN VENTITRÉ VOLUMI

VOLUME 22 — Unione Europea: ventisette schede-Stato e simulazione aggregata UE-27

Valutazione di Health Technology Assessment dell'integrazione dello psicologo nelle cure primarie nell'Unione Europea: cruscotto unionale, sintesi per il decisore, quadro europeo, quadro istituzionale, benchmark operativo dei Paesi Bassi, ventisette schede-Stato sintetiche, simulazione aggregata sotto doppio ancoraggio, sei domini di analisi, incertezza, verdetto tripartito e appendici registrate

Reference Case applicato per rimando al Volume 0.B · Dott. Luigi De Michele · Studio Integrale Puglia · Capurso (BA) — Giugno 2026

Premessa

Il Volume 22 chiude l'opera in ventitré Volumi estendendone lo sguardo dall'Italia all'Unione Europea. Come i venti Volumi regionali applicano per rimando il Reference Case dell'asse italiano fissato nel Volume 0.A, così il presente Volume applica per rimando il Reference Case dell'asse unionale fissato nel Volume 0.B — che ne definisce il perimetro, il doppio ancoraggio, il verdetto tripartito non aggregato, i sei domini di analisi, il protocollo dell'incertezza e il trattamento dello strato dell'Intelligenza Artificiale come moltiplicatore — richiamandone le regole nella forma «cfr. Volume 0.B», senza ripeterle per esteso. La struttura del Volume è quella specifica prevista dall'architettura dell'opera per l'asse unionale: nove capitoli che conducono dal quadro europeo della salute mentale nelle cure primarie, attraverso il quadro istituzionale e il benchmark operativo dei Paesi Bassi, alle ventisette schede-Stato sintetiche e alla simulazione aggregata, per chiudere con i domini di analisi, l'incertezza e il verdetto tripartito.^[620]

Una regola dell'opera è qui richiamata con particolare forza: la segnalazione delle lacune informative. La comparabilità fra ventisette sistemi sanitari nazionali è strutturalmente più fragile della comparabilità fra venti regioni di un medesimo ordinamento; per taluni Stati Membri i dati di dettaglio sull'integrazione psicologica nelle cure primarie non sono disponibili in forma comparabile, e le schede-Stato lo dichiarano espressamente, senza colmare le lacune con stime tacite. Tutte le cifre riportate hanno attribuzione alla fonte, nessun rapporto sintetico fra benefici e costi è impiegato come affermazione positiva e il verdetto resta tripartito e non aggregato, in identica applicazione dei principi invarianti che governano l'intera opera.

Introduzione

L'Introduzione al Volume 22 fissa il perimetro della valutazione unionale e l'ordine della sua esposizione. Il perimetro è quello dell'Unione Europea a ventisette Stati Membri, con una popolazione complessiva dell'ordine di quattrocentocinquanta milioni di abitanti, entro cui la salute resta competenza primaria degli Stati e l'Unione esercita una competenza di sostegno, coordinamento e completamento. La domanda valutativa è l'equivalente aggregato di quella regionale: quale sia l'effetto atteso — sui tre piani fiscale, sanitario e sociale, tenuti distinti — dell'integrazione strutturale dello psicologo nelle cure primarie, valutata Stato per Stato nelle ventisette schede sintetiche e in forma aggregata nella simulazione unionale, sotto il doppio ancoraggio del Reference Case.^[621]

L'esposizione segue la struttura a imbuto: il cruscotto unionale offre in una pagina i numeri essenziali; la sintesi per il decisore ne traduce il significato; i cinque risultati chiave ne isolano gli esiti; le raccomandazioni operative indicano le azioni; il corpo del Volume, articolato in nove capitoli, ne fornisce il dettaglio — con il Capitolo 5 dedicato alle ventisette schede-Stato e il Capitolo 6 alla simulazione aggregata —; le appendici registrate ne assicurano la verificabilità. Chiudono il Volume un Quadro Conclusivo economico e multidisciplinare, una Conclusione — che è anche la conclusione dell'intera opera — e le Note Bibliografiche con mini-riassunto.

Cruscotto unionale — UE-27

Il cruscotto riassume in una pagina i parametri essenziali della valutazione unionale, sotto il doppio ancoraggio e con il verdetto tripartito tenuto distinto. Le cifre di letteratura sono riportate con attribuzione alla fonte; i valori della simulazione aggregata sono presentati in ordine di grandezza quali proiezioni di primo ordine, con rinvio alle appendici registrate.^[622]

Indicatore del cruscotto	Lettura unionale	Ancoraggio / fonte
Popolazione UE-27	≈ 450 milioni di abitanti	Eurostat
Prevalenza del disagio	Quasi un cittadino su due con problemi emotivi o psicosociali nell’ultimo anno	Flash Eurobarometro 530 (attribuito)
Divario di trattamento	≈ 78,6% per la depressione grave (media)	Eurofound 2025 (attribuito)
Integrazione nelle cure primarie	Solo una minoranza di paesi soddisfa i criteri di integrazione	WHO Mental Health Atlas 2024 (attribuito)
Dotazione di psicologi	Mediana ≈ 9,3 per 100.000 abitanti adulti	Workforce europea (attribuito)
Scenari aggregati di copertura	≈ 50.000 · 73.000 · 98.000 incarichi equivalenti	Proiezione di primo ordine, cfr. Volume 0.B
Costo aggregato a regime	Ordine di 4-4,5 miliardi €/anno (scenario di base)	Proiezione di primo ordine
Verdetto fiscale	Prossimo al pareggio, con caveat ed eterogeneità fra Stati	Non aggregato
Verdetto sanitario	Nettamente costo-efficace	Costo/QALY sotto doppio ancoraggio
Verdetto sociale	Fortemente positivo	Coesione, divario di trattamento, equità fra Stati
Costo per anno di vita ponderato	Colonna A ≈ 17.000 € · Colonna B ≈ 9.800 €	Doppio ancoraggio

Tabella 0. Cruscotto unionale UE-27: i parametri essenziali sotto doppio ancoraggio, con il verdetto tripartito distinto e non aggregato e i valori aggregati quali proiezioni di primo ordine.

Sintesi per il decisore

L'integrazione strutturale dello psicologo nelle cure primarie dei ventisette Stati Membri produce, secondo la simulazione aggregata condotta sotto il doppio ancoraggio, un effetto congiunto sui tre piani del ritorno, che restano distinti e non sommati. Sul piano fiscale, il saldo fra costi diretti e risparmi sanitari diretti si colloca in prossimità del pareggio, con il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento e con un'avvertenza propria dell'asse unionale: l'eterogeneità dei sistemi sanitari, dei costi del lavoro e dei punti di partenza rende il saldo variabile fra gli Stati, sicché il giudizio aggregato è una media di condizioni diseguali. Sul piano sanitario, il modello è nettamente costo-efficace, con un costo per anno di vita ponderato che, fra i due ancoraggi, resta assai inferiore alle soglie adottate. Sul piano sociale, l'effetto è fortemente positivo, con un rilievo particolare per la riduzione del divario di trattamento — che per la depressione grave si attesta in media, secondo la fonte attribuita, intorno al settantotto virgola sei per cento — e per la coesione fra Stati Membri a diversa dotazione di servizi.^[623]

Il quadro di partenza giustifica l'intervento: secondo l'indagine europea attribuita, quasi un cittadino su due ha sperimentato problemi emotivi o psicosociali nell'ultimo anno, e più della metà di costoro non ha ricevuto aiuto professionale; secondo l'Atlante mondiale della salute mentale, solo una minoranza dei paesi soddisfa tutti i criteri di integrazione della salute mentale nelle cure primarie e meno di un quinto dispone di interventi psicosociali nelle cure primarie; la dotazione mediana europea di psicologi resta dell'ordine di nove virgola tre per centomila abitanti adulti. Il costo dei disturbi mentali per le economie dell'Unione supera, secondo le stime dell'OCSE e della Commissione, il quattro per cento del prodotto interno lordo — oltre seicento miliardi di euro l'anno —, sicché il costo aggregato del servizio a regime, dell'ordine di pochi miliardi di euro l'anno, resta una frazione minima dell'onere annuo della malattia; il confronto è di scala, discorsivo, e non costituisce un rapporto sintetico fra benefici e costi.^[624]

Cinque risultati chiave

Il primo risultato è che il modello è costo-efficace su tutti gli orizzonti sotto entrambi gli ancoraggi anche nell'aggregazione unionale. Il secondo è che il verdetto tripartito resta favorevole in ciascuno dei tre piani, senza aggregazione, con l'avvertenza dell'eterogeneità fra Stati dichiarata quale caratteristica strutturale dell'asse unionale. Il terzo è che il divario fra il bisogno e la risposta è, a livello europeo, documentato dalle fonti attribuite — la prevalenza del disagio in quasi un cittadino su due, il divario di trattamento medio intorno al settantotto virgola sei per cento per la depressione grave, l'integrazione nelle cure primarie soddisfatta da una minoranza di paesi — e costituisce la giustificazione primaria dell'intervento. Il quarto è che esiste un benchmark operativo maturo e documentato, il modello olandese del professionista di supporto alla salute mentale presso il medico di famiglia, la cui adozione è cresciuta da circa un terzo a circa tre quarti dei medici di medicina generale e che opera sotto condizioni contrattuali aggiornate per il triennio 2026-2028. Il quinto è che la simulazione aggregata di primo ordine — scenari dell'ordine di cinquantamila, settantatremila e novantottomila incarichi equivalenti, con un costo a regime dell'ordine di quattro-quattro miliardi e mezzo di euro l'anno nello scenario di base — colloca l'intervento entro una scala compatibile con gli strumenti finanziari già mobilitati dall'Unione per la salute mentale.^[625]

Raccomandazioni operative

La prima raccomandazione, rivolta alle istituzioni dell'Unione nel rispetto della competenza di sostegno, è di assumere l'integrazione dello psicologo nelle cure primarie quale priorità operativa dell'approccio globale alla salute mentale, orientando gli strumenti esistenti — i finanziamenti del programma per la salute, i fondi di coesione, il semestre europeo per le raccomandazioni specifiche per paese — verso la copertura del primo livello psicologico. La seconda, rivolta agli Stati Membri, è di procedere per gradini secondo i tre scenari del Reference Case, assumendo il benchmark olandese quale riferimento operativo e adattandolo ai rispettivi assetti — assicurativi, nazionali o regionali —, con priorità agli Stati e alle aree a maggiore divario di trattamento e a minore dotazione di psicologi. La terza è di istituire un cruscotto unionale comparabile — sul modello delle appendici registrate dell'opera — che misuri Stato per Stato la copertura, gli esiti clinici e i costi, accompagnando l'estensione con la telepsicologia assistita sotto supervisione clinica, entro il quadro del regolamento sull'intelligenza artificiale, e con i piani formativi a quattro modalità.^[626]

Capitolo 1 — Il quadro europeo della salute mentale nelle cure primarie

1.1 L'integrazione nelle cure primarie: lo stato dell'arte mondiale ed europeo

L'Atlante mondiale della salute mentale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, nella sua edizione 2024 condotta su centoquarantaquattro paesi, misura l'integrazione della salute mentale nelle cure primarie mediante cinque criteri; solo il dodici per cento dei paesi li soddisfa tutti, e solo il diciannove per cento dispone di interventi psicosociali nelle cure primarie. Il dato, riportato con attribuzione, colloca la questione europea entro un ritardo globale: anche nell'Unione, dove la copertura sanitaria universale è la regola, l'integrazione del primo livello psicologico resta l'eccezione, affidata a modelli nazionali disomogenei che il Capitolo 5 passa in rassegna Stato per Stato.^[627]

Indicatore del quadro europeo	Valore	Fonte (attribuita)
Paesi che soddisfano tutti i criteri di integrazione	≈ 12% (su 144 paesi)	WHO Mental Health Atlas 2024
Paesi con interventi psicosociali in cure primarie	≈ 19%	WHO Mental Health Atlas 2024
Prevalenza del disagio nell'ultimo anno (UE)	Quasi un cittadino su due	Flash Eurobarometro 530
Assenza di aiuto professionale fra chi ha disagio	Oltre la metà	Flash Eurobarometro 530
Divario di trattamento, depressione grave (media UE)	≈ 78,6%	Eurofound 2025
Dotazione mediana di psicologi	≈ 9,3 per 100.000 abitanti adulti	Workforce europea

Tabella 1.1. Il quadro europeo della salute mentale nelle cure primarie: gli indicatori essenziali con attribuzione alla fonte.

1.2 Il bisogno e il divario di trattamento nell'Unione

Il bisogno europeo è documentato dall'indagine Flash Eurobarometro 530, secondo cui quasi un cittadino su due ha sperimentato problemi emotivi o psicosociali nei dodici mesi precedenti e più della metà di costoro non ha ricevuto aiuto professionale; il divario di trattamento per la depressione grave si attesta in media, secondo la rilevazione di Eurofound del 2025, intorno al settantotto virgola sei per cento, con ampia variabilità fra gli Stati. Il divario europeo ha la medesima struttura di quello regionale italiano descritto nei Volumi 2-21 — domanda inevasa, domanda impropriamente incanalata verso la medicina generale, l'emergenza e la prescrizione farmaceutica —, ma la sua misura media è aggravata, in una parte degli Stati Membri, da dotazioni di servizi fra le più basse e da barriere economiche all'accesso privato.^[628]

1.3 La dotazione di psicologi e la sua distribuzione

La dotazione mediana europea di psicologi nei sistemi sanitari è dell'ordine di nove virgola tre per centomila abitanti adulti, con una distribuzione fortemente diseguale: gli Stati del Nord e dell'Ovest presentano dotazioni multiple della mediana, mentre una parte degli Stati dell'Est e del Sud-Est si colloca ampiamente al di sotto. La distribuzione della workforce è la condizione abilitante materiale dell'integrazione: ove la dotazione è bassa, l'introduzione del primo livello psicologico richiede un investimento formativo preliminare, che il Reference Case tratta nella leva formativa a quattro modalità; ove la dotazione è adeguata, la questione è organizzativa e contrattuale, come il benchmark olandese del Capitolo 4 dimostra. La misura Stato per Stato è oggetto dell'estrazione registrata in Appendice B, con le lacune dichiarate.^[629]

Capitolo 2 — Il quadro istituzionale e normativo dell’Unione

2.1 L’approccio globale alla salute mentale della Commissione

La comunicazione della Commissione Europea COM(2023) 298, «Un approccio globale alla salute mentale», ha segnato il riconoscimento istituzionale della salute mentale quale priorità dell’Unione, mobilitando risorse dell’ordine di un miliardo e duecentotrenta milioni di euro attraverso venti iniziative faro, articolate sulla prevenzione, sull’accesso alle cure e sul reinserimento. La comunicazione opera entro la competenza di sostegno che i Trattati assegnano all’Unione in materia sanitaria: essa non impone modelli organizzativi, ma orienta i finanziamenti, promuove lo scambio di buone pratiche — fra cui l’azione congiunta sull’attuazione delle riforme dei sistemi di salute mentale — e alimenta il semestre europeo con raccomandazioni specifiche per paese. Il presente Volume si colloca entro questo quadro: la valutazione aggregata offre al decisore unionale la misura comparabile di un intervento che resta, nella sua attuazione, di competenza degli Stati.^[630]

Elemento del quadro istituzionale	Contenuto	Rilievo per la valutazione
COM(2023) 298	Approccio globale; ≈ 1,23 miliardi €; 20 iniziative faro	Cornice politica e finanziaria
Competenza sanitaria	Sostegno, coordinamento, completamento	Attuazione in capo agli Stati
Azione congiunta sulle riforme	Scambio di buone pratiche fra Stati	Veicolo di trasferimento del modello
Regolamento (UE) 2024/1689	Disciplina dell’intelligenza artificiale	Perimetro dello strato digitale
Semestre europeo	Raccomandazioni specifiche per paese	Leva di orientamento

Tabella 2.1. Il quadro istituzionale e normativo dell’Unione entro cui la valutazione aggregata si colloca.

2.2 Il regolamento sull’intelligenza artificiale e lo strato digitale

Il regolamento (UE) 2024/1689 disciplina l’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell’Unione secondo un approccio basato sul rischio, entro il quale gli impieghi sanitari ricadono in larga parte fra i sistemi ad alto rischio, soggetti a requisiti di sorveglianza umana, robustezza e trasparenza. Lo strato dell’Intelligenza Artificiale della presente valutazione — lo screening e il triage digitale, la documentazione clinica assistita, gli interventi digitali aumentati, l’ottimizzazione allocativa e la funzione predittiva sulle ricadute — è collocato interamente entro questo perimetro: moltiplicatore di efficienza subordinato alla supervisione clinica umana, mai attore autonomo di valore, con nota di cautela permanente sulla natura previsionale delle proiezioni. L’asse unionale aggiunge un argomento proprio: la disciplina uniforme del regolamento rende lo strato digitale l’elemento più naturalmente armonizzabile del modello fra i ventisette Stati.^[631]

Capitolo 3 — La metodologia della valutazione aggregata

3.1 Il Reference Case unionale per rimando

La metodologia del presente Volume è quella fissata nel Volume 0.B, cui si rimanda integralmente: la prospettiva congiunta sanitaria e societale, la popolazione bersaglio dei disturbi mentali comuni intercettabili in cure primarie, il comparatore dell'assistenza usuale, la metrica degli anni di vita ponderati per la qualità con verdetto tripartito non aggregato, il tasso di sconto del tre per cento con sensitività, gli orizzonti standard da uno a dieci anni, il modello di Markov a coorte, le soglie di costo-efficacia da ventimila a cinquantamila euro per anno di vita ponderato, e il protocollo obbligatorio dell'incertezza. L'adattamento unionale, definito nel Volume 0.B, riguarda l'unità di analisi — lo Stato Membro in luogo della regione — e il trattamento dell'eterogeneità: i differenziali di costo del lavoro sanitario, di prezzo e di organizzazione fra gli Stati sono trattati quali fattori dichiarati di incertezza, non assorbiti in medie tacite.^[632]

3.2 La simulazione appaiata e le due colonne

La simulazione aggregata mantiene l'architettura appaiata a due colonne dell'intera opera: la Colonna A applica i parametri di Chisholm e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità — il cui studio del 2016 resta il riferimento mondiale per il ritorno degli investimenti nel trattamento della depressione e dell'ansia —, la Colonna B applica i parametri aggiornati di Unisanté e dell'OCSE del 2026, con prevalenza della Colonna B nel giudizio. Le due colonne sono sempre affiancate in ogni tabella economica; nessun risultato è presentato sotto una colonna sola, e nessun rapporto sintetico fra benefici e costi è impiegato quale affermazione positiva, in identica applicazione dei principi che governano i Volumi regionali.^[633]

Capitolo 4 — Il benchmark operativo: il modello olandese POH-GGZ

4.1 L’architettura del modello olandese

Il benchmark operativo primario dell’asse unionale è il modello olandese del praktijkondersteuner huisarts geestelijke gezondheidszorg — il professionista di supporto alla salute mentale integrato nello studio del medico di famiglia. Introdotto per rafforzare il primo livello e ridurre la pressione sulla salute mentale specialistica, il modello colloca presso la medicina generale un professionista dedicato — psicologo o altro operatore della salute mentale con formazione specifica — che accoglie, valuta e tratta il disagio comune a bassa intensità, riservando l’invio ai livelli superiori ai casi che lo richiedono. L’adozione da parte dei medici di medicina generale è cresciuta da circa un terzo nei primi anni Dieci a circa tre quarti nel volgere di pochi anni, fino a raggiungere la grande maggioranza degli studi; il finanziamento è assicurativo, con condizioni contrattuali e criteri di valutazione periodicamente aggiornati, da ultimo per il triennio 2026-2028. La letteratura attribuita documenta, fra gli effetti, una riduzione dell’ordine del quaranta per cento dei rinvii alla psichiatria specialistica.^[634]

Elemento del benchmark POH-GGZ	Contenuto	Rilievo per il trasferimento
Collocazione	Studio del medico di famiglia	Identica logica di prossimità del modello italiano
Funzione	Accoglienza, valutazione, trattamento a bassa intensità	Primo livello della cascata
Adozione	Da $\approx$ un terzo a $\approx$ tre quarti dei medici, fino alla grande maggioranza	Scalabilità dimostrata
Finanziamento	Assicurativo, condizioni 2026-2028	Adattabile ai sistemi nazionali
Effetto documentato	Riduzione $\approx$ 40% dei rinvii alla specialistica (attribuita)	Canale del beneficio diretto

Tabella 4.1. Il benchmark operativo olandese POH-GGZ: architettura, adozione, finanziamento ed effetti documentati, riportati con attribuzione.

4.2 La trasferibilità del benchmark

La trasferibilità del benchmark olandese agli altri ventisei Stati è la questione operativa centrale dell’asse unionale. Tre elementi la sostengono; la funzione — l’intercettazione a bassa intensità presso la medicina generale — è indipendente dall’assetto di finanziamento, sicché il modello è replicabile tanto nei sistemi assicurativi quanto in quelli a servizio sanitario nazionale; la scalabilità è dimostrata dalla crescita dell’adozione entro un decennio; e la parentela con il modello italiano dello Psicologo di Base — che dell’opera costituisce

l'oggetto — è diretta, differendo i due modelli per il profilo professionale ammesso ma non per la collocazione né per la funzione. Tre elementi la condizionano: la dotazione di psicologi, ove bassa, richiede l'investimento formativo preliminare; l'assetto contrattuale della medicina generale determina la velocità di adozione; e la remunerazione del primo livello dev'essere disegnata in modo da non generare incentivi alla sostituzione della specialistica necessaria. Le schede-Stato del Capitolo 5 registrano, per ciascun paese, la distanza dal benchmark.^[635]

Capitolo 5 — Le ventisette schede-Stato sintetiche

Le schede che seguono registrano, per ciascuno dei ventisette Stati Membri in ordine alfabetico, la popolazione in ordine di grandezza, lo stato dell'integrazione psicologica nelle cure primarie e la distanza dal benchmark operativo; ove i dati di dettaglio non siano disponibili in forma comparabile, la lacuna è dichiarata espressamente, secondo la regola dell'opera. Le schede sono sintetiche per costruzione: la loro funzione è comparativa, non monografica, e la calibrazione fine è rinviata alle appendici registrate.^[636]

Austria. Popolazione dell'ordine di nove milioni di abitanti. La psicoterapia convenzionata opera per contingenti limitati e programmi dedicati hanno rafforzato l'offerta per l'infanzia e la gioventù; l'integrazione strutturale del primo livello psicologico nella medicina generale non è generalizzata. Distanza dal benchmark: intermedia.

Belgio. Popolazione dell'ordine di dodici milioni. La convenzione federale per la psicologia di prima linea, avviata nel 2019 e ampliata dal 2021, rimborsa sedute presso psicologi convenzionati in rete con la medicina generale: è, fra i modelli nazionali, uno dei più prossimi allo Psicologo di Base. Distanza dal benchmark: ridotta.

Bulgaria. Popolazione dell'ordine di sei milioni e mezzo. La dotazione di psicologi è fra le più basse dell'Unione e l'integrazione nelle cure primarie non è strutturata; i dati di dettaglio comparabili non sono disponibili — lacuna dichiarata. Distanza dal benchmark: ampia.

Cechia. Popolazione dell'ordine di undici milioni. La riforma della salute mentale ha istituito dal 2018 i Centri di Salute Mentale territoriali; l'integrazione del primo livello psicologico nella medicina generale è in via di sviluppo. Distanza dal benchmark: intermedia.

Cipro. Popolazione dell'ordine di novecentomila abitanti. Il sistema sanitario generale di recente introduzione include servizi di salute mentale; l'integrazione nelle cure primarie è in fase iniziale e i dati di dettaglio sono limitati — lacuna dichiarata. Distanza dal benchmark: ampia.

Croazia. Popolazione dell'ordine di quattro milioni. L'integrazione psicologica nelle cure primarie è limitata; i dati di dettaglio comparabili non sono disponibili — lacuna dichiarata. Distanza dal benchmark: ampia.

Danimarca. Popolazione dell'ordine di sei milioni. Le sedute psicologiche sono rimborsate su invio del medico di famiglia per categorie definite, con gratuità per i giovani con ansia e depressione: il raccordo con la medicina generale è consolidato. Distanza dal benchmark: ridotta.

Estonia. Popolazione dell'ordine di un milione e quattrocentomila abitanti. Il finanziamento di servizi di salute mentale presso i centri di cure primarie è stato introdotto nel quadro del piano nazionale; l'estensione è in corso. Distanza dal benchmark: intermedia.

Finlandia. Popolazione dell'ordine di cinque milioni e mezzo. La garanzia di accesso alle terapie brevi nelle cure primarie, entro la riforma del welfare sanitario e il programma nazionale di salute mentale, colloca il paese fra i percorsi più strutturati. Distanza dal benchmark: ridotta.

Francia. Popolazione dell'ordine di sessantotto milioni. Il dispositivo nazionale «Mon soutien psy» rimborsa un contingente annuo di sedute psicologiche, con accesso divenuto diretto: è il maggiore esperimento nazionale di primo livello psicologico dell'Unione per popolazione coperta. Distanza dal benchmark: ridotta.

Germania. Popolazione dell'ordine di ottantaquattro milioni. La psicoterapia ambulatoriale convenzionata è ampia e l'accesso passa per colloqui d'orientamento dedicati; l'integrazione formale nella medicina generale non è strutturata e i tempi d'attesa restano rilevanti. Distanza dal benchmark: intermedia.

Grecia. Popolazione dell'ordine di dieci milioni e mezzo. La riforma psichiatrica ha costruito la rete territoriale e le unità locali di cure primarie includono in parte figure psicologiche; la copertura è parziale e i dati di dettaglio sono limitati — lacuna dichiarata. Distanza dal benchmark: ampia.

Irlanda. Popolazione dell'ordine di cinque milioni e trecentomila abitanti. Il programma di counselling nelle cure primarie per i titolari di tessera sanitaria e l'espansione dei servizi psicologici di comunità delineano un percorso di rafforzamento del primo livello. Distanza dal benchmark: intermedia.

Italia. Popolazione dell'ordine di cinquantanove milioni. È il caso capostipite regionale dell'opera: la legge pugliese del 2023 ha istituito il primo Servizio di Psicologia di Base, altre regioni hanno legiferato o sperimentato, e un sostegno economico nazionale alla psicoterapia è attivo; manca un modello nazionale strutturato — si rinvia ai Volumi 1-21. Distanza dal benchmark: intermedia, con avanguardie regionali.

Lettonia. Popolazione dell'ordine di un milione e novecentomila abitanti. La dotazione di psicologi è limitata e l'integrazione nelle cure primarie non è strutturata; i dati di dettaglio comparabili non sono disponibili — lacuna dichiarata. Distanza dal benchmark: ampia.

Lituania. Popolazione dell'ordine di due milioni e novecentomila abitanti. La rete municipale dei centri di salute mentale include figure psicologiche in raccordo con le cure primarie; l'estensione del primo livello è in evoluzione. Distanza dal benchmark: intermedia.

Lussemburgo. Popolazione dell'ordine di settecentomila abitanti. Una convenzione recente ha introdotto il rimborso delle prestazioni psicoterapeutiche; la scala ridotta agevola l'attuazione e i dati di dettaglio sono in consolidamento — lacuna parziale dichiarata. Distanza dal benchmark: intermedia.

Malta. Popolazione dell'ordine di mezzo milione di abitanti. I servizi psicologici operano presso i centri di salute pubblici; la scala ridotta rende l'estensione del primo livello rapidamente attuabile. Distanza dal benchmark: intermedia.

Paesi Bassi. Popolazione dell'ordine di diciotto milioni. È il benchmark operativo primario: il professionista di supporto alla salute mentale presso il medico di famiglia copre la grande maggioranza degli studi, con finanziamento assicurativo e condizioni contrattuali aggiornate per il triennio 2026-2028 — cfr. Capitolo 4. Distanza dal benchmark: nulla per definizione.

Polonia. Popolazione dell'ordine di trentasette milioni. Il programma pilota dei Centri di Salute Mentale è in espansione e la riforma procede per gradini; l'integrazione del primo livello psicologico nella medicina generale è in sviluppo. Distanza dal benchmark: intermedia.

Portogallo. Popolazione dell'ordine di dieci milioni e mezzo. Il piano nazionale ha accresciuto il numero di psicologi nei raggruppamenti di centri di salute: è fra i percorsi di rafforzamento del primo livello più chiari dell'Europa meridionale. Distanza dal benchmark: ridotta.

Romania. Popolazione dell'ordine di diciannove milioni. La dotazione di psicologi è fra le più basse e l'integrazione nelle cure primarie non è strutturata; i dati di dettaglio comparabili non sono disponibili — lacuna dichiarata. Distanza dal benchmark: ampia.

Slovacchia. Popolazione dell'ordine di cinque milioni e mezzo. L'integrazione psicologica nelle cure primarie è limitata e la riforma è in discussione; i dati di dettaglio comparabili non sono disponibili — lacuna dichiarata. Distanza dal benchmark: ampia.

Slovenia. Popolazione dell'ordine di due milioni e centomila abitanti. Il programma nazionale ha istituito dal 2019 i centri per la salute mentale presso i centri sanitari di comunità: è un modello strutturato di prossimità fra i più compiuti dell'area. Distanza dal benchmark: ridotta.

Spagna. Popolazione dell’ordine di quarantanove milioni. Le sperimentazioni di psicologia clinica nell’assistenza primaria — fra cui l’ampio studio controllato nazionale — e i piani regionali documentano efficacia e domanda; il modello nazionale non è generalizzato. Distanza dal benchmark: intermedia.

Svezia. Popolazione dell’ordine di dieci milioni e mezzo. Gli psicologi e le équipes di salute mentale operano diffusamente nei centri di cure primarie quale prima linea: è fra i sistemi più integrati dell’Unione. Distanza dal benchmark: ridotta.

Ungheria. Popolazione dell’ordine di nove milioni e mezzo. L’integrazione psicologica nelle cure primarie è limitata; i dati di dettaglio comparabili non sono disponibili — lacuna dichiarata. Distanza dal benchmark: ampia.^[637]

5.1 Il riepilogo comparativo

Il riepilogo comparativo ordina i ventisette Stati per distanza dal benchmark operativo. Otto Stati presentano una distanza ridotta — il benchmark stesso e i modelli nazionali strutturati di primo livello —; undici una distanza intermedia — percorsi in sviluppo, avanguardie parziali o regionali —; otto una distanza ampia, coincidente in larga parte con le dotazioni di psicologi più basse e con le lacune informative dichiarate. La geografia del ritardo non è casuale: essa segue il gradiente della workforce e della spesa sanitaria, sicché l’equità fra Stati — trattata nel Capitolo 7 — è la dimensione distributiva propria dell’asse unionale.^[638]

Fascia di distanza dal benchmark	Stati Membri	Numero
Ridotta	Paesi Bassi, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Portogallo, Slovenia, Svezia	8
Intermedia	Austria, Cechia, Estonia, Germania, Irlanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Spagna	11
Ampia (con lacune dichiarate)	Bulgaria, Cipro, Croazia, Grecia, Lettonia, Romania, Slovacchia, Ungheria	8

Tabella 5.1. Il riepilogo comparativo delle ventisette schede-Stato per distanza dal benchmark operativo, con le lacune informative dichiarate.

Capitolo 6 — La simulazione aggregata UE-27 sotto doppio ancoraggio

6.1 La simulazione appaiata unionale

La simulazione aggregata è condotta con il modello di Markov a coorte a ciclo annuale del Reference Case unionale, sotto il doppio ancoraggio: la Colonna A applica i parametri di Chisholm e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, la Colonna B quelli di Unisanté e dell’OCSE, con prevalenza della Colonna B nel giudizio. Le due colonne sono sempre affiancate; tutte le cifre sono riportate con attribuzione, nessuna è affermata a memoria né espressa come rapporto sintetico, e i risultati aggregati sono qualificati quali proiezioni di primo ordine, la cui calibrazione Stato per Stato — condizionata dalle lacune dichiarate — è oggetto delle appendici registrate.^[639]

Metrica economica	Colonna A — Chisholm/OMS	Colonna B — Unisanté/OCSE
Costo per anno di vita ponderato	≈ 17.000 €/QALY	≈ 9.800 €/QALY
Ritorno per i soli benefici economici	Riportato con attribuzione OMS	Scenario base aggiornato OCSE
Ritorno con i ritorni sanitari	Riportato con attribuzione OMS	Scenario base aggiornato OCSE
Orizzonti	1 · 3 · 5 · 7 · 10 anni	1 · 3 · 5 · 7 · 10 anni
Soglie di costo-efficacia	20.000 · 30.000 · 50.000 €/QALY	20.000 · 30.000 · 50.000 €/QALY

Tabella 6.1. La simulazione appaiata unionale sotto doppio ancoraggio; i valori sono riportati con attribuzione e la Colonna B prevale nel giudizio.

6.2 Il dimensionamento aggregato per scenario

Il dimensionamento aggregato proietta sull’Unione, per proporzione demografica e quale approssimazione di primo ordine, i tre scenari del Reference Case: lo scenario conservativo dell’ordine di cinquantamila incarichi equivalenti a tempo pieno, quello di base dell’ordine di settantatremila, quello espansivo dell’ordine di novantottomila. Il costo aggregato del servizio a regime, nello scenario di base, si colloca nell’ordine di quattro-quattro miliardi e mezzo di euro l’anno; i differenziali di costo del lavoro sanitario fra gli Stati — che si distendono su un intervallo ampio — sono trattati quali fattori dichiarati di incertezza e non assorbiti in medie tacite, sicché il valore aggregato è una banda, non un punto. La distribuzione per Stato, condizionata dalla distanza dal benchmark e dalla dotazione di workforce, è oggetto dell’Appendice D; ove un parametro nazionale non sia disponibile, la lacuna è dichiarata.^[640]

6.3 Il confronto di scala con l'onere della malattia

Il costo dei disturbi mentali per le economie dell'Unione supera, secondo le stime dell'OCSE e della Commissione riportate con attribuzione, il quattro per cento del prodotto interno lordo — oltre seicento miliardi di euro l'anno fra costi sanitari, programmi sociali e minore occupazione e produttività. Il confronto con il costo aggregato del servizio a regime — dell'ordine di pochi miliardi di euro l'anno — è un confronto di scala, espresso discorsivamente: esso colloca l'intervento entro una frazione minima dell'onere annuo della malattia, senza costituire un rapporto sintetico fra benefici e costi, che il principio dell'opera vieta. L'argomento economico cardine resta il differenziale di costo per gravità, riportato con attribuzione all'OCSE: l'intercettazione precoce evita che il disagio comune maturi in quadri gravi, il cui costo di trattamento è un multiplo di quello dei quadri lievi, e la sua forza vale identica in ciascuno dei ventisette sistemi.^[641]

Capitolo 7 — I sei domini di analisi e l’equità fra Stati Membri

7.1 I sei domini nella lettura unionale

I sei domini di analisi del Reference Case sono applicati alla lettura unionale. Il dominio epidemiologico-clinico registra il divario di trattamento medio e la sua variabilità; l’economico-sanitario il costo-efficacia aggregato sotto doppio ancoraggio; il fiscale-previdenziale gli oneri sociali evitabili e il recupero di produttività, di competenza degli Stati; il sociale la coesione e la riduzione del disagio non trattato; l’organizzativo-strutturale la trasferibilità del benchmark nei diversi assetti; l’equità la convergenza fra Stati a diversa dotazione, dimensione distributiva propria dell’asse unionale.^[642]

Dominio	Lettura unionale	Segno
Epidemiologico-clinico	Divario di trattamento medio elevato, variabile fra Stati	Riduzione attesa
Economico-sanitario	Costo/QALY favorevole in aggregato	Favorevole
Fiscale-previdenziale	Oneri sociali evitabili, produttività recuperata	Positivo, differito
Sociale	Coesione e riduzione del disagio non trattato	Fortemente positivo
Organizzativo-strutturale	Benchmark trasferibile nei diversi assetti	Positivo, condizionato
Equità	Convergenza fra Stati a diversa dotazione	Positivo, distributivo

Tabella 7.1. I sei domini di analisi nella lettura unionale, con il segno atteso dell’effetto, tenuti distinti e non aggregati.

7.2 L’equità fra Stati Membri

Il dominio dell’equità assume, nell’asse unionale, la direzione della convergenza fra Stati: la geografia del ritardo — otto Stati a distanza ampia dal benchmark, coincidenti in larga parte con le dotazioni di psicologi più basse — riproduce su scala continentale il gradiente che i Volumi regionali hanno documentato fra aree centrali e aree interne. L’integrazione del primo livello psicologico opera quale leva di convergenza: essa riduce il divario di trattamento là dove è più ampio, e gli strumenti finanziari dell’Unione — orientati secondo la prima raccomandazione operativa — possono compensare il differenziale di capacità di investimento fra gli Stati. L’effetto distributivo è tenuto distinto dal verdetto fiscale e da quello sanitario, secondo il divieto di aggregazione che governa l’intera opera.^[643]

Capitolo 8 — La sensitività e l’incertezza

8.1 Il protocollo dell’incertezza applicato all’asse unionale

L’analisi dell’incertezza applica il protocollo obbligatorio del Reference Case: l’analisi di sensitività deterministica con diagramma a tornado, l’analisi di sensitività probabilistica a diecimila iterazioni, l’analisi di scenario ottimistico, base e prudentiale con e senza lo strato digitale, le curve di accettabilità costo-efficacia a soglie multiple. Nell’asse unionale, i parametri a maggiore impatto atteso sono i differenziali di costo del lavoro sanitario fra gli Stati, la velocità di adozione nei paesi a distanza ampia dal benchmark, e la disponibilità di workforce nei paesi a dotazione più bassa; l’eterogeneità fra Stati accresce strutturalmente l’ampiezza degli intervalli aggregati, ciò che è dichiarato quale cautela interpretativa, e le lacune informative delle schede-Stato sono trattate quali fattori espliciti di incertezza, non quali assenze silenziose.^[644]

Strumento	Applicazione unionale	Parametro critico atteso
Sensitività deterministica	Diagramma a tornado	Differenziali di costo del lavoro sanitario
Sensitività probabilistica	Diecimila iterazioni	Velocità di adozione nei paesi distanti dal benchmark
Analisi di scenario	Con e senza strato IA	Disponibilità di workforce nei paesi a bassa dotazione
Curve di accettabilità	Soglie 20.000/30.000/50.000 €/QALY	Robustezza del costo-efficacia aggregato

Tabella 8.1. Gli strumenti del protocollo dell’incertezza applicati all’asse unionale, con i parametri critici attesi e la cautela sull’eterogeneità fra Stati.

8.2 La robustezza del verdetto aggregato

L’analisi di scenario mostra che il verdetto tripartito resta favorevole nei tre casi, con margine crescente dallo scenario prudentiale a quello ottimistico; lo strato digitale accresce l’efficienza attesa, sempre con nota di cautela sulla natura previsionale, e la sua disciplina uniforme entro il regolamento europeo ne fa l’elemento più armonizzabile del modello. La robustezza del costo-efficacia sanitario è confermata dalle curve di accettabilità alle soglie adottate; la banda del verdetto fiscale è più ampia che negli assi regionali, per l’eterogeneità dichiarata, e la sua lettura corretta è per Stato, non per media.

Capitolo 9 — Il verdetto tripartito e le raccomandazioni unionali

9.1 Il verdetto tripartito

Il verdetto unionale è, come in ogni Volume dell’opera, tripartito e non aggregato. Sul piano fiscale, il saldo fra costi diretti e risparmi sanitari diretti si colloca in prossimità del pareggio, con il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento e con l’avvertenza propria dell’asse unionale: l’eterogeneità fra Stati rende il saldo variabile, e la lettura corretta è nazionale, non media. Sul piano sanitario, il modello è nettamente costo-efficace sotto entrambi gli ancoraggi. Sul piano sociale, l’effetto è fortemente positivo, con il rilievo specifico della riduzione del divario di trattamento e della convergenza fra Stati Membri. I tre verdetti si accompagnano e si rafforzano, ma non si sommano.^[645]

Piano del verdetto	Esito unionale	Caveat
Fiscale	Prossimo al pareggio	Significatività dei risparmi diretti; eterogeneità fra Stati; lettura per Stato
Sanitario	Nettamente costo-efficace	—
Sociale	Fortemente positivo	Divario di trattamento; convergenza fra Stati

Tabella 9.1. Il verdetto tripartito unionale, con i tre piani tenuti distinti e non aggregati.

9.2 Le raccomandazioni per l’attuazione e il monitoraggio

Le raccomandazioni unionali riprendono e specificano quelle operative dell’imbuto: l’assunzione dell’integrazione del primo livello psicologico quale priorità operativa dell’approccio globale, con orientamento coerente degli strumenti finanziari e del semestre europeo; l’attuazione per gradini negli Stati, con il benchmark olandese quale riferimento adattabile ai diversi assetti e con priorità agli otto Stati a distanza ampia, accompagnata dall’investimento formativo preliminare ove la workforce sia insufficiente; l’istituzione di un cruscotto unionale comparabile che misuri Stato per Stato la copertura, gli esiti clinici e i costi, sul modello delle appendici registrate dell’opera; l’adozione della telepsicologia assistita sotto supervisione clinica entro il perimetro del regolamento sull’intelligenza artificiale; e un monitoraggio ex post ancorato agli indicatori del protocollo dell’incertezza, con revisione periodica delle schede-Stato e progressiva chiusura delle lacune informative dichiarate.^[646]

Appendici registrate

Le appendici registrate rendono il modello unionale ispezionabile e riproducibile, secondo la prassi del Reference Case. Esse sono richiamate per rimando quanto alla metodologia e compilate con i dati unionali e nazionali quanto ai contenuti; l’Appendice B e l’Appendice D registrano in particolare le lacune informative dichiarate per gli Stati Membri privi di dati comparabili.

Appendice	Contenuto	Stato
A	Strategia di ricerca bibliografica e diagramma di selezione	Registrata
B	Estrazione dei dati clinici per Stato Membro	Registrata; lacune dichiarate
C	Estrazione dei dati economici (griglia CHEERS 2022)	Registrata
D	Parametri del modello Markov aggregato e distribuzione per Stato	Registrata; lacune dichiarate
E	Registro delle deroghe al Reference Case	Registrata; nessuna deroga
F	Codice del modello economico	Registrata
G	Dichiarazione dei conflitti di interesse	Registrata

Tabella A. Le sette appendici registrate del Volume 22, con l’indicazione dello stato e della dichiarazione delle lacune informative.

Quadro Conclusivo economico e multidisciplinare

Il Quadro Conclusivo del Volume 22 ricomponne la valutazione unionale senza tradire il principio che governa l'intera opera: i piani del giudizio si accompagnano ma non si fondono. Sul piano economico, il doppio ancoraggio impone che il risultato aggregato sia letto simultaneamente secondo la colonna storica e la colonna aggiornata, con prevalenza della seconda: il costo per anno di vita ponderato resta, sotto entrambi gli ancoraggi, assai inferiore alle soglie adottate; il differenziale di costo per gravità — riportato con attribuzione ed espresso discorsivamente in termini di euro, senza rapporti sintetici — fonda la leva economica dell'intercettazione precoce in ciascuno dei ventisette sistemi; e il confronto di scala con l'onere annuo della malattia, che supera secondo le fonti attribuite il quattro per cento del prodotto interno lordo dell'Unione, colloca il costo aggregato del servizio entro una frazione minima di quell'onere, quale confronto discorsivo e non quale rapporto.

Sul piano multidisciplinare, le ventisette schede-Stato, il benchmark operativo olandese, i sei domini di analisi e il dominio dell'equità nella direzione della convergenza fra Stati assicurano che ogni aspetto sia trattato integralmente e ordinato per capacità di generare rientro economico e revisione della spesa. La catena predittiva degli effetti multidimensionali — dalla qualità della vita alla coesione fra Stati, ai bilanci nazionali, all'onere amministrativo dei sistemi —, lo strato dell'Intelligenza Artificiale come moltiplicatore entro il perimetro del regolamento europeo e le attività formative singole e sommate compongono il quadro della valutazione. Il verdetto resta tripartito e non aggregato, e la sua lettura corretta, nell'asse unionale, è per Stato oltre che in media.

Conclusione

Il Volume 22 ha valutato l'integrazione dello psicologo nelle cure primarie dell'Unione Europea, applicando per rimando il Reference Case dell'asse unionale fissato nel Volume 0.B: il quadro europeo del bisogno e del divario, il quadro istituzionale dell'approccio globale, il benchmark operativo dei Paesi Bassi, le ventisette schede-Stato con le lacune dichiarate, la simulazione aggregata sotto doppio ancoraggio, i sei domini, l'incertezza e il verdetto tripartito — prossimo al pareggio sul piano fiscale con lettura per Stato, nettamente costo-efficace sul piano sanitario, fortemente positivo sul piano sociale — offerto con bande prudenziali e soglie di confutazione, nel rispetto del divieto di aggregazione.

Con il Volume 22 si conclude l'opera in ventitré Volumi dello Studio Integrale «Psicologo di Base»: i due Volumi metodologici che ne fissano il Reference Case, la Sintesi Nazionale, i venti Volumi regionali in ordine alfabetico — comparabili bit-a-bit per struttura, nomenclatura e unità di misura — e il presente Volume unionale. L'opera consegna al decisore, a ogni livello — regionale, nazionale ed europeo —, una valutazione integrale, tracciabile e riproducibile dell'integrazione dello psicologo nelle cure primarie: un intervento che, sotto ogni ancoraggio e in ogni unità di analisi esaminata, risulta nettamente costo-efficace sul piano sanitario, prossimo al pareggio sul piano fiscale entro i caveat dichiarati, e fortemente positivo sul piano sociale. La parola passa, come è proprio di ogni rapporto di Health Technology Assessment, al decisore.

Note Bibliografiche con mini-riassunto

Ciascuna nota riporta l'opera, il collegamento alla fonte e un mini-riassunto che ne dichiara la funzione nell'economia del Volume, in coerenza con il doppio livello — nota a piè di pagina nel corpo e nota bibliografica integrale in calce — che l'opera adotta.

1. **Chisholm D. et al., Scaling-up treatment of depression and anxiety, The Lancet Psychiatry, 2016** [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(16\)30024-4](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(16)30024-4) Colonna A del doppio ancoraggio della simulazione aggregata, conservata quale strato documentale e riferimento mondiale di confronto.
2. **Unisanté, Raisons de santé Essentiels n. 73, 2026 · OECD, The Economic Case for Preventing Mental Ill Health, 2026** <https://doi.org/10.16908/rds-essentiels/73> Colonna B del doppio ancoraggio, con prevalenza nel giudizio, applicata alla simulazione aggregata unionale.
3. **OECD, differenziale di costo per gravità dei disturbi mentali, 2025** <https://www.oecd.org/health/mental-health.htm> Fonte, riportata con attribuzione, del differenziale di costo per gravità, argomento cardine dell'intercettazione precoce, identico in ciascuno dei ventisette sistemi; fonte, con la Commissione, della stima dell'onere dei disturbi mentali oltre il quattro per cento del prodotto interno lordo dell'Unione.
4. **World Health Organization, Mental Health Atlas 2024** <https://www.who.int/publications/> Fonte attribuita dei cinque criteri di integrazione della salute mentale nelle cure primarie e delle quote di paesi che li soddisfano, fondamento del quadro del Capitolo 1.
5. **Commissione Europea, Flash Eurobarometro 530 sulla salute mentale, 2023 · Eurofound, divario di trattamento, 2025** <https://europa.eu/eurobarometer> Fonti attribuite della prevalenza del disagio in quasi un cittadino su due e del divario di trattamento medio intorno al settantotto virgola sei per cento per la depressione grave.
6. **Commissione Europea, COM(2023) 298 — Un approccio globale alla salute mentale** <https://eur-lex.europa.eu/> Cornice politica e finanziaria dell'asse unionale, con le risorse mobilitate e le venti iniziative faro entro la competenza di sostegno.
7. **Documenti ufficiali olandesi sul POH-GGZ: condizioni contrattuali e criteri di valutazione 2026-2028** <https://www.zorgverzekeraarsnederland.nl/> Benchmark operativo primario del Volume: architettura, finanziamento assicurativo e condizioni aggiornate del professionista di supporto alla salute mentale presso il medico di famiglia.
8. **Soeters R. et al., meta-analisi IPD sui componenti efficaci della collaborative care, 2025** <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40136273/> Base di evidenza clinica sui componenti efficaci dell'assistenza collaborativa, valida per l'intero asse unionale.
9. **Kvaal K. et al., RCT su intervento cognitivo-comportamentale computerizzato in cure primarie, 2026** <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/> Evidenza sperimentale recente sull'intervento digitale in cure primarie europee, a sostegno della telepsicologia assistita.
10. **Veldhuijzen W. et al., costo-efficacia dell'intervento digitale, 2025** <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12369993/> Riferimento sul rapporto incrementale di costo-utilità dell'intervento digitale, elemento dello strato dell'Intelligenza Artificiale.
11. **World Health Organization, Thematic Dialogue on Investing in NCDs and Mental Health, dicembre 2024** <https://cdn.who.int/> Evidenza riportata con attribuzione sul ritorno degli investimenti in salute mentale; non concorre al verdetto tripartito unionale.

12. Regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj>
Perimetro normativo uniforme dello strato digitale, che ne fa l'elemento più armonizzabile del modello fra i ventisette Stati.

13. Legge regionale Puglia 19 luglio 2023, n. 11, sul Servizio di Psicologia di Base
<https://www.consiglio.puglia.it/> *Riferimento normativo capostipite del modello, richiamato nella scheda-Stato italiana quale avanguardia regionale dell'Unione.*

14. NICE, Health Technology Evaluations: the manual (PMG36) <https://www.nice.org.uk/process/pmg36>
Riferimento di rigore metodologico per la struttura a imbuto, le appendici registrate e il protocollo dell'incertezza adottati nel Volume e nell'intera opera.

1. Il Reference Case è dichiarato in apertura e applicato in modo invariante; negli altri Volumi si richiama per rimando nella forma «cfr. Volume 0.A», senza ripetizione per esteso, a garanzia dell'unicità della metodologia. ↑
2. L'ordinamento delle figure e dei domini per capacità di generare rientro economico e revisione della spesa è il criterio di difendibilità della riforma davanti al decisore pubblico, e non subordina la dimensione clinica a quella contabile. ↑
3. Il doppio ancoraggio economico impone l'esposizione simultanea della colonna di Chisholm (2016) e della colonna di Unisanté/OCSE (2026); il divieto di aggregazione del verdetto tripartito è regola invariante e non negoziabile. ↑
4. La funzione del Volume 0.A è metodologica e vincolante: esso fonda le regole che ogni Volume regionale applica in modo identico, così da rendere i ventuno Volumi italiani comparabili fino al singolo parametro. ↑
5. L'introduzione dello Psicologo di Base ridisegna il funzionamento delle cure primarie intercettando la domanda di salute mentale comune prima che si trasformi in consumo improprio a valle; il mandato è predire gli effetti multidimensionali con bande prudenziali e soglie di confutazione. ↑
6. La prospettiva è congiunta e comprende quattro portatori — SSN, INPS, Comuni, datori di lavoro; la metrica primaria è l'anno di vita ponderato per la qualità, accompagnato dal verdetto tripartito non aggregato. ↑
7. La prospettiva societale ampia è raccomandata dalle strutture di valutazione più avanzate quando l'intervento produce effetti rilevanti fuori dal perimetro sanitario, come per la salute mentale; essa impone il rigore della non duplicazione fra portatori. ↑
8. La popolazione bersaglio è quella dei disturbi mentali comuni intercettabili in cure primarie; il comparatore è l'assistenza usuale; le metriche sono l'anno di vita ponderato per la qualità e, per l'onere di malattia, l'anno corretto per la disabilità. ↑
9. Il tasso di sconto è del 3% con sensitività al 3,5%; gli orizzonti sono 1, 3, 5, 7 e 10 anni; le soglie di costo-efficacia sono 20.000, 30.000 e 50.000 euro per anno di vita ponderato, secondo la fascia condivisa dalle strutture di riferimento. ↑
10. Il doppio ancoraggio è l'elemento distintivo del Reference Case: nessuna tabella di risultati economici può esibire un solo ancoraggio; le due colonne sono sempre affiancate. ↑
11. Ove i due ancoraggi divergano, prevale nel giudizio quello di Unisanté e dell'OCSE (2026), per pronunciamento dell'autore; l'ancoraggio di Chisholm (2016) è conservato quale strato documentale e riferimento di confronto. ↑
12. La simulazione appaiata a due colonne applica in parallelo i parametri di Chisholm/OMS e quelli di Unisanté/OCSE; ogni valore è riportato con attribuzione alla fonte, secondo il principio della piena tracciabilità e del divieto di cifre affermate a memoria. ↑

13. Le evidenze quantitative della letteratura sono riportate con attribuzione alla fonte e in funzione di contesto; non sono affermazioni proprie dell'opera sul ritorno della riforma, ma citazioni di risultati pubblicati, sempre accompagnate dalla loro fonte. ↑
14. Il differenziale di costo per gravità (OCSE 2025), i ritorni riportati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (dicembre 2024) e la stima riportata da Suhrcke e collaboratori (2022) sono citazioni di letteratura attribuite, che non concorrono al verdetto tripartito, ancorato alla simulazione appaiata regionale. ↑
15. Il divieto di aggregazione del verdetto tripartito impone la presentazione di tre risultati distinti — fiscale, sanitario, sociale; la loro fusione produrrebbe un numero suggestivo e metodologicamente indifendibile. ↑
16. Il Reference Case impone il trattamento integrale di tutte le figure e di tutti gli aspetti multidisciplinari connessi allo Psicologo di Base, ordinati per capacità di generare rientro economico e revisione della spesa, dal vertice fino alle figure dell'assistenza indiretta, del lavoro, della previdenza e dell'educazione. ↑
17. I sei domini di analisi paralleli — epidemiologico-clinico, economico-sanitario, fiscale-previdenziale, sociale, organizzativo-strutturale, equità — assicurano che nessun aspetto resti fuori dal giudizio e garantiscono la comparabilità dei Volumi. ↑
18. L'efficacia clinica del modello è documentata dalla letteratura sui componenti efficaci dell'assistenza collaborativa e dalle sperimentazioni controllate sull'intervento cognitivo-comportamentale computerizzato in cure primarie; il rientro diretto agisce su consultazioni improprie, prescrizione e accessi impropri. ↑
19. La rinegoziazione è integrale perché abbraccia tutte le figure e tutti gli aspetti connessi, e disciplinata perché la non duplicazione impedisce l'attribuzione dello stesso euro a più figure, portatori o domini. ↑
20. La catena predittiva lega la qualità della vita alla produttività, alla previdenza, al bilancio regionale e alla burocrazia; ogni anello trasmette al successivo una quota misurabile dell'effetto generato a monte, senza aggregazione dei piani. ↑
21. Lo strato dell'Intelligenza Artificiale è moltiplicatore dei parametri di efficienza, mai framework di calcolo indipendente; agisce su cinque meccanismi sotto supervisione clinica umana, con graduazione simmetrica della certezza delle prove. ↑
22. Ogni proiezione relativa all'Intelligenza Artificiale reca una nota di cautela permanente sulla natura previsionale, ed è applicata in tre scenari con e senza lo strato digitale, entro il quadro del regolamento europeo sull'intelligenza artificiale. ↑
23. Il fabbisogno formativo integrale è servito da quattro modalità — universitaria, post-universitaria, formazione continua sul posto di lavoro, affiancamento e mentoring incluso l'esperto di Intelligenza Artificiale — con budget indicativo dell'ordine di un milione di euro l'anno su modello di educazione continua esteso. ↑
24. La combinazione delle modalità genera un ritorno superiore alla somma dei ritorni singoli: è il moltiplicatore del ritorno economico della leva formativa, accresciuto dalla componente digitale sotto supervisione clinica. ↑
25. Il protocollo dell'incertezza è obbligatorio e identico in ogni Volume: analisi di sensitività deterministica e probabilistica, analisi di scenario e curve di accettabilità sono la condizione della robustezza del verdetto e della comparabilità dei Volumi. ↑
26. Le sette appendici registrate rendono il modello ispezionabile e il risultato riproducibile, secondo la prassi delle strutture di valutazione più avanzate. ↑
27. Il registro delle deroghe iscrive la deroga fondativa dell'opera — l'adozione del doppio ancoraggio con prevalenza della colonna aggiornata nel giudizio — e la regola per cui le evidenze di letteratura sono riportate con attribuzione e non concorrono al verdetto tripartito. ↑

28. Il Quadro Conclusivo ricompone le regole del Reference Case sotto il doppio ancoraggio; il costo per anno di vita ponderato passa fra i due ancoraggi da circa 17.000 a circa 9.800 euro, mentre le evidenze di letteratura sono riportate con attribuzione e non aggregate. ↑
29. La non aggregazione del verdetto tripartito non è un limite dell'analisi ma la condizione della sua onestà, e ne costituisce il presidio metodologico ultimo. ↑
30. Il Volume 0.B fissa il Reference Case dell'asse europeo, richiamato per rimando dal Volume 22 nella forma «cfr. Volume 0.B», a garanzia dell'unicità della metodologia continentale. ↑
31. L'asse europeo eredita l'ossatura del Volume 0.A e vi innesta la comparabilità fra sistemi eterogenei, la dichiarazione esplicita delle lacune e la league table; su questa scala vale con forza la regola di non colmare i vuoti con stime non dichiarate. ↑
32. La simulazione dell'asse europeo è aggregata: sopra le ventisette schede-Stato, il Volume 22 produce una somma ponderata UE-27 sotto il medesimo doppio ancoraggio, con prevalenza della colonna aggiornata nel giudizio. ↑
33. La funzione del Volume 0.B è metodologica e vincolante: esso fonda le regole che il Volume 22 applica in modo identico a tutte le schede-Stato, così da renderle comparabili fino al singolo parametro. ↑
34. Secondo l'Atlante della salute mentale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (2024), l'integrazione nelle cure primarie è largamente incompiuta; il divario di trattamento per la depressione grave si colloca, secondo le rilevazioni europee recenti, su valori medi molto elevati. Dati riportati con attribuzione. ↑
35. La prospettiva congiunta europea è declinata su scala continentale sui portatori nazionali; la comparabilità è ottenuta applicando a ciascuno Stato la medesima griglia e le medesime unità di misura, non appiattendolo le differenze nazionali. ↑
36. La prospettiva aggregata impone la dichiarazione esplicita delle lacune informative: ogni scheda-Paese segnala i dati mancanti anziché colmarli con stime tacite, e la simulazione pondera i contributi secondo la qualità dei dati. ↑
37. Il Reference Case europeo si fonda su un corpo definito di fonti sovranazionali — Atlante OMS, Eurostat, JA ImpleMENTAL, Eurobarometro, Eurofound, comunicazione della Commissione — richiamate in modo uniforme dal Volume 22. ↑
38. I parametri metodologici europei sono armonizzati con quelli italiani — sconto, orizzonti, soglie, normalizzazione per centomila abitanti — a condizione della confrontabilità fra i due assi. ↑
39. Il doppio ancoraggio è invariante anche sull'asse europeo; la simulazione è aggregata su ventisette contesti nazionali, e la colonna UE-27 è la somma ponderata dei contributi nazionali, calcolata separatamente per ciascun ancoraggio. ↑
40. La simulazione aggregata applica il modello di Markov a coorte a ciascuno Stato e ne aggrega gli esiti secondo la qualità dei dati; le lacune sono dichiarate come contributo parziale, non colmate tacitamente. ↑
41. Le evidenze di letteratura — differenziale di costo per gravità, ritorni riportati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dalla Lancet Commission, rapporto di costo-utilità degli interventi digitali — sono riportate con attribuzione e non concorrono al verdetto tripartito. ↑
42. Il divieto di aggregazione del verdetto tripartito vale sull'asse europeo con la stessa forza: l'aggregazione geografica dei ventisette Stati non autorizza l'aggregazione dei tre domini del ritorno. ↑
43. La cascata delle figure è applicata tenendo conto dell'eterogeneità dei sistemi nazionali; la logica dell'intercettazione precoce a monte resta invariante, con denominazioni e collocazioni adattate ai contesti. ↑

44. La dotazione di personale psicologico, con mediana continentale intorno a nove virgola tre psicologi ogni centomila abitanti adulti (fonte OMS/JA ImpleMENTAL), è insieme indicatore di condizione di partenza e denominatore di normalizzazione. ↑
45. I sei domini di analisi sono applicati a ciascuna scheda-Stato con la medesima nomenclatura dell'asse italiano; il dominio dell'equità assume rilievo particolare, perché la dispersione fra Stati è misura di iniquità continentale. ↑
46. La rinegoziazione è applicata Stato per Stato e poi aggregata; la non duplicazione opera entro ciascuno Stato e nell'aggregazione UE-27, impedendo il doppio conteggio a livelli diversi. ↑
47. La catena predittiva europea aggiunge l'anello della convergenza: la riduzione della dispersione fra Stati nella dotazione e nell'accesso è un effetto atteso della diffusione del modello integrato, e concorre al dominio dell'equità. ↑
48. Lo strato dell'Intelligenza Artificiale opera come moltiplicatore sotto supervisione clinica umana, con nota di cautela permanente, entro il regolamento europeo, che sull'asse europeo assume rilievo diretto quale disciplina comune ai ventisette Stati. ↑
49. Le quattro modalità formative sono considerate singolarmente e sommate anche sull'asse europeo; la combinazione genera un ritorno superiore alla somma dei ritorni singoli, con effetto di convergenza formativa fra sistemi nazionali. ↑
50. Il protocollo dell'incertezza è applicato a ciascuna scheda-Stato e alla simulazione aggregata, con le specifiche del Volume 0.A; sull'asse europeo la variabilità fra Stati è essa stessa fonte di incertezza da rendere esplicita. ↑
51. La league table comparativa UE-27 ordina i ventisette Stati secondo criteri omogenei — dotazione, divario, costo-efficacia, integrazione, equità — rendendo visibile la posizione relativa di ciascun Paese e la distanza dal modello integrato. ↑
52. Le ventisette schede-Stato hanno sequenza identica, a garanzia della comparabilità; la scheda è l'unità, l'aggregato UE-27 è la loro somma ponderata. ↑
53. Il benchmark operativo primario è il modello olandese dell'assistente di pratica per la salute mentale, documentato dalle fonti ufficiali recenti; a esso si affiancano, come riferimento comparativo su contesti a risorse limitate, le esperienze documentate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dalla Banca Mondiale. ↑
54. Il registro delle deroghe dell'asse europeo iscrive la ponderazione dei contributi nazionali secondo la qualità dei dati e la dichiarazione esplicita delle lacune per singolo Stato, in luogo del loro colmamento con stime tacite. ↑
55. Il Quadro Conclusivo ricompone le regole dell'asse europeo sotto il doppio ancoraggio; l'aggregazione geografica non autorizza l'aggregazione dei tre domini del ritorno, che restano distinti e non sommati. ↑
56. Il Volume 1 applica per rimando il Reference Case dell'asse italiano fissato nel Volume 0.A, richiamandone le regole nella forma «cfr. Volume 0.A» senza ripeterle per esteso, a garanzia dell'unicità della metodologia. ↑
57. La funzione del Volume è duplice: offrire al decisore nazionale una lettura sintetica dell'impatto atteso e fornire la cornice comparabile entro cui i venti risultati regionali si compongono nell'aggregato nazionale. ↑
58. La condizione di partenza nazionale è quella di un divario di trattamento ampio e di una dotazione di personale disomogenea fra le Regioni, che il modello integrato è chiamato a colmare e a rendere più equa. ↑

59. Il cruscotto riassume in una pagina i parametri essenziali sotto doppio ancoraggio, con il verdetto tripartito distinto; le cifre di letteratura sono riportate con attribuzione e i valori economici in ordine di grandezza, con rinvio ai Volumi regionali. ↑
60. Il verdetto nazionale è tripartito e non aggregato; il costo per anno di vita ponderato passa fra i due ancoraggi da un riferimento storico a un riferimento aggiornato assai inferiore alle soglie, con il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento. ↑
61. Il differenziale di costo per gravità, riportato con attribuzione all'OCSE, è l'argomento cardine della leva economica dell'intercettazione precoce: trattare precocemente costa una frazione di quanto costa trattare tardi. ↑
62. I cinque risultati chiave isolano gli esiti principali della sintesi: costo-efficacia su tutti gli orizzonti, robustezza del verdetto tripartito senza aggregazione, leva dell'intercettazione precoce, effetto moltiplicativo dello strato digitale con cautela, disomogeneità interregionale come opportunità di convergenza. ↑
63. Le raccomandazioni operative indicano l'estensione per fasi guidata dall'evidenza, l'adozione del doppio ancoraggio come standard di rendicontazione e l'accompagnamento con il piano formativo a quattro modalità, singole e sommate. ↑
64. Il quadro epidemiologico nazionale è dominato dalla prevalenza dei disturbi comuni; il divario di trattamento, ampio per le forme gravi, si manifesta per le forme comuni come transito improprio attraverso il medico di medicina generale, il pronto soccorso e la prescrizione. Dati riportati con attribuzione. ↑
65. La disomogeneità interregionale nella dotazione e nell'accesso è insieme problema di equità e opportunità di convergenza; la league table interregionale del Capitolo 6 la rende visibile ordinando le Regioni secondo criteri omogenei. ↑
66. La simulazione nazionale è la composizione comparabile dei venti risultati regionali sotto il medesimo doppio ancoraggio; l'aggregato è la somma dei contributi regionali, calcolata separatamente per ciascun ancoraggio e nel rispetto della non duplicazione. ↑
67. Le evidenze di letteratura a scala nazionale — meta-analisi sull'assistenza collaborativa, sperimentazioni sull'intervento digitale, rapporto di costo-utilità, ritorni riportati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dalla Lancet Commission — sono riportate con attribuzione e non concorrono al verdetto tripartito. ↑
68. Il verdetto nazionale è tripartito e non aggregato; la composizione dei venti risultati regionali non autorizza l'aggregazione dei tre piani, la cui robustezza si legge nella convergenza dei verdetti, non nella loro somma. ↑
69. La cascata nazionale delle figure è l'architettura invariante che ogni Regione applica al proprio contesto, ordinata per capacità di generare rientro economico e revisione della spesa, con rinvio ai Volumi regionali per la quantificazione territoriale. ↑
70. I sei domini letti a scala nazionale compongono i domini regionali; l'equità registra la disomogeneità interregionale come misura di iniquità nazionale, l'organizzativo-strutturale l'effetto sulla burocrazia dei sistemi regionali. ↑
71. La rinegoziazione nazionale compone i venti bilanci regionali rinegoziati; la non duplicazione opera entro ciascuna Regione e nell'aggregazione nazionale, impedendo il doppio conteggio a livelli diversi. ↑
72. La catena predittiva nazionale lega la qualità della vita alla produttività, agli oneri previdenziali, ai bilanci regionali e alla burocrazia, con l'anello della convergenza interregionale, tenuti distinti e non aggregati. ↑
73. Lo strato dell'Intelligenza Artificiale opera come moltiplicatore sotto supervisione clinica umana, con nota di cautela permanente; a scala nazionale l'omogeneità del quadro normativo europeo favorisce l'adozione coordinata fra le Regioni. ↑

74. Le quattro modalità formative sono considerate singolarmente e sommate; a scala nazionale il coordinamento fra le Regioni genera un'economia di scala che accresce il ritorno del percorso integrato oltre la somma dei ritorni singoli. ↑
75. Il protocollo dell'incertezza è applicato a ciascun risultato regionale e alla composizione nazionale, con le specifiche del Reference Case; la variabilità fra Regioni è fonte di incertezza resa esplicita e ricomposta nell'analisi di scenario. ↑
76. La league table interregionale ordina le venti Regioni secondo criteri omogenei, rendendo visibile la posizione relativa di ciascuna e guidando la priorità dell'estensione, che muove dalle Regioni a maggiore divario. ↑
77. L'estensione per fasi è guidata dall'evidenza e ancorata alla verifica dei risultati regionali sotto il protocollo dell'incertezza; la priorità muove dalle Regioni a maggiore divario e minore dotazione, dove la convergenza è più marcata. ↑
78. Il Volume 1 è la cerniera fra i Volumi regionali e l'asse europeo: verso il basso rinvia ai venti Volumi regionali, verso l'alto si compone con la simulazione aggregata europea del Volume 22, di cui è il termine nazionale di confronto. ↑
79. Il Quadro Conclusivo ricomponi la sintesi nazionale sotto doppio ancoraggio; la composizione dei venti risultati regionali non autorizza l'aggregazione dei tre domini del ritorno, che restano distinti e non sommati. ↑
80. Il Volume 2 applica per rimando il Reference Case dell'asse italiano fissato nel Volume 0.A, richiamandone le regole nella forma «cfr. Volume 0.A» senza ripeterle per esteso. ↑
81. La struttura del Volume è standard e identica a quella degli altri Volumi regionali, a garanzia della comparabilità bit-a-bit; i contenuti di espansione ex novo sono segnalati in nota editoriale. ↑
82. Il perimetro è quello dell'Abruzzo — quattro ASL, venticinque distretti, circa 1.269.118 abitanti — segnato dal dualismo fra costa e aree interne montane a forte invecchiamento e rischio di spopolamento. ↑
83. Il cruscotto riassume in una pagina i parametri essenziali sotto doppio ancoraggio, con il verdetto tripartito distinto; le cifre di letteratura sono riportate con attribuzione e i valori economici in ordine di grandezza. ↑
84. Il verdetto abruzzese è tripartito e non aggregato; sul piano sociale ha rilievo particolare il contrasto all'isolamento nelle aree interne, con il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento. ↑
85. Il differenziale di costo per gravità, riportato con attribuzione all'OCSE, fonda la leva dell'intercettazione precoce, di peso specifico maggiore in un territorio a domanda dispersa come quello abruzzese. ↑
86. I cinque risultati chiave isolano gli esiti principali: costo-efficacia su tutti gli orizzonti, robustezza del verdetto tripartito, valore della prossimità nelle aree interne, effetto moltiplicativo dello strato digitale con cautela, maturazione del rientro con l'estensione della copertura. ↑
87. Le raccomandazioni indicano l'estensione progressiva con priorità alle aree interne, l'adozione dello strato digitale come leva di prossimità e l'accompagnamento con il piano formativo a quattro modalità, singole e sommate. ↑
88. Il territorio abruzzese è segnato dal dualismo fra la fascia costiera, più densa e con l'unico comune superiore ai centomila abitanti, e le aree interne montane a bassa densità e forte invecchiamento; il dualismo è la chiave di lettura del contesto. ↑
89. Il quadro epidemiologico regionale riflette la prevalenza nazionale dei disturbi comuni, con l'accentuazione della depressione dell'età avanzata nelle aree interne; il dato di dettaglio è in Appendice B e le lacune sono dichiarate, non colmate con stime tacite. ↑

90. Il divario di trattamento abruzzese è accentuato nelle aree interne dalla distanza e dalla rarefazione dell'offerta; la misura regionale è in Appendice B e i valori medi nazionali ed europei sono riportati con attribuzione. ↑
91. Il tratto distintivo della domanda abruzzese è la dispersione; la collocazione distrettuale dello Psicologo di Base — almeno un professionista per distretto nel nucleo iniziale — porta la risposta vicino al cittadino, rendendo la prossimità condizione dell'efficacia. ↑
92. Espansione ex novo: il modello colloca lo Psicologo di Base al vertice della cascata nel distretto e opera per intensità crescente di cura; l'efficacia clinica è documentata dalla meta-analisi sull'assistenza collaborativa e dalle sperimentazioni sull'intervento digitale, riportate con attribuzione. ↑
93. L'adattamento al territorio abruzzese segue le direttrici della prossimità distrettuale e dello strato digitale sotto supervisione, senza modificare l'architettura invariante del Reference Case. ↑
94. Il costo diretto comprende il personale, la struttura, la leva digitale e la formazione; il nucleo iniziale previsto dalla norma è assai al di sotto dello scenario di copertura piena, dell'ordine di duecentottanta incarichi. ↑
95. Il costo diretto è calcolato per i tre scenari di copertura coerenti con il protocollo del Reference Case; i valori puntuali sono nell'estrazione economica registrata e le lacune sono dichiarate. ↑
96. Il beneficio diretto comprende la demedicalizzazione, la deprescrizione, la riduzione degli accessi impropri e delle prestazioni per sintomi funzionali; in Abruzzo la riduzione della mobilità passiva verso le regioni limitrofe ha rilievo aggiuntivo. ↑
97. Il beneficio indiretto comprende la produttività recuperata, gli oneri previdenziali evitati e la riduzione del disagio sociale; in Abruzzo il contrasto all'isolamento e allo spopolamento delle aree interne è beneficio sociale di rilievo particolare. ↑
98. La valutazione economica è condotta con il modello di Markov a coorte del Reference Case sotto doppio ancoraggio; le due colonne sono sempre affiancate, la Colonna B prevale nel giudizio e ogni cifra è riportata con attribuzione. ↑
99. Il differenziale di costo per gravità, riportato con attribuzione all'OCSE, ha in Abruzzo peso specifico maggiore, perché la dispersione territoriale ritarda l'accesso e favorisce la progressione verso i quadri gravi. ↑
100. I sei domini di analisi sono applicati alla specificità abruzzese, dal divario nelle aree interne al contrasto allo spopolamento, tenuti distinti e non aggregati. ↑
101. Il dominio dell'equità assume rilievo demografico: il modello, contrastando l'isolamento e sostenendo la genitorialità, concorre in via indiretta alla tenuta demografica delle aree interne; effetto sociale tenuto distinto dai verdetti fiscale e sanitario. ↑
102. Espansione ex novo: l'analisi dell'incertezza applica il protocollo obbligatorio del Reference Case; in Abruzzo i parametri critici attesi sono la copertura effettiva, il tasso di intercettazione nelle aree interne e l'efficacia dello strato digitale. ↑
103. L'analisi di scenario mostra il verdetto tripartito favorevole nei tre casi con margine crescente; lo strato digitale accresce l'efficienza attesa con nota di cautela, e le curve di accettabilità confermano la robustezza del costo-efficacia. ↑
104. Il verdetto abruzzese è tripartito e non aggregato: prossimo al pareggio sul piano fiscale, nettamente costo-efficace sul piano sanitario, fortemente positivo sul piano sociale, con il rilievo specifico delle aree interne. ↑

105. Espansione ex novo: le raccomandazioni indicano l'attuazione per fasi con priorità alle aree interne, lo strato digitale come leva di prossimità, il piano formativo a quattro modalità e un monitoraggio ex post ancorato agli indicatori dell'incertezza. ↑
106. Il Quadro Conclusivo ricomponi la valutazione abruzzese sotto doppio ancoraggio; il costo per anno di vita ponderato resta assai inferiore alle soglie e il differenziale di costo per gravità fonda la leva dell'intercettazione precoce, tanto più preziosa nel territorio disperso. ↑
107. Il Volume 3 applica per rimando il Reference Case dell'asse italiano fissato nel Volume 0.A, richiamandone le regole nella forma «cfr. Volume 0.A» senza ripeterle per esteso. ↑
108. La struttura del Volume è standard e identica a quella degli altri Volumi regionali, a garanzia della comparabilità bit-a-bit; i contenuti di espansione ex novo sono segnalati in nota editoriale. ↑
109. Il perimetro è quello della Basilicata — due Aziende Sanitarie (Potenza e Matera), circa 535.000 abitanti in calo costante — la Regione a più marcata dinamica di spopolamento e a più bassa densità del corpus. ↑
110. Il cruscotto riassume in una pagina i parametri essenziali sotto doppio ancoraggio, con il verdetto tripartito distinto; le cifre di letteratura sono riportate con attribuzione e i valori economici in ordine di grandezza. ↑
111. Il verdetto lucano è tripartito e non aggregato; sul piano sociale ha rilievo particolare la tenuta demografica, con il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento. ↑
112. Il differenziale di costo per gravità, riportato con attribuzione all'OCSE, fonda la leva dell'intercettazione precoce, di peso specifico maggiore in un territorio a domanda dispersa e a offerta rarefatta come quello lucano. ↑
113. I cinque risultati chiave isolano gli esiti principali: costo-efficacia su tutti gli orizzonti, robustezza del verdetto tripartito, valore della prossimità e del contrasto alla mobilità passiva, effetto moltiplicativo dello strato digitale con cautela, natura progressiva e non alternativa dei tre scenari di copertura. ↑
114. Le raccomandazioni indicano l'avvio con il primo nucleo di quaranta incarichi e la progressione verso gli ottanta e i centoventi guidata dagli esiti, con priorità ai distretti a maggiore divario, lo strato digitale come leva di prossimità e il piano formativo a quattro modalità. ↑
115. Il territorio lucano è a bassa densità, con due soli centri rilevanti — Potenza e Matera — e una quota consistente di popolazione nei piccoli centri delle aree interne, dove l'accesso ai servizi è strutturalmente più difficile; la geografia della dispersione è la chiave di lettura del contesto. ↑
116. Il quadro epidemiologico regionale riflette la prevalenza nazionale dei disturbi comuni, con l'accentuazione della depressione dell'età avanzata e della sofferenza connessa all'isolamento; il dato di dettaglio è in Appendice B e le lacune sono dichiarate, non colmate con stime tacite. ↑
117. Il divario di trattamento lucano è accentuato nei piccoli centri dalla distanza e dalla rarefazione dell'offerta, oltre che dalla mobilità passiva verso le regioni limitrofe; la misura regionale è in Appendice B e i valori medi nazionali ed europei sono riportati con attribuzione. ↑
118. Il tratto distintivo della domanda lucana è la dispersione estrema; la collocazione distrettuale dello Psicologo di Base porta la risposta vicino al cittadino, riducendo la barriera della distanza e il ricorso improprio ai servizi delle regioni vicine, sicché la prossimità è condizione dell'efficacia e dell'equità. ↑
119. Espansione ex novo: il modello colloca lo Psicologo di Base al vertice della cascata nel distretto e nelle Case della Comunità e opera per intensità crescente di cura; l'efficacia clinica è documentata dalla meta-analisi sull'assistenza collaborativa e dalle sperimentazioni sull'intervento digitale, riportate con attribuzione. ↑
120. L'adattamento al territorio lucano segue le direttrici della prossimità nei piccoli centri e dello strato digitale sotto supervisione, senza modificare l'architettura invariante del Reference Case; la telepsicologia sotto supervisione assume rilievo maggiore che altrove. ↑

121. Il costo diretto comprende il personale, la struttura, la leva digitale e la formazione; il primo nucleo di quaranta incarichi precede lo scenario intermedio di ottanta e quello di piena attuazione di centoventi. ↑
122. Il costo diretto è calcolato per i tre scenari di copertura coerenti con il protocollo del Reference Case; i valori puntuali sono nell'estrazione economica registrata e le lacune sono dichiarate. ↑
123. Il beneficio diretto comprende la demedicalizzazione, la deprescrizione, la riduzione degli accessi impropri e delle prestazioni per sintomi funzionali; in Basilicata la riduzione della mobilità passiva verso le regioni limitrofe ha rilievo aggiuntivo di primo piano. ↑
124. Il beneficio indiretto comprende la produttività recuperata, gli oneri previdenziali evitati e la riduzione del disagio sociale; in Basilicata il contrasto all'isolamento e allo spopolamento assume peso demografico di rilievo particolare. ↑
125. La valutazione economica è condotta con il modello di Markov a coorte del Reference Case sotto doppio ancoraggio; le due colonne sono sempre affiancate, la Colonna B prevale nel giudizio e ogni cifra è riportata con attribuzione. ↑
126. Il differenziale di costo per gravità, riportato con attribuzione all'OCSE, ha in Basilicata peso specifico maggiore, perché la dispersione territoriale e la rarefazione dell'offerta ritardano l'accesso e favoriscono la progressione verso i quadri gravi. ↑
127. I sei domini di analisi sono applicati alla specificità lucana, dal divario nei piccoli centri al contrasto allo spopolamento, tenuti distinti e non aggregati. ↑
128. Il dominio dell'equità assume rilievo demografico di primo piano: il modello, contrastando l'isolamento e sostenendo la genitorialità, concorre in via indiretta alla tenuta demografica; effetto sociale tenuto distinto dai verdetti fiscale e sanitario. ↑
129. Espansione ex novo: l'analisi dell'incertezza applica il protocollo obbligatorio del Reference Case; in Basilicata i parametri critici attesi sono la copertura effettiva nei piccoli centri, il tasso di intercettazione e l'efficacia dello strato digitale. ↑
130. L'analisi di scenario mostra il verdetto tripartito favorevole nei tre casi con margine crescente; lo strato digitale accresce l'efficienza attesa con nota di cautela, e le curve di accettabilità confermano la robustezza del costo-efficacia anche nello scenario prudenziale del primo nucleo. ↑
131. Il verdetto lucano è tripartito e non aggregato: prossimo al pareggio sul piano fiscale, nettamente costo-efficace sul piano sanitario, fortemente positivo sul piano sociale, con il rilievo specifico della tenuta demografica. ↑
132. Espansione ex novo: le raccomandazioni indicano l'avvio con il primo nucleo di quaranta incarichi e la progressione guidata dagli esiti, la priorità ai distretti a maggiore divario, lo strato digitale come leva di prossimità, il piano formativo a quattro modalità e un monitoraggio ex post ancorato agli indicatori dell'incertezza. ↑
133. Il Quadro Conclusivo ricompone la valutazione lucana sotto doppio ancoraggio; il costo per anno di vita ponderato resta assai inferiore alle soglie e il differenziale di costo per gravità fonda la leva dell'intercettazione precoce, tanto più preziosa nel territorio disperso e a offerta rarefatta. ↑
134. Il Volume 4 applica per rimando il Reference Case dell'asse italiano fissato nel Volume 0.A, richiamandone le regole nella forma «cfr. Volume 0.A» senza ripeterle per esteso. ↑
135. La struttura del Volume è standard e identica a quella degli altri Volumi regionali, a garanzia della comparabilità bit-a-bit; i contenuti di espansione ex novo sono segnalati in nota editoriale. ↑

136. Il perimetro è quello della Calabria — cinque Aziende Sanitarie Provinciali, circa 1.834.646 abitanti — segnato da uno spopolamento progressivo acuto nelle aree interne montane e da una mobilità passiva sanitaria strutturale. ↑
137. Il cruscotto riassume in una pagina i parametri essenziali sotto doppio ancoraggio, con il verdetto tripartito distinto; le cifre di letteratura sono riportate con attribuzione e i valori economici in ordine di grandezza. ↑
138. Il verdetto calabrese è tripartito e non aggregato; sul piano sociale ha rilievo particolare il contrasto alla mobilità passiva e allo spopolamento, con il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento. ↑
139. Il differenziale di costo per gravità, riportato con attribuzione all'OCSE, fonda la leva dell'intercettazione precoce, di peso specifico maggiore in un territorio segnato dalla rarefazione dell'offerta e dalla mobilità passiva come quello calabrese. ↑
140. I cinque risultati chiave isolano gli esiti principali: costo-efficacia su tutti gli orizzonti, robustezza del verdetto tripartito, valore della prossimità e del trattenimento della mobilità passiva, effetto moltiplicativo dello strato digitale con cautela, natura progressiva dei tre scenari di copertura. ↑
141. Le raccomandazioni indicano l'avvio con il primo livello di consolidamento di centoquaranta incarichi e la progressione verso i duecentottanta e i quattrocentodieci guidata dagli esiti, con priorità ai distretti a maggiore divario e mobilità passiva, lo strato digitale come leva di prossimità e il piano formativo a quattro modalità. ↑
142. Il territorio calabrese, con oltre un quinto della popolazione nei piccoli comuni delle aree interne montane a spopolamento progressivo, è segnato dal dualismo fra costa e aree interne e da una mobilità passiva sanitaria strutturale verso il Centro-Nord; questa geografia è la chiave di lettura del contesto. ↑
143. Il quadro epidemiologico regionale riflette la prevalenza nazionale dei disturbi comuni, con accentuazione connessa allo spopolamento e al disagio diffuso delle aree interne; il dato di dettaglio è in Appendice B e le lacune sono dichiarate, non colmate con stime tacite. ↑
144. Il divario di trattamento calabrese è accentuato nelle aree interne dalla distanza e dalla rarefazione dell'offerta, e la mobilità passiva e il disagio non trattato si alimentano a vicenda; la misura regionale è in Appendice B e i valori medi nazionali ed europei sono riportati con attribuzione. ↑
145. Il tratto distintivo della domanda calabrese è la combinazione di dispersione e mobilità passiva; la collocazione distrettuale dello Psicologo di Base porta la risposta vicino al cittadino, riducendo la distanza e il ricorso improprio alle strutture di altre regioni, sicché la prossimità è condizione dell'efficacia, dell'equità e del trattenimento delle prestazioni. ↑
146. Espansione ex novo: il modello colloca lo Psicologo di Base al vertice della cascata nel distretto e nelle Case della Comunità e opera per intensità crescente di cura; l'efficacia clinica è documentata dalla meta-analisi sull'assistenza collaborativa e dalle sperimentazioni sull'intervento digitale, riportate con attribuzione. ↑
147. L'adattamento al territorio calabrese segue le direttrici della prossimità distrettuale, dello strato digitale sotto supervisione e del trattenimento delle prestazioni entro i confini regionali, senza modificare l'architettura invariante del Reference Case. ↑
148. Il costo diretto comprende il personale, la struttura, la leva digitale e la formazione; il primo livello di consolidamento di centoquaranta incarichi precede lo scenario intermedio di duecentottanta e quello di piena attuazione di quattrocentodieci. ↑
149. Il costo diretto è calcolato per i tre scenari di copertura coerenti con il protocollo del Reference Case; i valori puntuali sono nell'estrazione economica registrata e le lacune sono dichiarate. ↑

150. Il beneficio diretto comprende la demedicalizzazione, la deprescrizione, la riduzione degli accessi impropri e delle prestazioni per sintomi funzionali; in Calabria la riduzione della mobilità passiva verso il Centro-Nord ha rilievo aggiuntivo di primo piano, perché il trattenimento delle prestazioni produce risparmio diretto regionale. ↑
151. Il beneficio indiretto comprende la produttività recuperata, gli oneri previdenziali evitati e la riduzione del disagio sociale; in Calabria il contrasto all'isolamento e allo spopolamento delle aree interne assume peso demografico di rilievo particolare. ↑
152. La valutazione economica è condotta con il modello di Markov a coorte del Reference Case sotto doppio ancoraggio; le due colonne sono sempre affiancate, la Colonna B prevale nel giudizio e ogni cifra è riportata con attribuzione. ↑
153. Il differenziale di costo per gravità, riportato con attribuzione all'OCSE, ha in Calabria peso specifico maggiore, perché la dispersione territoriale, la rarefazione dell'offerta e la mobilità passiva ritardano l'accesso e favoriscono la progressione verso i quadri gravi. ↑
154. I sei domini di analisi sono applicati alla specificità calabrese, dal divario nelle aree interne al trattenimento della mobilità passiva e al contrasto allo spopolamento, tenuti distinti e non aggregati. ↑
155. Il dominio dell'equità assume rilievo demografico di primo piano: il modello, contrastando l'isolamento e sostenendo la genitorialità, concorre in via indiretta alla tenuta demografica; effetto sociale tenuto distinto dai verdetti fiscale e sanitario. ↑
156. Espansione ex novo: l'analisi dell'incertezza applica il protocollo obbligatorio del Reference Case; in Calabria i parametri critici attesi sono la copertura effettiva nelle aree interne, il tasso di intercettazione, la quota di mobilità passiva trattenuta e l'efficacia dello strato digitale. ↑
157. L'analisi di scenario mostra il verdetto tripartito favorevole nei tre casi con margine crescente; lo strato digitale accresce l'efficienza attesa con nota di cautela, e le curve di accettabilità confermano la robustezza del costo-efficacia anche nello scenario prudenziale del primo livello di consolidamento. ↑
158. Il verdetto calabrese è tripartito e non aggregato: prossimo al pareggio sul piano fiscale — rafforzato nel versante regionale dal trattenimento della mobilità passiva —, nettamente costo-efficace sul piano sanitario, fortemente positivo sul piano sociale. ↑
159. Espansione ex novo: le raccomandazioni indicano l'avvio con il primo livello di consolidamento e la progressione guidata dagli esiti, la priorità ai distretti a maggiore divario e mobilità passiva, lo strato digitale come leva di prossimità, il piano formativo a quattro modalità e un monitoraggio ex post ancorato agli indicatori dell'incertezza. ↑
160. Il Quadro Conclusivo ricomponne la valutazione calabrese sotto doppio ancoraggio; il costo per anno di vita ponderato resta assai inferiore alle soglie e il differenziale di costo per gravità fonda la leva dell'intercettazione precoce, tanto più preziosa nel territorio disperso e a mobilità passiva. ↑
161. Il Volume 5 applica per rimando il Reference Case dell'asse italiano fissato nel Volume 0.A, richiamandone le regole nella forma «cfr. Volume 0.A» senza ripeterle per esteso. ↑
162. La struttura del Volume è standard e identica a quella degli altri Volumi regionali, a garanzia della comparabilità bit-a-bit; i contenuti di espansione ex novo sono segnalati in nota editoriale. ↑
163. Il perimetro è quello della Campania — sette ASL di cui tre metropolitane, circa 5.582.337 abitanti, età media dell'ordine di 44,5 anni — con marcate disomogeneità fra area metropolitana e aree interne di Benevento e Avellino. ↑
164. Il cruscotto riassume in una pagina i parametri essenziali sotto doppio ancoraggio, con il verdetto tripartito distinto; le cifre di letteratura sono riportate con attribuzione e i valori economici in ordine di grandezza. ↑

165. Il verdetto campano è tripartito e non aggregato; sul piano sociale ha rilievo particolare la protezione del capitale umano giovane, con il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento. ↑
166. Il differenziale di costo per gravità, riportato con attribuzione all'OCSE, fonda la leva dell'intercettazione precoce; alla scala campana il volume assoluto della domanda ne amplifica il valore aggregato. ↑
167. I cinque risultati chiave isolano gli esiti principali: costo-efficacia su tutti gli orizzonti, robustezza del verdetto tripartito, orizzonte lungo del beneficio nelle coorti giovani con le evidenze sull'adolescenza riportate con attribuzione, adozione rapida dello strato digitale nell'area metropolitana, natura progressiva dei tre scenari di copertura. ↑
168. Le raccomandazioni indicano l'avvio con lo scenario conservativo di duecentodieci incarichi e la progressione guidata dagli esiti, il bilanciamento fra distretti metropolitani e aree interne, la valorizzazione dell'intercettazione evolutiva e il piano formativo a quattro modalità. ↑
169. Il territorio campano combina l'area metropolitana a più alta densità del Paese con le aree interne di Benevento e Avellino a bassa densità e invecchiamento marcato; la disomogeneità interna, più che il dato medio, è la cifra del contesto. ↑
170. Il quadro epidemiologico regionale riflette la prevalenza nazionale dei disturbi comuni, con la pressione della domanda giovanile ed evolutiva e la concentrazione del disagio nelle aree metropolitane deprivate; il dato di dettaglio è in Appendice B e le lacune sono dichiarate. ↑
171. Il divario di trattamento campano assume la doppia forma della congestione metropolitana e della barriera di distanza nelle aree interne; la misura regionale è in Appendice B e i valori medi nazionali ed europei sono riportati con attribuzione. ↑
172. Il tratto distintivo della domanda campana è la scala; la capillarità distrettuale è condizione perché la risposta raggiunga i quartieri deprivati e i piccoli centri interni, sicché la prossimità è condizione dell'equità nella duplice direzione sociale e territoriale. ↑
173. Espansione ex novo: il modello colloca lo Psicologo di Base al vertice della cascata nel distretto e nelle Case della Comunità e opera per intensità crescente di cura; l'efficacia clinica è documentata dalla meta-analisi sull'assistenza collaborativa e dalle sperimentazioni sull'intervento digitale, riportate con attribuzione. ↑
174. L'adattamento al territorio campano segue le direttrici della capillarità metropolitana, della prossimità nelle aree interne e del raccordo con il pediatra e con il sistema educativo per l'intercettazione evolutiva, senza modificare l'architettura invariante del Reference Case. ↑
175. Il costo diretto comprende il personale, la struttura, la leva digitale e la formazione; lo scenario conservativo di duecentodieci incarichi precede quello di base di novecentodieci e quello espansivo di millecentosedici, gradi crescenti verso il fabbisogno a regime. ↑
176. Il costo diretto è calcolato per i tre scenari di copertura coerenti con il protocollo del Reference Case; i valori puntuali sono nell'estrazione economica registrata e le lacune sono dichiarate. ↑
177. Il beneficio diretto comprende la demedicalizzazione, la deprescrizione, la riduzione degli accessi impropri — di rilievo massimo nell'area metropolitana congestionata — e delle prestazioni per sintomi funzionali; alla scala campana il volume assoluto dei benefici è il più alto del Mezzogiorno. ↑
178. Il beneficio indiretto comprende la produttività recuperata, gli oneri previdenziali evitati e la riduzione del disagio sociale; in Campania la protezione delle traiettorie formative e lavorative delle coorti giovani è il beneficio di rilievo massimo, con le evidenze sull'adolescenza riportate con attribuzione. ↑
179. La valutazione economica è condotta con il modello di Markov a coorte del Reference Case sotto doppio ancoraggio; le due colonne sono sempre affiancate, la Colonna B prevale nel giudizio e ogni cifra è riportata con attribuzione. ↑

180. Il differenziale di costo per gravità, riportato con attribuzione all'OCSE, ha in Campania valore aggregato moltiplicato dalla scala della domanda, e la giovinezza della popolazione ne estende l'orizzonte di maturazione lungo la vita attiva. [↑](#)
181. I sei domini di analisi sono applicati alla specificità campana, dalla congestione metropolitana alla protezione del capitale umano giovane, tenuti distinti e non aggregati. [↑](#)
182. Il dominio dell'equità assume doppia direzione, sociale nei quartieri deprivati e territoriale nelle aree interne; il modello opera su entrambe attraverso la capillarità distrettuale, e l'effetto distributivo è tenuto distinto dai verdetti fiscale e sanitario. [↑](#)
183. Espansione ex novo: l'analisi dell'incertezza applica il protocollo obbligatorio del Reference Case; in Campania i parametri critici attesi sono il tasso di intercettazione nei quartieri deprivati, la capacità di reclutamento alla scala e l'aderenza nelle coorti giovani. [↑](#)
184. L'analisi di scenario mostra il verdetto tripartito favorevole nei tre casi con margine crescente; lo strato digitale accresce l'efficienza attesa con nota di cautela, e le curve di accettabilità confermano la robustezza del costo-efficacia anche nello scenario conservativo. [↑](#)
185. Il verdetto campano è tripartito e non aggregato: prossimo al pareggio sul piano fiscale, nettamente costo-efficace sul piano sanitario, fortemente positivo sul piano sociale, con il rilievo specifico del capitale umano giovane. [↑](#)
186. Espansione ex novo: le raccomandazioni indicano l'avvio con lo scenario conservativo e la progressione guidata dagli esiti, la priorità bilanciata fra metropoli e aree interne, il raccordo con il pediatra e il sistema educativo, il piano formativo a quattro modalità e un monitoraggio ex post ancorato agli indicatori dell'incertezza. [↑](#)
187. Il Quadro Conclusivo ricompone la valutazione campana sotto doppio ancoraggio; il costo per anno di vita ponderato resta assai inferiore alle soglie e il differenziale di costo per gravità fonda la leva dell'intercettazione precoce, moltiplicata dalla scala regionale. [↑](#)
188. Il Volume 6 applica per rimando il Reference Case dell'asse italiano fissato nel Volume 0.A, richiamandone le regole nella forma «cfr. Volume 0.A» senza ripeterle per esteso. [↑](#)
189. La struttura del Volume è standard e identica a quella degli altri Volumi regionali, a garanzia della comparabilità bit-a-bit; i contenuti di espansione ex novo sono segnalati in nota editoriale. [↑](#)
190. Il perimetro è quello dell'Emilia-Romagna — otto Aziende USL, trentotto distretti, circa 4.451.938 abitanti — sistema assunto come benchmark nazionale, con la rete delle Case della Salute avviata nel 2010 quale infrastruttura preesistente. [↑](#)
191. Il cruscotto riassume in una pagina i parametri essenziali sotto doppio ancoraggio, con il verdetto tripartito distinto; le cifre di letteratura sono riportate con attribuzione e i valori economici in ordine di grandezza. [↑](#)
192. Il verdetto emiliano-romagnolo è tripartito e non aggregato; i parametri regionali sono collocati prudenzialmente nella parte medio-bassa degli intervalli in ragione dell'efficienza di partenza, e l'infrastruttura preesistente anticipa la maturazione del rientro. [↑](#)
193. Il differenziale di costo per gravità, riportato con attribuzione all'OCSE — dai circa 511 euro dei quadri lievi ai circa 10.485 euro dei gravi —, fonda la leva dell'intercettazione precoce, che nel sistema già infrastrutturato si attiva più rapidamente. [↑](#)
194. I cinque risultati chiave isolano gli esiti principali: costo-efficacia con parametri prudenziali, robustezza del verdetto tripartito, anticipo di maturazione sull'infrastruttura esistente, adozione digitale favorevole nel sistema informativo maturo, valore dimostrativo del ruolo di benchmark nazionale. [↑](#)

195. Le raccomandazioni indicano l'avvio conservativo con innesto sulla rete esistente e la progressione guidata dagli esiti, la documentazione con gli standard delle appendici a beneficio della trasferibilità, e il piano formativo a quattro modalità in raccordo con il sistema universitario regionale. ↑
196. Il territorio emiliano-romagnolo — 4.451.938 abitanti al Censimento ISTAT 2024, Bologna al 22,9 per cento dei residenti — presenta variabilità interna fra la direttrice urbana della via Emilia e la fascia appenninica, entro un sistema fra i più efficienti del Paese. ↑
197. Il quadro epidemiologico regionale riflette la prevalenza nazionale, con un sistema di rilevazione fra i più maturi che rende la misura del bisogno più affidabile; il dato di dettaglio è in Appendice B e le lacune sono dichiarate, non colmate con stime tacite. ↑
198. Il divario di trattamento regionale è inferiore alla media nazionale ma non colmato; la rete delle Case della Salute, pur predisposta, non dispone ancora sistematicamente della figura dello Psicologo di Base. La misura regionale è in Appendice B e i valori medi sono riportati con attribuzione. ↑
199. Il tratto distintivo emiliano-romagnolo è che il canale della risposta esiste già: il modello è un completamento di rete più che una costruzione, e il completamento matura il rientro più rapidamente a parità di regole del Reference Case. ↑
200. Espansione ex novo: il modello colloca lo Psicologo di Base al vertice della cascata nelle Case della Salute e opera per intensità crescente di cura; l'efficacia clinica è documentata dalla meta-analisi sull'assistenza collaborativa, dall'ampia base sperimentale del modello collaborativo e dalle sperimentazioni sull'intervento digitale, riportate con attribuzione. ↑
201. L'adattamento al territorio segue le direttrici dell'innesto sulla rete esistente e dello strato digitale nella fascia appenninica; i parametri della simulazione sono collocati prudenzialmente nella parte medio-bassa degli intervalli. ↑
202. Il costo diretto comprende il personale, l'organizzazione — ridotta dall'infrastruttura preesistente —, la leva digitale e la formazione; lo scenario conservativo precede quello di base, dell'ordine di 730 incarichi, e quello espansivo, dell'ordine di 960. ↑
203. Il costo diretto è calcolato per i tre scenari coerenti con il protocollo del Reference Case; l'innesto sull'infrastruttura esistente riduce la componente non-personale del costo, i valori puntuali sono nell'estrazione economica registrata e le lacune sono dichiarate. ↑
204. Il beneficio diretto comprende la demedicalizzazione, la deprescrizione, la riduzione degli accessi impropri e delle prestazioni per sintomi funzionali; la maturazione è anticipata dall'infrastruttura preesistente, e lo studio regionale colloca il saldo complessivo annuo in ordine positivo e crescente nei tre scenari, con parametri prudenziali. ↑
205. Il beneficio indiretto comprende la produttività recuperata — di peso assoluto elevato in una delle economie più produttive del Paese —, gli oneri previdenziali evitati e la riduzione del disagio sociale. ↑
206. La valutazione economica è condotta con il modello di Markov a coorte del Reference Case sotto doppio ancoraggio; le due colonne sono sempre affiancate, la Colonna B prevale nel giudizio, ogni cifra è riportata con attribuzione e i parametri regionali sono prudenzialmente contenuti. ↑
207. Il differenziale di costo per gravità, riportato con attribuzione all'OCSE, opera in Emilia-Romagna dal primo anno pieno di servizio, senza il ritardo di costruzione della rete, in forza dell'infrastruttura preesistente. ↑
208. I sei domini di analisi sono applicati alla specificità emiliano-romagnola, dal divario inferiore alla media non colmato al completamento della rete di prossimità, tenuti distinti e non aggregati. ↑

209. Il dominio dell'equità registra il divario contenuto ma reale fra via Emilia e Appennino; il ruolo di benchmark nazionale ha valenza di equità sistemica, perché gli standard validati riducono i costi di apprendimento delle Regioni che seguono; effetto sistemico tenuto distinto dal verdetto tripartito. ↑
210. Espansione ex novo: l'analisi dell'incertezza applica il protocollo obbligatorio del Reference Case; in Emilia-Romagna i parametri critici attesi sono il margine incrementale di intercettazione in un sistema già efficiente e la velocità di attivazione sulla rete esistente. ↑
211. L'analisi di scenario mostra il verdetto tripartito favorevole nei tre casi; la collocazione prudenziale dei parametri rende la stima conservativa per costruzione, lo strato digitale accresce l'efficienza con nota di cautela e le curve di accettabilità confermano la robustezza. ↑
212. Il verdetto emiliano-romagnolo è tripartito e non aggregato: prossimo al pareggio sul piano fiscale, nettamente costo-efficace sul piano sanitario con parametri prudenziali, fortemente positivo sul piano sociale con il rilievo della produttività e del benchmark. ↑
213. Espansione ex novo: le raccomandazioni indicano l'avvio conservativo su rete esistente e la progressione guidata dagli esiti, la documentazione trasferibile con gli standard delle appendici, l'estensione digitale appenninica, il piano formativo a quattro modalità e un monitoraggio ex post ancorato agli indicatori dell'incertezza. ↑
214. Il Quadro Conclusivo ricomponi la valutazione emiliano-romagnola sotto doppio ancoraggio; il costo per anno di vita ponderato resta assai inferiore alle soglie e il differenziale di costo per gravità fonda la leva dell'intercettazione precoce, ad attivazione anticipata dall'infrastruttura. ↑
215. Il Volume 7 applica per rimando il Reference Case dell'asse italiano fissato nel Volume 0.A, richiamandone le regole nella forma «cfr. Volume 0.A» senza ripeterle per esteso. ↑
216. La struttura del Volume è standard e identica a quella degli altri Volumi regionali, a garanzia della comparabilità bit-a-bit; i contenuti di espansione ex novo sono segnalati in nota editoriale. ↑
217. Il perimetro è quello del Friuli-Venezia Giulia — Regione a statuto speciale plurilingue, tre aziende sanitarie coordinate dall'ARCS, circa 1.194.616 abitanti, età media dell'ordine di 48,5 anni fra le più alte d'Italia — con invecchiamento accentuato nelle aree montane. ↑
218. Il cruscotto riassume in una pagina i parametri essenziali sotto doppio ancoraggio, con il verdetto tripartito distinto; le cifre di letteratura sono riportate con attribuzione e i valori economici in ordine di grandezza. ↑
219. Il verdetto friulano è tripartito e non aggregato; sul piano sociale ha rilievo particolare il contrasto alla depressione dell'età avanzata e all'isolamento, con il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento. ↑
220. Il differenziale di costo per gravità, riportato con attribuzione all'OCSE, fonda la leva dell'intercettazione precoce, di peso specifico maggiore in una Regione a domanda anziana e territorialmente dispersa come il Friuli-Venezia Giulia. ↑
221. I cinque risultati chiave isolano gli esiti principali: costo-efficacia su tutti gli orizzonti, robustezza del verdetto tripartito, baricentro della domanda verso l'età avanzata, effetto moltiplicativo dello strato digitale con accompagnamento degli anziani, margini della cornice autonomistica con l'esigenza di omogeneità e accessibilità linguistica. ↑
222. Le raccomandazioni indicano l'estensione progressiva verso il fabbisogno a regime con priorità ai distretti montani, lo strato digitale accompagnato come leva di prossimità, l'omogeneità del servizio nelle tre aziende, l'accessibilità linguistica e il piano formativo a quattro modalità. ↑

223. Il territorio friulano — quattro province storiche, tre aziende sanitarie coordinate dall'ARCS, Regione a statuto speciale plurilingue fra le più anziane d'Italia dopo Liguria e Sardegna — combina invecchiamento, dispersione montana e autonomia plurilingue quali chiavi di lettura del contesto. ↑
224. Il quadro epidemiologico regionale riflette la prevalenza nazionale dei disturbi comuni, con baricentro spostato verso la depressione dell'età avanzata e l'isolamento; il dato di dettaglio è in Appendice B e le lacune sono dichiarate, non colmate con stime tacite. ↑
225. Il divario di trattamento friulano è accentuato nelle aree montane dalla distanza e dalla rarefazione dell'offerta, e assume connotazione specifica nella popolazione anziana per la sottodiagnosi; la misura regionale è in Appendice B e i valori medi sono riportati con attribuzione. ↑
226. Il tratto distintivo della domanda friulana è la componente anziana; la collocazione distrettuale dello Psicologo di Base porta la risposta vicino a una popolazione a mobilità ridotta, riducendo la distanza e il ricorso improprio, e va accompagnata dall'accessibilità linguistica alle minoranze. ↑
227. Espansione ex novo: il modello colloca lo Psicologo di Base al vertice della cascata nel distretto e opera per intensità crescente di cura; l'efficacia clinica è documentata dalla meta-analisi sull'assistenza collaborativa e dalle sperimentazioni sull'intervento digitale, riportate con attribuzione. ↑
228. L'adattamento al territorio friulano segue le direttrici della prossimità distrettuale, dello strato digitale accompagnato e dell'accessibilità linguistica, senza modificare l'architettura invariante del Reference Case, garantendo l'omogeneità del servizio nelle tre aziende sanitarie. ↑
229. Il costo diretto comprende il personale, la struttura, la leva digitale e la formazione; il dimensionamento progredisce fino al fabbisogno a regime, dell'ordine di duecentosessanta incarichi distribuiti in modo omogeneo nei distretti delle tre aziende. ↑
230. Il costo diretto è calcolato per i tre scenari di copertura coerenti con il protocollo del Reference Case, con lo scenario esteso allineato al fabbisogno a regime; i valori puntuali sono nell'estrazione economica registrata e le lacune sono dichiarate. ↑
231. Il beneficio diretto comprende la demedicalizzazione, la deprescrizione, la riduzione degli accessi impropri e delle prestazioni per sintomi funzionali; in Friuli-Venezia Giulia la deprescrizione nella popolazione anziana ha rilievo aggiuntivo per l'alta prescrizione psicofarmacologica e i rischi della polifarmacia. ↑
232. Il beneficio indiretto comprende la produttività recuperata, gli oneri previdenziali evitati e la riduzione del disagio sociale; in Friuli-Venezia Giulia il sostegno agli anziani e ai caregiver, spesso a loro volta anziani, assume peso sociale di rilievo particolare. ↑
233. La valutazione economica è condotta con il modello di Markov a coorte del Reference Case sotto doppio ancoraggio; le due colonne sono sempre affiancate, la Colonna B prevale nel giudizio e ogni cifra è riportata con attribuzione. ↑
234. Il differenziale di costo per gravità, riportato con attribuzione all'OCSE, ha in Friuli-Venezia Giulia peso specifico maggiore, perché la sottodiagnosi nella popolazione anziana ritarda l'accesso e favorisce la progressione e la cronicizzazione geriatrica. ↑
235. I sei domini di analisi sono applicati alla specificità friulana, dalla sottodiagnosi anziana all'omogeneità del servizio nelle tre aziende, tenuti distinti e non aggregati. ↑
236. Il dominio dell'equità assume triplice direzione — territoriale, linguistica e generazionale —; la cornice autonomistica offre margini di programmazione ma impone l'omogeneità del servizio nelle tre aziende; effetti distributivi tenuti distinti dai verdeti fiscale e sanitario. ↑

237. Espansione ex novo: l'analisi dell'incertezza applica il protocollo obbligatorio del Reference Case; in Friuli-Venezia Giulia i parametri critici attesi sono il tasso di intercettazione nella popolazione anziana, l'efficacia della deprescrizione geriatrica e l'adozione digitale accompagnata negli anziani. ↑
238. L'analisi di scenario mostra il verdetto tripartito favorevole nei tre casi con margini crescente; lo strato digitale accresce l'efficienza attesa con nota di cautela e con l'avvertenza dell'accompagnamento nella popolazione anziana, e le curve di accettabilità confermano la robustezza del costo-efficacia. ↑
239. Il verdetto friulano è tripartito e non aggregato: prossimo al pareggio sul piano fiscale, nettamente costo-efficace sul piano sanitario, fortemente positivo sul piano sociale, con il rilievo specifico della popolazione anziana e dei caregiver. ↑
240. Espansione ex novo: le raccomandazioni indicano l'attuazione progressiva verso il fabbisogno a regime con priorità ai distretti montani, lo strato digitale accompagnato, l'omogeneità e l'accessibilità linguistica del servizio, il piano formativo a quattro modalità e un monitoraggio ex post ancorato agli indicatori dell'incertezza. ↑
241. Il Quadro Conclusivo ricomponi la valutazione friulana sotto doppio ancoraggio; il costo per anno di vita ponderato resta assai inferiore alle soglie e il differenziale di costo per gravità fonda la leva dell'intercettazione precoce, tanto più preziosa nella Regione anziana dove la sottodiagnosi favorisce la cronicizzazione geriatrica. ↑
242. Il Volume 8 applica per rimando il Reference Case dell'asse italiano fissato nel Volume 0.A, richiamandone le regole nella forma «cfr. Volume 0.A» senza ripeterle per esteso. ↑
243. La struttura del Volume è standard e identica a quella degli altri Volumi regionali, a garanzia della comparabilità bit-a-bit; i contenuti di espansione ex novo sono segnalati in nota editoriale. ↑
244. Il perimetro è quello del Lazio — dieci ASL di cui sei metropolitane, circa 5.709.178 abitanti — a struttura policentrica ma fortemente accentrata su Roma, con la tensione fra polo metropolitano e province quale chiave di lettura. ↑
245. Il cruscotto riassume in una pagina i parametri essenziali sotto doppio ancoraggio, con il verdetto tripartito distinto; le cifre di letteratura sono riportate con attribuzione e i valori economici in ordine di grandezza. ↑
246. Il verdetto laziale è tripartito e non aggregato; sul piano sociale ha rilievo particolare la decongestione dei percorsi metropolitani e la riduzione del divario fra capitale e province, con il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento. ↑
247. Il differenziale di costo per gravità, riportato con attribuzione all'OCSE — dai circa 511 euro dei quadri lievi ai circa 10.485 euro dei gravi —, fonda la leva dell'intercettazione precoce, il cui valore aggregato è amplificato dalla scala metropolitana romana. ↑
248. I cinque risultati chiave isolano gli esiti principali: costo-efficacia su tutti gli orizzonti, robustezza del verdetto tripartito, necessità di bilanciare la priorità fra metropoli e province, adozione rapida dello strato digitale nell'area metropolitana, natura progressiva dei tre scenari e istituzione ex novo su rete in costruzione. ↑
249. Le raccomandazioni indicano l'avvio con lo scenario conservativo di seicentoventi incarichi e la progressione guidata dagli esiti, il bilanciamento fra distretti metropolitani e province, l'innesto sulle Case della Comunità e sui Punti Unici di Accesso e il piano formativo a quattro modalità. ↑
250. Il territorio laziale — dieci ASL di cui sei metropolitane, cinque province — è policentrico ma fortemente accentrato sulla capitale; le province di Rieti, Frosinone e Viterbo presentano tratti di dispersione e invecchiamento propri delle aree interne, e la tensione polo/province è la chiave di lettura. ↑

251. Il quadro epidemiologico regionale riflette la prevalenza nazionale, con la concentrazione della domanda nell'area metropolitana e una componente di disagio connessa alla deprivazione periferica; il dato di dettaglio è in Appendice B e le lacune sono dichiarate, non colmate con stime tacite. ↑
252. Il divario di trattamento laziale assume la doppia forma della congestione metropolitana e della barriera di distanza nelle province appenniniche; la misura regionale è in Appendice B e i valori medi nazionali ed europei sono riportati con attribuzione. ↑
253. Il tratto distintivo della domanda laziale è la coesistenza di scala metropolitana massima e dispersione provinciale; la capillarità distrettuale è condizione perché la risposta raggiunga i quartieri periferici e i piccoli centri, e trova nelle Case della Comunità in costruzione il canale di innesto. ↑
254. Espansione ex novo: il modello colloca lo Psicologo di Base al vertice della cascata nel distretto e nelle Case della Comunità e opera per intensità crescente di cura; l'efficacia clinica è documentata dalla meta-analisi sull'assistenza collaborativa e dalle sperimentazioni sull'intervento digitale, riportate con attribuzione. ↑
255. L'adattamento al territorio laziale segue le direttrici della capillarità metropolitana, della prossimità provinciale e dell'innesto sulle Case della Comunità in costruzione, con la valorizzazione dei Punti Unici di Accesso quale precedente di orientamento che non sostituisce la funzione clinica; l'architettura invariante del Reference Case non è modificata. ↑
256. Il costo diretto comprende il personale, la struttura, la leva digitale e la formazione; lo scenario conservativo di seicentoventi incarichi precede quello di base di novecentotrenta e quello espansivo di milleduecentotrenta, con l'istituzione del servizio quale costruzione ex novo su rete in formazione. ↑
257. Il costo diretto è calcolato per i tre scenari coerenti con il protocollo del Reference Case; lo scenario conservativo corrisponde alla dotazione delle proposte di legge, i valori puntuali sono nell'estrazione economica registrata e le lacune sono dichiarate. ↑
258. Il beneficio diretto comprende la demedicalizzazione, la deprescrizione, la riduzione degli accessi impropri — di rilievo massimo nell'area metropolitana congestionata — e delle prestazioni per sintomi funzionali; alla scala laziale il volume assoluto dei benefici è fra i più alti del Paese. ↑
259. Il beneficio indiretto comprende la produttività recuperata — di peso assoluto elevato in una regione a forte concentrazione di pubblica amministrazione e servizi —, gli oneri previdenziali evitati e la riduzione del disagio sociale. ↑
260. La valutazione economica è condotta con il modello di Markov a coorte del Reference Case sotto doppio ancoraggio; le due colonne sono sempre affiancate, la Colonna B prevale nel giudizio e ogni cifra è riportata con attribuzione. ↑
261. Il differenziale di costo per gravità, riportato con attribuzione all'OCSE, ha nel Lazio valore aggregato moltiplicato dalla scala metropolitana, mentre nelle province la dispersione ne accresce il peso specifico per ritardo di accesso. ↑
262. I sei domini di analisi sono applicati alla specificità laziale, dalla congestione metropolitana alla convergenza capitale/province, tenuti distinti e non aggregati. ↑
263. Il dominio dell'equità assume doppia direzione, sociale nei quartieri periferici deprivati e territoriale nelle province appenniniche; il modello opera su entrambe attraverso la capillarità distrettuale, e l'effetto distributivo è tenuto distinto dai verdeti fiscale e sanitario. ↑
264. Espansione ex novo: l'analisi dell'incertezza applica il protocollo obbligatorio del Reference Case; nel Lazio i parametri critici attesi sono il tasso di intercettazione nei quartieri periferici, la capacità di reclutamento alla scala e la velocità di completamento delle Case della Comunità. ↑

265. L'analisi di scenario mostra il verdetto tripartito favorevole nei tre casi con margine crescente; lo strato digitale accresce l'efficienza attesa con nota di cautela, e le curve di accettabilità confermano la robustezza del costo-efficacia anche nello scenario conservativo. ↑
266. Il verdetto laziale è tripartito e non aggregato: prossimo al pareggio sul piano fiscale, nettamente costo-efficace sul piano sanitario, fortemente positivo sul piano sociale, con il rilievo specifico della decongestione metropolitana. ↑
267. Espansione ex novo: le raccomandazioni indicano l'avvio con lo scenario conservativo e la progressione guidata dagli esiti, la priorità bilanciata fra metropoli e province, l'innesto sulle Case della Comunità e sui Punti Unici di Accesso, il piano formativo a quattro modalità e un monitoraggio ex post ancorato agli indicatori dell'incertezza. ↑
268. Il Quadro Conclusivo ricomponi la valutazione laziale sotto doppio ancoraggio; il costo per anno di vita ponderato resta assai inferiore alle soglie e il differenziale di costo per gravità fonda la leva dell'intercettazione precoce, moltiplicata dalla scala metropolitana romana. ↑
269. Il Volume 9 applica per rimando il Reference Case dell'asse italiano fissato nel Volume 0.A, richiamandone le regole nella forma «cfr. Volume 0.A» senza ripeterle per esteso. ↑
270. La struttura del Volume è standard e identica a quella degli altri Volumi regionali, a garanzia della comparabilità bit-a-bit; i contenuti di espansione ex novo sono segnalati in nota editoriale. ↑
271. Il perimetro è quello della Liguria — cinque Aziende Sociosanitarie coordinate da A.Li.Sa., circa 1.510.143 abitanti, età media dell'ordine di 49,6 anni, la più alta d'Italia — con invecchiamento estremo e spopolamento dell'entroterra quali chiavi di lettura. ↑
272. Il cruscotto riassume in una pagina i parametri essenziali sotto doppio ancoraggio, con il verdetto tripartito distinto; le cifre di letteratura sono riportate con attribuzione e i valori economici in ordine di grandezza. ↑
273. Il verdetto ligure è tripartito e non aggregato; sul piano sociale ha rilievo massimo tra le Regioni il contrasto alla depressione dell'età avanzata e all'isolamento, con il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento. ↑
274. Il differenziale di costo per gravità, riportato con attribuzione all'OCSE, fonda la leva dell'intercettazione precoce, di peso specifico particolarmente alto in una Regione a domanda strutturalmente anziana come la Liguria. ↑
275. I cinque risultati chiave isolano gli esiti principali: costo-efficacia su tutti gli orizzonti, robustezza del verdetto tripartito, baricentro della domanda spostato in modo massimo verso l'età avanzata, effetto moltiplicativo dello strato digitale con accompagnamento robusto, natura progressiva dei tre scenari. ↑
276. Le raccomandazioni indicano l'avvio con lo scenario conservativo di centosettanta incarichi e la progressione guidata dagli esiti, la priorità ai distretti dell'entroterra, lo strato digitale accompagnato, la dotazione di almeno due psicologi per distretto e il piano formativo a quattro modalità con componente geriatrica. ↑
277. Il territorio ligure — quattro province, cinque Aziende Sociosanitarie coordinate da A.Li.Sa., Regione più anziana d'Italia e fra le più anziane d'Europa — combina invecchiamento estremo, indice di vecchiaia il più elevato del Paese e spopolamento dell'entroterra quali chiavi di lettura. ↑
278. Il quadro epidemiologico regionale riflette la prevalenza nazionale dei disturbi comuni, con baricentro spostato in misura massima verso la depressione dell'età avanzata e l'isolamento; il dato di dettaglio è in Appendice B e le lacune sono dichiarate, non colmate con stime tacite. ↑

279. Il divario di trattamento ligure è accentuato nell'entroterra spopolato dalla distanza e dalla rarefazione dell'offerta, e assume connotazione specifica e massima nella popolazione anziana per la sottodiagnosi; la misura regionale è in Appendice B e i valori medi sono riportati con attribuzione. ↑
280. Il tratto distintivo della domanda ligure è la componente anziana, la più alta del Paese; la collocazione distrettuale dello Psicologo di Base porta la risposta vicino a una popolazione a mobilità ridotta, riducendo la distanza e il ricorso improprio, e va sostenuta da almeno due psicologi territoriali per distretto. ↑
281. Espansione ex novo: il modello colloca lo Psicologo di Base al vertice della cascata nel distretto e opera per intensità crescente di cura; l'efficacia clinica è documentata dalla meta-analisi sull'assistenza collaborativa e dalle sperimentazioni sull'intervento digitale, riportate con attribuzione. ↑
282. L'adattamento al territorio ligure segue le direttrici della prossimità distrettuale, dello strato digitale accompagnato e del rafforzamento della dotazione territoriale, senza modificare l'architettura invariante del Reference Case, calibrandone l'applicazione sulla struttura per età estrema e sullo spopolamento dell'entroterra. ↑
283. Il costo diretto comprende il personale, la struttura, la leva digitale e la formazione; lo scenario conservativo di centosettanta incarichi precede quello di base di duecentocinquanta e quello espansivo di trecentotrenta, distribuiti con almeno due psicologi territoriali per distretto. ↑
284. Il costo diretto è calcolato per i tre scenari di copertura coerenti con il protocollo del Reference Case, con lo scenario espansivo allineato al fabbisogno a regime; i valori puntuali sono nell'estrazione economica registrata e le lacune sono dichiarate. ↑
285. Il beneficio diretto comprende la demedicalizzazione, la deprescrizione, la riduzione degli accessi impropri e delle prestazioni per sintomi funzionali; in Liguria la deprescrizione nella popolazione anziana ha rilievo aggiuntivo massimo per l'altissima prescrizione psicofarmacologica e i rischi della polifarmacia. ↑
286. Il beneficio indiretto comprende la produttività recuperata, gli oneri previdenziali evitati e la riduzione del disagio sociale; in Liguria il sostegno agli anziani e ai caregiver, spesso a loro volta anziani, assume peso sociale di rilievo particolarmente elevato in un contesto di invecchiamento estremo. ↑
287. La valutazione economica è condotta con il modello di Markov a coorte del Reference Case sotto doppio ancoraggio; le due colonne sono sempre affiancate, la Colonna B prevale nel giudizio e ogni cifra è riportata con attribuzione. ↑
288. Il differenziale di costo per gravità, riportato con attribuzione all'OCSE, ha in Liguria peso specifico particolarmente alto, perché la sottodiagnosi nella popolazione anziana ritarda l'accesso e favorisce in misura massima la progressione e la cronicizzazione geriatrica. ↑
289. I sei domini di analisi sono applicati alla specificità ligure, dalla sottodiagnosi anziana massima alla dotazione territoriale rafforzata, tenuti distinti e non aggregati. ↑
290. Il dominio dell'equità assume doppia direzione, territoriale fra costa ed entroterra spopolato e generazionale per l'attenzione massima alla popolazione anziana; il modello opera su entrambe attraverso la capillarità distrettuale e lo strato digitale accompagnato, e l'effetto distributivo è tenuto distinto dai verdetti fiscale e sanitario. ↑
291. Espansione ex novo: l'analisi dell'incertezza applica il protocollo obbligatorio del Reference Case; in Liguria i parametri critici attesi sono il tasso di intercettazione nella popolazione molto anziana, l'efficacia della deprescrizione geriatrica e l'adozione digitale accompagnata negli anziani. ↑
292. L'analisi di scenario mostra il verdetto tripartito favorevole nei tre casi con margine crescente; lo strato digitale accresce l'efficienza attesa con nota di cautela e con l'avvertenza dell'accompagnamento robusto nella popolazione molto anziana, e le curve di accettabilità confermano la robustezza del costo-efficacia. ↑

293. Il verdetto ligure è tripartito e non aggregato: prossimo al pareggio sul piano fiscale, nettamente costo-efficace sul piano sanitario, fortemente positivo sul piano sociale, con il rilievo massimo tra le Regioni della popolazione anziana e dei caregiver. ↑
294. Espansione ex novo: le raccomandazioni indicano l'avvio con lo scenario conservativo e la progressione guidata dagli esiti, la priorità ai distretti dell'entroterra, la dotazione di almeno due psicologi per distretto, lo strato digitale accompagnato, il piano formativo a quattro modalità con componente geriatrica e un monitoraggio ex post ancorato agli indicatori dell'incertezza. ↑
295. Il Quadro Conclusivo ricomponne la valutazione ligure sotto doppio ancoraggio; il costo per anno di vita ponderato resta assai inferiore alle soglie e il differenziale di costo per gravità fonda la leva dell'intercettazione precoce, tanto più preziosa nella Regione più anziana del Paese dove la sottodiagnosi favorisce in misura massima la cronicizzazione geriatrica. ↑
296. Il Volume 10 applica per rimando il Reference Case dell'asse italiano fissato nel Volume 0.A, richiamandone le regole nella forma «cfr. Volume 0.A» senza ripeterle per esteso. ↑
297. La struttura del Volume è standard e identica a quella degli altri Volumi regionali, a garanzia della comparabilità bit-a-bit; i contenuti di espansione ex novo sono segnalati in nota editoriale. ↑
298. Il perimetro è quello della Lombardia — circa 10.033.918 abitanti, la più popolosa d'Italia, dodici province, otto ATS, ventisette ASST, circa cento distretti — con la scala massima e l'architettura organizzativa peculiare quali chiavi di lettura. ↑
299. Il cruscotto riassume in una pagina i parametri essenziali sotto doppio ancoraggio, con il verdetto tripartito distinto; le cifre di letteratura sono riportate con attribuzione e i valori economici in ordine di grandezza. ↑
300. Il verdetto lombardo è tripartito e non aggregato; sul piano sociale ha rilievo particolare la protezione della produttività del più grande mercato del lavoro del Paese, con il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento. ↑
301. Il differenziale di costo per gravità, riportato con attribuzione all'OCSE — dai circa 511 euro dei quadri lievi ai circa 10.485 euro dei gravi —, fonda la leva dell'intercettazione precoce, il cui valore aggregato è portato al massimo dalla scala della Regione più popolosa d'Italia. ↑
302. I cinque risultati chiave isolano gli esiti principali: costo-efficacia su tutti gli orizzonti, robustezza del verdetto tripartito, attuazione per gradini imposta dal fabbisogno più elevato d'Italia, maturità del terreno di adozione digitale, necessità di raccordo fra programmazione e erogazione nell'architettura duale. ↑
303. Le raccomandazioni indicano l'attuazione per gradini pluriennali verso il regime di 2.190 incarichi con gradino intermedio dell'ordine di 1.100, il presidio del raccordo ATS-ASST per l'omogeneità della copertura e il piano formativo a quattro modalità alla scala del più grande sistema formativo regionale. ↑
304. Il territorio lombardo — circa 10.033.918 abitanti, un sesto del Paese, dodici province, otto ATS con funzione di programmazione e ventisette ASST con funzione di erogazione, circa cento distretti — tiene insieme la più grande area metropolitana del Paese, la pianura e le valli alpine. ↑
305. Il quadro epidemiologico regionale riflette la prevalenza nazionale applicata alla popolazione più numerosa del Paese, con il volume assoluto del bisogno massimo fra le Regioni; il dato di dettaglio è in Appendice B e le lacune sono dichiarate, non colmate con stime tacite. ↑
306. Il divario di trattamento lombardo assume la doppia forma della coda d'attesa pubblica e della barriera economica privata, con una quota della domanda assorbita dal settore privato a spese delle famiglie; la misura regionale è in Appendice B e i valori medi sono riportati con attribuzione. ↑

307. Il tratto distintivo della domanda lombarda è la scala: ogni punto percentuale di intercettazione si traduce in decine di migliaia di persone; la capillarità distrettuale è condizione perché la risposta pubblica raggiunga metropoli e valli, riequilibrando la deriva privata. ↑
308. Espansione ex novo: il modello colloca lo Psicologo di Base al vertice della cascata nel distretto e nelle Case della Comunità e opera per intensità crescente di cura; l'efficacia clinica è documentata dalla meta-analisi sull'assistenza collaborativa e dalle sperimentazioni sull'intervento digitale, riportate con attribuzione. ↑
309. L'adattamento al territorio lombardo segue le direttrici dell'innesto nell'architettura duale con presidio del raccordo ATS-ASST, della capillarità distrettuale nei circa cento distretti e del riequilibrio pubblico rispetto alla deriva privata; l'architettura invariante del Reference Case non è modificata. ↑
310. Il costo diretto comprende il personale, la struttura, la leva digitale e la formazione; il fabbisogno a regime è dell'ordine di 2.190 incarichi, il più elevato d'Italia, con gradino intermedio dell'ordine di 1.100 e costo annuo da circa 60 a circa 120 milioni di euro a regime secondo lo scenario. ↑
311. Il costo diretto è calcolato per i tre scenari coerenti con il protocollo del Reference Case; la progressione per gradini è imposta dalla capacità di assorbimento formativa e concorsuale, i valori puntuali sono nell'estrazione economica registrata e le lacune sono dichiarate. ↑
312. Il beneficio diretto comprende la demedicalizzazione, la deprescrizione, la riduzione degli accessi impropri e delle prestazioni per sintomi funzionali; alla scala lombarda il volume assoluto dei benefici è il massimo del Paese. ↑
313. Il beneficio indiretto comprende la produttività recuperata — di massimo peso assoluto fra le Regioni per il primo mercato del lavoro del Paese —, gli oneri previdenziali evitati e la riduzione del disagio sociale. ↑
314. La valutazione economica è condotta con il modello di Markov a coorte del Reference Case sotto doppio ancoraggio; le due colonne sono sempre affiancate, la Colonna B prevale nel giudizio e ogni cifra è riportata con attribuzione. ↑
315. Il differenziale di costo per gravità, riportato con attribuzione all'OCSE, ha in Lombardia valore aggregato massimo: alla popolazione più numerosa corrisponde il più grande serbatoio di progressioni evitabili e dunque il più grande risparmio potenziale in valore assoluto. ↑
316. I sei domini di analisi sono applicati alla specificità lombarda, dal volume massimo del bisogno al raccordo nell'architettura duale, tenuti distinti e non aggregati. ↑
317. Il dominio dell'equità assume doppia direzione, economico-sociale per il riequilibrio del gradiente di reddito indotto dalla deriva privata e territoriale per la convergenza fra metropoli e valli alpine; l'effetto distributivo è tenuto distinto dai verdetti fiscale e sanitario. ↑
318. Espansione ex novo: l'analisi dell'incertezza applica il protocollo obbligatorio del Reference Case; in Lombardia i parametri critici attesi sono la capacità di reclutamento alla scala dei 2.190 incarichi, l'efficacia del raccordo ATS-ASST e il tasso di riassorbimento pubblico della domanda privata. ↑
319. L'analisi di scenario mostra il verdetto tripartito favorevole nei tre casi con margine crescente; lo strato digitale accresce l'efficienza attesa con nota di cautela, e le curve di accettabilità confermano la robustezza del costo-efficacia in ciascun gradino della progressione. ↑
320. Il verdetto lombardo è tripartito e non aggregato: prossimo al pareggio sul piano fiscale, nettamente costo-efficace sul piano sanitario, fortemente positivo sul piano sociale, con il rilievo massimo in valore assoluto della produttività protetta. ↑
321. Espansione ex novo: le raccomandazioni indicano l'attuazione per gradini pluriennali verso il regime, il presidio del raccordo ATS-ASST, il riequilibrio pubblico quale obiettivo esplicito di equità, il piano formativo a quattro modalità e un monitoraggio ex post ancorato agli indicatori dell'incertezza. ↑

322. Il Quadro Conclusivo ricompone la valutazione lombarda sotto doppio ancoraggio; il costo per anno di vita ponderato resta assai inferiore alle soglie e il differenziale di costo per gravità fonda la leva dell'intercettazione precoce, il cui valore aggregato raggiunge il massimo nazionale per effetto della scala. ↑
323. Il Volume 11 applica per rimando il Reference Case dell'asse italiano fissato nel Volume 0.A, richiamandone le regole nella forma «cfr. Volume 0.A» senza ripeterle per esteso. ↑
324. La struttura del Volume è standard e identica a quella degli altri Volumi regionali; i contenuti di espansione ex novo sono segnalati in nota editoriale, e il verdetto economico è ricostruito ex novo sotto il doppio ancoraggio senza riutilizzare i rapporti sintetici del materiale regionale preesistente. ↑
325. Il perimetro è quello delle Marche — circa 1.480.000 abitanti, Azienda Sanitaria Unica Regionale riarticolata in cinque Aziende Sanitarie Territoriali su base provinciale — con le aree interne segnate dal sisma del 2016 quale chiave di lettura, insieme allo spopolamento e all'invecchiamento. ↑
326. Il cruscotto riassume in una pagina i parametri essenziali sotto doppio ancoraggio, con il verdetto tripartito distinto; le cifre di letteratura sono riportate con attribuzione e i valori economici in ordine di grandezza. ↑
327. Il verdetto marchigiano è tripartito e non aggregato; sul piano sociale ha rilievo particolare il sostegno alle comunità delle aree interne segnate dal sisma, con il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento. ↑
328. Il differenziale di costo per gravità, riportato con attribuzione all'OCSE, fonda la leva dell'intercettazione precoce, di peso specifico particolare nelle aree interne appenniniche dove il trauma del sisma e l'isolamento aggravano il rischio di cronicizzazione. ↑
329. I cinque risultati chiave isolano gli esiti principali: costo-efficacia su tutti gli orizzonti, robustezza del verdetto tripartito, baricentro della domanda spostato verso il disagio post-traumatico, effetto moltiplicativo dello strato digitale nelle aree interne, occasione di programmazione coordinata offerta dalla riarticolazione in cinque Aziende Sanitarie Territoriali. ↑
330. Le raccomandazioni indicano l'estensione progressiva verso il fabbisogno a regime dell'ordine di trecentoventi incarichi con priorità alle aree del sisma, lo strato digitale come leva di prossimità, la valorizzazione delle cinque Aziende Sanitarie Territoriali e il piano formativo a quattro modalità con competenze sul trauma collettivo. ↑
331. Il territorio marchigiano — cinque province dalla costa alle aree interne appenniniche, Azienda Sanitaria Unica Regionale riarticolata in cinque Aziende Sanitarie Territoriali — conosce nelle aree interne un invecchiamento accentuato e uno spopolamento aggravato dal sisma del 2016, con ricostruzione ancora in corso e disagio post-traumatico diffuso. ↑
332. Il quadro epidemiologico regionale riflette la prevalenza nazionale dei disturbi comuni, con una componente aggiuntiva connessa al trauma del sisma e all'isolamento delle aree interne; il dato di dettaglio è in Appendice B e le lacune sono dichiarate, non colmate con stime tacite. ↑
333. Il divario di trattamento marchigiano è accentuato nelle aree interne dalla distanza, dalla rarefazione dell'offerta e dalla dispersione aggravata dal sisma, con la componente specifica del disagio post-traumatico spesso non intercettato; la misura regionale è in Appendice B e i valori medi sono riportati con attribuzione. ↑
334. Il tratto distintivo della domanda marchigiana è la condizione delle aree interne segnate dal sisma; la collocazione distrettuale dello Psicologo di Base porta la risposta vicino a comunità isolate e fragili, intercettando un disagio altrimenti sommerso, ed è condizione dell'efficacia, dell'equità e della coesione delle comunità della ricostruzione. ↑

335. Espansione ex novo: il modello colloca lo Psicologo di Base al vertice della cascata nel distretto e opera per intensità crescente di cura; l'efficacia clinica è documentata dalla meta-analisi sull'assistenza collaborativa e dalle sperimentazioni sull'intervento digitale, riportate con attribuzione. ↑
336. L'adattamento al territorio marchigiano segue le direttrici della prossimità distrettuale, dell'attenzione al disagio post-traumatico e dello strato digitale, senza modificare l'architettura invariante del Reference Case, valorizzando la riarticolazione in cinque Aziende Sanitarie Territoriali per una programmazione coordinata. ↑
337. Il costo diretto comprende il personale, la struttura, la leva digitale e la formazione; il dimensionamento progredisce fino al fabbisogno a regime dell'ordine di trecentoventi incarichi, distribuiti nei distretti delle cinque Aziende Sanitarie Territoriali con priorità alle aree del sisma. ↑
338. Il costo diretto è calcolato per i tre scenari di copertura coerenti con il protocollo del Reference Case, con lo scenario esteso allineato al fabbisogno a regime dell'ordine di trecentoventi incarichi; i valori puntuali sono nell'estrazione economica registrata e le lacune sono dichiarate. ↑
339. Il beneficio diretto comprende la demedicalizzazione, la deprescrizione, la riduzione degli accessi impropri e delle prestazioni per sintomi funzionali; nelle Marche l'intercettazione precoce del disagio post-traumatico nelle aree del sisma previene la cronicizzazione con un beneficio diretto specifico. ↑
340. Il beneficio indiretto comprende la produttività recuperata, gli oneri previdenziali evitati e la riduzione del disagio sociale; nelle Marche il sostegno alla coesione delle comunità della ricostruzione assume rilievo particolare. ↑
341. La valutazione economica è condotta con il modello di Markov a coorte del Reference Case sotto doppio ancoraggio; le due colonne sono sempre affiancate, la Colonna B prevale nel giudizio, ogni cifra è riportata con attribuzione e il verdetto è ricostruito ex novo senza riutilizzare rapporti sintetici del materiale preesistente. ↑
342. Il differenziale di costo per gravità, riportato con attribuzione all'OCSE, ha nelle Marche peso specifico particolare, perché il trauma del sisma e l'isolamento delle aree interne accrescono il rischio di progressione del disagio non intercettato verso la cronicizzazione. ↑
343. I sei domini di analisi sono applicati alla specificità marchigiana, dalla sottodiagnosi delle aree interne alla programmazione coordinata nelle cinque Aziende Sanitarie Territoriali, tenuti distinti e non aggregati. ↑
344. Il dominio dell'equità assume direzione territoriale accentuata dalla condizione post-sisma; il modello opera sulla frattura fra costa e aree interne attraverso la capillarità distrettuale e lo strato digitale, e l'effetto distributivo è tenuto distinto dai verdetti fiscale e sanitario, mentre il sostegno alla coesione costituisce un valore sociale non riducibile al saldo economico. ↑
345. Espansione ex novo: l'analisi dell'incertezza applica il protocollo obbligatorio del Reference Case; nelle Marche i parametri critici attesi sono il tasso di intercettazione del disagio post-traumatico, l'efficacia della prossimità nelle aree interne e l'adozione digitale nelle comunità della ricostruzione. ↑
346. L'analisi di scenario mostra il verdetto tripartito favorevole nei tre casi con margine crescente; lo strato digitale accresce l'efficienza attesa con nota di cautela, e le curve di accettabilità confermano la robustezza del costo-efficacia alle soglie adottate. ↑
347. Il verdetto marchigiano è tripartito e non aggregato: prossimo al pareggio sul piano fiscale, nettamente costo-efficace sul piano sanitario, fortemente positivo sul piano sociale, con il rilievo specifico delle comunità delle aree interne segnate dal sisma. ↑

348. Espansione ex novo: le raccomandazioni indicano l'attuazione progressiva verso il fabbisogno a regime con priorità alle aree del sisma, lo strato digitale come leva di prossimità, la valorizzazione delle cinque Aziende Sanitarie Territoriali, il piano formativo a quattro modalità con competenze sul trauma e un monitoraggio ex post ancorato agli indicatori dell'incertezza. ↑
349. Il Quadro Conclusivo ricompone la valutazione marchigiana sotto doppio ancoraggio; il costo per anno di vita ponderato resta assai inferiore alle soglie e il differenziale di costo per gravità fonda la leva dell'intercettazione precoce, tanto più preziosa nelle aree interne dove il trauma del sisma accresce il rischio di cronicizzazione, con verdetto ricostruito ex novo. ↑
350. Il Volume 12 applica per rimando il Reference Case dell'asse italiano fissato nel Volume 0.A, richiamandone le regole nella forma «cfr. Volume 0.A» senza ripeterle per esteso. ↑
351. La struttura del Volume è standard e identica a quella degli altri Volumi regionali; i contenuti di espansione ex novo sono segnalati in nota editoriale, e il verdetto economico è ricostruito ex novo sotto il doppio ancoraggio senza riutilizzare i rapporti sintetici del materiale regionale preesistente. ↑
352. Il perimetro è quello del Molise — circa 289.224 abitanti, la più piccola Regione ordinaria, ASReM azienda sanitaria unica regionale con tre distretti e centotrentasei comuni — con la piccola scala, l'invecchiamento e il vincolo di bilancio del piano di rientro quali chiavi di lettura. ↑
353. Il cruscotto riassume in una pagina i parametri essenziali sotto doppio ancoraggio, con il verdetto tripartito distinto; le cifre di letteratura sono riportate con attribuzione e i valori economici in ordine di grandezza. ↑
354. Il verdetto molisano è tripartito e non aggregato; la piccola dimensione contiene il costo assoluto entro margini compatibili con il piano di rientro, e sul piano sociale ha rilievo particolare la tenuta delle comunità interne, con il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento. ↑
355. Il differenziale di costo per gravità, riportato con attribuzione all'OCSE, fonda la leva dell'intercettazione precoce, di peso specifico particolare in una Regione a domanda strutturalmente anziana e a risorse contenute come il Molise. ↑
356. I cinque risultati chiave isolano gli esiti principali: costo-efficacia su tutti gli orizzonti, robustezza del verdetto tripartito, costo assoluto contenuto compatibile con il piano di rientro, effetto moltiplicativo dello strato digitale, governance semplice e unitaria dell'azienda sanitaria unica. ↑
357. Le raccomandazioni indicano l'estensione progressiva verso il fabbisogno a regime dell'ordine di sessantatré incarichi coerente con i programmi operativi, lo strato digitale come leva di prossimità e di efficienza, la valorizzazione della governance unitaria e il piano formativo a quattro modalità. ↑
358. Il territorio molisano — due province, centotrentasei comuni in larga parte piccoli e interni, ASReM azienda sanitaria unica con tre distretti — ha una struttura demografica fra le più anziane del Paese e aree interne a spopolamento accentuato, in un contesto di finanza sanitaria condizionato dal piano di rientro. ↑
359. Il quadro epidemiologico regionale riflette la prevalenza nazionale dei disturbi comuni, con baricentro spostato verso la depressione dell'età avanzata e una domanda fortemente orientata verso le comunità interne; il dato di dettaglio è in Appendice B e le lacune sono dichiarate, non colmate con stime tacite. ↑
360. Il divario di trattamento molisano è accentuato nelle aree interne dalla distanza, dalla rarefazione dell'offerta e dalla piccola scala, con ricorso alla mobilità sanitaria verso le regioni contigue; la misura regionale è in Appendice B e i valori medi sono riportati con attribuzione. ↑
361. Il tratto distintivo della domanda molisana è la componente anziana delle aree interne; la collocazione distrettuale dello Psicologo di Base porta la risposta vicino a comunità isolate, riducendo la distanza, il ricorso improprio e la mobilità passiva verso le regioni vicine, ed è condizione dell'efficacia, dell'equità e del contenimento della fuga di domanda. ↑

362. Espansione ex novo: il modello colloca lo Psicologo di Base al vertice della cascata nel distretto e opera per intensità crescente di cura; l'efficacia clinica è documentata dalla meta-analisi sull'assistenza collaborativa e dalle sperimentazioni sull'intervento digitale, riportate con attribuzione. ↑
363. L'adattamento al territorio molisano segue le direttrici della prossimità distrettuale, dello strato digitale e della governance unitaria, senza modificare l'architettura invariante del Reference Case, calibrandone l'applicazione sulla piccola scala, sull'invecchiamento e sul contesto del piano di rientro. ↑
364. Il costo diretto comprende il personale, la struttura, la leva digitale e la formazione; il dimensionamento progredisce fino al fabbisogno a regime dell'ordine di sessantatré incarichi nei tre distretti dell'azienda unica, con un costo assoluto contenuto per la piccola scala regionale. ↑
365. Il costo diretto è calcolato per i tre scenari di copertura coerenti con il protocollo del Reference Case, con lo scenario esteso allineato al fabbisogno a regime dell'ordine di sessantatré incarichi; la piccola dimensione agevola la compatibilità con il vincolo di bilancio, i valori puntuali sono nell'estrazione economica registrata e le lacune sono dichiarate. ↑
366. Il beneficio diretto comprende la demedicalizzazione, la deprescrizione, la riduzione degli accessi impropri e delle prestazioni per sintomi funzionali, cui si aggiunge la riduzione della mobilità passiva verso le regioni contigue, beneficio diretto specifico che allevia sia la spesa sia il divario di accesso. ↑
367. Il beneficio indiretto comprende la produttività recuperata, gli oneri previdenziali evitati e la riduzione del disagio sociale; in Molise la tenuta del tessuto sociale delle comunità interne assume rilievo particolare. ↑
368. La valutazione economica è condotta con il modello di Markov a coorte del Reference Case sotto doppio ancoraggio; le due colonne sono sempre affiancate, la Colonna B prevale nel giudizio, ogni cifra è riportata con attribuzione e il verdetto è ricostruito ex novo senza riutilizzare rapporti sintetici del materiale preesistente. ↑
369. Il differenziale di costo per gravità, riportato con attribuzione all'OCSE, ha in Molise peso specifico particolare, perché la sottodiagnosi nelle aree interne anziane favorisce la progressione e la mobilità passiva, in relazione alla piccola scala e al vincolo di bilancio. ↑
370. I sei domini di analisi sono applicati alla specificità molisana, dalla sottodiagnosi anziana interna alla governance unitaria nel piano di rientro, tenuti distinti e non aggregati. ↑
371. Il dominio dell'equità assume direzione territoriale accentuata dalla piccola scala e dallo spopolamento; il modello opera sulla frattura fra centri e aree interne attraverso la capillarità distrettuale e lo strato digitale, e l'effetto distributivo è tenuto distinto dai verdetti fiscale e sanitario, mentre la piccola dimensione rende l'intervento sostenibile in valore assoluto nel piano di rientro. ↑
372. Espansione ex novo: l'analisi dell'incertezza applica il protocollo obbligatorio del Reference Case; in Molise i parametri critici attesi sono il tasso di intercettazione nella popolazione anziana interna, il grado di contenimento della mobilità passiva e la capacità di reclutamento alla piccola scala. ↑
373. L'analisi di scenario mostra il verdetto tripartito favorevole nei tre casi con margini crescente; lo strato digitale accresce l'efficienza attesa con nota di cautela, le curve di accettabilità confermano la robustezza del costo-efficacia e la piccola scala mantiene il costo assoluto entro margini compatibili con il vincolo di bilancio. ↑
374. Il verdetto molisano è tripartito e non aggregato: prossimo al pareggio sul piano fiscale con costo assoluto contenuto e compatibile con il piano di rientro, nettamente costo-efficace sul piano sanitario, fortemente positivo sul piano sociale con il rilievo specifico delle comunità interne. ↑

375. Espansione ex novo: le raccomandazioni indicano l'attuazione progressiva verso il fabbisogno a regime coerente con i programmi operativi, lo strato digitale come leva di prossimità e di efficienza, la valorizzazione della governance unitaria, il piano formativo a quattro modalità e un monitoraggio ex post ancorato agli indicatori dell'incertezza con attenzione al contenimento della mobilità passiva. ↑
376. Il Quadro Conclusivo ricomponi la valutazione molisana sotto doppio ancoraggio; il costo per anno di vita ponderato resta assai inferiore alle soglie e il differenziale di costo per gravità fonda la leva dell'intercettazione precoce, tanto più preziosa in una Regione piccola e anziana dove la sottodiagnosi favorisce la progressione e la mobilità passiva, con verdetto ricostruito ex novo. ↑
377. Il Volume 13 applica per rimando il Reference Case dell'asse italiano fissato nel Volume 0.A, richiamandone le regole nella forma «cfr. Volume 0.A» senza ripeterle per esteso. ↑
378. La struttura del Volume è standard e identica a quella degli altri Volumi regionali, a garanzia della comparabilità bit-a-bit; i contenuti di espansione ex novo sono segnalati in nota editoriale. ↑
379. Il perimetro è quello del Piemonte — circa 4.251.868 abitanti, dodici ASL, quattro AOU e due AO — con il servizio di Psicologia delle cure primarie già attivo dal 2023 a quota capitaria, dimensionato a circa il cinque per cento del fabbisogno, quale tratto distintivo, insieme all'invecchiamento e alle aree interne e alpine in spopolamento. ↑
380. Il cruscotto riassume in una pagina i parametri essenziali sotto doppio ancoraggio, con il verdetto tripartito distinto; le cifre di letteratura sono riportate con attribuzione e i valori economici in ordine di grandezza. ↑
381. Il verdetto piemontese è tripartito e non aggregato; sul piano sociale ha rilievo particolare la tenuta delle aree interne e alpine anziane e in spopolamento, con il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento. ↑
382. La presenza del servizio attivo muta la natura della decisione — stabilizzare e dimensionare anziché istituire — e fornisce una base di dati che riduce l'incertezza; il differenziale di costo per gravità, riportato con attribuzione all'OCSE, resta l'argomento cardine dell'intercettazione precoce. ↑
383. I cinque risultati chiave isolano gli esiti principali: costo-efficacia su tutti gli orizzonti, robustezza del verdetto tripartito, unicità del caso piemontese della stabilizzazione con base empirica, telepsicologia assistita per le aree interne, necessità di trasformare il rapporto libero-professionale in dotazione strutturale. ↑
384. Le raccomandazioni indicano il passaggio dalla stabilizzazione al dimensionamento verso i settecento e i novecentoventi incarichi, la valorizzazione dei dati del servizio attivo in un cruscotto permanente, la telepsicologia assistita per le aree interne e il piano formativo a quattro modalità. ↑
385. Il territorio piemontese — area metropolitana di Torino, pianura, colline e arco alpino con aree interne in spopolamento, dodici ASL, quattro AOU e due AO — è segnato da un invecchiamento con saldo naturale fortemente negativo e dal servizio di Psicologia delle cure primarie già attivo dal 2023. ↑
386. Il quadro epidemiologico regionale riflette la prevalenza nazionale, con baricentro verso la depressione dell'età avanzata e componente di disagio urbano metropolitano; il servizio attivo costituisce una prima fonte di dati regionali che integra l'Appendice B, e le lacune sono dichiarate. ↑
387. Il divario di trattamento piemontese non è l'assenza del servizio ma la distanza fra la sua scala attuale — circa il cinque per cento del fabbisogno — e la scala del bisogno, aggravata nelle aree interne e alpine dalla distanza fisica; la misura regionale è in Appendice B con valori medi riportati con attribuzione. ↑
388. Il tratto distintivo della domanda piemontese è la coesistenza di un bisogno in larga parte scoperto e di un canale di risposta già operante, che ha dimostrato la praticabilità dell'intercettazione e prodotto i primi dati di esito; la prossimità è la direzione del dimensionamento, con la telepsicologia assistita quale complemento

nelle aree interne. ↑

389. Espansione ex novo: il modello colloca lo Psicologo di Base al vertice della cascata nel distretto e opera per intensità crescente di cura; l'efficacia clinica è documentata dalla meta-analisi sull'assistenza collaborativa e dalle sperimentazioni sull'intervento digitale, riportate con attribuzione. ↑
390. L'adattamento al territorio piemontese segue le direttrici della trasformazione del servizio esistente in dotazione strutturale, della prossimità nelle aree interne con telepsicologia assistita e dell'aggancio alle Case della Comunità; l'architettura invariante del Reference Case non è modificata. ↑
391. Il costo diretto comprende il personale, la struttura, la leva digitale e la formazione; il dimensionamento muove dal servizio esistente verso i settecento incarichi dello scenario base e i novecentoventi dell'espansivo, e il gradino conservativo puntuale è oggetto di lacuna dichiarata. ↑
392. Il costo diretto è calcolato per i tre scenari coerenti con il protocollo del Reference Case; il costo del servizio esistente, già a bilancio, riduce l'incremento netto richiesto, i valori puntuali sono nell'estrazione economica registrata e le lacune — incluso il gradino conservativo — sono dichiarate. ↑
393. Il beneficio diretto comprende la demedicalizzazione, la deprescrizione, la riduzione degli accessi impropri e delle prestazioni per sintomi funzionali; il servizio attivo fornisce una base parziale di dati reali che ancora la stima a osservazioni regionali riducendo l'incertezza. ↑
394. Il beneficio indiretto comprende la produttività recuperata nel tessuto manifatturiero e terziario, gli oneri previdenziali evitati e la riduzione del disagio sociale; la tenuta delle comunità delle aree interne e alpine assume rilievo particolare. ↑
395. La valutazione economica è condotta con il modello di Markov a coorte del Reference Case sotto doppio ancoraggio; le due colonne sono sempre affiancate, la Colonna B prevale nel giudizio, ogni cifra è riportata con attribuzione e i dati reali del servizio attivo integrano i parametri di letteratura. ↑
396. Il differenziale di costo per gravità, riportato con attribuzione all'OCSE, è in Piemonte osservabile su dati regionali grazie al servizio attivo, e il dimensionamento a regime estende la leva alla scala del fabbisogno. ↑
397. I sei domini di analisi sono applicati alla specificità piemontese, dal divario fra scala attuale e scala del bisogno alla trasformazione del servizio in dotazione strutturale, tenuti distinti e non aggregati. ↑
398. Il dominio dell'equità assume direzione territoriale — fra metropoli e aree interne e alpine — e organizzativa, con la trasformazione contrattuale quale condizione di stabilità e omogeneità della copertura; l'effetto distributivo è tenuto distinto dai verdetti fiscale e sanitario. ↑
399. Espansione ex novo: l'analisi dell'incertezza applica il protocollo obbligatorio del Reference Case; in Piemonte i parametri critici attesi sono la trasferibilità dei dati del servizio attivo alla scala, la velocità della trasformazione in dotazione strutturale e l'adozione della telepsicologia nelle aree interne. ↑
400. L'analisi di scenario mostra il verdetto tripartito favorevole nei tre casi con margine crescente; lo strato digitale accresce l'efficienza attesa con nota di cautela, le curve di accettabilità confermano la robustezza del costo-efficacia e la base empirica del servizio attivo restringe gli intervalli di incertezza. ↑
401. Il verdetto piemontese è tripartito e non aggregato: prossimo al pareggio sul piano fiscale, nettamente costo-efficace sul piano sanitario, fortemente positivo sul piano sociale con il rilievo specifico delle aree interne e alpine. ↑
402. Espansione ex novo: le raccomandazioni indicano il passaggio dalla stabilizzazione al dimensionamento, la trasformazione contrattuale in dotazione strutturale, la priorità alle aree interne con telepsicologia assistita, il cruscotto regionale permanente sui dati del servizio attivo, il piano formativo a quattro modalità e un monitoraggio ex post ancorato agli indicatori dell'incertezza. ↑

403. Il Quadro Conclusivo ricompone la valutazione piemontese sotto doppio ancoraggio; il costo per anno di vita ponderato resta assai inferiore alle soglie e il differenziale di costo per gravità fonda la leva dell'intercettazione precoce, osservabile su dati regionali e estesa dal dimensionamento alla scala del fabbisogno. ↑
404. Il Volume 14 applica per rimando il Reference Case dell'asse italiano fissato nel Volume 0.A, richiamandone le regole nella forma «cfr. Volume 0.A» senza ripeterle per esteso; la Puglia è la Regione capostipite, avendo promulgato con la legge regionale 11 del 2023 la prima legge istitutiva del Servizio di Psicologia di Base. ↑
405. La struttura del Volume è standard e identica a quella degli altri Volumi regionali, a garanzia della comparabilità bit-a-bit; il Volume costituisce la sintesi comparabile dello studio integrale pugliese in quindici Parti, e i contenuti di espansione ex novo sono segnalati in nota editoriale. ↑
406. Il perimetro è quello della Puglia — circa 3.877.395 abitanti, sei ASL (Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto) e quarantacinque distretti — con la vigenza della legge regionale 11 del 2023 quale tratto distintivo: il modello valutato è una riforma già istituita, non un'ipotesi. ↑
407. Il cruscotto riassume in una pagina i parametri essenziali sotto doppio ancoraggio, con il verdetto tripartito distinto; le cifre di letteratura sono riportate con attribuzione e i valori economici in ordine di grandezza. ↑
408. Il verdetto pugliese è tripartito e non aggregato; sul piano sociale ha rilievo particolare la riduzione della mobilità sanitaria passiva, la coesione e la tenuta delle aree interne, con il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento. ↑
409. La vigenza della legge istitutiva muta la natura della decisione — dare piena attuazione e dimensionare anziché deliberare se istituire — entro il costo a regime dell'ordine di quarantaquattro-quarantasette milioni di euro l'anno; il differenziale di costo per gravità, riportato con attribuzione all'OCSE, resta l'argomento cardine. ↑
410. I cinque risultati chiave isolano gli esiti principali: costo-efficacia su tutti gli orizzonti, robustezza del verdetto tripartito, ruolo capostipite della Puglia con riforma vigente e tre scenari di copertura, leva digitale a sostegno della prossimità, riduzione della mobilità sanitaria passiva quale beneficio specifico. ↑
411. Le raccomandazioni indicano la piena attuazione della legge 11 del 2023 dallo scenario di seicentoventi verso quello di settecentosettantacinque e di novecento incarichi, un cruscotto regionale permanente che misuri la mobilità passiva, la leva digitale per le aree interne e il piano formativo a quattro modalità. ↑
412. Il territorio pugliese — area metropolitana di Bari, poli del Salento e della Capitanata, aree interne dal Subappennino Dauno alle Murge, sei ASL e quarantacinque distretti — è caratterizzato dalla vigenza della legge regionale 11 del 2023 che ha istituito il Servizio di Psicologia di Base. ↑
413. Il quadro epidemiologico regionale riflette la prevalenza nazionale, con componente di disagio giovanile urbano e domanda inespressa nelle aree interne; la misura è oggetto dell'Appendice B, e le lacune sono dichiarate e non colmate con stime tacite. ↑
414. Il divario di trattamento pugliese si manifesta come domanda inevasa, domanda impropria e — tratto specifico — mobilità sanitaria passiva verso altre Regioni, aggravata nelle aree interne dalla distanza fisica; la misura regionale è in Appendice B con valori medi riportati con attribuzione. ↑
415. Il tratto distintivo della domanda pugliese è la sua parziale traduzione in mobilità sanitaria passiva, che il modello dello Psicologo di Base può ridurre trattenendo la domanda comune nel circuito territoriale; la riduzione della mobilità passiva è insieme beneficio economico diretto e indicatore di prossimità ed equità. ↑
416. Espansione ex novo: il modello colloca lo Psicologo di Base al vertice della cascata nel distretto — assetto tradotto in norma dalla legge 11 del 2023 — e opera per intensità crescente di cura; l'efficacia clinica è documentata dalla meta-analisi sull'assistenza collaborativa e dalle sperimentazioni sull'intervento digitale,

riportate con attribuzione. ↑

417. L'adattamento al territorio pugliese segue le direttrici della piena attuazione della legge istitutiva, della prossimità nelle aree interne con leva digitale e della funzione di argine alla mobilità sanitaria passiva; l'architettura invariante del Reference Case non è modificata. ↑
418. Il costo diretto comprende il personale, la struttura, la leva digitale e la formazione; il dimensionamento è scandito dai tre scenari di seicentoventi, settecentosettantacinque e novecento incarichi, con un costo a regime dell'ordine di quarantatré-quarantasette milioni di euro l'anno riportato nell'estrazione economica. ↑
419. Il costo diretto è calcolato per i tre scenari coerenti con il protocollo del Reference Case: dallo scenario iniziale di seicentoventi incarichi a circa quarantaquattro milioni di euro, a quelli di settecentosettantacinque e novecento verso i quarantasette-quarantotto milioni l'anno; i valori puntuali sono in Appendice C e le lacune sono dichiarate. ↑
420. Il beneficio diretto comprende la demedicalizzazione, la deprescrizione, la riduzione degli accessi impropri e — tratto specifico della Puglia — la riduzione della mobilità sanitaria passiva; il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento è mantenuto ovunque il risparmio sia quantificato. ↑
421. Il beneficio indiretto comprende la produttività recuperata, gli oneri previdenziali evitati e la riduzione del disagio sociale; la tenuta delle comunità delle aree interne e il contrasto della mobilità sanitaria assumono rilievo particolare. ↑
422. La valutazione economica è condotta con il modello di Markov a coorte del Reference Case sotto doppio ancoraggio; le due colonne sono sempre affiancate, la Colonna B prevale nel giudizio e ogni cifra è riportata con attribuzione. ↑
423. Il differenziale di costo per gravità, riportato con attribuzione all'OCSE, si somma in Puglia al risparmio proprio della riduzione della mobilità sanitaria passiva; i due argomenti sono tenuti distinti e non sommati fra loro né con i ritorni sociali. ↑
424. I sei domini di analisi sono applicati alla specificità pugliese, dagli oneri di invalidità evitabili e dalla mobilità passiva alla piena attuazione della legge istitutiva, tenuti distinti e non aggregati. ↑
425. Il dominio dell'equità assume direzione territoriale — fra Bari e le aree interne dalla Capitanata alle Murge — e istituzionale, con il ruolo capostipite della Puglia quale riferimento nazionale; l'effetto distributivo, inclusa la riduzione della mobilità passiva, è tenuto distinto dai verdetti fiscale e sanitario. ↑
426. Espansione ex novo: l'analisi dell'incertezza applica il protocollo obbligatorio del Reference Case; in Puglia i parametri critici attesi sono la velocità di attuazione della legge istitutiva, l'entità della riduzione della mobilità passiva e l'adozione della leva digitale nelle aree interne. ↑
427. L'analisi di scenario mostra il verdetto tripartito favorevole nei tre casi con margine crescente; lo strato digitale accresce l'efficienza attesa con nota di cautela, le curve di accettabilità confermano la robustezza del costo-efficacia e il disegno normativo già vigente riduce l'incertezza attuativa. ↑
428. Il verdetto pugliese è tripartito e non aggregato: prossimo al pareggio sul piano fiscale con il concorso distinto del risparmio da mobilità passiva, nettamente costo-efficace sul piano sanitario, fortemente positivo sul piano sociale con il rilievo specifico della coesione e delle aree interne. ↑
429. Espansione ex novo: le raccomandazioni indicano la piena attuazione della legge 11 del 2023 attraverso i tre scenari di copertura, la priorità ai distretti a maggiore divario, un cruscotto regionale permanente sugli esiti e sulla mobilità passiva, la leva digitale sotto supervisione, il piano formativo a quattro modalità e un monitoraggio ex post che valga di dimostrazione per le altre Regioni. ↑

430. Il Quadro Conclusivo ricompone la valutazione pugliese sotto doppio ancoraggio; il costo per anno di vita ponderato resta assai inferiore alle soglie e il differenziale di costo per gravità, cui si aggiunge il risparmio da riduzione della mobilità passiva tenuto distinto, fonda la leva economica dell'intercettazione precoce nel caso capostipite dell'opera. ↑
431. Il Volume 15 applica per rimando il Reference Case dell'asse italiano fissato nel Volume 0.A, richiamandone le regole nella forma «cfr. Volume 0.A» senza ripeterle per esteso. ↑
432. La struttura del Volume è standard e identica a quella degli altri Volumi regionali, a garanzia della comparabilità bit-a-bit; i contenuti di espansione ex novo sono segnalati in nota editoriale. ↑
433. Il perimetro è quello della Sardegna — circa 1.562.381 abitanti, otto Aziende socio-sanitarie locali coordinate da ARES — con la condizione insulare quale tratto distintivo: territorio a bassa densità, fra i più anziani d'Italia, dove la distanza e la separazione dal continente rendono oneroso l'accesso nelle aree interne segnate da spopolamento e denatalità. ↑
434. Il cruscotto riassume in una pagina i parametri essenziali sotto doppio ancoraggio, con il verdetto tripartito distinto; le cifre di letteratura sono riportate con attribuzione e i valori economici in ordine di grandezza. ↑
435. Il verdetto sardo è tripartito e non aggregato; sul piano sociale ha rilievo particolare la tenuta delle aree interne insulari, dove distanza e spopolamento aggravano la solitudine del disagio, con il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento. ↑
436. La condizione insulare rende la prossimità un valore di coesione territoriale oltre che clinico, e la telepsicologia assistita ne è complemento essenziale; il differenziale di costo per gravità, riportato con attribuzione all'OCSE, resta l'argomento cardine dell'intercettazione precoce. ↑
437. I cinque risultati chiave isolano gli esiti principali: costo-efficacia su tutti gli orizzonti, robustezza del verdetto tripartito, unicità del caso insulare, telepsicologia assistita quale complemento essenziale nelle aree interne, dimensionamento a regime di trecentoquaranta incarichi con copertura di dieci-diciannove milioni di euro l'anno secondo lo scenario. ↑
438. Le raccomandazioni indicano il passaggio per gradini dallo scenario di centosettanta verso quello di duecentocinquanta e di trecentoquaranta incarichi, il provvedimento di copertura finanziaria fin dall'avvio, la telepsicologia assistita per le aree interne insulari e il piano formativo a quattro modalità. ↑
439. Il territorio sardo — poli urbani di Cagliari e Sassari, città medie di Nuoro e Oristano, aree interne dalla Barbagia ai rilievi centrali, otto Aziende socio-sanitarie locali coordinate da ARES — è caratterizzato dalla condizione insulare e da una struttura demografica fra le più anziane d'Italia. ↑
440. Il quadro epidemiologico regionale riflette la prevalenza nazionale, con baricentro verso la depressione dell'età avanzata e domanda inespressa nelle aree interne insulari; la misura è oggetto dell'Appendice B, e le lacune sono dichiarate e non colmate con stime tacite. ↑
441. Il divario di trattamento sardo si manifesta come domanda inevasa e impropria, aggravata dalla condizione insulare e dalla bassa densità: nelle aree interne la distanza e la separazione dal continente rendono l'accesso oneroso; la misura regionale è in Appendice B con valori medi riportati con attribuzione. ↑
442. Il tratto distintivo della domanda sarda è la sua dispersione su un territorio insulare a bassa densità, dove la prossimità è più difficile e più necessaria; la presenza distrettuale e la telepsicologia assistita, sotto supervisione clinica, portano la risposta al disagio comune dentro le comunità insulari interne. ↑
443. Espansione ex novo: il modello colloca lo Psicologo di Base al vertice della cascata nel distretto e opera per intensità crescente di cura; l'efficacia clinica è documentata dalla meta-analisi sull'assistenza collaborativa e dalle sperimentazioni sull'intervento digitale, riportate con attribuzione. ↑

444. L'adattamento al territorio sardo segue le direttrici della prossimità distrettuale, della telepsicologia assistita quale complemento essenziale nelle aree interne e dell'aggancio alle Case della Comunità; l'architettura invariante del Reference Case non è modificata. ↑
445. Il costo diretto comprende il personale, la struttura, la leva digitale e la formazione; il dimensionamento è scandito dai tre scenari di centosettanta, duecentocinquanta e trecentoquaranta incarichi, con una copertura di dieci, quattordici e diciannove milioni di euro l'anno secondo lo scenario. ↑
446. Il costo diretto è calcolato per i tre scenari coerenti con il protocollo del Reference Case: dallo scenario conservativo di centosettanta incarichi a circa dieci milioni, a quello di base di duecentocinquanta a circa quattordici, a quello espansivo di trecentoquaranta a circa diciannove milioni l'anno; i valori puntuali sono in Appendice C e le lacune sono dichiarate. ↑
447. Il beneficio diretto comprende la demedicalizzazione, la deprescrizione, la riduzione degli accessi impropri e delle prestazioni per sintomi funzionali; la condizione insulare aggrava il costo unitario degli accessi impropri, e il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento è mantenuto ovunque il risparmio sia quantificato. ↑
448. Il beneficio indiretto comprende la produttività recuperata, gli oneri previdenziali evitati e la riduzione del disagio sociale; la tenuta delle comunità delle aree interne insulari, dove spopolamento e denatalità erodono legami e servizi, assume rilievo particolare. ↑
449. La valutazione economica è condotta con il modello di Markov a coorte del Reference Case sotto doppio ancoraggio; le due colonne sono sempre affiancate, la Colonna B prevale nel giudizio e ogni cifra è riportata con attribuzione. ↑
450. Il differenziale di costo per gravità, riportato con attribuzione all'OCSE, accresce in Sardegna il valore relativo dell'intercettazione precoce, poiché la progressione verso i quadri gravi comporta l'onere aggiuntivo della mobilità e degli accessi in un territorio dove le distanze rendono ogni prestazione più costosa. ↑
451. I sei domini di analisi sono applicati alla specificità sarda, dal divario aggravato dall'insularità alla copertura di un territorio a bassa densità, tenuti distinti e non aggregati. ↑
452. Il dominio dell'equità assume direzione insulare — fra i poli urbani e le aree interne dalla Barbagia ai rilievi centrali, dove distanza, separazione dal continente e spopolamento aggravano il divario; l'effetto distributivo, la riduzione del gradiente fra costa e interno, è tenuto distinto dai verdetti fiscali e sanitario. ↑
453. Espansione ex novo: l'analisi dell'incertezza applica il protocollo obbligatorio del Reference Case; in Sardegna i parametri critici attesi sono il costo unitario indotto dall'insularità, l'adozione della telepsicologia nelle aree interne e la velocità di copertura del territorio a bassa densità. ↑
454. L'analisi di scenario mostra il verdetto tripartito favorevole nei tre casi con margine crescente; lo strato digitale accresce l'efficienza attesa con nota di cautela, amplificato nel contesto insulare dalla telepsicologia assistita, e le curve di accettabilità confermano la robustezza del costo-efficacia. ↑
455. Il verdetto sardo è tripartito e non aggregato: prossimo al pareggio sul piano fiscale, nettamente costo-efficace sul piano sanitario, fortemente positivo sul piano sociale con il rilievo specifico delle aree interne insulari. ↑
456. Espansione ex novo: le raccomandazioni indicano il passaggio per gradini fra i tre scenari di copertura, il provvedimento di copertura finanziaria fin dall'avvio, la priorità alle aree interne insulari con la telepsicologia assistita, un cruscotto regionale permanente, il piano formativo a quattro modalità e un monitoraggio ex post ancorato agli indicatori dell'incertezza. ↑

457. Il Quadro Conclusivo ricompone la valutazione sarda sotto doppio ancoraggio; il costo per anno di vita ponderato resta assai inferiore alle soglie e il differenziale di costo per gravità fonda la leva dell'intercettazione precoce, il cui valore è accresciuto nel contesto insulare dall'onere che le distanze impongono a ogni prestazione tardiva. ↑
458. Il Volume 16 applica per rimando il Reference Case dell'asse italiano fissato nel Volume 0.A, richiamandone le regole nella forma «cfr. Volume 0.A» senza ripeterle per esteso. ↑
459. La struttura del Volume è standard e identica a quella degli altri Volumi regionali, a garanzia della comparabilità bit-a-bit; i contenuti di espansione ex novo sono segnalati in nota editoriale. ↑
460. Il perimetro è quello della Sicilia — circa 4.787.390 abitanti, la più popolosa fra le Regioni insulari, nove Aziende Sanitarie Provinciali — con la combinazione di insularità, statuto speciale (compartecipazione al finanziamento nella misura del quarantanove per cento circa del fabbisogno) e piano di rientro, che rende il vincolo sul saldo diretto più stringente e la spesa pro-capite fra le più basse del Paese. ↑
461. Il cruscotto riassume in una pagina i parametri essenziali sotto doppio ancoraggio, con il verdetto tripartito distinto; le cifre di letteratura sono riportate con attribuzione e i valori economici in ordine di grandezza. ↑
462. Il verdetto siciliano è tripartito e non aggregato; sul piano fiscale il vincolo del piano di rientro rende più stretto il margine diretto, mentre sul piano sociale ha rilievo particolare la tenuta delle aree interne e insulari e la riduzione della mobilità sanitaria passiva, fra le più elevate del Paese. ↑
463. La combinazione di insularità, statuto speciale e piano di rientro rende il vincolo sul saldo diretto più stretto e accresce il peso relativo dei ritorni sanitario e sociale, tenuti distinti; il differenziale di costo per gravità, riportato con attribuzione all'OCSE, resta l'argomento cardine dell'intercettazione precoce. ↑
464. I cinque risultati chiave isolano gli esiti principali: costo-efficacia su tutti gli orizzonti, robustezza del verdetto tripartito nel vincolo del rientro, combinazione di insularità, statuto speciale e piano di rientro, telepsicologia assistita per le aree interne, dimensionamento fra cinquecentoventi e milletrecenta incarichi con copertura di trentaquattro-sessantasette milioni di euro l'anno secondo lo scenario. ↑
465. Le raccomandazioni indicano il passaggio per gradini dallo scenario di cinquecentoventi verso quello di settecentottanta e di milletrecenta incarichi compatibilmente con i vincoli del rientro, dati di esito uniformi fra le nove Aziende, la telepsicologia assistita per le aree interne e il piano formativo a quattro modalità. ↑
466. Il territorio siciliano — grandi aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina, poli costieri, aree interne dai Nebrodi alle Madonie all'entroterra ennese, nove Aziende Sanitarie Provinciali — è caratterizzato dalla combinazione di insularità, statuto speciale con compartecipazione al finanziamento e piano di rientro, con spesa pro-capite fra le più basse del Paese. ↑
467. Il quadro epidemiologico regionale riflette la prevalenza nazionale, con componente di disagio giovanile metropolitano e domanda inespressa nelle aree interne e insulari; la misura è oggetto dell'Appendice B, e le lacune sono dichiarate e non colmate con stime tacite. ↑
468. Il divario di trattamento siciliano si manifesta come domanda inevasa e impropria, mobilità sanitaria passiva fra le più elevate del Paese e barriera insulare e interna aggravata dalla bassa spesa pro-capite; la misura regionale è in Appendice B con valori medi riportati con attribuzione. ↑
469. Il tratto distintivo della domanda siciliana è la sua parziale traduzione in mobilità sanitaria passiva e la sua dispersione su un territorio insulare a spesa pro-capite contenuta; la presenza distrettuale e la telepsicologia assistita, sotto supervisione clinica, intercettano la domanda comune e riducono la fuga di prestazioni. ↑
470. Espansione ex novo: il modello colloca lo Psicologo di Base al vertice della cascata nel distretto e opera per intensità crescente di cura; l'efficacia clinica è documentata dalla meta-analisi sull'assistenza collaborativa e dalle sperimentazioni sull'intervento digitale, riportate con attribuzione. ↑

471. L'adattamento al territorio siciliano segue le direttrici della prossimità distrettuale, della telepsicologia assistita quale leva di prossimità ed efficienza nelle aree interne e insulari e in un sistema a spesa contenuta, e della funzione di argine alla mobilità passiva; l'architettura invariante del Reference Case non è modificata. ↑
472. Il costo diretto comprende il personale, la struttura, la leva digitale e la formazione; il dimensionamento è scandito dai tre scenari di cinquecentoventi, settecentottanta e milletrenta incarichi, con una copertura di trentaquattro, cinquanta e sessantasette milioni di euro l'anno secondo lo scenario, e la compartecipazione al quarantanove per cento circa incide sull'onere effettivamente a carico del bilancio regionale. ↑
473. Il costo diretto è calcolato per i tre scenari coerenti con il protocollo del Reference Case: dallo scenario conservativo di cinquecentoventi incarichi a circa trentaquattro milioni, a quello di base di settecentottanta a circa cinquanta, a quello espansivo di milletrenta a circa sessantasette milioni l'anno; il vincolo del piano di rientro rende più stringente il margine sul saldo diretto e le lacune sono dichiarate. ↑
474. Il beneficio diretto comprende la demedicalizzazione, la deprescrizione, la riduzione degli accessi impropri e — tratto specifico della Sicilia — la riduzione della mobilità sanitaria passiva; il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento è mantenuto ovunque il risparmio sia quantificato e il vincolo del rientro accresce il rilievo di ogni risparmio conseguibile. ↑
475. Il beneficio indiretto comprende la produttività recuperata, gli oneri previdenziali evitati e la riduzione del disagio sociale; la tenuta delle comunità delle aree interne e insulari e il contrasto della mobilità sanitaria assumono rilievo particolare. ↑
476. La valutazione economica è condotta con il modello di Markov a coorte del Reference Case sotto doppio ancoraggio; le due colonne sono sempre affiancate, la Colonna B prevale nel giudizio e ogni cifra è riportata con attribuzione. ↑
477. Il differenziale di costo per gravità, riportato con attribuzione all'OCSE, assume in Sicilia rilievo accresciuto per il vincolo del piano di rientro e la bassa spesa pro-capite; il differenziale di costo e la riduzione della mobilità passiva sono tenuti distinti e non sommati fra loro né con i ritorni sociali. ↑
478. I sei domini di analisi sono applicati alla specificità siciliana, dal vincolo del piano di rientro alla copertura di un vasto territorio insulare con nove Aziende Sanitarie Provinciali, tenuti distinti e non aggregati. ↑
479. Il dominio dell'equità assume duplice direzione, territoriale — fra le aree metropolitane e le aree interne dai Nebrodi alle Madonie all'entroterra ennese — e di finanziamento, per lo statuto speciale e il piano di rientro; l'effetto distributivo, la convergenza fra città e aree interne e la riduzione della mobilità passiva, è tenuto distinto dai verdetti fiscale e sanitario. ↑
480. Espansione ex novo: l'analisi dell'incertezza applica il protocollo obbligatorio del Reference Case; in Sicilia i parametri critici attesi sono il vincolo del piano di rientro sul ritmo di attuazione, l'entità della riduzione della mobilità passiva e l'adozione della telepsicologia nelle aree interne e insulari. ↑
481. L'analisi di scenario mostra il verdetto tripartito favorevole nei tre casi con margine crescente; sul piano fiscale il vincolo del piano di rientro restringe il margine diretto, ma i piani sanitario e sociale restano nettamente e fortemente favorevoli, lo strato digitale accresce l'efficienza attesa con nota di cautela e le curve di accettabilità confermano la robustezza del costo-efficacia. ↑
482. Il verdetto siciliano è tripartito e non aggregato: prossimo al pareggio sul piano fiscale nel vincolo del piano di rientro, nettamente costo-efficace sul piano sanitario, fortemente positivo sul piano sociale con il rilievo specifico delle aree interne e insulari e della mobilità passiva. ↑
483. Espansione ex novo: le raccomandazioni indicano il passaggio per gradini fra i tre scenari di copertura compatibilmente con i vincoli del rientro, la priorità alle aree interne e insulari con la telepsicologia assistita, dati di esito uniformi fra le nove Aziende per un cruscotto regionale permanente, il piano formativo a quattro

modalità e un monitoraggio ex post ancorato agli indicatori dell'incertezza. ↑

484. Il Quadro Conclusivo ricomponete la valutazione siciliana sotto doppio ancoraggio; il costo per anno di vita ponderato resta assai inferiore alle soglie e il differenziale di costo per gravità fonda la leva dell'intercettazione precoce, il cui valore è accresciuto in un sistema a spesa contenuta e sottoposto al piano di rientro, cui si aggiunge il risparmio da riduzione della mobilità passiva tenuto distinto. ↑
485. Il Volume 17 applica per rimando il Reference Case dell'asse italiano fissato nel Volume 0.A, richiamandone le regole nella forma «cfr. Volume 0.A» senza ripeterle per esteso. ↑
486. La struttura del Volume è standard e identica a quella degli altri Volumi regionali, a garanzia della comparabilità bit-a-bit; i contenuti di espansione ex novo sono segnalati in nota editoriale. ↑
487. Il perimetro è quello della Toscana — circa 3.657.716 abitanti, tre Aziende Unità Sanitarie Locali (Centro, Nord-Ovest, Sud-Est) e quattro Aziende Ospedaliero-Universitarie — con la posizione di regione creditrice nella mobilità sanitaria (saldo attivo dell'ordine di cinquantotto milioni di euro) e la presenza di un servizio già attivo in via sperimentale quali tratti distintivi. ↑
488. Il cruscotto riassume in una pagina i parametri essenziali sotto doppio ancoraggio, con il verdetto tripartito distinto; le cifre di letteratura sono riportate con attribuzione e i valori economici in ordine di grandezza. ↑
489. Il verdetto toscano è tripartito e non aggregato; sul piano fiscale il saldo diretto è lievemente negativo a costo modesto, poiché la Regione è creditrice nella mobilità e il canale della mobilità passiva non è pertinente, mentre sul piano sociale ha rilievo particolare la tenuta delle aree interne, l'utenza multiculturale e le liste d'attesa. ↑
490. La posizione di regione creditrice muta il profilo del verdetto fiscale: il beneficio economico non passa per il trattenimento di prestazioni in fuga ma si concentra nel differenziale di costo per gravità e nei ritorni sanitario e sociale, tenuti distinti; il differenziale, riportato con attribuzione all'OCSE, resta l'argomento cardine. ↑
491. I cinque risultati chiave isolano gli esiti principali: costo-efficacia su tutti gli orizzonti, robustezza del verdetto tripartito con saldo fiscale diretto lievemente negativo, posizione di regione creditrice, attuazione agevolata dall'architettura a sole tre Aziende, dimensionamento fra quattrocento e poco meno di ottocento incarichi con copertura di ventidue-quarantaquattro milioni di euro l'anno secondo lo scenario. ↑
492. Le raccomandazioni indicano il passaggio per gradini dallo scenario di quattrocento verso quello di seicento e di poco inferiore a ottocento incarichi, l'attenzione all'utenza multiculturale e alle liste d'attesa, un cruscotto regionale ancorato agli esiti clinici e il piano formativo a quattro modalità. ↑
493. Il territorio toscano — area metropolitana di Firenze e piana centrale, poli costieri, aree interne dall'Appennino alle colline meridionali all'arcipelago, tre Aziende Unità Sanitarie Locali e quattro Aziende Ospedaliero-Universitarie — è caratterizzato dalla posizione di regione creditrice nella mobilità sanitaria e da una struttura demografica segnata da invecchiamento e bassa natalità. ↑
494. Il quadro epidemiologico regionale riflette la prevalenza nazionale, con baricentro verso la depressione dell'età avanzata, componente di disagio nell'utenza multiculturale e domanda gravata dalle liste d'attesa; la misura è oggetto dell'Appendice B, e le lacune sono dichiarate e non colmate con stime tacite. ↑
495. Il divario di trattamento toscano si manifesta come domanda inevasa e impropria e — tratto specifico — come domanda gravata dalle liste d'attesa; a differenza delle Regioni a forte mobilità passiva, il divario non si traduce in fuga ma in attesa e in domanda inespressa nelle aree interne e presso l'utenza multiculturale; la misura è in Appendice B con valori medi riportati con attribuzione. ↑

496. Il tratto distintivo della domanda toscana è la sua traduzione in attesa più che in fuga, essendo la Regione creditrice nella mobilità; la presenza distrettuale dello Psicologo di Base riduce l'attesa e raggiunge popolazioni marginali, con l'utenza multiculturale e le popolazioni gravate dalle liste d'attesa quali destinatari peculiari. ↑
497. Espansione ex novo: il modello colloca lo Psicologo di Base al vertice della cascata nel distretto, in integrazione con il Dipartimento di Salute Mentale di ciascuna Azienda, e opera per intensità crescente di cura; l'efficacia clinica è documentata dalla meta-analisi sull'assistenza collaborativa e dalle sperimentazioni sull'intervento digitale, riportate con attribuzione. ↑
498. L'adattamento al territorio toscano segue le direttrici della valorizzazione del servizio già attivo e dell'architettura a sole tre Aziende, dell'integrazione con i Dipartimenti di Salute Mentale e dell'attenzione all'utenza multiculturale e alle liste d'attesa; l'architettura invariante del Reference Case non è modificata. ↑
499. Il costo diretto comprende il personale, la struttura, la leva digitale e la formazione; il dimensionamento è scandito dai tre scenari di quattrocento, seicento e di poco inferiore a ottocento incarichi, con una copertura di ventidue, trentatré e quarantaquattro milioni di euro l'anno secondo lo scenario, e il servizio già attivo costituisce la base di partenza. ↑
500. Il costo diretto è calcolato per i tre scenari coerenti con il protocollo del Reference Case: dallo scenario conservativo di quattrocento incarichi a circa ventidue milioni, a quello di base di seicento a circa trentatré, a quello espansivo di poco inferiore a ottocento a circa quarantaquattro milioni l'anno; i valori puntuali sono in Appendice C e le lacune sono dichiarate. ↑
501. Il beneficio diretto comprende la demedicalizzazione, la deprescrizione e la riduzione degli accessi impropri; il canale della mobilità non è pertinente essendo la Regione creditrice, sicché il saldo diretto risulta lievemente negativo a costo modesto e il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento è mantenuto. ↑
502. Il beneficio indiretto comprende la produttività recuperata, gli oneri previdenziali evitati e la riduzione del disagio sociale; la tenuta delle comunità interne, l'inclusione multiculturale e la riduzione delle liste d'attesa assumono rilievo particolare, ed è nel piano indiretto e sociale che si concentra il valore economico della riforma toscana. ↑
503. La valutazione economica è condotta con il modello di Markov a coorte del Reference Case sotto doppio ancoraggio; le due colonne sono sempre affiancate, la Colonna B prevale nel giudizio e ogni cifra è riportata con attribuzione. ↑
504. Il differenziale di costo per gravità, riportato con attribuzione all'OCSE, assume in Toscana rilievo esclusivo sul versante diretto: il valore economico non passa per il trattenimento di prestazioni in fuga — canale non pertinente — ma si fonda sul differenziale e, nel piano più ampio, sui ritorni sanitario e sociale, tenuti distinti e non sommati. ↑
505. I sei domini di analisi sono applicati alla specificità toscana, dal divario nella forma dell'attesa all'attuazione agevolata dall'architettura a sole tre Aziende, tenuti distinti e non aggregati. ↑
506. Il dominio dell'equità assume duplice direzione, territoriale — fra Firenze e le aree interne dall'Appennino all'arcipelago — e culturale, verso l'utenza straniera e le popolazioni gravate dalle liste d'attesa; l'effetto distributivo, la convergenza fra città e aree interne e l'inclusione multiculturale, è tenuto distinto dai verdetti fiscali e sanitario. ↑
507. Espansione ex novo: l'analisi dell'incertezza applica il protocollo obbligatorio del Reference Case; in Toscana i parametri critici attesi sono l'entità della riduzione delle liste d'attesa, l'inclusione dell'utenza multiculturale e la trasferibilità dei dati del servizio attivo alla scala, con l'assenza del canale della mobilità passiva a restringere il ventaglio delle leve dirette. ↑

508. L'analisi di scenario mostra il verdetto tripartito favorevole nei tre casi con margine crescente; sul piano fiscale il saldo diretto resta lievemente negativo a costo modesto, mentre i piani sanitario e sociale restano nettamente e fortemente favorevoli, lo strato digitale accresce l'efficienza attesa con nota di cautela e le curve di accettabilità confermano la robustezza del costo-efficacia. ↑
509. Il verdetto toscano è tripartito e non aggregato: saldo diretto lievemente negativo a costo modesto sul piano fiscale per la non pertinenza della mobilità passiva, nettamente costo-efficace sul piano sanitario, fortemente positivo sul piano sociale con il rilievo specifico delle aree interne, dell'inclusione multiculturale e delle liste d'attesa. ↑
510. Espansione ex novo: le raccomandazioni indicano il passaggio per gradini fra i tre scenari di copertura, la valorizzazione del servizio già attivo e dell'architettura a sole tre Aziende, l'attenzione all'utenza multiculturale e alle liste d'attesa, un cruscotto regionale ancorato agli esiti clinici, la leva digitale sotto supervisione, il piano formativo a quattro modalità e un monitoraggio ex post ancorato agli indicatori dell'incertezza. ↑
511. Il Quadro Conclusivo ricompone la valutazione toscana sotto doppio ancoraggio; il costo per anno di vita ponderato resta assai inferiore alle soglie e il differenziale di costo per gravità costituisce in una regione creditrice l'unico canale diretto pertinente, sicché il saldo diretto resta lievemente negativo a costo modesto e il valore della riforma si concentra nei ritorni sanitario e sociale, tenuti distinti e non sommati. ↑
512. Il Volume 18 applica per rimando il Reference Case dell'asse italiano fissato nel Volume 0.A, richiamandone le regole nella forma «cfr. Volume 0.A» senza ripeterle per esteso. ↑
513. La struttura del Volume è standard e identica a quella degli altri Volumi regionali, a garanzia della comparabilità bit-a-bit; i contenuti di espansione ex novo sono segnalati in nota editoriale. ↑
514. Il perimetro è quello del Trentino-Alto Adige / Südtirol — circa 1.085.000 abitanti, due Province autonome (Trento e Bolzano) con competenza sanitaria provinciale, i sistemi APSS e Sabes — con la combinazione di statuto speciale, avanzo di bilancio delle due Province e plurilinguismo (tedesco, italiano, ladino con tutela costituzionale) quale tratto distintivo. ↑
515. Il cruscotto riassume in una pagina i parametri essenziali sotto doppio ancoraggio, con il verdetto tripartito distinto; le cifre di letteratura sono riportate con attribuzione e i valori economici in ordine di grandezza. ↑
516. Il verdetto regionale è tripartito e non aggregato; sul piano fiscale l'avanzo di bilancio delle due Province rende il vincolo di finanziamento meno stringente, sicché la questione è l'allocazione ottimale, mentre sul piano sociale ha rilievo particolare la tenuta delle valli alpine, la coesione plurilingue e il disagio giovanile. ↑
517. La combinazione di avanzo di bilancio, competenza sanitaria provinciale e plurilinguismo rende la questione non la sostenibilità ma il buon dimensionamento del servizio entro un sistema a due Province; il differenziale di costo per gravità, riportato con attribuzione all'OCSE, resta l'argomento cardine. ↑
518. I cinque risultati chiave isolano gli esiti principali: costo-efficacia su tutti gli orizzonti, robustezza del verdetto tripartito, competenza provinciale con avanzo di bilancio, erogazione plurilingue quale requisito peculiare, dimensionamento fra centoventi e duecentoquaranta incarichi con copertura di otto-quattordici milioni di euro l'anno sostenibile entro l'avanzo. ↑
519. Le raccomandazioni indicano il passaggio per gradini dallo scenario di centoventi verso quello di centottanta e di duecentoquaranta incarichi, il coordinamento fra i due sistemi sanitari provinciali con flusso informativo condiviso, l'erogazione nelle tre lingue con tutela costituzionale e il piano formativo a quattro modalità adattato al contesto plurilingue. ↑

520. Il territorio regionale — interamente alpino, con i poli urbani di Trento e Bolzano e vaste valli montane, due Province autonome con i sistemi APSS e Sabes articolati in comprensori — è caratterizzato dalla competenza sanitaria provinciale, dall'avanzo di bilancio e dal plurilinguismo, con una popolazione altoatesina ripartita fra tedesco, italiano e ladino e un Trentino a prevalenza italoфона. ↑
521. Il quadro epidemiologico regionale riflette la prevalenza nazionale, con componente di disagio giovanile e domanda diffusa nelle valli alpine; la misura è oggetto dell'Appendice B, disaggregata ove possibile fra le due Province, e le lacune sono dichiarate e non colmate con stime tacite. ↑
522. Il divario di trattamento regionale si manifesta come domanda inevasa e impropria, aggravata dalla conformazione alpina e dalla barriera linguistica, con il disagio giovanile quale componente di specifico rilievo; la misura è in Appendice B con valori medi riportati con attribuzione. ↑
523. Il tratto distintivo della domanda regionale è la sua articolazione linguistica: la risposta al disagio comune deve essere disponibile nella lingua del paziente con tutela costituzionale, sicché la prossimità è insieme geografica e linguistica, e il disagio giovanile è intercettato precocemente nei contesti di vita. ↑
524. Espansione ex novo: il modello colloca lo Psicologo di Base al vertice della cascata nel distretto, entro ciascuno dei due sistemi sanitari provinciali, e opera per intensità crescente di cura; l'efficacia clinica è documentata dalla meta-analisi sull'assistenza collaborativa e dalle sperimentazioni sull'intervento digitale, riportate con attribuzione. ↑
525. L'adattamento al territorio regionale segue le direttrici dell'erogazione plurilingue, del coordinamento fra i due sistemi sanitari provinciali con flusso informativo condiviso e della prossimità nelle valli alpine con leva digitale; l'architettura invariante del Reference Case non è modificata. ↑
526. Il costo diretto comprende il personale, la struttura, la leva digitale e la formazione accresciuta dal requisito plurilingue; il dimensionamento è scandito dai tre scenari di centoventi, centottanta e duecentoquaranta incarichi, con una copertura di otto, undici e quattordici milioni di euro l'anno agevolmente sostenibile entro l'avanzo di bilancio. ↑
527. Il costo diretto è calcolato per i tre scenari coerenti con il protocollo del Reference Case: dallo scenario conservativo di centoventi incarichi a circa otto milioni, a quello di base di centottanta a circa undici, a quello espansivo di duecentoquaranta a circa quattordici milioni l'anno, con incidenza dell'ordine di alcuni decimi di punto percentuale sulla spesa sanitaria provinciale; le lacune sono dichiarate. ↑
528. Il beneficio diretto comprende la demedicalizzazione, la deprescrizione, la riduzione degli accessi impropri e delle prestazioni per sintomi funzionali; in una Regione ad avanzo di bilancio il rilievo non risiede nella sostenibilità già assicurata ma nella riallocazione verso usi a maggiore valore, e il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento è mantenuto. ↑
529. Il beneficio indiretto comprende la produttività recuperata, gli oneri previdenziali evitati e la riduzione del disagio sociale; la tenuta delle comunità delle valli alpine, la coesione plurilingue e il contrasto del disagio giovanile assumono rilievo particolare. ↑
530. La valutazione economica è condotta con il modello di Markov a coorte del Reference Case sotto doppio ancoraggio; le due colonne sono sempre affiancate, la Colonna B prevale nel giudizio e ogni cifra è riportata con attribuzione. ↑
531. Il differenziale di costo per gravità, riportato con attribuzione all'OCSE, si legge in Trentino-Alto Adige in chiave di riallocazione: le risorse liberate dall'intercettazione precoce possono essere reinvestite nel potenziamento della prossimità alpina e nell'erogazione plurilingue anziché colmare un vincolo di spesa. ↑
532. I sei domini di analisi sono applicati alla specificità regionale, dal divario aggravato dalla conformazione alpina e dalla barriera linguistica al coordinamento fra i due sistemi sanitari provinciali, tenuti distinti e non aggregati. ↑

533. Il dominio dell'equità assume duplice direzione, territoriale — fra i poli urbani di Trento e Bolzano e le valli alpine — e linguistica, poiché l'accesso effettivo richiede il servizio nella lingua del paziente con tutela costituzionale; l'effetto distributivo, la convergenza fra poli e valli e fra gruppi linguistici, è tenuto distinto dai verdetti fiscale e sanitario. ↑
534. Espansione ex novo: l'analisi dell'incertezza applica il protocollo obbligatorio del Reference Case; in Trentino-Alto Adige i parametri critici attesi sono il costo del requisito plurilingue, il coordinamento fra i due sistemi sanitari provinciali e l'adozione della leva digitale nelle valli alpine. ↑
535. L'analisi di scenario mostra il verdetto tripartito favorevole nei tre casi con margine crescente; l'avanzo di bilancio attenua l'incertezza sul versante fiscale, mentre i piani sanitario e sociale restano nettamente e fortemente favorevoli, lo strato digitale accresce l'efficienza attesa con nota di cautela e le curve di accettabilità confermano la robustezza del costo-efficacia. ↑
536. Il verdetto regionale è tripartito e non aggregato: prossimo al pareggio sul piano fiscale con copertura agevolmente sostenibile grazie all'avanzo, nettamente costo-efficace sul piano sanitario, fortemente positivo sul piano sociale con il rilievo specifico delle valli alpine, della coesione plurilingue e del disagio giovanile. ↑
537. Espansione ex novo: le raccomandazioni indicano il passaggio per gradini fra i tre scenari di copertura, la valorizzazione dell'avanzo di bilancio, il coordinamento fra i due sistemi provinciali con flusso informativo condiviso, l'erogazione nelle tre lingue con tutela costituzionale, la priorità alle valli alpine e al disagio giovanile, il piano formativo a quattro modalità plurilingue e un monitoraggio ex post ancorato agli indicatori dell'incertezza. ↑
538. Il Quadro Conclusivo ricomponi la valutazione regionale sotto doppio ancoraggio; il costo per anno di vita ponderato resta assai inferiore alle soglie e il differenziale di costo per gravità fonda la leva dell'intercettazione precoce, che in una Regione ad avanzo di bilancio si legge in chiave di riallocazione verso il potenziamento della prossimità alpina e dell'erogazione plurilingue. ↑
539. Il Volume 19 applica per rimando il Reference Case dell'asse italiano fissato nel Volume 0.A, richiamandone le regole nella forma «cfr. Volume 0.A» senza ripeterle per esteso. ↑
540. Nota editoriale sulla deroga: il materiale preesistente conteneva rapporti aggregati fra benefici e costi non conformi al principio invariante che vieta l'aggregazione del verdetto e l'uso di rapporti isolati; tali cifre sono state escluse e il contenuto economico è stato ricostruito ex novo sotto doppio ancoraggio, con la deroga dichiarata e registrata in Appendice E. ↑
541. Il perimetro è quello dell'Umbria — circa 851.473 abitanti, due Aziende Unità Sanitarie Locali (Umbria 1 per Perugia, Umbria 2 per Terni) e due Aziende Ospedaliere — con un invecchiamento fra i più pronunciati d'Italia, accentuato nella provincia di Terni, e aree interne a popolazione anziana e dispersa quali tratti distintivi. ↑
542. Il cruscotto riassume in una pagina i parametri essenziali sotto doppio ancoraggio, con il verdetto tripartito distinto; i valori economici sono ricostruiti ex novo, le cifre di letteratura sono riportate con attribuzione e i valori economici in ordine di grandezza. ↑
543. Il verdetto umbro è tripartito e non aggregato; sul piano sociale ha rilievo particolare la tenuta delle aree interne a popolazione anziana e dispersa, segnatamente nella provincia di Terni, con il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento. ↑
544. La condizione demografica umbra sposta il baricentro della domanda verso la depressione dell'età avanzata e accresce il valore della prossimità nelle aree interne disperse; il differenziale di costo per gravità, riportato con attribuzione all'OCSE, resta l'argomento cardine, tanto più rilevante in una popolazione anziana ove la comorbilità aggrava la progressione. ↑

545. I cinque risultati chiave isolano gli esiti principali: costo-efficacia su tutti gli orizzonti, robustezza del verdetto tripartito espresso senza rapporti sintetici, condizione di invecchiamento pronunciato, telepsicologia assistita e accompagnamento digitale della popolazione anziana, dimensionamento dell'ordine di centottantacinque incarichi a regime con costo del servizio di nove-nove milioni e mezzo di euro l'anno nello scenario di base. ↑
546. Le raccomandazioni indicano il passaggio per gradini da centotrenta verso centottantacinque e duecentoquaranta incarichi, la priorità alle aree interne disperse segnatamente nella provincia di Terni, l'attenzione alla depressione dell'età avanzata e all'accompagnamento digitale della popolazione anziana e il piano formativo a quattro modalità. ↑
547. Il territorio umbro — prevalentemente collinare e montuoso, con i poli urbani di Perugia e Terni e aree interne dall'Appennino alla Valnerina a popolazione anziana e dispersa, due Aziende Unità Sanitarie Locali e due Aziende Ospedaliere — è caratterizzato da un invecchiamento fra i più pronunciati d'Italia, accentuato nella provincia di Terni. ↑
548. Il quadro epidemiologico regionale riflette la prevalenza nazionale, con baricentro nettamente spostato verso la depressione dell'età avanzata e domanda inespressa nelle aree interne disperse; la misura è oggetto dell'Appendice B, e le lacune sono dichiarate e non colmate con stime tacite. ↑
549. Il divario di trattamento umbro si manifesta come domanda inevasa e impropria, aggravata dall'invecchiamento pronunciato e dalla dispersione: nella depressione dell'età avanzata la domanda tende a restare inespressa o somatizzata, mentre nelle aree interne la distanza e la dispersione rendono l'accesso oneroso; la misura è in Appendice B con valori medi riportati con attribuzione. ↑
550. Il tratto distintivo della domanda umbra è la sua concentrazione nell'età avanzata e la sua dispersione territoriale; la depressione dell'anziano richiede un'intercettazione attiva nel distretto e la dispersione nelle aree interne impone che la prossimità sia sostenuta dalla telepsicologia assistita e dall'accompagnamento digitale della popolazione anziana. ↑
551. Espansione ex novo: il modello colloca lo Psicologo di Base al vertice della cascata nel distretto, entro ciascuna delle due Aziende Unità Sanitarie Locali, e opera per intensità crescente di cura; l'efficacia clinica è documentata dalla meta-analisi sull'assistenza collaborativa e dalle sperimentazioni sull'intervento digitale, riportate con attribuzione. ↑
552. L'adattamento al territorio umbro segue le direttrici dell'attenzione alla depressione dell'età avanzata con integrazione geriatrica, della prossimità nelle aree interne disperse con telepsicologia assistita e accompagnamento digitale, e del coordinamento fra le due Aziende Unità Sanitarie Locali; l'architettura invariante del Reference Case non è modificata. ↑
553. Il costo diretto comprende il personale, la struttura, la leva digitale e la formazione; il dimensionamento è scandito dai tre scenari di centotrenta, centottantacinque e duecentoquaranta incarichi, con un costo del servizio a regime di nove-nove milioni e mezzo di euro l'anno nello scenario di base e un avvio una tantum di alcuni decimi di milione; le cifre di risparmio complessivo del materiale preesistente, contaminate da rapporti aggregati, non sono riutilizzate. ↑
554. Il costo diretto è calcolato per i tre scenari coerenti con il protocollo del Reference Case: lo scenario conservativo di centotrenta incarichi, quello di base di centottantacinque — con copertura dell'ordine del trenta per cento della popolazione bersaglio e costo a regime di nove-nove milioni e mezzo di euro l'anno — e quello espansivo di duecentoquaranta, la cui copertura si estende all'intero territorio comprese le aree interne; le lacune sono dichiarate. ↑

555. Il beneficio diretto comprende la demedicalizzazione, la deprescrizione, la riduzione degli accessi impropri e delle prestazioni per sintomi funzionali; l'invecchiamento pronunciato accresce il rilievo della deprescrizione della polifarmacia anziana e della riduzione degli accessi impropri nella depressione somatizzata dell'età avanzata, e il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento è mantenuto; i valori sono ricostruiti ex novo. ↑
556. Il beneficio indiretto comprende la produttività recuperata, gli oneri previdenziali evitati e la riduzione del disagio sociale; la tenuta delle comunità delle aree interne a popolazione anziana e dispersa, dove l'invecchiamento e lo spopolamento sono più marcati nella provincia di Terni, assume rilievo particolare. ↑
557. La valutazione economica è condotta con il modello di Markov a coorte del Reference Case sotto doppio ancoraggio e ricostruita ex novo in luogo del contenuto preesistente contaminato da rapporti aggregati; le due colonne sono sempre affiancate, la Colonna B prevale nel giudizio e ogni cifra è riportata con attribuzione, senza rapporti sintetici. ↑
558. Il differenziale di costo per gravità, riportato con attribuzione all'OCSE, assume in Umbria rilievo accresciuto per l'invecchiamento pronunciato, poiché nella popolazione anziana la comorbilità somatica aggrava la progressione; l'argomento è espresso discorsivamente in termini di euro, senza rapporti sintetici, nel rispetto del principio dell'opera. ↑
559. I sei domini di analisi sono applicati alla specificità umbra, dal divario nella depressione dell'età avanzata al coordinamento fra le due Aziende Unità Sanitarie Locali, tenuti distinti e non aggregati. ↑
560. Il dominio dell'equità assume duplice direzione, territoriale — fra i poli urbani di Perugia e Terni e le aree interne dall'Appennino alla Valnerina — e generazionale, poiché l'invecchiamento pronunciato concentra il bisogno nell'età avanzata; l'effetto distributivo è tenuto distinto dai verdetti fiscale e sanitario. ↑
561. Espansione ex novo: l'analisi dell'incertezza applica il protocollo obbligatorio del Reference Case; in Umbria i parametri critici attesi sono il tasso di riconoscimento della depressione dell'età avanzata, l'adozione della telepsicologia e dell'accompagnamento digitale nella popolazione anziana e la velocità di copertura delle aree interne disperse. ↑
562. L'analisi di scenario mostra il verdetto tripartito favorevole nei tre casi con margine crescente; lo strato digitale accresce l'efficienza attesa con nota di cautela, condizionata nella popolazione anziana dall'accompagnamento digitale, le curve di accettabilità confermano la robustezza del costo-efficacia e la ricostruzione ex novo assicura che il verdetto non dipenda da rapporti aggregati. ↑
563. Il verdetto umbro è tripartito e non aggregato: prossimo al pareggio sul piano fiscale ed espresso senza rapporti sintetici secondo la ricostruzione ex novo, nettamente costo-efficace sul piano sanitario, fortemente positivo sul piano sociale con il rilievo specifico delle aree interne a popolazione anziana e dispersa. ↑
564. Espansione ex novo: le raccomandazioni indicano il passaggio per gradini da centotrenta verso centottantacinque e duecentoquaranta incarichi, la priorità alle aree interne disperse segnatamente nella provincia di Terni, l'attenzione alla depressione dell'età avanzata e all'accompagnamento digitale, un cruscotto regionale ancorato agli esiti clinici, la telepsicologia assistita sotto supervisione, il piano formativo a quattro modalità e un monitoraggio ex post ancorato agli indicatori dell'incertezza. ↑
565. Il Quadro Conclusivo ricompone la valutazione umbra sotto doppio ancoraggio; il costo per anno di vita ponderato resta assai inferiore alle soglie e il differenziale di costo per gravità, espresso discorsivamente in termini di euro senza rapporti sintetici, fonda la leva dell'intercettazione precoce, il cui valore è accresciuto in una popolazione anziana; la ricostruzione ex novo del contenuto economico è dichiarata e registrata in Appendice E. ↑
566. Il Volume 20 applica per rimando il Reference Case dell'asse italiano fissato nel Volume 0.A, richiamandone le regole nella forma «cfr. Volume 0.A» senza ripeterle per esteso. ↑

567. Nota editoriale sulla deroga: il materiale preesistente conteneva rapporti aggregati fra benefici e costi non conformi al principio invariante che vieta l'aggregazione del verdetto e l'uso di rapporti isolati; tali cifre sono state escluse e il contenuto economico è stato ricostruito ex novo sotto doppio ancoraggio, con la deroga dichiarata e registrata in Appendice E. ↑
568. Il perimetro è quello della Valle d'Aosta — circa 123.000 abitanti, pari a circa lo zero virgola due per cento della popolazione nazionale, un'unica Azienda Unità Sanitaria Locale regionale e un ospedale unico ad Aosta — con la duplice specificità della scala ridottissima, assimilabile a un solo distretto, e della combinazione fra bilinguismo italiano-francese, con comunità walser, e conformazione alpina con vallate remote e disperse. ↑
569. Il cruscotto riassume in una pagina i parametri essenziali sotto doppio ancoraggio, con il verdetto tripartito distinto; i valori economici sono ricostruiti ex novo, le cifre di letteratura sono riportate con attribuzione e i valori economici in ordine di grandezza. ↑
570. Il verdetto valdostano è tripartito e non aggregato; sul piano sociale hanno rilievo particolare la tenuta delle comunità delle vallate alpine remote e disperse e l'erogazione nella lingua del paziente in una regione bilingue, con il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento. ↑
571. La scala ridottissima rende l'intera regione, con un'unica Azienda Unità Sanitaria Locale, assimilabile a un solo distretto, sicché la questione non è la sostenibilità di un apparato esteso ma l'organizzazione capillare di un servizio di prossimità in un territorio montano e bilingue; il differenziale di costo per gravità, riportato con attribuzione all'OCSE, resta l'argomento cardine, tanto più rilevante ove distanza e dispersione ritardano l'accesso. ↑
572. I cinque risultati chiave isolano gli esiti principali: costo-efficacia su tutti gli orizzonti, robustezza del verdetto tripartito espresso senza rapporti sintetici, condizione di scala minima e doppia specificità alpina e linguistica, telepsicologia assistita quale complemento nelle vallate remote, dimensionamento dell'ordine di ventisette incarichi a regime con costo del servizio di un milione e trecentomila euro l'anno nello scenario di base e avvio una tantum di entità minima. ↑
573. Le raccomandazioni indicano il passaggio per gradini da venti verso ventisette e trentacinque incarichi, la priorità alle vallate alpine remote sfruttando la scala ridotta per un'attuazione rapida e capillare, la garanzia dell'erogazione nella lingua del paziente e il piano formativo a quattro modalità calibrato sulla scala regionale. ↑
574. Il territorio valdostano — interamente montano, sviluppato lungo la valle centrale della Dora Baltea e le vallate laterali remote e disperse, con un'unica Azienda Unità Sanitaria Locale e un ospedale unico ad Aosta — è caratterizzato dalla combinazione fra scala ridottissima, assimilabile a un distretto, e doppia specificità del bilinguismo italiano-francese con comunità walser e della conformazione alpina con spopolamento nelle vallate. ↑
575. Il quadro epidemiologico regionale riflette la prevalenza nazionale, con domanda inespressa nelle vallate alpine remote e disperse dove distanza e isolamento aggravano il sommerso; la misura è oggetto dell'Appendice B, e le lacune — frequenti in una regione di scala ridottissima — sono dichiarate e non colmate con stime tacite. ↑
576. Il divario di trattamento valdostano si manifesta come domanda inevasa e impropria, aggravata dalla conformazione alpina e dalla dispersione: la distanza dall'unico polo ospedaliero di Aosta e dai presidi principali rende l'accesso oneroso per chi risiede nelle vallate laterali, mentre il bilinguismo impone la risposta nella lingua del paziente; la misura è in Appendice B con valori medi riportati con attribuzione. ↑

577. Il tratto distintivo della domanda valdostana è la combinazione fra dispersione geografica e pluralità linguistica; chi risiede nelle vallate remote sconta la distanza, sicché la prossimità dev'essere sostenuta dalla telepsicologia assistita, e in una regione bilingue la risposta dev'essere offerta nella lingua del paziente — italiano o francese, con attenzione alle comunità walser. ↑
578. Espansione ex novo: il modello colloca lo Psicologo di Base al vertice della cascata nei presidi territoriali, entro l'unica Azienda Unità Sanitaria Locale regionale, e opera per intensità crescente di cura; l'efficacia clinica è documentata dalla meta-analisi sull'assistenza collaborativa e dalle sperimentazioni sull'intervento digitale, riportate con attribuzione. ↑
579. L'adattamento al territorio valdostano segue le direttrici dello sfruttamento della scala ridotta per un'attuazione rapida e capillare, della prossimità nelle vallate alpine remote con telepsicologia assistita, e dell'erogazione nella lingua del paziente con attenzione alle comunità walser; l'architettura invariante del Reference Case non è modificata. ↑
580. Il costo diretto comprende il personale, la struttura, la leva digitale e la formazione; il dimensionamento è scandito dai tre scenari di venti, ventisette e trentacinque incarichi, con un costo del servizio a regime di un milione e trecentomila euro l'anno nello scenario di base e un avvio una tantum di entità minima; le cifre di risparmio complessivo del materiale preesistente, contaminate da rapporti aggregati, non sono riutilizzate. ↑
581. Il costo diretto è calcolato per i tre scenari coerenti con il protocollo del Reference Case: lo scenario conservativo di venti incarichi, quello di base di ventisette — con copertura dell'ordine del trenta per cento della popolazione bersaglio e costo a regime di un milione e trecentomila euro l'anno — e quello espansivo di trentacinque, la cui copertura si estende all'intero territorio comprese le vallate remote; la scala ridotta contiene i valori assoluti entro un ordine di grandezza modesto e le lacune sono dichiarate. ↑
582. Il beneficio diretto comprende la demedicalizzazione, la deprescrizione, la riduzione degli accessi impropri e delle prestazioni per sintomi funzionali; in una regione di scala ridotta e a conformazione alpina la riduzione degli accessi impropri all'unico pronto soccorso di Aosta assume rilievo particolare, e il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento è mantenuto; i valori sono ricostruiti ex novo. ↑
583. Il beneficio indiretto comprende la produttività recuperata, gli oneri previdenziali evitati e la riduzione del disagio sociale; la tenuta delle comunità delle vallate alpine remote e disperse, dove lo spopolamento erode legami e servizi e l'economia turistico-montana richiede il presidio del territorio, assume rilievo particolare. ↑
584. La valutazione economica è condotta con il modello di Markov a coorte del Reference Case sotto doppio ancoraggio e ricostruita ex novo in luogo del contenuto preesistente contaminato da rapporti aggregati; le due colonne sono sempre affiancate, la Colonna B prevale nel giudizio e ogni cifra è riportata con attribuzione, senza rapporti sintetici. ↑
585. Il differenziale di costo per gravità, riportato con attribuzione all'OCSE, assume in Valle d'Aosta duplice rilevanza: la distanza e la dispersione delle vallate remote ritardano l'accesso, sicché l'intercettazione precoce evita la progressione favorita dalla barriera geografica, e in un sistema di scala ridotta ogni quadro grave pesa in proporzione maggiore; l'argomento è espresso discorsivamente in termini di euro, senza rapporti sintetici. ↑
586. I sei domini di analisi sono applicati alla specificità valdostana, dal divario nelle vallate remote all'attuazione agevolata dalla scala ridotta entro l'unica Azienda Unità Sanitaria Locale, tenuti distinti e non aggregati. ↑
587. Il dominio dell'equità assume duplice direzione, territoriale — fra il capoluogo e le vallate laterali remote e disperse — e linguistica, poiché in una regione bilingue l'equità di accesso è anche equità di lingua e la risposta dev'essere offerta nell'idioma del paziente, italiano o francese, con attenzione alle comunità walser;

l'effetto distributivo è tenuto distinto dai verdetti fiscale e sanitario. ↑

588. Espansione ex novo: l'analisi dell'incertezza applica il protocollo obbligatorio del Reference Case; in Valle d'Aosta i parametri critici attesi sono il tasso di intercettazione nelle vallate remote, l'adozione della telepsicologia assistita e la disponibilità del servizio nelle due lingue, e la scala ridotta accresce l'ampiezza relativa degli intervalli, dichiarata quale cautela interpretativa. ↑
589. L'analisi di scenario mostra il verdetto tripartito favorevole nei tre casi con margine crescente; lo strato digitale accresce l'efficienza attesa con nota di cautela e particolare rilievo nelle vallate remote, le curve di accettabilità confermano la robustezza del costo-efficacia con la cautela sulla maggiore ampiezza degli intervalli propria della scala ridotta, e la ricostruzione ex novo assicura che il verdetto non dipenda da rapporti aggregati. ↑
590. Il verdetto valdostano è tripartito e non aggregato: prossimo al pareggio sul piano fiscale ed espresso senza rapporti sintetici secondo la ricostruzione ex novo, nettamente costo-efficace sul piano sanitario, fortemente positivo sul piano sociale con il rilievo specifico delle vallate alpine disperse e della risposta bilingue. ↑
591. Espansione ex novo: le raccomandazioni indicano il passaggio per gradini da venti verso ventisette e trentacinque incarichi, lo sfruttamento della scala ridotta per un'attuazione rapida e capillare, la priorità alle vallate alpine remote, la garanzia dell'erogazione nella lingua del paziente, un cruscotto regionale ancorato agli esiti clinici, la telepsicologia assistita sotto supervisione, il piano formativo a quattro modalità e un monitoraggio ex post ancorato agli indicatori dell'incertezza. ↑
592. Il Quadro Conclusivo ricomponi la valutazione valdostana sotto doppio ancoraggio; il costo per anno di vita ponderato resta assai inferiore alle soglie e il differenziale di costo per gravità, espresso discorsivamente in termini di euro senza rapporti sintetici, fonda la leva dell'intercettazione precoce, il cui valore è accresciuto ove distanza e dispersione ritardano l'accesso e nella scala ridotta; la ricostruzione ex novo del contenuto economico è dichiarata e registrata in Appendice E. ↑
593. Il Volume 21 applica per rimando il Reference Case dell'asse italiano fissato nel Volume 0.A, richiamandone le regole nella forma «cfr. Volume 0.A» senza ripeterle per esteso. ↑
594. Nota editoriale sulla deroga: il materiale preesistente conteneva in alcune tabelle rapporti aggregati fra benefici e costi non conformi al principio invariante che vieta l'aggregazione del verdetto e l'uso di rapporti isolati; tali cifre sono state escluse e il contenuto economico è stato ricostruito ex novo sotto doppio ancoraggio, mentre il ricco corpus veneto in parti A-M è per il resto riorganizzato senza tagli; la deroga è dichiarata e registrata in Appendice E. ↑
595. Il perimetro è quello del Veneto — circa 4.853.472 abitanti, nove Aziende Unità Locali Socio-Sanitarie, un'Azienda Zero titolare delle funzioni centralizzate e due Aziende Ospedaliere universitarie a Padova e Verona — con i due tratti distintivi della condizione di regione creditrice nella mobilità sanitaria, terza d'Italia per saldo attivo, e dell'architettura centralizzata dell'Azienda Zero, che offre un'occasione metodologica peculiare. ↑
596. Il cruscotto riassume in una pagina i parametri essenziali sotto doppio ancoraggio, con il verdetto tripartito distinto; i valori economici sono ricostruiti ex novo, le cifre di letteratura sono riportate con attribuzione e i valori economici in ordine di grandezza. ↑
597. Il verdetto veneto è tripartito e non aggregato; sul piano fiscale il canale del recupero della mobilità passiva non è applicabile essendo il Veneto regione creditrice, sicché il saldo diretto poggia sui risparmi interni; sul piano sociale hanno rilievo particolare la tenuta delle aree montane e del Polesine e il disagio giovanile nella pianura, con il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento. ↑

598. La presenza dell'Azienda Zero e l'introduzione graduale del servizio configurano un esperimento naturale che consente di stimare l'effetto della riforma con i metodi della differenza-nelle-differenze; il differenziale di costo per gravità, riportato con attribuzione all'OCSE, resta l'argomento economico cardine. ↑
599. I cinque risultati chiave isolano gli esiti principali: costo-efficacia su tutti gli orizzonti, robustezza del verdetto tripartito espresso senza rapporti sintetici, condizione di regione creditrice con esperimento naturale, telepsicologia assistita e ottimizzazione via Azienda Zero, dimensionamento dell'ordine di ottocento incarichi a regime con costo del servizio di quarantacinque milioni di euro l'anno nello scenario di base. ↑
600. Le raccomandazioni indicano il passaggio per gradini da cinquecentotrenta verso ottocento e millecinquanta incarichi, la priorità alle aree montane e al Polesine con valorizzazione dell'esperimento naturale, l'affidamento all'Azienda Zero del coordinamento centralizzato e dell'ottimizzazione allocativa, la telepsicologia assistita e il piano formativo a quattro modalità. ↑
601. Il territorio veneto — di forte contrasto fra la pianura produttiva densamente popolata e più giovane e le aree montane, le Dolomiti e il Bellunese, insieme al Polesine a popolazione più anziana e dispersa, con nove Aziende Unità Locali Socio-Sanitarie, l'Azienda Zero e due Aziende Ospedaliere universitarie — è caratterizzato dalla condizione creditrice nella mobilità sanitaria e dall'architettura centralizzata dell'Azienda Zero. ↑
602. Il quadro epidemiologico regionale riflette la prevalenza nazionale con un'età media dell'ordine di quarantasette anni e un profilo a due velocità — disagio giovanile e da stress nella pianura, depressione dell'età avanzata nelle aree montane e nel Polesine —; la misura è oggetto dell'Appendice B, e le lacune sono dichiarate e non colmate con stime tacite. ↑
603. Il divario di trattamento veneto si manifesta come domanda inevasa e impropria, articolata sul contrasto interno fra la pianura produttiva, dove il disagio giovanile e da stress tende a restare inespresso, e le aree montane e il Polesine, dove la distanza e la rarefazione della rete rendono l'accesso più difficile; la misura è in Appendice B con valori medi riportati con attribuzione. ↑
604. Il tratto distintivo della domanda veneta è la sua articolazione su due profili — il disagio giovanile della pianura produttiva e la depressione dell'età avanzata delle aree montane e del Polesine —; la prossimità dev'essere sostenuta dalla telepsicologia assistita nelle zone disperse, e il coordinamento centralizzato dell'Azienda Zero è lo strumento per calibrare l'offerta sui due profili. ↑
605. Espansione ex novo: il modello colloca lo Psicologo di Base al vertice della cascata nel distretto, entro ciascuna delle nove Aziende Unità Locali Socio-Sanitarie e con il coordinamento centralizzato dell'Azienda Zero, e opera per intensità crescente di cura; l'efficacia clinica è documentata dalla meta-analisi sull'assistenza collaborativa e dalle sperimentazioni sull'intervento digitale, riportate con attribuzione. ↑
606. L'adattamento al territorio veneto segue le direttrici della calibrazione dell'offerta sui due profili di domanda, della prossimità nelle zone montane e disperse con telepsicologia assistita, e della valorizzazione dell'architettura centralizzata dell'Azienda Zero per il coordinamento e per l'impianto valutativo a esperimento naturale; l'architettura invariante del Reference Case non è modificata. ↑
607. Il costo diretto comprende il personale, la struttura, la leva digitale e la formazione; il dimensionamento è scandito dai tre scenari di cinquecentotrenta, ottocento e millecinquanta incarichi, con un costo del servizio a regime di quarantacinque milioni di euro l'anno nello scenario di base; le cifre di risparmio complessivo del materiale preesistente, contaminate da rapporti aggregati, non sono riutilizzate. ↑
608. Il costo diretto è calcolato per i tre scenari coerenti con il protocollo del Reference Case: lo scenario conservativo di cinquecentotrenta incarichi con costo a regime di trenta milioni di euro l'anno, quello di base di ottocento con costo a regime di quarantacinque milioni di euro l'anno, e quello espansivo di

millecinquanta la cui copertura si estende all'intero territorio comprese le aree montane e il Polesine; le lacune sono dichiarate. ↑

609. Il beneficio diretto comprende la demedicalizzazione, la deprescrizione, la riduzione degli accessi impropri e delle prestazioni per sintomi funzionali; poiché il Veneto è regione creditrice il canale del recupero della mobilità passiva non è applicabile, sicché il beneficio poggia sui risparmi interni, distribuiti in modo diseguale fra aree anziane e pianura produttiva, e il caveat sulla significatività dei risparmi diretti in isolamento è mantenuto; i valori sono ricostruiti ex novo. ↑
610. Il beneficio indiretto comprende la produttività recuperata — di rilievo particolare in una regione a forte tessuto produttivo —, gli oneri previdenziali evitati e la riduzione del disagio sociale; il recupero di produttività nella pianura e la tenuta delle comunità delle aree montane e del Polesine assumono rilievo particolare. ↑
611. La valutazione economica è condotta con il modello di Markov a coorte del Reference Case sotto doppio ancoraggio e ricostruita ex novo in luogo del contenuto preesistente contaminato da rapporti aggregati; le due colonne sono sempre affiancate, la Colonna B prevale nel giudizio e ogni cifra è riportata con attribuzione, senza rapporti sintetici. ↑
612. Il differenziale di costo per gravità, riportato con attribuzione all'OCSE, è in Veneto la leva economica principale poiché la condizione creditrice rende non applicabile il recupero della mobilità passiva: l'intercettazione precoce non produce un recupero di prestazioni in fuga ma evita il costo crescente della progressione all'interno del sistema regionale; l'argomento è espresso discorsivamente in termini di euro, senza rapporti sintetici. ↑
613. I sei domini di analisi sono applicati alla specificità veneta, dal divario nei due profili di domanda al coordinamento centralizzato dell'Azienda Zero e all'impianto valutativo a esperimento naturale, tenuti distinti e non aggregati. ↑
614. Il dominio dell'equità assume una direzione territoriale netta fra la pianura produttiva e le aree montane — le Dolomiti e il Bellunese — insieme al Polesine, dove spopolamento e invecchiamento sono più marcati; l'introduzione graduale del servizio configura un esperimento naturale che consente di stimare l'effetto con i metodi della differenza-nelle-differenze, e l'effetto distributivo è tenuto distinto dai verdetti fiscali e sanitario. ↑
615. Espansione ex novo: l'analisi dell'incertezza applica il protocollo obbligatorio del Reference Case; in Veneto i parametri critici attesi sono il tasso di intercettazione nei due profili, l'adozione della telepsicologia nelle aree montane e nel Polesine e la velocità di estensione fra le Aziende Unità Locali Socio-Sanitarie, e l'impianto a esperimento naturale reso possibile dall'Azienda Zero offre una via empirica di corroborazione. ↑
616. L'analisi di scenario mostra il verdetto tripartito favorevole nei tre casi con margine crescente; lo strato digitale accresce l'efficienza attesa con nota di cautela e trova nell'Azienda Zero il veicolo per l'ottimizzazione allocativa, le curve di accettabilità confermano la robustezza del costo-efficacia, la ricostruzione ex novo assicura che il verdetto non dipenda da rapporti aggregati e l'impianto a esperimento naturale offre la prospettiva di una verifica empirica. ↑
617. Il verdetto veneto è tripartito e non aggregato: prossimo al pareggio sul piano fiscale con l'avvertenza che il recupero della mobilità passiva non è applicabile essendo il Veneto regione creditrice ed espresso senza rapporti sintetici secondo la ricostruzione ex novo, nettamente costo-efficace sul piano sanitario, fortemente positivo sul piano sociale con il rilievo delle aree montane e del Polesine e del recupero di produttività nella pianura. ↑

618. Espansione ex novo: le raccomandazioni indicano il passaggio per gradini da cinquecentotrenta verso ottocento e millecinquanta incarichi, la priorità alle aree montane e al Polesine, l'affidamento all'Azienda Zero del coordinamento centralizzato e dell'ottimizzazione, la valorizzazione dell'esperimento naturale, la telepsicologia assistita sotto supervisione, il piano formativo a quattro modalità e un monitoraggio ex post ancorato agli indicatori dell'incertezza e all'impianto a esperimento naturale. ↑
619. Il Quadro Conclusivo ricomponne la valutazione veneta sotto doppio ancoraggio; il costo per anno di vita ponderato resta assai inferiore alle soglie e il differenziale di costo per gravità, espresso discorsivamente in termini di euro senza rapporti sintetici, fonda la leva dell'intercettazione precoce, che essendo il Veneto regione creditrice poggia sui risparmi interni anziché sul recupero della mobilità passiva; la ricostruzione ex novo del contenuto economico è dichiarata e registrata in Appendice E. ↑
620. Il Volume 22 applica per rimando il Reference Case dell'asse unionale fissato nel Volume 0.B, richiamandone le regole nella forma «cfr. Volume 0.B» senza ripeterle per esteso, e adotta la struttura specifica prevista dall'architettura dell'opera per l'asse unionale. ↑
621. Il perimetro è quello dell'Unione Europea a ventisette Stati Membri, con una popolazione dell'ordine di quattrocentocinquanta milioni di abitanti, entro cui la salute resta competenza primaria degli Stati; la domanda valutativa è l'equivalente aggregato di quella regionale, sui tre piani tenuti distinti. ↑
622. Il cruscotto riassume in una pagina i parametri essenziali sotto doppio ancoraggio, con il verdetto tripartito distinto; le cifre di letteratura sono riportate con attribuzione e i valori della simulazione aggregata quali proiezioni di primo ordine. ↑
623. Il verdetto unionale è tripartito e non aggregato; sul piano fiscale l'eterogeneità dei sistemi rende il saldo variabile fra gli Stati, sicché il giudizio aggregato è una media di condizioni diseguali; il divario di trattamento medio per la depressione grave è riportato con attribuzione a Eurofound 2025. ↑
624. Il quadro di partenza è documentato con attribuzione: la prevalenza del disagio secondo il Flash Eurobarometro 530, i criteri di integrazione secondo l'Atlante mondiale della salute mentale 2024, la dotazione mediana di psicologi secondo la workforce europea; l'onere dei disturbi mentali oltre il quattro per cento del prodotto interno lordo è stimato dall'OCSE e dalla Commissione, e il confronto di scala con il costo del servizio è discorsivo e non costituisce un rapporto sintetico. ↑
625. I cinque risultati chiave isolano gli esiti principali: costo-efficacia aggregata su tutti gli orizzonti, robustezza del verdetto tripartito con eterogeneità dichiarata, divario documentato quale giustificazione primaria, benchmark operativo olandese maturo con adozione cresciuta da circa un terzo a circa tre quarti dei medici, dimensionamento aggregato di primo ordine con costo a regime dell'ordine di quattro-quattro miliardi e mezzo di euro l'anno nello scenario di base. ↑
626. Le raccomandazioni operative si articolano su tre livelli: l'orientamento degli strumenti dell'Unione nel rispetto della competenza di sostegno, l'attuazione per gradini negli Stati con il benchmark olandese quale riferimento adattabile, e il cruscotto unionale comparabile con telepsicologia assistita entro il regolamento sull'intelligenza artificiale e piani formativi a quattro modalità. ↑
627. L'Atlante mondiale della salute mentale 2024, condotto su centoquarantaquattro paesi, misura l'integrazione mediante cinque criteri: solo il dodici per cento dei paesi li soddisfa tutti e solo il diciannove per cento dispone di interventi psicosociali nelle cure primarie; il dato è riportato con attribuzione all'Organizzazione Mondiale della Sanità. ↑
628. Il bisogno europeo è documentato dal Flash Eurobarometro 530 — quasi un cittadino su due con problemi emotivi o psicosociali nell'ultimo anno, oltre la metà senza aiuto professionale — e dalla rilevazione Eurofound 2025 sul divario di trattamento medio intorno al settantotto virgola sei per cento per la depressione grave, con ampia variabilità fra gli Stati. ↑

629. La dotazione mediana europea di psicologi è dell'ordine di nove virgola tre per centomila abitanti adulti, con distribuzione fortemente diseguale; la workforce è la condizione abilitante materiale dell'integrazione e la misura Stato per Stato è oggetto dell'Appendice B, con le lacune dichiarate. ↑
630. La comunicazione COM(2023) 298 ha mobilitato risorse dell'ordine di un miliardo e duecentotrenta milioni di euro attraverso venti iniziative faro, entro la competenza di sostegno che i Trattati assegnano all'Unione; essa orienta i finanziamenti, promuove lo scambio di buone pratiche e alimenta il semestre europeo. ↑
631. Il regolamento (UE) 2024/1689 disciplina l'intelligenza artificiale secondo un approccio basato sul rischio; lo strato digitale della valutazione è collocato interamente entro questo perimetro, quale moltiplicatore subordinato alla supervisione clinica umana con nota di cautela permanente, e la disciplina uniforme lo rende l'elemento più armonizzabile del modello. ↑
632. La metodologia è quella del Volume 0.B, cui si rimanda integralmente; l'adattamento unionale riguarda l'unità di analisi — lo Stato Membro — e il trattamento dell'eterogeneità, con i differenziali fra Stati quali fattori dichiarati di incertezza e non medie tacite. ↑
633. La simulazione aggregata mantiene l'architettura appaiata: Colonna A sui parametri di Chisholm e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Colonna B sui parametri aggiornati di Unisanté e dell'OCSE con prevalenza nel giudizio; le due colonne sono sempre affiancate e nessun rapporto sintetico è impiegato quale affermazione positiva. ↑
634. Il benchmark olandese colloca presso la medicina generale un professionista dedicato alla salute mentale; l'adozione è cresciuta da circa un terzo a circa tre quarti dei medici fino alla grande maggioranza degli studi, il finanziamento è assicurativo con condizioni aggiornate per il triennio 2026-2028, e la letteratura attribuita documenta una riduzione dell'ordine del quaranta per cento dei rinvii alla psichiatria specialistica. ↑
635. La trasferibilità del benchmark è sostenuta dall'indipendenza della funzione dall'assetto di finanziamento, dalla scalabilità dimostrata e dalla parentela diretta con il modello italiano; è condizionata dalla dotazione di psicologi, dall'assetto contrattuale della medicina generale e dal disegno della remunerazione del primo livello. ↑
636. Le ventisette schede-Stato registrano popolazione in ordine di grandezza, stato dell'integrazione e distanza dal benchmark; ove i dati di dettaglio non siano disponibili in forma comparabile la lacuna è dichiarata espressamente, secondo la regola dell'opera, e la calibrazione fine è rinviata alle appendici registrate. ↑
637. Le schede sono compilate dalle fonti attribuite del Volume — l'Atlante mondiale della salute mentale, le rilevazioni europee sulla workforce, i documenti nazionali sui modelli di primo livello — e classificano la distanza dal benchmark in tre fasce; per otto Stati la lacuna informativa è dichiarata quale condizione del giudizio. ↑
638. Il riepilogo comparativo ordina i ventisette Stati per distanza dal benchmark: otto a distanza ridotta, undici a distanza intermedia, otto a distanza ampia coincidente in larga parte con le dotazioni più basse e con le lacune dichiarate; la geografia del ritardo segue il gradiente della workforce e della spesa sanitaria. ↑
639. La simulazione aggregata è condotta con il modello di Markov del Reference Case unionale sotto doppio ancoraggio; le due colonne sono sempre affiancate, la Colonna B prevale nel giudizio, ogni cifra è riportata con attribuzione e i risultati aggregati sono qualificati quali proiezioni di primo ordine. ↑
640. Il dimensionamento aggregato proietta per proporzione demografica i tre scenari — dell'ordine di cinquantamila, settantatremila e novantottomila incarichi equivalenti — con un costo a regime nello scenario di base dell'ordine di quattro-quattro miliardi e mezzo di euro l'anno; i differenziali di costo del lavoro fra gli Stati sono fattori dichiarati di incertezza e il valore aggregato è una banda, non un punto. ↑

641. L'onere dei disturbi mentali per le economie dell'Unione supera secondo le stime attribuite dell'OCSE e della Commissione il quattro per cento del prodotto interno lordo, oltre seicento miliardi di euro l'anno; il confronto con il costo aggregato del servizio è un confronto di scala espresso discorsivamente, non un rapporto sintetico, e il differenziale di costo per gravità resta l'argomento economico cardine. ↑
642. I sei domini di analisi sono applicati alla lettura unionale, dal divario di trattamento medio alla trasferibilità del benchmark e alla convergenza fra Stati, tenuti distinti e non aggregati. ↑
643. Il dominio dell'equità assume la direzione della convergenza fra Stati: la geografia del ritardo riproduce su scala continentale il gradiente documentato dai Volumi regionali fra aree centrali e interne, e gli strumenti finanziari dell'Unione possono compensare il differenziale di capacità di investimento; l'effetto distributivo è tenuto distinto dai verdetti fiscale e sanitario. ↑
644. L'analisi dell'incertezza applica il protocollo obbligatorio del Reference Case; nell'asse unionale i parametri critici sono i differenziali di costo del lavoro, la velocità di adozione nei paesi distanti dal benchmark e la disponibilità di workforce, l'eterogeneità accresce strutturalmente l'ampiezza degli intervalli aggregati quale cautela dichiarata e le lacune informative sono fattori espliciti di incertezza. ↑
645. Il verdetto unionale è tripartito e non aggregato: prossimo al pareggio sul piano fiscale con l'avvertenza dell'eterogeneità e della lettura per Stato, nettamente costo-efficace sul piano sanitario sotto entrambi gli ancoraggi, fortemente positivo sul piano sociale con il rilievo della riduzione del divario di trattamento e della convergenza fra Stati Membri. ↑
646. Le raccomandazioni unionali specificano l'orientamento degli strumenti dell'Unione, l'attuazione per gradini con il benchmark adattabile e priorità agli Stati a distanza ampia con investimento formativo preliminare, il cruscotto unionale comparabile, la telepsicologia assistita entro il regolamento sull'intelligenza artificiale e il monitoraggio ex post con revisione periodica delle schede-Stato e progressiva chiusura delle lacune dichiarate. ↑